罗校傅青主女科和女科医案集

作者：明末清初·傅青主
整理校释：罗维跃

罗校傅青主女科和女科医案集

作者：明末清初·傅青主
整理校释：罗维跃

更新日期:2023 年 31 月 15 日

目录

简介 1
张序 1
祁序 1
罗序 1
第一章 带下 1
第一节 白带下 1
完带汤方： 1
【灸带脉穴治妇人患赤白带下医案】 3
【完带汤治白带医案】摘自《河南中医》： 4
【完带汤治疗白带阴痒】网文： 4
【附子汤白带量多二年余伴腰酸腹痛而凉医案】孙长德： 5
【附子汤小腹下坠白带多宫颈糜烂医案】权依经： 6
第二节 青带下 6
加减逍遥散方： 6
逍遥散方： 7
【丹栀逍遥散治月经期间感冒】朱进忠： 7
【丹栀逍遥散每次遗精之后即出现感冒】朱进忠： 8
【丹栀逍遥散治阳事难举医案】朱进忠： 8
【丹栀逍遥散巅顶灼热】朱进忠： 8
【丹栀逍遥散治昼夜难眠】朱进忠： 9
【丹栀逍遥散咽喉异物感子宫肌瘤】朱进忠： 9
【丹栀逍遥散劳淋白带】朱进忠： 9
【丹栀逍遥散劳淋】朱进忠： 10
【丹栀逍遥散足心灼热难忍】朱进忠： 10
【丹栀逍遥散阳萎腰酸背痛】朱进忠： 10
【丹栀逍遥散足心灼热难忍】朱进忠： 11
【丹栀逍遥散舌痛淋痛】朱进忠： 11
第三节 黄带下 12
易黄汤方： 12
【易黄汤滴虫性阴道炎医案】： 15
第四节 黑带下 17
利火汤方： 17
【利火汤治黑带】 18
【利火汤治前列腺炎合并睾丸炎】 18
【利火汤治 男性无合并症急性淋菌性尿道炎】 18
第五节 赤带下 19
清肝止淋汤方： 19
【清肝止淋汤治经间期出血(排卵期出血)】： 20
第二章 下血崩漏 20

第一节 血崩昏暗六 20
固本止崩汤方： 20
【固本止崩汤医案】李玲辉: 21
【固本止崩汤月经先期量多医案】晏金娥: 21
【固本止崩汤习惯性流产医案】王艳: 21
第二节 年老血崩七 22
加减当归补血汤方： 22
【老年下血傅青主加减当归补血汤加生地黄医案】张锡纯： 22
【加减当归补血汤合因冲汤崩漏】刘国平： 22
【加减当归补血汤支气管扩张咳血】张华： 23
【加减当归补血汤吐血】张华： 23
【加减当归补血汤便血】张华： 23
【加减当归补血汤尿血】张华： 23
第三节 少妇血崩 24
固气汤方： 24
【固气汤治月经点滴不净医案】 25
【固气汤 14 岁初潮起即每日点滴不净医案】 25
【桂枝加附子汤血崩医案】闫云科： 25
第四节 交感出血 26
引精止血汤方： 26
【引精止血汤治疗房帷交感精血混出】唐汝梅: 26
【引精止血汤治疗更年期功能性子宫出血】 27
【引精止血汤治疗更年期子宫功能性出血】李萍： 27
【引精止血汤治疗人工流产后子宫内膜修复期出血】： 27
【引精止血汤治疗患者阴道不规则出血已 13 年】史国平： 27
第五节 郁结血崩 28
平肝开郁止血汤方 28
【傅青主平肝开郁止血汤功能失调性子宫出血】张贵兰： 28
【傅青主平肝开郁止血汤功能失调性子宫出血】饶惠玲： 28
第六节 闪跌血崩 28
逐瘀止血汤方： 28
【逐瘀止血汤治宫内节育器所致月经失调医案】 29
【逐瘀止血汤治宫内节育器所致月经失调医案 1】杜林： 29
【加减逐瘀止血汤治疗放环后月经失调】 29
【加减逐瘀止血汤治疗放环后月经失调】李旭京： 29
【逐瘀止血汤加减治疗上环后月经失调】 30
【逐瘀止血汤加减治疗阴道出血】郭涛荣： 30
【加味逐瘀止血汤治疗宫内节育器致子宫异常出血】蔡雪芬： 30
【逐瘀止血汤加味治疗青春期功能性子宫出血】王青： 30
【药物流产后阴道流血的患者加服逐瘀止血汤】张文家 31
【逐瘀止血汤加减治疗经期延长】冯蓓： 31
第七节 血海太热血崩 31
清海丸方： 31
【临床应用与医案】 32

【清海丸治月经稀病案】吴慧娇：.....32
第三章 妇人鬼胎.....33
第一节 腹似怀妊鬼胎.....33
荡鬼汤方：.....33
第二节 室女鬼胎.....34
桂香方：.....34
平胃散方：.....35
荡邪散方：.....35
调正汤方：.....35
第三章 月经不调.....35
第一节 经水先期.....35
清经散：.....35
两地汤方：.....36
【两地汤治疗月经病】秦理：.....36
【两地汤治疗月经经间期出血病】秦理：.....36
【两地汤治疗虚热型经期延长】李志伟：.....36
【两地汤加减治疗崩漏】石梅仙：.....36
【傅青主两地汤治男性不育精液量少症医案】张宗圣：.....36
【两地汤治男性不育精液不液化症医案】张宗圣：.....37
第二节 经水后期.....37
温经摄血汤方：.....37
【月经后期临床应用与医案】张素：.....38
【月经后期不孕医案】杜竹枝：.....38
【归脾汤加吴茱萸治不进饮食经水过期而少】薛立斋：.....38
第三节 经水先后无定期.....38
定经汤方：.....38
【定经汤治疗月经过少 30 例的临床体会】郭艳：.....39
【定经汤治疗子宫肌瘤 30 例】業昌劳.....39
【傅氏定经汤组方及应用闭经溢乳综合征】张晓峰：.....39
【定经汤治男科疾病不射精】辛文华：.....39
【定经汤治男科疾病功能性勃起障碍】李广涛：.....40
【定经汤治更年期综合征】辛文华：.....40
第四节 经水数月一行.....40
助仙丹方：.....40
【助仙丹治闭经月经减少医案】李芬：.....41
【用助仙丹加香附、龟板，生鸡内金治好女儿月经数月一行】网文懒兔子漫画中医.....41
【助仙丹治多囊卵巢病变月经不不规律医案】黎崇裕：.....42
第五节 年老经水复行.....42
安老汤方：.....42
【安老汤在妇科崩漏病医案】王仁尧：.....43
【安老汤滑胎医案】王仁尧：.....43
【安老汤闭经医案】王仁尧：.....43
【安老汤月经先期医案】王仁尧：.....43

【安老汤在更年期综合征妇科崩漏病医案】王仁尧：.....43
【安老汤子宫肥大医案】姚淑华：.....44
第六节 经水忽来忽断时疼时止.....44
加味四物汤方：.....44
【傅青主加减四物汤的医案】陈秀琴：.....44
第七节 经水未来腹先疼.....44
宣郁通经汤方：.....45
【宣郁通经汤治疗青春期痛经】张有明.....45
【宣郁通经汤治疗经前腹痛伴双侧乳腺疼痛乳腺小叶增生症】崔万胜：.....45
【宣郁通经汤治赤带】高仰秀：.....45
【宣郁通经汤治功能性不射精】王立华.....46
【宣郁通经汤阴道炎】赵淑媛：.....46
【宣郁通经汤慢性附伴炎】赵淑媛：.....46
【宣郁通经汤治疗子宫肌瘤】李淑华：.....46
【宣郁通经汤治愈输卵管不通继发性不孕症】沈开金：.....47
【宣郁通经汤加减治疗痤疮】李润生.....47
【宣郁通经汤加减治疗乙型肝炎后胁痛】侯公明：.....47
【宣郁通经汤治乳房溢奶医案】孙广建：.....47
【宣郁通经汤治乳泣乳房溢血医案】孙广建：.....48
【宣郁通经汤治疗暴盲】张萍：.....48
第八节 行经后少腹疼痛.....48
调肝汤方：.....49
【调肝汤痛经医案】周惠芳：.....49
【调肝汤闭经医案】王艳：.....49
【调肝汤崩漏医案】王艳：.....49
【调肝汤经行乳房胀痛医案】王艳：.....50
【调肝汤阴痒医案】王艳：.....50
【小建中加柴芩治痛经医案】.....50
第九节 经前腹疼吐血（倒经）.....50
顺经汤方：.....50
【傅青主顺经汤治经前鼻血】李成芳：.....51
【傅青主顺经汤治经前咳嗽咯血】付海根：.....51
【傅青主顺经汤治更年期综合征】杨再山：.....51
【傅青主顺经汤治治疗经期球结膜下出血】张春华：.....52
第十节 经水将来脐下先疼痛.....52
温脐化湿汤方：.....52
【傅青主温脐化湿汤痛经医案】曲春玲：.....53
【傅青主温脐化湿汤继发性不孕医案】贾玲允：.....53
第十一节 经水过多.....53
加减四物汤方：.....53
第十二节 经前泄水.....54
方用健固汤方：.....54
【健固汤加味治阴道泄水验案】杨医亚：.....54
第二节 经前大便下血.....55

顺经两安汤方：.....55
第三节 年未老经水断.....55
益经汤方：.....56
【益经汤加减治疗卵巢功能早衰】颜建敏：.....56
【益经汤加减治疗排卵障碍性不孕】颜建敏：.....57
【益经汤治疗绝经综合征 56 例】王艳东.....57
【傅青主益经汤治疗月经过少 40 例】邓力军.....57
【傅青主益经汤治疗辨治心悸验案举隅】邓力军.....57
第四章 种子不孕症.....57
第一节 身瘦不孕.....57
养精种玉汤方：.....58
【傅青主养精种玉汤不孕医案】：.....58
【倦怠呵欠口干妇人不孕医案】张氏医通：.....58
第二节 胸满不思食不孕.....59
并提汤方：.....59
第三节 下部冰冷不孕.....60
温胞饮方：.....60
【温胞饮加减治疗不孕症 98 例】朱惠英：.....61
【温胞饮加减治自然流产其后久不受孕】温丽娜.....61
【傅氏温胞饮加味男子少精症】刘立华：.....61
第四节 胸满少食不孕.....61
【温土毓麟汤医案】.....62
第五节 少腹急迫不孕.....62
【宽带汤与少腹拘急不舒医案】.....63
【宽带汤神经官能症医案】.....63
第六节 嫉妒不孕.....63
开郁种玉汤方：.....64
第七节 肥胖不孕.....64
加味补中益气汤方：.....65
补中益气汤（李东垣《脾胃论》）.....65
【傅氏加味补中益气汤（补中益气汤与二陈汤合方）治肥胖不孕】杨学.....65
第八节 骨蒸夜热不孕.....65
【清骨滋肾汤骨蒸夜热不孕症】王大生：.....66
【清骨滋肾汤骨蒸夜热不孕症医案】.....66
【清骨滋肾汤骨蒸夜热不孕症医案】张婷婷：.....67
第九节 腰酸腹胀不孕.....67
升带汤方：.....67
【升带汤医案】.....68
【升带汤慢性盆腔炎医案】.....68
第十节 便涩腹胀足浮肿不孕.....68
第三节 68
化水种子汤方：.....68
【化水种子汤医案】.....69
【化水种子汤医案】.....69

【化水种子汤医案】 69
【化水种子汤医案】 70
【化水种子汤医案】 70
第五章 妊娠 70
第一节 妊娠恶阻 70
妊娠恶阻方： 71
第二节 妊娠浮肿 71
加减补中益气汤方： 71
第三节 妊娠少腹疼 71
安奠二天汤方： 72
第四节 妊娠口干咽疼 72
润燥安胎汤方： 72
第五节 73
援土固胎汤方： 73
第五节 妊娠子悬胁疼 73
第六节 73
第六节 妊娠跌损 73
第七节 74
救损安胎汤方： 74
第七节 妊娠小便下血病名胎漏 74
第八节 74
助气补漏汤方： 74
第八节 妊娠子鸣 74
扶气止啼汤方： 74
第九节 妊娠腰腹疼渴汗燥狂即子狂 74
第九节 75
息焚安胎汤方： 75
【息焚安胎汤方治妊娠期心中烦乱口渴夜不成寐验案】网文： 76
第十节 妊娠中恶 76
第十节 76
消恶安胎汤 76
第十一节 妊娠多怒堕胎 76
利气泄火汤 76
第六章 小产 76
第一节 行房小产 77
固气填精汤方： 77
第二节 跌闪小产 77
理气散瘀汤方： 77
第三节 大便干结小产 77
加减四物汤方： 78
第四节 畏寒腹疼小产 78
黄耆补气汤方： 78
第五节 大怒小产 78
引气归血汤方： 78

第七章 难产门 79
第一节 血虚难产 79
送子丹： 79
第二节 交骨不开难产 79
用降子汤方： 79
第三节 脚手先下难产五十八 80
转天汤 80
第四节 气逆难产 80
舒气散 80
第五节 子死产门难产 81
救母丹： 81
第六节 子死腹中难产 81
疗儿散 81
第八章 正产 81
第一节 正产胞衣不下 81
送胞汤 81
补中益气汤 82
第二节 正产气虚血晕 82
补气解晕汤 82
第三节 正产血晕不语 83
第四节 正产败血攻心晕狂六十五 83
安心汤方： 83
第十一节 83
加味生化汤 83
第五节 正产肠下 83
补气升肠饮 84
第九章 产后门 84
第一节 产后少腹疼 84
散结定疼汤 84
第十二节 84
第二节 产后气喘 85
第三节 产后恶寒身颤 85
十全大补汤方： 85
第四节 产后恶心呕吐 85
温肾止呕汤 86
第五节 产后血崩 86
救败求生汤方： 86
第六节 产后手伤胞胎淋漓不止 86
完胞饮 86
第七节 产后四肢浮肿 87
转气汤方： 87
第八节 产后肉线出 87
两收汤方： 87
第九节 产后肝痿七十五 88

收膜汤方：……88
第十节 产后气血两虚乳汁不下……88
通乳丹方：……88
第十一节 产后郁结乳汁不通……88
通肝生乳汤方：……89
第十章 产后总论……89
第十一章 产前后方症宜忌……89
第十二节 正产……89
第十六节 ……89
第十三节 伤产……90
第十四节 调产……90
第十七节 催生……90
第十八节 ……90
第十五节 冻产……91
第十六节 热产……91
第十七节 横产……91
第十八节 盘肠产……91
第十九节 难产……91
第十九节 ……91
加味芎归汤方：……91
第二十节 死产……92
第二十一节 下胞……92
第二十二节 断脐……92
第二十节 ……92
第二十一节 ……92
治产秘验良方：……92
第二十二节 ……93
第二十三节 ……93
第二十四节 ……93
第十二章 新产治法……93
第二十五节 产后用药十误……93
第二十三节 产后寒热……94
第二十四节 胎前患伤寒疫症疟疾堕胎等症……94
第十三章 产后诸症治法……94
第一节 血块第一……94
生化汤原方：……94
第二十六节 ……95
加味生化汤方：……95
第二节 血晕第二……95
生化汤方：……95
第二十七节 ……95
加味生化汤方：……95
第二十八节 ……95
加参生化汤方：……95

第三节 厥症第三 96
加参生化汤方 96
第二十九节 96
滋荣益气复神汤方： 96
第四节 血崩第四 96
第三十节 96
生血止崩汤方： 96
第三十一节 96
升举大补汤方： 96
第五节 气短似喘第五 97
加参生化汤方： 97
补气养荣汤方： 97
第十四章 妄言妄见第六 97
安神生化汤方： 97
第三十二节 98
滋荣益气复神汤方： 98
第十五章 伤食第七 98
第三十三节 98
加味生化汤方： 98
第三十四节 98
健脾消食生化汤方： 98
第三十五节 98
长生活命丹方： 98
第十六章 忿怒第八 98
第三十六节 98
木香生化汤方： 98
第三十七节 99
健脾化食散气汤方： 99
第十七章 类疟第九 99
第三十八节 99
第三十九节 99
第四十节 99
第十八章 类伤寒二阳症 99
第四十一节 100
加味生化汤方： 100
第一节 类伤寒三阴症 100
第四十二节 100
养正通幽汤方： 100
第四十三节 100
第二节 类中风 100
第四十四节 100
第四十五节 101
天麻丸： 101
第三节 类痉 101

第四十六节 101
加减生化汤方： 101
第四节 出汗 101
第四十七节 101
麻黄根汤方： 101
第四十八节 101
八味地黄丸： 101
第五节 盗汗 102
第四十九节 102
止汗散： 102
第五十节 102
又方：止汗散 2： 102
第六节 口渴兼小便不利 102
第五十一节 102
生津止渴益水饮 102
第七节 遗尿 102
第五十二节 102
第十九章 产后诸症治法（续上） 103
第一节 误破尿胞 103
第五十三节 103
补脬饮方： 103
第二节 患淋 103
第五十四节 103
茅根汤方： 103
第五十五节 103
第三节 便数 103
第五十六节 103
第四节 泻第 104
第五十七节 104
加减生化汤方： 104
第五十八节 104
健脾利水生化汤方： 104
第五节 完谷不化 104
第五十九节 104
加味生化汤方： 104
第六十节 104
参苓生化汤方： 104
第六节 痢 105
第六十一节 105
加减生化汤方： 105
第六十二节 105
青血丸： 105
第七节 霍乱 105
第六十三节 106

生化六和汤方：.....106
第六十四节 106
附子散：.....106
第六十五节 106
温中汤方：.....106
第八节 呕逆不食.....106
第六十六节 106
加减生化汤方：.....106
温胃丁香散：.....106
石莲散：.....106
第六十九节 106
生津益胃汤方：.....106
第九节 咳嗽.....107
第七十节 107
加味生化汤方：.....107
加参安肺生化汤方：.....107
第七十二节 107
加味四物汤方：.....107
第十节 水肿.....107
第七十三节 107
五皮散：.....107
第七十四节 107
第十一节 流注.....108
葱熨法：.....108
参归生化汤方：.....108
第十二节 膨胀.....108
第七十七节 108
补中益气汤方：.....108
第七十八节 108
健脾汤.....108
第七十九节 108
养荣生化汤方：.....108
第十三节 怔忡惊悸.....109
第八十节 109
加减养荣汤方：.....109
第八十一节 109
养心汤方：.....109
第一节 骨蒸.....109
第八十二节 109
柴胡梅连汤方：.....109
第八十三节 109
保真汤方：.....109
第八十四节 109
加味大造汤方：.....109

第二节 心痛第 110
第八十五节 110
加味生化汤方： 110
第三节 腹痛 110
第八十六节 110
加减生化汤方： 110
第四节 小腹痛 110
第八十七节 110
加减生化汤方： 110
第五节 虚劳 110
第八十八节 110
当归黄耆人参韭白猪肾汤方： 110
第六节 遍身疼痛 110
第八十九节 111
趁痛散方： 111
第七节 腰痛 111
养荣壮肾汤方： 111
第九十节 111
第九十一节 111
第八节 胁痛 111
第九十二节 111
补肺散： 111
第九节 阴痛 111
第九十三节 111
祛风定痛汤方： 111
第九十四节 112
十全阴疳散： 112
第十节 恶露 112
第九十五节 112
加味补中益气汤方： 112
第九十六节 112
三消丸： 112
第十一节 乳痈 112
第九十七节 113
第九十八节 113
十全大补汤方： 113
第九十九节 113
又方： 113
第十二节 风甚 113
第一节 不语 113
第一百节 113
七珍散： 113
第一百〇一节 113
治产后不语方： 113

第二十章 补集 113
第一节 产后大便不通 113
第一百〇二节 114
炼蜜枣法： 114
第一百〇三节 114
治产后鸡爪风： 114
第一百〇四节 114
保产无忧散： 114
第一百〇五节 114
治遍体浮肿方： 114
第二十一章 附录：妇人病案集 115
第一节 妇人精神病 115
【麦甘大枣汤治无故悲泣不止】本事方： 115
【妊娠四五个月遇昼则惨戚悲伤泪下】妇人良方： 115
【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云： 115
【抵当汤治月经不来下焦蓄血引起的精神病】胡希恕曰： 115
【血在下则忘精神病医案】刘渡舟： 115
【喜笑不休医案】张氏医通： 116
【喜笑不休医案】张氏医通： 116
【笑哭不常医案】张氏医通： 116
【辰砂甘遂散治妇人神经病终日歌唱达旦不寐医案】曹颖甫： 116
【桂枝汤加龙骨牡蛎治入夜每与人交医案】徐伯伦： 116
【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云： 116
【桂枝汤加龙骨牡蛎治表情抑郁少语寡言时时惊恐医案】付美育： 116
【脏躁奔豚汤治精神恍惚医案】王峰： 117
【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云： 117
【桂枝汤加龙骨牡蛎治入夜每与人交医案】徐伯伦： 117
第二节 妇人乳房病医案 117
【桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤主之治乳腺增生】网文： 117
【半夏厚朴汤乳腺纤维腺瘤(乳癖)】李志亮： 117
【半夏厚朴汤急性乳腺炎(乳痈)】承忠委： 118
【少腹逐瘀汤治乳腺增生乳房胀痛医案】 118
【软坚散结化乳癖】 118
【白通汤加味治乳痈(乳腺炎)】 118
【麻黄附子细辛汤加味乳痈(乳腺炎)】 119
【结乳肿疼兼治乳痈奇方】张锡纯： 119
【消乳汤治乳痈医案】张锡纯： 119
【少腹逐瘀汤治乳腺增生乳房胀痛医案】 120
【百合知母汤合甘麦大枣汤治疗乳腺病双乳胀痛】高秀飞： 120
【百合知母汤治疗乳腺病乳腺癌术后难以入睡】高秀飞： 120
【乳腺癌术后局部创面感染不愈案】 120
【右乳腺小叶增生医案】王秀玉： 121
【栝蒌薤白白酒汤加味治初产后左乳肿痛医案】李长青： 121
【初产后两月患急性乳腺炎医案】权依经： 121

【大黄甘遂汤产后腹满小便难】.....121
【葛根汤治产后乳痈医案】.....121
【枳实薤白桂枝汤治乳房上方簇状疱疹】.....122
【桂枝茯苓丸双乳胀痛医案】王辅民：.....122
第三节 妇人月经不调诸病.....122
【回阳饮治寒闭经(误服蚕砂酒引发危证)】.....122
【抵当汤治少女闭经医案】曹颖甫：.....123
【理冲汤腹痛闭经医案】张锡纯：.....123
【理冲汤腹痛闭经医案】张锡纯：.....124
【腹痛闭经医案】（医学训中参西录）广西柳州宾生来函：.....124
【安冲汤原方治经水行时多而且久淋漓八九日始断后复如故医案】张锡纯：.....124
【安冲汤去黄芪加白术治经水行不止医案】张锡纯：.....124
【安冲汤去术加麦冬霍石斛香附米治经水行时多而且久】直隶青县张生来函：.124
【当归生姜羊肉汤闭经医案】刘爱国：.....124
【抵当汤治妇人经水不利】曹颖甫：.....125
【资生汤治痨瘵闭经】张锡纯：.....125
【资生汤治痨瘵闭经医案】四川泾南周生来函：.....125
【一味薯蓣饮治闭经】张锡纯：.....125
【资生通脉汤治月经不来】张锡纯：.....126
【资生通脉汤治闭经】张锡纯：.....126
【资生通脉汤治闭经】张锡纯：.....126
【当归生姜羊肉汤闭经医案】刘爱国医案：.....127
【醴泉饮治水经数月不行医案】张锡纯：.....127
【鸡内金治月信不通】张锡纯：.....127
【腹痛闭经医案】张锡纯：.....128
【腹痛闭经医案】张锡纯：.....128
【山楂红糖汤治月信不来】张锡纯：.....128
【生料八味倍桂、附少腹不时酸痛经不行者半载余】张氏医通：.....128
【抵当丸治月经不通患癞病三年赤斑如云】《古方便览》：.....128
【资生汤加减治处女经闭医案】张锡纯：.....128
【肾气汤治长期低热月经延迟医案】俞长荣：.....129
【三黄泻心汤治闭经】刘渡舟：.....129
【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：.....129
【资生汤治痨瘵闭经】张锡纯：.....129
【资生汤治痨瘵闭经医案】四川泾南周生来函：.....130
【一味薯蓣饮治闭经】张锡纯：.....130
【大黄牡丹皮汤治腹中有干血着脐下不大便月经不调医案】.....130
【验方益元暖宫汤少腹坠胀冷痛经闭】.....130
【当归建中汤月事将行必先腹痛证医案】.....131
【甘麦大枣汤闭经医案】王国瑭：.....131
【下瘀血汤月经过多医案】陈果然：.....131
【大黄䗪虫丸治闭经】：.....131
【大黄甘遂汤治月事不复小便难少腹满日渐膨隆医案】戴鉴周：.....132
【薏苡附子败酱散治少腹痛甚闭经】QQ 群流传：.....132

【肾气汤治痛经医案】柳英华：.....132
【桂枝汤证治月事后期而少时时微恶寒医案】曹颖甫：.....132
【当归生姜羊肉汤治经水 50 余天未行医案】刘爱国：.....133
【大黄牡丹皮汤治腹中有干血着脐下不大便月经不调医案】.....133
【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：.....133
【抵当汤与瓜蒂散治腹脉坚实心下硬塞月经不来奇怪医案】《漫游杂志》：.....133
【少腹逐瘀汤加味治疗痛经医案案例】.....134
【少腹逐瘀汤加味治疗痛经医案案例】.....134
【桂枝茯苓丸治治疗闭经】：.....134
【桂枝茯苓丸治痛经】：.....134
【温经汤闭经医案】《经方躬行录》.....134
【温经汤痛经医案】《经方躬行录》.....134
【失笑散经闭三月少腹痛贯彻心医案】张璐：.....135
【半夏厚朴汤治闭经的经验】承忠委：.....135
【少腹逐瘀汤治闭经医案】.....135
【少腹逐瘀汤加味治治疗治疗月经后期 68 例医案案例】.....135
【血府逐瘀汤是治经来淋漓不尽】齐建民：.....136
【补中益气汤合少腹逐瘀汤经来腹痛呕吐下腹坠胀疼痛案】.....136
【当归四逆加吴茱萸生姜汤治痛经医案】陈沅生：.....136
【黄芪建中汤加减腹痛常发于月经来时病医案】.....136
【疮疡三两三治经闭风疹】.....137
【阳和汤治痛经】李秀丽：.....137
【桃核承气汤治倒经腹中有块】.....137
【奔豚汤治经行时呕吐医案】魏翠荣：.....138
【小柴胡汤治神经性厌食闭经医案】日本：.....138
【验方益元暖官汤少腹坠胀冷痛经闭】.....138
【四逆汤治反复发作鼻出血淋漓月经淋漓不断医案】李洪善：.....138
【小柴胡汤合四物汤治疗来月经时发热】矢数道明：.....139
【己椒苈黄丸闭经医案】刘露祥：.....139
【桂枝茯苓丸加味月经不调医案】谭俊臣：.....140
【验方益元暖官汤少腹坠胀冷痛经闭】.....140
【当归芍药散月经过多】.....140
【血府逐瘀汤治逆经】：.....141
第四节 妇人痛经.....141
【血府逐瘀汤加味治瘀滞痛经案】：.....141
【桂枝茯苓丸经来少腹痛不可忍医案】张季高：.....142
【少腹逐瘀汤加味治原发性痛经医案案例】.....142
【血府逐瘀汤加味治瘀滞痛经案】：.....143
【乌梅汤加味治痛经】蒲辅周医案：.....143
【乌头汤治痛经医案】陈寿永医案：.....143
第五节 妇人崩漏下血诸病.....144
【经行血崩及口鼻出血不止】.....144
【胶艾治经行血崩】.....145
【崩漏的案例】尤阳春：.....145

【老年下血傅青主方医案】张锡纯：.....146
【安冲汤治少女下血不止医案】张锡纯：.....146
【资生汤、一味薯蓣饮治闭经】张锡纯：.....146
【资生汤加减治处女经闭】张锡纯：.....146
【固冲汤治下血两日不止医案】张锡纯：.....147
【固冲汤治骤得下血证医案】张锡纯：.....147
【固冲汤妊流产下血甚多治案】直隶青县张生来函：.....148
【固冲汤行经过期不止治案】直隶盐山李生来函：.....148
【固冲汤小产后血不止者治案】.....148
【小柴胡汤合当归芍药散加生地艾叶治崩漏不止】胡希恕：.....148
【黄芪桂枝五物汤治春产后两个月阴道出血淋漓不断月经不调医案】：王金洲.149
【用大剂真武汤治漏下医案】易庆棠：.....149
【张锡纯升陷汤证宗气下陷治子宫出血半年医案】娄绍昆.....149
【桂枝汤加龙骨牡蛎治产后暴崩医案】连建伟：.....150
【当归芍药散合柏叶汤加阿胶汤治月经淋漓不尽】冯世纶.....150
【血府逐瘀汤治经来淋漓不尽】.....151
【血府逐瘀汤治经来淋漓不尽】齐建民：.....151
【血府逐瘀汤治疗崩漏症案】：.....151
【真武汤治阴道出血两月余医案】韩桂茹：.....152
【少腹逐瘀汤加味治经行点滴迁延时医案案例】.....152
【少腹逐瘀汤加味治经行点滴迁延时医案案例】.....152
【血崩证医案】张锡纯：.....152
【四逆汤治反复发作鼻出血淋漓月经淋漓不断医案】李洪善：.....153
【黄连阿胶汤治月经淋漓不止医案】刘渡舟：.....153
【黄连阿胶汤治阴道流血医案】权依经：.....153
【当归四逆加吴茱萸生姜汤治经来量多色黑成块腹痛坠胀难支】朱可贞：.....153
【小柴胡汤合当归芍药散加生地艾叶汤治月经淋漓至今未止医案】胡希恕：.....154
【吴茱萸汤治月经前轻度头痛头痛频发】.....154
【黄土汤早期流产出血不止医案】赵锡武：.....154
【黄土汤月经量多医案】丁小燕：.....154
【黄土汤加味治疗崩漏 36 例】孔文清：.....154
【桂枝茯苓丸合下瘀血汤下血晦暗滴沥不断医案】张法运：.....154
【回阳饮加人参经行血崩】.....155
【张锡纯的升陷汤证宗气下陷治子宫出血半年医案】娄绍昆：.....155
升陷汤方：（张锡纯）.....156
张锡纯曰：.....156
【黄连阿胶汤治月经来潮时下腹部疼痛剧烈】.....156
【血府逐瘀汤治疗崩漏症案】：.....158
第六节 妇人外阴诸疾病.....158
【甘麦大枣汤外阴瘙痒医案】邵金阶：.....158
第一百〇七节 158
甘草小麦大枣汤方：汉《伤寒论》）.....158
【当归四逆汤治子宫肌瘤并不孕症】.....158
【蛇床子散与苓桂术甘汤合方加味治多年真菌性阴道炎】.....159

【蛇床子散治阴道瘙痒】：.....159
【甘麦大枣汤外阴瘙痒医案】邵金阶：.....159
【甘麦大枣汤尿道涩痛医案】邵金治：.....159
【附子汤治阴痒】孙长德：.....160
【附子汤治子宫脱垂宫颈糜烂案】：.....160
【当归四逆加吴茱萸生姜汤治阴户遽现紧缩手足厥冷医案】赵守真：.....160
【百合地黄汤治阴道干涩症】高齐民：.....160
【当归四逆加吴茱萸生姜汤治少腹大痛医案】赵守真：.....160
【当归四逆加吴茱萸生姜汤治妇人阴缩】.....161
【外阴湿疹搔痒溢水双眼干涩全身发小脓疮下肢红斑累累医案】王足明：.....161
【附子汤阴痒而痛夜间尤甚局部可见腐烂医案】孙长德：.....161
【大承气并大陷胸汤加味臌胀下阴常流黄水臭味异常】.....161
【蛇床子散与苓桂术甘汤合方加味治多年真菌性阴道炎】.....162
【蛇床子散治阴道瘙痒】：.....162
【反复阴痒二周伴白带增多医案】.....162
【蛇床子散交感则觉阴中隐痛】.....163
第七节 妇人癥瘕卵巢囊肿子宫肌瘤诸病症.....164
【化癥回生丹治卵巢囊肿医案】路新：.....164
【化癥回生丹治子宫肌瘤医案】梁颂如：.....164
【化癥回生丹治癥瘕医案】：.....164
【理冲汤癥瘕起于少腹医案】张锡纯：.....165
【理冲汤癥瘕结于上脘医案】张锡纯：.....165
【理冲汤心腹满闷医案】张锡纯：.....165
【理冲汤少年癖结于少腹医案】张锡纯：.....165
【当归芍药散合桂枝茯苓丸癥瘕(子宫肌瘤)医案】岳美中：.....165
【桂枝茯苓丸加味治卵巢囊肿医案】刘昭坤：.....166
【麻黄附子细辛汤合桂枝茯苓丸治多囊卵巢综合证一例】.....166
【薏苡附子败酱散治卵巢囊肿白带增多医案】.....167
【癥瘕结于上脘医案】张锡纯：.....167
【六十年代当我用一个方子消掉了患者多年的子宫肌瘤】.....167
【薏苡仁能促使孕妇流产的理由卵巢囊肿子宫肌瘤医案】矢数道明.....168
【少腹逐瘀汤加味治子宫肌瘤医案案例】.....169
【少腹逐瘀汤加味治治卵巢囊肿医案案例】.....169
【当归四逆汤治腰痛小肚子痛冰凉冰凉医案】刘渡舟：.....169
【抵当丸卵巢囊肿破裂医案】矢数道明：.....170
【下瘀血汤抵当治女性小腹积块汤案】翟书庆：.....170
【抵当汤治少腹疼痛而拒按女性脐下积块医案】：.....170
【抵当汤治瘀血少腹肿胀医案】刘景琪：.....171
【附子汤治子宫肌瘤案】：.....171
【少腹逐瘀汤治疗治疗子宫肌瘤医案】.....171
【血府逐瘀汤加减治疗行气解郁治经闭多囊卵巢综合征】.....171
【多发子宫肌瘤右侧附件囊肿盆腔积液医案】微信网文：.....172
【血府逐瘀汤治疗慢性子宫出血】：.....173
【少腹逐瘀汤加味治治疗慢性盆腔炎医案案例】.....173

【癥瘕起于少腹医案】张锡纯：.....174
【温经汤治子宫肌瘤，乳腺增生，甲状腺亢进癣医案】楞青社：.....174
【活血祛瘀消症瘕】.....174
【大黄牡丹汤治小腹疼痛带下量多输卵管囊性肿块医案】刘芳贵：.....175
【葛根汤合桂枝茯苓丸治脸上麻鹊斑囊肿和肌瘤】蔡长福：.....175
【附子汤治子宫肌瘤案】：.....175
【附子汤治子宫脱垂宫颈糜烂案】：.....176
【当归芍药散治疗子宫下垂】矢数道明：.....176
【附子汤治月子病案】：.....176
【折冲饮治疗月经痛子宫肌瘤卵巢囊肿】矢数道明：.....176
【桂枝茯苓丸行经腹痛黑色血块左侧卵巢囊肿医案】刘昭坤：.....177
【林氏子宫内膜异位症】.....177
第八节 妇人腹满寒疝诸病.....177
【当归生姜羊肉汤治血虚寒疝(慢性胰腺炎)停经医案】刘俊士医案：.....177
【大黄甘遂汤治月事不复小便难少腹满日渐膨隆医案】戴鉴周：.....177
【大黄甘遂汤治闭经三月余腹部膨隆医案】谢胜臣：.....177
【防己椒目葶苈大黄汤治腹胀月经不调医案】孙德华.....178
【大黄附子细辛汤治少腹经常冷痛皮疹密布集簇成片医案】张广麒：.....178
【大黄牡丹汤治盆腔炎医案】魏磊：.....178
【桂枝茯苓丸加味双侧输卵管不通医案】王峰：.....178
第九节 妇人带下诸病.....179
【薏苡附子败酱散治黄带(慢性盆腔炎)医案】.....179
【薏苡附子败酱散治黄带(慢性盆腔炎)医案】江准保：.....179
【附子粳米汤治少女带下医案】夏先福：.....179
【黄芪桂枝五物汤治白带量增多状如鸡子清淋漓不断医案】张宽智：.....180
【肾气汤治带下量多色白质稀医案】金家隆：.....180
【资生汤治痨瘵闭经白带医案】张锡纯.....180
【赤小豆当归散赤白带下医案】彭述宪：.....181
【当归芍药散治带下(慢性附件炎)医案】张天思：.....181
【矾石治带下医案】经方心裁：.....181
【真武汤治疗白带】卢医：.....182
【乌梅丸治疗妇科疾病真菌性阴道炎症见豆腐渣样带下医案】.....182
【桂枝汤加龙骨牡蛎治带下清稀绵绵不断医案】叶益丰：.....182
【反复阴痒二周伴白带增多医案】.....182
【真武汤治白带多清稀无臭医案】亢海荣：.....183
【薏苡附子败酱散治卵巢囊肿流白带医案】于慎中：.....183
【薏苡附子败酱散治黄带(慢性盆腔炎)医案】江准保：.....183
【当归四逆加吴茱萸生姜汤治白带多而清稀经期少腹冷痛医案】陈沅生：.....184
【大黄牡丹汤治腹痛拒按带下色黄臭秽杂有血液医案】刘昭坤：.....184
【大黄牡丹汤治小腹疼痛带下量多输卵管囊性肿块医案】刘芳贵：.....184
【桃花汤以芡实易粳米加肉桂、阿胶治赤白带下经来紫黑淋沥不断】.....184
【桂枝汤加龙骨牡蛎治带下清稀绵绵不断医案】叶益丰：.....185
【附子理中汤加真武汤治患慢性腹泻白带两年医案】娄绍昆：.....185
【当归芍药散少腹作痛慢性盆腔炎白带多医案】岳美中：.....185

第十节 妇人淋之为病 185
【薏苡附子败酱散治劳淋(慢性肾盂肾炎)医案】 185
【甘麦大枣汤小便不禁医案】张正海： 186
【薏苡附子败酱散治劳淋(慢性肾盂肾炎)医案】许琼政： 186
第十一节 妇人不孕证诸疾病 186
【大黄牡丹汤治婚后 9 年不育医案】李玉有： 187
【肾气汤治性欲淡漠幼稚子宫婚后 6 年不孕医案】赵三立： 187
【吴茱萸汤患者婚后两年不孕医案】案例分享： 187
【内经四乌贼骨一蘧茹丸方治左侧输卵管狭窄阻塞】岳美中： 187
【当归四逆汤治子宫肌瘤并不孕症】 187
【血府逐瘀汤治不孕证】 187
【少腹逐瘀汤治不孕医案】王清任： 188
【少腹逐瘀汤治疗不孕症 40 例医案案例】 188
【少腹逐瘀汤治疗不孕症医案】 188
【少腹逐瘀汤治疗不孕症医案】 188
【少腹逐瘀汤治妇女双侧输卵管因炎症而阻塞不通不育医案】 189
【少腹逐瘀汤治妇女不育医案】 189
【半夏厚朴汤治不孕】 189
【少腹逐瘀汤婚后痛经紊乱色紫血块数年无生育】 189
【温经汤治不孕】曹颖甫： 189
【抵当汤治不孕】曹颖甫： 189
【温经汤不孕医案】《经方躬行录》 189
【婚后 2 年不孕经前腹泻如水数年验案】： 190
【附子汤治不孕案】 190
【生水蛭治少腹有癥瘕不育医案】张锡纯： 190
【半夏泻心汤治不孕医案】彭海燕： 191
【防已椒目葶苈大黄汤原发性不孕症医案】侯成钦 191
防已椒目葶苈大黄丸方： 191
【半夏泻心汤治不孕医案】彭海燕 ： 192
【葛根汤合并龙胆泻肝汤治怪病面上肿不能孕】蔡长福： 192
【附子汤治不孕案】 193
【吴茱萸汤患者婚后两年不孕医案】案例分享： 193
【吴茱萸汤治患者婚后两年不孕医案】案例分享： 193
【大黄附子细辛汤治 4 年未孕医案】刘大平： 193
【重用黄连大黄黄连泻心汤面部红肿和不孕的病症】汪阿姨： 193
【金匮肾气丸痛经婚后三年未怀孕】娄绍昆： 193
【六经辨证桂枝汤妇女不孕症的诊治】娄绍昆： 194
【当归芍药散婚后 5 年不孕慢性输卵管炎医案】赵三立： 194
【六经辨证桂枝汤妇女不孕症的诊治】娄绍昆： 194
【金匮肾气丸痛经婚后三年未怀孕】娄绍昆： 195
【桂枝茯苓丸肾盂肾炎未怀孕】娄绍昆： 195
【当归建中汤后半月小腹疼恶露淋漓】娄绍昆： 195
【大黄黄连泻心汤五年未能怀孕】汪阿姨 195
【血府逐瘀汤治不孕证】 195

第十二节 妇人妊娠诸病 196
【当归四逆汤妊娠冲疝，痛甚昏厥】 196
【附子粳米汤治妊娠恶阻医案】夏先福： 196
【附子粳米汤治滑胎(习惯性流产)】夏先福医案： 196
【黄芪桂枝五物汤治妊娠尿不尽之感医案】： 196
【半夏泻心汤加乌梅妊娠恶阻】 196
【四逆当归补血汤加味妊娠胎漏(先兆流产)】 197
【四逆当归补血汤加枣艾半产血崩(流产失血)】 197
【当归芍药散加大黄治疗妊娠的高血压】矢数道明： 197
【当归芍药散呕吐全身黄色鲜明周身浮肿医案】金芝芳： 198
第十三节 妇人产后病 198
【猪苓汤产后患慢性肾炎医案】聂惠民： 198
【回阳饮加味产后失血】 198
【附子粳米汤治产后腹痛医案】夏先福： 199
【当归生姜羊肉汤治产后腹痛医案】李翠萍医案： 199
【当归生姜羊肉汤治产后寒痹气厥医案】辛军： 199
【当归生姜羊肉汤治产后发热医案】张介眉： 199
【黄芪桂枝五物汤治流产后每逢经行及经后小腹疼痛医案】金志春： 200
【一味独参汤产后大出血的案例】刘渡舟: 200
【桃仁承气汤合大陷胸汤、抵当汤死胎不下医案】黎庇留： 200
【小柴胡汤治产后数日大便难呕不能食微眩晕医案】易庆棠： 200
【安冲汤小产后数日忽又下血医案】张锡纯： 201
【抵当汤治半产后脉紧而脐下结硬血不得下医案】日本《生生堂治验》： 201
【产后营卫气血不足新加汤医案】郝万山： 202
【当归生姜羊肉汤治产后身痛加味】杨洪安： 202
【血府逐瘀汤郑氏等产后缺乳】 203
【血府逐瘀汤治疗产后气虚】： 203
【小产后寒热腹痛医案】张璐： 203
【当归生姜羊肉汤治产后发热医案】张介眉： 203
【当归生姜羊肉汤治产后腹痛医案】李翠萍： 204
【异功散治产妇咳而胸满不食涕唾面肿气逆医案】： 204
【资生汤治产后虚劳医案】奉天法库县万生来函： 204
【红蓝花酒产后恶露不尽医案】王明宇： 204
【大黄牡丹汤治产后半月乳汁泌少医案】李玉有： 204
【大黄牡丹汤治新产发热不退医案】李玉有： 205
【葛根汤加高丽参产后发热下利】 205
【小补肝汤治产后综合征抑郁症医案】： 205
【桂枝茯苓丸死男婴小便不通医案】谭俊臣： 205
【桂枝茯苓丸人工流产手术下腹部坠胀疼痛医案】刘绪英： 205
【桂枝茯苓丸人流后阴道出血淋漓不止医案】王明惠： 206
【桂枝茯苓丸死胎医案】张季高： 206
【桂枝茯苓丸初产后恶露不尽医案】蒲辅周： 206
【四逆当归补血汤加味妊娠胎漏(先兆流产)】 207
【当归建中汤后半月小腹疼恶露淋漓】娄绍昆： 207

【血府逐瘀汤郑氏等产后缺乳】.....207
【血府逐瘀汤治疗产后气虚】：.....207
第十四节 妇人其它疾病.....208
【参附汤加味衄血】.....208
【四逆当归补血汤加枣艾治衄血】.....208
【胡希恕桂枝茯苓丸治脉管炎】.....208
【当归生姜羊肉汤治眩晕(低血压眩晕)医案】徐有全：.....208
【当归生姜羊肉汤治肌衄(血小板减少性紫癜)医案】田国栋：.....209
【黄芪桂枝五物汤治左下肢慢性溃疡医案】程莉：.....209
【黄芪桂枝五物汤治皮肤紫殿医案】赵克安：.....209
【黄芪桂枝五物汤治荨麻疹医案】陈国权：.....210
【黄芪桂枝五物汤治产后爱出汗医案】王金洲：.....210
【黄芪桂枝五物汤治产后四肢抽搐医案】金志春：.....210
【黄芪桂枝五物汤治腹产后腰腿疼痛医案】闵捷：.....210
【黄芪桂枝五物汤治顺产后小便欲解而不下医案】张雯：.....211
【黄芪桂枝五物汤治动则汗出恶阻医案】王金洲：.....211
【红蓝花治产后恶露不尽汤医案】王明宇：.....211
【资生汤治产后虚劳医案】奉天法库县万生来函：.....211
【甘麦大枣汤产后自汗医案】吴德熙：.....211
【白头翁汤治产后下利赤白里急后重医案】：.....212
【下瘀血汤产后三天恶露未行随即高热不退神昏谵语医案】胡杰峰：.....212
【桂枝汤加龙骨牡蛎治上半身烘热汗出医案】张秀云：.....212
【当归贝母苦参丸治小便不利有涩痛感医案】赵宁真：.....212
【抵当汤、桃核承气汤治.....212
【下瘀血汤治附件炎】.....213
【心腹满闷医案】张锡纯：.....213
【带下绵注色白已2年】：.....213
【少腹逐瘀汤在妇科临床中的应用】.....213
【少腹逐瘀汤治疗下腹部持续性疼痛医案】.....214
【血府逐瘀汤治更年期综合症】.....214
【少腹逐瘀汤治右侧股骨头坏死医案】.....215
【黄芪建中汤急性盆腔炎医案】何少山章勤：.....215
【升肝舒郁汤治阴挺医案】张锡纯：.....216
第一百〇九节.....216
升肝舒郁汤方：.....216
【理郁升陷汤阴挺医案】张锡纯：.....216
【附子汤治月子病案】：.....216
【下瘀血汤腹痛拒按医案】姜春华：.....216
【下瘀血汤四逆汤活血化瘀产后两日胞衣不下腹中冷痛】张谷才：.....216
【下瘀血汤全身广泛出血医案】林上卿：.....217
【下瘀血汤间歇性左下腹部剧痛医案】胡杰峰：.....217
【大黄甘遂汤治四肢头面肿水与血结在血室】易庆棠：.....217
【大黄甘遂汤治腹大如鼓小便甚难医案】易巨荪：.....217
【大黄甘遂汤变方治产后小腹微胀医案】宋同勋：.....217

【肾气汤治口中泛咸妇女更年期综合症医案】艾发源：.....218
【桂枝汤加龙骨牡蛎治产后暴崩医案】连建伟：.....218
【加味逍遥散治疗老年性郁病】矢数道明：.....218
【当归芍药散妇人交媾疼痛】曹习诠：.....218
【四逆三生饮方证治形寒肢冷性欲下降】阿骅表兄：.....219
第十五节 桂枝茯苓丸方证.....219
【桂枝茯苓丸医案癥瘕(子宫肌瘤)】岳美中：.....219
癥瘕(桂枝茯苓丸加味治卵巢囊肿)刘昭坤：.....219
【胡希恕桂枝茯苓丸治脉管炎】.....220
【麻黄附子细辛汤合桂枝茯苓丸治多囊卵巢综合证一例】.....220
【核承气汤去芒硝合桂枝茯苓丸治脉混合痔】熊兴江：.....220
【桂枝茯苓丸治下肢水肿】熊兴江：.....221
【桂枝茯苓丸治疗肺病】黄煌：.....221
【桂枝茯苓丸治疗咳嗽痰血暗红】黄煌：.....221
【桂枝茯苓丸治疗上肺陈旧性肺结核】黄煌：.....221
【桂枝茯苓丸治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压】黄煌：.....222
【桂枝茯苓丸治疗下肢静脉血栓】黄煌：.....222
【柴胡加龙骨牡蛎汤合桂枝茯苓丸与栀子厚朴汤治疗痴呆老人】黄煌：.....223
【桂枝茯苓丸治性肺栓塞】黄煌：.....223
【桂枝茯苓丸治身上的紫斑】黄煌：.....224
【桂枝茯苓丸加大黄牛膝下瘀血如神】黄煌：.....224
【桂枝茯苓丸方证的一角肺团块状软组织影】黄煌：.....225
【桂枝茯苓丸方证的一角尿毒症的经方透析法】黄煌：.....225
【桂枝茯苓丸治临床应用医案】网文：.....225
【桂枝茯苓丸合安宫牛黄丸治疗晚期肝癌医案】：.....226
【桂枝茯苓丸治列腺增生前列腺炎癃闭医案】：.....226
【桂枝茯苓丸治眩晕医案】：.....226
【桂枝茯苓丸治癃闭哮证(哮喘)】：.....226
【桂枝茯苓丸治腰痛】：.....226
【桂枝茯苓丸治不孕症】：.....226
【桂枝茯苓丸肾盂肾炎未怀孕】娄绍昆：.....226
【桂枝茯苓丸治卵巢囊肿】：.....226
【桂枝茯苓丸治治疗附件囊性包块（卵巢囊肿）】：.....227
【桂枝茯苓丸治慢性盆腔炎】：.....227
【桂枝茯苓丸治痛经（月经期小腹疼痛）】：.....227
【桂枝茯苓丸治子宫肌瘤】：.....227
【桂枝茯苓丸治子宫内膜异位症】：.....227
【桂枝茯苓丸治异位妊娠】：.....227
【桂枝茯苓丸下死胎】：.....227
【桂枝茯苓丸治治疗子宫肥大症】：.....227
【桂枝茯苓丸治黄褐斑】：.....228
【桂枝茯苓丸治痤疮】：.....228
【桂枝茯苓丸加减治乳腺增生】：.....228
【桂枝茯苓丸体会】：.....228

【桂枝茯苓丸加大黄牛膝下瘀血如神】：.....228
【桂枝茯苓丸善于消解少腹腰腿瘀血】：.....228
【桂枝茯苓丸肾盂肾炎未怀孕】娄绍昆.....229
第十六节 药物流产避孕方.....229
【药物流产避孕方】宋孝志：.....229
【避孕“神曲麦芽汤”】宋孝志：.....229
第二十二章 温经汤方证.....229
温经汤方：金匮）.....229
【温经汤医案】王雪华：.....230
【温经汤治男科病】蒋毅：.....230
【温经汤治疗精索静脉曲张】赵淑艳：.....231
【温经汤治肌若鱼鳞】.....231
【能美手的温经汤治手掌皲裂】黄煌：.....231
【用温经汤治疗三年无月经】矢数道明：.....232
【温经汤治疗闭经】.....232
【温经汤治牛皮癣医案】楞青社：.....233
【温经汤治子宫肌瘤，乳腺增生，甲状腺亢进癣医案】楞青社：.....233
【温经汤不孕医案】《经方躬行录》.....233
【温经汤闭经医案】《经方躬行录》.....234
【温经汤痛经医案】《经方躬行录》.....234
【温经汤治不孕】曹颖甫：.....234
【抵当汤治不孕】曹颖甫：.....235
【温经汤合吴茱萸汤治高血压发作时头晕欲呕医案】：.....235
【温经汤治怕冷口腔溃疡案】.....235
【温经汤治经水淋漓不断医案】：.....235
【温经汤治小腹冷痛医案】李贯国：.....236
【温经汤治月经先后不定期医案】秦德平：.....236
【温经汤治阴吹医案】杨百茆：.....236
【温经汤治痛经医案】颜德馨：.....236
【温经汤治不育精子活动率不足医案】张庆云：.....237
【温经汤治阳萎不举医案】李白宪：.....237
【温经汤治睾丸硬痛发胀医案】张庆云：.....237
【温经汤治双手不温指端反复出现苍白青紫麻木医案】高正今：.....237
【温经汤治四肢麻木医案】高正今：.....237
【温经汤治心前区闷痛心肌梗塞医案】魏小萌：.....238
【温经汤治血吸虫性肝硬化少量腹水医案】陈新宝：.....238
【温经汤治口干多梦手掌心热月事不调入睡则尿床医案】萧铁珊：.....238
第二十三章 妇人病偏方.....238
【大黄木香治月经痛经、经少不调秘方】（来源抖音：李振华口述）.....238
【山楂治妇人诸病】张锡纯：.....239
第二十四章 【不育灸法】（出自《备急千金要方》）.....239
第二十五章 妇方常用药.....239
第一节 【鸡内金解】张锡纯：.....239
【鸡内金治月信不通】张锡纯：.....240

【鸡内金治胃脘有硬物杜塞】张锡纯：.....240
【鸡内金治腹有积聚】张锡纯：.....240
【鸡内金治贲门有物窒碍】张锡纯：.....240
【鸡内金治胃痛】张锡纯：.....240
【鸡内金治胃脘旧有停积】张锡纯：.....241
【鸡内金治腹有积聚】张锡纯：.....241
第二节 【穿山甲解】张锡纯：.....241
【穿山甲治血箭证】.....241
第三节 【乳香、没药解】张锡纯：.....241
第四节 【三棱、莪术解】张锡纯：.....241
第五节 【水蛭解】张锡纯：.....242
第二十六章 内经四乌鲗骨一藘茹丸方证.....242
【四乌鲗骨一藘茹丸治血崩医案】.....243
【四乌鲗骨一藘茹丸治漏下医案】.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治月经过多医案】名老中医李祥云：.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治产后恶露不绝医案】.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治带下医案】.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治经期延长医案】.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治闭经医案】.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治不孕医案】岳美中：.....244
【四乌鲗骨一藘茹丸治宫颈癌医案】王三虎：.....245
第二十七章 温经汤方证.....245
温经汤方：古本）.....248
温经汤方：金匮）.....248
【温经汤治烦心医案】王雪华：.....248
【温经汤治男科病】蒋毅：.....248
【温经汤治疗精索静脉曲张】赵淑艳：.....249
【温经汤治肌若鱼鳞】.....249
【能美手的温经汤治手掌皲裂】南京中医药大学黄煌：.....249
【用温经汤治疗三年无月经】矢数道明：.....250
【温经汤治疗闭经】.....251
【温经汤治牛皮癣医案】楞青社：.....251
【温经汤治子宫肌瘤，乳腺增生，甲状腺亢进癣医案】楞青社：.....251
【温经汤不孕医案】《经方躬行录》.....251
【温经汤闭经医案】《经方躬行录》.....252
【温经汤痛经医案】《经方躬行录》.....252
【温经汤治不孕】曹颖甫：.....253
【温经汤合吴茱萸汤治高血压发作时头晕欲呕医案】：.....253
【温经汤治怕冷口腔溃疡案】.....253
【温经汤治经水淋漓不断医案】：.....253
【温经汤治小腹冷痛医案】李贯国：.....254
【温经汤治月经先后不定期医案】秦德平：.....254
【温经汤治阴吹医案】杨百茆：.....254
【温经汤治痛经医案】颜德馨：.....254

【温经汤治不育精子活动率不足医案】张庆云：.....255
【温经汤治阳萎不举医案】李白宪：.....255
【温经汤治睾丸硬痛发胀医案】张庆云：.....255
【温经汤治双手不温指端反复出现苍白青紫麻木医案】高正今：.....255
【温经汤治四肢麻木医案】高正今：.....255
【温经汤治心前区闷痛心肌梗塞医案】魏小萌：.....256
【温经汤治血吸虫性肝硬化少量腹水医案】陈新宝：.....256
【温经汤治口干多梦手掌心热月事不调入睡则尿床医案】萧铁珊：.....256
第二十八章 桃核承气汤方证.....256
【抵当汤桃核承气汤治半产后面色黧黑下焦蓄血医案】《生生堂治验》.....256
【小柴胡汤证与桃仁承气汤证俱在的三叉神经痛】娄绍昆：.....257
【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：.....258
第二十九章 血府逐瘀汤方证.....258
【血府逐瘀汤治疗活血祛瘀消症瘕子宫肌瘤】：.....258
【血府逐瘀汤加减治疗软坚散结化乳癖】：.....259
【血府逐瘀汤加减治疗行气解郁治经闭多囊卵巢综合征】：.....259
【血府逐瘀汤治疗慢性子宫出血】：.....260

简介

《傅青主女科》是清代主要传世之妇产科专着，由傅青主编着。傅青主，名山，字青主，是明末清初著名的医学家、思想家、诗人、学者、画家和爱国志士。

《傅青主女科》共二卷，医论独有见地，通俗易懂，立法严谨而灵活，制方精良且不矜奇立异，疗效卓著而备受中医妇科医家尊崇，堪为妇科之精典。

张序

青主先生于明季时，以诸生伏阙上书，讼袁临侯冤事，寻得白，当时义声动天下。《马文甬义士传》比之裴瑜、魏邵。国变后，隐居崛（山围）山中，四方仰望丰采。己未鸿词之荐，先生坚卧不赴。有司敦促就道，先生卒守介节，圣祖仁皇帝鉴其诚，降旨：傅山文学素着，念其年迈，从优加衔，以示恩荣。遂授内阁中书，听其回籍。盖其高尚之志，已久为圣一辈子所心重矣。而世之称者，乃盛传其字学与医术，不已细哉！字为六艺之一，先生固尝究心。若医者，先生所以晦迹而逃名者也。而名即随之，抑可奇矣。且夫医亦何可易言。自后汉张仲景创立方书以来，几千年来，专门名家，罕有穷其奥者。先生以余事及之，遽通乎神。余读《兼济堂文集》并《觚賸》诸书，记先生轶事。其诊疾也微而臧，其用方也奇而法，有非东垣、丹溪诸人所能及者。昔人称张仲景有神思而乏高韵，故以方术名。先生即擅高韵，又饶精思，贤者不可测如是耶。向闻先生有手著女科并产后书二册，未之见也，近得钞本于友人处。乙酉适世兄王奎章来省试，具道李子缉中贤。至丙戌冬，果寄资命剞劂。甚德事也。故乐为序而行之，并述先生生平大节，及圣朝广大之典，不禁为之掩卷而三叹也。

道光丁亥夏五月丹崖张凤翔题。

祁序

执成方而治病，古今之大患也。昔人云：用古方治今病，如拆旧屋盖新房，不经大匠之手，经营如何得宜。诚哉是言！昔张仲景先生作《伤寒论》，立一百一十三方，言后世必有执其方以误人者甚矣，成方之不可执也。然则今之女科一书，何为而刻乎？此书为傅青主征君手着，其居心与仲景同，立方与仲景异。何言之？仲景伤寒论杂症也，有五运六气之殊，有中表传里之异。或太阳、太阴不一其禀，或内伤、外感不一其原，或阳极似阴、阴极似阳不一其状，非精心辨证，因病制方，断不能易危就安，应手即愈。此书则不然，其方专为女科而设，其证则为妇女所同。带下血崩，调经种子，以及胎前产后，人虽有虚实、寒热之分，而方则极平易、精详之至，故用之当时而效，传之后世而无不效。非若伤寒杂病，必待临症详审，化裁通变，始无贻误也。尝慨后世方书汗牛充栋，然或偏攻偏补，专于一家，主热主寒，坚执谬论，炫一己之才华，失古人之精奥。仲景而后，求其贯彻《灵》、《素》，能收十全之效者，不数数觏。读征君此书，谈证不落古人窠臼，制方不失古人准绳。用药纯和，无一峻品；辨证详明，一目了然。病重者，十剂奏功；病浅者，数服立愈。较仲景之《伤寒论》，方虽不同，而济世之功则一也。此书晋省钞本甚伙，然多秘而不传，间有减去药味，错乱分量者，彼此参证，多不相符。兹不揣冒昧，详校而重刊之。窃愿家置一编，遇症翻检，照方煎服，必能立起沉疴，并登寿域。或亦济人利世之一端也夫。

道光十一年新正上元同里后学祁尔诚谨序

罗序

傅氏之方，对于妇人之疾，众医家用之神验，故此书广为传讼。此为我的学习笔记，傅

氏之言，较难理解，故而我加了医案，加了其它注家之言，以明医理。

看此书应该活看，不是看它治女科什么病，应该看它治具体病背后的机理，就是说看一看背后的病因和病机，只要病机相同，用方是可以一样的。并不单用于女科，男科也一样可以用。就象《医林改错》的王清任所言，只要血府一通，就能治百病，此言其实夸大成份，但是依其之法，往往又能真的治好病。所以，寻求药方背后的机理很重要。

日本人更对中医扩展了思路，日本人他提出一个方子作用部位的方法，就是说，这个方子就是对这个疾病的位置起作用的。所以看本书的方子的时候，也思考一下这个方子的作用部位和这个方子的机理。没有相同的医案，但有相同的机理。

我附了很多女科医案。只要是女科的都附上，扩大认识范围，不仅限于傅氏的认识范围。这个书是没有发行版本的，如果需要还是要自行印制。

这个书有什么错误的地方，希望加我 QQ：284377157（微信同）告诉我。喜欢这个书的朋友。想印刷的，直接联系热心网友代印，微信号：mimicatlife3，或者微信号：LMJ2238245774，加他注明“印书”就是了。我会将最新更新版本发给他。

罗维跃　2020 年于连州

女科上卷

第一章 带下

第一节 白带下

曰：夫带下俱是湿症。而以“带”名者，因带脉不能约束而有此病，故以名之。盖带脉通于任、督。任、督病而带脉始病。带脉者，所以约束胞胎之系也。带脉无力，则难以提系，必然胎胞不固，故曰带弱则胎易坠，带伤则胎不牢。然而带脉之伤，非独跌闪挫气已也，或行房而放纵，或饮酒而颠狂，虽无疼痛之苦，而有暗耗之害，则气不能化经水，而反变为带病矣。故病带着，惟尼僧，寡妇，出嫁之女多有之，而在室女则少也。

况加以脾气之虚，肝气之郁，湿气之侵，热气之逼，安得不成带下之病哉！故妇人有终年累月下流白物，如涕如唾，不能禁止，甚则臭秽者，所谓白带也。夫白带乃湿盛而火衰，肝郁而气弱，则脾土受伤，湿土之气下陷，是以脾精不守，不能化荣血以为经水，反变成白滑之物，由阴门直下，欲自禁而不可得也。治法宜大补脾胃之气，稍佐以舒肝之品，使风木不闭塞於地中，则地气自升腾於天上，脾气健而湿气消，自无白带之患矣。方用完带汤。

完带汤方：

白术一两（土炒），山药一两（炒），人参二钱，白芍五钱（炒），车前子三钱（酒炒），苍术三钱（制），甘草一钱，陈皮五分，黑芥穗五分，柴胡六分

水煎服。二剂轻，四剂止，六剂则白带全愈。

方歌：完带汤中二术陈，人参甘草车前仁，柴芍淮山黑芥穗，化湿止带此方神。

傅山曰：此方脾、胃、肝三经同治之法，寓补於散之中，寄消於升之内，开提肝木之气，则肝血不燥，何至下克脾土?补益脾土之元，则脾气不湿，何难分消水气。至於补脾而兼以补胃者，由里以及表也。脾非胃气之强，则脾之弱不能旺，是补胃正所以补脾耳。

王雪华曰：已经摸索出来的成熟经验，如果白术要生用的话，在 25-30 克，的用量上，就会造成便稀，有通便的作用。焦白术，它就健脾、补脾。所以，这就是你想止泻或健脾，就得是焦白术，炒白术，这在儿科上非常实用，你不一定不是为了通便，就用榔片，甚至于大黄后下，那对小孩的脾胃非常有伤害。

药解：黑芥穗又名黑荆芥、荆芥炭。是将荆芥切段后，用赋火炒至焦艳，存性，少喷清水，取出晾干入药。性味与经：辛涩，微温。归肺、肝经。收涩止血。用于便血，崩漏，产后血晕。

病因病机：中焦脾胃虚而水湿

辩证依据：脾胃虚不纳食，便溏、白带下，白舌淡苔白，脉濡缓

方剂学曰：功用补脾疏肝，化湿止带。主治脾虚肝郁，湿浊带下。带下色白，清稀如涕，面色晄白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓或濡弱。本方为治疗白带的常用方剂，所主病证乃由脾虚肝郁、带脉失约、湿浊下注所致。脾虚生化之源不足，气血不能上荣于面致面色晄白；脾失健运，水湿内停，清气不升致倦怠便溏；脾虚肝郁，湿浊下注，带脉不固致带下色白量多、清稀如涕；舌淡白，脉濡弱为脾虚湿盛之象。治宜补脾益气，疏肝解郁，化湿止带。方中重用白术、山药为君，意在补脾祛湿，使脾气健运，湿浊得消；山药并有固肾止带之功。臣以人参补中益气，以助君药补脾之力；苍术燥湿运脾，以增祛湿化浊之力；白芍柔肝理脾，使肝木条达而脾土自强；车前子利湿清热，令湿浊从小便分利。佐以陈皮之理气燥湿，既可使补药补而不滞，又可行气以化湿；柴胡、芥穗之辛散，得白术则升发脾胃清阳，配白芍则疏肝解郁。使以甘草调药和中，诸药相配，使脾气健旺，肝气条达，清阳得升，湿浊得化，则带下自止。

本方的配伍特点是寓补于散，寄消于升，培土抑木，肝脾同治。

【运用】：

1．辨证要点：本方为治脾虚肝郁，湿浊下注带下之常用方。临床应用以带下清稀色白舌淡苔白，脉濡缓为辨证要点。

2．加减变化　若兼湿热，带下兼黄色者，加黄柏、龙胆草以清热燥湿；兼有寒湿，小腹疼痛者，加炮姜、盐茴香以温中散寒；腰膝酸软者，加杜仲、续断以补益肝肾；日久病滑脱者，加龙骨、牡蛎以固涩止带。

3．现代运用　本方常用于阴道炎、宫颈糜烂、盆腔炎而属脾虚肝郁，湿浊下注者。

4．使用注意　带下证属湿热下注者，非本方所宜。

罗按：此方剂与补中益所汤有相似，大抵亦是先补中益气。此法傅氏云为脾虚而湿盛而火衰，肝郁而气虚的白带而设。带脉横通于腰，所以联系诸经者也。带脉则横围于腰，状如束带，所以总约诸脉者也。带脉是人体奇经八脉之一，多在侧腹部的位置，章门穴下 1.8 寸的地方，在肚脐位置绕腰围一圈。带脉有保护妇女带下的作用。临床上常用于治疗月经不调，闭经，腹痛，疝气和腰痛等病症。现在多用于辅助治疗子宫内膜炎，附件炎和盆腔炎等妇科疾病。本方名为完带汤，其实是带脉为病，病位在带脉，病根在脾胃，不独言胞宫，也不独言白带之下，而病因和为脾虚而下焦寒湿，是既寒且湿也，病位在胞宫之部位，为诸病也，而外证各异。是经气弱为病机先而诸病生也。青主言“脾 、胃、肝三经同治”，其实谓病在下焦，治在中焦者是也，盖中焦能为下焦供气血，其治也。

此方若对证而治，用之神验，但实践得出一些经验：用红参比白参好，不知何因，或许是白参种植药效不大罢，这个是病人得出的经验。白术和山药要自行用黄土干炒，炒后药带黄土，不要洗去，此乃伏龙肝。陈皮不能用药房的，药房多为新皮，色带红，须另行找，必用三年，陈年之皮色黑。

若用此方无效，得从药上思考一下。不要开出方无效就算了，其实方中须制过的药，药店基本没有。比如白术无土炒，山药、白芍无炒制的卖。车前子也没有酒炒的。

此方虽名为完带汤，不专为妇人而设，若是男者，病机相同比如肝有郁而脾有虚，下焦又虚，也可用此方。读者在看此书时得思考一下，不要让什么土啊火啊弄糊涂了，这是古人的一个理论，很玄乎的一个理论。我们现代就是说白带的出现，其实是下焦出现毛病了。白带是什么东西？其实人体本来就存在白带，就是一些分泌物，正常的时候，它也有分泌，比如说在房事的时候就大量分泌出来，现在它自己走出来了，就是下焦虚，失去收约了。就是肯定的说，这是虚证。治法是：虚则补之。但是在这里，它不能补本脏，要补其母，补脾胃。为什么？就是说下焦的元气和营卫气血，皆来自中焦脾胃，现在的情况是，脾胃本身已经虚了，所以不能向下焦提供元气物质。所以要补脾胃。为什么要治肝啊，古人说，肝管疏泄的，就是白带的生成与排出它都管。其实呢，它不但管白带，也管女人的月经和奶水，这个就是厥阴肝经所主，就是说，白带的生成就归脾胃管。但是白带的开关在肝经上，有一个疏肝的问题。

《金匮要略》曰：妇人之病，因虚，积冷结气，为诸经水断绝，血结胞门。或绕脐疼痛，状如寒疝；或痛在关元，肌若鱼鳞；或阴中掣痛，少腹恶寒；或引腰脊，或下气街，此皆带下。

《伤寒论》曰：带脉为病，苦腹痛，腰间冷痛，脉当沉而细，治属少阴。

秦越人曰：带之为病，腹满，腰溶溶如坐水中。（溶溶缓慢貌）

明堂曰：带脉二穴，主腰腹纵溶溶如囊水之状。妇人少腹痛，里急后重，螈月事不调，赤白带下，可针六分，灸七壮。张洁古曰：带脉之病，太阴主之，宜灸章门二穴，三壮。

素问曰：邪客于太阴之络，令人腰痛引小腹控，不可以养息。（谓季胁下之空软处）

张仲景曰：大病瘥后，腰以下有水气，牡蛎泽泻散主之。若不已，灸章门穴。

王叔和曰：带脉为病，左右绕脐，腰脊痛，冲阴股也。

王海藏曰:小儿癫疝，可灸章门三壮而愈，以其与带脉行于厥阴之分，而太阴主之。

又曰：女子经病血崩，久而成枯者，宜涩之益之。血闭久而成竭者，宜益之破之。破血有三治，始则四物入红花，调黄、肉桂。次则四物入红花，调鲮鲤甲、桃仁、桂，童子小便，利酒煎服。末则四物入红花，调易老没药散。

张子和曰：十二经与奇经七脉，皆上下周流，惟带脉起少腹之侧，季胁之下，环身一周，络腰而过，如束带之状。而冲、任二脉，循腹胁，夹脐旁，传流于气冲，属于带脉，络于督脉，冲、任、督三脉，同起而异行，一源而三歧，皆络带脉。因诸经上下往来，遗热于带脉之间，客热郁抑，白物满溢，随溲而下，绵绵不绝，是为白带。内经云：思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，发为筋痿，及为白淫。白淫者，白物淫衍，如精之状，男子因溲而下，女子绵绵而下也，皆从湿热治之，与治痢同法。赤白痢乃邪热传于大肠，赤白带乃邪热传于小肠，后世皆以赤为热、白为寒，流误千载，是医误之矣。

【灸带脉穴治妇人患赤白带下医案】

又曰：生经载一妇人患赤白带下，有人为灸气海未效，次日为灸带脉穴（注：侧腹部），有鬼附耳云，昨日灸亦好，只灸我不着，今灸着我，我去矣，可为酒食祭我。其家如其言祭之，遂愈。予初怪其事，因思晋景公膏肓二鬼之事，乃虚劳已甚，鬼得乘虚居之。此妇亦或劳心虚损，故鬼居之。灸既着穴，不得不去。自是凡有病此者，每为之按此穴，莫不应手酸痛，令归灸之，无有不愈。其穴，在两胁季肋之下一寸八分，若更灸百会穴尤佳。《内经》云：上有病下取之，下有病，上取之。又曰：上者下之，下者上之，是矣。

【带脉穴定位】：在侧腹部，章门下 1.8 寸，当第 12 肋骨游离端下方垂线与脐水平线的交点上

刘宗浓曰：带下多本于阴虚阳竭，营气不升，经脉凝涩，卫气下陷，精气积滞于下焦奇经之分，蕴酿而成。以带脉为病得名，亦以病形而名，白者属气，赤者属血，多因醉饱房劳，服食燥热所致。亦有湿痰流注下焦者，肾肝阴淫湿胜者；或惊恐而木乘土位，浊液下流；或思慕无穷，发为筋痿，所谓二阳之病发心脾也；或余经湿热，屈滞于少腹之下，或下元虚冷，子宫湿淫。治之之法，或下或吐，或发中兼补，补中兼利，燥中兼升发，润中兼温养，或温朴，或收涩，诸例不同，亦病机之活法也。

巢元方《病源》曰：肾着病，腰痛冷如冰，身重腰如带五千钱，不渴，小便利，因劳汗出，衣里冷湿而得，久则变为水也。《千金》用肾着汤，《三因》用渗湿汤，李东垣用独活汤主之。

罗按：带脉出现毛病了，外证腹中苦痛，腰间冷痛，脉应当现沉而细，应该从少阴上下手。少阴者，肾也，这个外证有些似肾着汤证。“肾着之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦，身劳汗出，衣一作表）里冷湿，久久得之，腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘草干姜茯苓白术汤主之。”

民方歌:完带汤中用白术，山药人参白芍辅，苍术车前黑芥穗，陈皮甘草与柴胡。

注家曰：本方所主病证乃由脾虚肝郁、带脉失约、湿浊下注所致。脾虚生化之源不足，气血不能上荣于面致面色㿠白；脾失健运，水湿内停，清气不升致倦怠便溏；脾虚肝郁，湿浊下注，带脉不固致诸病，此方不仅治白带，而此以白带为病为医案耳。本方为治脾虚肝郁，湿浊下注带下之常用方。临床应用以带下清稀色白舌淡苔白，脉濡缓为辨证要点。

若带下色白量多、清稀如涕；舌淡白，脉濡弱为脾虚湿盛之象。治宜补脾益气，疏肝解郁，化湿止带。方中重用白术、山药为君，意在补脾祛湿，使脾气健运，湿浊得消；山药并有固肾止带之功。臣以人参补中益气，以助君药补脾之力；苍术燥湿运脾，以增祛湿化浊之力；白芍柔肝理脾，使肝木条达而脾土自强；车前子利湿清热，令湿浊从小便分利。佐以陈皮之理气燥湿，既可使补药补而不滞，又可行气以化湿；柴胡、芥穗之辛散，得白术则升发脾胃清阳，配白芍则疏肝解郁。使以甘草调药和中，诸药相配，使脾气健旺，肝气条达，清

阳得升，湿浊得化，则带下自止。

配伍特点：寓补于散，寄消于升，培土抑木，肝脾同治。

加减化裁：若兼湿热，带下兼黄色者，加黄柏、龙胆草以清热燥湿；兼有寒湿，小腹疼痛者，加炮姜、盐茴香以温中散寒；腰膝酸软者，加杜仲、续断以补益肝肾；日久病滑脱者，加龙骨、牡蛎以固涩止带。

禁忌：带下证属湿热下注者，非本方所宜。

【完带汤治白带医案】摘自《河南中医》：

陈某，30 岁，1998 年 5 月 20 日初诊。因家中变故悲伤而起，近月来自觉白带量多，绵绵不断，日换内裤 2 次，白带色白质清稀，有轻微腥味，面色萎黄，精神倦怠，胃纳不佳，便软，腰酸，舌质淡，苔薄白，脉细弱。诊断为带下病脾虚型，治以健脾益气，除湿止带佐补肾。用完带汤加减：炒党参 15g，炙黄芪 15g，炒白术 20g，怀山药 30g，苍术 10g，陈皮 10g，炒柴胡 4.5g，荆芥 4.5g，车前子（包）12g，芡实 15g，白鸡冠花 10g，炒杜仲 12g。7 剂，水煎服。

二诊：药后白带量较前减少，精神好转，惟腰酸仍明显，治宗原法出入。方药：炒党参 15g，炙黄芪 15g，炒白术 20g，怀山药 30g，陈皮 10g，焦谷芽 10g，车前子（包）12g，芡实 12g，炒杜仲 12g，炒川续断 12g，金樱子 12g，覆盆子 12g。服用 14 剂痊愈。

【医案分析】：病起于“变故悲伤”，要考虑情绪因素，即要考虑到肝。“白带量多...清稀，有轻微腥味，面色萎黄，精神倦怠，胃纳不佳”，这是典型的脾虚内湿下注。上二者结合，可能是肝旺伤脾，也可能是本有脾虚，遭肝乘而病作。当下症状群中，脾虚表现非常突出，应是以此为主，从脉象不弦也能够看出来。舌淡、脉细弱也提示是虚证。“腰酸”，可能兼有肾虚，甚至肾虚不固又加重了带下（经、尿、精、带都容易受肾的影响）。治疗可以健脾渗湿为主，佐以升脾阳、疏肝、补肾、固涩止带，正可用补脾疏肝、祛湿止带的完带汤为基础加味。

作者在此方基础上，加芡实、山药补肾固涩，加芡实、杜仲止腰酸，白鸡冠花止带。7 剂后腰酸以外均明显好转，遂再添续断、金樱子、覆盆子三味加强补肾力量，后二者还兼可收涩止带，又 14 剂痊愈。方证较为简洁，效果较好。

【完带汤治疗白带阴痒】网文：

网友绿叶，网上看到本人用白头翁汤治疗阴痒，遂自己试服，但无效，也无副作用。寻到本人，再次咨询。详细问之：白带清稀，偶觉自流。阴痒仅是外部。非白头翁汤所治。

处方：傅青主之完带汤原方，一钱四克，计，四剂。后来反馈，服至四剂，白带止，阴痒止，续服三剂。

罗按：续服三剂很好，巩固治疗。本人也用完带汤治阴痒一例，主诉是阴痒，下焦的问题，但实际上是脾胃虚寒，容易便溏，完带汤其实是治中焦的，吃了 30 剂才愈。

《邓中甲方剂学讲稿》中关于完带汤的论述：

完带汤也是从固涩剂移过来的，脾虚带下。

主证分析：肝郁脾虚，湿浊下注证。“夫白带乃湿盛而火衰，肝郁而气弱，则脾土受伤，湿土之气下陷，是以脾精不守，不能化荣血以为经水，反变成白滑之物，由阴门直下，欲自禁而不可得也。”

火衰，阳气不足。肝郁而气弱，则脾土受伤，脾虚，脾湿下流，形成白带。肝郁你看不出来，但是在用法上又是健脾调肝相结合的。他对白带的认识，湿盛而火衰，火衰失于温化，肝郁而气弱，肝脾同病，则脾土受伤，湿土之气下陷，是以脾精不守，不能化荣血以为经水，反变成白滑之物，由阴门直下，欲自禁而不可得也。”

白带来源于脾虚不运，这个过程当中，肝气郁结不能助脾胃运化这个有关，所以他认为肝脾同病。

首先木不疏土，导致脾虚，当然这个证在临床反应往往脾虚很突出，脾虚很突出就是有一组基本的脾虚表现，同时肝郁以后不能升发，肝的升发对脾的升清有关系，所以脾不能升清，加上脾虚不运，就湿盛，湿浊下注就造成带下量多，他的指导思想，是这样一个病机过程。

治疗方面，既要益气健脾，帮助脾运化水湿，又要通过疏肝解郁来帮助肝的升发。这样使木能疏土，脾能升清，加上脾的运化来治疗这种脾虚带下。所以病机上，完带汤是针对脾虚肝郁，临床上病人可以有肝郁的表现。也可以从症状上不明显。它是从带下的形成的机理，来推导这个病机和组方的。

带下主证，必然由两组构成：一个有基于的脾虚见证。再加上往往白带量多，由于有气虚，脾不健运造成的湿浊下注，所以往往比较清稀，无臭味。构成了脾虚湿浊下注，这个带下证。

治法：补脾疏肝，化湿止带。

疏肝的作用两个，一个帮助脾胃运化，脾虚之后，往往肝脾不和。一个是疏肝有助脾的升清。所以完带汤还是建立在四君子汤的基础上的，利用**建脾补气的四君子汤**的基本结构。

方解：君：白朮，燥湿运脾；山药，补脾，又固肾。

臣：人参，四君子汤基础；苍朮、白芍、车前子，泌别清浊

佐：陈皮　理气化湿；柴胡，疏肝，又升清阳；黑芥穗；疏肝收涩

使：甘草　益气，调和药味

白朮、苍朮同用，增加燥湿运脾的作用。山药用量也较大，既能补脾，又能固肾，带脉失固，所以用山药固肾。这样四君子汤基础上加上山药，又用苍朮。他不用茯苓的意思，茯苓是健脾渗湿的，可以增加这脾湿下流的这种趋向，不用茯苓用车前子，车前子既能泌别清浊，能够利湿，利湿的起点是小肠，膀胱向下的。起点不是脾胃，不会促使脾湿下流，而是对以下流的脾湿形成的带下，也渗湿泄浊的作用。这个构思，用药上，也充分考虑了药物的归经。

芍药在这里，对于补气当中结合益阴养血，一般这类脾虚病程较长，气虚可以影响到阴血的不足，这是一个方面。第二方面，和柴胡相配，有调肝的作用。实际上这里面又结合了相当于疏肝、健脾、养血的一些基本结构。这是柴胡、芍药可以调肝。陈皮、柴胡、荆芥穗这一组，刚才说到柴胡本身可以升举清扬，在这里可以调肝。和荆芥穗相配，黑芥穗，炒一炒，一个它有疏肝作用，他自己解释，芥穗是为了疏肝。黑芥穗还带有一点收涩作用。和柴胡一配，既能疏肝，又能够升清阳。陈皮是理气化湿。用甘草本身益气，加上调和药味。

整个完带汤，从治法方面是一个肝脾同治，同时体现了升降兼顾。有升清降浊作用。升清降浊、既益气，补脾调肝，又化湿泄浊，标本兼顾。用药是比较平和的。适合于脾虚日久，带下量多，这个可以服用时间较长。所以形成了妇科，治疗白带的一个常用名方。

他构思治法吸取了调肝脾的理论，而且吸取了李东垣升举清阳的方法。用药上认真的斟酌，的确像李东垣这个四君子汤，不用茯苓，改用车前子。包括燥湿、化湿、渗湿，三焦分消，多种祛湿的手段也是综合的。特别柴胡、芥穗的相配，也是一种升举清阳，疏肝，来肝脾同治。

辨证要点：带下清稀色白，舌淡苔白，脉濡缓。(这典型的反映出气虚型，气虚不化湿)

随证加减：兼寒证，小腹疼痛，加炮姜，茴香(温里)

腰脊酸软，加杜仲、续断(病久涉及到肾，增加补益肝肾)

带下日久，量多滑脱者，加龙骨、牡蛎。

【附子汤白带量多二年余伴腰酸腹痛而凉医案】孙长德：

赵某，女，32 岁，1982 年 3 月 2 日诊。白带量多二年余，经多方医治未效。现症白带量多而清稀，味腥，淋漓不断，伴腰酸，腹痛而凉，小便清长•月经二月未潮，舌淡、苔白滑，

脉沉迟。证属肾阳不足，阳虚内寒。治以温经通阳，固涩止带为主。方投附子汤加味：

附子 12 克，白朮、党参、破故纸各 15 克，茯苓 20 克，白芍 10 克，肉桂 6 克。

连服 2 剂后，白带大减，守上方加吴茱萸 6 克，又服 2 剂，月经来潮，量中、色黯。经净后守上方去吴茱萸，加鹿角霜 30 克，又连服 2 剂，白带止，后以白带丸善后。

【附子汤小腹下坠白带多宫颈糜烂医案】权依经：

朱某某，女，32 岁，1980 年 3 月 10 日初诊。患者自感小腹下坠，白带多，质稀薄，无臭味，已一年余。活动后病情往往加重，伴有小腹冰凉，腰酸，疲乏无力。西医诊断为子宫脱垂 I 度，宫颈糜烂 I 度。舌体胖质淡白，苔薄白，脉沉迟。辨证为脾肾阳虚。方用附子汤治疗：

附片 6 克，白朮 12 克，白芍 9 克，茯苓 9 克，党参 6 克。开水煎分二次服。3 剂。

二诊：患者服上药后，自感白带减少，下坠感轻，小腹冰凉有所好转。舌脉同上。仍用上方，继服 3 剂。三诊：患者又服 3 剂后，自感病情更为好转，白带已转正常，小腹转温，腰酸、乏力亦明显好转，惟活动后有小腹下坠之感。脉转为和缓有力。继用上方，再服 3 剂。

四诊：患者服上方共 9 剂后，诸症消失，已能参加轻微劳动，小腹不再感觉下坠，舌脉亦转为正常。故令其停药观察，至今病未复发。

第二节 青带下

【原文】：妇人有带下而色青者，甚则绿如绿豆汁，稠粘不断，其气腥臭，所谓青带也。夫青带乃肝经之湿热。肝属木，木色属青，带下流如绿豆汁，明明是肝木之病矣。但肝木最喜水润，湿亦水之积，似湿非肝木之所恶，何以竟成青带之症？不知水为肝木之所喜，而湿实肝木之所恶，以湿为土之气故也。以所恶者合之所喜必有违者矣。

肝之性既违，则肝之气必逆。气欲上升，而湿下带青欲下降，两相牵掣，以停住于中焦之间，而走于带脉，遂从阴器而出。其色青绿者，正以其乘肝木之气化也。逆轻者，热必轻而色青；逆重者，热必重而色绿。似乎治青易而治绿难，然而均无所难也。解肝木之火，利膀胱之水，则青绿之带病均去矣。方用加减逍遥散。

加减逍遥散方：

茯苓五钱，白芍五钱（酒炒），甘草五钱（生用），柴胡一钱，茵陈三钱，陈皮一钱，栀子三钱(炒)

水煎服。二剂而色淡，四剂而青绿之带绝，不必过剂矣。

傅山曰：夫逍遥散之立法也，乃解肝郁之药耳，何以治青带若斯其神与？盖湿热留於肝经，因肝气之郁也，郁则必逆，逍遥散最能解肝之郁与逆。郁逆之气既解，则湿热难留，而又益之以茵陈之利湿，栀子之清热，肝气得清，而青绿之带又何自来！此方之所以奇而效捷也。倘仅以利湿清热治青带，而置肝气於不问，安有止带之日哉！

病因与病机：肾虚湿热带下

辩证依据：

罗按：古典的医学，限于当时的认识，往往以现象为本质，见色青为肝之色。我们在看古典医学时应当思考一下。这个带下青色，和上边的白带的区别是，白带它容易流出来，但假若白带留而不出，变质了，变成青色才出来，这就是青带了，就象腐烂了的牡蛎，其色青，恶臭。

白带是什么东西？其实人体本来就存在白带，就是一些分泌物，正常的时候，它也有分泌，只是在房事的时候就大量分泌出来。并不是说你要的时候它才分泌出来的，它其实本来就有，储存在器官内。正常的时候，不变质，白带是有活力的清稀状物质，就象食物放在冰箱中一样。若是冰箱坏了，物质就腐烂了，就是说，保存白带的冰箱出了毛病，白带腐烂变

质了，这就是青带的由来，它腐烂，所以腥而臭，就象臭鸡蛋一样。就是说流出来的青带是一种没有生命力的腐烂物质。

古人很聪明，因为它是腐烂，就是说有热，放在冰箱的东西不会腐烂变质的，只有温度高的地方才容易，就是说，凡是腐烂的情况出现，都与热相关。就是说，因为有热，里面的东西就腐烂了。腐烂了才流出来。就是肯定的说，这是热证。有湿的热证。

治法是：一是要肝经中解决热的问题，栀子、茵陈。要把器官中的腐烂物质排出来，这是肝的问题。古人说，肝管疏泄的，就是白带的生成与排出它都管。其实呢，它不但管白带，也管女人的月经和奶水，这个就是厥阴肝经所主，就是说，白带的生成就归脾胃管。但是白带的开关在肝经上，有一个疏肝的问题。

二是要解决一个通道的问题，白带的生成与排出它有一个通道，要把这个通道打通，是不是，这个通道有气机，也有水道。所以用柴胡理气机，用茯苓利水道。

上边邓中甲说了为什么不用茯苓，茯苓渗湿啊，这里却用茯苓是为什么？因为白带留而不出，所以变成青带，所以要用茯苓利水渗湿，让滞于其中的带液托出来。

青带是蕴含有热，热令物腐烂，故知也。治从厥阴肝经。肝藏血，大抵肝结郁结，营卫不行，血流不动，是以秽不能出。“流水不腐，户枢不蠹”之义也。

此方由逍遥散去白术，加陈皮、茵陈、栀子而来。

逍遥散方：

肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚者。

甘草半两（微炙赤，15g），当归（去苗，锉，微炒）、茯苓（去皮，白者）、白芍药、白术、柴胡（去苗）各一两(各 30g)

上为粗末，每服二钱(6g)，水一大盏，烧生姜一块切破，薄荷少许，同煎至七分，去滓热服，不拘时候（现代用法：共为散，每服 6-9g，煨姜、薄荷少许，共煎汤温服，日 3 次。亦可作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌减。亦有丸剂，每服 6-9g，日服 2 次）。

加味逍遥散是在逍遥散的基础上加丹皮、栀子而成，故又名丹栀逍遥散、八味逍遥散。因肝郁血虚日久，则生热化火，此时逍遥散已不足以平其火热，故加丹皮以清血中之伏火，炒山栀善清肝热，并导热下行。临床尤多用于肝郁血虚有热所致的月经不调，经量过多，日久不止，以及经期吐衄等。

朱进忠丹栀逍遥散加减医案十二则：

【丹栀逍遥散治月经期间感冒】朱进忠：

李女，女，38 岁。七、八年来，每次月经将至前一两天即出现头痛身痛，鼻塞流涕，频繁的喷嚏，或见轻微的咳嗽，月经过后两天以上症状自然消失，前后曾用多种西药和中药解表清热、疏风散寒、补气固表之剂治疗，一直不效。特别是最近两年多来，以上症状更加严重，此次月经来前三天即头痛头晕，鼻塞喷嚏，眼痒流泪，鼻流清涕，全身酸痛，月经来后以上症状更加严重，应用感冒清、感冒冲剂、扑尔敏、去痛片三天，中药解表之剂两剂不见好转。细审其证，除以上症状外，并见胸满心烦，手心热，舌苔薄白，脉弦细。综合脉证，反复思考：月经者，为冲脉所主，冲脉者，隶属于肝，肝为将军之官，将军之官者，调营卫，御外邪者也；肝郁血虚，郁而化火，则卫气不固，故而反复感冒也。治宜丹栀逍遥散养血舒肝，解郁泄火。冀其肝木得舒，卫气得升，表邪得解。处方：

柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克，甘草 10 克，干姜 3 克，生姜三片，丹皮 10 克，栀子 10 克。

服药一剂，诸证好转。继服一剂，诸证消失。其后每次月经将至时服药四剂，共服三个周期，中药 12 剂，诸证消失而愈。

罗按：月经来时，以泻血为主，故夺阳气，肝经经气一虚，里虚不能顾表，故表亦虚也。故其本在里。经血为厥阴肝经所主，故治从厥阴经。

【丹栀逍遥散每次遗精之后即出现感冒】朱进忠：

李××，男，30 岁。遗精数年，经治不效。近年来，每周遗精 1～2 次，遗精之后即感头晕乏力，全身酸痛，喷嚏不断，发热。每次感冒之后一用治感冒的药物治疗就很快好转，但下次遗精之后又感冒如前，有时因无药内服，数日后，感冒也自然消失，但最近几个月来，感冒以后再用以前的方法治疗始终不再见效。不得已，停药观察数天，感冒症状非但不减，反见加重。审其脉弦而细，舌苔薄白。审其前用诸药，除西药外，中药大多为补气，解表之剂。综合脉证及前用药物效果后考虑：遗精之后而发，与肾有关也，肾与肝同源，肝为将军之官，出卫气，御外邪，肝肾俱虚，肝木失达，则卫表不固。治宜补肝肾，理肝木，调营卫，其病可解。宗滋水清肝饮。处方：

柴胡 10 克，白芍 10 克，当归 10 克，生地 18 克，山药 12 克，山萸萸 10 克，白术 6 克，茯苓 10 克，泽泻 10 克，丹皮 10 克，栀子 10 克，薄荷 6 克。

刚刚处方完毕，某医问：可否用六味地黄丸?患者听后插话曰：已用六味地黄丸数百合，但不愈也。余曰：遗精固然属肾，遗精之后感冒固然亦应考虑其病在肾，但肾虚不一定感冒，因其不主卫气耳，卫气乃肝所主，此必肝肾俱虚始得此疾，又本病患者往往合并有肝郁化火之心烦易怒，相火动则遗精必频繁，故宜丹栀逍遥散舒肝气泻相火以助卫阳，六味地黄丸补肾水益精气。患者听后插话云，就是经常心烦不安，烦躁易怒，然未注意此证。故未叙述耳。服药 30 剂，诸证果然消失而愈。

按：以上五例，治法虽异，然其治肝则同。可见感冒之疑难者，应求其肝耳。

【丹栀逍遥散治阳事难举医案】朱进忠：

一阳事难举，想性生活即心悸难忍：苏生，男，35 岁。在一年多以前，有一次出差外出时，因工作不顺利，思想上特别不愉快，回家后，同房时发现阳事举而不坚，有时刚刚接触即精液流出，为此曾到数个医院治疗。一年来，不但早泄，而且发现阳痿，为此爱人很有意见。细审其症，除上述症状者外，并见头晕头痛，心烦意乱，心悸失眠，有时出现心跳有暂停的感觉，食欲较差，偶见胸胁苦满，舌苔白，脉弦细数。细询其原用方药，大都为补肾助阳，涩精固肾之品。综合脉证及所用药物效果后分析：此病既非肾阳之虚，亦非肾精不固，乃**肝郁血虚，郁而化火，宗筋失养**之故，乃拟养血舒肝，解郁泻火。丹栀逍遥散加减。处方：

柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克 甘草 10 克，干姜 4 克，薄荷 3 克，丹皮 10 克，栀子 10 克

服药六剂后，不但心烦心悸，头晕头痛等症好转，而且阳萎亦见改善，并云：此次性交时已有快感。某医听后问：丹栀逍遥散乃治妇科妙品，为什么用于治疗阳痿而有效？答曰：阴茎乃宗筋所主，宗筋属肝，肝郁血虚则宗筋失养，宗筋失养则阳痿不举，丹栀逍遥散乃养血舒肝，理气泻火之品，肝气舒，阴血养，郁火除，其病自解，又继服 20 剂而愈。

注家按：阳痿一证，因肝而致者甚多，其中以肝郁气滞所致者为最多见，故临床治疗因肝所致者，多从解郁舒肝治疗之。

罗按：这个医案很有意思。很有深意。

【丹栀逍遥散巅顶灼热】朱进忠：

姜××，男，50 岁。一年多来，经常感到巅顶灼热治忍，先请某院西医治疗，未确诊。半年后，又请中医以清热泻火，养阴平肝等治疗七个多月一直无明显效果。细审其病，除以上诸证外，并见胸满心烦，心悸乏力，失眠，舌苔薄白，脉弦细，综合脉证，反复考虑：诊为肝郁血虚、郁而化火，因拟养血舒肝。解郁泻火。丹栀迫遥散加减。处方：

柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克甘草 10 克，生姜 4 片 薄荷 6 克，丹皮 10 克，栀子 10 克

服药四剂后，胸满、心烦等证好转。继服十剂后，巅顶灼热霍然消失。

某医问：前医用泻火清热，养阴平肝而不效，师用丹栀逍遥散见效，其故何也？丹栀逍遥散为泻火之剂，前医所用之方亦为泻火之剂，为什么同为泻火之剂，而一方有效，一方无效呢?答曰：火之实者、有郁火、实火之分，若单纯由实火所致者，当泻火；若由郁而生火者，非散非发不解故《内经》说：火郁发之。本证巅顶灼热为郁火所致，故应发应散，而不应泻、降，若降、若泻则火邪更郁而病难除，故前用泻火不效，后用舒、散而功。

【丹栀逍遥散治昼夜难眠】朱进忠：

阎××，女，成。3 年多来经常失眠，每夜几乎连 1 个小时也难以入睡，特别是月经前后更加严重。某院诊为神经衰弱，前后住院 7 个多月，西药安眠药和中药安神镇静剂虽用之超过常规剂量也难入睡，最近一个时期，因治病心切，经常因服用过量的镇静安眠药而出现浮肿、呕吐、恶心，甚至两眼不能睁开，四肢软弱无力，也不能入睡。细审其证，除严重失眠外，并见颜面浮肿，疲乏无力，腰酸腰痛，胸胁窜痛，烦躁不安，口苦咽干，月经失调，舌苔黄白，脉沉弦数。综合脉症，反复思考：此乃肝郁血虚，郁而化火之证，治宜舒肝养血，解郁泻火。丹栀逍遥散加减。处方：

柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克甘草 10 克，生姜 3 片薄荷 4 克，丹皮 10 克，栀子 10 克，丹参 15 克

服药 2 剂之后，睡眠增至 4 个小时，继服 8 剂之后，睡眠增至 5 个小时。连服 2 个月后，诸症消失而愈。

某医问：如此严重的失眠，为什么不用龙骨、牡蛎、炒枣仁?答曰：肝主疏泄，若疏泄失职者，但疏其肝而郁可解，若重用重镇之药抑其疏达之性则郁者更郁而病难解，故仅予舒肝而不用龙骨、牡蛎、炒枣仁也。

【丹栀逍遥散咽喉异物感子宫肌瘤】朱进忠：

腹满，子宫肌瘤。曲××，女，39 岁。2 年多来，经常小腹憋胀，月经期间小腹满痛，在妇科普查时发现有多发性子宫肌瘤。最近 1 年多来，又发现咽喉部有异物感，胸胁苦满，心烦心悸，头晕失眠。某医诊为梅核气。开始用四七汤加减治疗，不但咽喉异物感不见好转，反而月经更加不调。后又改用四物汤加减治疗月经不调，非但月经不调未见改善，就是咽喉不利亦见加重。细审其症，除以上所述者外，并见苔舌薄白，脉弦细涩。综合脉症，诊为肝郁血虚，痰滞血淤，寒热夹杂之症。为拟舒肝养血，活血化痰，辛开苦降。丹栀逍遥散加减。处方：

柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，甘草 10 克，干姜 3 克，薄荷 6 克，丹皮 10 克，栀子 10 克，香附 10 克乌药 10 克

服药 6 剂后，咽喉异物感，胸胁苦满，腹满腹胀均大减。继服 12 剂后，咽喉异物感消减 90%，腹满腹胀等消失。

某医问：本症用四七汤、四物汤等加减方不效，而改用丹栀逍遥散加减取效，其故何也?答曰：四七汤但理气而未理血，四物汤但理血而未理气，又或但凉而不温或但温而不凉，致胶结之邪不得散耳。

【丹栀逍遥散劳淋白带】朱进忠：

劳淋，白带，小腹满痛：郅××，女，48 岁。尿急尿频尿痛腰酸腰痛，反复发作 7～8 年，每次发作应用西药治疗后很快症状即可消失，但停药不久，以上症状又反复出现。最近 4 年以来，以上症状发作日渐频繁，平均每 3～4 个月即复发 1 次，尤其是近 1 年多来，虽然反复采用中、西药治疗，但以上症状始终没有彻底改善。最近半年来，以上症状不但不见好转，反日渐加剧，并日渐腹满腹痛。后经住院反复检查诊断为慢性肾盂肾炎、左侧肾盂积水、慢性盆腔炎。细察其症，除尿热尿痛，腰酸腰痛，腹满腹痛外，并见经常头晕头痛，胸满心烦，失眠健忘，白带增多，舌苔白，脉沉弦细涩。再经某院泌尿科检查诊为左肾功能已基本

丧失、右肾功能受损。综合脉症，反复思考：诊为肾气不足为本，肝郁气滞为标，宗急则治标，治拟舒肝解郁，清温并施法。丹栀逍遥散加减。处方：

柴胡10克，当归10克，白芍10克，白术10克，甘草10克 干姜6克，薄荷4克，丹皮10克，栀子10克，香附10克，乌药10克

服药12剂后，尿频尿痛，腹满腹痛，胸满心烦，头晕头痛等证均好转。舌苔薄白，脉沉细涩，尺弱，此肾气之不足也。改予八味地黄丸加减。处方：

生地28克，山药12克山萸肉10克茯苓10克，泽泻10克丹皮10克，肉苁蓉15克，车前子10克(布包)怀牛藤10克五味子10克

服药12剂后，腰痛好转，恒头晕头痛胸满心烘，腹满腹痛等症不减，此乃肝郁较甚，改予丹栀逍遥加减法，其后腹满腹痛，胸满心烦，头晕头痛等症又减，而腰痛又甚。乃再改用八昧地黄丸加减法。如此间隔应用两方一年多，以上症状全部消失，肾功，肾盂造影均正常。

【丹栀逍遥散劳淋】朱进忠：

劳淋，小腹满痛：郝××，女，成。尿热尿痛，尿频尿急反复发作七八年，小腹胀痛、白带增多5～6年。某院诊为慢性肾盂肾炎、慢性盆腔炎，本病开始两年多时，每次应用抗菌素，并住院半月即可痊愈，但近3年来，尿热尿频，尿急尿痛，小腹满痛，日渐加剧，虽反复应用西、中药物亦无明显效果。细察其证，除以上所述者外，并见胸满心烦，头晕头痛，失眠健忘，腰困腰痛，月经失调，白带增多，舌苔白，脉弦细涩，综合脉证，诊为肝郁血虚，寒火夹杂。治拟舒肝解郁，清上温下。丹栀逍遥散加减。处方：

柴胡10克，当归10克，白芍10克，获苓10克，白术10克干姜6克，薄荷4克，丹皮10克，栀子10克，香附10克，乌药10克

服药6剂后，尿热尿频，尿急尿痛，小腹满痛，腰围腰痛均好转，白带减少。继服30剂，诸症消失而愈。

某医问：泌尿系感染应用八正散、五淋散，以及其他的清热解毒药乃治淋证之常法，而老师反而不用,丹栀逍遥散为治妇科疾病之良方,诸医很少提及其治淋证?老师反用之而取效，其故何也?答曰：八正散及其他清热解毒之剂对急性泌尿系感染确有神效，然而本证为肝郁化火，上热下寒之证，但清其热必郁者更郁，火邪更炽，所以必以温散之法才可散其郁火。故用丹栀逍遥加味方而取效，而用清热解毒之剂无功也，

【丹栀逍遥散足心灼热难忍】朱进忠：

足心灼热难忍，非用扇扇不能睡眠：雷××，男，成。半年多以来，两足心烦热难忍，某医诊为阴虚发热。予知柏地黄、六味地黄等加减进行治疗。数月之后，烦热更加严重。后又邀某医治之，认为气虚夹杂阴虚，予补中益气加知母、黄柏治之。服药20余剂后，足心烦热非但不减，反而发现足心烦热更加难于忍受，时时心烦，开始时将脚放到棉被之外还能入睡，其后每夜不用扇子扇冷就不能入睡。最近靠自己用扇扇虽能暂时入睡，但不入即因难受而不能再睡。特别是最近1个多月以来，每天都得别人用扇扇之才能入睡，入睡1小时后若不再扇即不能继续再睡，所以也引起别人的反感。细察其证，除以上所述者外，按其两足蹠部与正常者无异，惟见其心烦急躁不安，舌苔薄白，脉弦细。综合脉证，反复思考：肾虚者，尺脉必或大或沉微，然其脉仅为弦细，此必肝郁气结，阳气阻隔，阴阳失其交融之令所致。治宜拟舒肝解郁，和调阴阳。丹栀逍遥散加味。处方：

柴胡10克，白芍10克，当归10克，干姜4克，茯苓10克薄荷3克，丹皮10克，栀子10克，玫瑰花10克，代代花10克

服药2剂后，足心烦热骤减，继服10剂后，足心烦热减轻达90%，睡眠正常。加生地19克，服药6剂而愈。

【丹栀逍遥散阳萎腰酸背痛】朱进忠：

阳萎，腰酸背痛，久治不愈：葛××，男，25岁。2年前，因为工作不顺利和家庭关系

的不和睦，引起经常失眠。其后，随着工作环境的改善和家庭关系的日渐好转，睡眠也莲渐恢复正常，但却逐渐发现腰背酸痛，头晕乏力，阳萎遗精。经某院检查诊断为前列腺炎、神经衰弱。先用西药治疗半年，未见明显效果。又请某院中医治之，诊断为肾阳亏损，予补肾壮阳之剂治之。共服药300余剂，不但阳萎遗精不见好转，而且日渐头晕乏力，记忆力衰退，腰背酸痛，甚或有时在排便之后亦感气短，精神甚差。细察其证，除以上所述者外，并见胸胁苦满，心烦心悸，纳呆食减，舌苔薄白，脉弦细小数。综合脉证，并结合所用药物效果进行分析。诊为肝郁血虚，郁而化火。为拟疏肝解郁，养血泻火。丹栀逍遥散加减，处方：

柴胡10克，当归10克，白芍10克，白术10克，甘草10克，生姜3片薄荷3克，丹皮10克，栀子10克，瓜蒌15克

服药4剂之后，不但头晕，胸满、心烦、心悸、腰背酸痛好转，而且阳萎乏力明显好转。继续服用上药60剂，诸证消失而愈。

某医问：患者肾虚之证俱在，为什么久用补肾之剂反无效？答曰：患者虽然肾虚之证惧在，然肝经郁火之证亦俱存，即所谓虚实之证俱有。这种虚实俱存之证，在辨证论治时不但要辨其有与无，而且要辨其多与少，主与次。本证脉弦细小数，再结合主诉症状来看，是一个肝郁化火为主的证候。朱丹溪曾云：火为元气之贼，相火不除则必伤肝肾。故必须先治肝胆相火，至相火贼邪一去，病即可愈。所以先以丹栀逍遥散琉肝解郁，养血泻火进行治疗。

【丹栀逍遥散足心灼热难忍】朱进忠：

小腹满痛。里急后重，心烦易怒：朱××，女，27岁。一年多以前，突然发现小腹满痛，里急后重，大便1日3～4次，某院诊为急性肠炎，用西药治疗1周不效。改请中医治疗，某医诊为淤血阻滞，以活血祛淤止痛之剂治之，效果仍不明显。10个月前，又突然发现小腹满痛，尿急尿频尿痛。某院诊为急性泌尿系感染。予吠喃坦丁、庆大霉素等治疗半月后症状消失，但不久又发现月经失调，有时提前，有时错后，经期小腹坠张疼痛加重。最近4个月来，以上情况不但不见好转，反见日渐严重。经某院反复检查诊为肠结核、盆腔结核、慢性肾盂肾炎。予抗痨药、抗菌素等治疗后，仍然不见好转。细察其证，小腹满痛，时轻时重，里急后重，大便有时1日数次而溏泻难止，有时又数日不行，若按其腹部则疼痛更甚。头晕头痛，心烦失眠，月经已闭止4个月，消瘦乏力，手心烦热，舌苔白，脉沉弦涩。综合脉证，再结合前药果进行分析，诊为肝郁血虚，寒热夹杂之证。治拟舒肝理气，养血活血，清上温下，丹栀逍遥散加减。处方：

柴胡10克，当归10克，白术10克，茯苓10克，甘草10克，干姜6克，薄荷3克，丹皮10克栀子10克，香附10克乌药10克。服药6剂后，腹胀、腹痛、里急后重，大便或秘或泻等症好转。精神改善，食欲增加，又继服上方60剂，诸证消失，而愈。

某医问：本证是一个寒热夹杂证，其寒热的多少如何衡量?答曰：应证、脉相参，若证主要表现热证则为热多于寒，证热少而脉为寒者则为寒多于热，如本证仅有心烦，手心烦热之热证，而脉却见寒证，故为寒多于热。

【丹栀逍遥散舌痛淋痛】朱进忠：

舌痛、淋痛时发时止，数年不愈：甄××，女，28岁。舌痛舌肿时轻时重2年多，近2年以来又尿热尿频尿痛时作时止，某院诊为舌炎、慢性肾盂肾炎。虽曾在两个医院分别住院两次，共约8个多月，但效果一直不够理想。近一年多来又发现月经不调，有时月经20多天一至，有时60多天不潮。特别是近8个多月以来，当月经较为调匀时，尿急尿频尿痛即加剧，舌痛改善时，月经失调，尿频尿痛就加剧，如此之此起彼状，彼起此伏现象，一直难解。细察其证，除舌痛，尿热尿痛，月经失调外，并见心烦心悸，胸胁苦满，头晕头痛，小腹满胀，白带增多，舌苔黄白，脉弦涩不调，综合脉证，诊为心与小肠火热，肝郁气结，寒热相兼。治拟舒肝理气，清火散寒同施。丹栀逍遥散加减，处方：

紫胡10克，当归10克，白芍10克，白术10克，甘草10克，干姜6克，薄荷3克，栀

子 10 克，丹皮 10 克，香附 10 克，乌药 10 克

服药 6 剂之后，舌痛、尿热尿痛均好转。但继续服用 6 剂之后，以上诸证不再继续好转。再细审其脉见弦滑小数。此乃上方化痰理气不足，致痰火郁结于肝胆也。治拟理气舒肝，化痰泻火。柴芩温胆汤加减。处方：

柴胡 10 克，黄芩 6 克，龙胆草 10 克，竹茹 10 克，枳壳 10 克，半夏 10 克，陈皮 10 克，滑石 10 克，竹叶 10 克，夜交藤 15 克

服药六剂后，舌痛消失，尿热尿痛亦大部消失，惟小腹满胀未除。此乃肝郁气滞，下焦寒湿未除。继改予丹梔逍遥散加减方 20 剂愈。

某医问：逍遥散、温胆汤治舌痛未曾闻过，老师反用之取效者何也?答曰：肝火乃相火，相火为诸脏之贼，肝经郁火不解则诸火难除。本病前医曾以清心火之法治之，但郁火不散，故心与小肠之火不除也。所以用柴芩温胆汤、逍遥散者，即为解郁而泄火者设，即所谓肝火除则诸火消。

第三节 黄带下

【原文】妇人有带下而色黄者，宛如黄茶浓汁，其气腥秽，所谓黄带是也。夫黄带乃任脉之湿热也。任脉本不能容水，湿气安得而入而化为黄带乎？不知带脉横生，通于任脉，任脉直上走于唇齿，唇齿之间，原有不断之泉下贯于任脉以化精，使任脉无热气之绕，则口中之津液尽化为精，以入于肾矣。惟有热邪存于下焦之间，则津液不能化精，而反化湿也。夫湿者，土之气，实水之侵；热者，火之气，实木之生。水色本黑，火色本红，今湿与热合，欲化红而不能，欲返黑而不得，煎熬成汁，因变为黄色矣。此乃不从水火之化，而从湿化也。所以世之人有以黄带为脾之湿热，单去治脾而不得痊者，是不知真水、真火合成丹邪、元邪，绕於任脉、胞胎之间，而化此黔色也，单治脾何能痊乎！法宜补任脉之虚，而清肾火之炎，则庶几矣。方用易黄汤。

易黄汤方：
山药一两（炒），芡实一两（炒），炒黄柏二钱（盐水炒），车前子一钱（酒炒），白果（十枚，碎）
水煎服。

傅山曰：此不特治黄带方也，凡有带病者，均可治之，而治带之黄者，功更奇也。盖山药、芡实专补任脉之虚，又能利水，加白果引入任脉之中，更为便捷，所以奏功之速也。至於用黄柏清肾中之火也，肾与任脉相通以相济，解肾中之火，即解任脉之热矣。

注曰：凡带症多系脾湿，初病无热但补脾土兼理冲任之气其病自愈，若湿久生热必得清肾火而湿始有去路。方用黄柏，车前子妙！山药，芡实尤能清热生津。

【药性】：

芡实：芡实与莲子，二者同科属，均为甘涩平，主归脾、肾经。均能益肾固精、补脾止泻、止带，其补中兼涩，主治肾虚遗精、遗尿；脾虚食少、泄泻；脾肾两虚之带下等。但芡实益脾肾固涩之中，又能除湿止带，故为虚、实带下证之常用药物。【应用】1．遗精，滑精。本品甘涩收敛，善能益肾固精。治肾虚不固之腰膝酸软，遗精滑精者，常与金樱子相须而用，如水陆二仙丹(《仁存堂经验方》)；亦可与莲子、莲须、牡蛎等配伍，如金锁固精丸(《医方集解》)。 2．脾虚久泻。本品既能健脾除湿，又能收敛止泻。可用治脾虚湿盛，久泻不愈者，常与白术、茯苓、扁豆等药同用。 3． 带下。本品能益肾健脾、收敛固涩、除湿止带，为治疗带下证之佳品。治脾肾两虚之带下清稀，常与党参、白术、山药等药同用。 若治湿热带下，则配伍清热利湿之黄柏、车前子等同用，如易黄汤(《傅青主女科》)。

黄柏：苦，寒。归肾、膀胱、大肠经。清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。【应用】湿热带下、热淋。本品苦寒沉降，长于清泻下焦湿热。用治湿热下注之带下黄浊臭秽，常配山

药、芡实、车前子等药用，如易黄汤（《傅青主女科》）；若治湿热下注膀胱，小便短赤热痛，常配萆薢、茯苓、车前子等药用，如萆薢分清饮（《医学心悟》）。 2. 湿热泻痢、黄疸。本品清热燥湿之中，善除大肠湿热以治泻痢，常配白头翁、黄连、秦皮等药用，如白头翁汤（《伤寒论》）；若配栀子用，可治湿热郁蒸之黄疸，如栀子柏皮汤（《伤寒论》）。3.湿热脚气、痿证：取本品清泄下焦湿热之功，用治湿热下注所致脚气肿痛、痿证，常配苍术、牛膝用，如三妙丸（《医学心悟》）。若配知母、熟地、龟甲等药用，可治阴虚火旺之痿证，如虎潜丸（《丹溪心法》）。4. 骨蒸劳热，盗汗，遗精。本品主入肾经而善泻相火、退骨蒸，用治阴虚火旺，潮热盗汗、腰酸遗精，常与知母相须为用，并配生地黄、山药等药用，如知柏地黄丸（《医宗金鉴》）；或配熟地黄、龟甲用，如大补阴丸（《丹溪心法》）。 5. 疮疡肿毒、湿疹瘙痒。取本品既能清热燥湿，又能泻火解毒，用治疮疡肿毒，内服外用均可，如黄连解毒汤（《外台秘要》）以本品配黄芩、黄连、栀子煎服，又如二黄散（《痈疽神验秘方》）以本品配大黄为末，醋调外搽；治湿疹瘙痒，可配荆芥、苦参、白鲜皮等煎服；亦可配煅石膏等分为末，外撒或油调搽患处，如石黄散（《青囊秘传》）。【鉴别用药】黄芩、黄连、黄柏三药性味皆苦寒，而黄连为苦寒之最。三药均以清热燥湿、泻火解毒为主要功效，用治湿热内盛或热毒炽盛之证，常相须为用。但黄芩偏泻上焦肺火，肺热咳嗽者多用；黄连偏泻中焦胃火，并长于泻心火，中焦湿热、痞满呕逆及心火亢旺、高热心烦者多用；黄柏偏泻下焦相火、除骨蒸，湿热下注诸证及骨蒸劳热者多用。

车前子：甘，微寒。归肝、肾、肺、小肠经。 利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。 【应用】 1. 淋证，水肿。本品甘寒而利，善通利水道，清膀胱热结。治疗湿热下注于膀胱而致小便淋沥涩痛者，常与木通、滑石、瞿麦等清热利湿药同用，如八正散（《和剂局方》）；对水湿停滞水肿，小便不利，可与猪苓、茯苓、泽泻同用；若病久肾虚，腰重脚肿，可与牛膝、熟地黄、山茱萸、肉桂等同用，如济生肾气丸（《济生方》）。2. 泄泻。本品能利水湿，分清浊而止泻，即利小便以实大便。尤宜于小便不利之水泻，可单用本品研末，米饮送服；若脾虚湿盛泄泻，可配白术同用；若暑湿泄泻，可与香薷、茯苓、猪苓等同用，如车前子散（《杨氏家藏方》）。3. 目赤肿痛，目暗昏花，翳障。车前子善清肝热而明目，故治目赤涩痛，多与菊花、决明子等同用；若肝肾阴亏，两目昏花，则配熟地黄、菟丝子等养肝明目药，如驻景丸（《圣惠方》）。4. 痰热咳嗽。本品入肺经，能清肺化痰止咳。治肺热咳嗽痰多，多与瓜蒌、浙贝母、枇杷叶等清肺化痰药同用。

【方剂学注解】：

【功用】：固肾止带，清热祛湿。

【主治】：肾虚湿热带下。带下粘稠量多，色黄如浓茶汁，其气腥秽，舌红，苔黄腻者。

【方解】：肾与任脉相通，肾虚有热，损及任脉，气不化津，津液反化为湿，循经下注于前阴，故带下色黄、粘稠量多，其气腥秽。治宜固肾清热，祛湿止带。方中重用炒山药、炒芡实补脾益肾，固涩止带，《本草求真》曰：“山药之补，本有过于芡实，而芡实之涩，更有胜于山药”，故共为君药。白果收涩止带，兼除湿热，为臣药。用少量黄柏苦寒入肾，清热燥湿；车前子甘寒，清热利湿，均为佐药。诸药合用，重在补涩，辅以清利，使肾虚得复，热清湿祛，则带下自愈。

【运用】：

1.辨证要点　本方为治肾虚湿热带下的常用方。临床应用以带下色黄，其气腥秽，舌苔黄腻为辨证要点。

2.加减变化　湿甚者，加土茯苓、薏苡仁以祛湿；热甚者，可加苦参、败酱草、蒲公英以清热解毒；带下不止，再加鸡冠花、墓头回以止带。

3.现代运用　本方常用于宫颈炎、阴道炎等属肾虚湿热下注者。

[临床报道]

罗氏用易黄汤为主治疗带下病110例。其中经实验室及妇科检查：滴虫性阴道炎13例，阴道炎50例，宫颈糜烂19例，慢性盆腔炎8例。全部病例均以带下连绵，或稠或稀，或腥或臭为主症，用易黄汤为主方酌情加减。若阴痒者，配以苦参、蛇床子、花椒、枯矾，水煎外洗阴部。治疗效果：痊愈89例(白带正常，诸症消除，随访2年无复发)；显效21例（带下近正常，其他诸症均显著减轻或消除，但2年内尚有复发)。[罗飞．易黄汤为主治疗带下110例临床观察。浙江中医杂志 1987；(8)：366]

罗按：上边说了白带和青带，白带是新鲜的分泌物，青带是腐烂的变质了的分泌物，黄带就是介乎于白带的青带的一个情况。“黄茶浓汁，其气腥秽”，这个可从白色的内裤看得到，特别是“其气腥秽”。这个味道一般是闻不到的，若是房事之后，就最容易闻到了。所以其病因是脾虚失收涩，所以必要治脾之药，它色黄，意为有热，故也有黄柏，车前子止泻利小便，其实是去湿的一个药，湿能滞下焦气机。

方歌：易黄山药与芡实，白果黄柏车前子，能消带下黏稠秽，补肾清热又祛湿。

【易黄汤方解】：肾与任脉相通，肾虚有热，损及任脉，气不化津，津液反化为湿，循经下注于前阴，故带下色黄、粘稠量多，其气腥秽。治宜固肾清热，祛湿止带。方中重用炒山药、炒芡实补脾益肾，固涩止带。炒芡，味甘、涩，性平。归脾、肾经。功效益肾固精，补脾止泻，除湿止带。用于遗精滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下。《本草求真》曰：“山药之补，本有过于芡实，而芡实之涩，更有胜于山药”，故共为君药。白果收涩止带，兼除湿热，为臣药。用少量黄柏苦寒入肾，清热燥湿；车前子甘寒，清热利湿，均为佐药。

配伍特点：本方为治肾虚湿热带下的常用方。临床应用以带下色黄，其气腥秽，舌苔黄腻为辨证要点。

加减化裁：湿甚者，加土茯苓、薏苡仁以祛湿；热甚者，可加苦参、败酱草、蒲公英以清热解毒；带下不止，再加鸡冠花、墓头回以止带。

【易黄汤主治】湿热带下。带下色黄，其气腥秽，舌红，苔黄腻者。

【方药】：

白果，银杏的种子。功能主治为：敛肺气，定喘嗽，止带浊，缩小便。治哮喘，痰嗽，白带，白浊，遗精，淋病，小便频数。①《三元延寿书》：生食解酒。②《滇南本草》：大疮不出头者，白果肉同糯米蒸合蜜丸：与核桃捣烂为膏服之，治噎食反胃，白浊、冷淋；捣烂敷太阳穴，止头风眼疼，又敷无名肿毒。③《品汇精要》：煨熟食之，止小便频数。④《医学入门》：清肺胃浊气，化痰定喘，止咳。⑤《纲目》：熟食温肺益气，定喘嗽，缩小便，止白浊；生食降痰，消毒杀虫；（捣）涂鼻面手足，去泡，黯，皴皱及疥癣疳匿、阴虱。⑥《本草再新》：补气养心，益肾滋阴，止咳除烦，生肌长肉，排脓拔毒，消疮疥疽瘤。⑦《本草便读》：上敛肺金除咳逆，下行湿浊化痰涎。⑧《现代实用中药》：核仁治喘息，头晕，耳鸣，慢性淋浊及妇人带下。果肉捣碎作贴布剂，有发泡作用；菜油浸一年以上，用于肺结核。⑨《山东中药》：治遗精，遗尿。

芡实：具有益肾固精，补脾止泻，除湿止带之功效。常用于遗精滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下。

《本草经百种录》：“鸡头实，甘淡，得土之正味，乃脾肾之药也。脾恶湿而肾恶燥，鸡头实淡渗甘香，则不伤于湿，质粘味涩，而又滑泽肥润，则不伤干燥，凡脾肾之药，往往相反，而此则相成，故尤足贵也。”

《本草求真》：“芡实如何补脾，以其味甘之故；芡实如何固肾，以其味涩之故。惟其味甘补脾，故能利湿，而泄泻腹痛可治；惟其味涩固肾，故能闭气，而使遗、带、小便不禁皆愈。功与山药相似，然山药之阴，本有过于芡实，而芡实之涩，更有甚于山药；且山药兼补肺阴，而芡实则止于脾肾而不及于肺。”

治精滑不禁：沙苑蒺藜（炒）、芡实（蒸）、莲须各二两，龙骨（酥炙）、牡蛎（盐水

煮一日一夜，煅粉）各一两。共为末，莲子粉糊为丸，盐汤下。（《医方集解》金锁固精丸）

治浊病：芡实粉、白茯苓粉。黄蜡（化），蜜和丸，梧桐子大。每服百丸，盐汤下。（《摘玄方》分清丸）

【易黄汤滴虫性阴道炎医案】：

刘某，女，27 岁，公务员，已婚，2002 年 8 月 26 日来诊。患者半年前自觉头重，腰背沉重，带下量多，呈泡沫状，色黄有臭味，伴外阴瘙痒或灼热疼痛。经某院妇科检查，诊为“滴虫性阴道炎”，采用灭滴灵等药物治疗数月，气味腥臭，尿频尿痛，小腹坠痛，食纳欠佳，面色萎黄，神疲乏力，五心烦热，午后尤甚，舌质胖大，苔黄腻，脉弦滑数。辨证为脾虚湿盛，日久化热，湿热下注，蕴结胞宫，任脉受损所致。同时结合现代医学检查，认为该病由阴道滴虫引起，同时又混合了细菌感染。拟健脾祛湿，调理肝肾，清热解毒。并结合抗滴虫，抗菌疗法。用加减易黄汤方：生山药、生薏苡仁、土茯苓、椿根皮、蒲公英各 30g，芡实、金银花、白花蛇舌草各 20g，黄柏、白果、柴胡各 10g，车前子 15g，青蒿 10g。每日一剂，六剂后，诸证明显减轻，五心烦热消失，又 12 剂痊愈。 （现代中医药）

医案分析：“头重，腰背沉重”，必是湿盛，视其是否兼表证，病起即急用祛湿剂中的藿香正气散或三仁汤治之，可速愈。患者可能因失治误治，致肌肤之湿入里，湿浊下流，郁而化热，造成“带下量多，呈泡沫状，色黄有臭味，伴外阴瘙痒或灼热疼痛”，这是较典型的湿热黄带，不过泡沫和瘙痒似有风邪。患者还未得到有效治疗，湿热进一步由下焦胞宫扩散至邻近的膀胱，出现“尿频尿痛”。而“小腹坠痛，食纳欠佳，面色萎黄，神疲乏力，舌质胖大”，是湿邪长期不去，最易伤脾，损伤了脾之阳气。“五心烦热，午后尤甚”，可能化热后又造成热甚阴伤。病机重点为下焦湿热，其次为脾气虚，再次为阴虚。当利湿热、止带、健脾升阳，略加养阴和祛风药。凡前阴诸湿热证，均可以清热剂中龙胆泻肝汤加减，当然，用治湿热黄带的易黄汤加减更对证。甚至用清热燥湿、益气养血的当归六黄汤也不能算错。不管用何方调整，上述几个治法最好都兼顾到，只要分清主次就行。

中西医结合的方法是可取的。实证带下病结合西药的阴部冲洗，效果会更快，但若单纯用西药，却极易复发，尤其有虚证因素的情况下。中药用的是易黄汤为主，苡仁、车前子利湿热，土茯苓、椿根皮、黄柏清热燥湿，青蒿清热化湿，蒲公英、金银花、白花蛇舌草清热解毒（蒲公英善治带下臭秽明显者），椿根皮、白果止带，山药、芡实补肾固涩，苡仁、山药健脾。柴胡引药入少腹？还是防土虚木乘？从全方来看，总体是围绕病机的主要方面施治的。虽然重点似乎过于突出了一些，健脾养阴似乎单薄了一些，但治疗早期以攻邪为主，也不能算错。待实邪消其大半，可再扶正祛邪并重或扶正为主。从本案效果来看，还是不错的。但没有扶正善后，却不知以后会不会复发。另一点值得高度关注的是，并无明显养阴药，头 6 剂则“五心烦热消失”。若果如此，则五心烦热还可直接由湿热引起，以后养阴退热没效果的时候，再从这方面考虑。摘自《方剂学案例分析》

【邓中甲关于易黄汤的论述】

固涩的方子，易黄汤。它和前面的完带汤是一对。都是《傅青主女科》里的名方。这个方就是一个肾虚，又有湿热下注。

主证分析：肾虚湿热带下。肾虚：带下量多。失热带下：带下黏稠色黄，其气腥秽，舌红，苔黄腻。

易黄汤，傅青主认为涉及到任脉，带下是跟带脉有关，但带脉是联络很多方面的脉，就是说横向环绕，纵向经脉它都维系。带脉和任脉关系密切。带下量多，他认为不管是哪类带下，都和任脉有关，任脉是正面纵向的，也出于胞宫，上达于口了，就像做气功的，他要练到小周天，督脉从后向上，环绕到头顶，和任脉在前面走，交会，口舔上颌，督脉任脉相通。正常情况下，任脉向上，口中产生很多津液。道家把这个津液看作是华池之水。特别是练功时候化生口水会很多。《内经》里说小口小口的咽，指的是在气功态状况下。所以认为津液从

任脉向下本身可以精华物质，任脉不是走水的，走气血，特别血的，那这个津液可以化生为血，成为精血的来源。

如果任脉亏虚了，湿邪可以下流，在下焦可以郁而化热，或者下焦有火，他说，湿热下注直接成为湿热，他认为这种湿热，不是光湿热带下，（易黄汤主要治疗湿热带下），不能光清热利湿止带，还要补任脉。这是他自身理论的特点。

从临床症状来讲，肾虚主要反应在失固，湿热带下黏稠色黄，其气腥秽，这是带下的特点。而且用易黄汤还是量比较多。量多是由于肾虚失固。他认为这里反映的肾虚，主要是肾虚失固，对下焦。

不管是白带黄带，都和任脉有关。这是《傅青主女科》的一个特点。所以主治方剂还要跟那个医家的理论特点有关。以往传统都这样看。原有不断之泉下贯于任脉以化精，这是化津液，本身是一种不断之泉，下贯于任脉以化精，使任脉无热气之绕，以入于肾。这和气功家们说法一致的。如果下焦有热的话，这个津液向下和热相结就成为湿热了。唯有热邪存于下焦之间，而反化湿也。他说这不是正常的。不是从水火之化，而从湿化。那不是有用的津液，而成没用的水湿。以往对湿热，脾蕴湿的要清热利湿，清热化湿。往往对下是个利，对脾胃有个化。他说，单治脾何能痊乎！法宜补任脉之虚，而济肾火之炎，这个指导思想来主治这个方。则庶几，就是有希望了，方用易黄汤。

功用：固肾止带，清热祛湿。

方解：君：山药，补脾固肾，又能收涩。芡实，补脾，固涩(强)。臣：白果，收涩止带。佐：黄柏(盐水炒)，清热燥湿。车前子：盐水炒，清热燥湿利湿。

这方对药物的功能他有特殊看法。对清热利湿来讲，燥湿利湿，一看很好理解，他用山药、芡实。固肾，傅青主还认为，他还有其它医案提过，山药擅长于补和涩，收涩。能够补脾固肾，又能收涩。说它特别能够用于补任脉。这个除了他讲这个，我们在很多本草书里不是这样提了。后来包括张山雷这些，也提到山药对任脉的一个作用。这是他个人一个经验、体会。因为任主胞胎，冲为血海，从这个理论，和山药常在固肾起这方面的治疗作用。他就说它能补任脉。山药和芡实，都有补脾作用，都能固涩，山药比芡实补性多，收摄固涩少。芡实固涩力量强，补益力量小。但认为这两个相配是常用于补任脉。能够收涩止带。这是他用药的经验。李时珍擅长用白果治带下，认为它能固涩止带。黄柏，车前子盐水炒，入肾。清热燥湿利湿，针对湿热带下。

易黄汤体现了一种补益，补肾固摄，收涩。补涩兼顾。补涩清利，说它四法兼备。补涩是以涩为主。清利、补涩相结合，又是补涩为主。这是易黄汤，虽然药味少，就成为了治量湿热带下的一个常用方。临床效果很好的。傅青主自己讲，这个方不管黄带、白带，都能用。教你调整加味。

但相比完带汤来讲，应该说这个方主要用于湿热带下。这类方，我体会就从它的一个药味来说，起到一种固涩补益，清利结合。你不一定完全抠它髂的跟任脉的关系。过去收完带汤，易黄汤作附方，不太做正方。但临床运用的时候，在妇科易黄汤的地位，临床运用上并不亚于完带汤。而且两个体现出，一个偏湿热的，一个有脾虚结合肝郁的。两个类型不同。这个运用实际上涉及到固肾。从带下性质有湿热的，这两个应该都有。

配伍特点：重在补涩，辅以清利。

刚才讲到易黄汤的结构，它重在补涩，辅以清利。治湿热带下，一般以清热利湿为主。这方特点建立在，它带脉、任脉和带下关系这个理论，傅青主在这个理论基础上，它是以补涩为主，辅以清利。而这方呢，在临床上的确很有效果。治湿热带下很多，妇科老师很爱用易黄汤，很有名。所以在历来书理论探讨里，欠缺一些，到目前出来的教科书，包括很多教参，结合傅青主自身理论的探讨，多是针对性不够强。或者不是很深入的。这方面我还收集过一些书，看过这个。

运用：现在范围越来越宽，除了妇科用，其它内科也用。从临床观察的病例报导很多，它治疗蛋白尿，它本身有泌别清浊的作用，所以对像蛋白尿，它泌别清浊，在治疗方面病例报导不少。所以不仅仅是妇科湿热带下方面运用。

辨证要点：带下色黄，其气腥秽，舌苔黄腻。

随证加减：湿盛，加土茯苓、苡仁；热重，加苦参、败酱草、蒲公英；带下日久不止，加鸡冠花、_回头。

这方清利湿热的作用，不是太大。所以湿重的，还可以加一些利湿药；偏热重的，可以加清热药，这是在这个方的基础上，这五味药基础上可以加味运用的。带下时间长，还可以加强收涩作用。

第四节 黑带下

【原文】：妇人有带下而色黑者，甚则如黑豆汁，其气亦腥，所谓黑带也。夫黑带者，乃火热之极也。或疑火色本红，何以成黑？谓为下寒之极或有之。殊不知火极似水，乃假象也。其症必腹中疼痛，小便时如刀刺，阴门必发肿，面色必发红，日久必黄瘦，饮食必兼人，口中必热渴，饮以凉水，少觉宽快，此胃火太旺，与命门，膀恍，三焦之火合而熬煎，所以熬干而变为炭色，断是火热之极之变，而非少有寒气也。此等之症，不至发狂者，全赖肾水与肺金无病，其生生不息之气，润心济胃以救之耳，所以但成黑带之症，是火结于下而不炎于上也。治法惟以　火为主，火热退而湿自除矣。方用利火汤。

利火汤方：

大黄三钱，白术五钱（土炒）茯苓三钱，车前子三钱（酒炒），王不留行三钱，黄连三钱，栀子三钱（炒），知母二钱，石膏（五钱，煅），刘寄奴三钱，

水煎服。一剂小便疼止而通利，二剂黑带变为白，三剂白亦少减，再三剂全愈矣。

傅山曰：或谓此方过於迅利，殊不知火盛之时，用不得依违之法，譬如救火之焚，而少为迁缓，则火势延燃，不尽不止。今用黄连、石膏、栀子、知母一派寒凉之品，入於大黄之中，则迅速扫除。而又得王不留行与刘寄奴之利湿甚急，则湿与热俱无停住之机。佐白亢以辅土，茯苓以渗湿，车前以利水，则火退水进，便成既济之封矣。

注家曰：病愈后当节饮食，戒辛热之物，调养脾土。若恃有此方，病发即服，必伤元气矣，慎之！）

病因和病机：

辩证要点：人黄瘦、口渴，带下色黑

方解：方中以石膏、知母白虎之竣猛直折阳明经火势，黄连、栀子大苦大寒，泄火解毒、除烦热、坚阴液；大黄力峻攻下，洁净腑，能顿挫病势，使邪祛正安；王不留行、刘寄奴清利湿热、活血通络；白术、茯苓健脾渗湿；车前子泄热利水。诸药合用，共奏清热泄火、渗湿利水之功。

刘寄奴：刘寄奴又名六月雪，为菊科植物奇蒿的全草。刘寄奴味苦，性温，归心、脾经。功效与主治：破血通经，敛疮消肿。治胸腹胀痛、产后血瘀、跌打损伤、金疮出血、痈毒等。破血通经，消积，止血消肿。主治血滞经闭，痛经，产后瘀滞腹痛，症瘕，食积腹痛，跌打损伤，金疮出血，尿血，痈毒，烫伤。

罗按：白带是什么东西？其实人体本来就存在白带，就是一些分泌物，正常的时候，它也有分泌，只是在房事的时候就大量分泌出来。现在它变成黑色为什么？就是说未出来之前已经坏了，腐烂了。有关腐烂都与热相关。就是肯定的说，这是热证。治法是：热则寒之，对不对。但是在这里，它先要把腐烂的东西排出，要用茯苓、车前子三钱（酒炒），王不留行去排浊。用大黄、黄连清里热。

【利火汤治黑带】

杨某某，女，20 岁，未婚。初诊：2003 年 8 月 22 日。末次月经 7 月 26 日来潮，3 天干净，至 8 月 18 日发现黑带，至今仍有。近日因工作不顺，性情烦躁，口干且苦，大便秘结。脉弦数带滑，舌红且干、苔薄黄。证属肝郁化火，煎熬阴津。治拟泄火为主。方用利火汤。

药用：大黄 9g(后下)（土炒）白术 15g，车前子 9g(包)，黄连 9g，王不留行 9g，刘寄奴 9g，茯苓 9g，栀子 9g，知母 6g，石膏 15g(先煎)。3 剂。复诊(8 月 9 日)：昨起黑带消失，脉弦不数，舌红且润，肝火已退，改用逍遥丸调理。2 个月后随访，黑带治愈，未见复发。

【利火汤治前列腺炎合并睾丸炎】

张某，男，57 岁。初诊日期:2009 年 5 月 8 日。患者既往有前列腺炎病史，近 10 个月来反复尿急尿痛，伴见会阴部坠痛。曾辗转于多家医院泌尿专科，诊为前列腺炎、睾丸炎，迭经大剂量抗生素静脉滴注，未见显效，会阴疼痛无缓解，久立久坐及进食辛辣之品后加重。

刻诊:尿急尿痛，小溲短少不畅，余沥不尽，色黄;会阴部坠痛，放射至两大腿内侧以下，伴左侧睾丸胀痛，行走时尤甚;口干口苦，心烦易怒，夜寐不安，大便偏干;舌暗红，苔黄厚腻，脉弦滑。

查体:阴囊周围及双大腿内侧潮湿，皮色红，无破溃及皮疹。尿常规检查正常。中医辨证:肝经湿热，瘀热交阻，气机不利;治法:清火利湿，消瘀散结，行气活血。

方用利火汤加减。处方:生石膏 30g，牡丹皮 15g，丹参 15g，王不留行 15g，生薏苡仁 30g，生栀子 9g，三棱 15g，莪术 15g，车前子 30g(包煎)，生大黄 9g，黄柏 9g，黄连 6g，川牛膝 15g，生地黄 15g，蒲公英 30g，玄胡索 15g，青皮 9g，柴胡 9g。7 剂，每日 1 剂，分早晚 2 次顿服。

二诊(5 月 15 日):患者诉服中药 2 剂，疼痛即明显减轻，行走时疼痛已不显;服药 7 剂后，小便转畅，自诉 10 个月来未有这般轻松;口干口苦减，大便转调畅;舌暗红，苔薄黄腻，脉弦。证治同前，上方减玄胡索，再服 7 剂，用法同前。

三诊(5 月 22 日):尿痛及会阴部坠痛消失，久行后双大腿内侧稍有牵拉不舒感，小便畅，色清;口干口苦已大减，大便调，夜寐尚可;舌暗红，苔黄薄腻，脉滑。现湿热未净，气机仍有不利之象，故仍当利湿清热、理气活血，稍佐扶正，予原方加减。处方:生薏苡仁 30g，白茅根 20g，车前子(包煎)30g，黄柏 9g，刘寄奴 9g，王不留行 15g，生栀子 9g，川楝子 9g，乌药 9g，青皮 9g，三棱 15g，莪术 15g，苍术 9g，生大黄 6g，茯苓 15g，枸杞子 15g。7 剂。

四诊(5 月 29 日):已无尿频尿急，小溲清畅;会阴疼痛无，偶有牵拉不适;无口干，略感口苦，胃纳可，大便畅，寐尚可;舌暗红，苔黄薄腻，脉滑。证治同前，三诊方加柴胡 9g、川牛膝 15g。7 剂。随访半年，症情平稳，未再发作。

【利火汤治 男性无合并症急性淋菌性尿道炎】

曹方洪等在长期的临床工作中，总结出利火汤方对淋菌性尿道炎有较好疗效，全部患者治疗期间及治疗结束后 8 天以内禁房事、饮酒、辛辣温燥食物，停止一切其他治疗。

治疗组给予利火汤方:大黄 10g，白术 15g，茯苓 10g，车前子 10g(酒炒)，王不留行 10g，黄连 10g，栀子 10g(炒)，知母 6g，石膏 15g(煅)，刘寄奴 10g，每日 1 剂，水煎 3 次，第 1、2 次水煎液混合，早晚饭前各服 1 次，第 3 次水煎液外洗会阴部并温热(以能耐受为度，避免烫伤)坐浴 15 分钟，连续 6 天。热不甚者加小茴香 6g，素有胃脘冷痛者加干姜 5g。对照组给予单剂量环丙沙星 600mg 顿服。两组患者均于治疗结束后第 4 和第 8 天，作前列腺按摩后，用消毒棉签进入尿道内 2~4cm 取分泌物做涂片直接镜检和培养。记录病人不良反应，治疗前后查血清谷丙转氨酶、总胆红素、尿素氮，并作治疗前后对照。本组病例显示，与环丙沙星对照，痊愈率优于对照组(P<005)，总有效率相当(P>005)，淋菌转阴率高于对照组。

【临证提要】

本方乃清热泻火之竣剂，只可用于湿热火极体壮者，用之中病则止，不可过用，以免损

阳耗阴。倘若本虚标实者，应据其阴阳气血之虚损，酌情辅以固本之药，以使湿热清除而又不伤正。

妇人带下色黑者味奇臭秽，除见于生殖系统的炎症外，亦可见于生殖系统的恶性肿瘤。故临床见此患者，宜嘱其做妇科检查，探究原因，以便更明确地辨病辨证，及时地采取相应的治疗措施。以免耽误病情。切记！

第五节 赤带下

【原文】：妇人有带下而色红者，似血非血，淋沥不断，所谓赤带也。夫赤带亦湿病，湿是土之气，宜见黄白之色，今不见黄白而见赤者，火热故也。火色赤，故带下亦赤耳。惟是带脉系于腰脐之间，近乎至阴之地，不宜有火。

而今见火症，岂其路通于命门，而命门之火出而烧之耶？不知带脉通于肾，而肾气通于肝。妇人忧思伤脾，又加郁怒伤肝，于是肝经之郁火内炽，下克，脾土，脾土不能运化，致湿热之气蕴于带脉之间；而肝不藏血，亦渗于带脉之内，皆由脾气受伤，运化无力，湿热之气，随气下陷，同血俱下，所以似血非血之形象，现于其色也。其实血与湿不能两分，世人以赤带属之心火误矣。治法须清肝火而扶脾气，则庶几可愈。方用清肝止淋汤。

清肝止淋汤方：
白芍一两（醋炒）。当归一两（酒洗）。生地五钱（酒炒）。阿胶三钱（白面炒）
粉丹皮三钱，黄柏二钱，牛膝二钱，香附一钱（酒炒），红枣十个　小黑豆一两

辨证依据：本方是治疗妇科赤带的常用方。临床以经间期出血，色深红，质稠，带下黄赤臭秽，舌红，苔黄腻，脉滑数为用方依据。

【功效】清肝凉血，除湿止带。用于湿热蕴结冲任所致经间期出血或赤带证。症见经间期出血，血色深红，质稠，平素带下量多色黄，有臭味，小腹时痛，心烦易怒，口苦口渴，舌红，苔黄腻，脉滑数。

【加减】出血量多，去当归、牛膝、香附，加炒地榆、茜草根、乌贼骨以加强止血作用；带下量多者，加茯苓、马齿苋、土茯苓以清热解毒止带；纳呆或食后腹胀者，去生地黄、白芍，加厚朴、麦芽以行气消食。淋证见湿毒内蕴者，加木通、蒲公英以利尿通淋，清热解毒。排卵期出血，加续断、菟丝子益肾固本，调和冲任。宫颈糜烂出血，加红藤、鱼腥草、车前子以清热泻火，利湿解毒。放环后的经期延长，加地榆、白及以收敛止血。

傅山曰：此方但主补肝之血，全不利脾之湿者，以赤带之为病，火重而湿轻也。失火之所以旺者，由於血之衰，补血即足以制火。且水与血合而成赤带之症，竟不能辨其是湿非湿，则湿亦尽化而为血矣，所以治血则湿亦除，又何必利湿之多事哉！此方之妙，妙在纯於治血，少加清火之味，故奏功独奇。倘一利其湿，反引火下行，转难速效矣。或问曰：先生前言助其脾土之气，今但补其肝木之血何也？不知用芍药以平肝，则肝气行得舒，肝气舒自不克，土，脾不受克，则脾土自旺，是平肝正所以扶脾耳，又何必加人参、白术之品，以致累事哉！

罗按：仲景云：“见肝之病，知肝传俾”，此时肝盛，传之于脾，脾虚不受，传之于肾盛于少阴肾。故先清肝火而扶脾，是故脾旺不受邪，则不传肾。少阴脉为足少阴肾经，少阴脉在太溪穴处，即脚眼骨后二寸位置。陈修园云：肾脉取之太溪，亦谓之少阴脉。此实为带脉病。仲景云：“带脉为病，苦腹痛，腰间冷痛，脉当沉而细，治属少阴”。少阴脉当沉而细，滑而数，是阳有余者是也，热。带脉为病，而现少阴之脉者，治从少阴。并非所有带脉病皆从少阴治。带脉为诸病，多现于妇人下焦胞宫之诸病。带脉横通于腰，所以联系诸经者也。带脉则横围于腰，状如束带，所以总约诸脉者也，带脉出现毛病了。

【清肝止淋汤治经间期出血(排卵期出血)】：

经间期出血又称排卵期子宫出血，系指在两次月经中间，出现周期性少量子宫出血。经间期出血一般发生在月经周期的12~16天，血量少，常伴下腹部不适，现代医学认为由于排卵期雌激素水平暂时性下降所致的撤退性出血,属于功能失调性子宫出血疾病(排卵性功血)。由于排卵期雌激素短暂下降致子宫内膜.部分脱落出血，当排卵后黄体形成，雌、孕激素分泌足够时，内膜又被修复而止血。周期性经间期出血，历时1~2小时或1~3天。血量少于正常月经，或表现为白带夹血，伴轻微腰腹痛，月经周期正常。妇查无特殊异常。基础体温测定时，基础体温低高温相交替时出现少量阴道出血可确诊。

本病相当于中医的“崩漏”范畴，临床分型常为肾阴虚型，湿热型，肝郁化热型。本方适于肝郁化热型。

清肝止淋汤加减：黄柏10克，川牛膝10克，生苡仁10克，丹皮(炒)、地榆炭各15克，小蓟15克，赤芍15克，白芍15克，苍术9克，香附(制)9克。

如气虚者，加党参、黄芪、白扁豆、白术；兼血瘀者，加蒲黄炭(包)、五灵脂、三七、茜草根炭，或桃仁、乳香、没药；肝气郁滞者，加柴胡、青皮、郁金；阴虚火旺者，加生墨旱莲、知母、地骨皮、黄芩。

(1)根据《湖北中医杂志》，王净报道：应用清肝止淋汤或三妙丸、四妙丸加减治疗经间期出血38例，痊愈者20例，有效者11例，2例无效，总有效率94.7%。处方：白芍15克，(醋炒)，当归15克，生地9克，阿胶9克，(烊化)，粉丹皮9克，黄柏6克，牛膝6克，香附3克，红枣6个，小黑豆15克，黄柏9克，地榆炭、小蓟、赤芍各15克，苍术、香附(制)各9克，一般每个经间期用药5~10剂左右。治疗3个周期为1个疗程。出血前的治疗，在下次月经周期的第10天左右用药。

(2)根据《江苏中医》，刘家风报道：应用清肝止淋汤加减治疗经间期出血。处方为：白芍20克，(炒)，生地黄30克，丹皮、黄柏(炒)、侧柏叶各10克，小蓟10克，血止后改用清热利湿止带法，处方：败酱草、蒲公英各30克，黄柏(炒)、赤芍、苍术(炒)各10克，山萸肉30克，椿根皮10克，当归5克，车前子.10克，(包)c水煎，分早晚2次温服，每日1剂，连服15剂。

第二章 下血崩漏

第一节 血崩昏暗六

【原文】：妇人有一时血崩，两目黑暗，昏晕在地，不省人事者，人莫不谓火盛动血也。然此火非实火，乃虚火耳。世人一见血崩，往往用止涩之品，虽亦能取效于一时，但不用补阴之药，则虚火易于冲击，恐随止随发，以致经年累月不能全愈者有之。是止崩之药，不可独用，必须于补阴之中行土崩之法。方用固本止崩汤。

固本止崩汤方：
大熟地一两（九蒸），白术一两（土炒焦），黄耆三钱（生用），当归五钱（酒洗），黑姜二钱，人参三钱
水煎服。一剂崩止，十剂不再发。

傅山曰：倘畏药味之重而减半，则力薄而不能止。方妙在全不去止血而惟补血，又不止补血而更补气，非惟补气而更补火。盖血崩而至於黑暗昏晕，则血已尽去，仅存一线之气，以为护持，若不急补其气以生血，而先补其血而遗气，则有形之血，恐不能遽生，而无形之气，必且至尽散，此所以不先补血而先补气也。然单补气则血又不易生；单补血而不补火，则血又必凝滞，而不能随气而速生。况黑姜引血归经，是补中又有收敛之妙，所以同补气补血之药并用之耳。

注家曰：若血崩数日，血下数斗，六脉俱无，鼻中微微有息，不可遽服此方，恐气将脱不能受峻补也。有力者用辽人参去芦三钱煎成，冲贯众炭末一钱服之，待气息微旺然后服此方，仍加贯众炭末一钱，无不见效；无力者用无灰黄酒冲贯众炭末三钱服之，待其气接神清始可服此方。人参以党参代之，临服亦加贯众炭末一钱冲入。

【方解】方中重用参芪益气摄血，白术健脾而统血，重用熟地配当归以养血滋阴，生化有形之血，俾气有所附，虚热自消。佐以黑姜入血分而温经止血。贯众炭是将洗干净后的贯众片炒至焦黑，后喷洒清水，放凉晒干而成。贯众具有清热解毒、杀虫的功效，贯众炭具有良好的凉血止血的功效。贯众炭擅长治疗血热所致吐血、鼻血、便血、尿血、月经淋漓不尽、白带多、外伤出血、人流及产后出血等。贯众炭是治疗实热的药，阴虚内热慎用；由于贯众炭偏凉，脾胃虚寒者慎用，孕妇慎用。

【固本止崩汤医案】李玲辉：

崩漏周某某，女，45岁，教师，已婚，2006年9月6日门诊就诊。主诉：阴道出血半月多，伴心悸、眩晕。患者40岁后开始月经紊乱。13岁月经初潮。周期一般26~32天，偶见2~5月一潮，持续时间10~25天不等，量多。曾多处服药治疗，效果欠佳。前次月经2006年4月，停经4个月后于8月16日阴道流血，开始时量多如崩，继则时多时少，以后血量渐次减少，色淡红，无瘀块，但淋漓不断，至9月6日来诊。症见面色比白，头晕目眩，心悸气短，腰膝酸软，形寒肢冷，纳呆便溏，舌淡胖边有齿痕，苔薄白，脉沉细。一般检查：基础体温测定：基础体温呈不规则的单相型。实验室检查：血常规：血红蛋白85g/L。妇科常规检查：宫颈黏液结晶：宫颈黏液持续透明量多，延展性好，镜下呈典型羊齿植物结晶。超声波检查：内生殖器无异常声像图显示。出血期有时可见宫内有血块，或出血前内膜过厚。

诊断：崩漏辨证：脾肾两虚兼气血不足。治则：健脾益气、补肾固冲止血。处方：人参30g，黄芪30g，白术20g，熟地30g，归身15g，黑姜20g，阿胶20g(烊服)，鹿胶15g(烊服)，艾叶炭15g，菟丝子10g，女贞子15g，血余炭10g。1剂/天，上药加水500mL，浸泡20分钟后，用武火煎沸后文火煎30分钟。取药汁300mL，分3次口服。连服3剂后，阴道流血量减少。再按上方服用7剂后阴道流血停止，上述症状痊愈。依上法再给予中成药人参归脾丸和六味地黄丸交替服用1个月。2006年11月22日月经复潮，经量经色正常，5天干净。自觉头晕目眩，心悸气短，腰膝酸软，形寒肢冷，纳呆便溏等症状消失。复查血常规：血红蛋白105g/L。以后继续门诊随访。2年来月经一直正常，精神面色均好。(中国医药指南)。

【固本止崩汤月经先期量多医案】晏金城：

夏某某，43岁，电厂话务员。患者6年前出现月经提前10余天来潮，甚则每月2次。色淡红，量多，夹块，经行7~8天干净。本次月经提前12天来潮，量多，已10天未净。伴头晕乏力，纳差，二便调。查：面色少华，舌淡红，苔薄白，脉细滑。证属脾不统血。治以健脾益气，养血止血。处方：西洋参10g，黄芪15g，白术10g，黑姜5g，熟地炭30g，阿胶珠30g，当归5g，川芎5g，白芍10g，甘草3g，4剂而血止。后仍以健脾益气，养血调经法治疗。第2次月经5月8日来潮，量中等，色红，经行4天干净。随访2个月，月经正常。(湖南中医杂志)。

【固本止崩汤习惯性流产医案】王艳：

屈某，女，岁，已婚。1998年5月6号初诊。患者平素体虚于1996年、1997年妊娠3个月连续流产2次，曾服西药注射针液治疗，效果不佳。现妊娠3月始感腹部不适，阴道少量见红，并有下坠之感，遂来本院就诊。证见面色无华，精神不佳，头晕心悸，纳食减少，恶心，腰膝酸软，舌质淡、苔薄白，脉沉细无力。RBC 2.89x 10'/L，Hb10g/L。

由于患者平素体虚，则气虚不足以载胎，血虚不足以养胎，肾虚则冲任不固，胎失所系，导致滑胎：当务之急，须防再坠，治宜补脾肾，益气血，固冲任，安胎元。方用固本止崩汤合寿胎丸加减：炙黄芪30g，人参、熟地、姜炭、白术、阿胶(烊化)、菟丝子、白芍、黄芩

等各 10g，川断、桑寄生各 15g，砂仁 6g。进药 3 剂后，漏红已止，腹部不适亦减，效不更方，继服 2 周，胃纳可，精神佳，其他诸证减轻。嘱患者注意卧床休息。于 1998 年 11 月足月生产一男婴，母子俱安。4.上环后出血邵某，27 岁，2003 年 5 月 19 日就诊。主诉：上环近 1 年，月经量明显增多，且经期延长，淋漓不断，少则 10 天，多则半月余。曾多处治疗，效果不佳。现症：月经量增多，末次月经 2003 年 5 月 13 日，一天用工生巾 5~6 片，经色淡红，质薄，至今未见减少来诊。伴见气短神疲，面色比白，手足不温，失眠多梦，腰膝酸软，舌质淡，苔薄白，脉沉弱。B 超检查环位正常，未见子宫肌瘤等器质性病变。症属脾虚失统，冲任失固。治以补气摄血，养血调经。处以固本止崩汤加减治疗。方药：生地黄 20g，熟地黄 20g，白术 10g，黄芪 15g，党参 10g，白芍 15g，山药 10g，炒荆芥 6g，炒蒲黄 15g，焦三仙 10g，续断 15g，大枣 6 枚。3 剂，日 1 剂，水煎服。5 月 22 日复诊，自述用药后出血停止，但白带夹血丝，伴随症状明显减轻，精神好转，嘱继服上方 3 剂巩固疗效，下次月经来潮第五天来诊。2003 年 6 月 20 日来诊，自述此次月经量比以往减少但比上环以前量增多。面色红润，饮食增加，失眠多梦，腰膝酸软等伴随症状减轻，舌淡，苔薄白，脉细有力。嘱继服上方 6 剂，以巩固治疗。半年后随访，经期、经量恢复正常，未见复发。(河南中医)。

【临证提要】临床上固本止崩汤多用于漏下日久，淋漓不净，方中大补气血以止血，且强调大补元气，“不急补其气以生血，而先补其血而遗气，则有形之血，恐不能遽生，而无形之气，必且至尽散，此所以不先补血而先补气也”。若暴发崩中，出血过多而不止，以致昏厥晕倒，不省人事，当此危机之际，恐固本止崩汤缓难以济急，必须重用独参汤或参附汤，酌加姜炭、阿胶以回阳固脱。等苏复之后再进上方，较为安妥。并应询问病史，结合妇科检查，排除妊娠出血疾患或生殖器官损伤、肿瘤等。

第二节 年老血崩七

【原文】：妇人有年老血崩者，其症亦与前血崩昏暗者同，人以为老妇之虚耳，谁知是不慎房帏之故乎！方用加减当归补血汤。

加减当归补血汤方：

当归一两（酒洗），黄耆一两（生用），三七根末三钱，桑叶（十四片）

水煎服。二剂而血少止，四剂不再发。然必须断欲始除根，若再犯色欲，未有不重病者也。

傅山曰：夫补血汤乃气血两补之神剂，三七根乃止血之圣药，加入桑叶者，所以滋肾之阴，又有收敛之妙耳。但老妇阴精既亏，用此方以止其暂时之漏，实有奇功，而不可责其永远之绩者，以补精之味尚少也。服此四剂后，再增入：白术五钱，熟地一两，山药四钱，麦冬三钱，北五味一钱，服百剂，则崩漏之根可尽除矣。

注家曰：亦有孀妇年老血崩者，必系气冲血室，原方加杭芍炭三钱，贯众炭三钱极效。

【老年下血傅青主加减当归补血汤加生地黄医案】张锡纯：

家族婶有下血证，医治十余年，时愈时发，终未除根。一九二六年六月，病又作，请为诊视。治以《傅青主女科》治老妇血崩方，遵师训加生地黄一两，一服即愈。七月，病又反复。治以安冲汤方，以其心中觉凉，加干姜二钱，一剂病又愈。

罗按：罗大伦云此乃三七之功用。张氏很推崇《傅青主女科》，用方加生地黄一两，一剂而愈，其效如神。

【加减当归补血汤合因冲汤崩漏】刘国平：

吴某，45 岁，以月经紊乱，经量多，经期长半年于 2007 年 6 月 1 日就诊。患者在 2005 年底即月经量多、持续 10 余日，经期无规律。曾用中西药治疗效不显，前来就诊。现月经来潮 18 天，量时多时少、血块、色暗，伴小腹时痛，面色萎黄、四肢乏力、体倦，舌淡胖齿痕，脉细略数，诊为崩漏，证属脾气虚弱，用加味当归补血汤合固冲汤化裁：黄芪 50g，当归 20g，

炒白术 12g，炒白芍 40g，阿胶 10g(烊化)，桑叶 30g，党参 25g，煅龙骨 30g，煅牡蛎 30g，海螵蛸 15g，蘼草 10g，棕榈炭 15g，仙鹤草 40g，三七 10g(炖)。3 剂血止，继用归脾汤调治而愈。(内蒙古中医)。

罗注：固冲汤乃张锡纯之方也，治妇女血崩。方：

白术一两（炒），生黄芪六钱，龙骨八钱（捣细），牡蛎（八钱，捣细），萸肉（八钱，去净核）生杭芍四钱，海螵蛸四钱，捣细），茜草三钱，棕边炭二钱，五倍子五分，轧细药汁送服）

张氏曰：脉象热者加大生地一两；凉者加乌附子二钱；大怒之后，因肝气冲激血崩者，加柴胡二钱。若服两剂不愈，去棕边炭，加真阿胶五钱，另炖同服。服药觉热者宜酌加生地。从前之方，龙骨、牡蛎皆生用，其理已详于理冲丸下。此方独用煅者，因煅之，则收涩之力较大，欲借之以收一时之功也。

【加减当归补血汤支气管扩张咳血】张华：

男，32 岁，农民。1986 年 3 月 16 日初诊，患“支气管扩张”5 年之久，每遇感冒或劳累后即发，曾住院多次未能根治，本次因感冒而发，咳嗽，咳血量多，色鲜红，病已 3 天，经西药治疗，外感已解，咳嗽，咳血未除，面色萎黄，形体消瘦，气短乏力，舌淡苔白，脉细无力。证属：肺气耗散，血失统摄。治法以益气敛肺摄血。方药：黄芪 30g，当归 12g，霜桑叶 10g，三七粉 4g(冲)，生地 15g，阿胶 15g(化)，炙枇叶 10g，水煎服，3 剂，1 剂血减大半，3 剂血全止。后以上方去三七粉，熟地易生地，加山萸肉 10g，意在金水相生，以巩固疗效。1 年后随访，咳血末曾复发，感冒发病次数较前减少。(陕西中医学院学报)。

【加减当归补血汤吐血】张华：

男，40 岁。1987 年 10 月 3 日初诊，既往有“胃溃疡”病史 10 余年。每遇生冷饭食或食杂粮后，即感胃脘嘈杂疼痛，反酸，自服“维 U 颠茄铝镁片、复方氢氧化铝”等后可缓解。1 周前因饭食不当，上证复发，并吐血 2 次，每次约 150mL，为咖啡色，自服上药，效果不佳，随来就诊，胃脘闷疼，喜温喜按，面色萎黄神疲乏力，便溏色黑，舌淡边暗苔白，脉沉涩无力。证属：气虚络瘀、血不归经。治法为益气通络，引血归经。方药：黄芪 30g，当归 12g，霜桑叶 10g，三七粉 4g(冲)，乌贼骨 10g，煅瓦楞 30g，伏龙肝 30g，炒白术 12g。水煎服，3 剂吐血反酸全止，原方去三七粉，嘱其继服半月，1 年后随访，吐血末再发生。(陕西中医学院学报)。

【加减当归补血汤便血】张华：

女，52 岁，农民。1987 年 2 月 9 日初诊，腹泻半年余，以血便为主，时夹有黏液。经西医诊断为“慢性非特异性溃疡性结肠炎”，每因劳累或饮食不当而加重，纳差消瘦，腹痛隐隐，喜温喜按，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细弱。证属脾虚气陷，血失统摄。治法为健脾益气摄血。方药：黄芪 30g，当归 12g，霜桑叶 10g，三七粉 4g(冲)，焦白术 12g，伏龙肝 30g，槐米 12g，焦地榆 15g。3 剂血止。大便不实，后于原方去三七粉加党参，隔日 1 剂，连服月余而愈。(陕西中医学院学报)。

【加减当归补血汤尿血】张华：

男，15 岁，学生，1984 年 10 月 6 日初诊。患“急性肾小球肾炎”3 年，每年 10 月份复发。颜面浮肿，面色白，神疲微言，尿少，色如洗肉水状，舌淡体胖苔白，脉濡缓。查尿常规：蛋白(++)，红细胞(+++)，管型少许。血红蛋白 8g，红细胞 2.6x10”/L。证属脾肾气虚，水泛血溢。治法为健脾补肾，摄血利水。方药：黄芪 30g，当归 10g，霜桑叶 10g，三七粉 3g(冲)，山药 15g，白茅根 30g，炒白术 10g，茯苓 15g，连翘 30g，连服 3 剂。肿消血止，尿色如常。原方去三七粉，加山萸肉 10g，丹皮 10g，7 剂。复查尿：蛋白转阴，红细胞消失。嘱上方隔日 1 剂，再服 20 剂。同时服用六味地黄丸，以巩固疗效，次年随访未复发。

【临证提要】本方加减应用：①岳美中老先生以病例形式介绍一例：是一育龄妇女，经

数医医治无效，用此方加白芍一两、白术四钱收效，且认为白芍量也必须是一两以上，他说："用此方止血，关键在白芍、桑叶用量要大。根据《止园医话》载：白芍止血力大，我加入方中，常用一两以上大量，治愈多人"。有医家应用之，确有其效，只不过对有脾胃欠佳者，以炒用之，以防腹泻之虞。方中黄芪宜生用且剂量要大 30~60g，功效为益气升清，配伍白术健脾利湿消肿，二者合用有强壮作用，可增强免疫功能，促进蛋白代谢。②对脾胃虚者可合张锡纯《衷中参西录》中的固冲汤。因张氏固冲汤对脾胃虚弱、中气不足、血失统摄者有良效，加之方中止血药多，所以收效更佳。③偏血热者可合张志远先生的地榆、贯众、白头翁以清热凉血，因三味药皆为苦寒之品，有凉血作用。在许多本草书中均言有治崩漏之力，事实证明，的确疗效甚佳。"它们在止血方面的区别是：地榆味酸偏于收敛，贯众促进宫缩，侧重清热解毒，白头翁祛瘀生新，兼消积聚。三药配伍使用，不仅能清热泄火，尚有涩以固脱和祛瘀生新相辅相成的特殊功能"。(刘国平)。

第三节 少妇血崩

【原文】：有少妇甫娠三月，即便血崩，而胎亦随堕，人以为挫闪受伤而致，谁知是行房不慎之过哉！治法自当以补气为主，而少佐以补血乏品，斯为得之。方用固气汤。

固气汤方：

人参一两，白术五钱（土炒），大熟地五钱（九蒸），当归三钱（酒洗），白茯苓二钱，甘草一钱，杜仲三钱（炒黑），山萸肉二钱（蒸），远志一钱（去心），五味子十粒（炒）

水煎服。一剂而血止，连服十剂全愈。

【方歌】少妇血崩固气汤，气血精亏用是方，参苓术草萸五味；杜仲远志归地黄。

傅山曰：此方固气而兼补血。已去之血，可以速生，将脱之血，可以尽摄。凡气虚而崩漏者，此方最可通治，非仅治小产之崩。其最妙者，不去止血，而止血之味，含於补气之中也。

原注：妊娠宜避房事，不避者纵幸不至崩，往往堕胎，即不堕胎，生子亦难养，慎之！戒之！

【固气汤功用】补气养血，益肾安胎，益气养血，填精固元。

【主治】少妇早孕行房不慎而血崩，坠胎，伴腰部酸痛，小腹坠胀，阴道出血，血色淡红，神疲乏力，面色恍白，心悸气短，头晕耳鸣等，舌质淡，苔薄白，脉细滑无力。元气素亏、精血不足之小产或血崩漏下。可以兼见神疲懒言、气短乏力、腰膝酸软、面色无华，舌淡、脉沉无力。

【方解】方名固气，固者，固胎、固血之意，气者，补气之意；固气者，补益坚固元气之谓。方中重用人参一两，益气生精，固元培本；人参合熟地黄补气生精；人参合土炒白术、茯苓、甘草为名方四君子汤，主健脾益气；熟地黄、当归养血；杜仲炭、山萸肉、远志、炒五味子益肾填精、培元固胎，又有涩血之功；远志、炒五味子定神志安心神。全方集益气养血、补肾填精为一方，收止血固胎之功。

【加减】腰部酸痛者，加杜仲、川断以补益肾气；心悸气短者，加黄芪、茯苓以健脾益气；食欲不振者，加鸡内金、麦芽以健脾消食。

【方论】傅青主创立固气汤，主要治疗少妇早孕后由于房事不当所造成的坠胎出血之症以及素体气虚而崩漏者，其指出此方"固气而兼补血，已去之血可以速生，将脱之血可以尽摄"。方中重用人参大补亡气，白术健脾益气，加之茯苓甘草即为四君子汤。益气健脾而使将脱之血固摄，已去之血速生，寓止血于补气之中，当归、熟地补血养血，山萸肉、杜仲滋补脾肾，炒黑杜仲又可益肾止崩，对胎未坠者可固肾安胎。远志交通心肾，五味子收敛肾气，

甘草调和诸药，全方共奏补气养血，益肾安胎之功。肾气得固，冲任得养，即可摄血。正如傅氏所言“其最妙者，不去止血，而止血之味含于补气之中也”。

【方解】本方由八珍汤加减化裁而成，因病属气虚不能摄血，故八珍汤去川芎、白芍、防其伐气，加杜仲、山萸肉以补肝肾而养冲任，远志、五味子以交通心肾。因病由房事而起，同房则心气动而肾精泄，故益远志宁心安神，五味子滋肾养精，且二药同用，可使心肾相交、水火既济。诸药合用共奏益气、补血、填精，以固冲任之效。故傅氏云：“此方固气而兼补血。已去之血，可以速生，将脱之血，可以尽摄。凡气虚而崩漏者，此方最可通治，非仅治小产之崩。其最妙者，不去止血，而止血之味，含于补气之中也。”

【医论】冲脉为血海，任脉主胞胎，冲任二脉气血充足，则胎有所载，血有所养，胞胎乃安。傅青主认为，妇人元气本虚，冲任不固，又甫辰三月，房帏不慎，复伤气血，胎无所养而易胎坠血崩。治疗此宜固气为主兼以补血，对于气虚崩漏者亦可用此方。正如其言“气弱而又娠，再加以久战，内外之气皆动…...其崩而坠也……，治法自当以补气为主，而少佐以补血之品…方用固气汤”

此症属于祖国医学的坠胎或小产病。多是气血虚弱，肾精亏虚，或外伤跌闪，热病伤胎等造成。素体脾胃虚弱，气血不足，或先天肾精亏虚，气虚不能载胎，血虚又不能养胎，肾虚胎元不固，热邪内扰冲任，跌仆闪挫损伤胎元，皆可致堕胎、小产。而本症所述即是素体虚弱，又行房不慎，肾虚不固所致的堕胎。对于少妇房事不当所致堕胎，以往医家亦有所述，《医部全录妇科》：“妊娠胎动不安者，由冲任经虚，受胎不实也，亦有饮酒房室过度，损伤不安者……..”堕胎、小产乃现代医学的“流产”。妊娠 12 周以内为“早期流产”，妊娠 12~20 周为“晚期流产”。多是由于胚胎发育不全，或母体创伤，多种疾病，血型不合，生活无节等多种原因引起，临床以阴道出血及腹痛为主要症状，应根据病人及胎儿情况分别处理。

【固气汤治月经点滴不净医案】

高某，女 25 岁，已婚。月经点滴不净一月余，腰酸、乏力、小腹微冷，舌淡苔薄，脉细滑。证因元气不足而至，治宜调补气血以养元气，兼以温经止血。

处方：当归，黄芪各 30 克，党参 10 克，熟地黄 15 克，白术，茯苓，菟丝子，艾叶，杜仲 1 各 0 克，甘草 3 克，仙鹤草 30 克，水煎服，3 剂。

二诊：经血已净，诸症好转，去仙鹤草。当归、黄芪改为 15 克，续服 10 余剂诸症消失而愈。

【固气汤 14 岁初潮起即每日点滴不净医案】

王某，女，24 岁，未婚，2013 年 9 月 23 日来诊。患者自 14 岁初潮起即每日点滴不净，无月经规律，服药只可暂止，停药即复；气短乏力，腰痛。舌淡白苔薄，脉细弱。证属肾气虚弱，法当补肾调经，益气养元。

处方：巴戟天，杜仲，菟丝子各 10 克，补骨脂 6 克，熟地黄 15 克，山萸肉 6 克，黄芪，党参各 15 克，白术 10 克，五味子 2 克，炮姜 5 克，水煎服，5 剂。

二诊：服药 2 剂后经血即止，诸症好转。续调理两月余，已有正常经期，随访至今未复。

【桂枝加附子汤血崩医案】闫云科：

李某，女，40 岁，素日形体消瘦，虚弱多病。今年妊娠五月行引产手术，术中出血较多，迁延半月方止，亦未及时调补。术后 36 天，复又见红，量多色淡，微有血块，少腹不痛，自认为月经，未予重视，七日血不减，始就医。先用消炎、止血剂不效，后又行刮宫术，量虽减，犹未止。逶延月余，致虚衰益甚。头晕目眩，体倦无力，昼不思食，夜不得寐，心悸筑筑，汗出津津。近复因食水果患泄泻，一日三四行。恶心嗳逆，肠鸣后重。本属至虚之体，复遭创伤、伤食之苦。询知自引产后，时发热，自汗出，汗后恶寒，口不干，不思饮。视其面色萎黄，爪甲少红，舌淡白，苔薄白。切诊脉象沉缓无力，腹直肌紧张，无压痛。

观其脉症，知其气血两虚，营卫不和，阳气失固，故漏、汗、利诸症一时并见，治当调和营卫，补阳益气。拟桂枝加附子汤加味：桂枝 10g，白芍 10g，炙草 6g，附子 6g，白术 15g，黄芪 15g，生姜 10 片，红枣 5 枚，二剂。二诊：崩漏停，下利止，知饥思食，发热汗出、心悸失眠亦轻。仍恶寒，脉象弱。拟原方二剂。三诊：发热汗出止，不再恶寒，诸症悉轻，嘱服归脾丸善后。

按：指出阳虚液脱之病因、症状及治方。证之临床，桂枝证加阳虚液脱者，即可投用，不必限于发汗与否。如本案久漏不止，为阳虚液脱之因，亦系遂漏不止之“红汗”也。故投桂枝加附子汤以治。可见伤寒方非囿于治伤寒也。（医案）

第四节 交感出血

【原文】：妇人有一交合则流血不止者，虽不至于血崩之甚，而终年累月不得愈，未免血气两伤，久则恐有血枯经闭之忧。此等之病，成于经水正来之时交合，精冲血管也。夫精冲血管，不过一时之伤，精出宜愈，何以久而流红？不知血管最娇嫩，断不可以精伤。凡妇人受孕，必于血管己净之时，方保无虞。倘经水正旺，彼欲涌出而精射之，则欲出之血反退而缩入，既不能受精而成胎，势必至集精而化血。交感之际，淫气触动其旧日之精，则两相感召，旧精欲出，而血亦随之而出。治法须通其胞胎之气，引旧日日之集精外出，而益之以补气补精之药，则血管之伤，可以补完矣。方用引精止血汤。

引精止血汤方：

人参五钱，白术一两（土炒）茯苓三钱（去皮），熟地一两（九蒸）山萸肉五钱（蒸），黑姜一钱，黄柏五分，芥穗三钱，车前子三钱（酒炒）

水煎。连服四剂愈，十剂不再发。

傅山曰：此方用参儿以补气，用地萸以补精，精气既旺，则血管流通；加入茯苓、车前以利水与窍，水利则血管亦利；又加黄柏为引，直入血管之中，而引夙精出於血管之外；芥穗引败血出於血管之内；黑姜以止血管之口。一方之中，实有调停曲折之妙，故能怯旧病而除陈苛。然必须慎房帏三月，破者始不至重伤，而补者始不至重损，否则不过取目前之效耳。其慎之哉！宜寡欲。

【作用与功效】益气健脾，补肾止血。

【方解】此方用参术以补气，用地、萸以补精，精气既旺，则血管流通；加人茯苓、车前以利水与窍，水利则血管亦利；又加黄柏为引，直人血管之中，而引夙精于血管之外；芥穗引败血出于血管之内；黑姜以止血管之口。

1. 男子房帏交感精血混出唐汝梅用此方治男子房韩交感精血混出 22 例，基本方：山萸肉 18g，党参、车前子各 15g，炒白术、熟地、荆芥穗各 12g，茯苓、黑姜各 10g，黄柏 6g。加减：阴虚火旺明显者，去党参、白术，加龟板胶、炒知母、山栀、丹皮；小腹胀痛甚者，加橘核仁、醋香附。痊愈 12 例，显效 6 例，有效 2 例，无效 2 例，总有效率 90.9%。

【引精止血汤治疗房帷交感精血混出】唐汝梅：

典型案例：王某，男，46 岁。1989 年 8 月 27 日初诊。近月来房帏排精红白相兼，并感会阴部坠胀刺痛，房事后小腹胀痛，似有气攻冲而牵及腰部，头晕，口苦，喜冷饮，胸闷脘胀，食则加剧，舌质红，苔薄黄腻，脉细弦滑数。证属相火妄动，精伤络损，血瘀气滞。治宜补精益阴，泄火行气之法。方拟引精止血汤加减：生地、龟板胶、丹皮各 15g，熟地、山萸肉各 12g，炒黄柏 9g，黑芥穗、橘核仁各 10g，黑姜炭、焦山栀、肥知母、醋香附各 6g。5 剂。二诊(9 月 3 日)：药后会阴疼痛减轻，但食后脘闷不适，再拟原方去山栀加神曲 12g。5 剂。三诊(9 月 8 日)：症状已基本消失，房帏时精液如常。复拟益肾养肝之剂 20 剂以资调理。(安徽中医临床杂志)。

【引精止血汤治疗更年期功能性子宫出血】

2.更年期功能性子宫出血李萍报道近年来运用《傅青主女科》引精止血汤治疗更年期功能性子宫出血10例。10例患者均来自门诊，年龄平均在45~55岁之间；病程长者0.5年，短者30天，经B超诊断排除子宫肌瘤，子宫腺肌症，子宫内膜异位症，宫颈癌等各种器质性病变。临床表现为不明原因的阴道出血，时多时少，倦怠乏力，纳差失眠，心悸，时有腰酸背痛，头晕，面色皖白，舌淡胖，有齿痕，苔薄白，脉沉细无力。诊为更年期子宫功能性出血症。引精止血汤具有益气健脾、消炎止血的功效。其药物组成：人参15g(另包)，白术30g，茯苓9g，熟地黄30g(久蒸)，山茱萸15g，炮姜3g，黄柏1.5g，黑荆芥9g，车前子30g(布包)，贯众炭3g(研粉冲服)，水煎服，早晚2次分服，日1剂，5剂为1疗程。

【引精止血汤治疗更年期子宫功能性出血】李萍：

典型病例：唐某，女，48岁，汉族，干部。2004年9月15日初诊。自诉8月1日到上海出差时月经来潮，今已月余，曾在上海某西医院治疗，并输液(用药不详)，但无效。至今仍淋漓不断，血量较前有所增多。现腰背酸痛，头微晕，体乏，口淡无味，面色皖白，舌淡胖有齿痕，苔薄白，脉虚弱无力。B超提示：子宫大小正常，内膜稍厚，双侧附件未见异常，依据以上症状，诊断为更年期子宫功能性出血，遂予引精止血汤，服药2剂血已减少，再3剂血已止。三诊时嘱其再服5剂以防复发。(河南中医学院学报)。

【引精止血汤治疗人工流产后子宫内膜修复期出血】：

3.交感出血史国平报道自1989~1999年选用《傅青主女科》引精止血汤治疗此症140例，140例中年龄23~30岁31例，31~40岁91例，41~45岁18例。病程最短15天，最长13年。出血发生在月经期间90例，产褥期22例，人工流产后子宫内膜修复期28例。诊断标准是：在月经来潮期间、产褥期、人工流产后子宫内膜修复期进行性生活所致不规则流血。排除其他疾病所致的阴道出血。内服引精止血汤，方剂组成：党参、白术、熟地各30g，山萸肉、车前子(包煎)各15g，黑荆芥、茯苓各9g，黑干姜3g，黄柏1.5g。每日1剂，水煎2次，取汁500mL，分2次服。服药期间停用其他一切止血类药物。140例经服3~5天后，阴道不规则流血均获止住，有效率达100%。典型病例：杨某，36岁。1990年1月22日诊。患者剖腹产后不规则阴道流血3月余，量少，面色不华，贫血貌，气短，纳差，畏寒，头痛，口无味，反酸水，阵发性心慌，两膝关节酸痛发冷。舌淡胖而嫩、苔白，脉细数。经妇科治疗，疗效不显，追问病史，获悉在此期间有性生活。遂予引精止血汤。服5剂，阴道出血由缓解而止住，因伴有气血两亏及瘀血凝滞见症，改用加味桃红四物汤善后。

【引精止血汤治疗患者阴道不规则出血已13年】史国平：

典型病例：毕某，38岁。1990年3月31日诊。患者阴道不规则出血已13年，并与崩漏交替出现，少有干净时日。神萎，面色不华，贫血貌，气短，喜叹息，常有呃逆，盗汗，纳呆，便秘，头痛头晕，齿衄，两肋疼痛，两髂部疼痛麻木，两下肢厥冷。询知13年前曾有子痫病史。妇科检查，子宫稍大，稍软，宫颈II度糜烂。B超示子宫腔内未见占位性病变。舌绛而边有瘀斑、苔少，脉沉细。处予引精止血汤。服5剂后，阴道出血已止。因其病程较长，有气血两亏，及寒凝肝郁等见症，改用补气益血、温经祛瘀、疏肝理气等方药调治，逐渐恢复健康。(浙江中医杂志)。

【临证提要】引精止血汤是《傅青主女科》上记载治疗男女交感出血的良方，傅氏提出“经本于肾”的辨证方法，又据《诸病源候论·妇人杂病》云：“漏下之病由劳伤气血……冲任之脉虚损，不能制约经血，故血非时而下，淋漓或漏也。”前人对病机论述深刻且透彻，方中诸药合用益气健脾，消炎止血，又祛肾中浮火，故效果显著。临床上不仅治疗男子房帏交感精血混出、女子交感出血，还可治疗更年期功能失调性子宫出血。

第五节 郁结血崩

【原文】：妇人有怀抱甚郁，口干舌渴，呕吐吞酸，而血下崩者，人皆以火治之，时而效，时而不效，其故何也？是不识为肝气之郁结也。夫肝主藏血，气结而血亦结，何以反至崩记？盖肝之性急，气结则其急更甚，更急则血不能藏，故崩不免也。治法宜以开郁为主，若徒开其郁，而不知平肝，则肝气大开，肝火更炽，而血亦不能止矣。方用平肝开郁止血汤。

平肝开郁止血汤方

白芍一两（醋炒），白术一两（土炒），当归一两（酒洗），丹皮三钱，三七根三钱（研末），生地三钱（酒炒），甘草二钱，黑芥穗二钱，柴胡一钱，

水煎服。一剂呕吐止，二剂干渴除，四剂血崩愈。

傅山曰：方中妙在白芍之平肝，柴胡之开郁，白术利腰脐，则血无积住之虞。荆芥通经络，则血有归还之乐。丹皮又清骨髓之热。生地复清脏腑之炎。当归、三七於补血之中，以行止血之法，自然郁结散而血崩止矣。

（此方入贯仲炭三钱更妙。）

【傅青主平肝开郁止血汤功能失调性子宫出血】张贵兰：

用此方治疗血崩 30 例，痊愈 27 例，好转 3 例。处方：柴胡 7g，丹皮 9g，白芍，生地黄，当归各 15g，甘草 6g，黑芥穗 15g，三七 4g，阿胶 10g(烊化)，白术 15g，续断 15g。水煎，分 2 次服，日 1 剂。15 剂为 1 疗程。（河北中医）

【傅青主平肝开郁止血汤功能失调性子宫出血】饶惠玲：

应用平肝开郁止血汤加味治疗功能性子宫出血 10 例，显效 8 例，有效 1 例，无效 1 例。处方：白术、柴胡各 9g，白芍 25g，生地黄 2g，丹皮，当归各 9g，甘草、黑芥穗、三七参各 6g(冲)，茜草 9g。(山西医药杂志)。

【临证提要】肝属木，主藏血而司疏泄，喜条达而恶抑郁。若情志抑郁，最易伤肝。肝郁则木不条达，疏泄失常；郁久则易化火，火气上炎，则津液被伤而口干舌渴；木横恶土，则胃失和降而呕吐吞酸；肝气郁结，疏泄失常，血失所藏而崩。本病既由肝郁火逆引起，法应平肝解郁。郁解则木自达，木达则火平，血自归经而得藏。方用平肝解郁止血汤。此方为逍遥散加减变化而成，方中重用白芍、当归养血平肝以解郁；大量白术以健脾统血；柴胡疏肝解郁；丹皮、生地清肝之郁火，凉血止血；三七、黑芥穗止血归经。诸药合用共奏平肝解郁，清热止血之功。

第六节 闪跌血崩

【原文】：妇人有升高坠落，或闪挫受伤，以致恶血下流，有如血崩之状者，若以崩治，非徒无益而又害之也。盖此症之状，必手按之而疼痛，久之则面色痿黄，形容枯槁，乃是瘀血作祟，并非血崩可出。倘不知解瘀而用补涩，则瘀血内攻，疼无止时，反致新血不得生，旧血无由化，死不能悟，岂不可伤哉！治法须行血以去瘀，活血以止疼，则血自止而愈矣。方用逐瘀止血汤。

逐瘀止血汤方：

生地一两（酒炒），大黄三钱，赤芍三钱，丹皮一钱，当归尾五钱，枳壳五钱（炒），龟板三钱（醋炙），桃仁十粒（泡炒，研）

水煎服。一剂疼轻，二剂疼止，三剂血亦全止，不必再服矣。

傅山曰：此方之妙，妙於活血之中，佐以下滞之品，故逐瘀如扫，而止血如神。或疑跌闪升坠，是由外而伤内，虽不比内伤之重，而既已血崩，则内之所伤，亦不为轻，何以只治其瘀而不顾气也？殊不知跌闪升坠，非由内伤以及外伤者可比。盖本实不拔，去其标病可耳，

故日急则治其标。

注家曰：凡跌打损伤致唾血，呕血皆宜如此治法，若血聚胃中，宜加川厚朴一钱半，姜汁炒。

【方解】此方重用生地，清热凉血；归尾、赤芍、桃仁化瘀止痛；丹皮清热凉血；大黄凉血逐瘀；枳壳下气，佐大黄以促其涤荡瘀热之功；龟板既可祛瘀，又可养阴，有去瘀生新之功。诸药共奏活血化瘀，理血归经，止痛之效。此方之妙，妙于活血之中，佐以下滞之品，故逐瘀如扫，而止血如神。本方由桃红四物汤合桃核承气汤加减化裁而成。虽然傅氏初设本方为治跌扑闪挫外伤所致血崩，但临床上不可局限于此，从以上临床应用可知宫内节育器所致月经失调、青春期功能性子宫出血、药物不全流产、经期延长等临床上辨证属瘀热互结伤阴，灵活应用本方，或可获良效。

罗按：跌打损伤致血从阴出之故，诸伤皆可类从。傅氏之论甚妙，此病，桃核承气汤可从。若不用汤药，用针也应尊此大法，针令血出，令恶血去，新血生。龟板醋炙炮法，但凡甲壳类药物，均用此法，用沙炒后加醋，有医家云，不用此法，恐怕无效。

【逐瘀止血汤治宫内节育器所致月经失调医案】

杜林，秦应娟用逐瘀止血汤内服治疗宫内节育器致月经异常 50 例。结果：月经过多 22 例中，显效 12 例，有效 8 例，无效 2 例，总有效率为 90.9%；经期延长 11 例中显效 7 例，有效 4 例，总有效率为 100%；月经先期 17 例中，显效 9 例，有效 5 例，无效 3 例，总有效率为 82.4%。处方：生地炭 20g，赤芍 10g，丹皮 10g，桃仁 10g，当归 10g，大黄 6g，枳壳 10g，龟板 15g。每日 1 剂，水煎分早中晚 3.次服，均于下次月经前 3 天始服，连服 7 剂，以两个月经周期为 1 疗程，第三个月经周期停药观察疗效。治疗期间停用其他药物。辨证加减：气短、乏力者加党参 12g、黄芪 10g；咽干口燥者加地骨皮 12g、白芍 15g；身重苔腻者去龟板加黄柏 12g、茅根 15g；腰痛头晕者加寄生、杜仲炭各 15g；少腹胀痛甚者加刘寄奴、香附各 12g.

【逐瘀止血汤治宫内节育器所致月经失调医案 1】杜林：

典型病例：叶某，女，31 岁，1995 年 10 月初诊。患者平素月经正常，半年前置节育环后致月经提前 1 周左右来潮，常持续至第 10 天。就诊时月经提前 8 天而至，经量多、色暗红，质黏稠有块，伴少腹刺痛，有时坠胀痛，经前及经期心烦易怒，睡眠差，口干欲冷饮，舌红苔薄黄，脉弦数。此属瘀热互结、胞络阻滞、冲任失调所致，投逐瘀止血汤以活血清热、调理冲任。3 剂后经量显减，血块消失，腹痛缓解。继守方 4 剂内服后，经净、腹痛止。第二个月经周期如法调治后停药，此后月经期量色质正常。随访半年，症状无复发。(四川中医)。

【加减逐瘀止血汤治疗放环后月经失调】

李旭京等采用加减逐瘀止血汤治疗放环后月经失调 48 例，观察患者月经周期、经期、经量等变化情况，结果：治疗后显效 23 例(占 47.9%)，有效 21 例(占 43.8%)，无效 4 例(占 8.3%)，总有效率为 91.7%。基本方：生地、生蒲黄(包煎)各 15g，炙龟板(先煎)、炒川断、山药各 12g，当归、赤芍、丹皮、炒五灵脂各 10g，大黄炭、枳壳各 6g。若月经量多如冲，加旱莲草、仙鹤草各 15g，乌贼骨 20g；兼有心肝郁火，胸闷烦躁者，加黑山栀 12g，黄芩 10g；平时赤白带下，纳减，舌苔黄白腻者，加薏苡仁、败酱草各 15g，茯苓 10g；小腹冷痛者，加艾叶 10g，乌药 12g；气血虚弱加黄芪 20g，炒白术 10g；气阴两虚明显加太子参 12g，麦冬 10g。服药方法：经行量多或经前淋漓不净宜经前 5~7 天开始服药；经期延长或月经淋漓不断即服上方，每日 1 剂，连服 7~10 天，3 个月为 1 疗程。

【加减逐瘀止血汤治疗放环后月经失调】李旭京：

徐某，女，35 岁，已婚，2002 年 12 月 10 日初诊。经期延长，12~15 天方净。已婚已产，既往月经规律，5~7/30 天，量中，色红，无块。于 9 个月前行上环术，放环后月经量较前明显增多，周期规律，行经时有血块，伴轻微腹痛，透视环位正常。曾于行经期就诊于当地诊

所，予青霉素、灭滴灵等静脉点滴行抗炎治疗，以及氨甲苯酸注射液、酚磺乙胺等止血，开始尚有效，近几个月用之效不佳。来诊时诉平日多伴腰坠胀痛，口干心烦。舌暗尖红、苔薄黄，脉细。证属瘀热蕴结，伴气阴亏虚。正值行经之日，予逐瘀止血汤加味，药用：生地、生蒲黄(包煎)各15g，炙龟板(先煎)、炒川断、山药、麦冬各12g，当归、赤芍、丹皮、炒五灵脂各10g，大黄炭、枳壳各6g，乌贼骨20g。连服6剂血止，继服4剂以巩固疗效。经连续使用3个月经周期停药，随访1年未复发。(山西中医)。

【逐瘀止血汤加减治疗上环后月经失调】

郭涛荣等用逐瘀止血汤加减治疗上环后月经失调24例，治愈11例，显效7例，有效4例，无效2例。采用逐瘀止血汤加减进行治疗。基本方：生地、茜草根各15g，当归12g，赤芍、丹皮、龟板、枳壳各9g，制香附、大黄炭各10g，益母草20g。加减：出血量多者加仙鹤草30g、旱莲草20g，地榆炭12g、阿胶6g(烊化)，或吞服云南白药0.5g，每日2次；腰骶疼痛者加桑寄生、续断各12g，延胡索9g；气滞加柴胡9g，青皮12g；气虚加党参15g，升麻10g。水煎，每日1剂，分2次服。月经先期量多者于月经周期前6~8天始服上方，每日1剂，连服6剂；月经淋漓不断，出血时间过长者可见出血即服，每日1剂，连服3~5剂。

【逐瘀止血汤加减治疗阴道出血】郭涛荣：

姜某，29岁，2001年4月16日初诊。主诉：阴道出血20余天。患者以往月经的期、量均正常，色暗红，时有血块。3月26日上环后见有少量出血、腰酸、小腹隐痛，30日因持重摔倒，即出现腰及小腹刺痛拒按，继则阴道出血量多，色暗红夹有紫血块。西医曾用安络血、维生素E、当归片等药治疗半月余，效果不佳。症见阴道出血时多时少有紫血块，腰骶、小腹刺痛，面色萎黄，神疲，舌质淡暗有瘀斑，舌下脉络有迂曲，脉沉涩。方用：生地、当归、茜草根各15g，赤芍、丹皮、龟板、枳壳、玄胡索各9g，制香附、大黄炭各10g，桑寄生、续断各12g，益母草20g。3剂，水煎分2次服。4月20日二诊：服上方后下紫血块不少，小腹酸痛有减。上方又服3剂。4月24日三诊：服上方后出血量大减，腹也不痛，腰还稍酸，面白神疲。上方去赤芍、茜草根，加党参12g，3剂水煎服。服药后不再出血，以人参养荣丸善后调理。随访半年，月经期、量、色、质均已正常。(四川中医)。

【加味逐瘀止血汤治疗宫内节育器致子宫异常出血】蔡雪芬：

宫内节育器致子宫异常出血蔡雪芬等应用加味逐瘀止血汤治疗宫内节育器致子宫异常出血57例，疗效满意。药物组成：当归10g，丹皮10g，桃仁10g，赤芍12g，生地12g，龟板20g，、大黄炭10g，血竭0.9g(吞服)，白花蛇舌草30g，枳壳5g。加减：头晕加枸杞子10g，钩藤18g；便秘加瓜蒌仁15g；便溏去桃仁，改用泽兰10g。服法：行经第1天给予加味逐瘀止血汤，1天1剂，煎服2次，7剂为1个疗程，1个月经周期服1个疗程，连用3个疗程，停药观察3个月经周期。逐瘀止血汤来自《傅青主女科》，本方加用血竭、白花蛇舌草二药可提高清热化瘀止血作用，用之屡屡见效本方重在祛瘀，又不失扶正，故能通血脉、消瘀血，使冲任得固，离经之血得以归经而血止，经络通而不痛。(中国中药杂志)。

【逐瘀止血汤加味治疗青春期功能性子宫出血】王青：

青春期功能性子宫出血王青等运用逐瘀止血汤加味治疗青春期功能性子宫出血36例,痊愈14例，好转19例，未愈3例，总有效率91.7%；药物组成：当归10g，枳壳10g，生地10g，大黄炭6g，白芍15g，炙龟甲9g，丹皮10g，桃仁10g，女贞子15g，旱莲草15g。加减：淋漓不断，色紫黑，有血块，加三七粉3g(另香)；血去气弱，面色苍白，神疲乏力，加黄芪，党参各15g，枸杞子15g；大便溏者，加砂仁6g(后下)；血瘀夹热者，加大小蓟，仙鹤草各10g；血瘀夹寒者，加艾叶、官桂各5g。每日1剂，加水600mL，煎取150mL，二煎加水300mL，煎取100mL，两煎混合分2次服用。血止后继续服药至下次月经来潮停药，以后每于月经来潮前1周开始服药，至月经来潮。连用3个月为1个疗程。(包头医学院学报)。

【药物流产后阴道流血的患者加服逐瘀止血汤】张文家

药物不全流产张文山给药物流产后的患者加服逐瘀止血汤，175 例中没有 1 例再清宫，阴道流血时间平均为 4.92 天，阴道流血量统计，少量为 174 例，中量 1 例，效果显著。既起到药物清宫作用，减少子宫内膜损伤与感染机会，又祛除瘀血，加速子宫复旧，对流产后的康复起到良好作用，同时又减轻患者的痛苦与经济负担。处方：当归、桃仁、炮姜炭、炒五灵脂、蒲黄炭、金银花炭、黄柏、延胡索各 9g，川芎、制香附各 6g。此逐瘀止血汤为生化汤与失笑散化裁而成。生化汤出自《傅青主女科》，主治“产后瘀血腹痛，恶露不行，小腹疼痛”。方中当归、川芎、桃仁、制香附、延胡索活血行气止痛，炮姜炭温经散寒、止痛止血。失笑散中炒五灵脂配蒲黄炭，功用活血散结、祛瘀止痛；黄柏、金银花炭消炎止血，预防感染。逐瘀止血汤主旨立足于祛瘀、止血两大点，同时辅以养血理血、行气止痛。(安徽中医学院学报)。

【逐瘀止血汤加减治疗经期延长】冯蓓：

经期延长冯蓓应用逐瘀止血汤加减治疗经期延长 35 例。结果痊愈 25 例，好转 7 例，未愈 3 例，总有效率为 91.4%。处方：生地 30g，大黄 9g，赤芍 9g，丹皮 3g，归尾 10g，桃仁 9g，龟板 5g。加减：血块较多者，加田七末 6g(冲服)、茜草根 15g，蒲黄 15g；脾气虚加北芪 30g、白术 20g、升麻 5g；腹胀腹痛加香附 15g、延胡索 15g；阴虚血热加女贞子 20g、旱莲草 20g、黄柏 10g。于月经第 1 天开始服药，每日 1 剂，水煎服，连续服药至第 4 天停药，为 1 疗程，一般治疗 3 个疗程。(四川中医)。

第七节 血海太热血崩

【原文】：妇人有每行人道，经水即来，一如血崩，人以为胞胎有伤，触之以动其血也，谁知是子宫血海因太热而不固乎！夫子宫即在胞胎之下，而血海又在胞胎之上。血海者，冲脉也。冲脉太寒而血即亏，冲脉太热而血即沸，血崩之为病，正冲脉之火热也。然既由冲脉之热，则应常崩而无有止时，何以行人道而始来，果与肝木无恙耶？夫脾健则能摄血，肝平则能藏血。人未入房之时，君相二火，寂然不动，虽冲脉独热，而血亦不至外驰。及有人道之感，则子宫大开，君相火动，以热招热，同气相求，翕然齐动，以鼓其精房，血海泛滥，有不能止遏之势，肝欲藏之而不能，脾欲摄之而不得，故经水随交感而至，若有声应之捷，是惟火之为病也。治法必须滋阴降火，以清血海而和子宫，则终身之病，可半载而除矣。然必绝欲　三月而后可。方用清海丸。

清海丸方：

大熟地一斤（九蒸），山萸十两 （蒸），山药十两 （炒），丹皮十两，北五味二两（炒），麦冬肉十两，白术一斤（土炒），白芍一斤（酒炒），龙骨二两，地骨皮十两，干桑叶一斤，元参一斤，沙参十两，石斛十两。

上十四味，各为细末，合一处，炼蜜丸桐子大，早晚每服五钱，白滚水送下，半载全愈。

傅山曰：此方补阴而无浮动之虑，缩血而无寒凉之苦，日计不足，月计有余，潜移默夺，子宫清凉，而血海自固。倘不揣其本而齐其末，徒以发灰、白矾，黄连炭、五倍子等药末，以外治其幽隐之处，则恐愈涩而愈流，终必至於败亡也。可不慎与！

罗注：“每行人道”即是行房之意。行房之后经水即来。

【方解】此方以麦味地黄丸减茯苓、泽泻，加沙参、石斛、玄参、桑叶、白芍、地骨皮，此皆为清热养阴之品。白术健脾摄血，龙骨收涩止血。全方滋阴降火、补益肾、肝、脾而止血。傅氏曰：“此方补阴而无浮动之虑，缩血而无寒凉之苦，日计不足，月计有余，潜移默夺，子宫清凉，而血海自固。倘不揣其本而齐其末，徒以发灰、白矾、黄连炭、五倍子等药

末，以外治其幽隐之处，则恐愈涩而愈流，终必至于败亡也。可不慎与！”

【清海丸配伍相关的中药功效】

桑叶：甘、苦、寒。归肺、肝经。疏散风热，清肺润燥，平抑肝阳，清肝明目。

玄参：甘、苦、咸，微寒。归肺、胃、肾经。清热凉血，滋阴降火，解毒散结。

地骨皮：甘、寒。归肺、肝、肾经。凉血除蒸，清肺降火。

龙骨：甘、涩，平。归心、肝、肾经。镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

白术：甘、苦，温。归脾、胃经。补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎。

山药：甘，平。归脾、肺、肾经。益气养阴，补脾肺肾，涩精止带。

白芍：苦、酸，微寒。归肝、脾经。养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。

麦冬：甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。养阴润肺，益胃生津，清心除烦。

石斛：甘，微寒。归胃、肾经。益胃生津，滋阴清热。

山茱萸：酸、涩，微温。归肝、肾经。补益肝肾，收涩固脱。

北五味：就是五味子。性味：酸、咸、温。归经：入肺、肾经。功能：敛肺止咳、滋肾涩精，上泻，止汗。主治：肺虚咳嗽，口渴，遗精，自汗，盗汗，久泻久痢等症。主治肺肾虚寒之咳嗽，遗精。五味子根据产地不同，可分为北五味子和南五味子，北五味子主要产于东北及河北省。南五味子主要产于陕西和湖北等地，两者都具有敛肺止咳，生津止渴，补肾安神的作用，用于治疗咳喘日久，消渴，自汗盗汗，失眠多梦等症。北五味子和南五味子的区别在于北五味子具有涩肠止泻的功效。可用于治疗脾肾的虚寒证引起的久泻。两者区别并不是很大。但是由于北五味子产量较多，颗粒饱满，性状较好，所以目前主要在临床上使用的五味子多为北五味子。

【临床应用与医案】

崩漏之病，徐维德等应用加味清海丸治疗崩漏 40 例，以加味清海丸为基本方：熟地 30g，山药 15g，山萸肉 15g，丹皮 10g，龙骨 30g，白术 10g，白芍 15g，桑叶 10g，玄参 15g，沙参 10g，石斛 10g，三七 5g(冲)(原方中少三七)。5 剂 1 个疗程，1 疗程流血未止的续服，个别月经后流血持续不止的，嘱在每次经水适来时连服 2 疗程，最多 3 个月经期，6 个疗程。40 例中，39 例治愈(崩漏停止，月经周期 25 天以上，量不多，经期少 5 天)，1 例无效(为 1 例卵巢囊肿患者，经 B 超确诊后服 5 剂药流血未净，因故别处治疗)。最少服用 5 剂，最多 3 个月 6 疗程 30 剂，平均 17 剂，血流停止最快者为 3 天。血量减少见效最快为 1 剂，最多为 7 剂。[徐维德，闫泽山. 加味清海丸治疗崩漏 40 例. 宁夏医学杂志. 2003. 25(8)：498]。

【临证提要】临床上本方多用于崩漏，正如《妇科经论》云：“血属阴，静则循经荣内，动则错经妄行，故七情过极则五志亢盛，经血暴下，久而不止，谓之崩中，治法初用止血，以塞其流；中用清热凉血，以澄其源；末用补血，以复其旧。若止塞其流，不澄其源，则滔天之势不能遏；若止澄其源，而不复旧，则热阳上浮无以止，不可在审也。”本方以清热养阴为主，兼补气以生血，适用于崩漏的中末期，即不可用于经血暴下，因其方中止血作用欠佳。

【清海丸治月经稀病案】吴慧娇：

患者，李某，48 岁，已婚，服务员。2016 年 10 月 10 日初诊。自诉月经稀发已一年，月经 2-3 月一至，量多，需用尿布湿，前往当地医院就诊，妇检未见异常，服用激素，三七片，宫血宁胶囊等对症治疗后出血量减，但不能速绝，也曾服用过益气、养血及大量炭类药涩血，服药 20 余剂不效。

主诉:经血妄行漏下不止 6 天，兼症:月经血色红，无血块，失眠多梦，盗汗，易心烦，偶有头晕耳鸣，手足心发热，颧稍赤，晨起尿黄，大便偏干结，口干，喜冷饮，舌质红，苔少略黄，脉细略数。既往月经规则，一月一至，量中，孕 2 产 2,结扎 10 余年。西医诊断:功能失调性子宫出血。中医诊断:崩漏，阴虚血热，冲任不固。治则:滋阴清热固冲。

拟方:清海丸加减。处方:熟地 16g、沙参 16g、麦冬 16g、五味子 16g、石斛 16g、丹皮 15g、地骨皮 15g、女贞子 10g、旱莲草 10g、白术 15g、桑叶 9g、龙骨 9g，远志 10g。共 10 剂，每日一-剂，水煎服，煎两次，共取汁 300ml， 分两次服用。并嘱其必绝欲三月。服药后出血停止，随访未复发。

按此妇女之病的发生与绝经前后的生理特点密切关系。西医妇科学认为女性进入围绝经期后，月经周期经期等即将开始发生变化，卵巢功能逐渐降低，因为随着年龄增加，卵泡数量会减少，且卵泡质量也会逐年下降，所以就会发生功能失调性子宫出血，当卵泡耗竭完后，也就标志着即将绝经。

西医对该病治疗主要以激素类药为主，且服药时间长，且激素疗法很难被广大女性所接受，所以用西药治疗患者缺乏依从性，治疗发挥有限。而祖国医学认为，妇女至七七之年，天癸渐枯竭，肾气渐衰，冲脉也逐渐亏虚，阴血不足，虚火内生，则血海为之沸腾，冲任因而失固，故出现经血妄行漏下不止。肾水亏虚，上不能制约心火，即心肾不交，故致心神不宁，心烦失眠。肾阴不足，阴虚内热，津液不足，故手心烦热，口干。舌红，苔少略黄，脉细数为阴虚血热之征。方中于滋阴清热之清海丸中，加用女贞子、旱莲草以补肝肾之阴，远志通肾气，上达于心， 故能宁心助眠。诸药合用，故服之见效。

第三章 妇人鬼胎

第一节 腹似怀妊鬼胎

【原文】：妇人有腹似怀妊，终年不主，甚至二三年不生者，此鬼胎也。其人必面色黄瘦，肌肤消削，腹大如斗。厥所由来，必素与鬼交，或入神庙而兴云雨之思，或游山林而起交感之念，皆能召祟成胎。幸其人不至淫荡，见祟而有惊惶，遇合而生愧恶，则鬼祟不能久恋，一交媾即远去。然淫妖之气已结于腹，遂成鬼胎。其先尚未觉，迨后渐渐腹大，经水不行，内外相色，一如怀胎之状，有似血臌之形，其实是鬼胎而非臌也。

治法必须以逐秽为主。然人至怀胎数年不主，即非鬼胎，亦必气血衰微。况此非真妊，则邪气必旺，正不敌邪，其虚弱之状，必有可掬。乌可纯用迅利以祛荡乎！必于补中逐之为的也。方用荡鬼汤。

荡鬼汤方：
人参一两，当归一两，大黄一两，雷丸三钱，川牛膝三钱，红花三钱，丹皮三钱，枳壳一钱，厚朴一钱，小桃仁三十粒
水煎服。一剂腹必大鸣，可泻恶物半桶。再服一剂，又泻恶物而愈矣。断不可复用三剂也。盖虽补中用逐，未免迅利，多用恐伤损元气。

傅山曰：此方用雷丸以祛秽，又得大黄之扫除，用佐以厚朴、红花、桃仁等味，皆善行善攻之品，何邪之尚能留腹中而不尽逐下也哉！尤妙在用参、当以补气血，则邪去而正不伤。若单用雷丸、大黄以迅下，必有气脱血崩之患矣。倘或知是鬼胎，如室女寡妇辈，邪气虽盛而真气未漓，可用岐天师亲传霹雳散：红花半斤、大黄五两、雷丸三两，水煎服，亦能下鬼胎。然未免太于迅利，过伤气血，不若荡鬼汤之有益无损为愈也。在人临症时斟酌而善用之耳。

罗按：此“鬼胎”之言不必太较真，此应是腹有异物，今人所言之肿瘤之类是也，古人限于无解剖学，不得而知。以方逐秽为主得知，应是里有积聚实结。荡鬼汤通应具有活血散结的功效，还有破瘀消积的作用。荡鬼汤的中药含量有人参、当归、大黄、雷丸、川牛膝、红花、丹皮、枳壳、厚朴、小桃仁等，在服用药物以后，可以起到活血散结和破瘀消积的效果。

注家曰：此方用雷丸以祛秽，又得大黄之扫除，且佐以厚朴、红花、桃仁等味，皆善行善攻之品，何邪之尚能留腹中而不尽逐下也哉。尤妙在用参归以补气血，则邪去而正不伤。若单用雷丸、大黄以迅下之，必有气脱血崩之患矣。方中雷丸祛秽消积，牛膝、红花、桃仁、丹皮活血破瘀，消积散结，枳壳、厚朴行气以助血运，与活血药皆为行善攻之品，大黄荡涤积滞，使浊阴下达，人参、当归补气血，使邪去而正不伤，若单用雷丸、大黄以迅下之，必有气脱血崩之忧，防患于未然。诸药合用秽除积散而正不伤。

[运用]

本方是临床下死胎方之一，针对气滞血瘀之鬼胎而设，以孕期阴道不规则流血，紫暗有块，腹大异常，无胎动胎心，熊胁胀满，舌紫暗，脉涩或沉弦为辨证要点，现代用治葡萄胎，侵蚀性葡萄胎属气滞血瘀者。也可用于妇科肿瘤的治疗。

[加减化裁]瘀滞重者，加三棱、莪术；积块较大难消者，加鳖甲、水蛭；疼痛较重者，加元胡、香附、小茴香。

雷丸：为多孔菌科植物雷丸菌。别名：竹苓、雷实、竹铃芝、雷矢、竹铃子。性味与归经：味苦，寒，有小毒。归胃、大肠经。 主治：杀虫。用于绦虫，钩虫，蛔虫。

临床应用：

1. 雷丸散（《冉氏经验方》）治钩虫病，杀虫驱虫：雷丸 300g。将雷丸洗净，低温干燥，研为细粉，过筛即得，每服 6g。每日 3 次，每 2 日为一疗程，温开水送下。密闭防潮，勿令受热。入汤剂无效。方中雷丸杀虫，为君药。

2. 雷丸散（《杨氏家藏方》）治消疳杀虫：雷丸、使君子（炮，去壳）、鹤虱、榧子、槟榔各等分。上为细末，每服 3g，乳食前，温米饮调下。方中雷丸杀虫，为君药。

3. 雷丸浴汤（《太平圣惠方》）治小儿寒热，惊啼不安：雷丸、牡蛎、黄芩、细辛各 1g，蛇床子 30g。上药以水 1 斗，煎取 7 升，去渣，分为两度，看冷暖用，先令浴儿头，勿令水入耳目，次浴背膊，后浴腰以下，浴时避风，以粉扑之。方中雷丸逐风，杀蛔虫，为君药。

第二节 室女鬼胎

【原文】：女子有在家未嫁，月经忽断，腹大如妊，面色乍赤乍白，六脉乍大乍小。人以为血结经闭也，谁知是灵鬼凭身乎！夫人之身正，则诸邪不敢侵；其身不正，则诸邪来犯。或精神恍惚而梦里求亲，或眼目昏花而对面相狎，或假托亲属而暗处贪欢，可明言仙人而静地取乐，其始则惊诧为奇遇而不肯告人，其后则羞赧为淫亵而不敢告人。

日久年深，腹大如斗，有如怀妊之状。一身之精血，仅足以供腹中之邪，则邪日旺而正日衰，势必至经闭而血枯。后欲导其经，而邪据其腹，则经亦难通。欲生其血而邪食其精，则血实难长。医以为胎，而实非真胎。又以为瘕，而亦非瘕病。往往因循等待，不重可悲哉！治法似宜补正以祛邪，然邪不先祛，补正亦无益也。必须先祛邪而后补正，斯为得之。方用荡邪散。

注家曰：此方阴隲大矣。见有因此病羞愤而蹈于非命，劳疲而丧于妙年，深为可悯。若服此方不应，宜服桂香平胃散，无不见效。愈后宜调养气血，节饮食。

桂香方：

肉桂一钱（去粗皮），麝香一钱

以上二味共研细末，开水为丸如桐子大，空心开水下。服后半日时煎平胃散一剂服之。

平胃散方：

苍术三钱（米泔炒），厚朴二钱（姜汁炒），广皮一钱，枳实二钱（土炒），全当归三钱，川芎一钱（酒洗）

注家曰：服后必下恶物。若不见下恶物，次日再服平胃散，不用桂香。

荡邪散方：

雷丸六钱，桃仁六十粒，当归一两，丹皮一两，甘草四钱

水煎服。一剂必下恶物半桶，再服调正汤治之。

调正汤方：

白术五钱，苍术五钱，茯苓三钱，陈皮一钱，贝母一钱，薏米五钱，

水煎。

傅山曰：连服四剂则脾胃之气转，而经水渐行矣。前方荡邪，后方补正，实有次第。或疑身怀鬼胎，必大伤其血，所以闭经。今既坠其鬼胎矣，自当大补其血，乃不补血而反补胃气，何故？盖鬼胎中人，其正气大虚可知，气虚则血必不能骤生，欲补血先补气，是补气而血自然生也。用二术以补胃阳，阳气旺则阴气难犯，尤善后之妙法也。倘重用补阴之品，则以阴招阴，吾恐鬼胎虽下，而鬼气未必不再侵，故必以补阳为上策，而血自随气而生也。

第三章 月经不调

第一节 经水先期

【原文】：妇人有先期经来者，其经甚多，人以为血热之极也，谁知是肾中水火太旺乎！夫火太旺则血热，水太旺则血多，此有余之病，非不足之症也，似宜不药有喜。但过于有余，则子宫太热，亦难受孕，更恐有烁干男精之虑，过者损之，谓非既济之道乎！然而火不可任其有余，而水断不可使之不足。治之法但少清其热，不必泄其水也。方用清经散。

清经散：

丹皮三钱，地骨皮五钱，白芍三钱（酒炒），大熟地三钱（九蒸），青蒿二钱，白茯苓一钱，黄柏五分（盐水浸炒）

水煎服。二剂而火自平。此方虽是清火之品，然仍是滋水之味，火泄而水不与俱泄，损而益也。

傅山曰：又有先期经来只一、二点者，人以为血热之极也，谁知肾中火旺而阴水亏乎！夫同是先期之来，何以分虚实之异？盖妇人之经最难调，苟不分别细微，用药鲜克，有效。先期者火气之冲，多寡者水气之验，故先期而来多者，火热而水有余也；先期而来少者，火热而水不足也。倘一见先期之来，俱以为有余之热，但泄火而不补水，或水火两泄之，有不更增其病者乎！治之法不必泄火，只专补水，水既足而火自消矣，亦既济之道也。方用两地汤。

【功效】清热凉血，养阴调经。用于阳盛血热，热伤冲任之月经先期。症见经期提前，量多质稠，色深红或紫，心胸烦闷，渴喜冷饮，大便燥结，小便短赤，面赤身热，舌红苔黄，脉滑数。

【加减】月经过多者，去茯苓，加地榆、茜草根以凉血止血；经行腹痛，见经血夹瘀块者，加炒蒲黄、三七以活血化瘀止痛。月经先期加女贞子、墨旱莲、阿胶补肾中之水。月经过多，见出血量多如注、色鲜红、质黏稠者，加地榆炭、煅牡蛎以清热凉血，固经止血；热伤津液，症见口干咽燥、大便秘结，加知母、沙参、麦冬以养阴生津止血、润肠通便；气随血脱，见出血量多质稀、气短懒言者，加黄芪、党参以益气升阳，固脱摄血；瘀血阻滞气机，

见腹胀明显者，加木香、乌药以行气活血。

【按语】本方重在清热凉血，养阴调经。临床以经期提前或经期发热，量多色深红或紫，质稠，心烦口渴，舌红苔黄，脉数为用方依据。常用于月经先期、子宫出血、产褥感染、慢性盆腔炎、子宫内膜异位症、产后盗汗等证属血热内炽证者。

两地汤方：

大生地一两（酒炒），元参一两，白芍药五钱（酒炒），麦冬肉五钱，地骨皮三钱，阿胶三钱，

水煎服。四剂而经调矣。

傅山曰：此方之用地骨、生地，能清骨中之热。骨中之热，由於肾经之热，清其骨髓，则肾气自清，而又不损伤胃气，此治之巧也。况所用诸药，又纯是补水之味，水盛而火自平理也。此条与上条参观，断无误治先期之病矣。

【作用与功效】滋阴清热。

【主治适应症】阴虚血热之经水先期量少。

【方解】方中以生地、地骨皮清骨中之热而滋肾阴，玄参滋阴生津，麦冬润肺清心，以滋水之上源而降心火，使心火不炎而水火既济，阿胶以养血滋阴，白芍柔肝。全方不用苦寒清热，而重用甘寒养阴，从而达到“水盛而火自平，阴生而经自调”之目的。

【两地汤治疗月经病】秦理：

月经先期王某某，女，24 岁，已婚。2007 年 6 月 10 日诊。诉 4 个月前药流 1 次，因出血不止曾行清宫术。以后出现月经紊乱，每月提前 10 天左右，量少色红、质稠、心烦、咽干，诊之舌质红，苔少，脉细数。予两地汤治疗，药物：生地、玄参、麦冬各 15g，地骨皮 10g，阿胶 20g(烊化兑服)，白芍药 10g、水煎服，服 3 剂而痊愈，6 个月后随访无复发。(中国中医药现代远程教育)。

【两地汤治疗月经经间期出血病】秦理：

吴某某，女，30 岁，已婚。2008 年 1 月 18 日，患者诉 4 个月来，在 2 次月经中间见阴道出血，量中等，色鲜红，质黏稠，失眠，腰酸头晕，五心烦热，诊之舌质红、无苔、脉细数。拟两地汤合二至丸。药物：阿胶 20g(烊化兑服)，玄参、麦冬、生地各 15g，白芍 12g，地骨皮 12g，女贞子 15g，旱莲草 25g，水煎服，5 剂。2 个月后随访无复发。(中国中医药现代远程教育)。

【两地汤治疗虚热型经期延长】李志伟：

经期延长李志伟采用“两地汤”与醋酸甲羟孕酮分组对比治疗虚热型经期延长各 30 例，进行临床疗效观察，结论：治疗组“两地汤”治疗虚热型经期延长临床疗效肯定，尤其是复发性与对照组比较，有明显的优势。(贵阳中医学院学报)。

【两地汤加减治疗崩漏】石梅仙：

崩漏石梅仙用两地汤加减治疗崩漏 82 例，其中青春期崩漏 52 例，上环后出血 30 例。结果：青春期崩漏患者中治愈 31 例，有效 18 例，无效 3 例，总有效率 94.2%。上环后出血患者治愈 19 例，有效 8 例，无效 3 例，总有效率 90.0%。(临床医药实践)。

【傅青主两地汤治男性不育精液量少症医案】张宗圣：

精液量少患者，男，28 岁，1999 年 3 月 13 日就诊。婚后 3 年不育，性生活正常，配偶曾做多项检查，排除女方不孕因素。曾多次做精液检查，量均在 0.3~1mL 之间。曾四处求诊 1 年余，未见明显疗效。观其以前所服之药，大多为壮阳之品。查睾丸发育正常。患者稍感乏力，口干，心烦失眠，舌质红、苔薄白、脉细。诊断：精液量少。治宜补肾精，清虚热。两地汤加减：生地黄、熟地黄各 15g，玄参 15g，白芍 20g，麦冬 15g，地骨皮 10g，阿胶 10g，枸杞子 10g，山茱萸 10g，淫羊藿 10g。水煎服，日 1 剂。服药 30 剂后，查精液量为 1.5mL，复服药 30 剂，精液量约 3mL，pH7.6，液化时间 30 分钟，精子计数 30×10”个/L，活动率

75%，活动类型：3 级、4 级之和为 50%，精浆果糖 2.5g/L。停止服药 2 个月后，配偶怀孕，后生一健康女婴。(山东中医杂志)。

【两地汤治男性不育精液不液化症医案】张宗圣：

患者，男，27 岁。2000 年 4 月 3 日就诊。婚后 2 年半未育，性生活正常，排除女方不孕因素。精液检查：量约 1.5mL，2 小时不液化，精子计数 20x109 个/L，精子活动率 30%，活动类型：3 级、4 级之和为 5%。自述平时腰酸乏力，有时耳鸣，手足心热，有前列腺炎病史。舌质红，苔薄黄，脉细。诊断：精液不液化。治宜滋肾阴，清虚热。两地汤加减：生地黄、熟地黄各 15g，玄参 15g，麦冬 10g，地骨皮 10g，白薇 10g，枸杞子 10g，菟丝子 15g，山茱萸 10g，山药 20g，蒲公英 15g。水煎服，日 1 剂。服药 35 剂后精液量约 3.5mL，30 分钟完全液化，精子计数 35x10°/L，活动力 70%，活动类型：3 级、4 级之和为 45%，精浆果糖 1.9g/L。其妻于 2000 年 8 月怀孕，后生一健康男婴。(山东中医杂志)。

【临证提要】妇女以血为本，以肝为先天，朱丹溪提出的“阳常有余，阴常不足”的理论在月经病中体现较为充分。“阴常不足”指肾阴，肝血之不足。“阳常有余”实是阴血亏虚所生之内热，而非阳气之有余。两地汤善能滋阴养血，清虚热，故为月经病常用之主方。两地汤治疗范围甚广，所用诸药，集甘苦酸咸寒之性味特点，皆“纯补水之味，水盛而火自平也”。从以上病证看，虽病种有别，但总的病机不外阴虚，故用同一方药，皆获良效，体现了“异病同治”的特点。

第二节 经水后期

【原文】：妇人有经水后期而来多者，人以为血虚之病也，谁知非血虚乎！盖后期之多少，实有不同，不可执一而论。盖后期而来少，血寒而不足；后期而来多，血寒而有余。

夫经本于肾，而其流五脏六腑之血皆归之，故经来而诸经之血尽来附益，以经水行而门启不遑迅阖，诸经之血乘其隙而皆出也，但血既出矣，则成不足。治法宜于补中温散之，不得曰后期者俱不足也。方用温经摄血汤。

温经摄血汤方：
大熟地一两（九蒸），白芍一两（酒炒），川芎五钱（酒洗），白术五钱（土炒），柴胡五分，五味子三分，续断一钱，肉桂五分（去粗，研）
水煎服。三剂而经调矣。

傅山曰：此方大补肝、肾、脾之精与血，加肉桂以祛其寒，柴胡以解其郁，是补中有散，而散不耗气；补中有泄，而泄不损阴，所以补之有益，而温之收功，此调经之妙药也，而摄血之仙丹也。凡经来后期者，俱可用。倘元气不足，加人参一、二钱亦可。

【作用与功效】补益精血，温经散寒。

【主治适应症】妇女经水后期，经来量多者。

【方解】方中熟地黄、炒白芍药补肾养血，川芎活血，炒白术健脾生血，柴胡疏肝和血，肉桂辛温，温肾散寒、温经通脉。五味子酸甘，滋肾生津，宁心安神。肉桂和五味子一散一收，阴阳双补。续断补肝肾，通行血脉，补而不滞，行而不泄。诸药合用，共奏补肾益精、益气养血之功，使肝气条达，脾气健运，肾精充足，气盛血旺，冲任得养，经血自能满盈，应时而下。

【医论】经水后期的病因病机可分为血脉虚寒与血脉实寒。血脉虚寒者系由于素体阳气虚弱，阳虚则生寒，气血化生匮乏，冲任血虚，血海不能按时盈满，致月经后期而量少；若寒邪内侵，客于胞宫，血为寒凝，经血运行不畅，亦致月经后期。治法宜于补中温散之，不得曰后期者俱不足也，即补益精血，温经散寒。方用温经摄血汤。

【月经后期临床应用与医案】张素：

1.月经后期张素等将76例月经后期患者按3:1比例随机分为治疗组(57例)和对照组(19例)。治疗组采用温经摄血汤治疗，对照组采用醋酸甲羟孕酮治疗，比较2组临床疗效及复发率。结果提示温经摄血汤加减治疗月经后期疗效较西药持久，且复发率较低。(上海中医药杂志)

2.不孕症杜竹枝用温经摄血汤加减治疗76例月经后错引起不孕患者，30剂为1个疗程，服中药治疗1个疗程显效26例，有效15例；2个疗程显效12例，有效4例，无效9例，有效率为89%。效果较为满意。

【月经后期不孕医案】杜竹枝：

患者，女，28岁，教师，2004年12月20日初诊。结婚同居4年，始终未孕。16岁初潮月经即不规律，40~90天来潮一次，偶尔使用黄体酮转经，基础体温单相，末次月经2004年12月8日，经来1周干净，经量少，色淡黯，伴血块，痛经(较剧)。经来时怕冷、无力，经前1周乳房胀痛。性腺轴六项检查正常，外院输卵管造影示双侧通畅。患者就诊时恰值月经周期第12天，做阴道B超示子宫大小48mmx44mmx32mm，内膜厚3mm，左侧卵巢30mmx17mmx16mm，右侧卵巢25mmx22mmx12mm，双侧卵巢均未发现有发育卵泡。根据患者临床症状，诊断：①原发性不孕；②月经后期；③宫寒不孕，肝郁血瘀.治以温经暖宫，扶阳育阴，疏肝理气，调补冲任，活血调经。给温经摄血汤早晚空腹服，连服20天，并嘱思想放松，解除顾虑，保持良好的心态，每周2次性生活配合治疗。2005年3月31日二诊，服药后至今已113天，月经未来潮，晨起恶心，食欲减退，双侧乳房发胀，乳晕加宽加深，尿妊娠试验阳性，又做B超确定，子宫增大如孕80天状，宫腔内妊娠，囊内可见胎儿形体，原始心管搏动好。孕期经过顺利，于2005年9月15日足月顺娩一男性婴儿.体重3500g。(河南中医)。

【临证提要】月经后期的发生有虚有实。虚者，因血虚、肾虚致冲任不足，血海空虚，不能按时满溢。如《丹溪心法》云："过期而来，乃是血虚。"实者，因血寒、气滞、痰湿阻滞冲任，冲任受阻，气血运行不畅，因而后期。如《圣济总录·妇人血气门》云："凡月水不利，有因风冷伤于经络，血气得冷则涩而不利者；有因心气抑滞，血气郁结，不能宣流者。"在临床中该病以血虚、血寒、肝郁多见，病位在肝脾肾三脏。因此，治疗月经后期宜肝脾肾三脏同治。古代医家有诸多论述，如《陈素庵妇科补解·经水后期方论》说："妇人经水后期而至者，血虚也。此由脾胃虚弱，饮食减少，不能生血所致，当补脾胃，以滋生化之源。"李士材《病机沙篆》谓："血之源头在于肾，气血久虚，常须补肾益精以生血。"《女科经纶》引方约之言："凡妇人病，多是气血郁结，故治以开郁行气为主。郁开气行，而月候自调，诸病自愈矣。"

【归脾汤加吴茱萸治不进饮食经水过期而少】薛立斋：

治一妇，年三十余，忽不进饮食，日饮清茶三五碗，少用水果，经三年矣。经水过期而少，此思虚伤脾，脾气郁结所致，用归脾汤加吴茱萸，不数剂而饮食如故。

第三节 经水先后无定期

【原文】：妇人有经来断续，或前或后无定期，人以为气血之虚也，谁知是肝气之郁结乎！夫经水出诸肾，而肝为肾之子，肝郁则肾亦郁矣；肾郁而气必不宣，前后之或断或续，正肾之或通或闭耳；或曰肝气郁而肾气不应，未必至于如此。殊不知子母关切，子病而母必有顾复之情，肝郁而肾不无缱绻之谊，肝气之或开或闭，即肾气之或去或留，相因而致，又何疑焉。治法宜舒肝之郁，即开肾之郁也，肝肾之郁既开，而经水自有一定之期矣。方用定经汤。

定经汤方：

菟丝子一两（酒炒），白芍一两（酒炒），当归一两（酒洗），大熟地五钱

（九蒸），山药五钱（炒），白茯苓三钱，芥穗二钱（炒黑），柴胡五分
水煎服。二剂而经水净，四剂而经期定矣。

傅山曰：此方舒肝肾之气，非通经之药也；补肝肾之精，非利水之品也，肝肾之气舒而精通，肝肾之精旺而水利，不治之治，正妙於治也。

注家曰：以上调经三条辨论明晰，立方微妙，但恐临时或有外感，内伤不能见效，有外感者宜加苏叶一钱，有内伤者宜加神曲二钱（炒），有因肉食积滞者再加东山楂肉二钱（炒），临症须酌用之。若肝气郁抑又当以逍遥散为主，有热加栀炭、丹皮即加味逍遥散。）

【定经汤作用与功效】疏肝解郁，补肾调经。

【主治适应症】肾虚肝郁之月经先后无定期

【方解】定经汤由熟地、当归、白芍、柴胡、茯苓、山药、菟丝子、荆芥

穗八味药组成，菟丝子补肾养肝，熟地滋阴补肾，二药配伍补肾益精，养冲任；当归、白芍养血柔肝调经；柴胡、荆芥既可疏肝解郁，又可理血；山药、茯苓健脾和中而利肾水，全方共奏疏肝肾之气，补肝肾之精血，肝气舒而肾精旺，气血调和，冲任相资，而得月经量增多之疗效，治病求本，古方新用。

【定经汤治疗月经过少 30 例的临床体会】郭艳：

月经过少郭艳等用定经汤加减治疗肾虚肝郁型月经过少患者 30 例，连服 3 个月经周期，停药后每月复查 1 次，共复查 3 个月。结果提示治愈 23 例；显效 4 例；有效 2 例；无效 1 例；总有效率 99.66%。(贵阳中医学报)。

【定经汤治疗子宫肌瘤 30 例】業昌劳

子宫肌瘤嬰昌劳，尚何青用定经汤加减治疗子宫肌瘤 30 例，治疗结果示：治愈：经临床 B 超查肌瘤消失，临床症状消失者 8 例。占 26.7%；好转：临床症状减轻，B 超查较以前肌瘤缩小或萎缩者 19 例，占 63.3%；无效：治疗后无改变或加重者改用其他办法或手术治疗者 3 例，占 10%，总有效率为 90%，治疗时间最长者 100 天，最短的 20 天。(陕西中医)

【傅氏定经汤组方及应用闭经溢乳综合征】张晓峰：

闭经溢乳综合征李某，35 岁，已婚，闭经半年，于 1997 年 3 月 9 日来诊。患者既往月经时有错后，平时性急易怒。自 1996 年 9 月 15 日末次来经后迄今已闭止半年未行，因时感乳胀，偶然挤之，竟挤出少许乳汁样物。经做头部 CT、乳房局部远红外扫描及血清内分泌等有关检查，排除脑垂体腺瘤和乳房病变，诊为“闭经溢乳综合征”，血清泌乳素(PRL)为 48ug/L。望其形体较丰，面色黯滞，神情抑郁；询其神疲乏力，畏寒肢冷，夜尿多，带下清稀；诊其舌质胖大有齿痕，色紫暗，苔薄白，脉弦细，尺脉弱。先以通经回乳为首务，方用傅氏定经汤合《金鉴》免怀散、麦芽煎化裁：当归 12g，赤、白芍各 15g，红花 10g，川牛膝 15g，山药 30g，菟丝子 30g，淫羊藿 30g，益智仁 25g，桑螵蛸 15g，茯苓 12g，柴胡 9g，黑荆芥 9g，炒麦芽 50g，代赭石 20g，益母草 30g，枳壳 12g。以上方略做增损服用近 1 个月，月经来潮。继而采用中药人工周期疗法，有时间以五子补肾丸、金匮肾气丸、逍遥丸、益母丸等成药，并用炒麦芽煎水送服。继续治疗近 1 年，月经周期基本正常，乳胀消失，已挤不出乳液，他症改善。后经复查血清 PRL，已恢复至 25ug/L 以下。(中国中医药信息杂志)。

【定经汤治男科疾病不射精】辛文华：

米某，男，27 岁，1986 年 10 月 3 日初诊。自述婚后 4 年，性交时不排精，延时甚久，阴茎触痛，曾服中西药未效。证见精神颓废，急躁易怒，双目干涩，失眠盗汗，舌质黯红、苔薄黄，脉弦细数。辨证为肝郁失疏，肾精不足，精关失灵。治宜疏肝滋肾，佐以通络。予定经汤加味。处方：当归 15g，熟地 45g，白芍、云茯苓、菟丝子各 12g，荆芥炭 3g，柴胡 6g，淮山药 30g，蛤蚧 4 条。服 7 剂，神情爽朗。继服 10 剂，同房时已有精液排出，再服 7 剂，性生活如常。(新中医)。

【定经汤治男科疾病功能性勃起障碍】李广涛：

李广涛等用定经汤加减治疗男性功能性勃起障碍90例，对比治疗前后ⅡIEF评分变化，结果治愈20例，显效48例，好转16例，无效6例。总有效率93.3%。本方对于功能性勃起功能障碍及部分器质性勃起功能障碍及老年混合性勃起功能障碍均有较好疗效。(河北中医)。

【定经汤治更年期综合征】辛文华：

更年期综合征陈某，女，48岁。1981年7月5日初诊。近3年来，月经周期不定，潮则漏不止，绵延半月有余，血色淡，头晕目眩，胸闷心烦，夜寐不安，纳食渐减，手足发胀，四肢困倦，腰酸背痛，诊断为“更年期综合征”，屡用中西药均未获效，脉细弦，舌淡苔白。证属肝肾阴虚，脾失健运。治以补益肝肾，健脾和胃。方用定经汤加味：菟丝子、钩藤各15g，杭芍、生地炭、山药、白蒺藜、苡仁各20g，当归、芥穗炭、柴胡、赤石脂各10g，获荃12克，3剂，水煎服。服药3剂，月经已净，后以本方加减调理月余，药证合拍，经绝体安。(陕西中医)

【临证提要】定经汤为治疗“经水先后无定期”之方。后世医家对于定经汤很少有专门探讨，故用之者不如傅青主其他方剂多。但临床实践证明，

定经汤确为“不治之治，正妙于治”的具有实际价值的效方。观傅山创制的定经汤之遗方用药，实为逍遥散去白术、薄荷、生姜、甘草，加菟丝子、熟地黄、山药、荆芥穗而成。自傅氏创制本方以来，主要用治月经先后无定期，数版高等教材《中医妇科学》都将该方选为治疗月经先后无定期肾虚肝郁型之代表方。然而异病可以同治，只要辨为肾虚肝郁、脾虚失运、精亏血虚、气滞湿阻或水瘀互阻，妇科之经、带、胎、产、杂无论何病，皆可用此方加减化裁以治之，甚至内科疾患亦未尝不可。临床多用于月经后期、月经过少、闭经以及不孕症等。因为这类病证大多病情复杂，每每肾肝脾三脏俱病，精、气、血、水数端失调，虚实夹杂，寒热互见，而用本方灵活化裁，因宜变通，每获良效。

第四节 经水数月一行

【原文】：妇人有数月一行经者，每以为常，亦无或先或后之异，亦无或多或少之殊，人莫不以为异，而不知非异也。盖无病之人，气血两不亏损耳。夫气血既不亏损，何以数月而一行经也？妇人之中，亦有天生仙骨者，经水必一季一行。盖以季为数，而不以月为盈虚也。真气内藏，则坎中之真阳不损，倘加以炼形之法，一年之内，便易飞腾。无如世人不知，见经水不应月来，误认为病，妄用药饵，本无病而治之成病，是治反不如其不治也。山闻异人之教，特为阐扬，使世人见此等行经，不必妄行治疗，万勿疑为气血之不足，而轻一试也。虽然天生仙骨之妇人，世固不少。而嗜欲损夭之人，亦复甚多，又不可不立一疗救之方以辅之，方名助仙丹。

助仙丹方：

白茯苓五钱，陈皮五钱，白术三钱（土炒），白芍三钱（酒炒）山药三钱（炒），菟丝子二钱（酒炒）杜仲一钱（炒黑）甘草一钱，

河水煎服。四剂而仍如其旧，不可再服也。

傅山曰：此方平补之中，实有妙理。健脾益肾而不滞，解郁清痰而不泄，不损天然之气血，便是调经之大法，何得用他药以冀通经哉！

【作用与功效】健脾益肾，滋补精血。

【主治适应症】脾肾两虚致月经数月一行。

【方解】方中白术、山药、甘草补脾土以资化源，菟丝子、白芍、杜仲益肾而无滋腻之弊，茯苓、陈皮理气化痰。诸药共奏健脾益肾，解郁清痰，生精益血之功。此方平补之中，实有妙理。健脾益肾而不滞，解郁清痰而不泄，不损天然之气血，便是调经之大法，何得用

他药以冀通经哉！

【助仙丹治闭经月经减少医案】李芬：

张某，女，23 岁。患者服用避孕药 2 年，停药后 2 个月未来月经，症见面色皖白，头晕腰痛，纳呆便溏，脉弦细，舌淡，边有齿痕，苔薄。因恐惧打针要求服用药物治疗，给予妇科调经片口服 1 周未见效果，再次复诊辨证为脾肾不足，气血两虚给予茯苓 15g，陈皮 15g，炒白术 10g（酒炒）白芍 10g，炒山药 10g（酒炒）菟丝子 6g. 焦杜仲 3g，甘草 3g，3 剂河水煎服。服用 1 剂第 2 天来月经。随访 2 个月月经正常，未再复发。(中外妇儿健康)。

【临证提要】盖无病之人，气血两不亏损耳。而嗜欲损天之人. 亦复甚多。生理性的月经数月一行，气血两不亏损，病理性的月经数月一潮，病因病机为精血劳损不能充盈血海。临床上月经稀发、月经量少、闭经等辨证属精血劳损不能充盈血海，可用本方以健脾益肾调经，本方健脾益肾而不滞，解郁清痰而不泄，不损天然之气血。

【用助仙丹加香附、龟板，生鸡内金治好女儿月经数月一行】网文懒兔子漫画中医

女儿 20 岁，从月经初潮起就一直月经不调，好的时候两三月来一次，不好的时候半年来一次，期间也喝中药调理过，没有明显效果。

今年疫情刚好长期在家方便调理，我看她舌苔厚腻，舌胖大，脸上长痘，饮食喜肉，判断为湿气重，血瘀。但因心里没底，再者她嫌我是赤脚医生不敢喝我弄的中药，就用温胆汤、血府逐瘀汤轮流泡脚。可是泡了一段时间，似乎也没什么效果。

之后又带她去找我们这里有名的中医，吃了近一个月的中药还是无效，我们都有些着急了，就想到医院找妇科专家去诊断下。去了医院就被要求做 B 超，检查结果都正常，可子宫膜厚度为 4mm。专家说 4mm 还没有来月经的迹象不太正常，于是建议我们检查雌激素水平。

我问医生，如果检查出雌激素高或低是否就要用激素进行治疗？是否有副作用？医生说肯定要用激素治疗，也肯定会有副作用。我又问是否有别的办法？比如中药治疗？那个专家只冷笑着摇了一下头。我和女儿一致认为不能用激素，于是没有进行下一步检查就回家了。

到家后我还是决定自己找治疗方法，我反复看各名医治疗月经不调的医案，感觉有好多方剂适合女儿，但我没有十足的把握给女儿用。一是她不相信我的医术，名中医都调理不好，更何况我这只菜鸟。二是喝了那多久的中药，她已经不愿意再喝了。

有一天，我突然看到了一则傅青主的助仙丹医案：

(组成)白茯苓五钱，陈皮五钱，白术三钱（土炒）白芍三钱（酒炒）山药三钱，炒菟丝子二钱（酒炒）杜仲一钱，甘草一钱。

【作用与功效】健脾益肾，滋补精血。

【主治适应症】脾肾两虚致月经数月一行。

【方解】方中白术、山药、甘草补脾土以资化源，菟丝子、白芍、杜仲益肾而无滋腻之弊，茯苓、陈皮理气化痰。诸药共奏健脾益肾，解郁清痰，生精益血之功。

我觉得这个方剂太妙了，一定要想办法给女儿一试。因表姐是医生，于是我把这个方剂发过去和她讨论，她也认为可以。借表姐的意见说服了女儿，又因女儿还有肝气不舒、血瘀之证，在原方的基础上加了香附、龟板，生鸡内金。组方：茯苓 15 克，陈皮 15 克，炒白术 9 克，炒白芍 9 克，炒山药 9 克，炒菟丝子 6 克，炒杜仲（炒黑）3 克，甘草 3 克，抓了 5 付。

一付服用 1 天。服用第三天，月经就来了！然后停药。月经期间用四物汤加味 3 剂，经行 7 日而净。经后续服前方十余剂，第二月月经迟来一周。连续两月来月经，那个愉悦的心情只有自己能体会啦。

当时我就想把这个验方写出来让更多的人受益，但想到时间太短，停药后不知道效果如何。于是又等了两个月，结果女儿的月经每个月都准时报道了！我觉得这个方剂治疗月经数月一行疗效确切。

原书中还写："四剂而仍如其旧，不可再服"。就是说，如果吃了四服药月经还没来，就别再吃了。我不懂其中的含义，事实上这个方子用药很普通，正如傅先生自己写的："此方平补之中，实有妙理。健脾益肾而不滞，解郁清痰而不泄，不损天然之气血"。因此我个人觉得完全可以多用几付，以观疗效。供各位参考。事实上文中作者给女儿就是用了十几付，并未有任何不良反应，反而是彻底地把她的月经调整好了。

【助仙丹治多囊卵巢病变月经不不规律医案】黎崇裕：

陈某某，女，22 岁，2016 年 6 月 11 日初诊。经不调 7 年。患者 15 岁月经来潮，之后月经一直不规律，月经时一个月两行或两个月一行，常大小便时下身有血丝，行经期 7 天，月经量多色鲜红，无痛经，经前便秘，行经期大便一日两次偏稀，末次月经 5 月 16 日，上上次月经 3 月 19 日，情绪易紧张，舌体瘦小苔黄白偏干，咽部暗红，脉浮弦细。否认怀孕，外院 B 超检查显示多囊卵巢病变。

定经汤合助仙丹化裁：盐菟丝子 30 熟地黄 15 茯苓 10 荆芥炭 6 北柴胡 6 白芍 15 当归 10 海螵蛸 30 茜草 10 枸杞子 7 炒白术 10 山茱萸 30 续断 20 红枣 10 盐杜仲 15 香附 10。7 剂。2016 年 9 月 20 日因四肢疼痛来诊，述前药后月经每个月正常来潮。

第五节 年老经水复行

【原文】：妇人有年五十外或六、七十岁忽然行经者，或下紫血块、或如红血淋，人或谓老妇行经，是还少之象，谁知是血崩之渐乎！夫妇人至七七之外，天癸已竭，又不服济阴补阳之药，如何能精满化经，一如少妇。然经不宜行而行者，乃肝不藏脾不统之故也，非精过泄而动命门之火，即气郁甚而发龙雷之炎，二火交发，而血乃奔矣，有似行经而实非经也。此等之症，非大补肝脾之气与血，而血安能骤止。方用安老汤。

安老汤方：

人参一两，黄耆一两（生用）大熟地一两（九蒸），白术五钱（土炒），当归五钱（酒洗），山萸五钱（蒸），阿胶一两（蛤粉炒），黑芥穗一钱，甘草一钱，香附五分（酒炒），木耳炭一钱，

水煎服。一剂减，二剂尤减，四剂全减，十剂愈。

傅山曰：此方补益肝脾之气，气足自能生血而摄血。尤妙大补肾水，水足而肝气自舒，肝舒而脾自得养，肝藏之而脾统之，又安有泄漏者，又何虑其血崩哉！

注家曰：加贯仲炭一钱，研细末，以药冲服尤妙。

【作用与功效】补肝肾，益脾气，摄血生血。

【主治适应症】妇人有年五十外或六七十岁忽然行经者，或下紫血块、或如红血淋，即年老经水复行者。

【方解】方中重用人参、黄芪、白术，补无形之元气，固摄将脱之血；熟地、阿胶、当归滋阴液，补已亡之血，使阴血充复，阳气有所依附，浮阳回归，起到养阴维阳之功，山萸肉补肝肾并收敛耗散之精血；木耳炒炭入络退火止血；香附乃血中之气药，能敷经络之气；芥穗炒黑入营止血；甘草调和诸药。

【临证提要】临床运用安老汤加减当归、加柴胡、山药。方中熟地、山药补气血、滋肾水、益真阴；党参、黄芪、白术益气健脾；柴胡、香附疏肝解郁；阿胶珠、木耳炭、炒荆芥、贯众炭养血止血，引血归经；甘草调和诸药。全方谨守病机，对症下药。正如《傅青主女科》所说："尤妙在大补肾水，水足而肝气自舒，肝舒而脾自保养，肝藏之，脾统之，安有泄漏者。"据《景岳全书》记载：当归"气辛而动，故欲其静者当避之"。张山雷《沈氏女科辑要笺正》记载"当归一药，富有脂渔，气味俱厚，向来视为补血要剂…惟其气最雄，走而不守苟其阴不涵阳而为失血，则辛温助阳，实为大禁"。因此，当归虽有补血养血之功，弃而

不用。《医学衷中参西录》上册(一)医方(二十九)治妇科方5固冲汤“子某某在京，又治血崩证，先用固冲汤不效，加柴胡二钱，1剂即愈，足见柴胡升提之力，可为治崩要药”。故临床治崩，多加柴胡一味，效果显著。方中，还加入山药以增强补肾肝脾之功。安老汤一方，傅青主谨守病机，重用主药，如熟地、黄芪、党参重达30g，轻者香附1.5g，炒荆芥3g等。

【安老汤在妇科崩漏病医案】王仁尧：

吴某，28岁，1985年7月11日初诊。患者崩漏20余日，经多方医治未见好转，量多如注，面色苍白无华，四肢无力，腰部酸软，头晕耳鸣，舌淡红苔白，脉细弱按之若无。此属脾肾两亏，冲任不固，治拟补益脾肾，固摄冲任，用安老汤加减：黄芪30g，党参30g，白术15g，生甘草5g，熟地20g，枸杞子10g，荆芥炭10g，木耳炭10g(研吞)，煅牡蛎30g。3剂后经血已止，原方去二炭加升麻5g，当归10g，菟丝子10g。再服5剂，诸证好转而愈的(浙江中医学院学报)。

【安老汤滑胎医案】王仁尧：

石某，28岁，1987年3月16日初诊。诉滑胎已3次，现怀孕4个月余，近日来阴道有少量流血、伴有腹痛，腰酸，头晕，身倦乏力，舌淡边有齿痕，脉虚弱无力。证属脾肾两虚，胎元不固，治拟大补脾肾、固摄胎元：黄芪30g，党参30g，白术30g，熟地30g，淮山药15g，川断15g，山萸肉15g，甘草5g，砂仁5g，荆芥炭10g，贯众炭10g，木耳炭10g(研细分吞)。3剂后阴道流血即止，腰酸腹痛减轻，原方去三炭加菟丝子10g，嘱每月间服10剂，足月分娩。(浙江中医学院学报)。

【安老汤闭经医案】王仁尧：

俞某，37岁。1984年10月22日初诊。患者先表现经期缩短，经量减少，用理气活血辈欲通之，反致月经闭止不行，至今已近1年。自觉身倦无力，四肢发麻，头晕，心惊，目花，舌淡苔薄，脉虚细无力。证属肝肾两虚，气血不足，冲任失养。治拟补脾肾、益气血，养冲任：党参30g，黄芪30g，白术15g.甘草5g，熟地24g，当归15g，阿胶15g，白芍15g，香附10g，郁金10g.*芎6g。20剂后月经来潮，但血量较少。原方加减续服2个月，经期经量均恢复正常。(浙江中医学院学报)。

【安老汤月经先期医案】王仁尧：

丁某，36岁。1985年6月9日初诊。患者开始月经提前5~6天，继而提前10余日，近来半月一行，量多色淡，四肢酸麻，腰背酸痛不耐久立，胃纳尚可，二便无殊，舌质淡，苔薄白，脉细弱。证属脾肾虚亏，冲任不固，用安老汤加减：黄芪30g，党参30g，白术15g，甘草5g，熟地18g，枸杞子12g，阿胶15g，杜仲10g，荆芥炭10g，木耳炭10g(研吞)。3剂后月经即止，原方减去二炭加淮山药、桑寄生，连服15剂，月经恢复正常。(浙江中医学院学报)。

【安老汤在更年期综合征妇科崩漏病医案】王仁尧：

刘某，女，52岁。2006年8月10日初诊。自诉：经来不止20余天，5月份曾出现相同的情况，口服止血西药不止，在我院妇产科做诊断性刮宫，诊为功能性子宫出血，诊刮后两三天经止。刻下患者月经量多、色暗红、有少量血块，无腹痛，头晕乏力、腰酸背困、胸闷、喜出长气、心烦、坐卧不安、每晨醒时烘热汗出、睡眠不实，舌质暗红体胖、边有齿痕、苔白，脉关尺部沉弱略数。辨证属于脾肾两虚，肝郁内扰。予安老汤加减。药物组成：黄芪30g，党参30g，白术15g，熟地30g，山萸15g，当归6g，阿胶15g(烊化)、香附1.5g，木耳炭3g，贯众炭20g，黑芥穗6g，生地炭15g，乌贼骨15g，生龙、牡各20g，炒枣仁20g，夜交藤20g。6剂后，患者月经干净，仍面部阵阵烘热汗出、五心烦热、口干甚、坐卧不安，舌脉同前。上方去贯众炭、木耳炭、乌贼骨，改生地炭为生地，加地骨皮30g，浮小麦30g，麻黄根10g，百合30g，炒栀子6g，豆豉6g。6剂后，患者所有症状基本消失。(山西中医学院学报)。

【安老汤子宫肥大医案】姚淑华：

应用安老汤为主治疗子宫肥大症62例，62例均用安老汤治疗。方药：党参30g，黄芪30g，熟地黄30g，白术15g，当归15g，山茱萸15g，阿胶15g(烊化)，黑芥穗5g，炙甘草5g，香附5g，贯众炭25g，海螵蛸25g，仙鹤草30g，益母草15g，水煎3次，取汁混合为800mL，每次200mL，每日2次。每5剂为1疗程。如腰痛明显加炒杜仲25g，狗脊20g，腹坠明显者加升麻5g、柴胡5g，白带量多加炒苡仁30g、萆薢15g，黄带者加苡仁30g、黄柏10g、车前子20g(包煎)，血止后去黑芥穗炭、海蝶峭，增益母草为30g。效果满意。(长春中医学院学报)。

第六节 经水忽来忽断时疼时止

【原文】：妇人有经水忽来忽断，时疼时止，寒热往来者，人以为血之凝也，谁知是肝气不舒乎！夫肝属木而藏血，最恶风寒。妇人当行经之际，腠理大开，适逢风之吹寒之袭，则肝气为之闭塞，而经水之道路亦随之而俱闭，由是腠理经络，各皆不宣，而寒热之作，由是而起。其气行于阳分则生热，其气行于阴分则生寒，然此犹感之轻者也。倘外感之风寒更甚，则内应之热气益深，往往有热入血室，而变为如狂之症。若但往来寒热，是风寒未甚而热未深耳。治法宜补肝中之血，通其郁而散其风，则病随手而效，所谓治风先治血，血和风自灭，此其一也。方用加味四物汤。

加味四物汤方：

大熟地一两（九蒸），白芍五钱（酒炒）当归五钱（酒洗），川芎三钱（酒洗）白术五钱（土炒），粉丹皮三钱，元胡一钱（酒炒），甘草一钱，柴胡一钱，水煎服。

傅山曰：此方用四物以滋脾胃之阴血；用柴胡、白芍、丹皮以宣肝经之风郁；用甘草，白术，元胡以利腰脐而和腹疼，入於表里之间，通乎经络之内，用之得宜，自奏功如响也。（加荆芥穗（炒黑）一钱，尤妙。）

【作用与功效】养血益气，摄血调经。

【主治适应症】妇人有经水过多，行后复行，面色痿黄，身体倦怠，而困乏愈甚者。

【方解】方中四物乃补血养阴调经，加白术健脾祛湿，益气摄血；黑荆芥引血归经；加山萸、续断益肾调冲任，止中有行；加甘草以调和诸药，诸药合用使血足而归经。

【傅青主加减四物汤的医案】陈秀琴：

胎位不正用加减四物汤治疗80例胎位不正孕妇，其中横位8例，斜位2例，臀位70例，每晚服药1剂，3剂为1疗程，治疗后转正75例，总治愈率为93.75%。(山东中医杂志)。

【临证提要】四物汤在临床上应用广泛，所谓加减四物汤，必有减有加，结合本方主证：妇人有经水过多，行后复行，面色痿黄，身体倦怠，而困乏愈甚。出血量多，临证时可去温性活血之当归，加黄芪、党参补气之品，更加棕榈炭、生地炭、姜炭等炭类以止血。

第七节 经水未来腹先疼

【原文】：妇人有经前腹疼数日，而后经水行者，其经来多是紫黑块，人以为寒极而然也，谁知是热极而火不化乎！夫肝属木，其中有火，舒则通畅，郁则不扬，经欲行而肝不应，则抑拂其气而疼生。然经满则不能内藏，而肝中之郁火焚烧，内逼经出，则其火亦因之而怒泄。其紫黑者，水火两战之象也。其成块者，火煎成形之状也。经失其为经者，正郁火内夺其权耳。治法似宜大泄肝中之火，然泄肝之火，而不解肝之郁，则热之标可去，而热之本未除也，其何能益！方用宣郁通经汤。

宣郁通经汤方：

白芍五钱（酒炒），当归五钱（酒洗），丹皮五钱，山栀子三钱（炒）白芥子二钱，炒研），柴胡一钱，香附一钱（酒炒），川郁金一钱（醋炒）黄芩一钱（酒炒）生甘草一钱，

水煎。连服四剂，下月断不先腹疼而后行经矣。

傅山曰：此方补肝之血，而解肝之郁，利肝之气，而降肝之火，所以奏功之速。

【临证提要】此方主要是治疗肝经郁火，血瘀胞络而致的痛经病。就临床体验来看，痛的时间，有在经前，有在经后，有在行经期中，不必如傅氏所讲，仅在经前疼痛。至于疼痛的性质，也有参考价值，比如胀痛厉害可加台乌、沉香等行气之品，如刺痛明显，可加蒲黄、五灵脂等活血止痛之剂。经来时，可以有紫黑血块，但也可以是淡色的血液。关键问题是月经量少。舌质红，苔或白或黄，口干，口苦，脉数，心烦易怒。

不论是单纯的，或是兼证较复杂的肝经郁火所致的痛经病，只要具备痛经、量少、舌红、口苦、脉数这几个主要症候，都可以使用此方再根据临床上的具体表现，加减出入，就能获得良好的疗效。

此方临床应用甚广：乳腺小叶增生、赤带、继发性不孕、功能性不射精、痤疮、乳泣乳衄、乙肝后胁痛等，临床辨证时注意对病因的问诊，情绪抑郁化火乃是重要病机。

【作用与功效】开郁清热，通经止痛。

【主治适应症】妇人有经前腹疼数日，而后经水行者，其经来多是紫黑块。

【宣郁通经汤方解】方中重用当归、白芍养血柔肝，柴胡与郁金疏肝解郁，畅通血行；制香附透气入营，理气活血止痛，丹皮性寒人血分以清血热，栀子、黄芩和白芥子合用苦寒以清泻里热，佐生甘草清热解毒，并调和诸药。诸药合用，共奏开郁清热化瘀止痛之功，使郁开热退瘀除则痛止。

【宣郁通经汤治疗青春期痛经】张有明

鲍某，16 岁，未婚。1987 年 8 月诊。月经初潮 13 岁，经前腹痛持续 3 年余，每于经前二天感小腹部疼痛，以胀痛为主，时有针刺样剧痛，疼痛剧烈时，有紫色血块，且有块下痛减之感，疼痛可持续 1~2 天。刻下经前腹痛又作，经稠色紫有块，块下后疼痛减轻，舌红微紫，苔薄黄、脉弦紧。中医辨证属瘀热内阻，气机不畅型痛经。拟宣郁通经汤化裁。柴胡、郁金、丹皮、黄芩、五灵脂、赤白芍各 10g，制香附 15g，甘草、白芥子各 6g，三七粉 3g(冲服)。服 3 剂后，疼痛明显缓解，月经块少且经流通畅。其后嘱患者按月经周期前五天服药 5 剂，调治 3 个月，腹痛渐轻，直至消除。1 年后追访，月经按时来潮，经量、经色均属正常，经前腹痛未作，经期血块消除。（四川中医）

【宣郁通经汤治疗经前腹痛伴双侧乳腺疼痛乳腺小叶增生症】崔万胜：

呼某，女，42 岁。1998 年 6 月 4 日初诊。患者经前腹痛，伴双侧乳腺疼痛 2 年。每次疼痛随经期而起落，乳腺渐增大而不能消退，疼痛呈持续性。查：双侧乳腺可扪及条索状大小不等的多个片块状肿物，活动性良好，正值经期，仍伴有痛经，口干、口苦，经色呈紫褐色，有瘀血块，舌红、尖有瘀斑、瘀点、苔薄黄。诊为乳癖，肝经郁滞型，拟方宜郁通经汤加味：当归 15g，丹皮 15g，栀子 10g，醋柴胡 6g，香附 3g，黄芩 9g，甘草 3g，白芥子 6g，夏枯草 20g，川楝子 15g。7 剂，每日 1 剂，水煎服，服后用药渣外敷乳腺疼痛处。6 月 12 日二诊，患者经期已过，下腹痛消失，乳腺疼痛也明显减轻，乳腺内条索状物变小，原方加牡蛎、丹参、淫羊藿。继服 30 剂，诸症消失，乳腺增生消退。随访 1 年未发。(山西中医)。

【宣郁通经汤治赤带】高仰秀：

患者，女，22 岁，学生。2005 年 10 月 21 日初诊。2 年来，患者月经间期出现白带色红，淋沥不断 7~8 天，伴腹痛、腹胀、食欲差，若食多，则易消化不良，经血有黑血块。曾用消炎止血药，效不佳。患者平素心重，每遇学习压力大或心情不愉快时症状加重。查：舌尖略

红，苔薄黄，脉弦滑。此为肝郁化火，脾失健运，湿热下注所致。药用：当归 30g，白芍 30g，香附 9g，郁金 9g，牡丹皮 9g，栀子 9g，黄柏 9g，白芥子 9g，柴胡 6g，甘草 3g。每日 1 剂，水煎服。3 剂后，赤带量少，色淡，腹痛减轻。守方继服 5 剂，赤带愈，腹不痛，饮食精神转佳，4 天后月经来潮，血块明显减少。2 个月后随访，未再有赤带出现。（中国中医药信息杂志）

【宣郁通经汤治功能性不射精】王立华

宣郁通经汤 4. 张某，男，41 岁，干部。1991 年 8 月 24 日初诊。1 个月来左少腹不适，隐隐胀痛，行房事不射精，小便稍黄，大便正常，食欲尚好，别无不适，经某医院检查，诊断为功能性不射精。舌质正常，舌苔薄黄，脉象弦细略数，此系肝郁化热，失于疏泄，宜疏肝活络之法，宣郁通经汤加味治之，处方：柴胡 6g，归尾 9g，白芍 15g，郁金 15g，香附 10g，栀子 9g，丹皮 10g，白芥子 5g，川楝子 9g，甘草 6g。水煎服，6 剂。二诊：药后左少腹觉舒，胀痛已除，行房事已达高潮，但欲泄不泄。舌苔正常，脉象仍弦，守原方加石菖蒲 12g，再服 6 剂。三诊：服药 4 剂，射精正常，其他症状亦除。(山西中医)

【宣郁通经汤阴道炎】赵淑媛：

乔某，女，42 岁。1988 年 9 月 22. 日初诊。诉前阴痛痒 1 年余，1987 年 11 月在当地医院诊断为“阴道炎”。内服外用多种中西药均少效。遂来我科就诊，患者面红目赤、心烦易怒、口苦咽干、胸闷食少、外阴及阴道痛痒而坐卧不宁、带下量多、色黄而多秽，月经按期而至，惟经期少腹胀满、经量少、色暗淡、脉弦细。证属肝经郁热、脾虚湿热下注。当疏肝泄热、健脾燥湿、杀虫止痒。以宣郁通经汤加味：丹皮、木通、黄芩、茯苓、郁金、柴胡各 10g，白芥子、龙胆草、栀子、甘草各 8g，当归、白芍各 20g，香附、苍术各 15g，3 剂，外用苦参、土茯苓、黄柏各 45g，煎汤熏洗。上方连用 6 剂，阴道痛痒大减，带下量亦少，效不更方，再予 8 剂，诸症皆失。(陕西中医)

【宣郁通经汤慢性附伴炎】赵淑媛：

沈某，女，32 岁，电工。1988 年 12 月 6 日诊。诉患慢性附件炎已 4 年曾用青、链霉素、庆大霉素、胎盘组织液，效均不佳。今来我科就诊，证见下腹坠胀疼痛、腰骶部酸困、多于劳累或生气后加重。伴心烦少寐、白带多、月经不调，舌紫暗、苔白腻、脉弦细。证属肝经郁热、气滞血瘀。治以疏肝泄热、理气行血。宣郁通经汤加减：白芍、香附、川芎、柴胡、当归、党参各 12g，郁金、栀子、丹皮各 10g，木香、玄胡索各 6g，丹参、佛手各 15g。服药 5 剂，诸症减半。药中病机，守方继进，前后进药 20 余剂，4 年沉疴豁然若失。(陕西中医)。

【宣郁通经汤治疗子宫肌瘤】李淑华：

王某某，女，41，岁，工人。1990 年 5 月初诊。患者主诉：1 年多来，月经提前，经量亦多，经前及经期少腹疼痛，近日在 264 医院和山西省人民医院 B 超，确诊为“多发性子宫肌瘤”，建议手术。因患者暂不愿手术，想以中药试试，故而求我诊治。

查患者少腹柔软，未触及包块，舌质略红，舌侧有瘀斑，苔薄黄，脉弦数；饮食、睡眠、大小便均正常。询问患者，近几年家庭经济困难，工作亦不遂心。辨证：肝气郁结，郁而化火；气滞则血瘀，火盛则煎熬津液为痰，痰瘀互结，郁阻胞宫，不通则痛；火盛则迫使月经先期而量多，诸症之所由也。

治法：疏肝解郁、清火化痰，养血活血化瘀。处方：白芍 15g，当归 15g，丹皮 10g，栀子 15g，黄芩 15g，柴胡 10g，香附 10g，郁金 10g，白芥子 10g，甘草 6g。水煎服，7 剂，早晚服。

二诊：药后无任何不适，经后已 22 天，月经未来(前有时 20 天即来)，舌脉同前。原方继服 7 剂。

三诊：药后经期比上次错后 5 天，基本接近正常，经前、经期少腹疼痛有所减轻，舌脉同前。上方加夏枯草 30g，生薏仁 30g，10 剂，隔日 1 剂。四诊：上月月经周期正常，月经

量也不多，腹亦未痛，脉已不数，舌质舌苔均趋正常。病已见效，效不更方，穷寇宜追，击鼓再进。上方继服10剂，仍隔日1剂。五诊：临床症状全部消失。嘱患者以上方为丸，每丸三钱重，每日早晚各服2丸连用2个月，以巩固疗效。并嘱2个月后，再B超检查。3个月后，患者面露欣喜之色，特前来告我：B超未见到肿瘤，病愈。(中医药研究)。

【宣郁通经汤治愈输卵管不通继发性不孕症】沈开金：

张某，30岁，1995年10月6日诊。结婚8年，婚后次年怀孕2个半月不慎流产，当时因流血多日不净而行清宫术。之后月经不调，量多，经期少腹两侧痛，有血块，色紫黑，口渴，平时白带发黄，脉弦数。曾作输卵管通液2次，左侧不通，右侧通而欠畅。中西药迭进数年未奏效。用基本方(丹皮、黄芩、柴胡、生地、郁金各10g，川芎6g，赤、白芍、香附、白芥子各12g，丹参、益母草各15g)加制没药6g，五灵脂、蒲黄、王不留行各10g。每次月经来潮时服5剂。平时服当归丸、逍遥丸，早晚各服12粒。连用3个月经周期，先是腹痛血块消除，月经准时，后口渴、黄带消失，经色转红，于第4个月，经水未转，停经5旬来诊，其脉滑匀，微有恶心感，尿胶乳试验(+)，后足月顺产1女婴，母女平安。（甘肃中医）

【宣郁通经汤加减治疗痤疮】李润生：

宣郁通经汤9.痤疮遂某，女，23岁。2007年7月9日初诊。颜面粉刺时轻时重6个月余，加重数日。患者于6个月前因工作不顺遂逐渐出现颜面粉刺，时轻时重。曾就诊于多家诊所及皮肤专科门诊，多施以痤疮膏之类外用药，中药亦多属清利湿热兼托表之剂，效不著。数日前患者症状加重且伴少腹隐痛。

刻诊：精神抑郁，颜面粉刺呈不均匀分布，红白相间，小如黄米，大如小豆，经期将至，少腹隐痛，舌质淡红，苔薄略黄，脉弦。经前经期腹痛6个月余，经行时有血块。查尿常规及子宫附件B超均未见异常。中医诊断：颜面粉刺伴痛经。治宜疏肝理气，行气止痛佐托表。方用傅青主宣郁通经汤加味。药物组成：白芍药10g，当归10g，牡丹皮6g，白芥子10g，醋柴胡10g，香附10g，郁金10g，栀子6g，黄芩6g，甘草6g，浮萍10g。3剂。日1剂，水煎取汁300mL，分早晚2次温服。

2007年7月12日二诊：精神好转，痤疮、少腹痛较前明显减轻。正值月经来潮，经行伴血块，舌质黯红少苔，脉弦涩。治以行气活血为主，故以上方去白芍药、黄芩，加赤芍药10g、桃仁10g、红花10g，以增强活血化瘀之功，予4剂，服法同前。2007年7月16日三诊：少腹痛消失，颜面粉刺殆尽。月经已净，舌质淡红少苔，脉细数。经后当以固冲任为主。方以宣郁通经汤去柴胡、香附、黄芩，加阿胶10g(烊化)、山药10g、山茱萸10g，服法同前。并嘱患者每次月经周期按上述3组处方服药，连服3个月。1年后追访粉刺及痛经未复发。（河北中医）

【宣郁通经汤加减治疗乙型肝炎后胁痛】侯公明：

宣郁通经汤10.乙型肝炎后胁痛刘，女，31岁。1985年7月5日诊。患者1984年2月患“乙型肝炎”，治疗10个月，肝功能恢复正常，HBsAg阴性，但右胁经常出现隐痛或刺痛，夜间为甚。服芸芝肝泰及益气疏肝药，效果不明显。近月来胁痛繁，胀痛或刺痛，心烦易怒，口干纳差，少寐，舌尖红、苔薄白，脉弦。证属肝郁气滞，瘀血内阻，余毒未尽，予宣郁通经汤加减：柴胡10g，香附10g，川楝子10g，郁金15g，丹参15g，白芍20g，当归10g，生地黄12g，栀子10g，神曲10g，板蓝根12g，甘草6g。服药20剂，自觉症状消失，复查肝功能正常，HBsAg阴性，随访1年未曾复发。(湖南中医学院学报)。

【宣郁通经汤治乳房溢奶医案】孙广建：

宣郁通经汤11.乳泣李某，女，24岁，已婚。因左乳头外溢清稀乳汁于1986年9月2日就诊。自述初孕月余，几天前因家务事生气，继之左侧乳房开始胀痛，

日甚一日，2天来左乳头自行外溢清稀乳汁，淋沥不断。患者平素精神抑郁，胸闷嗳气，烦躁易怒，头晕头胀口苦等。查患者两乳头着色，乳房丰满，未扪及结节及包块，舌红、苔

薄黄，脉弦数。此为肝郁化热，火热内迫，乳汁外溢。治以清泻肝火，兼以理气解郁，方用宣郁通经汤加减：龙胆草 6g，当归、柴胡、丹皮、栀子各 9g，白芍 10g，生牡蛎 30g，黄芩、香附各 12g，蒲公英 15g，甘草 6g。水煎服，每日 1 剂，连服 3 剂而愈。1 个月后因生气复发，仍用原方 3 剂而愈。(陕西中医)。

【宣郁通经汤治乳泣乳房溢血医案】孙广建：

刘某，女，41 岁。1989 年 4 月 8 日初诊。患者 5 天来发现右胸衬衣上有血迹，随即解衣，见血自右乳头流出，色鲜红，量较多，间断发作。问其病因始得，半年前其女夭折，致此精神抑郁，胸闷，喜叹息。近日性情急躁，易动好气，自感头晕胀痛，失眠多梦，头面有烘热感，口干苦，两侧乳房胀痛等。查患者右乳房可扪及如核桃大硬块，质不硬，活动压之诉痛，舌边尖红、苔黄脉弦数。此因肝郁化火，肝火逆气，郁于中部，迫血妄行而作乳衄。

治以清泻肝火，凉血止血，方用宣郁通经汤加减：龙胆草、黄芩、丹皮、香附、白芥子各 10g，当归、白芍、栀子、郁金各 9g，仙鹤草、茜草、小蓟各 15g，柴胡、甘草各 6g。3 剂，水煎服。二诊，自述服药后乳头已不出血，仅挤压时有血珠溢出，仍用上方加夏枯草、生龙牡各 25g，再进 5 剂，乳部肿块缩小如杏仁大，诸证消失。(陕西中医)。

【宣郁通经汤治疗暴盲】张萍：

暴盲(急性视神经乳头炎)王某，女，22 岁，工人，1988 年 10 月 6 日初诊。自诉半月前做人工流产出血较多，回家后又与家人生气争吵，遂感右眼内胀痛，视物模糊。翌日视物不见，诊断为“急性视神经乳头炎(右)”。用青霉素及泼尼松等药治疗 10 余天罔效而来诊。查视力左眼 1.5，右眼 0.05。外观患眼正常，眼底：右视乳头充血水肿，边缘模糊，生理凹陷消失，视网膜静脉怒张弯曲，黄斑中心凹光反射不清。伴面色艾白，头晕体倦，胸胁胀痛，烦躁欲哭，舌质淡红，苔白润，脉弦细。

诊为暴盲(右眼急性视神经乳头炎)。证属气血亏虚，肝郁气结，治宜益气养血，疏肝解郁，方用宣郁通经汤加减：黄芪 25g，炙甘草 9g，柴胡 12g，当归 10g，白芍 15g，郁金 12g，香附 10g，白芥子 10g，茯苓 15g，阿胶 10g(烊化)，炮姜 15g，人参 6g(另炖)。服药 6 剂后，右眼视力增至 0.4，视乳头充血水肿减轻，生理凹陷可见。上方加人泽兰、红花各 15g，继服 30 剂。复查：右眼视力 0.8，眼底视乳头充血水肿消失，边缘清晰，黄斑反光点恢复，视网膜静脉略充盈。嘱病人停药，多食用动物肝脏，避免过劳。随访 1 年未见复发。(广西中医药)。

【临证提要】此方主要是治疗肝经郁火，血瘀胞络而致的痛经病。就临床体验来看，痛的时间，有在经前，有在经后，有在行经期中，不必如傅氏所讲，仅在经前疼痛。至于疼痛的性质，也有参考价值，比如胀痛厉害可加台乌、沉香等行气之品，如刺痛明显，可加蒲黄、五灵脂等活血止痛之剂。经来时，可以有紫黑血块，但也可以是淡色的血液。关键问题是月经量少。舌质红，苔或白或黄，口干，口苦，脉数，心烦易怒。

不论是单纯的，或是兼证较复杂的肝经郁火所致的痛经病，只要具备痛经、量少、舌红、口苦、脉数这几个主要症候，都可以使用此方再根据临床上的具体表现，加减出入，就能获得良好的疗效。

此方临床应用甚广：乳腺小叶增生、赤带、继发性不孕、功能性不射精、痤疮、乳泣乳衄、乙肝后胁痛等，临床辨证时注意对病因的问诊，情绪抑郁化火乃是重要病机。

第八节 行经后少腹疼痛

【原文】：妇人有少腹疼于行经之后者，人以为气血之虚也，谁知是肾气之涸乎！夫经水者，乃天一之真水也，满则溢而虚则闭，亦其常耳，何以虚能作疼哉？盖肾水一虚则水不能生木，而肝木必克，脾土，木土相争，则气必逆，故尔作疼。治法必须以舒肝气为主，而益之以补肾之味，则水足而肝气益安，肝气安而逆气自顺，又何疼痛之有哉！方用调肝汤。

调肝汤方：

山药五钱（炒），阿胶三钱（白面炒），当归三钱（酒洗），白芍三钱（酒炒），山萸肉三钱（蒸熟），巴戟一钱（盐水浸），甘草一钱，

水煎服。此方平调肝气，既能转逆气，又善止郁疼。

傅山曰：经后之症，以此方调理最佳。不特治经后腹疼之症也。

注家曰：经前经后腹痛二方极妙，不可加减。若有别症亦宜此方为主，另加药味治之。原方不可减去一味。）

【临证提要】调肝汤虽专为行经后少腹疼痛而设，用于肝肾亏虚，精血暗耗，精亏血少，冲任失濡，血海空虚而导致的痛经。有调补肝肾，养血缓痛之功效。而目前诸多医家对此方广泛应用，用此方治疗闭经、崩漏、经行乳房胀痛、阴痒等疾病，效果也满意。

【作用与功效】滋补肝肾，调经止痛。

【主治适应症】妇人有少腹疼于行经之后属肾精亏虚者。

【方解】方中山药、山萸肉、巴戟补肾中之精，阿胶滋阴以生肾水，当归活血止痛，白芍柔肝止痛，甘草缓急止痛，共奏补肾水以泄肝中之火，水足而肝气得安，肝气得安则脾气和之功，故肝肾得滋，精血充沛，冲任得养，疼痛得止。

【调肝汤痛经医案】周惠芳：

章某，女，34 岁，诉近 3 个月来，每次月经将净时，小腹绵绵作痛，直至经净 1 周方止，经量偏多，色红夹块，5 日自净。腹痛时纳谷不香，大便溏薄，日行 1~2 次，舌淡边尖红，脉细弦。当时考虑为经后气血亏虚，脾运不健，故予八珍汤合参苓白术散加减 7 剂。1 个月后患者来复诊，又值经净 1 天，腹痛又作，诸症如前。诉上次服药后，纳谷有增，大便已实，但腹痛未减。予做妇科检查及盆腔 B 超，均未发现异常。细问其因及伴随症状：近几月来，工作压力大，情志不畅，经前 1 周起两乳作胀，心烦易怒，经行后两乳仍微胀不适，至经净 10 余天方消。想起《女科》经后腹痛调肝汤主之，予淮山药 10g. 阿胶珠 10g，山萸肉 10g，制黄精 10g，炒当归 10g，炒白芍 20g，醋柴胡 6g，炒白术 10g，云茯苓 10g，巴戟天 10g，共 7 剂，并嘱服完后要复诊。1 周后患者复诊时诉：服药 3 剂后腹痛已止，乳胀也消，大便渐实，纳谷有增。(辽宁中医杂志)

【调肝汤闭经医案】王艳：

刘某，女，32 岁，工人，已婚。患者孕 2 产 1.17 岁初潮，平日多后期而至，量少色淡，质稀，末次月经 2004 年 6 月。于 2005 年 4 月足月顺产 1 胎，产时出血量多，出院后阴道不规则出血 50 天，经门诊中西药止血治疗近 1 周，阴道仍有少量出血，时有时无。此后患者经常出现头晕耳鸣，腰膝酸软，1 年来未经治疗。2006 年 11 月 10 日就诊，月经 1 年余未见来潮，伴见形体消瘦，面色失华，头晕乏力，耳鸣，失眠，五心烦热，易燥，阴毛、腋毛稀少，舌红少苔，脉弦细。妇科检查：外阴轻度萎缩，颜色较暗，阴道干涩无分泌物，子宫偏小，子宫附件处无包块。诊断：闭经；证属：肝肾阴虚，冲任失调。治疗：益肾柔肝，调理冲任。方药：调肝汤加减。山萸肉 9g，山药 15g，阿胶 9g，当归 9g，白芍 9g，巴戟 3g，菟丝子 9g，龟板 10g，川牛膝 9g。水煎服，2 剂/天。15 剂后自觉症状明显改善，月经来潮量少，色淡红，效不更方，继用前方 10 余剂，巩固疗效。(陕西中医学院学报)。

【调肝汤崩漏医案】王艳：

靳某，女，37 岁，职员，已婚。平日月经正常，近 1 年来，月经量多，经期延长，周期 23 天，经期持续 7~10 天，经色暗红，有血块，本次月经持续 20 天未净，量多，色暗红，质黏稠有块，伴腰膝酸软，心烦易怒，彻夜未眠，舌暗，脉弦细。妇科检查：外阴已婚已产式；阴道有暗红色血性分泌物，宫颈肥大，充血，光滑；宫体后位，表面光滑，活动欠佳。诊断：崩漏；证属：肝血不足，肾精亏损，冲任不固。治以调养肝肾，化瘀补阴，固冲止崩。方药：调肝汤加减。山萸肉 9g，山药 15g，阿胶 10g，当归 9g，白芍 9g，巴戟 3g，血余炭 10g，仙

鹤草、三七粉各 9g。水煎服，2 剂/天。3 剂后流血止，诸症减轻。上方去仙鹤草，血余炭，加黄柏 3g，车前子 6g，芥穗 9g。水煎服，2 次/天，继续调理 2 个周期，随访 3 个月，月经恢复正常。(陕西中医学院学报)

【调肝汤经行乳房胀痛医案】王艳：

桂某，女，42 岁，无职业，已婚。以“月经来潮时乳房疼痛 3 年，加重 1 个月”之主诉人院。患者平素急躁易怒，偶有乳房胀痛，每于月经来潮时疼痛明显加重，伴见腰膝酸痛，咽干口燥，两目干涩，舌红少苔，脉细数。妇科检查：乳房未触及明显包块，触时有轻微疼痛。诊断：经行乳房胀痛，证属肝肾阴虚，乳络失养，经脉郁滞。方药：调肝汤加减合柴胡疏肝散。山萸肉 10g，山药 6g，阿胶 8g，当归 10g，白芍 9g，甘草 3g，香附 10g，陈皮 9g，川芎 9g，生地 10g，白术 10g，柴胡 15g。水煎服，2 剂/天。上方 3 剂后，患者自觉疼痛减轻，继服 10 剂巩固疗效。(陕西中医学院学报)。

【调肝汤阴痒医案】王艳：

庞某，女，43 岁，农民，已婚。患者孕 4 产 2，平日急躁易怒，偶尔头晕目眩，耳鸣口干，自从 2004 年 11 月以后，自感症状加重，且阴户有灼热痒痛感，曾先后在诊所口服消炎药，并外用洁尔阴等洗剂，其痒痛仍未缓解，特来我院就诊。刻诊：患者自感烘热汗出，口干耳鸣，腰脊酸楚，阴部灼热痒痛，下腹坠胀，舌略红，苔少，脉细数。妇科检查：外阴皮肤萎缩干涩，发红，有抓痕、白带较多，呈淡黄色；阴道黏膜充血，伴散在点状出血灶。诊断：阴痒；证属：肝肾亏损；方用调肝汤加减。山萸肉 9g，山药 15g，甘草 3g，巴戟 3g，阿胶 9g，当归 9g，白芍 9g，知母 9g，黄柏 9g，黄芩 9g。水煎服，2 剂/天。服 6 剂后，症状明显好转，上方继服 5 剂，后嘱服六味地黄丸以巩固疗效。(陕西中医学院学报)

【小建中加柴芩治痛经医案】

顾右，十月二十六日，产后月事每四十日一行，饭后则心下胀痛，日来行经，腹及少腹俱痛，痛必大下，下后忽然中止，或至明日午后再痛，痛则经水又来，又中止，至明日却又来又去。两脉俱弦。此为肝胆乘脾脏之虚，宜小建中加柴、芩。桂枝三钱，生白芍五钱，炙草二钱，软柴胡三钱，酒芩一钱，台乌药钱半，生姜五片，红枣十二枚，饴糖三两。拙巢注：一剂痛止，经停，病家因连服二剂，痊愈。按：余初疑本证当用温经汤加楂、曲之属，而吴兄凝轩则力赞本方之得。师曰：大论云：“伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，若不差者，小柴胡汤主之。”我今不待其不差，先其时加柴、芩以治之，不亦可乎？况妇人经水之病，多属柴胡主治，尔侪察诸云云。翌日据报，病向愈矣。《经方实验录》

第九节 经前腹疼吐血（倒经）

【原文】：妇人有经未行之前一二日忽然腹疼而吐血，人以为火热之极也，谁知是肝气之逆乎！夫肝之性最急，宜顶而不宜逆，顺则气安，逆则气动；血随气为行止，气安则血安，气动则血动，亦勿怪其然也。或谓经逆在肾不肝，何以随血妄行，竟至从口上出也，是肝不藏血之故乎？抑肾不纳气而然乎？殊不知少阴之火急如奔马，得肝火直冲而上，其势最捷，反经而为血，亦至便也，正不必肝不藏血，始成吐血之症，但此等吐血与各经之吐血有不同者。盖各经之吐血，由内伤而成，经逆而吐血，乃内溢而激之使然也，其症有绝异，而其气逆则一也。治法似宜平肝以顺气，而不必益精以补肾矣。虽然，经逆而吐血，虽不大损夫血，而反复颠倒，未免太伤肾气，必须於补肾之中，用顺气之法始为得当。方用顺经汤。

顺经汤方：

当归五钱（酒洗），大熟地五钱（九蒸），白芍二钱（酒炒），丹皮五钱，白茯苓三钱，沙参三钱，黑芥穗三钱，

水煎服。一剂而吐血止，二剂而经顺，十剂不再发。

傅山曰：此方於补肾调经之中，而用引血归经之品，是和血之法，实寓顺气之法也。肝不逆而肾气自顺，肾气既顺，又何经逆之有哉！

注家曰：妇人年壮吐血往往有之，不可作劳症治。若认为劳症，必至肝气愈逆，非劳反成劳矣。方加莆草一钱，怀牛膝八分尤妙。）

罗按：这是倒经的治则。倒经，指经血上逆，是正常经血运动路受阻，经血无从出，故寻奇道，或从口鼻，或从耳目。单南山《胎产证治录》：“有行经期只吐血、衄血或眼耳出血者，是谓倒经。”倒经概念：月经期，在子宫以外部位如鼻粘膜、胃、肠、肺、乳腺等部位发生出血，称为倒经，亦称“代偿性月经”、“周期性子宫外出血”。此时，月经量少，甚至无月经，鼻衄或吐血量可多可少。常伴有全身不适、精神不畅、烦躁不安、下腹部胀痛等症状。

【作用与功效】补水制火，养血调肝。

【主治适应症】妇人有经未行之前一二日忽然腹疼而吐血者。

【方解】方中用丹皮、白芍泻厥阴肝经之火，敛肝阴柔木性；配熟地滋肾水以济火；沙参甘寒清肺热祛痰火，又能降逆安中，同白芍为平肝清肺要药，成酸甘化阴之妙；当归补养耗损之血，又能活血行经；茯苓安宁初耗之神；芥穗炒黑能入血络，以清火安血。

【傅青主顺经汤治经前鼻血】李成芳：

郑某，女，15 岁，1996 年 4 月 14 日初诊。该患者 13 岁初潮，月经周期不规则，月经量或多或少，有少量血块，伴有轻微腹痛，性格内向。于 1995 年 11 月月经期前，鼻口出血，每天多次，且出血较多，月经量少，同时兼见头痛、口干、口苦、口渴等症。月经过后，口鼻血止，诸症全无。此后，每逢月经期均见上述症状，历时半年之久而来我院门诊就医。查：颜面潮红，舌质红，舌苔微黄而干，脉见弦滑。脉症合参，证属逆经，予以清热凉血，引血下行，佐以疏肝清肝。方用顺经汤加味：生地 10g，白芍 15g，丹皮 10g，牛膝 15g。头痛加栀子 10g，天麻 7.5g，黄芩 15g；口干苦渴加龙胆草 10g，柴胡 10g，沙参 10g。3 剂，水煎服，凉服，忌食辛辣之品。以后每月经期服用 3 剂。半年后，诸症消失，随访至今未复发。(吉林中医药)。

【傅青主顺经汤治经前咳嗽咯血】付海根：

吴某，女，34 岁，干部。1993 年 9 月 30 日初诊，自诉：每次月经来潮之前或行经之中，即喉痒，咳嗽，咯血已几年，延医多处，疗效不显。本月经期将至，又出现咳嗽，咯血色红量多，伴心烦，胁胀，口干舌苦，急躁易怒，便干尿赤。经胸部 X 光摄片提示：两肺未见实质性病变。脉弦数，舌质红，苔薄黄。证乃肝火上逆，肝血上行所致。治宜平肝顺气，引血下行，方用顺经汤加味：柴胡 9g，郁金 10g，山枝 10g，牡丹皮 10g，生地 15g，沙参 15g，当归 10g，白芍 10g，荆芥炭 10g，牛膝 15g。3 剂，服法：每日 1 剂，水煎服。复诊：患者感咳嗽减轻，咯血量少，月经来潮，色红，量少，再诊时，咯血停止，诸证消失，月经基本干净。嘱其在每届月事来潮咯血未出现之前，即煎服上方，每日 1 剂，连服 5~6 剂，连续 3 个月，月经按期，未见咯血，随访半年未再发。（湖南中医药导报）。

【傅青主顺经汤治更年期综合征】杨再山：

赵某，47 岁，教授。1992 年 4 月 18 日初诊。患者 2 年前月经开始紊乱，1 年前绝经，现头晕，耳鸣，精神抑郁，虚烦难寐，周身汗出。经某医院确诊为更年期综合征。服用更年康和其他西药疗效不显。刻诊：面色萎黄，烘热汗出，头晕耳鸣，精神忧郁，虚烦难寐，睡中易惊，体倦乏力，舌红，苔微黄腻，脉弦细。辨证为肝郁肾虚，枢机不利。治宜和肝调气，滋补肝肾。予顺经汤加减：当归 15g，牡丹皮 10g，生地黄 30g，炒白芍药 15g，沙参 10g，石斛 30g，郁金 10g，黄芩 10g，五味子 6g，龙齿 20g，竹茹 10g。服药 6 剂，自觉精神转佳，烘热汗出减少。夜能人睡，但仍虚烦懊侬，口干微苦。辨证为郁久化火，火扰心神。前方加

栀子 10g，继服 6 剂，诸症大减。又守方 10 剂，再配合七宝美髯丹早、晚各 1 丸口服，并结合精神疗法治疗，病告痊愈。随访 10 个月未见复发。(河北中医)。

【傅青主顺经汤治治疗经期球结膜下出血】张春华：

李某，女，40 岁，2001 年 10 月 8 日初诊。自诉于 2001 年 3 月开始，每逢经期双眼球结膜下出血，曾服用维生素 C0.2g，3 次/天，维生素 B，10mg，3 次/天，润舒眼药水滴眼 3 次/天，均无效。检查：视力右 5.0，左 5.0，双眼球结膜下大片出血，色鲜红，角膜清亮，前房清，瞳孔正常。诊见：头晕眼花、心烦潮热，咽干口渴，经期量少，舌红少津，脉细数。证属素体阴虚血热，加之经期冲气旺盛，气火上逆，迫血妄行，血不顺经，上冲于目。治宜养阴清热，引血下行。方选《傅青主女科》顺经汤加味：当归 10g，生地 10g，沙参 10g，白芍 10g，茯苓 10g，荆芥 10g(炒黑)，牡丹皮 10g，牛膝 10g，栀子 8g，枸杞子 10g。下次月经前 7 天开始服药，每日 1 剂，水煎温服，共服 5.天。药后经期未见球结膜下出血，随访 1 年未复发。(吉林中医药)

【临证提要】此方临床上多用于逆经证属肝气上逆甚则化火者。肝郁者加川楝、郁金以疏肝解郁；血热者加地榆、茜草、黄芩以清血中之热而止血；瘀血者加丹参、桃仁以化瘀；肝肾阴虚者加枸杞、女贞子以养阴；阴虚火旺者加地骨皮、知母、沙参以清虚热；气逆甚者加苏子、代赭石以调气降逆。本病病程较长，一般需调治 2~3 个月经周期，才能巩固疗效。并嘱患者少吃刺激性食物，力戒念怒。

第十节 经水将来脐下先疼痛

【原文】：妇人有经水将来三五日前而脐下作疼，状如刀刺者；或寒热交作，所下如黑豆汁，人莫不以为血热之极，谁知是下焦寒湿相争之故乎！夫寒湿乃邪气也。妇人有冲任之脉，居于下焦。冲为血海，任主胞胎，为血室，均喜正气相通，最恶邪气相犯。经水由二经而外出，而寒湿满二经而内乱，两相争而作疼痛，邪愈盛而正气日衰。寒气生浊，而下如豆汁之黑者，见北方寒水之象也。治法利其湿而温其寒，使冲任无邪气之乱，脐下自无疼痛之疚矣。方用温脐化湿汤。

温脐化湿汤方：
白术一两（土炒），白茯苓三钱，山药五钱（炒），巴戟肉五钱（盐水浸），扁豆（炒，捣）三钱，白果（十枚，捣碎），建莲子三十枚（不去心）
水煎服。然必须经未来前十日服之。四剂而邪气去，经水调，兼可种子。

傅山曰：此方君白术以利腰脐之气；用巴戟、白果以通任脉；扁豆、山药、莲子以卫冲脉，所以寒湿扫除而经水自调，可受妊矣。倘疑腹疼为热疾，妄用寒凉，则冲任虚冷，血海变为冰海，血室反成冰室，无论难於生育，而疼痛之止，又安有日哉！

注家曰：冲任之气宜通不宜降，故化湿不用苍术，薏仁。馀宜类参。）

【临证提要】此方临床上多应用于痛经及继发性不孕症，其疗效满意，临证时经量多者加仙鹤草、茜根、益母草；经前乳房胀痛者加柴胡、白芍、橘核、川楝子；经来腰痛加杜仲；经行头痛时加蔓荆子、白芷、菊花；有瘀块加桃仁、红花、牛膝。如寒湿明显用此方效不佳，可采用《妇人大全良方》中的温经汤(当归、川芎、白芍、莪术、牛膝、丹皮、人参、桂心、甘草)加减。

【作用与功效】利湿散寒，温通经脉。

【主治适应症】妇人有经水将来三五日前而脐下作疼，状如刀刺者；或寒热交作，所下如黑豆汁。

【方解】方中白术以利腰脐之气，佐以巴戟、白果以通任脉，扁豆、山药、莲子以卫冲

脉，综合药方，利湿而温散其寒，调理冲任之脉，月经自然调理正常。

【傅青主温脐化湿汤痛经医案】曲春玲：

王某，女，23 岁。2002 年 9 月 12 日初诊。行经腹痛，月经量少 2 个月。患者平素月经正常 13 岁初潮，周期 4~5 注家曰：8~30 天，经时无不适感。3 个月前外出旅游时正值经期，曾下水游泳，当时未有不适。近 2 个月来经时出现小腹疼痛，月经量少色黑。现月经第 2 天，舌苔白腻，脉沉紧。中医诊断：痛经(寒湿凝聚)，因正值经期，予少腹逐瘀汤 3 剂口服，症状稍好转。嘱下次来经前 10 天服温脐化湿汤。药用：炒白术 30g，炒山药、巴戟肉、建莲子各 15g，茯苓、炒扁豆、白果各 10g。4 剂，每日 1 剂，水煎服。第二次月经时经量增多.颜色好转，小腹疼痛减轻，第三次来经前 10 天继服上方 4 剂后月经转为正常，腹痛消失。(覆玲允.山西中医)

曲春玲在 2007 年 3 月~2009 年 9 月间在临床上采用温脐化湿汤加减治疗西北地区 264 例痛经患者，方药：白术 15g(土炒).茯苓 9g，炒山药 12g.巴戟肉 9g(盐水浸)，炒扁豆 9g，白果 12g，建莲子 15g。经血中多是紫血块去炒扁豆、白果、建莲子，加白芍、当归、香附、川郁金；经期疼痛加阿胶(痒化)、山茱萸、白芍。收到良好效果。(中国社区医师(医学专业))。

【傅青主温脐化湿汤继发性不孕医案】贾玲允：

李某，女，32 岁，1990 年 8 月 10 日初诊。结婚 5 年不孕，曾在多家医院诊治。月经 14 岁初潮，周期 5~6 注家曰：6~28 天，自诉经量偏少，色黑。平素小腹怕冷，喜温喜按，经来时更甚，白带多。舌质淡黯、边有齿痕、苔薄白，根部稍厚，脉弦细。妇科检查未见明显异常，行诊断性刮宫术、输卵管通液术未见异常。抗精子抗体、形虫抗体均阴性。辨证为寒湿之邪侵袭下焦，予温脐化湿汤。药用：炒白术 30g，炒山药、巴戟肉、建莲子各 15g，茯苓、炒扁豆、白果各 10g。嘱其月经来潮前 10 天口服，每日 1 剂，水煎服。畏寒、喜温症状明显减轻，嘱下次月经来潮前 10 天继服上药 4 剂。三诊：诉此次来经颜色正常，小腹怕冷症状消失。共服 12 剂后患者因停经 40 余天而来我院，经 B 超检查证实为早孕。(山西中医)。

第十一节 经水过多

【原文】：妇人有经水过多，行后复行，面色痿黄，身体倦怠，而困乏愈甚者，人以为血热有余之故，谁知是血虚而不归经乎！失血旺始经多，血虚当经缩。今日血虚而反多经多，是何言与？殊不知血归于经，虽旺而经亦不多；血不归经，虽衰而经亦不少，世之人见经水过多，谓是血之旺也，此治之所以多错耳。倘经多果是血旺，自是健壮之体，须当一行即止，精力如常，何至一行后而再行，而困乏无力耶！惟经多是血之虚，故再行而不胜其困乏，血损精散，骨中髓空，所以不能色华于面也。治法宜大补血而引之归经，又安有行后复行之病哉！方用加减四物汤。

加减四物汤方：

大熟地一两（九蒸），白芍三钱（酒炒），当归五钱（酒洗），川芎二钱（酒洗），白术五钱（土炒），黑芥穗三钱，山萸三钱（蒸），续断一钱，甘草一钱。

水煎服。四剂而血归经矣。十剂之后，加人参三钱，再服十剂，下月行经，适可而止矣。

傅山曰：夫四物汤乃补血之神品，加白术，荆芥，补中有利；加山萸、续断，止中有行；加甘草以调和诸品，使之各得其宜，所以血足而归经，归经而血自静矣。

注家曰：荆芥炭引血归经。方妙极，不可轻易加减。

第十二节 经前泄水

【原文】：妇人有经未来之前，泄水三日，而后行经者，人以为血旺之故，谁知是脾气之虚乎！夫脾统血，脾虚则不能摄血矣；且脾属湿土，脾虚则土不实，土不实而湿更甚，所以经水将动，而脾先不固；脾经所统之血，欲流注于血海，而湿气乘之，所以先泄水而后行经也。调经之法，不在先治其水，而在先治其血；抑不在先治其血，而在先补其气。盖气旺而血自能生，抑气旺而湿自能除，且气旺而经自能调矣。方用健固汤。

方用健固汤方：

人参五钱，白茯苓三钱，白术一两（土炒），巴戟五钱（盐水浸），薏苡仁三钱（炒）

水煎。连服十剂，经前不泄水矣。

傅山曰：此方补脾气以固脾血，则血摄於气之中，脾气日盛，自能运化其湿，湿既化为乌有，自然经水调和，又何至经前泄水哉！

病因和病机：脾虚

辩证依据：经前阴道泄水、经前下利

【加减】如泄水淡黄清稀且无邪味，腹部微冷，脾阳不足者，可加干姜、肉桂，温阳散寒；若兼见小腹冷，腰骶酸坠，肾阳不足者，宜加菟丝子、补骨脂温肾暖土；如湿积成痰，痰湿壅聚胞宫，其人形体肥胖，泄水量多，状如痰涎，连绵如带，经量亦多者，可加半夏、南星、苍术等，健脾燥湿化痰。如果湿邪久留，郁而化热，泄水色紫，状如赤豆汁，阴道灼痛，当先清热渗湿，方用龙胆泻肝汤，待热象解除，再用健脾利湿法善后。

注家曰：经前泄水系指“经行泄泻”一症。它与月经周期有密切关系，故属“月经前后诸证”范畴，多由于脾虚湿盛而致。“月经前后诸证”在古医籍中并无此病名，但根据所出现的不同症状，散见于各书中的有“经行泄泻”、“经前便血”、“经行头痛”、“经行发热”、“经行浮肿”等。“月经前后诸证”每于经前数日或经期规律性地出现一些症状，有时可单独出现，有时可以同时出现数个症状，故又称“经前期紧张综合征”。一般以经前 2~7 天最为明显，经后即逐渐消失。多由于脏腑功能失调而引起。临床病机有肝郁、血虚、阴虚、脾虚、肾虚等。现代医学认为本病与卵巢功能失调有关。健固汤治之有效。若久病不愈，脾虚及肾、肾虚阳衰，则出现腰酸膝软，肠鸣作泄等，治以健固汤合四神丸；若脾虚日久，土虚木乘，可出现腹痛不适，痛后作泻等，治以健固汤合痛泻要方；若脾肾阳虚，真火不足，不能温煦脾阳，可出现腹中冷痛、畏寒肢冷、泻下清水、完谷不化等，治以健固汤合附子理中丸。

罗注：经行泄水，是由于脾肾气虚以及湿热下注，不能行水化湿所致。症状可以见月经来潮的前两天，阴道泄清水，水量次数也是不等的，通常表现为月经量的增多，以及经期出现浮肿。证见妇人未来经前，时而有水样物流出，三日后方行经，水样物虽量不多，然妇人每月必有此症，伴纳谷不香，体倦乏力等。可予健固汤方。

方中虽重用人参、白术以健脾益气，却又佐巴戟量至五钱之多，以温补肾气而上暖脾阳，言重在脾阳不振则可，如谓与肾阳无涉则不可。至于佐茯苓、苡仁二味，不过为除湿利水着想，全方组织独到，无可非厚也。临床仿健固汤法，治脾泄泻，方中酌加肉蔻、故纸、莲肉，扁豆、补骨脂等味，每收良效。若肾阳虚甚，腰酸下部清冷，再稍加桂附，亦较平妥。

【健固汤加味治阴道泄水验案】杨医亚：

崔 xx，女，42 岁，唐山陶瓷五厂职工。1973 年 11 月 15 日初诊：患者生育 3 胎，流产 1 次，营养欠佳，工作亦觉劳累，因之身体日渐衰弱，面色萎黄虚浮，晨起眼睑微肿，气短乏力，每晚回家即感腰酸身困，难以操持家务。2 年多来，月经较多，色淡红，并有白带，近半年来，每于经前 2~3 天，阴道即流水，初则不曾介意，后因量多，常需用卫生纸兜垫，身

体也越感不支，故来院就诊。舌淡苔薄白而润，牙龈色淡，脉沉细无力，两尺尤甚。综观病史，惹由胎孕过众，先天之本受戏，胞脉因伤，本当调养后天，以滋肾气，而却饮食失当，劳倦过度，后天亦损，源流不足，以致脾肾皆虚，酿成斯证。故治宜健脾益肾，调理 2 天，方用健固汤加味：党参 15 克，黄芪 24 克，白术 12 克，山药 12 克，巴戟天 15 克，菟丝子 15 克，补骨脂 9 克，狗脊 9 克，茯苓 15 克，薏仁米 12 克，车前子 6 克(包)，炙甘草 6 克。水煎，每日 1 剂。

二诊：11 月 19 日。服药 1 剂，又见阴道泄水，服完 3 剂，泄水已少，经血已见。除气短稍轻外，余证同前。恙属痼疾，难以速挽，沉着应战，原方再进 5 剂。

三诊：11 月 26 日。上药服完，月经已止。面色较前红润，虚浮之象已失，腰瘦身困亦减，但食纳尚少，前方去车前子，加砂仁 3 克，炒麦芽 9 克，继服。

以上方加减，共服药 40 余剂，体力恢复，诸证消失。4 个月后，我因去该厂参观，询问病况，言病未再发。(中医自学丛书·妇科)

经前泄水即为经前泄泻，是指月经前大便稀水，一般经后即自行痊愈，临证虽较少见，但不经治疗是难以彻底向愈的。再则，这种病也影响生育，故须重视治疗。其发病原因，根据古人认识，一般认为是脾虚所致。

第二节 经前大便下血

【原文】：妇人有行经之前一日大便先出血者，人以为血崩之症，谁知是经流于大肠乎！夫大肠与行经之路，各有分别，何以能入乎其中？不知胞胎之系，上通心而下通肾，心肾不交，则胞胎之血，两无所归，而心肾二经之气，不来照摄，听其自便，所以血不走小肠而走大肠也。治法若单止大肠之血，则愈止而愈多；若击动三焦之气，则更拂乱而不可止。盖经水之妄行，原因心肾之不交；今不使水火之既济，而徒治其胞胎，则胞胎之气无所归，而血安有归经之日！故必大补其心与肾，便心肾之气交，而胞胎之气自不散，则大肠之血自不妄行，而经自顺矣。方用顺经两安汤。

顺经两安汤方：

当归五钱（酒洗），白芍五钱（酒炒），大熟地五钱（九蒸），山萸肉二钱（蒸）人参三钱，白术五钱（土炒），麦冬五钱（去心），黑芥穗二钱，巴戟肉一钱（盐水浸），升麻四分

水煎服。二剂大肠血止，而经从前阴出矣，三剂经止，而兼可受妊矣。

傅山曰：此方乃大补心肝肾三经之药，全不去顾胞胎，而胞胎有所归者，以心肾之气交也。盖心肾虚则其气两分；心肾足则其气两合，心与肾不离，而胞胎之气听命於二经之摄，又安有妄动之形哉！然则心肾不交，补心肾可也，又何兼补夫肝木耶？不知肝乃肾之子心之母也，补肝则肝气往来於心肾之间，自然上引心而下入於肾，下引肾而上入於心，不啻介绍之助也。此便心肾相交之一大法门，不特调经而然也，学者其深思诸。

注家曰：若大便下血过多，精神短少，人愈消瘦，必系肝气不舒，久郁伤脾，脾伤不能统血又当分别治之。方用补血汤，嫩黄耆二两（生熟各半），归身四钱（酒洗（炒黑），杭芍炭二钱，焦白术五钱（土炒），杜仲二钱（炒断丝），荆芥炭二钱，姜炭二钱，引用贯仲炭一钱冲入服之，四剂必获愈，愈后减半再服二剂。经入大肠必当行经之际而大便下血也，初病血虽错行精神必照常，若脾不统血精神即不能照常矣，用者辨之。）

第三节 年未老经水断

【原文】：经云："女子七七而天癸绝。"有年未至七七而经水先断者，人以为血枯经闭也，谁知是心肝脾之气郁乎！使其血枯，安能久延于人世。医见其经水不行，妄谓之血枯耳，其实非血之枯，乃经之闭也。且经原非血也，乃天一之水，出自肾中，是至阴之精而有至阳之气，故其色赤红似血，而实非血，所以谓之天癸。世人以经为血，此千古之误，牢不可破，倘果是血，何不名之曰血水，而曰经水乎！经水之名者，原以水出于肾，乃癸干之化，故以名之。

无如世人沿袭而不深思其旨，皆以血视之。然则经水早断，似乎肾水衰涸。吾以为心肝脾气之郁者，盖以肾水之生，原不由于心肝脾，而肾水之化，实有关於心肝脾。使水位之下无土气以承之，则水滥灭火，肾气不能化；火位之下无水气以承之，则火炎铄金，肾气无所生；木位之下无金气以承之，则木妄破土，肾气无以成。

倘心肝脾有一经之郁，则其气不能入於肾中，肾之气即郁而不宣矣。况心肝脾俱郁，即肾气真足而无亏，尚有茹而难吐之势。矧肾气本虚，又何能盈满而化经水外泄耶！经日"亢则害"，此之谓也。此经之所以闭塞有似乎血枯，而实非血枯耳。治法必须散心肝脾之郁，而大补其肾水，仍大补其心肝脾之气，则精溢而经水自通矣。方用益经汤。

益经汤方：

大熟地一两（九蒸），白术一两（土炒）山药五钱（炒），当归五钱（酒洗），白芍三钱（酒炒），生枣仁三钱，捣碎）丹皮二钱，沙参三钱，柴胡一钱，杜仲一钱（炒黑）人参二钱

水煎。连服八剂而经通矣，服三十剂而经不再闭，兼可受孕。

傅山曰：此方心肝脾肾四经同治药也。妙在补以通之，散以开之；倘徒补则郁不开而生火，徒散则气益衰而耗精；设或用攻坚之剂，辛热之品，则非徒无益，而又害之矣。

【临证提要】由此方可见，傅氏不仅强调了月经的产生与肾的关系密切，而且明确了治疗闭经应从肾入手再结合辨证施治，所以傅氏所创 15 首调经方中，每方必有熟地、山药、杜仲等滋肾益精、填补真水作用的药物。其调经方之用药，甚具特色，充分体现了经水之病源于肾的规律。缘于此，在治疗本病的过程中，求源之中不忘正确的辨证施治，往往能取得令人满意的效果。本方不仅可辨证应用于月经过少、更年期综合征，还可用于治疗证属肾虚肝郁脾虚证的不孕。

【作用与功效】补肾养血，疏肝健脾。

【主治适应症】有年未至七七而经水先断者。

【方解】全方十一味药，熟地黄一味为君，统领补肾，人参、当归为臣，健脾养血为纲，白术、山药、沙参佐以健脾，杜仲佐以补肾，酸枣仁、柴胡、白芍、牡丹皮四药为使，不仅分人心、肝、脾、肾四经而且兼顾他经，即解心肝之气郁，又散血分之郁，沙参补益肺气，养肺胃之阴，并制诸药温燥之性。全方旨在补肾疏肝健脾。

【益经汤加减治疗卵巢功能早衰】颜建敏：

华某，38 岁，1999 年 2 月 17 日初诊。患者闭经 2 年，曾行西药人工周期疗法治疗半年，虽有月经来潮、但经量不多，停药后月经不能自行恢复。行内分泌激素检查：促卵泡激素(FSH)≥25IU/L，B 超检查示：子宫略小于正常。卵泡形态学观察，最大卵泡直径在 6mm 以下。妇科检查：阴毛稀少，外阴皮肤弹性较差，阴道分泌物少。伴潮热汗出，烦躁易怒，腰酸腿软，性欲淡漠，头晕耳鸣，纳食不香，神疲乏力，舌淡暗、苔薄白，脉弦细沉。诊断：卵巢功能早衰，证属肾虚血瘀，肝郁脾虚，治以补肾活血，疏肝健脾。方用益经汤加减。处方：党参、鸡血藤、熟地黄各 18g，白术、当归各 15g，白芍、酸枣仁、沙参、杜仲、肉苁蓉、丹参各 12g，柴胡、鸡内金、甘草各 6g，牡丹皮 9g，山药 30g。每天 1 剂，水煎，分 3 次口服，每次 150mL。

服 36 剂后，月经来潮，量不多，持续 4 天干净。坚持服药 6 个月余，月经恢复正常，周

期为 34~37 天，经量为既往正常量，余症消失。(新中医)

【益经汤加减治疗排卵障碍性不孕】颜建敏：

刘某，33 岁，2005 年 10 月 9 日初诊。患者因结婚 3 年同居未避孕而不孕来诊。曾行子宫输卵管碘油造影检查示：子宫、双侧输卵管未见异常。B 超监测卵泡形态学变化示：主卵泡最大直径为 15mm，夫妻双方行其他相关检查，未发现功能性及器质性病变。曾行促排卵及人工受精治疗未成功。诊时值月经周期第 9 天，诊见：轻微腰酸，带下量不多，夜寐欠安，余无特殊不适，舌淡、苔薄白，脉沉细。证属肾虚肝郁，治以补肾疏肝、调理冲任。方以益经汤加减。处方：熟地黄、白术、当归、赤芍、鹿胎膏(烊化)、沙参、巴戟天、山药、党参各 15g，酸枣仁、杜仲各 12g，柴胡 10g，鸡血藤 30g，牡丹皮、甘草各 6g。每天 1 剂，水煎，分 3 次口服，每次 100mL，连服 10 剂，等待月经来潮，于月经周期第 9 天，续服上方 10 剂，患者无不适。月经过期未潮，经检查已妊娠。(新中医)。

【益经汤治疗绝经综合征 56 例】王艳东

3.绝经综合征王艳东于 2005 年~2009 年采用中药益经汤加味治疗绝经综合征 56 例。患者在用药 10 天后症状好转，1 个疗程后评分明显下降。症状完全消失，痊愈 10 例，显效 19 例，有效 26 例，无效 2 例，总有效率 96%。益经汤基本方：熟地、白术各 30g，山药、当归各 15g，沙参、白芍、生枣仁 10g，柴胡 5g，丹皮、人参各 6g。气虚重者人参 9g，寒重者杜仲 9g。(陕西中医)。

【傅青主益经汤治疗月经过少 40 例】邓力军

月经过少邬素珍在临床上对 40 例月经过少患者非经期用益经汤(熟地 15g，白术 10g，山药 15g，当归 10g，白芍 15g，生枣仁 20g，丹皮 15g，沙参 15g，柴胡 10g，杜仲 15g，党参 10g)治疗，连续服药 3 个月经周期。痊愈 12 例，显效 16 例，有效 9 例，无效 3 例，总有效率 92.5%。(广东广州第九次全国中医妇科学术研讨会论文集)。

【傅青主益经汤治疗辨治心悸验案举隅】邓力军

心悸刘某某，女，43 岁。2009 年 10 月 16 日初诊。3 年来患者在月经前自觉心悸，发作时检查心电图示：窦性心律不齐，超声心动未见异常。3 个月来月经未行，心悸频发，伴有失眠多梦，五心烦热，纳可便调，舌苔薄黄、边有齿痕，脉弦左细。辨证属肝郁脾虚，心失所养。予益经汤加减。处方：熟地 30g，土白术 30g，山药 15g，丹皮 10g，山萸肉 15g，枸杞子 20g，杜仲 3g，柴胡 3g，党参 10g，生龙牡(各)30g(先煎)，茯神 15g，郁金 10g。6 剂。水煎，每日 1 剂分 2 次服。二诊：服药后月经至，瘀块甚多，遂以四物汤加减治之。处方：熟地 30g，当归 20g，白芍 20g，桃仁 10g，柴胡 10g，郁金 20g，川芎 15g，丹皮 6g，炙草 10g。7 剂。水煎服每日 1 剂。三诊：行经 6 天止，心悸未作，眠安。再拟益经汤连服月余，心悸痊愈，月经恢复正常。追访 3 个月病症未发。(江苏中医药)。

第四章 种子不孕症

第一节 身瘦不孕

【原文】：妇人有瘦怯身躯，久不孕育，一交男子，即卧病终朝。人以为气虚之故，谁知是血虚之故乎。或谓血藏于肝，精涵于肾，交感乃泄肾之精，与血虚何与?殊不知肝气不开，则精不能泄，肾精既泄，则肝气亦不能舒。以肾为肝之母，母既泄精，不能分润以养其子，则木燥乏水，而火且暗动以铄精，则肾愈虚矣。况瘦人多火，而又泄其精，则水益少而火益炽，水虽制火，而肾精空乏，无力以济，成火在水上之卦，所以倦怠而卧也。此等之妇，偏易动火。然此火因贪欲而出于肝木之中，又是偏燥之火，绝非真火也。且不交合则已，交合又偏易走泄，此阴虚火旺不能受孕。即偶尔受孕，必致逼干男子之精，随种而随消者有之。治法必须大补肾水而平肝木，水旺则血旺，血旺则火消，便成水在火上之卦。方用养精种玉

汤。

养精种玉汤方：
大熟地一两（九蒸），当归五钱（酒洗），白芍五钱（酒洗），山萸肉五钱（蒸熟）
水煎服。三月便可身健受孕，断可种子。

傅山曰：此方之用，不特补血而纯于填精，精满则子宫易于摄精，血足则子宫易于容物，皆有子之道也。惟是贪欲者多，节欲者少，往往不验。服此者果能节欲三月，心静神清，自无不孕之理。否则不过身体健壮而已，勿咎方之不灵也。

服药三月后不受孕，仍月原方加杜仲二钱炒断丝，续断二钱，白术五钱上炒焦，云苓三钱，服数剂后必受孕。

【按语】素体肾阴不足，或房劳多产、久病失血，耗损真阴，天癸乏源，不能摄精成孕，故婚久不孕；肾阴亏虚，精血不足，冲任血海匮乏，故经量少或月经停闭；阴精不能荣养体肤，故形体消瘦，肌肤不润，阴中干涩；不能充填髓海，髓海不足，故头晕耳鸣，腰膝酸软；阴虚生内热，虚热内扰冲任，迫血妄行，故月经常提前，或漏下不止，经色较鲜红；虚热上扰心神，则故五心烦热，失眠多梦，心悸。舌质稍红略干、苔少、脉细数，亦为阴虚内热之象。

【组成】大熟地黄 30g，当归(酒洗)、白芍(酒炒)、山茱萸肉(蒸熟)各 15g。

【功效】滋肾养血，调补冲任。主治不孕症，证属肾阴虚者，症见身瘦不孕，月经后期或闭经，量少色红，或漏下不止，头晕耳鸣，腰酸膝软，形体消瘦，肌肤失润，阴中干涩，五心烦热，失眠多梦，心悸，舌质稍红略干，苔少，脉细数。

【方解】经云“精不足者，补之以味”。熟地黄借酒蒸熟，甘温柔润，气味浓厚，直达下焦，以滋心肾，养肝血，填精补髓见长，前人云：“阴虚而神散者，非熟地黄之守不足以聚之；阴虚而火升者，非熟地黄之重不足以降之；阴虚而躁动者，非熟地黄之静不足以镇之…….”(《本草正义》)故方中重用为君。山茱萸酸温，补益肝肾而涩精，为臣。君臣相伍，共建滋阴养肾之功。白芍酸甘，补血敛阴；当归辛甘而温，补血和血，二药开合有度，养血和血之功最良，与熟地黄相伍，不但取“乙癸同源”之意，能使本方填精补血之功更著，而且兼能养肝调经，故为佐使。综观全方，专于滋补肝肾精血，走守结合而以守为主。

【加减】阴虚内热而见五心烦热、盗汗者，加女贞子、墨旱莲、麦冬、知母；兼脾气虚而见体倦食少、气短懒言者，加黄芪、白术、党参以补气健脾。

【傅青主养精种玉汤不孕医案】：

朱某，女，28 岁。2005 年 6 月 17 日初诊。自然流产后 2 年未孕，伴月经稀发。13 岁初潮起月经稀发，曾服用炔雌醇环丙孕酮片避孕 6 个月。2003 年 6 月孕 7 周自然流产，未避孕至今未孕。基础体温单相，末次月经日期 2005 年 5 月 17 日。察其舌暗红，舌苔薄黄，脉弦。诊其为肾虚精亏，兼有瘀滞。肾虚精亏，冲任血海不能按时满盈，故自月经初潮起月经后期；肾主生殖，肾虚则胎元不固，而自然流产；肾虚精亏，难以摄精成孕，故流产后 2 年未孕。治宜补肾填精。因正值经前，用上方治以补肾养血，活血通经。

复诊：平时以补肾填精为主，经前佐以活血通经。患者原月经失调，基础体温单相，治疗三诊时，基础体温出现双相，月经规律。3 个月后受孕。

【倦怠呵欠口干妇人不孕医案】张氏医通：

易思兰治一妇，患浑身倦怠，呵欠口干，经月不食，强之不过数粒而已，有以血虚治之者，有以气弱治之者，有知为火而不知火之源者，用药杂乱，愈治愈病，至冬微瘥，次年夏间，诸病复作，肌消骨露，三焦脉洪大侵上，脾肺二脉微沉，余部皆平和，此肺火病也。以栀子仁姜汁浸一宿，炒黑研极细末，用人参、麦冬、乌梅煎汤调下，进二服，即知饥喜食，旬日肢体充实如常，后因久病不孕，众皆以为血虚，而用参、 之品，半月胸膈饱胀，饮食顿

减，至三月余而经始通，下黑秽不堪，或行或止，不得通利，其苦万状，易复以四乌汤换生地，加陈皮、苏梗、黄芩、山栀、青皮、枳壳十数剂，一月内即有孕。

第二节 胸满不思食不孕

【原文】：妇人有饮食少思，胸膈满闷，终日倦怠思睡，一经房事，呻吟不已。人以为脾胃之气虚也，谁知是肾气不足乎。夫气宜升腾，不宜消降。升腾于上焦则脾胃易于分运，降陷于下焦则脾胃难于运化。人乏水谷之养，则精神自尔倦怠，脾胃之气可升而不可降也明甚。然则脾胃之气虽充于脾胃之中，实生于两肾之内。无肾中之水气，则胃之气不能腾；无肾中之火气，则脾之气不能化。惟有肾之水火二气，而脾胃之气姑能升腾而不降也。然则补脾胃之气，可不急补肾中水火之气乎？治法必以补肾气为主，但补肾而不兼补脾胃之品，则肾之水火二气不能提于至阳之上也。方用并提汤。

并提汤方：

大熟地一两（九蒸），巴戟一两（盐水浸）白术一两（土炒），人参五钱，黄芪五钱（生用），山萸肉三钱（蒸），枸杞二钱，柴胡五分

水煎服。三月而肾气大旺。再服一月，未有不能受孕者。

傅山曰：此方补气之药多于补精，似乎以补脾胃为主矣。孰知脾胃健而生精自易，是脾胃之气与血，正所以补肾之精也水也。又益以补精之味，则阴气自足，阳气易升，自尔腾越于上焦矣。阳气不下陷，则无非大地阳春，随遇皆是化生之机，安有不受孕之理与！

注家曰：胸满不孕。人每误为脾胃虚寒，不能克，食。用扶脾消导之药。肾气愈虚，何能受孕。妙在立方不峻补肾火，所以不用桂附等药，但专补肾气，使脾胃之气不复下陷，则带脉气充，胞胎气暖，自然受孕无难矣。

功能主治：补肾气，兼补脾胃。主肾气（阳）不足。

方义：妇人嗜卧倦怠，胃纳欠佳，似乎脾胃有病，或中气衰弱，然究之不孕根本，乃肾阳内虚，不能生火暖土熟谷，累及脾土受困。故方中以山萸肉、巴戟肉温肾补气，配熟地、枸杞益肾填精，俾精足气腾，以人参、黄芪大补元气升阳，配白术健运中土，土能旺而精自生。此意在以后天养先天矣。少佐柴胡疏肝理气，不致肝木侮土也。综观全方多补益之品，有虑滋腻碍胃，愚意加陈皮、木香更醒运化气机，资助气血生化之沅。

方中以山萸肉、巴戟天温肾补气，配熟地、枸杞益肾填精；以人参、黄芪大补元气升阳，配白术健运中土，土能旺而精自生，以后天养先天。稍佐柴胡疏肝理气，不使肝木侮土。

《傅青主女科》关于不孕常见三类原因，一是下部冰冷不孕，子宫寒凉，就好像漫漫雪地，种子不得发芽，一类是痰湿厚重不孕，就好像被洪水泡过的土地，种子也不得发芽。第三类是胸满不思食不孕的脾肾气虚双亏。我们先看看原文："妇人有饮食少思，胸膈满闷，终日倦怠思睡．一经房事，呻吟不已。人以为脾胃之气虚也，谁知是肾气不足乎。夫气宜升腾，不宜消降。升腾于上焦则脾胃易于分运，降陷于下焦则脾胃难于运化。人乏水谷之养，则精神自尔倦怠，脾胃之气可升而不可降也明甚。然则脾胃之气虽充于脾胃之中，实生于两肾之内。无肾中之水气，则胃之气不能腾；无肾中之火气，则脾之气不能化。惟有肾之水火二气，而脾胃之气姑能升腾而不降也。然则补脾胃之气，可不急补肾中水火之气乎？治法必以补肾气为主，但补肾而不兼补脾胃之品，则肾之水火二气不能提于至阳之上也。方用并提汤。"

并提汤：大熟地 30 克，巴戟 30 克（盐水浸），土炒白术 30 克，人参 15 克，生黄芪 15 克，山萸肉 9 克，枸杞子 6 克，柴胡 1.5 克。水煎服三个月而肾气大旺。再服一月，未有不能受孕者。

此方补气之药多于补精，以补脾胃为主。脾胃健而生精自易，是脾胃之气与血，正所谓以补肾之精水也。又补精之味，则阴气自足，阳气易升于上焦矣。胸满不孕。误为脾胃虚寒，不能克食。用扶脾消导之药。肾气愈虚，何能受孕。妙在不峻补肾火，所以不用桂附等药，但专补肾气，使脾胃之气不复下陷，则带脉气充，胞胎气暖，自然受孕。如果女性每天总觉得胸满胀着，胃口差，吃得很少，每天很倦怠，上班也不想上，想个问题都觉得脾虚：脾胃之气虽充于脾胃之中，实生于两肾之内。无肾中之水气，则胃之气不能腾；无肾中之火气，则脾之气不能化。总而言之，补肾，又健脾，两个气都得提，叫做并提汤。舌诊：有齿痕。外治法可用脏腑按摩加脾肾同灸，坚持一到三个月，自然肾气能升腾，子宫能温暖，胃口会改善，带脉会充盈，当然，配合用“并提汤”，效果会更佳。

第三节 下部冰冷不孕

【原文】：妇人有下身冰冷，非火不暖，交感之际，阴中绝无温热之气。人以为天分之薄也，谁知是胞胎寒之极乎！夫寒冰之地，不生草木；重阴之渊，不长鱼龙。今胞胎既寒，何能受孕。虽男子鼓勇力战，其精甚热，直射于子宫之内，而寒冰之气相逼，亦不过茹之于暂而不能不吐之于久也。夫犹是人也，此妇之胞胎，何以寒凉至此，岂非天分之薄乎?非也。盖胞胎居于心肾之间，上系于心而下系于肾。胞胎之寒凉，乃心肾二火之衰微也。故治胞胎者，必须补心肾二火而后可。方用温胞饮。

温胞饮方：

白术一两（土炒），巴戟一两（盐水浸），人参二钱，杜仲三钱（炒黑），菟丝子三钱（酒浸炒），山药三钱（炒）芡实三钱（炒），肉桂三钱（去粗研）附子三分（制），补骨脂二钱（盐水炒）

水煎服。一月而胞胎热。

傅山曰：此方之妙，补心而即补肾，温肾而即温心。心肾之气旺，则心肾之火自生。心肾之火生，则胞胎之寒自散。原因胞胎之寒，以至茹而即吐，而今胞胎既热矣，尚有施而不受者乎?若改汤为丸，朝夕吞服，尤能摄精，断不至有伯道无儿之叹也。

注家曰：今之种子者多喜服热药，不知此方特为胞胎寒者设，若胞胎有热则不宜服。审之。

【作用与功效】温补心肾，暖胞祛寒。

【主治适应症】妇人有下身冰冷，非火不暖，交感之际，阴中绝无温热之气。

【方解】方中白术补气健脾，滋养化源，巴戟温肾暖宫，人参、淮山药助白术补气健脾，杜仲、菟丝子、附子助巴戟补肾益精、温肾壮阳。芡实甘平，补肾益精、收敛固涩，可抑桂、附等辛热之品耗伤精气，肉桂人肾，补命门真火且益心阳，益火消阴、祛沉寒痼冷；补骨脂苦温入心肾，温肾壮阳，上药合用以温补心肾，益火消阴、祛寒除冷、养精益气。

白术补气健脾，滋养化源，以利腰脐之气血，且土炒后，同气相求，更增其人脾补土之力；巴戟温肾暖宫，《本草正义》谓：“巴戟隆冬不凋，味辛气温，专人肾家为鼓舞阳气之用。温养元阳，邪气自除。”盐水浸后，更增其入肾补火之力。二药均重用至一两，一培后天之土，一补先天之火，共为君药。人参、淮山药助白术补气健脾；杜仲、菟丝子、附子助巴戟补肾益精、温肾壮阳。五者共为臣药。芡实甘平，补肾益精、收敛固涩，明•缪希雍谓其“得水土之阴者能抑火”，故可抑桂、附等辛热之品耗伤精气，为佐药。肉桂入肾，补命门真火且益心阳，益火消阴、祛沉寒痼冷；补骨脂苦温入心肾，温肾壮阳，清•黄宫绣谓其“能使心胞之火与命门之火相通。”二者共为使药。十药相合，君、臣、佐、使井然分明。共奏温补心肾，益火消阴、祛寒除冷、养精益气之功。

【温胞饮加减治疗不孕症98例】朱惠英：

不孕朱惠英、杜瑛瑛从1987年开始在临床上运用本方加减治疗宫寒不孕症98例，疗效颇佳，用药：生晒参15g(或人参6g)，巴戟天10g，白术10g，杜仲15g，补骨脂10g，淮山药24g，菟丝子12g，肉桂0.2g(或桂枝5g)，仙茅10g，淫羊藿10g，肉苁蓉12g。(福建中医学院学报)。

【温胞饮加减治自然流产其后久不受孕】温丽娜

邱某，女，38岁，2009年2月就诊。生一女后流产15次，其中近2次孕2个月左右自然流产，其后久不受孕，近2年来月经量少、约为以往50%，日用不足1片卫生巾，经色淡暗，性欲淡漠，小腹怕冷，腰酸隐作，带下量多，清稀如水，时有耳鸣，手足不温，舌淡黯苔白，脉沉细。B超监测子宫内膜偏薄，排卵后内膜约4~5cm。宫腔镜检查见子宫内膜菲薄。治以补肾暖宫，调补冲任。方用温胞饮加减。药用鹿胎粉、白术、巴戟天、杜仲、菟丝子、山药、人参、芡实、熟地各10g，补骨脂15g。于黄体期连服10剂，其余时间口服中成药鹿胎颗粒补气养血。复诊时腰酸、耳鸣均有好转，手足怕冷明显改善，稍口干，舌黯有减，苔薄，脉细。治以滋肾助阳。药用熟地20g，炒白芍10g，阿胶珠10g，炒当归10g，麦冬10g，山药10g，山茱萸10g，续断10g，菟丝子10g。日1剂，水煎服，每日2次。经周前半期口服后方，后半周期服用前方，经行第2天停药。2009年10月11日妊娠，保胎，予中药益肾安胎剂寿胎丸加减，于2010年6月产一健康女婴。(实用中医药杂志)。

【傅氏温胞饮加味男子少精症】刘立华：

张某，男，31岁，1988年5月21初诊，患者婚后5年不育，夫妻感情较好，性生活正常，妻子身体健康。诊见头晕耳鸣，失眠多梦，腰膝软弱无力、畏冷，苔薄白，脉沉细无力。检查精液结果：质清稀，量约2~3mL，畸形精子10%，精子活动不良，成活率20%~30%，精子计数30x10'/L。此乃肾阳不足所致少精症。治宜温肾助阳。方用傅氏温胞饮加味：党参、补骨脂各20g，白术、巴戟、杜仲、菟丝子各15g，芡实25g，肉桂、附片(先煎)各10g，山药、鹿角胶各30g。水煎服。以此略加减服用20剂后，诸症均有所好转。查精液量：4mL，成活率50%，畸形精子5%，精子计数80x10'/L。效不更方，续用此方加减治疗”服药30剂后，复查精液：精子计数80x10'/L，其他各项指标均属正常。次年其妻正常顺产一女孩。(四川中医)

【临证提要】随证加减：肾虚寒甚，症见性欲淡漠，婚久不孕，经期后错，量少色淡，畏寒腹冷，腰骶酸楚，苔薄白，质淡，脉沉迟者，倍用肉桂0.3~0.5g，加淡附子10g，紫石英15g，助阳补肾壮火。肝肾阴虚，月经稀发，量少色淡，经期多后延，头晕目眩，面色萎黄，精神倦怠，舌淡苔薄，脉沉细者，加紫河车12g，枸杞15g，女贞子15g，旱莲草10g，调肝补肾填精。痛经挟瘀，经行小腹胀痛，经血块多，色暗，面部有褐色斑，舌紫暗或瘀点，脉弦不畅，加血竭10g，红花5g，香附10g，川芎5g以行气活血行瘀。肝郁气滞，表现婚后多年不孕，精神抑郁不乐，胁痛乳胀，经期紊乱，经行不畅，舌质暗红，苔薄白，脉弦等症，去仙茅、淫羊藿、肉桂加柴胡、香附、丹参、郁金、路路通、合欢皮以疏肝理气，温肾调肝，理气助孕。兼有痰湿之症，表现多年不孕，其特征为形体肥胖，经行延期，带下量多，质稠而黏，面色萎黄，伴头晕心悸，苔白腻，脉沉滑，加半夏、苍术、陈皮、香附之类，以温肾壮阳化痰祛湿。

第四节 胸满少食不孕

【原文】：妇人有素性恬淡，饮食少则平和，多则难受，或作呕泄，胸膈胀满，久不受孕。人以为赋禀之薄也，谁知是脾胃虚寒乎。夫脾胃之虚寒，原因心肾之虚寒耳。盖胃土非心火不能生，脾土非肾火不能化。心肾之火衰，则脾胃失生化之权，即不能消水谷以化精微

矣。既不能化水谷之精微，自无津液以灌溉于胞胎之中，欲胞胎有温暖之气以养胚胎，必不可得。纵然受胎，而带脉无力，亦必堕落。此脾胃虚寒之咎，故无玉麟之毓也。治法可不急温补其脾胃乎?然脾之母原在肾之命门，胃之母原在心之包络。欲温脾胃，必须补二经之火。盖母旺子必不弱，母热子必不寒，此子病治母之义也。方用温土毓麟汤。

温土毓麟汤方：

巴戟一两，去心（酒浸），覆盆子一两（酒浸蒸），白术五钱（土炒），人参三钱，怀山药五钱（炒），神曲一钱（炒）

水煎服。一月可以种子矣。

傅山曰：此方之妙，温补脾胃而又兼补命门与心包络之火。药味不多，而四经并治。命门心包之火旺，则脾与胃无寒冷之虞。子母相顾，一家和合，自然饮食多而善化，气血旺而能任。带脉有力，不虞落胎，安有不玉麟之育哉！

注家曰：少食不孕与胸满不思饮食有间。一补肾中之气，一补命门与心包络之火。药味不多，其君臣佐使之妙。宜细参之。

【作用与功效】温肾暖胞，健脾益气。

【主治适应症】妇人有素性恬淡，饮食少则平和，多则难受，或作呕泄，胸膈胀满，久不受孕。

【方解】方中巴戟天、覆盆子温肾暖胞以养胚胎；太子参、白术、山药健脾益气，以滋化源，使源盛流畅；神曲醒胃以畅纳谷之用。

【温土毓麟汤医案】

妊娠合并消化性溃疡妊娠早期妇女合并消化性溃疡病例临床较少见，因此易忽视对本病的诊断与治疗，致使妊娠晚期或分娩后由于肾上腺皮质功能增强，胃液内盐酸及蛋白酶含量的逐渐增高而使溃疡病情加重。近年来，徐嵘采用温土毓麟汤加减(巴戟天 20g，覆盆子 18g，太子参、白术、山药、白芍、海螵蛸各 15g，苏梗、百合、茯苓、陈皮各 10g，郁金、当归、甘草各 6g。每日 1 剂，水煎取汁 150mL，1 日分 2 次，小口温服。)治疗妊娠合并消化性溃疡 35 例，取得较满意疗效。[徐嵘.温土毓麟汤加减治疗妊娠合并消化性溃疡疗效观察.湖北中医杂志，208，30(11)：33-34]。

【临证提要】临床上用于妊娠合并消化性溃疡时，由于胃为阳土，喜润而恶燥，为多气多血之腑，病久胃之气血耗伤，气滞络瘀，故配白术、百合养胃阴、润胃燥，柔肝止痛；陈皮、郁金疏肝理气、和胃止痛为辅药：佐以苏梗宽中安胎、行气止痛，当归补血活血止痛，茯苓、海蠕蛸健脾渗湿、制酸制痛，以防主药滋腻太过，使阴滋燥润而不腻，甘草缓急止痛为使药。

第五节 少腹急迫不孕

【原文】：妇人有少腹之间自觉有紧迫之状。急而不舒，不能生育。此人人之所不识也，谁知是带脉之拘急乎。

夫带脉系于腰脐之间，宜弛而不宜急。今带脉之急者，由于腰脐之气不利也。而腰脐之气不利者，由于脾胃之气不足也。脾胃气虚，则腰脐之气闭，腰脐之气闭，则带脉拘急。遂致牵动胞胎，精即直射于胞胎，胞胎亦暂能茹纳，而力难负载，必不能免小产之虞。况人多不能节欲，安得保其不坠乎？此带脉之急，所以不能生子也。治法宜宽其带脉之急。而带脉之急，不能遽宽也，宜利其腰脐之气。而腰脐之气，不能遽利也，必须大补其脾胃之气与血，而腰脐可利，带脉可宽，自不难于孕育矣。方用宽带汤。

宽带汤方：

白术一两（土炒 ），巴戟五钱（酒浸），补骨脂一钱（盐水炒），人参三钱，

麦冬三钱（去心），杜仲三钱（炒黑），大熟地五钱（九蒸），肉苁蓉三钱（洗净），白芍三钱（酒炒），归二钱（酒洗），五味三分（炒），建莲子二十粒（不去心）水煎服。四剂少腹无紧迫之状，服一月即受胎。

傅山曰：此方之妙，脾胃两补，而又利其腰脐之气，自然带脉宽舒，可以载物而胜任矣。或疑方中用五味、白芍之酸收，不增带脉之急，而反得带脉之宽，殊不可解。岂知带脉之急，由于气血之虚，盖血虚则缩而不伸，气虚则挛而不达。用芍药之酸以平肝木，则肝不克，脾。用五味之酸以生肾水，则肾能益带。似相妨而实相济也，何疑之有。

注家曰：凡种子治法，不出带脉胞胎二经。数言已泄造化之秘矣。

【作用与功效】健脾益肾缓带。

【主治适应症】妇人有少腹之间自觉有紧迫之状。急而不舒，不能生育。

【方解】方中人参、白术、建莲子益气健脾，利腰脐之气；当归、白芍、麦冬养血育阴；杜仲、熟地、巴戟肉、补骨脂、肉苁蓉益肾固本。方中用白芍之酸以平肝木，使肝不侮脾；用五味子之酸化生肾水，使肾能益带。

【宽带汤与少腹拘急不舒医案】

患者王某某，女，65 岁，农民，1994 年 7 月 18 日初诊，患者素有高血压、冠心病史，平素婆媳不睦，性格内向，不善言谈。诉其近 1 个月来自觉腰脐之间紧束不舒，少腹急迫，宽衣后仍不能有丝毫缓解，苦不堪言。纳少、腹胀、尿少、便溏，且觉头晕、胸闷憋气、颜面及下肢浮肿、舌胖大、色淡、苔厚腻、脉弦数、面色黧黑。西医查体：血压 180 傅山曰：10mmHg， 心率 96 次/分，心肺听诊(-)，腰间无皮疹及破损，双下肢可见指凹性浮肿。心电图：心肌缺血，右束支传导阻滞。中医辨证为肝郁脾虚，带脉拘急，治则以疏肝健脾，益肾缓带，方药用宽带汤加味：党参 20g，白术 10g，巴戟肉 10g，五味子 10g，补骨脂 10g，麦冬 10g，建莲子 10g，肉苁蓉 10g，当归 10g，白芍 15g，杜仲 10g，熟地 10g，牛膝 10g，车前子 10g，白茅根 20g，甘草 6g。服药 1 剂即觉带脉拘急症状大减，尿量增多，3 剂后少腹急迫症状消失，精神状态明显好转，浮肿消通，自觉身轻气爽，继服 3 剂巩固疗效。停药后至今未再复发。[张景江.宽带汤临证举隅.天津中医学院学报，2000，19(4)：54]。

【宽带汤神经官能症医案】

2 例单纯性带脉拘急病人，多方求医，经西医多种理化检查未发现阳性结果，而诊断为神经官能症，予以谷维素、维生素 B，治疗；有中医大夫考虑肾寒之证予肾著汤等药投之未效。后经宽带汤治疗 3 剂而愈。[张景江.宽带汤临证举隅.天津中医学院学报，2000.19(4)：54]。

【临证提要】此方乃大补脾胃之剂，临床上少腹拘急不孕者，排除器质性病变，辨证属肝郁脾虚，带脉拘急，可以应用本方，往往会收到意料之外的结果。临床用之多感滋腻，必须加减灵活使用。可酌情加木香、砂仁之品。

第六节 嫉妒不孕

【原文】：妇人有怀抱素恶不能生子者，人以为天心厌之也，谁知是肝气郁结乎。夫妇人之有子也，必然心脉流利而滑，脾脉舒徐而和，肾脉旺大而鼓指，始称喜脉。未有三部脉郁而能生子者也。若三部脉郁，肝气必因之而更郁，肝气郁则心肾之脉必致郁之极而莫解。盖子母相依，郁必不喜，喜必不郁也。其郁而不能成胎者，以肝木不舒，必下克，脾土而致塞。脾土之气塞，则腰脐之气必不利。腰脐之气不利，必不能通任脉而达带脉，则带脉之气亦塞矣。带脉之气既塞，则胞胎之门必闭，精即到门。亦不得其门而人矣。其奈之何哉?治法必解四经之郁，以开胞胎之门，则几矣。方用开郁种玉汤。

开郁种玉汤方：

白芍一两（酒炒），香附三钱（酒炒），当归五钱（酒洗），白术五钱（土炒）丹皮三钱（酒洗），茯苓三钱（去皮），花粉二钱

水煎服。一月则郁结之气开，郁开则无非喜气之盈腹，而嫉妒之心亦可以一易，自然两相合好，结胎于顷刻之间矣。

傅山曰：此方之妙。解肝气之郁，宣脾气之困，而心肾之气亦因之俱舒，所以腰脐利而任带通达，不必启胞胎之门，而胞胎自启。不特治嫉妒考也。

注家曰：方似平平无奇，然却能解妒种子，不可忽视。若怀娠而仍然嫉妒，必致血郁堕胎。即幸不堕胎，生子多不能成。方加解妒合煎之，可保无虞，必须变其性情始效。解妒饮：黍、谷各九十粒，麦（生用）、小黑豆各四十九粒〔豆炒熟），高粱五十粒。

【用法】水煎，每日1剂，分早晚2次温服。

不孕症是指育龄期妇女，夫妻同居2年以上，配偶生殖功能正常，未避孕而未怀孕者；或曾有孕育，又间隔2年以上，未避孕而未再受孕者，称为不孕症。前者称原发性不孕，后者称继发性不孕。不孕的原因，男女双方都有一定关系。女性方面除内外生殖器先天畸形外，多因排卵障碍，或内分泌失调，或输卵管、宫颈管阻塞，或受精卵无良好的着床基地所致，此外免疫因素及缺乏性知识亦为引起不孕的重要原因之一。

原发性不孕中医称“全不产”、“无子”症，继发性不孕称“断绪”。多因脏腑功能失常，气血失调导致冲任不能相资，胞宫不能摄精成孕。常见的原因有肾虚、肝郁、痰湿、血瘀，而血热、宫寒、积血所致的不孕也不少见。开郁种玉汤适用于肝郁所致不孕症。

开郁种玉汤加减：当归10克，白术10克，白芍12克，茯苓10克，丹皮10克，香附10克，花粉10克，甘草6克。

一般在本方中需加人青皮、陈皮、橘叶、广郁金各10克；若腰酸明显者，加人川断、桑寄生各12克；若胸胁、乳房胀满甚有结块，去白术，加郁金10克，王不留行15克，路路通.15克，橘核15克；梦多难眠者，加炒枣仁12克，柏子仁10克，夜交藤12克。

根据《陕西中医》1987，(11)：495，史志来等报道：应用开郁种玉汤加味治疗不孕症15例，治愈2例，显效10例，无效3例。处方：白芍，白术，茯苓，丹皮，香附，瓜蒌，皂角刺，王不留行，通草，党参，延胡索，炙甘草。每日1剂，水煎2次，分2次服。

根据《吉林中医药》1988，(1)：8，祝石等报道：应用开郁种玉汤加减共治疗不孕症41例，治愈38例，孕育率为92%。处方：当归15克，焦白术30克，白芍(酒炒)50克，茯苓15克，丹皮15克，香附15克，天花粉15克，青皮15克。每日1剂，水煎2次，分2次服。

第七节 肥胖不孕

【原文】：妇人有身体肥胖，痰涎甚多，不能受孕者。人以为气虚之故，谁知是湿盛之故乎。夫湿从下受，乃言外邪之湿也。而肥胖之湿，实非外邪，乃脾土之内病也。然脾土既病，不能分化水谷以养四肢，宜其身躯瘦弱，何以能肥胖乎?不知湿盛者多肥胖，肥胖者多气虚，气虚者多痰涎，外似健壮而内实虚损也。

内虚则气必衰，气衰则不能行水，而湿停于肠胃之间，不能化精而化涎矣。夫脾本湿土，又因痰多，愈加其湿。脾不能受，必浸润于胞胎，日积月累，则胞胎竟变为汪洋之水窟矣。且肥胖之妇，内肉必满，遮隔子宫，不能受精，此必然之势也。况又加以水湿之盛，即男子甚健，阳精直达子宫，而其水势滔滔，泛滥可畏，亦遂化精成水矣，又何能成妊哉。治法必须以泄水化痰为主。然徒泄水化痰，而不急补脾胃之气，则阳气不旺，湿痰不去，人先病矣。乌望其茹而不吐乎！方用加味补中益气汤。

加味补中益气汤方：

人参三钱，黄芪三钱（生用），柴胡一钱，当归三钱（酒洗），白术一两（土炒），升麻四分，陈皮五分，茯苓五钱，半夏三钱（制）

水煎服。八剂痰涎尽消，再十剂水湿利，子宫涸出，易于受精而成孕矣。

傅青主曰：其在于昔，则如望洋观海；而在于今，则是马到成功也。快哉！此方之妙，妙在提脾气而升于上，作云作雨，则水湿反利于下行。助胃气而消于下，为津为液，则痰涎转易于上化。不必用消化之品以损其肥，而肥自无碍；不必用浚决之味以开其窍，而窍自能通。阳气充足，自能摄精，湿邪散除，自可受种。何肥胖不孕之足虑乎！

注家曰：再十剂后方加杜仲一钱半（炒断丝），续断钱半〔炒），必受孕矣。

附方：补中益气汤方：

补中益气汤（李东垣《脾胃论》）

黄芪（病甚，劳役热者一钱）、甘草（炙）以上各五分，人参（去节，三分，有嗽去之。）（以上三味，除湿热、烦热之圣药也。）当归身（三分，酒焙干，或日干，以和血脉），橘皮（不去白，二分或三分，以导气，又能益元气，得诸甘药乃可，若独用泻脾胃），升麻（二分或三分，引胃气上腾而复其本位，便是行春升之令），柴胡（二分或三分，引清气，行少阳之气上升），白术（三分，降胃中热，利腰脐间血）

上件药，釜咀。都作一服，水二盏，煎至一盏，量气弱气盛，临病斟酌水盏大小，去渣，食远，稍热服。如伤之重者，不过二服而愈；若病日久者，以权立加减法治之。

【临证提要】本方乃补中益气汤与二陈汤合方，临床多用于月经量少，而带下量多，色白无臭，头晕心悸，苔白腻，脉滑缓。若痰湿胶腻难化者，可加炮南星、枳壳去瓤麸炒、滑石研细各 3 克，祛湿化痰力更胜。

【傅氏加味补中益气汤（补中益气汤与二陈汤合方）治肥胖不孕】杨学

畅某，女，34 岁，1990 年 3 月 15 日来诊，主诉：婚前月经正常，婚后日见身体发胖，月经一直推迟 2~3 个月来潮一次，经西医治疗 3~4 年，用黄体酮雌激素即来月经，如不用药 4 个月也不来 1 次月经，自感气短喘促，头晕乏力，嗜睡，心慌易饥，腰身肥胖，行走劳作困难，查心肝肾无异常，二便调，舌淡伴有齿痕，苔白腻，脉沉细。证属脾阳不振，水湿内停，阻遏气血，浸渍胞宫而致不孕，治宜健脾益气和胃化湿，药用人参 9g，黄芪 9g，柴胡 5g，甘草 5g，当归 10g，白术土炒 60g，升麻 1.5g，陈皮 2g，茯苓 15g，半夏 9g，服药 10 剂自觉尿多，服药 30 剂后小便改为正常，月经来潮量多，连服 2 个月后，喘促乏力嗜睡消失，活动灵便，并已怀孕，1994 年元月顺产一女婴。（实用医技杂志）

【临证提要】本方乃补中益气汤与二陈汤合方，临床多用于月经量少，而带下量多，色白无臭，头晕心悸，苔白腻，脉滑缓。若痰湿胶腻难化者，可加炮南星、枳壳去瓤麸炒、滑石研细各 3 克，祛湿化痰力更胜。

第八节 骨蒸夜热不孕

【原文】：妇人有骨蒸夜热，遍体火焦，口干舌燥，咳嗽吐沫，难于生子者。人以为阴虚火动也，谁知是骨髓内热乎。夫寒阴之地固不生物，而干旱之田岂能长养?然而骨髓与胞胎何相关切，而骨髓之热，即能使人不嗣，此前贤之所未言者也。山一旦创言之，不几为世俗所骇乎。而要知不必骇也，此中实有其理焉。盖胞胎为五脏外之一脏耳，以其不阴不阳，所以不列于五脏之中。所谓不阴不阳者，以胞胎上系于心包，下系于命门。系心包者通于心，心者阳也；系命门者通于肾，肾者阴也。是阴之中有阳，阳之中有阴，所以通于变化。或生

男或生女，俱从此出。然必阴阳协和，不偏不枯，始能变化生人，否则否矣。况胞胎既能于肾，而骨髓亦肾之所化也。骨髓热由于肾之热，肾热而胞胎亦不能不热。且胞胎非骨髓之养，则婴儿无以生骨。骨髓过热，则骨中空虚，惟存火烈之气，又何能成胎?治法必须清骨中之热。然骨热由于水亏，必补肾之阴，则骨热除，珠露有滴濡之喜矣。壮水之主，以制阳光，此之谓也。方用清骨滋肾汤。

清骨滋肾汤方：

地骨皮一两（酒洗），丹皮五钱，沙参五钱，麦冬五钱（去心），元参五钱（酒洗），五味子五分（炒研），白术三钱（土炒），石斛二钱。

水煎。连服三十剂而骨热解，再服六十剂自受孕。

傅山曰：此方之妙，补肾中之精，凉骨中之热，不清胞胎而胞胎自无太热之患。然阴虚内热之人，原易受妊，今因骨髓过热，所以受精而变燥，以致难于育子，本非胞胎之不能受精。所以稍补其肾，以杀其火之有余，而益其水之不足，便易种子耳。

注家曰：治骨髓热所以不用熟地，方极善。用者万勿加减。凡峻药病去七分即止，不必拘泥三十剂、六十剂之数。三元生人不一，余类推。

辩证依据：骨蒸夜热，遍体火焦，口干舌燥，咳嗽吐沫

【清骨滋肾汤骨蒸夜热不孕症】王大生：

马 x，女 25 岁，结婚 3 年未孕，几经妇科检查无异常。初诊：月事正常，惟量偏少；头晕沉、易怒、五心烦热，口干舌燥，常因烦热不能眠，即使冬日亦须将足伸出被外，夜间、经间尤甚，近有加重之势；舌红少津，脉细数。此为阴虚火旺所致。投以上方，连服 5 剂，病已减半。法守上方去知母、黄柏，加生黄 10 克。继服 10 剂，诸症皆失。嘱以“六味地黄丸”常服巩固疗效。3 个月后停经 50 天，且有恶心呕吐，经妇检及尿妊娠试验诊为早孕。后随访足月顺产 1 女婴。

按语：本案实为傅氏之“骨蒸夜热不孕症”。《傅青主男女科》说：“阴阳协和，不偏不枯，始能变化生人，否则难矣。况胞胎即通于肾，而骨髓亦肾之所化也，骨髓热由于肾之热，肾热而胞胎亦不能不热，且胞胎无骨髓之养则婴儿无以生骨。骨髓过热，则中空虚，惟存火烈之气，又何成胎。治法必须清骨中之热。”用其清骨滋肾汤更加知母、黄柏以助滋阴降火之力，由于药证相符，坚持治疗，终获良效。

【清骨滋肾汤骨蒸夜热不孕症医案】

胎小不孕高某，女，33 岁。婚后 7 年未孕，曾经两处地区医院妇科检查，其子宫体大似十一二岁幼女子宫，故诊为“先天性子宫发育不良”。多处就医，终未获效。1981 年夏，邀余诊治。诊其两颧如妆，躯体羸瘦。问诊言辄感头晕耳鸣。心烦善感，咽燥口干，月信后期，量少色紫，且时有盗汗。脉沉细而数，舌红绛无苔。投以猪花肠散合清骨滋肾汤加味治之。处方：地骨皮 10g，丹皮 15g，沙参 15g，麦冬 15g，玄参 15g，五味子 15g，白术 9g，石斛 6g，熟地黄 60g，陈皮 9g。每日 1 剂，水煎 1 次服，服时以药汁冲服猪花肠末 30g(即取猪之子宫一具，洗净焙干研末)。

服药 10 剂后，诸症略减，适逢月信来潮，量较前略增，色近正常，脉亦较前有力，舌呈红润，且略见薄白之苔。效不更方，仍以前方增损继服。前后共进药 45 剂，舌脉正常，诸症悉除，月经之期、色、量等亦均正常。嘱其停服汤药，继用猪花肠末，每日早晚各 15g，温开水冲服。服至第 3 个月，经妇查诊为早孕。后足月顺产一女。[林治虎.胞宫奇小不，山东中医杂志，1988，7(4)：47-48]。

【临证提要】此方多用于治疗不孕、不育、肺痨等症见五心烦热、潮热盗汗、口干舌燥、舌红苔薄、脉细数等一派阴虚内热之象的疾病。此方重在滋补肾阴，兼以清虚热。临床应用时忌苦寒直折以伐胃阴、滋腻之品以碍胃气。

【清骨滋肾汤骨蒸夜热不孕症医案】张婷婷：

排卵障碍性不孕属于中医“不孕症”范畴，中医认为“经本于肾”，肾气充盛，使肾中真阴化生天癸，脏腑精血得以充盈，任通冲盛，则女性行经受孕。若肾中真阴亏虚，故天癸乏源，进而使得血海空虚，胞宫失养而不孕；若肝肾精血不足亦可使阴虚生内热，热扰冲任致不孕。

王琪教授结合多年临床经验方选《傅青主女科》中清骨滋肾汤为基础方，并辩证加减，以治疗肾阴虚型排卵障碍性不孕，使患者形成成熟卵泡，排出，并受孕。

其基础方药为地骨皮、丹皮、玄参、沙参、麦冬、白术，五味子、石斛。病案举例：2019年01月15日初诊：杨某，女，31岁，职员，末次月经：2019年01月12日；患者未避孕4+年未孕，既往月经周期25-35天，经期3天，量少，色黯红，夹血块，平索眠差。感夜热盗汗，手足心热，口干舌燥，舌红苔黄脉细数。患者4+年前人工流产一次，输卵管造影试验双侧输卵管通畅，既往排卵监测最大卵泡为1，2*1，5em。今日查性激素正常，辩证为肾阴虚，选清骨滋肾汤原方，予地骨皮20g，牡丹皮10g，沙参10g，麦冬10g， 延胡索10g，五味子6g， 白术10g，石斛6g，共5付，水冲服，日2次，嘱患者月经第9天行排卵监测。

2019年01月20日二诊：患者诉月经量较前稍增加，色黯红，手足心热较前明显缓解，感腰骶部酸痛，舌红脉细数。予清骨滋肾汤加女贞子30g，巴戟天10g，淫羊崔10g，菟丝子10g，酸枣仁10g共7付，水冲服，日2次，2019年01月27日三诊：患者排卵监测右侧卵巢见成熟卵泡，大小约1.8*1.9cm，内膜0.7em，患者诉腰酸，感夜热，眠差，舌红脉滑数。予二诊原方去牡丹皮，石斛，加茯苓10g，柴胡10g，仙茅10g，倍酸枣仁，5付，水冲服，日2次。嘱患者同房。连续调理3个月经周期后，排卵监测卵泡大小1.9*1.9cm.内膜1.2cm，嘱患者同房，次月月经未来潮。LMP：3月17日，停经40天查血HCC(4月26日)：21 700mIU/mL.B超示宫内早孕。

辩证思路分析：患者人流术后4+年不孕，夜热汗出，舌红脉细数，属肾阴虚型不孕，初诊时为月经第3天，因患者月经量少，且夜热汗出，故查性激索排出卵巢早衰后，予清骨滋肾汤原方5付以滋阴清热，活血调经。二诊时患者虚热症状减轻，为经后期，阴生的重要时期，益滋肾填精故原方加女贞子、巴戟天、淫羊翟、菟丝子；并加酸枣仁以助睡眠，嘱患者监测排卵。三诊时患者见成熟卵泡，为重阴转阳，排卵受孕时期，故原方去活血之品牡丹皮，去性寒之品石斛；加茯苓助白术以健脾，并去滋阴药物滋腻之性，使后天之本化生有源；加柴胡取其疏肝解郁之性以助脾胃，调达肝气；加仙茅以使阴得阳助以转化阴阳。

第九节 腰酸腹胀不孕

【原文】：妇人有腰酸背楚，胸满腹胀，倦怠欲卧，百计求嗣不能如愿。人以为腰肾之虑也，谁知是任督之困乎。夫任脉行于前，督脉行于后，然皆从带脉之上下而行也。故任脉虚则带脉坠于前，督脉虚则带脉坠于后，虽胞胎受精亦必小产。况任督之脉既虚，而疝瘕之症必起。疝瘕碍胞胎而外障，则胞胎缩于疝瘕之内，往往精施而不能受。虽饵以玉燕，亦何益哉！治法必须先去其疝瘕之病，而补其任督之脉，则提挚天地，把握阴阳，呼吸精气，包裹成形，力足以胜任而无虞矣。外无所障，内有所容，安有不能生育之理！方用升带汤。

升带汤方：

白术一两（土炒），人参三钱，沙参五钱，肉桂一钱（去粗研），荸荠粉三钱，鳖甲三钱（炒）茯苓三钱，半夏一钱（制）神曲一钱（炒）

水煎。连服三十剂，而任督之气旺。再服三十剂，而疝瘕之症除。

傅山曰：此方利腰脐之气，正升补任督之气也。任督之气升，而疝瘕自有难容之势。况方中有肉桂以散寒，荸荠以祛积，鳖甲之攻坚，茯苓之利湿，有形自化于无形，满腹皆升腾

之气矣。何至受精而再坠乎哉！

注家曰：此方为有疝瘕而设，故用沙参、荸荠粉，鳖甲以破坚理气。若无疝瘕，去此三味加杜仲一钱半（炒黑）、泽泻一钱半〔炒），甘枸杞二钱，三味服之，腰酸腹胀自除矣。鳖甲破气，不可误服。荸荠粉又叫马蹄粉。

【功用】消疝除瘕，健脾益气。

【主治适应症】妇人有腰酸背楚，胸满腹胀，倦怠欲卧，百计求嗣不能如愿。

【方解】方中肉桂以温经散寒，荸荠以祛积，鳖甲之攻坚，党参、白术、沙参益气，茯苓、半夏、神曲健脾渗湿，全方攻补兼施，使疝瘕除而脾气健运。

【升带汤医案】

卵泡未破裂黄素化综合征史建辉等采用升带汤为主辨证加减观察其治疗卵泡未破裂黄素化综合征的效果，结果示28例克罗米酚促排卵周期发病者排卵率77.1%，妊娠率42%，无效率22.9%，12例自然月经周期发病者排卵率76.7%，妊娠率42.6%，无效率23.3%，结论：升带汤为主治卵泡未破裂黄素化综合征确实有效。正史建辉，李国臣，王秀霞.升带汤为主治疗卵泡未破裂黄素化综合征40例.浙江中医杂志，2008，43(2)：98]。

【升带汤慢性盆腔炎医案】

刘某，女，32岁。2003年2月11日就诊。下腹坠痛2个月，月经正常。舌质稍黯，苔薄白，脉细弦。妇科检查：子宫后位大小正常左附件区扪及一约5cmx4cm大小包块， 活动欠佳， 压痛明显， 右附件区增厚、压痛。彩超示：左附件区5.5cmx 3.8cm混合性包块。诊断：左附件区炎性包块。予以青霉素640万U，每日2次，甲硝唑250mL，每日2次，静脉滴注，用药7日后复查，盆腔包块无明显缩小，遂予加味升带汤治疗。1个疗程后患者腰腹痛消失，包块缩减为2.5cmx 1.8cm， 继服2个疗程后妇科检查及彩超均示包块消失，随访6个月无复发。加味升带汤：炒白术30g，人参9g，肉桂3g(后下)，茯苓9g，制半夏9g，沙参15g，连翘15g，丹参15g，延胡索12g，木香6g。加减：腰酸腹胀者加杜仲15g、泽泻9g、枸杞子15g；有包块者加鳖甲9g、神曲6g。每日1剂，分早晚2次，饭前30分钟温服。药渣加适量醋调匀，热敷下腹部。10日为1疗程，连服2个疗程，有包块者服3个疗程。[韩颜华，韩艳荣.加味升带汤治疗慢性盆腔炎156例：河北中医，2006.28(1)：27]。

【临证提要】傅青主在此篇中专门提出了腹中有**疝瘕”的病证，在西医学中多用此方治疗妇科炎性肿块、囊肿等疾病。此方在治疗这类疾病力量稍弱，应配以其他药物共同治疗方可达到良效。临证加减：腰酸腹胀者加杜仲、泽泻、枸杞子；有包块者加鳖甲、神曲。

第十节 便涩腹胀足浮肿不孕

【原文】：妇人有小水艰涩，腹胀脚肿，不能受孕者。人以为小肠之热也，谁知是膀胱之气不化乎。夫膀胱原与胞胎相近，膀胱病而胞胎亦病矣。然水湿之气必走膀胱，而膀胱不能自化，必得肾气相通，始能化水，以出阴器。倘膀胱无肾气之通，则膀胱之气化不行，水湿之气必且渗入胞胎之中，而成汪洋之势矣。汪洋之田，又何能生物也哉?治法必须壮肾气以分消胞胎之湿，益肾火以达化膀胱之水。使先天之本壮，则膀肮之气化；胞胎之湿除，而汪洋之田化成雨露之壤矣。水化则膀胱利、火旺则胞胎暖，安有布种而不发生者哉！方用化水种子汤。

化水种子汤方：

巴戟一两（盐水浸），白术一两（土炒），茯苓五钱，人参三钱，菟丝子五钱（酒炒），芡实五钱（炒），车前二钱（酒炒），肉桂一钱（去粗研）

水煎服。二剂膀胱之气化，四剂难涩之症除，又十剂虚胀脚肿之病形消。再服

六十剂，肾气大旺，胞胎温暖易于受胎而生育矣。

傅山曰：此方利膀胱之水，全在补肾中之气。暖胞胎之气，全在壮肾中之火。至于补肾之药，多是濡润之品，不以湿而益助其湿乎?然方中之药，妙于补肾之火，而非补肾之水，尤妙于补火而无燥烈之虞，利水而非荡涤之猛。所以膀胱气化，胞胎不湿，而发荣长养无穷与。

注家曰：便涩、腹胀、足浮肿，此病极多。不惟不能受孕，抑且渐添杂症，久而不愈，甚有成劳瘵摄不治者。此方补水而不助湿，补火而使归原，善极，不可加减一味。若无好肉桂，以破故纸一钱（炒）代之。用核桃仁二个，连皮烧黑去皮，用仁作引。若用好肉桂，即可不用核桃引。

【作用与功效】温肾化阳，健脾利水。

【主治适应症】妇人有小水艰涩，腹胀脚肿，不能受孕者。

【方解】方中巴戟天、肉桂温补肾阳，一则补先天不足，二则助膀胱气化利水，去除胞宫水湿；白术、茯苓、人参健脾补气；菟丝子补肾益精；芡实健脾补肾，固涩肾精；再以少量车前子利水渗湿，共达利湿补脾肾，化水祛湿之效。

【化水种子汤医案】

不孕刘某某，女，26 岁。婚后 5 年未孕，经哲里木盟某医院检查，夫妇双方均无生理缺陷。患者每于经行前下肢浮肿，小便涩痛，腰痛腹胀，不思饮食，受凉饮冷后诸证加重，月经按期，但量多，色淡不染衣，曾四方求医，服药治疗，终未受孕。1980 年 10 月 9 日来我科求诊。检查：面色灰暗虚浮、形寒畏冷、四肢不温、胫骨前缘按之有压痕，舌质淡，苔白滑，脉沉迟无力。证属脾肾阳气不足，膀胱气化不行，寒水停聚胞宫，故而不孕。治宜温肾助阳、健脾化湿。方用化水种子汤加味：巴戟天 30g(盐水浸)，焦术 30g，茯苓 15g，芡实 15g，肉桂 5g，党参 20g，车前子 6g，菟丝子 15g(酒炒)，附子 3g，鹿角粉 15g，补骨脂 9g，水煎服。上方服 5 剂后，面色转红润，手足温暖，小便畅利，腹胀消失，饮食增加。效不更方，前方又服 5 剂，诸症消失，舌脉正常，续用前方 3 剂为末，蜜制为丸，朝夕吞服，3 个月后，受孕足月顺生一女婴。[孙海廷.化水种子汤临床应用.内蒙古中医药，1987，(2)：42-43]。

【化水种子汤医案】

习惯性小产关某某，女，27 岁。患者结婚 5 年，受孕 4 次，前 3 次怀孕均不满 6 个月而小产，每次怀孕 3 个月后，逐渐出现腰酸腹胀，小溲涩痛，下肢浮肿，继则阴道流出大量黄色水液而小产，每次都请医生诊断治疗，均未获效。1985 年 6 月 10 日，患者第四次怀孕将近 3 个半月，又出现小产先兆症状， 来我科求诊。检查血压 100/70mmHg， 面色灰暗， 呼吸迫促， 下肢浮肿，以指按之，凹痕不起，舌胖、质淡、苔白滑，脉沉微。证属脾肾虚寒，膀胱之气化不行，水湿渗人胞胎之中。治宜速去胞胎之水以治其标，兼予温肾健脾以固其本。方用化水种子汤加味：巴戟天 30g、焦术 30g、茯苓 20g、党参 15g、菟丝子 20g、芡实 15g、车前子 12g、肉桂 3g、续断 10g、桑寄生 10g，水煎服。服 3 剂后，小漫畅利，下肢肿消大半，腹胀亦减。上方又服 3 剂，诸证悉除，面色红润，饮食倍增。原方去车前子、肉桂，加阿胶 12g、黄芪 12g，继服 3 剂，以巩固疗效而停药。经随访得知，患者于 1985 年 11 月 22 日，顺生一男，母婴均健。[孙海廷.化水种子汤临床应用.内蒙古中医药，1987，(2)：43]。

【化水种子汤医案】

水肿廖某，男，40 岁，1999 年 9 月初诊。患者水肿反复发作 3 年余。经市某医院诊为慢性肾炎，以中西医治疗未愈。近半年来全身浮肿以下腹为甚，小便量少，色黄，气短，四肢乏力，腰酸，纳少，腹胀便溏。诊见：颜面虚浮，面色晦白，手足欠温，舌淡胖、苔白滑，脉沉缓无力。体检：下肢凹陷性浮肿(++)，腹部移动性浊音(+)，心、肺、肝、脾、神经系统均正常。尿常规：蛋白(+++)，白细胞 3~5，红细胞 5~10，颗粒管型 1~2，肾功能检查无异常。证属脾肾阳虚，水湿泛滥。治宜温肾健脾，化湿利水。方拟化水种子汤加减。处方：巴戟天、白术、大腹皮各 30g，茯苓、党参、菟丝子、防己、益母草各 15g，炒车前子、黄芪各 20g，

肉桂 3g，连服 5 剂，浮肿较前消退，精神、食欲好转，尿量增，腰痛减。复查：尿蛋白(++)，红细胞 3~5，颗粒管型 1~2。仍守前方再服 5 剂，药后水肿大部分消退，诸症均减，纳增，仍有腹胀。尿常规：蛋白(+)，红细胞 0~2，管型(一)，面色晦暗，四肢转温，大便成形，舌淡红、苔薄白，脉缓。守前方加陈皮 10g，再进 10 剂，尿蛋白(±)，余正常。嘱继用龟鹿补肾丸、六味地黄丸交替服 3 个月，以调理善后而愈。[罗秀兰.化水种子汤新用.新中医，2001.33(12)：62]。

【化水种子汤医案】

子气黄某，24 岁，2000 年 7 月初诊。患者孕 7 个月，近日精神疲倦，食欲不振，腰膝酸软，尿少，双下肢浮肿，无眩晕。诊见：面色苍白，眼睑浮肿，双下肢凹陷性浮肿(++)，四肢欠温，舌淡胖、苔白，脉沉缓。BP 120/82mmHg。中医诊为子气， 证属脾肾阳虚。治宜温肾利水， 健脾祛湿。拟化水种子汤加减。处方：巴戟天 15g，白术、大腹皮、党参、茯苓皮各 30g，菟丝子、炒芡实各 15g，肉桂 3g，生姜 3 片。每天 1 剂，水煎服。服 3 剂基本消肿，食欲好转，效不更方，续服 3 剂而愈。9 月底顺产一子，母子平安。[罗秀兰.化水种子汤新用.新中医，2001，33(12)：621

【化水种子汤医案】

带下白某，32 岁，2000 年 12 月初诊。患者身体羸弱，消瘦，近 3 个月来觉疲乏，形寒肢冷，腰膝酸软无力，白带多，质稀水样，每天需用护垫，微臭，纳呆，大便烂。妇检为慢性宫颈炎，宫颈肥大，子宫颈Ⅱ度糜烂。经用抗生素等及局部用药、冲洗治疗，复查子宫颈仍Ⅰ度糜烂，近日白带又多如前，要求中药治疗。诊见：面色苍黄，精神疲倦，眼睑浮肿，纳差，舌淡胖有齿印、苔白滑，脉缓无力。证属脾肾阳虚，寒湿下注。治宜温补肾阳，健脾祛湿止带。方拟化水种子汤加减。处方：巴戟天、菟丝子、苍术、狗脊各 15g，白术、茯苓、党参、大腹皮各 30g，升麻、陈皮各 10g，肉桂(后下)3g。服 3 剂，白带减少，稍稠，食欲好转，大便成形。效不更方，再进 3 剂，白带明显减少，无臭味，不需用护垫，守方加减再进 3 剂。自觉精神好转，怕冷、腰酸均减，白带趋正常。妇检：子宫颈轻度糜烂。守方服 5 剂以巩固疗效。[罗秀兰.化水种子汤新用.新中医，2001，33(12)：62]。

【临证提要】傅山应用此方治疗“妇人有小水艰涩，腹胀脚肿，不能受孕者”，此方以温肾化阳、健脾利水为法，还可应用于其他疾病，如带下病、肾病等。此方应用广泛，凡是水液代谢问题属脾肾阳虚、水湿内停的均可考虑使用。

女科下卷

第五章　妊娠

第一节 妊娠恶阻

【原文】：妇人怀娠之后，恶心呕吐，思酸解渴，见食憎恶，困倦欲卧，人皆曰妊娠恶阻也，谁知肝血太燥乎！夫妇人受妊，本于肾气之旺也，肾旺是以摄精，然肾一受精而成娠，则肾水生胎，不暇化润于五脏；而肝为肾之子，日食母气以舒，一日无津液之养，则肝气迫索，而肾水不能应，则肝益急，肝急则火动而逆也；肝气既逆，是以呕吐恶心之症生焉。呕吐纵不至太甚，而其伤气则一也。气既受伤，则肝血愈耗，世人用四物汤治胎前诸症者，正以其能生肝之血也。然补肝以生血，未为不佳，但生血而不知生气，则脾胃衰微，不胜频呕，犹恐气虚则血不易生也。故于平肝补血之中，加以健脾开胃之品，以生阳气，则气能生血，尤益胎气耳。或疑气逆而用补气之药，不益助其逆乎！不知妊娠恶阻，其逆不甚，且逆是因虚而逆，非因邪而逆也。因邪而逆者，助其气则逆增；因虚而逆者，补其气则逆转。况补气於补血之中，则阴足以制阳，又何虑其增逆乎！宜用顺肝益气汤。

亦有肝郁气滞，胸膈膨闷，见食不恶，不能多食，虽系妊娠而非恶阻，宜分别治之。后另有方。

妊娠恶阻方：

人参一两，当归一两（酒洗），苏子一两（炒研），白术三钱（土炒），茯苓二钱，熟地五钱（九蒸），白芍三钱（酒炒），麦冬三钱（去心），陈皮三分，砂仁一粒（烘研），神曲一钱（炒）

水煎。服一剂轻，二剂平，三剂全愈。

傅山曰：此方平肝则肝逆除，补肾则肝燥息，补气则血易生。凡胎病而少带恶阻者，俱以此方投之无不安，最有益於胎妇，其功更胜於四物焉。

注家曰：方极效。但苏子一两，疑是一钱之误。然国初上元生人。禀赋最壮。或非用两不效。今当下元，用一钱可也。万不可用一两。

疏肝化滞汤方：

全当归（酒洗）六钱，杭芍（酒炒）三钱，党参（去芦）三钱、白扁豆（去皮）四钱，云苓二钱，香附（炒焦）二钱，砂仁（炒，研）钱半，条苹（炒焦）八分，神曲（炒焦）钱半。广皮八分，薄荷六分，甘草五分。

水煎服。

第二节 妊娠浮肿

【原文】：妊妇有至五个月，肢体倦怠，饮食无味，先两足肿，渐至遍身头面俱肿，人以为湿气便然也，谁知是脾肺气虚乎！夫妊娠虽有按月养胎之分，其实不可拘于月数，总以健脾补肺为大纲。

盖脾统血，肺主气，胎非血不荫，非气不生，脾健则血旺而荫胎，肺清则气旺而生子。苟肺衰则气馁，气馁则不能运气于皮肤矣；脾虚则血少，血少则不能运血于肢体矣。气与血两虚，脾与肺失职，所以饮食难消，精微不化，势必至气血下陷，不能升举，而湿邪即乘其所虚之处，积而成浮肿症，非由脾肺之气血虚而然耶。治法当补其脾之血与肺之气，不必祛湿，而湿自无不去之理。方用加减补中益气汤。

加减补中益气汤方：

人参五钱，黄耆三钱（生用），柴胡一钱，甘草一分，当归三钱（酒洗），白术五钱（土炒）茯苓一两，升麻三分，陈皮三分

水煎。服四剂即愈，十剂不再犯。

傅山曰：夫补中益气汤之立法也，原是升提脾肺之气，似乎益气而不补血，然而血非气不生，是补气即所以生血。观当归补血汤用黄耆为君，则较着彰明矣。况湿气乘脾肺之虚而相犯，未便大补其血，恐阴太盛而招阴也。只补气而助以利湿之品，则气升而水尤易散，血亦随之而生矣。然则何以重用茯苓而至一两，不凡以利湿为君乎？磋！磋！湿症而不以此药为君，将以何者为君乎！况重用茯苓於补气之中，虽曰渗湿，而仍是健脾清肺之意。且凡利水之品，多是耗气之药，而茯苓与参术合，实补多於利，所以重用之以分湿邪，即以补气血耳。

注家曰：白术一味，今多以苍术充之，凡白术伪者更多。白术补胎，苍术打胎，用者宜审。若恐其伪，以白扁豆、山药代之较妥。

第三节 妊娠少腹疼

【原文】：妊娠少腹作疼，胎动不安，如有下堕之状，人只知带脉无力也，谁知是脾肾之亏乎；夫胞胎虽系于带脉，而带脉实关于脾肾。脾肾亏损，则带脉无力，胞胎即无以胜任矣。况人之脾肾亏损者，非饮食之过伤，即色欲之太甚。脾肾亏则带脉急，胞胎所以有下坠之状也。然则胞胎之系，通于心与肾，而不通于脾，补肾可也，何故补脾？然脾为后天，肾为先天，脾非先天之气不能化，肾非后天之气不能生，补肾而不补脾，则肾之精何以遽生也，是补后天之脾，正所以补先天之肾也；补先后二天之脾与肾，正所以固胞胎之气与血，脾肾可不均补乎！方用安奠二天汤。

安奠二天汤方：

人参一两（去芦），熟地一两（九蒸），白术一两（土炒），山药五钱（炒），炙草一钱，山萸五钱（蒸，去核），杜仲三钱（炒黑），枸杞二钱，扁豆五钱（炒去皮）

水煎。服一剂而疼止，二剂而胎安矣。

傅山曰：夫胎动乃脾肾双亏之症，非大用参、术、熟地补阴补阳之品，断不能挽回於顷刻。世人往往畏用参术或少用，以冀建功，所以寡效。此方正妙在多用也。

注家曰：人参一两，或以党参代之，无上党参者，以嫩黄耆代之。

第四节 妊娠口干咽疼

【原文】：妊妇至三四个月，自觉口干舌燥，咽喉微痛，无津以润，以至胎动不安，甚则血流如经水，人以为火动之极也，谁知是水亏之甚乎；夫胎也者，本精与血之相结可成，逐月养胎，古人每分经络，其实均不离肾水之养，故肾水足而胎安，肾水亏而胎动。虽然肾水亏又何能动胎，必肾经之火动，而胎始不安耳。然而火之有余，仍是水之不足，所以火炎而胎必动，补水则胎自安，亦所济之义也。惟是肾水不能逮生，必须滋补肺金，金润则能生水，而水有逢源之乐矣。水既有源泉混混；而火又何难制乎。再少加以清热之品，则胎自无不安矣。方用润燥安胎汤。

润燥安胎汤方：

熟地一两（九蒸），生地三钱（蒸），炒山萸肉五钱（蒸），麦冬五钱（去心），五味一钱（炒），阿胶二钱（蛤粉炒），黄芩二钱（酒炒），益母二钱

水煎。服二剂而燥息，再二剂而胎安。连服十剂，而胎不再动矣。

傅山曰：此方专填肾中之精，而兼补肺。然补肺仍是补肾之意，故肾经不干燥，则火不能灼，胎焉有不安之理乎！

注家曰：方极妙，用之立应。万不可因咽病而加豆根，射干等药；亦不可因过润而加云苓。

【作用与功效】补肺滋肾，润燥安胎。

【主治适应症】妊妇至三四个月，自觉口十舌燥，咽喉微痛，无津以润，以至胎动不安，甚则血流如经水。

【方解】二地滋阴养血；麦门冬、阿胶滋阴润肺；五味子滋肾生津；山茱萸补肾填精；黄芩清热以安胎；益母草祛瘀生新，防热邪煎熬阴血而成瘀；全方滋肾润肺，使之水足燥息而胎安。

第四节 妊娠吐泻腹疼

【原文】：妊妇上吐下泻，胎动欲堕，腹疼难忍，急不可缓，此脾胃虚极而然也。夫脾

胃之气虚，则胞胎无力，必有崩坠之虞。况又上吐下泻，则脾与胃之气，因吐泻而愈虚，欲胞胎之无恙也得乎！然胞胎疼痛而究不至下坠者，何也？全赖肾气之固也。胞胎系于肾而连于心，肾气固则交于心，其气通于胞胎，此胞胎之所以欲坠而不得也。且肾气能固，则阴火必来生脾；心气能通，则心火必来援胃，脾胃虽虚而未绝，则胞胎虽动而不堕，可不急救其脾胃乎！然脾胃当将绝而未绝之时，只救脾胃而难遽生，更宜补其心肾之火，使之生土，则两相接续，胎自固而安矣。方用援土固胎汤。

援土固胎汤方：

人参一两，白术二两（土炒），山药一两（炒），肉桂二钱（去粗研）制附子五分，续断三钱，杜仲三钱（炒黑），山萸一两，蒸，去核）枸杞三钱，菟丝子三钱（酒炒）砂仁三粒（炒研），炙草一钱，

水煎。服一剂而泄止，二剂而诸病尽愈矣。

傅山曰：此方救脾胃之土十之八，救心肾之火十之二也。救火轻於救土者，岂以土欲绝而火未甚衰乎？非也。盖土崩非重剂不能援，火衰虽小剂而可助，热药多用，必有太燥之虞，不比温甘之品也。况胎动系土衰而非火弱，何用太热。妊娠忌桂附，是恐伤胎，岂可多用。小热之品，计之以钱，大热之品，计之以分者，不过用以引火，而非用以壮火也。其深思哉！

注家曰：白术多伪，肉桂更无佳者。用者若有真药固妙，如无真药，白术以白扁豆代之，肉桂以破故纸代之。

第五节 妊娠子悬胁疼

【原文】：妊妇有怀抱忧郁，以致胎动不安，两胁闷而疼痛，如弓上弦，人止知是子悬之病也，谁知是肝气不通乎！夫养胎半系于肾水，然非肝血相助，肾水实有独力难支之势。故保胎必滋肾水，而肝血断不可不顾，使肝气不郁，则肝之气不闭，而肝之血必旺，自然灌慨胞胎，合肾水而并协养胎之力。今肝气因忧郁而闭塞，则胎无血荫，肾难独任，而胎安得不上升以觅食，此乃郁气使然也。莫认为子之欲自悬，而妄用泄子之品，则得矣。治法宜开肝气之郁结，补肝血之燥干，则子悬自定矣。方用解郁汤。

解郁汤方：

人参一钱，白术五钱（土炒）白茯苓三钱，当归一两（酒洗）白芍一两（酒炒），枳壳五分（炒）砂仁三粒（炒研），山栀子三钱（炒）薄荷二钱

水煎。服一剂而闷痛除，二剂而子悬定，至三剂而全安。

傅山曰：去栀子，再多服数剂不复发。此乃平肝解郁之圣药，郁开则木不克，土，肝平则火不妄动。方中又有健脾开胃之品，自然水精四布，而肝与肾有润泽之机，则胞胎自无干燥之患，又何虑上悬之不愈哉！

注家曰：方加薏仁三、四钱，尤妙。

第六节 妊娠跌损

【原文】：妊妇有失足跌损，致伤胎元，腹中疼痛，势如将堕者，人只知是外伤之为病也，谁知有内伤之故乎！凡人内无他症，胎元坚固，即或跌扑闪挫，依然无恙。惟内之气血素亏，故略有闪挫，胎便不安。若止作闪挫外伤治，断难奏功，且恐有因治而反堕者，可不慎与！必须大补气血，而少加以行瘀之品，则瘀散胎安矣。但大补气血之中，又宜补血之品多于补气之药，则无不得之。方用救损安胎汤。

救损安胎汤方：

当归一两（酒洗），白芍三钱（酒炒），生地一两（酒炒），白术五钱（土炒）炙草一钱，人参一钱，苏木三钱，捣碎），乳香一钱（去油）没药一钱（去油）

水煎。服一剂而疼痛止，二剂而势不下坠矣，不必三剂也。

傅山曰：此方之妙，妙在既能祛瘀而不伤胎，又能补气补血，而不凝滞，周无通利之害，亦痊跌闪之伤，有益无损，大建奇功，即此方与。然不特治怀孕之闪挫也，即无娠闪挫，亦可用之。

注家曰：即用寻常白术（土炒）焦最妙，以其能理气行血也。於白术味过甘，不能理气行血，用者知之。

第七节 妊娠小便下血病名胎漏

【原文】：妊妇有胎不动腹不疼，而小便中时常有血流出者，人以为血虚胎漏也，谁知气虚不能摄血乎！夫血只能荫胎，而胎中之荫血，必赖气以卫之，气虚下陷，则荫胎之血亦随气而陷矣。然则气虚下陷，而血未尝虚，似不应与气同陷也。不知气乃血之卫，血赖气以固，气虚则血无凭依，无凭依必燥急，燥急必生邪热；血寒则静，血热则动，动则外出而莫能遏，又安得不下流乎！倘气不虚而血热，则必大崩，而不止些微之漏矣。治法宜补其气之不足，而泄其火之有余，则血不必止而自无不止矣。方用助气补漏汤。

助气补漏汤方：

人参一两，白芍五钱（酒炒）黄芩三钱（酒炒）黑），生地三钱（酒炒）黑）益母草一钱，续断二钱，甘草一钱，

水煎。服一剂而血止，二剂再不漏矣。

傅山曰：此方用人参以补阳气，用黄芩以泄阴火。火泄则血不热而无欲动之机，气旺则血有依而无可漏之窍，气血俱旺而和协，自然归经而各安其所矣，又安有漏泄之患哉！

注家曰：补血不用当归妙，以当归之香燥也。，

第八节 妊娠子鸣

【原文】：妊妇怀胎至七八个月，忽然儿啼腹中，腰间隐隐作痛，人以为胎热之过也，谁知是气虚之故乎！治宜大补其气，方用扶气止啼汤。

扶气止啼汤方：

人参一两，黄耆一两（生用）麦冬一两（去心），当归五钱（酒洗），橘红五分，甘草一钱，花粉一钱

水煎。服一剂而啼即止，二剂不再啼。此方用人参、黄耆、麦冬以补肺气，使肺气旺，则胞胎之气亦旺，胞胎之气旺，则胞中之子气有不随母之气以为呼吸者，未之有也。（黄耆用嫩黄耆，不可用箭耆，箭耆系北口外苜蓿根。），

第九节 妊娠腰腹疼渴汗燥狂即子狂

【原文】：妇人怀妊，有口渴汗出，大饮冷水，而烦躁发狂，腰腹疼痛，以致胎欲堕者，人莫不谓火盛之极也，抑知是何经之火盛乎？此乃胃火炎炽，熬煎胞胎之水，以致胞胎之水涸，胎失所养，故动而不安耳。

夫胃为水谷之海，多气多血之经，所以养五脏六腑者，盖万物皆生于土，土气厚而物始生，土气薄而物必死。然土气之所以能厚者，全赖火气之来生也；胃之能化水谷者，亦赖火气之能化也。今胃中有火，宜乎生土，何以火盛而反致害乎？不知无火难以生土，而火又多能烁水。虽土中有火土不死，然亦必有水方不燥；使胃火太旺，必致烁干肾水，土中无水，则自润不足，又何以分润胞胎；土烁之极，火势炎蒸，犯心越神，儿胎受逼，安得不下坠乎！经所谓“二阳之病发心脾”者，正此义也。治法必须泄火滋水，使水气得旺，则火气自平，火平则汗、狂、燥、渴自除矣。方用息焚安胎汤。

息焚安胎汤方：

生地一两（酒炒），青篙五钱，白术五钱（土炒），茯苓三钱，人参三钱，知母二钱，花粉二钱。

水煎。服一剂而狂少平，二剂而狂大定，三剂而火尽解，胎亦安矣。

傅山曰：此方药料颇重，恐人虑不胜，而不敢全用，又不得不再为嘱之。怀胎而火胜若此，非大剂何以能蠲，火不息则狂不止，而胎能安耶！况药料虽多，均是滋水之味，益而无损，勿过虑也。

注家曰：原方不可加减。妊娠燥狂，每误有别症，不曰痰甚，即云时疫传经，而置妊娠于不问。误服多药，数月不愈。甚有打胎而顾大人性命为名者，更属糊涂之极！）

【青篙】：味苦、辛，性寒。归归肝、胆经。功效：清虚热，除骨蒸，解暑热，截疟，退黄。用于温邪伤阴，夜热早凉，阴虚发热，骨蒸劳热，暑邪发热，疟疾寒热，湿热黄疸等病症的治疗。

【相关医论】

1、治暑毒热痢：青蒿叶一两，甘草一钱。水煎服。（《圣济总录》）

2、治虚劳，盗汗、烦热、口干：青蒿一斤。取汁熬膏，入人参末、麦冬末各一两，熬至可丸，丸如梧桐子大。每食后米饮下二十丸。（《圣济总录》青蒿丸）

3、治温病夜热早凉，热退无汗，热自阴来者：青蒿二钱，鳖甲五钱，细生地四钱，知母二钱，丹皮三钱。水五杯，煮取二杯，日再服。（《温病条辨》青蒿鳖甲汤）

4、治劳瘦：青蒿嫩者（细锉）一升，以水三升，童子小便五升。同煎成膏，丸如梧桐子大。每服十丸，温酒下，不以时。（《鸡峰普济方》青蒿煎）

【息焚安胎汤方方解】网文：

【辩证】妊娠胎动不安，腰腹疼痛，喜饮冷水，汗出烦躁，甚则发狂，舌质红，苔黄而燥，脉细滑数。

【加减】如胸闷心烦较甚者，加黄芩、竹茹以清热除烦安胎；如伴阴道下血者，加阿胶、艾炭养阴止血；如肾水偏亏而见腰酸、咽干、五心烦热者，加旱莲草、女贞子、麦冬，并改生地黄为熟地黄以滋养肾阴；如胃热偏盛而见烦渴引饮、躁动不安者，加黄连、黄芩以清热安胎；如虚火偏盛者，加黄柏、地骨皮以降火退热。

【方论】方中人参益气生津以养胎，白术扶脾以统血，生地、青蒿以清热凉血，滋肾水而养阴，茯苓宁心安神，知母清肺胃上焦之火，伍花粉以养阴润燥生津。诸药合用，共奏泄火滋水之功，水旺则火衰，则妊娠烦渴狂躁之症可除矣。

【医论】妊娠烦闷不安，郁郁不乐，或烦躁易怒，称为“子烦”亦称“妊娠心烦”。《经效产宝》有“妊娠常苦烦闷，此是子烦”的记载。关于病因，如《沈氏女科辑要笺正》云：“子烦病因，曰痰，日火，日阴亏。”《妇科玉尺》曰：“平素有火之人，内外之火相感，作烦躁闷乱不安者，名曰子烦。”傅青主认为本病是由妊娠素体阴虚，致使五脏火旺，血液聚于养胎，水阴自奉不足，故烦狂不安，肝肾之阴亏乏，胃火烁极，火势炎蒸，犯心越神，儿胎受逼，安得不下坠乎?经所谓“二阳之病发心脾”。“子烦”一症相当于现代医学之先兆子痫，临症之时应根据症状、体征慎重治之。

【息焚安胎汤方治妊娠期心中烦乱口渴夜不成寐验案】网文：

赵 xx，女，36 岁。1986 年 5 月 14 日初诊。病史：妊娠 5 个月，时有心中烦乱，口渴，夜不成寐，现为第 2 胎(曾连续流产 2 次)。近七八天来，心中烦乱，不时发作，并有头痛、心悸、口渴、心下痞满等。舌红苔白而干，脉细滑数。辨证：胃阴不足，胎热上乘。治则：滋阴清热，方用息焚安胎汤加减：生地 30 克，青蒿 15 克，白术 15 克，茯苓 9 克，党参 9 克，知母 6 克，花粉 6 克，竹叶 3 克。水煎服，每日 1 剂，5 剂。二诊：心烦、失眠、口渴均明显减轻，续服 5 剂而愈。

第十节 妊娠中恶

【原文】：妇人怀子在身，痰多吐涎，偶遇鬼神祟恶，忽然腹中疼痛，胎向上顶。人疑为子悬之病也，谁知是中恶而胎不安乎。大凡不正之气，最易伤胎。故有孕之妇，断不宜入庙烧香与僻静阴寒之地，如古洞幽岩，皆不可登。盖邪祟多在神宇潜踪，幽阴岩洞亦其往来游戏之所，触之最易相犯，不可不深戒也。况孕妇又多痰饮，眼目易眩，目一眩如有妄见，此招祟之因痰而起也。人云怪病每起于痰，其信然与。治法似宜以治痰为主，然治痰必至耗气，气虚而痰难消化，胎必动摇。必须补气以生血，补血以活痰，再加以清痰之品，则气血不亏，痰亦易化矣。方用消恶安胎汤。

消恶安胎汤
当归一两（酒洗），白芍一两（酒洗）白术五钱（土炒），茯苓五钱，人参三钱，甘草一钱，陈皮五分，花粉三钱，苏叶一钱，沉香一钱（研末）
此方大补气血，辅正邪自除之义也。

注家曰：辅正逐邪，方极平正。如此可知，金石之药以化痰者，皆矜奇立异，欲速取效，不知暗耗人之真气。戒之！）。

第十一节 妊娠多怒堕胎

【原文】：妇人有怀妊之后，未至成形，或已成形，其胎必堕，人皆曰气血衰微，不能固胎也，谁知是性急怒多，肝火大动而不静乎！夫肝本藏血。肝怒则不藏，不藏则血难固。盖肝虽属木，而木中实寄龙雷之火，所谓相火是也。相火宜静不宜动，静则安，动则炽。况木中之火，又易动而难静。人生无日无动之时，即无日非动火之时。大怒则火益动矣，火动而不可止遏，则火势飞扬，不能生气养胎，而反食气伤精矣；精伤财胎无所养，势必不坠而不已。经所谓“少火生气，壮火食气”，正此义也。治法宜乎其肝中之火，利其腰脐之气，便气生失血而血清其火，则庶几矣。方用利气泄火汤。

利气泄火汤
人参三钱，白术一两（土炒）甘草一钱，熟地五钱（九蒸）当归三钱（酒洗），白芍五钱（酒炒）芡实三钱（炒），黄芩二钱（酒炒）
水煎。服六十剂而胎不坠矣。此方名虽利气而实补气也。

傅山曰：然补气而不加以泄火之品，则气旺而火不能平，必反害其气也。故加黄芩於补气之中以泄火；又有熟地、归、芍以滋肝而壮水之主，则血不燥而气得和，怒气息而火自平，不必利气而气无不利，即无往而不利矣。

注家曰：性急怒多而不用舒肝药者，以其有胎娠故也。经云：胎病则母病，胎安则母病自愈。所以妊娠一门总以补气、养血、安胎为主，则万病自除矣。

第六章 小产

第一节 行房小产

【原文】：妊妇因行房癫狂致小产，血崩不止。人以为火动之极也，谁知是气脱之故乎！大凡妇人之怀妊也，赖肾水以荫胎。水源不足，则火易沸腾。加以久战不已，则火必大动，再至兴酣颠狂，精必大泄。精大泄则肾水益涸，而龙雷相火益炽。水火两病，胎不能固而堕矣。胎堕而火犹未息，故血随火而崩下，有不可止遏之势。人谓火动之极，亦未为大误也。但血崩本于气虚，火盛本于水亏，肾水既亏，则气之生源涸矣；气源既涸，而气有不脱者乎？此火动是标，而气脱是本也。经云："治病必求其本"。本固而标自立矣。若只以止血为主，而不急固其气，则气散不能速回，而血何由止！不大补其精，则水涸不能速长，而火且益炽，不揣其本，而齐其末，山未见有能济者也。方用固气填精汤。

固气填精汤方：

人参一两，黄耆一两（生用），白术五钱（土炒），大熟地一两（九蒸），当归五钱（酒洗），三七三钱（研末），荆芥穗二钱（炒黑）

水煎。服一剂而血止，二剂而身安，四剂则全愈。

傅山曰：此方之妙，妙在不去清火，而惟补气补精，其奏功独神者，以诸药温润能除大热也。盖热是虚，故补气自能摄血，补精自能止血，意在本也。

注家曰：小产血期多由行房而致。若年逾四十参耆宜倍用，熟地宜减半用，以其气虚火衰也，否则每令气脱不救。凡有妊娠者，须忍欲谨避房事，万勿自蹈危途，慎之！）

第二节 跌闪小产

【原文】：妊妇有跌扑闪挫，遂致小产，血流紫块，昏晕欲绝者，人皆曰瘀血作祟也，谁知是血室损伤乎！夫血室与胞胎相连，如唇齿之相依。胞胎有伤，则血室亦损，唇亡齿寒，理有必然也。然胞胎伤损而流血者，其伤浅；血室伤损而流血者，其伤深。伤之浅者，疼在腹；伤之深者，晕在心。同一跌扑损伤，而未小产与已小产，治各不同。未小产而胎不安者，宜顾其胎，而不可轻去其血；已小产而血大崩，宜散其瘀，而不可重伤其气。盖胎已堕，血既脱，而血室空虚，惟气存耳。倘或再伤其气，安保无气脱之忧乎！经云："血为营，气为卫"。使卫有不固，则营无依而安矣。故必补气以生血，新血生而瘀血自散矣。方用理气散瘀汤。

理气散瘀汤方：

人参一两，黄耆一两（生用）当归五钱（酒洗），茯苓三钱，红花一钱，丹皮三钱，姜炭五钱，

水煎。服一剂而流血止，二剂而昏晕除，三剂而全安矣。

傅山曰：此方用人参、黄耆以补气，气旺则血可摄也。用当归，丹皮以生血，血生则瘀难留也。用红花、黑姜以活血，血活则晕可除也。用茯苓以利水，水利则血易归经也。

注家曰：胎未堕宜加杜仲（炒炭）一钱，续断（炒黑）一钱；若胎已堕服原方。血崩不止，加贯众炭三钱；若血闭心晕，加元胡炭一钱。，

第三节 大便干结小产

傅山曰：妊妇有口渴烦躁，舌上生疮，两唇肿裂，大便干结，数日不得通，以致腹疼小产者，人皆曰大肠之火热也，谁知是血热烁胎乎！夫血所以养胎也，温和则胎受其益，太热则胎受其损。如其热久烁之，则儿在胞胎之中，若有探汤之苦，难以存活，则必外越下奔，以避炎气之逼迫，欲其胎之下坠也得乎！然则血荫乎胎，则血必虚耗。

血者阴也，虚则阳亢，亢则害矣。且血乃阴水所化，血日荫胎，取给刻不容缓。而火炽

阴水不能速生以化血，所以阴虚火动。阴中无非火气，血中亦无非火气矣，两火相合，焚逼胎儿，此胎之气所以下坠也。治法宜清胞中之火，补肾中之精，则可已矣。或疑儿已下坠，何故再顾其胞？血不荫胎，何必大补其水？殊不知火动之极，以致胎坠，则胞中纯是一团火气，此火乃虚火也。实火可泄，而虚火宜於补中清之，则虚火易散，而真火可生。倘一味清凉以降火，全不顾胞胎之虚实，势必至寒气逼人，胃中生气萧索矣。胃乃二阳，资养五脏者也。胃阳不生，何以化精微以生阴水乎！有不变为劳瘵者几希矣。方用加减四物汤。

加减四物汤方：

熟地五钱（九蒸），白芍三钱（生用），当归一两（酒洗），川芎一钱，山栀子一钱（炒），山萸二钱（蒸去核），山药三钱（炒），丹皮三钱（炒）

水煎。服四，五剂而愈矣。

傅山曰：丹皮性极凉血，产后用之，最防阴凝之害，慎之！（此方加条芩二钱，尤妙。），

第四节 畏寒腹疼小产

傅山曰：妊妇有畏寒腹疼，因而堕胎者，人只知下部太寒也，谁知是气虚不能摄胎乎！夫人生于火，亦养于火，非气不充，气旺则火旺，气衰则火衰。人之所以坐胎者，受父母先天之真火也。先天之真火，即先天之真气以成之。故胎成于气，亦摄于气，气旺则胎牢，气衰则胎堕，胎日加长，而气日加衰，安得不堕哉！况又遇寒气外侵，则内之火气更微，火气微则长养无资，此胎之不能不堕也。使当其腹疼之时，即用人参、干姜之类，补气祛寒，则可以疼止而胎安。无如人拘于妊娠之药禁而不敢用，因致堕胎，而仅存几微之气，不急救气，尚有何法。方用黄耆补气汤。

黄耆补气汤方：

黄耆二两（生用），肉桂五分（去粗皮，研），当归一两（酒洗）

（肉桂须用好的，如无佳者，用炮姜代之，或一钱二钱皆可，不可只用五分。）

水煎。服五剂愈矣。倘认定是寒，大用辛热，全不补气与血，恐过於燥热，反致亡阳而变危矣。

第五节 大怒小产

【原文】：妊妇有大怒之后，忽然腹疼吐血，因而堕胎；及堕胎之后，腹疼仍未止者，人以为肝之怒火未退也，谁知是血不归经而然乎！夫肝所以藏血者也。大怒则血不能藏，宜失血而不当堕胎，何为失血而胎亦随堕乎？不知肝性最急，血门不闭，其血直捣于胞胎，胞胎之系，通于心肾之间，肝血来冲，必断绝心肾之路；胎因心肾之路断，胞胎失水火之养，所以堕也。胎既堕矣，而腹疼如故者，盖因心肾未接，欲续无计，彼此痛伤肝气，欲归于心而心不受，欲归于肾而肾不纳，故血犹未静而疼无已也。治法宜引肝之血，仍入于肝，而腹疼自已矣。然徒引肝之血而不平肝之气，则气逆而不易转，即血逆而不易归也。方用引气归血汤。

引气归血汤方：

白芍五钱（酒炒），当归五钱（酒洗），白术三钱（土炒）甘草一钱，黑芥穗三钱，丹皮三钱，姜炭五分，香附五分（酒炒）麦冬三钱（去心），郁金一钱（醋炒）

水煎服。此方名为引气，其实仍是引血也，引血亦所以引气，气归於肝之中，血亦归於肝之内，气血两归，而腹疼自止矣。

注家曰：产后忌用白芍，因其酸寒也。胎堕后用白芍五钱，惟上元生人可。若下元生人，

万不可用。必不得已而用之，将白芍炒炭用三钱可也。余药如法制。

第七章 难产门

第一节 血虚难产

【原文】：妊娠有腹疼数日，不能生产。人皆曰气虚力弱，不能送子出产门，谁知是血虚胶滞，胞中无血，儿难转身乎！夫胎之成，成于肾脏之精；而胎之养，养于五脏六腑之血，故血旺则子易生，血衰则子难产。所以临产之前，宜用补血之药；补血而血不能遽生，必更兼补气以生之，然不可纯补其气也，恐阳过于旺，则血仍不足，偏胜之害，必有升而无降，亦难产之渐也。防微杜渐，其惟气血兼补乎。使气血并旺，则气能推送，而血足以济之，是汪洋之中自不难转身也，又何有胶滞之患乎！方用送子丹。

送子丹：

生黄耆一两，当归一两（酒洗）麦冬一两（去心），熟地五钱（九蒸）川芎三钱，

（方妙。若头产交骨不开，加炙龟板尾三钱，生过子妇人顶心发三钱。洗净，用新瓦一个，置火上焙发成灰，入药同煎服下，即效。）

水煎。服二剂而生矣。且无横生倒产之患。

傅山曰：此补血补气之药也。二者相较，补血之味，多於补气之品。盖补气止用黄耆一味，其馀无非补血之品，血旺气得所养，气生血得所依，胞胎润泽，自然易产；譬如舟遇水浅之处，虽大用人力，终难推行，忽逢春水泛滥，舟自跃跃欲行，再得顺风以送之，有不扬帆而迅行者乎！

第二节 交骨不开难产

【原文】：妊妇有儿到产门，竟不能下，此危急存亡之时也，人以为胞胎先破，水干不能滑利也，谁知是交骨不开之故乎！盖产门之上，原有骨二块，两相斗合，名日交骨。未产之前，其骨自合，若天衣之无缝；临产之际，其骨自开，如开门之见山。妇人儿门之肉，原自斜生，皮亦横长，实可宽可窄、可大可小者也。苟非交骨连络，则儿门必然大开，可以手入探取胞胎矣。此交骨为儿门之下关，实妇人锁钥之键。此骨不闭，则肠可直下；此骨不开，则儿难降生。然而交骨之能开能合者，气血主之也。血旺而气衰，则儿虽向下而儿门不开；气旺而血衰，则儿门可开而儿难向下，是气所以开交骨，血所以转儿身也。欲生产之顺利，非大补气血不可。然交骨之闭甚易，而交骨之开甚难。临产交骨不开者，多由於产前贪欲，泄精太甚，精泄则气血失生化之本，而大亏矣。气血亏则无以运润於儿门，而交骨粘滞不开矣。故欲交骨之开，必须於补气补血之中，而加开骨之品，两相合治，自无不开之患，不必催生，而儿自迅下，母子俱无恙矣。方用降子汤。

用降子汤方：

当归一两，人参五钱，川芎五钱，红花一钱，川牛膝三钱，柞木枝一两，

水煎服。一剂儿门必响亮一声，交骨开解，而儿乃降生矣。

傅山曰：此方用人参以补气，芎、归以补血，红花以活血，牛膝以降下，柞木枝以开关解骨，君臣左使同心协力，所以取效如神，在用开於补之中也。然单用柞木枝亦能开骨，但不补气与血，恐开而难合，未免有下部中风之患，不若此方之能开能合之为神妙也。至於儿未临门之时万不可先用柞木以开其门；然用降子汤亦正无妨，以其能补气血耳。若欲单用柞木，必须候到门而后可。

注家曰：方为子已临门救急而设。若子未临门，血虚难产，宜服前送子丹，不可遽服此

方。

第三节 脚手先下难产五十八

【原文】：妊妇生产之际，有脚先下而儿不得下者，有手先下而儿不得下者，人以为横生倒产，至危之症也，谁知是气血两虚之故乎！夫儿在胞胎之中，儿身正坐，男面向后，女面向前。及至生时，头必旋转而向下生，此天地造化之奇，非人力所能勉强者。虽然先天与后原并行而不悖，天机之动，必得人力以济之。所谓人力者，非产母用力之谓也，谓产母之气与血耳。产母之气血足，则胎必顺，产母之气血亏，则胎必逆；顺则易生，逆则难产。气血既亏，母身必弱，子在胞中，亦必弱；胎弱无力，欲转头向下而不能，此胎之所以有脚手先下者也。当是之时，急用针刺儿之手足，则儿必痛而缩入。急用转天汤以救顺之。

转天汤
人参二两，当归二两（酒洗），川芎一两，川牛膝三钱，升麻四分，附子一分（制）
水煎服。一剂而儿转身矣，再二剂自然顺生。

傅山曰：此方之妙，用人参以补气之亏；用芎归以补血之亏，人人皆知其义。若用升麻又用牛膝、附子，恐人未识其妙也。盖儿已身斜，非用提挈则头不易转，然转其身非用下行则身不易降。升麻、牛膝并用，而又用附子者，欲其无经不达，使气血迅速以催生也。

注家曰：若服三剂后，以针刺儿手足仍不转身，以针刺产妇合骨穴，儿即下。万不可使稳婆用手探取，以致子母俱危，戒之！）

第四节 气逆难产

【原文】：妇人有生产数日而胎不下者，服催生之药，皆不见效，人以为交骨之难开也，谁知是气逆不行而然乎！夫交骨不开，固是难产，然儿头到产门而不能下者，方是交骨不开之故，自当用开骨之剂。若儿头尚未到产门，乃气逆不行，儿身难转，非交骨不开之故也。若开其交骨，则儿门大开，儿头未转而向下，必致变症非常，是儿门万万不可轻开也。大凡生产之时，切忌坐草太早。若儿未转头，原难骤生，乃早于坐草，产妇见儿许久不下，未免心怀恐惧，恐则神怯，怯则气下而不能升，气既不升，则上焦闭塞，而气乃逆矣；上气既逆，而上焦必胀满，而气益难行，气沮滞于上下之间，不利气而徒催生，则气愈逆而胎愈闭矣。治法但利其气，儿自转身而下矣。方用舒气散。

舒气散
人参一两，当归一两（酒洗）川芎五钱，白芍五钱（酒炒）紫苏梗三钱，牛膝二钱，陈皮一钱，柴胡八分，葱白七寸）
水煎服。一剂而逆气转，儿即下矣。

傅山曰：此方利气而实补气。盖气逆由於气虚，气虚易於恐惧，补其气而恐惧自定，恐惧定而气逆者将莫知其何以定也，何必开交骨之多事乎哉！

注家曰：凡临产二日前，必先腹痛一小次，名曰试痛。此时万忽坐草临盆，但将包儿诸物预备现成，不可早叫稳婆来。过三日后，腹若大痛，方叫稳婆来。不可令产妇见面，暂让别室静待，不可高言。盖稳婆名曰收生，使其两手接收，不欲儿堕地受伤，非稳婆别有妙法也。若稳婆来之，即令产妇见面，彼此胡言乱语，用力太早，必致难产，百变丛生。戒之，慎之。

第五节 子死产门难产

【原文】：妇人有生产三四日，儿已到产门，交骨不开，儿不得下，子死而母未亡者，服开骨之药不验，当有死亡之危。今幸而不死者，正因其子死而胞胎下坠，子母离开，母气已收，未至同子气俱绝也。治但救其母，而不必顾其子矣。然死子在产门，塞其下口，有致母死之患，宜用推送之法，补血以生水，补气以生血，使气血两旺，死子可出而存母命也。倘徒用降子之剂以坠之，则死子未必下，而母气先脱矣，非救援之善者也。山亲见此等之症，常用救母丹，活人颇多。故志之。

救母丹：

人参一两，当归二两（酒洗）川芎一两，益母草一两，赤石脂一钱，芥穗三钱（炒黑）水煎服。一剂而死子下矣。

此方用芎、归以补血，人参以补气，气旺血旺，则上能升而下能降，气能推而血能送。况益母草又善下死胎，石脂能下瘀血，自然一涌而出，无少阻滞矣。（方妙。不可加减）

第六节 子死腹中难产

【原文】：妇人有生产六七日，胞衣已破，而子不见下，人以为难产之故也，谁知是子已死于腹中乎！夫儿死于儿门之边易辨，而死于腹中难识。盖儿已到产门之边，未死者头必能伸能缩，已死者必然不动，即以手推之，亦必不动如故。若系未死，用手少拔其儿之发，儿必退入，故曰易辨。若儿死在腹中，何从而知之？然实有可辨而知之者。凡子死腹中，而母可救者，产母之面，必无煤黑之气，是子死而母无死气也；子死腹中而母难救，产母之面，必有烟熏之气，是子死而母亦无生机也。以此辨死生，断断不爽也。既知儿死腹中，不能用药以降之，危道也；若用霸道以泄之，亦危道也。盖生产至六七日，其母之气必甚困乏，乌能胜霸道之治，如用霸道以强逐其死子，恐死子下而母亦立亡矣。必须仍补其母，使母之气血旺，而死子自下也。方用疗儿散。

疗儿散

人参一两，当归二两（酒洗），川牛膝五钱，乳香二钱（去油），鬼臼三钱（研，水飞）

水煎。服一剂死子下而母生矣。

傅山曰：凡儿之降生，必先转其头；原因其母气血之虚，以致儿不能转头以向下，世人用催生之药，以耗儿之气血，则儿之气涌通达，反致闭闷而死於腹中，此实庸医杀之也。所以难产之疾，断断不可用催生之药，只宜补气补血，以壮其母，而全活婴儿之命，正无穷也。此方救儿死之母，仍大补气血，所以救其本也，谁知救本即所以催生哉！

注家曰：下死胎不用厚朴，妙。曾有产妇面黑舌青，用补气、养血、活血之药而子母复得皆全者；亦万中之一。幸也。

第八章 正产

第一节 正产胞衣不下

【原文】：产妇有儿已下地，而胞衣留滞于腹中，二、三日不下，心烦意躁，时欲昏晕，人以为胞衣之蒂未断也，谁知是血少干枯，粘连于腹中乎！世人见胞衣不下，未免心怀疑惧，恐其冲之于心，而有死亡之兆。然而胞衣究何能上冲于心也。但胞衣不下，瘀血未免难行，恐有血晕之虞耳。治法仍宜大补其气血，使生血以送胞衣，则胞衣自然润滑，润滑则易下，生气以助生血，则血生自然迅速，尤易催堕也。方用送胞汤。

送胞汤

当归二两（酒洗），川芎五钱，益母草一两，乳香一两（不去油）没药一两（不

去油），芥穗三钱（炒黑）麝香五钱（研，另冲）

水煎服，立下。

傅山曰：此方以芎、归补其气血，以荆芥引血归经，用益母、乳香等药，逐瘀而下胞衣，新血既生，则旧血难存，气旺上升，而瘀浊自降，尚有留滞之苦哉！夫胞衣是包儿之一物，非依於子，即依於母，子生而不随子俱下，以子之不可依也，故留滞於腹，若有回顺其母之心，母胞虽已生子，而其蒂间之气，原未遽绝，所以留连欲脱而未脱，往往有存腹六七日不下，而竟不腐烂者，正以其尚有生气也。可见胞衣留腹，不能杀人，补之而自降耳。或谓胞衣既有生气，补气补血，则胞衣亦宜坚牢，何以补之而反降也？不知子未下，补则益於子；子已下，补则益於母。益子而胞衣之气连，益母而胞衣之气脱。此胞胎之气关，通则两合，闭则两开矣。故大补气血而胞衣反降也。

【原文】：有妇人子下地五、六日，而胞衣留於腹中，百计治之，竟不能下，而又绝无昏晕烦躁之状，人以为瘀血之粘连也，谁知是气虚不能推送乎！夫瘀血在腹，断无不作祟之理，有则必然发晕，今安然无恙，是血已净矣。血净宜清气升而浊气降。今胞衣不下，是清气下降而难升，遂至浊气上浮而难降。然浊气上升，又必有烦躁之病，今亦安然者，是清浊之气两不能升也。然则补其气不无浊气之上升乎？不知清升而浊降者，一定之理，未有清升而浊亦升者也。苟能於补气之中，仍分其清浊之气，则升清正所以降浊也。方用补中益气汤。

补中益气汤

人参三钱，生黄耆一两，柴胡三分，炙草一分，当归五钱，白术五分（土炒），升麻三分，陈皮二分，莱服子五分（炒研）

水煎服。一剂而胞衣自下矣。

傅山曰：夫补中益气汤乃提气之药也，并非推送之剂，何以能降胞衣如此之速也？然而浊气之下降者，由於清气之不升也；提其气则清升而浊降，浊气降则腹中所存之物，即无不随浊气而尽降，正不必再用推送之法也。况又加莱菔子数分，能理浊气，不至两相扞格，所以奏功之奇也。

第二节 正产气虚血晕

【原文】：妇人甫产儿后，忽然眼目昏花，呕恶欲吐，中心无主，或神魂外越，恍若天上行云，人以为恶血冲心之患也，谁知是气虚欲脱而然乎！盖新产之妇，血必尽倾，血室空虚，止存几微之气；倘其人阳气素虚，不能生血，心中之血，前已荫胎，胎堕而心中之血亦随胎而俱堕，心无血养，所赖者几微之气以固之耳。今气又虚而欲脱，而君心无护，所剩残血欲奔回救主，而血非正血，不能归经，内庭变乱而成血晕之症矣。治法必须大补气血，断不可单治血晕也；或疑血晕是热血上冲，而更补其血，不愈助其上冲之势乎？不知新血不生，旧血不散，补血以生新血，正活血以逐旧血也。然血有形之物，难以速生，气乃无形之物，易於迅发，补气以生血，尤易於补血以生血耳。方用补气解晕汤。

补气解晕汤

人参一两，生黄耆一两，当归一两（不酒洗），黑芥穗三钱，姜炭一钱。

水煎服。一剂而晕止，二剂而心定，三剂而血生，四剂而血旺，再不晕矣。

傅山曰：此乃解晕之圣药，用参、耆以补气，使气壮而生血也；用当归以补血，使血旺而养气也。气血两旺，而心自定矣。用荆芥炭引血归经，用姜炭以行瘀引阳，痰血去而正血归，不必解晕而晕自解矣。一方之中，药止五味，而其奏功之奇而大如此，其神矣乎。

原方极妙，不可加减。

第三节 正产血晕不语

【原文】：产妇有子方下地，即昏晕不语，此气血两脱也，本在不救；然救之得法，亦有能生者。山得岐天师秘诀，何敢隐而不宣乎？当斯之时，急用银针刺其眉心，得血出则语矣。然后以人参一两煎汤灌之，无不生者；即用黄耆二两，当归一两，名当归补血汤，煎汤一碗灌之亦得生。

万不可于二方之中，轻加附子。盖附子无经不达，反引气血之药，走而不守，不能专注于胞胎，不若人参、归、耆直救其气血之绝，聚而不散也。

盖产妇昏晕，全是血室空虚，无以养心，以致昏晕。舌为心之苗，心既无主，而舌又安能出声耶？夫眉心之穴，上通于脑，下通于舌，而其系则连于心，刺其眉心，则脑与舌俱通，而心之清气上升，则瘀血自然下降矣，然后以参、耆、当归之能补气生血者，煎汤灌之，则气与血接续，又何至於死亡乎！虽单用参、耆、当归亦有能生者，然终不若先刺眉心之为更妙。世人但知灸眉心之法，不知刺更胜於灸，盖灸法缓而刺法急，缓则难於救绝，急则易於回生，所谓“急则治其标，缓则治其本”者，此也。

罗注：此气血两失，津液失，救急未得药，当灌童子尿。

第四节 正产败血攻心晕狂六十五

【原文】：妇人有产后二、三日，发热，恶露不行，败血攻心，狂言呼叫，甚欲奔走，拿提不定，人以为邪热在胃之过，谁知是血虚心不得养而然乎！夫产后之血，尽随胞胎而外越，则血室空虚，脏腑皆无血养，只有心中之血，尚存几微，以护心君。而脏腑失其所养，皆欲取给于心；心包为心君之宰相，拦绝务脏腑之气，不许入心，始得心神安静，是护心者全藉心包之力也。使心包亦虚，不能障心，而各脏腑之气遂直入于心，以分取乎心血，心包情急，既不能内顾其君，又不能外御乎众，于是大声疾呼，号鸣勤王，而其迹象反近于狂悖，有无可如何之势，故病状似热而实非热也。治法须大补心中之血，使各脏腑分取以自养，不得再扰乎心君，则心君泰然，而心包亦安矣。方用安心汤。

安心汤方：

当归二两，川芎一两，生地五钱（炒），丹皮五钱（炒）生蒲黄二钱，干荷叶一片（引）

水煎服。一剂而狂定，恶露亦下矣。

傅山曰：此方用芎、归以养血，何以又用生地、丹皮之凉血，似非产后所宜？不知恶露所以奔心，原因虚热相犯，於补中凉之，而凉不为害，况益之以荷叶，七窍相通，引邪外出，不惟内不害心，且佐蒲黄以分解乎恶露也。但只可暂用以定狂，不可多用以取咎也。谨之，慎之。

注家曰：服药后狂定，宜服加味生化汤）

加味生化汤

当归（酒洗）一两一钱、川芎三钱、桃仁（研）钱半、荆芥穗（炒炭）一钱、丹皮钱半，服四剂妙。

第五节 正产肠下

【原文】：产妇肠下，亦危症也，人以为儿门不关之故，谁知是气虚下陷而不能收乎！夫气虚下陷，自宜用升提之药，以提其气。然新产之妇，恐有瘀血在腹，一旦提气，并瘀血升腾于上，则冲心之患，又恐变出非常，是气又不可竟提也。气既不可竟提，而气又下陷，将用何法以治之哉？盖气之下陷者，因气之虚也，但补其气，则气旺而肠自升举矣。惟是补

气之药少，则气力薄而难以上升，必须以多为贵，则阳旺力强，断不能降而不升矣。方用补气升肠饮。

补气升肠饮
人参一两（去芦），生黄耆一两，当归一两（酒洗），白术五钱（土炒）川芎三钱（酒洗），升麻一分
水煎服。一剂而肠升矣。

傅山曰：此方纯於补气，全不去升肠，即如用升麻一分，亦不过引气而升耳。盖升麻之为用，少则气升，多则血升也，不可不知。又方用萆麻仁四十九粒捣涂顶心以提之，肠升即刻洗去，时久则恐吐血，此亦升肠之一法也。

注家曰：生产有子未下肠先下者，名盘肠生，勿遽服此方。急取一净盆，用开水洗热，将肠置于盆内，静待勿惧，子下后肠即徐徐收回。若时久盆与肠俱冷，不能速收，急用开水一盆，待温以入得手为度，将温水倾于置肠盆内，肠热气充，即可收起矣。若子先下，急服此方，少迟恐气脱不救。

第九章 产后门

第一节 产后少腹疼

【原文】：妇人产后少腹疼痛，甚则结成一块，按之愈疼，人以为儿枕之疼也，谁知是瘀血作祟乎！夫儿枕者，前人谓儿头枕之物也。儿枕之不疼，岂儿生不枕而反疼，是非儿枕可知矣。既非儿枕，何故作疼？乃是瘀血未散，结作成团而作疼耳。凡此等症，多是壮健之妇血有余，而非血不足也。似乎可用破血之药；然血活则瘀血自除，血结则瘀作祟；若不补血而反败血，虽瘀血可消，毕竟耗损难免，不若于补血之中，以行逐瘀之法，则气血不耗，而瘀亦尽消矣。方用散结定疼汤。

散结定疼汤
当归一两（酒洗），川芎五钱（酒洗），丹皮二钱（炒），益母草三钱，黑芥穗二钱，乳香一钱（去油）山楂（十粒（炒黑），桃仁七粒，泡去皮尖（炒研）
水煎。服一剂而疼止而愈，不必再剂也。

傅山曰：此方逐瘀于补血之中，消块於生血之内，妙在不专攻疼病而疼病止。彼世人一见儿枕之疼，动用元胡、苏木、蒲黄、灵脂之类以化块，又何足论哉！

妇人产后少腹疼痛，按之即止，人亦以为儿枕之疼也，谁知是血虚而然乎！夫产后亡血过多，血室空虚，原能腹疼，十妇九然。但疼有虚实之分，不可不辨；如燥糖触体光景，是虚疼而非实疼也。大凡虚疼宜补，而产后之虚疼，尤宜补焉。惟是血虚之疼，必须用补血之药，而补血之味，多是润滑之品，恐与大肠不无相碍；然产后血虚，肠多干燥，润滑正相宜也，何碍之有。方用肠宁汤。

肠宁汤
当归一两（酒洗），熟地一两（九蒸）人参三钱，麦冬三钱（去心）阿胶三钱（蛤粉炒），山药三钱（炒）续断二钱，甘草一钱，肉桂二分（去粗，研）
水煎服。一剂而疼轻，二剂而疼止，多服更宜。
此方补气补血之药也；然补气而无太郁之忧，补血而无太滞之患，气血既生，不必止疼而疼自止矣。

第二节 产后气喘

【原文】：妇人产后气喘，最是大危之症，苟不急治，立刻死亡，人只知是气血之虚也，谁知是气血两脱乎！夫既气血两脱，人将立死，何又能作喘？然此血将脱，而气犹未脱也。血将脱而气欲挽之，而反上喘。

如人救溺，援之而力不胜，又不肯自安于不救，乃召号同志以求助，故呼声而喘作。其症虽危，而可救处正在能作喘也。盖肺主气，喘则肺气似盛而实衰，当是之时，血将脱而万难骤生，望肺气之相救甚急；若赤子之望慈母然。而肺因血失，止存几微之气，自顾尚且不暇，又何能提挈乎血，气不与血俱脱者几希矣，是救血必须补气也。方用救脱活母汤。

救脱活母汤方：

人参二两，当归一两（酒洗），熟地一两（九蒸），枸杞子五钱，山萸五钱（蒸，去核），麦冬一两（去心），阿胶二钱（蛤粉炒），肉桂一钱（去粗研）黑芥穗二钱

水煎服。一剂而喘轻，二剂而喘减，三剂而喘定，四剂而全愈矣。

傅山曰：此方用人参以接续元阳，然徒补其气而不补其血，则阳燥而狂，虽回生於一时，亦旋得旋失之道；即补血而不补其肝肾之精，则本原不固，阳气又安得而续乎！所以又用熟地、山萸、枸杞之类，以大补其肝肾之精，而后大益其肺气，则肺气健旺，升提有力矣。特虑新产之后，用补阴之药，腻滞不行，又加肉桂以补命门之火，使火气有根，助人参以生气，且能运化地黄之类，以化精生血。若过於助阳，万一血随阳动瘀而上行，亦非保全之策，更加荆芥以引血归经，则肺气安而喘速定，治几其神乎。

注家曰：方妙不可加减。

第三节 产后恶寒身颤

【原文】：妇人产后恶寒恶心，身体颤，发热作渴，人以为产后伤寒也，谁知是气血两虚，正不敌邪而然乎；大凡人之气不虚，则邪断难入。产妇失血既多，则气必大虚，气虚则皮毛无卫，邪原易入，正不必户外之风来袭体也，即一举一动，风即可乘虚而入之。然产后之妇，风易入而亦易出。凡有外邪之感，俱不必祛风，况产妇之恶寒者，寒由内生也。发热者，热由内弱也；身颤者，颤由气虚也。治其内寒，而外寒自散；治其内弱，而外热自解；壮其元阳，而身颤自除。方用十全大补汤。

十全大补汤方：

人参三钱，白术三钱（土炒），茯苓三钱（去皮），甘草一钱（炙）川芎一钱（酒洗），当归三钱（酒洗）熟地五钱（九蒸），白芍二钱（炒）黄耆一两（生用），肉桂一两，去粗，研）

水煎服。一剂而诸病悉愈。

傅山曰：此方但补气与血之虚，而不去散风与邪之实，正以正足而邪自除也，况原无邪气乎！所以奏功之捷也。

注家曰：宜连服数剂，不可只服一剂。，

第四节 产后恶心呕吐

【原文】：妇人产后恶心欲呕，时而作吐，人皆曰胃气之寒也，谁知是肾气之寒乎！夫胃为肾之关，胃之气寒，则胃气不能行于肾之中；肾之气寒，则肾气亦不能行于胃之内，是肾与胃不可分而两之也。惟是产后失血过多，必致肾水干涸，肾水涸应肾火上炎，当不至胃有寒冷之虞，何故肾寒而胃亦寒乎？盖新产之馀，水乃遽然涸去，虚火尚不能生，火既不生，

而寒之象自现。治法宜补其肾中之火，然火无水济，则火在水上，未必不成火动阴虚之症；必须于水中补火，肾中温胃，而后肾无太热之患，胃有既济之欢也。方用温肾止呕汤。

温肾止呕汤

熟地五钱（九蒸），巴戟一两（盐水浸）人参三钱，白术一两（土炒）山萸五钱（蒸，去核），炮姜一钱，茯苓二钱（去皮），橘红五分（姜汁洗）白蔻一粒（研）

水煎服。一剂而呕吐止，二剂而不再发，四剂而全愈矣。

傅山曰：此方补肾之药，多於治胃之品，然而治肾仍是治胃也。所以肾气升腾，而胃寒自解，不必用大热之剂，温胃而祛寒也。

注家曰：服此方必待恶露尽后，若初产一、二日之内恶心欲呕，乃恶露上冲，宜服加味生化汤方：全当归一两（酒洗）、川芎二钱、炮姜一钱、东查炭二钱、桃仁一钱（研），用无灰黄酒一盅，水三盅同煎。

第五节 产后血崩

【原文】：少妇产后半月，血崩昏晕，目见鬼神。人皆曰恶血冲心也，谁知是不慎房帏之过乎。夫产后业逾半月，虽不比初产之二三日，而气血初生，尚未全复，即血路已净，而胞胎之损伤未痊，断不可轻于一试，以重伤其门户。无奈少娇之妇，气血初复，不知慎养，欲心大动，贪合图欢，以致血崩昏晕，目见鬼神，是心肾两伤，不特胞胎门户已也。明明是既犯色戒，又加酣战，以致大泄其精，精泄而神亦随之而欲脱。此等之症，乃自作之孽，多不可活。然于不可活之中，而思一急救之法。舍大补其气与血，别无良法也。方用救败求生汤。

救败求生汤方：

人参二两，当归二两（酒洗）白术二两（土炒），九蒸熟地一两，山萸五钱（蒸），山药五钱（炒）枣仁五钱（生用），附子一分或一钱（自制）

水煎服。一剂而神定，二剂而晕止，三剂而血亦止矣。

傅山曰：倘一服见效，连服三、四剂，减去一半，再服十剂，可庆更生。此方补气以回元阳於无何有之乡，阳回而气回，自可摄血以归神，生精而续命矣。

注家曰：亦有中气素虚，产后顷刻血崩不止，气亦随之而脱。此至危之证，十常不救者八、九，惟用独参汤尚可救活一、二。辽人参去芦五钱，打碎，急煎，迟则气脱不及待矣。煎成徐徐灌之，待气回再煎一服灌之。其馀治法参看血崩门。但产后不可用杭芍炭以及诸凉药。然此证皆系临产一、二日前入房所致，戒之！）

第六节 产后手伤胞胎淋漓不止

【原文】：妇人有生产之时，被稳婆手入产门，损伤胞胎，因而淋漓不止，欲少忍须臾而不能，人谓胞破不能再补也，孰知不然。夫破伤皮肤，尚可完补，岂破在腹内者，独不可治疗？或谓破在外可用药外治，以生皮肤；破在内，虽有灵膏，无可救补。然破之在内者，外治虽无可施力，安必内治不可奏功乎！试思疮伤之毒，大有缺陷，尚可服药以生肌肉，此不过收生不谨；小有所损，并无恶毒，何难补其缺陷也。方用完胞饮。

完胞饮

人参一两，白术十两 （土炒），茯苓三钱（去皮），生黄耆五钱，当归一两（酒炒），川芎五钱，白芨末一钱，红花一钱，益母草三钱，桃仁（十粒，泡炒，研）

用猪羊胞一个，先煎汤，后煎药，饥服十剂全愈。

傅山曰：夫胞损宜用补胞之药，何以反用补气血之药也？盖生产本不可手探试，而稳婆竟以手探，胞胎以致伤损，则难产必矣。难产者，因气血之虚也。产后大伤气血，是虚而又虚矣，因虚而损，复因损而更虚，若不补其气与血，而胞胎之破，何以奏功乎！今之大补其气血者，不啻饥而与之食，渴而与之饮也，则精神大长，气血再造，而胞胎何难补完乎？所以旬日之内便成功也。

注家曰：胞破诸书单方多，然不如此妙。

第七节 产后四肢浮肿

【原文】：产后四肢浮肿，寒热往来，气喘咳嗽，胸隔不利，口吐酸水，两胁疼痛，人皆曰败血流于经络，渗于四肢，以致气逆也，谁知是肝肾两虚，阴不得出之阳乎！夫产后之妇，气血大亏，自然肾水不足，肾火沸腾；然水不足则不能养肝，而肝木大燥，木中乏津，木燥火发，肾火有党，子母两焚，火焰直冲，而上克，肺金，金受火刑，力难制肝，而咳嗽喘满之病生焉；肝火既旺而下克，脾土，土受木刑，力难制水，而四肢浮肿之病出焉。然而肝木之火旺，乃假象而非真旺也。假旺之气，若盛而实不足，故时而热时而寒，往来无定，乃随气之盛衰以为寒热，而寒非真寒，热亦非真热，是以气逆於胸隔之间而不舒耳。两胁者，肝之部位也。酸者，肝之气味也。吐酸胁疼痛，皆肝虚而肾不能荣之象也。治法宜补血以养肝，补精以生血，精血足而气自顺，而寒热咳嗽浮肿之病悉退矣。方用转气汤。

转气汤方：

人参三钱，茯苓三钱（去皮）白术三钱（土炒），当归五钱（酒洗），白芍五钱（酒炒），熟地一两（九蒸）山萸三钱（蒸），山药五钱（炒）芡实三钱（炒），柴胡五分，故纸一钱（盐水炒）

水煎服。三剂效，十剂痊。

傅山曰：此方皆是补血补精之品，何以名为转气耶？不知气逆由於气虚，乃是肝肾之气虚也。补肝肾之精血，即所以补肝肾之气也。盖虚则逆，旺则顺，是补即转也；气转而各症尽愈，阴出之阳，则阴阳无扞格之虞矣。

注家曰：方妙不可加减。白芍宜炒炭用。

第八节 产后肉线出

【原文】：妇人有产后水道中出肉线一条，长二、三尺，动之则疼痛欲绝，人以为胞胎之下坠也，谁知是带脉之虚脱乎！夫带脉束于任督之间，任脉前而督脉后，二脉有力，则带脉坚牢；二脉无力，则带脉崩坠。产后亡血过多，无血以养任督，而带脉崩坠，力难升举，故随溺而随下也。带脉下垂，每每作痛于腰脐之间，况下坠者而出于产门之外，其失于关键也更甚，安得不疼痛欲绝乎！方用两收汤。

两收汤方：

人参一两，白术二两（土炒），川芎三钱（酒洗），九蒸熟地二两，山药一两（炒），山萸四钱（蒸）芡实五钱（炒），扁豆五钱（炒）巴戟三钱（盐水浸），杜仲五钱（炒黑）白果（十枚，捣碎）

水煎。服一剂而收半，二剂而全收矣。

傅山曰：此方补任督而仍补腰脐者，盖以任督连於腰脐也。补任督而不补腰脐，则任督无助，而带脉何以升举？惟两补之，则任督得腰脐之助，带脉亦得任督之力而收矣。

注家曰：此方凡肾虚腰痛、遗尿皆可治，甚勿轻忽。

第九节 产后肝痿七十五

【原文】：妇人产后阴户中垂下一物，其形如帕，或有角、或二歧，人以为产颓也，谁知是肝痿之故乎！夫产后何以成肝痿也？盖因产前劳役过伤，又触动怪怒，以致肝不藏血，血亡过多，故肝之脂膜随血崩坠，其形似子宫，而实非子宫也。若是子宫之下坠，状如茄子，只到产门，而不能越出于产门之外。惟肝之脂膜往往出产门外者，至六、七寸许，且有粘席干落一片，如手掌大者，如是子宫坠落，人立死矣，又安得而复生乎！治法宜大补其气与血，而少加升提之品，则肝气旺而易生，肝血旺而易养，肝得生养之力，而脂膜自收。方用收膜汤。

收膜汤方：

生黄耆一两，人参五钱，白术五钱（土炒），当归三钱（酒洗）升麻一钱，白芍五钱（酒炒）焦）

水煎服。一剂即收矣。

傅山曰：或疑产后禁用白芍，恐伐生气之源，何以频用之而奏功也？是未读仲景之书者，嗟乎！白芍之在产后不可频用者，恐其收敛乎瘀也；而谓伐生气之源，则误矣。况病之在肝者，尤不可以不用；且用之於大补气血之中，在芍药亦忘其为酸收矣，又何能少有作祟者乎！矧脂膜下坠，正藉酸收之力，助升麻以提升气血，所以奏功之捷也。

注家曰：收肝膜全赖白芍之功，不可用炭。

第十节 产后气血两虚乳汁不下

【原文】：妇人产后绝无点滴之乳，人以为乳管之闭也，谁知是气与血之两涸乎！夫乳乃气血之所化而成也，无血固不能生乳汁，无气亦不能生乳汁，然二者之中，血之化乳，又不若气之所化为尤速。新产之妇，血已大亏，血本自顾不暇，又何能以化乳？乳全赖气之力，以行血而化之也。今产后数目，而乳不下点滴之汁，其血少气衰可知。气旺则乳汁旺，气衰则乳汁衰，气涸则乳汁亦涸，必然之势也。世人不知大补气血之妙，而一味通乳，岂知无气则乳无以化，无血则乳无以生。不几向饥人而乞食，贫人而索金乎？治法宜补气以生血，而乳汁自下，不必利窍以通乳也。方名通乳丹。

通乳丹方：

人参一两，生黄耆一两，当归二两（酒洗），麦冬五钱（去心）木通三分，桔梗三分，七孔猪蹄二个（去爪壳）

水煎服。二剂而乳如泉涌矣。

傅山曰：此方专补气血以生乳汁，正以乳生於气血也。产后气血涸而无乳，非乳管之闭而无乳者可比。不去通乳而名通乳丹，亦因服之乳通而名之；今不通乳而乳生，即名生乳丹亦可。

第十一节 产后郁结乳汁不通

【原文】：少壮之妇，于生产之后，或闻丈夫之嫌，或听翁姑之谇，遂致两乳胀满疼痛，乳汁不通，人以为阳明之火热也，谁知是肝气之郁结乎！夫阳明属胃，乃多气多血之府也。乳汁之化，原属阳明，然阳明属土，壮妇产后，虽云亡血，而阳明之气，实未尽衰，必得肝木之气以相通，始能化成乳汁，未可全责之阳明也。盖乳汁之化，全在气而不在血。今产后数日，宜其有乳，而两乳胀满作痛，是欲化乳而不可得，非气郁而何？明明是羞愤成郁，土木相结，又安能化乳而成汁也。治法宜大舒其肝木之气，而阳明之气血自通，而乳亦通矣，

不必专去通乳也。方名通肝生乳汤。

通肝生乳汤方：

白芍五钱（醋炒），当归五钱（酒洗），白术五钱（土炒），熟地三分，甘草三分，麦冬五钱（去心），通草一钱，柴胡一钱，远志一钱。

水煎服。一剂即通，不必再服也。

注家曰：麦冬用小米炒，不惟不寒胃，且得米味一直引入胃中；而化乳愈速。

产后编上卷

第十章 产后总论

凡病起于血气之衰，脾胃之虚，而产后尤甚。是以丹溪先生论产后，必大补气血为先，虽有他症，以末治之，斯言尽治产之大旨。若能扩充立方，则治产可无过矣，夫产后忧、惊、劳、倦，气血暴虚，诸症乘虚易入，如有气毋专耗散，有食毋专消导；热不可用芩、连，寒不可用桂、附；寒则血块停滞，热则新血崩流。至若中虚外感，见三阳表症之多，似可汗也，在产后而用麻黄，则重竭其阳；见三阴里症之多，似可下也，在产后而用承气，则重亡阴血。耳聋胁痛，乃肾虚恶露之停，休用柴胡。谵语出汗，乃元弱似邪之症，非同胃实。厥由阳气之衰，无分寒热，非大补不能回阳而起弱。

痉因阴血之亏，不论刚柔，非滋荣不能舒筋而活络，乍寒乍热，发作无期，症似疟也，若以疟治，迁延难愈。言论无伦，神不守舍，病似邪也，若以邪治，危亡可待。去血过多而大便燥结，肉从蓉加於生化，非润肠承气之能通，去汗过多而小便短涩，六君子倍加参，耆，必生津助液之可利。加参生化汤频服，救产后之危；长生活命丹屡用，苏绝谷之人。颓疝脱肛，多是气虚下陷，补中益气之方。口噤拳挛，乃因血燥类风，加参生化之剂。产户入风而痛甚，服宜羌活养荣汤。玉门伤凉而不闭，洗宜〔虫麻〕儿黄硫散。怔忡惊悸，生化汤加以定志。似邪恍惚，安神丸助以归脾。

因气而闷满虚烦，生化汤加木香为佐。因食而嗳酸恶食，六君子加神曲、麦芽为良。苏木、莪术，大能破血；青皮、枳壳，最消满胀。一应耗气破血之剂，汗吐宣下之法，止可施诸壮实，岂宜用於胎产。大抵新产后，先问恶露如何，块痛未除，不可遽加参术；腹中痛止，补中益气无疑。至若亡阳脱汗，气虚喘促，频服加参生化汤，是从权也。又如亡阴火热，血崩厥晕，速煎生化原方，是救急也。王太仆云："治下补下，治以急缓，缓则道路达而力微，急则气味厚而为重。"故治产当遵丹溪而固本，服法宜效太仆以频加。凡付生死之重寄，须着意於极危；欲救俯仰之无亏，用存心于爱物。此虽未尽产症之详，然所闻一症，皆援近乡治验为据，亦未必无小补云。

第十一章 产前后方症宜忌

第十二节 正产

【原文】：正产者，有腹或痛或止，腰胁酸痛；或势急而胞未破，名弄胎，服八珍汤加香附自安。有胞破数日而痛尚缓，亦服上药俟之。

八珍汤方（八珍散）《瑞竹堂经验方》

【主治】气血两虚证。面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力。

人参，白术，白茯苓，当归，川芎，白芍药，熟地黄，　甘草炙，各一两(30g)

上哎咀，每服三钱(9g)，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓，不拘时候，通口服（现代用法：或作汤剂，加生姜 3 片，大枣 5 枚，水煎服，用量根据病情酌定）。

【功用】益气补血。

【方解】本方所治气血两虚证多由久病失治、或病后失调、或失血过多而致，病在心、脾、肝三脏。心主血，肝藏血，心肝血虚，故见面色苍白、头晕目眩、心悸怔忡、舌淡脉细；脾主运化而化生气血，脾气虚，故面黄，肢倦、气短懒言、饮食减少、脉虚无力。治宜益气与养血并重。房中人参与熟地相配，益气养血，共为君药。白术、茯苓健脾渗湿，助人参益气补脾；当归、白芍养血和营，助熟地滋养心肝，均为臣药。川芎为佐，活血行气，使地、归、芍补而不滞。炙甘草为使，益气和中，调和诸药。全方八药，实为四君子汤和四物汤的复方。用法中加入姜、枣为引，调和脾胃，以资生化气血，亦为佐使之药。

【运用】

1. 辨证要点　本方是治疗气血两虚证的常用方。临床应用以气短乏力，心悸眩晕，舌淡，脉细无力为辨证要点。

2. 加减变化：若以血虚为主，眩晕心悸明显者，可加大地、芍用量；以气虚为主，气短乏力明显者，可加大参、术用量；兼见不寐者，可加酸枣仁、五味子。

3. 现代运用：本方常用于病后虚弱、各种慢性病，以及妇女月经不调等属气血两虚者。

第十三节 伤产

【原文】：伤产者，胎未足月，有所伤动，或腹痛脐痛，或服催生药太早，或产母努力太过，逼儿错路，不能正产，故临月必举动从容，不可多睡，饱食饮酒，但觉腹中动转，即正身仰卧，待儿转顺，与其临时费力，不如先时慎重。

第十四节 调产

【原文】：调产者，产母临月，择稳婆、办器用、备参药，产时不可多人喧闹，二人扶身，或凭物站。心烦，用滚水调白蜜一匙，独活汤更妙；或饥，服糜粥少许，勿令饥渴。有生息未顺者，只说有双胎，或胎衣不下，勿令产母惊恐。

第十七节 催生

【原文】：催生者，因坐草太早，困倦难产，用八珍汤，稍佐以香附、乳香，以助血气。胞衣早破，浆血已干，亦用八珍汤。

八珍汤方（八珍散）《瑞竹堂经验方》

【主治】气血两虚证。面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力。

人参，白术，白茯苓，当归，川芎，白芍药，熟地黄，　甘草炙，各一两(30g)

上哎咀，每服三钱(9g)，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓，不拘时候，通口服（现代用法：或作汤剂，加生姜 3 片，大枣 5 枚，水煎服，用量根据病情酌定）。

【功用】益气补血。

【方解】本方所治气血两虚证多由久病失治、或病后失调、或失血过多而致，病在心、

脾、肝三脏。心主血，肝藏血，心肝血虚，故见面色苍白、头晕目眩、心悸怔忡、舌淡脉细；脾主运化而化生气血，脾气虚，故面黄，肢倦、气短懒言、饮食减少、脉虚无力。治宜益气与养血并重。房中人参与熟地相配，益气养血，共为君药。白术、茯苓健脾渗湿，助人参益气补脾；当归、白芍养血和营，助熟地滋养心肝，均为臣药。川芎为佐，活血行气，使地、归、芍补而不滞。炙甘草为使，益气和中，调和诸药。全方八药，实为四君子汤和四物汤的复方。用法中加入姜、枣为引，调和脾胃，以资生化气血，亦为佐使之药。

【运用】

1. 辨证要点　本方是治疗气血两虚证的常用方。临床应用以气短乏力，心悸眩晕，舌淡，脉细无力为辨证要点。

2. 加减变化：若以血虚为主，眩晕心悸明显者，可加大地、芍用量；以气虚为主，气短乏力明显者，可加大参、术用量；兼见不寐者，可加酸枣仁、五味子。

3. 现代运用：本方常用于病后虚弱、各种慢性病，以及妇女月经不调等属气血两虚者。

第十五节 冻产

【原文】：冻产者，天寒血气凝滞，不能速生，故衣裳宜厚，产室宜暖，背心、下体尤要。

第十六节 热产

【原文】：热产者，暑月宜温凉得宜。若产室人众，热气蒸逼，致头痛面赤昏晕等症，宜饮清水少许以解之。然风雨阴凉，亦当避之。

第十七节 横产

【原文】：横产者，儿居母腹，头上足下，产时则头向下，产母若用力逼之，胎转至半而横，当令产母安然仰卧，令其自顺。稳婆以中指挟其肩，勿使脐带羁绊。用催生药，努力即生。

当归、紫苏各三钱，长流水煎服即下。

◎一方，用好京墨磨服之，即下。

◎一方，用败笔头一个，火煅。以藕节自然汁调服之，即下。

◎一方，用益母草六两浓煎，加童便一大杯调服即下。

第十八节 盘肠产

【原文】：盘肠产者，产则子肠先出，然后生子，其肠或未即收，以蓖麻子四十九粒，研碎涂头上，肠收，急急洗去，迟则有害。又方，止用四十粒（去皮）研为膏，涂顶中，收即拭之。如肠燥，以磨刀水润之，再用磁石煎汤服之。须阴阳家用过有验者。

第十九节 难产

【原文】：难产者，交骨不开，不能生产也，服加味芎归汤，良久即下。

加味芎归汤方：

小川芎一两，当归一两，败龟版一个（酒炙），妇人发灰一握（须用生过男

妇者，为末）

水一盅，煎七分服。

第二十节 死产

【原文】：死产者，子死腹中也。验母舌青黑，其胎已死。先用平胃散一服，酒水各一盅，煎八分，投朴硝煎服，即下。用童便亦好，后用补剂调理。

罗注：又下死胎方，桂枝茯苓丸。活血化瘀基础方：桂枝茯苓丸。作为活血化瘀基础方，换一句话说所有瘀血我们在治病的过程中，都可以把桂枝茯苓丸作为首选方。做成汤药的量很大就变成催生方，还有下死胎方的药是一样的，你量变了剂型变了。

桂枝茯苓丸方：伤寒论）

桂枝、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍药各等分

上五味，末之，炼蜜为丸，如兔屎大，每日食前服一丸，不知可渐加至三丸。

第二十一节 下胞

【原文】：胞衣不下，用滚酒送下失笑散一剂，或益母丸，或生化汤送鹿角灰一钱，或以产母发入口作吐，胞衣即出。有气虚不能送出者，腹必胀痛，单用生化汤。

生化汤方：

全当归一两，川芎三钱，白术一钱，香附一钱，加人参三钱更妙，用水煎服。

一方，用蓖麻子二两，雄黄二钱，研膏，涂足下涌泉穴，衣下，急速洗去。

平胃散：

南苍术（米泔水浸炒），厚朴（姜炒），陈皮、炙甘草各二钱

共为粗末，或水煎，或酒煎，煎成时加，硝二钱，再煎一二沸，温服。

失笑散：

五灵脂、蒲黄

俱研为细末，每服三钱，热酒下。

第二十二节 断脐

【原文】：断脐，必以绵裹咬断为妙。如遇天寒，或因难产，母子劳倦，宜以大麻油纸燃，徐徐烧断，以助元气，虽儿已死，令暖气入脐，多得生，切勿以刀断之。

滑胎散：

临月常服数剂以便易生

当归三、五钱，川芎五、七钱，杜仲二钱，熟地三钱，枳壳七分，山药二钱

水二盅，煎八分，食前温服。如气体虚弱人，加人参、白术、随宜服之；如便实多滞者，加牛膝二钱。

治产秘验良方：

治横生逆产，至数日不下，一服即下；有未足月，忽然胎动，一服即安；或临月先服一服，保护无虞，更能治胎死腹中，及小产伤胎无乳者，一服即如原体。

全当归，川芎（各一钱五分）川贝母一钱（去心），荆芥穗、黄耆各八分厚朴，（姜炒），蕲艾、红花（各七分）菟丝子一钱二分，甘草五分，羌活六分（面

炒），枳壳六分（面炒），白芍一钱二分（冬月不用）

上十三味，只用十二味，不可加减。安胎去红花；催生去蕲艾，用井水盅半，姜三片为引，热服，渣用水一盅煎半盅热服。如不好，再用水一盅煎半盅，服之即效，不用二剂。

催生兔脑丸

治横生逆产神效。

腊月兔脑髓一个，母丁香一个 乳香一钱（另研），麝香一分

兔脑为丸，芡实大，阴干密封，用时以温酒送下一丸。

夺命丹：

临产未产时，目反口噤，面黑唇青，口中吐沫，命在须臾。若脸面微红，子死母活，急用。

◎蛇退、蚕故子（烧灰不存性）、发灰一钱，乳香五分共为细末，酒下。

加味芎归汤方：

治子宫不收，产后不闭

人参二钱，黄耆一钱，当归二钱，升麻八分，川芎一钱，炙草四分，五味子（十五粒）

第十二章 新产治法

【原文】：生化汤先连进二服。若胎前素弱妇人，见危症热症堕胎，不可拘帖数，服至病退乃止。若产时劳甚，血崩形脱，即加人参三、四钱在内，频服无虞。若气促亦加人参，加参于生化汤者，血块无滞，不可以参为补而弗用也。有治产不用当归者，见偏之甚。此方处置万全，必无一矢。世以四物汤治产，地黄性寒滞血，芍药微酸无补，伐伤生气，误甚。

生化汤方：

全当归一两，川芎三钱，白术一钱，香附一钱，加人参三钱更妙，用水煎服。

一方，用蓖麻子二两，雄黄二钱，研膏，涂足下涌泉穴，衣下，急速洗去。

第二十五节 产后用药十误

一因气不舒而误用耗气顺气等药，反增饱闷，陈皮用至五分，禁枳实、厚朴。

二因伤气而误用消导，反损胃气，至绝谷，禁枳壳、大黄、蓬、棱、曲、朴。

三因身热而误用寒凉，必致损胃增热，禁芩、连、栀、柏、升、柴。

四因日内未曾服生化汤，勿用参、耆、术，以致块痛不消。

五毋用地黄以滞恶露。

六毋用枳壳、牛膝、枳实以消块。

七便秘毋用大黄、芒硝。

八毋用苏木、棱、蓬以行块，芍药能伐气，不可用。

九毋用山楂汤以攻块定痛，而反损新血。

十毋轻服济坤丹以下胎下胞。

产后危疾诸症，当频服生化汤，随症加减，照依方论。

生化汤方：

全当归一两，川芎三钱，白术一钱，香附一钱，加人参三钱更妙，用水煎服。

一方，用蓖麻子二两，雄黄二钱，研膏，涂足下涌泉穴，衣下，急速洗去。

第二十三节 产后寒热

【原文】：凡新产后，荣卫俱虚，易发寒热；身痛腹痛，决不可妄投发散之剂，当用生化汤为主，稍佐发散之药。产后脾虚，易于停食，以致身热，世人见有身热，便以为外感，遽然发汗，速亡甚矣，当于生化汤中加扶脾消食之药。大抵产后先宜补血，次补气。若偏补气而专用参耆，非善也。产后补虚，用参、耆、芎、归、白术、陈皮、炙草，热轻则用茯苓淡渗之药，其热自除，重则加干姜。或云大热而用姜何也？曰此热非有余之热，乃阴虚内生热耳。盖干姜能人肺分，利肺气，又能入肝分，引众药生血，然必与阴血药同用之。产后恶寒发热腹痛者，当主恶血；若腹不痛，非恶血也。

产后寒热，口眼歪邪，此乃气血虚甚，以大补为主，左手脉不足，补血药多於补气药；右手脉不足，补气药多於补血药，切不可用小续命等发散之药。

生化汤方：

全当归一两，川芎三钱，白术一钱，香附一钱，加人参三钱更妙，用水煎服。

一方，用蓖麻子二两，雄黄二钱，研膏，涂足下涌泉穴，衣下，急速洗去。

第二十四节 胎前患伤寒疫症疟疾堕胎等症

【原文】：胎前或患伤寒、疫症、疟疾，热久必致堕胎，堕后愈增热，因热消阴血，而又继产失血故也。治者甚勿妄论伤寒，疟疫未除，误投栀子豉汤、柴、芩、连、柏等药。虽或往来潮热，大小便秘，五苓、承气等药，断不可用。只重产轻邪，大补气血，频服生化汤。如形脱气脱，加生脉散以防血晕。盖川芎味辛能散，干姜能除虚火，虽有便秘烦渴等症，只多服生化汤，自津液生而二便通矣。若热用寒剂，愈虚中气，误甚。

第十三章 产后诸症治法

第一节 血块第一

【原文】：此症勿拘古方，妄用苏木、蓬、棱，以轻人命。其一应散血方、破血药，俱禁用。虽山楂性缓，亦能害命，不可擅用，惟生化汤系血块圣药也。

生化汤原方：

当归八钱，川芎三钱，桃仁十四粒（去皮尖，研），黑姜五分，炙草五分

用黄酒，童便各半，煎服。

傅山曰：又益母丸、鹿角灰，就用生化汤送下一钱，外用烘热衣服，暖和块痛处，虽大暑亦要和暖块痛处。有气不运而晕迷厥，切不可妄说恶血抢心，只服生化汤为妙。俗有生地、牛膝行血；山棱、蓬术败血；山楂、沙糖消块；蕲艾、椒酒定痛，反致昏晕等症，切不可妄用。二、三、四日内，觉痛减可揉，乃虚痛也，宜加参生化汤。

如七日内，或因寒凉食物，结块痛甚者，加入肉桂八分一作三分）於生化汤内。如血块末消，不可加参、耆，用之则痛不止。总之，慎勿用峻利药，勿多饮姜椒艾酒，频服生化汤，行气助血，外用热衣以暖腹。如用红花以行之，苏木、牛膝以攻之，则误。其胎气胀，用乌药、香附以顺之；枳壳、厚朴以舒之，甚有青皮、枳实、苏子以下气定喘；芩、连、栀子、黄柏以退热除烦。至於血结更甚，反用承气汤下之而愈结；汗多小便短涩，反用五苓散通之

而愈秘，非徒无益，而又害之也。

凡儿生下，或停血不下，半月外尚痛，或外加肿毒，高寸许，或身热，减饮食，倦甚，必用生化汤加三棱、蓬术、肉桂等，攻补兼治，其块自消。如虚甚，食少泄泻，只服此帖定痛，且健脾胃，进食止泻，然后服消块汤。

加味生化汤方：

治血块日久不消，半月后方可用之。

川芎一钱，当归三钱，肉姜四分，桃仁（十五粒），三棱六分（醋炒），元胡六分肉桂六分，炙草四分

第二节 血晕第二

【原文】：分娩之后，眼见黑花，头眩昏晕，不省人事者：一因劳倦甚而气竭神昏；二因大脱血而气欲绝；三因痰火乘虚泛上而神不守。当急服生化汤二、三帖，外用韭菜细切，纳有嘴瓶中，用滚醋二盅冲入瓶内，急冲产母鼻中，即醒。若偏信古方，认为恶血抢心，而轻用散血之剂；认为疫火，而用无补消降之方，误甚矣。

生化汤方：

全当归一两，川芎三钱，白术一钱，香附一钱，加人参三钱更妙，用水煎服。

一方，用蓖麻子二两，雄黄二钱，研膏，涂足下涌泉穴，衣下，急速洗去。

傅山曰：如晕厥，牙关紧闭，速煎生化汤，挖开口，将鹅毛探喉，酒盏盛而灌之。如灌下腹中渐温暖，不可拘帖数，外用热手在单衣上，从心揉按至腹，常热火暖之一两时，服生化汤，四帖完，即神清。始少缓药，方进粥，服至十剂而安。故犯此者，速灌药火暖，不可弃而不救。若在冬月，妇人身欠暖，亦有大害，临产时必预煎生化汤，预烧秤盅硬石子，候儿下地，连服二、三帖。又产妇枕边，行醋韭投醋瓶之法，决无晕症。又儿生时，合家不可喜子而慢母，产母不可顾子忘倦，又不可产讫即卧，或忿怒逆气，皆致血晕，慎之，慎之！

加味生化汤方：

治产后三血晕症。

川芎三钱，当归六钱黑姜四分，桃仁（十粒）炙草五分，荆芥四分（炒黑）大枣，水煎服。

傅山曰：劳倦甚而晕，及血崩气脱而晕，并宜速灌两服。如形色脱，或汗出而脱，皆急服一帖，即加人参三、四钱，一加肉桂四分），决不可疑参为补而缓服。痰火乘虚泛上而晕，方内加橘红四分。虚甚加人参二钱。肥人多痰，再加竹沥七分，姜汁少许，总不可用棱术破血等方。其血块痛甚，兼送益母丸，或鹿角灰、或元胡散，或独胜散、上消血块方，服一服即效，不必易方，从权救急。

加参生化汤方：

治产后形色脱晕，或汗多脱晕。

人参三钱，有倍加至五钱者）川芎二钱，当归五钱，炙草四分，桃仁（十粒）炮姜四分，大枣，水煎服。

傅山曰：脉脱形脱，将绝之症，必服此方，加参四、五钱，频频灌之。产后血崩、血晕、兼汗多，宜服此方。无汗不脱，只服本方，不必加参。左尺脉脱，亦加参。此方治产后危急诸症，可通用，一昼一夜，必须服三、四剂，若照常症服，岂能接将绝之气血，扶危急之变症耶！产后一、二日，血块痛虽未止，产妇气血虚脱，或晕或厥、或汗多、或形脱，口气渐凉，烦渴不止，或气喘急，无论块痛，从权用加参生化汤。病势稍退，又当减参，且服生化汤。

加减法：血块痛甚加肉桂七分；渴加麦冬一钱，五味十粒；汗多加麻黄根一钱。如血块不痛，加炙黄耆一钱以止汗；伤饭食面食，加炒神曲一钱，麦芽五分炒；伤肉食，加山楂五

个，砂仁四钱炒。

第三节 厥症第三

【原文】：妇人产有用力过多，劳倦伤脾，故逆冷而厥，气上胸满，脉去形脱，非大补不可，岂钱数川芎、当归能回阳复神乎！必用加参生化汤，倍参，进二剂，则气血旺而神自生矣，厥自止矣。若服药而反渴，另有生脉散，独参代茶饮，救脏之燥。如四肢逆冷，又泄痢类伤寒阴症，又难用四逆汤，必用倍参生化汤，加附子一片，可以回阳止逆，又可以行参、归之力。立二方于下分先后。

加参生化汤方：

治产后发厥，块痛未止，不可加耆、术。

川芎二钱，当归四钱，炙草五分，炮姜四分（一作黑姜）桃仁十粒（去皮尖，研），人参二钱，引加枣一枚

水煎，进二服。

滋荣益气复神汤方：

治产后发厥，问块痛已除可服此方。

人参三钱，黄耆一两，蜜炙），白术一钱（土炒）），当归三钱，炙草四分，陈皮四分，五味（十粒），川芎一钱，熟地一钱，麦芽一钱，枣一枚，水煎服。

手足冷，加附子五分；汗多，加麻黄根一钱，熟枣仁一钱；妄言妄见，加益智、柏子仁、龙眼肉；大便实，加肉从蓉二钱。大抵产后晕厥二症相类。但晕在临盆，症急甚於厥，宜频服生化汤几帖，块化血旺，神清晕止；若多气促形脱等症，必加参、耆。厥在分娩之后，宜倍参生化汤，止厥以复神，并补气血也，非如上偏补气血而可愈也。要知晕有块痛，耆、术不可加；厥症若无块痛，耆、术、地黄，并用无疑也。

第四节 血崩第四

【原文】：产后血大来，审血色之红紫，视形色之虚实。如血紫有块，乃当去其败血也，止留作痛，不可论崩。如鲜红之血，乃是惊伤心不能生血，怒伤肝不能藏血，劳伤脾不能统血，俱不能归经耳，当以崩治，先服生化汤几帖，则行中自有补。若形脱汗多气促，宜服倍参生化汤几帖以益气，非棕灰之可止者。如产后半月外崩，又宜升举大补汤治之，此症虚极，服药平稳，未见速效，须二十帖后，诸症顿除。

生血止崩汤方：

治产后血崩。

川芎一钱，当归四钱，黑姜四分，炙草五分，桃仁（十粒），荆芥五分（炒黑）乌梅五分，〔火段〕灰）蒲黄五分（炒）枣，

水煎。忌姜、椒、热物，生冷。（凡止崩用荆芥，俱宜炒黑。）

傅山曰：鲜红血大来，荆芥穗炒黑、白芷各五分。血竭形败，加参三、四钱。汗多气促，亦加参三、四钱；无汗，形不脱，气促，只服生化汤，多服则血自平。有言归、芎但能活血，甚误。

升举大补汤方：

滋荣益气。如有块动，只服前方，耆、术勿用。

黄耆，白术 陈皮（各四分），人参二钱，炙草，升麻（各四分）当归，熟地（各二钱，麦冬一钱，川芎一钱，白芷四分，黄连三分（炒）荆芥穗四分（炒黑）

汗多，加麻黄根一钱，浮麦炒一小撮；大便不通，加肉从蓉一钱，禁用大黄；气滞，磨木香三分；痰，加贝母六分，竹沥、姜汁少许；寒嗽，加杏仁十粒，桔梗五分，知母一钱；惊，加枣仁、柏子仁各一钱；伤饭，加神曲、麦芽各一钱；伤肉食，加山楂、砂仁各八分，俱加枣、水煎。身热不可加连、柏；伤食怒气，均不可专用耗散无补药。凡年老虚人患崩，宜升举大补汤。

按：症虚极，注中有“身热不可加连、柏”云云。后三页复神汤项下，注有宜用此汤“少佐黄连坠火”云云。设无火可坠，此方内并无热药，无须反佐。恐黄连未可轻用，此处最宜详慎。又注中寒嗽加有知母，既系寒嗽，知母亦未可擅用。此条疑原刊“寒”字有误。

第五节 气短似喘第五

【原文】：因血脱劳甚，气无所恃，呼吸止息，违其常度。有认为痰火，反用散气化痰之方，误人性命，当以大补血为主。如有块，不可用参、耆、术；无块，方可用本方，去桃仁，加熟地并附子一片；足冷，加熟附子一钱，及参、术、陈皮，接续补气养荣汤。

加参生化汤方：

治分娩后即患短气者。有块不可加耆、术。

川芎二钱，当归四钱，炙草五分，炮姜四分（一作黑姜）桃仁十粒（去皮尖，研），人参二钱，引加枣一枚

水煎，进二服。连进二、三帖后，再用后方。

补气养荣汤方：

治产后气短日，血块不痛，宜服此方。

黄耆一钱，白术一钱，当归四钱，人参三钱，陈皮四分，炙草四分，熟地二钱，川芎二钱，黑姜四分

如手足冷，加熟附子一钱；汗多，加麻黄根一钱，浮麦一小撮；渴，加麦冬一钱，五味子十粒；大便不通，加肉从蓉一钱，麻仁一撮；伤面饭，加炒神曲一钱，炒麦芽一钱；伤肉食，加山楂、砂仁各五分。

按：麦芽有回乳之害，用者慎之！黄耆、白术一作各二钱。凡止汗用浮麦宜炒。

第十四章 妄言妄见第六

【原文】：由气血虚，神魂无依也，治当论块痛有无缓急。若块痛未除，先服生化汤二、三帖，痛止，继服加参生化汤，或补中益气汤，加安神定志丸调服之。若产日久，形气俱不足，即当大补气血，安神定志，服至药力充足，其病自愈。勿谓邪祟，若喷以法水惊之，每至不救。屡治此症，服药至十数帖方效。病虚似邪，欲除其邪，先补其虚，先调其气，次论诸病，此古人治产后虚症，及年老虚喘，弱人妄言，所当用心也。

安神生化汤方：

治产后块痛未止，妄言妄见症，未可用耆、术。

川芎一钱，柏子仁一钱，人参一、二钱，当归二、三钱，茯神二钱，桃仁（十二粒）黑姜四分，炙草四分，益智八分（炒），陈皮三分，枣

水煎。

滋荣益气复神汤方：

块痛已止，妄言妄见，服此方即愈。

黄耆，白术 麦冬，川芎 柏子仁，茯神 益智（各一钱，陈皮三分人参，熟地（各二钱炙草四分，五味子（十粒）枣仁（十粒、一钱，莲子（八枚）元肉（八个）枣，水煎服。

傅山曰：产后血崩、血脱、气喘、气脱，神脱、妄言，虽有血气阴阳之分，其精散神去一也。比晕后少缓，亦危症也。若非厚药频服，失之者多矣。误论气实痰火者，非也。新产有血块痛，并用加参生化汤，行中有补，斯免滞血血晕之失也。其块痛止，有宜用升举大补汤，少佐黄连，坠火以治血脱，安血归经也；有宜用倍参补中益气汤，少佐附子，助参以治气脱，摄气归渊也；有宜用滋荣益气复神汤，少佐痰剂，以清心火，安君主之官也。

第十五章 伤食第七

【原文】：新产后禁膏粱，远厚味。如饮食不节，必伤脾胃。治当扶元，温补气血，健脾胃。审伤何物，加以消导诸药。生化汤加神曲、麦芽以消面食；加山楂、砂仁以消肉食；如寒冷之物，加吴萸、肉桂；如产母虚甚，加人参、白术。又有块，然后消补并治，无有不安者。屡见治者不重产后之弱，惟知速消伤物，反损真气，益增满闷。可不慎哉！

加味生化汤方：

治血块未消，服此以消食。

川芎二钱，当归五钱，黑姜四分，炙草五分，桃仁（十粒）

问伤何物，加法如前，煎服

健脾消食生化汤方：

治血块已除，服此消食。

川芎一钱，人参、当归（各二钱，白术一钱半，炙草五分

审伤何物，加法如前。如停寒物日久，脾胃虚弱，恐药不能运用，可用揉按，炒神曲熨之，更妙。凡伤食误用消导药，反绝粥几日者，宜服此方

长生活命丹方：

人参三钱，水一盅半，煎半盅。先用参汤一盏，以米饭锅焦研粉三匙，渐渐加参汤、焦锅粉，引开胃口。煎参汤用新罐或铜勺，恐闻药气要呕也。如服寒药伤者，加姜三大片煎汤。

人参名活命草，锅焦名活命丹，此方曾救活数十人。

第十六章 忿怒第八

【原文】：产后怒气逆，胸膈不利，血块又痛，宜用生化汤去桃仁。服时磨木香二分在内，则块化怒散，不相悖也。若轻产重气，偏用木香、乌药、枳壳、砂仁之类，则元气反损，益增满闷。又加怒后即食，胃弱停闷。当审何物，治法如前。慎勿用木香槟榔丸、流气引子之方，使虚弱愈甚也。

木香生化汤方：

治产后血块已除，因受气者。

川芎二钱，当归六钱，陈皮三分，黑姜四分

服时磨木香二分在内。此方减桃仁，用木香、陈皮。前有减干姜者，详之

健脾化食散气汤方：

治受气伤食，无块痛者。

白术二钱，当归二钱，川芎一钱，黑姜四分，人参二钱，陈皮三钱，

审伤何物，加法如前。

傅山曰：大抵产后忿怒气逆及停食二症，善治者，重产而轻怒气消食，必以补气血为先，佐以调肝顺气，则怒郁散而元不损；佐以健脾消导，则停食行而思谷矣。若专理气消食，非徒无益，而又害之。

注家曰：陈皮一作三分。又有炙草四分，存参。）

第十七章 类疟第九

【原文】：产后寒热往来，每日应期而发，其症似疟，而不可作疟治。夫气血虚而寒热更作，元气虚而外邪或侵，或严寒、或极热、或昼轻夜重、或日晡寒热，绝类疟症，治当滋荣益气，以退寒热。有汗宜急止，或加麻黄根之类；只头有汗而不及于足，乃孤阳绝阴之危症，当加地黄、当归之类；如阳明无恶寒，头痛无汗，且与生化汤，加羌活、防风、连须、葱白数根以散之。其柴胡清肝饮等方，常山、草果等药，俱不可用。

滋荣养气扶正汤方：

治产后寒热有汗，午后应期发者。

人参二钱，炙黄耆 白术，川芎 熟地，麦冬 麻黄根（各一钱，当归三钱，陈皮四分，炙草五分，枣水煎。

加减养胃汤方：

治产后寒热往来，头痛无汗类疟者。

炙草四分，白茯苓一钱，半夏（八分（制），川芎一钱，陈皮四分，当归二钱苍术一钱，藿香四分，人参一钱，

姜引煎服。有痰加竹沥、姜汁、半夏、神曲，弱人兼服河车丸。凡久疟不愈，兼服参术膏以助药力。

参术膏：

白术一斤，米泔浸一宿，锉焙，人参一两。

用水六碗，煎二碗，再煎二次，共计六碗，合在一处，将药汁又熬成一碗，空心米汤化半酒盏。

第十八章 类伤寒二阳症

【原文】：产后七日内，发热头痛恶寒，毋专论伤寒为太阳症；发热头痛胁痛，毋专论伤寒为少阳症，二症皆由气血两虚，阴阳不和而类外感。治者慎勿轻产后热门，而用麻黄汤以治类太阳症；又勿用柴胡汤以治类少阳症。且产母脱血之后，而重发其汗，虚虚之祸，可胜言哉！昔仲景云：“亡血家不可发汗。”丹溪云：“产后切不可发表。”二先生非谓产后真无伤寒之兼症也，非谓麻黄汤、柴胡汤之不可对症也，诚恐后辈学业偏门而轻产，执成方而发表耳。谁知产后真感风感寒，生化中芎、姜亦能散之乎！

加味生化汤方：

治产后三日内发热头痛症。

川芎，防风各一钱，当归三钱，炙草四分桃仁（十粒），羌活四分（一本无桃仁，有黑姜四分）

傅山曰：查刊本去桃仁。然必须问有块痛与否，方可议去。服二帖后，头仍痛，身仍热，加白芷八分、细辛四分；如发热不退，头痛如故，加连须葱五个、人参三钱。产后败血不散，亦能作寒作热，何以辨之？曰：时有刺痛者，败血也；但寒热无他症者，阴阳不和也。刺痛用当归，乃和血之药；若乃积血而刺痛者，宜用红花、桃仁、归尾之类。

第一节 类伤寒三阴症

【原文】：潮热有汗，大便不通，毋专论为阳明症；口燥咽干而渴，毋专论为少阴症；腹满液干，大便实，毋专论为太阴症；又汗出谵语便闭，毋专论为肠胃中燥粪宜下症。数症多由劳倦伤脾，运化稽迟，气血枯槁，肠腑燥涸，乃虚症类实，当补之症，治者勿执偏门轻产，而妄议三承气汤，以治类三阴之症也。间有少壮产后妄下，幸而无妨；虚弱产妇亦复妄下，多致不救。屡见妄下成膨，误导反结。又有血少，数日不通，而即下致泻不止者，危哉！《妇人良方》云：产后大便秘，若计其日期，饭食数多，即用药通之，祸在反掌。必待腹满觉胀，欲去不能者，反结在直肠，宜用猪胆汁润之。若日期虽久，饮食如常，腹中如故，只用补剂而已。若服苦寒疏通，反伤中气，通而不止，或成痞满，误矣！

养正通幽汤方：

治产后大便秘结类伤寒三阴症。

川芎二钱半，当归六钱炙草五分，桃仁（十五粒）麻仁二钱（炒），肉从蓉（酒洗去甲，一钱

汗多便实，加黄耆一钱，麻黄根一钱，人参二钱；口燥渴，加人参、麦冬各一钱；腹满溢便实，加麦冬一钱，枳壳六分，人参二钱，苁蓉一钱；汗出谵语便实，乃气血虚竭，精神失守，宜养荣安神，加茯神、远志、苁蓉各一钱，人参、白术各二钱，黄耆、白芷各一钱，柏子仁一钱。

以上数等大便燥结症，非用当归，人参至斤数，难取功效。大抵产后虚中伤寒，口伤食物，外症虽见头痛发热，或胁痛腰痛，是外感宜汗，犹当重产亡血禁汗。惟宜生化汤，量为加减，调理无失。又如大便秘结，犹当重产亡血禁下，宜养正助血通滞，则稳当矣。

又润肠粥：

治产后日久大便不通。

芝麻一升，研末，和米二合，煮粥食，肠润即通。

第二节 类中风

【原文】：产后气血暴虚，百骸少血濡养，忽然口噤牙紧，手足筋脉拘搐等症，类中风痫痉，虽虚火泛上有痰，皆当以末治之，勿执偏门，而用治风消痰之方，以重虚产妇也。治法当先服生化汤，以生旺新血。如见危症，三服后，即用加参，益气以救血脱也；如有痰火，少佐橘红、炒芩之类，竹沥、姜汁亦可加之，黄柏、黄连切不可并用，慎之！

滋荣活络汤方：

治产后血少口噤项强筋搐类风症。

川芎一钱半，当归熟地，人参（各二钱黄耆，茯神天麻（各一钱，炙草陈皮，荆芥穗防风，羌活（各四分）黄连（八分，姜汁炒）

有痰，加竹沥、姜汁、半夏；渴加麦冬、葛根；有食，加山楂、砂仁以消肉食，神曲、麦芽以消饭食；大便闭，加肉从蓉一钱半；汗多，加麻黄根一钱；惊

悸，加枣仁一钱。

天麻丸：

治产后中风恍惚语涩四肢不利。

天麻一钱，防风一钱，川芎七分，羌活七分人参，远志柏子仁，山药麦冬（各一钱，枣仁一两，细辛一钱，南星曲八分石菖蒲一钱，

研细末，炼蜜为丸，辰砂为衣，清汤下六、七十丸。（一本枣仁用一钱，细辛用四分，存参。）

第三节 类痉

原文：产后汗多，即变痉者，项强而反，气息如绝，宜速服加减生化汤。

加减生化汤方：

专治有汗变痉者。

川芎，麻黄根各一钱，当归四钱，桂枝五分，人参一钱，炙草五分，羌活五分，天麻八分，附子一片，羚羊角八分。

如无汗类痉者中风，用川芎三钱，当归一两（酒洗），枣仁、防风俱无份量。（一本心引用生姜一片，枣一枚。）

第四节 出汗

【原文】：凡分娩时汗出，由劳伤脾，惊伤心，恐伤肝也。产妇多兼三者而汗出，不可即用敛汗之剂，神定而汗自止。若血块作痛，耆、术未可遽加，宜服生化汤二、三帖，以消块痛，随继服加参生化汤，以止虚汗。若分娩后倦甚，濈濈然汗出，形色又脱，乃亡阳脱汗也；汗本亡阳，阳亡则阴随之，故又当从权，速灌加参生化汤，倍参以救危，毋拘块痛。妇人产多汗，当健脾以敛水液之精，益荣卫以嘘血归源，灌溉四肢，不使妄行。杂症虽有自汗、盗汗之分，然当归六黄汤不可治产后之盗汗也，并宜服加参生化汤及加味补中益气二方；若服参耆而汗多不止，及头出汗而不至腰足，必难疗矣；如汗出而手拭不及者，不治。产后汗出气喘等症，虚之极也，不受补者，不治。

麻黄根汤方：

治产后虚汗不止。

人参二钱，当归二钱，黄耆一钱半（炙），白术一两（炒），桂枝五分，麻黄根一钱，粉草五分（炒），牡蛎（研，少许），浮麦一大撮。

虚脱汗多，手足冷，加黑姜四分，熟附子一片；渴加麦冬一钱，五味十粒。肥白人产后多汗，加竹沥一盏，姜汁一小匙，以清痰火。恶风寒，加防风、桂枝各五分；血块不落，加熟地三钱，晚服八味地黄丸。

八味地黄丸：

山茱萸、山药、丹皮、云苓各八钱，泽泻五钱，熟地八钱，五味子五钱，炙黄耆一两，炼蜜为丸。

阳加於阴则汗，因而遇风，变为瘈疭者有之，尤难治。故汗多，宜谨避风寒。汗多小便不通，乃亡津液故也，勿用利水药。

第五节 盗汗

【原文】：产后睡中汗出，醒来即止，犹盗瞰入睡，而谓之盗汗，非汗自至之比。《杂症论》云：“自汗阳亏，盗汗阴虚”。然当归六黄汤又非产后盗汗方也，惟兼气血而调治之，乃为得耳。

止汗散：

治产后盗汗。

人参二钱，当归二钱，熟地一钱半，麻黄根五分，黄连五分（酒炒），浮小麦一大撮），枣一枚

又方：止汗散 2：

牡蛎五分（煅细末），小麦面（炒黄，研末）。（一本：牡蛎、小麦炒黄，各五分，空心调服。），

第六节 口渴兼小便不利

【原文】：产后烦躁，咽干而渴，兼小便不利，由失血汗多所致，治当助脾益肺，升举气血，则阳升阴降，水入经而为血为液，谷入胃而气长脉行，自然津液生而便调利矣。若认口渴为火，而用芩、连、栀、柏以降之，认小便不利为水滞，而用五苓散以通之，皆失治也。必因其劳损而温之益之，因其留滞而濡之行之，则庶几矣。

生津止渴益水饮

人参，麦冬当归，生地（各三钱黄耆一钱，葛根一钱，升麻，炙草（各四分）茯苓八分，五味子（十五粒）

汗多，加麻黄根一钱，浮小麦一大撮；大便燥，加肉从蓉一钱分；渴甚，加生脉散，不可疑而不用。

第七节 遗尿

【原文】：气血太虚，不能约束，宜八珍汤加升麻、柴胡，甚者加熟附子一片。

八珍汤方（八珍散）《瑞竹堂经验方》

【主治】气血两虚证。面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力。

人参，白术，白茯苓，当归，川芎，白芍药，熟地黄，甘草炙，各一两(30g)

上哎咀，每服三钱(9g)，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓，不拘时候，通口服（现代用法：或作汤剂，加生姜 3 片，大枣 5 枚，水煎服，用量根据病情酌定）。

【功用】益气补血。

【方解】本方所治气血两虚证多由久病失治、或病后失调、或失血过多而致，病在心、脾、肝三脏。心主血，肝藏血，心肝血虚，故见面色苍白、头晕目眩、心悸怔忡、舌淡脉细；脾主运化而化生气血，脾气虚，故面黄，肢倦、气短懒言、饮食减少、脉虚无力。治宜益气与养血并重。房中人参与熟地相配，益气养血，共为君药。白术、茯苓健脾渗湿，助人参益气补脾；当归、白芍养血和营，助熟地滋养心肝，均为臣药。川芎为佐，活血行气，使地、归、芍补而不滞。炙甘草为使，益气和中，调和诸药。全方八药，实为四君子汤和四物汤的

复方。用法中加入姜、枣为引，调和脾胃，以资生化气血，亦为佐使之药。

【运用】

1. 辨证要点 本方是治疗气血两虚证的常用方。临床应用以气短乏力，心悸眩晕，舌淡，脉细无力为辨证要点。

2. 加减变化：若以血虚为主，眩晕心悸明显者，可加大地、芍用量；以气虚为主，气短乏力明显者，可加大参、术用量；兼见不寐者，可加酸枣仁、五味子。

3. 现代运用：本方常用于病后虚弱、各种慢性病，以及妇女月经不调等属气血两虚者。

产后编下卷

第十九章 产后诸症治法（续上）

第一节 误破尿胞

【原文】：产理不顺，稳婆不精，误破尿胞膀胱者，用参、芪为君，归、芎为臣，桃仁、陈皮、茯苓为佐，猪羊尿胞煎药，百服乃安。

又方云：用生黄丝绢一尺，白牡丹皮根为末，白芨末各二钱，水二碗，煮至绢烂如饴，服之。宜静卧，不可作声，名补脬饮，神效。

注家曰：胞破，女科下卷另有方，极妥且效。

补脬饮方：

生黄丝绢一尺，白牡丹皮根为末，白芨末各二钱。

水二碗，煮至绢烂如饴，服之。宜静卧，不可作声，神效。

第二节 患淋

【原文】：由产后虚弱，热客于脬中，内虚频数，热则小便淋涩作痛，曰淋。

茅根汤方：

凡产后冷热淋并治之。

石膏一两，白茅根一两，瞿麦，白茯苓（各五钱葵子，人参桃胶，滑石（各一钱，石首鱼头四个）

灯心水煎，入齿末，空心服。

一本小注载：症由内虚，方用石膏一两，无此治法，不可拘执陈方以致误人。一本石膏作一钱，无滑石。一作各等分。

又方：治产后小便痛淋血。

白茅根，翟麦葵子，车前子通草（以上俱无份量），鲤鱼齿一百个）

水煎服。亦入齿末。

按：齿末，疑均是鲤鱼齿。

第三节 便数

【原文】：由脬内素有冷气，因产发动，冷气入脬故也。用赤石脂二两为末，空心服。又方：治小便数及遗尿，用益智仁二十八枚为末，米饮送下二钱。又：

又：桑螵蛸散

桑螵蛸三十个），人参黄芪，鹿茸牡蛎，赤石脂（各三钱

为末，空心服二钱，米饮送下。

第四节 泻第

【原文】：产后泄泻，非杂症有食泄、湿泄、水谷注下之论，大率气虚食积与湿也。气虚宜补、食积宜消、湿则宜燥。然恶露未净，遽难骤燥，当先服生化汤二三帖，化旧生新，加茯苓以利水道，俟血生，然后补气以消食，燥湿以分利水道，使无滞涩虚虚之失。若产旬日外，方论杂症，尤当论虚实而治也。如痛下清水，腹鸣，米饮不化者，以寒泄治；如粪水黄赤，肛门作痛，以热泄治之。有因饮食过多，伤脾成泄，气臭如败卵，以食积治之。又有脾气久虚少食，食下即鸣，急尽下所食之物方觉快者，以虚寒泄治之。治法寒则温之，热则清之，脾伤食积，分利健脾，兼消补虚，善为调治，无失也。产后虚泻，眠昏人不识，弱甚形脱危症，必用人参二钱，白术、茯苓各二钱，附子一钱，方能回生。若脉浮弦，按之不鼓，即为中寒，此盖阴先亡而阳欲去，速宜大补气血，加附子、黑姜以回元阳，万勿忽视。

加减生化汤方：

治产后块未消患泻症。

川芎二钱，茯苓二钱，当归四钱，黑姜五分，炙草五分，桃仁（十粒），莲子八枚。

水煎，温服。

健脾利水生化汤方：

治产后块已除，患泻症。

川芎一钱，茯苓一钱半归身二钱，黑姜四分陈皮五分，炙草五分人参三钱，肉果一个（制）白术一钱（土炒）），泽泻八分

寒泻，加干姜八分；寒痛，加砂仁、炮姜各八分；热泻，加炒黄连八分；泻水腹痛，米饮不化，加砂仁八分，麦芽、山楂各一钱；泻有酸嗳臭气，加神曲、砂仁各八分。脾气久虚，泻出所食物方快，以虚寒论；泻水者，加苍术一钱以燥湿；脾气弱，元气虚，必须大补，佐消食清热却寒药。弱甚形色脱，必须第一方，参、术、苓、附，必用之药也。诸泻俱加升麻酒炒，莲子十粒。

第五节 完谷不化

【原文】：因产后劳倦伤脾，而运转稽迟也，名飧泄；又饮食太过，脾胃受伤，亦然，俗呼水谷痢是也。然产方三日内，块未消化，此脾胃衰弱，参、耆、术未可遽加，且服生化汤加益智、香、砂，少温脾气，俟块消后，加参、耆、术补气，肉果、木香、砂仁、益智温胃，升麻、柴胡清胃气，泽泻、茯苓、陈皮以利水，为上策也。

加味生化汤方：

治产后三日内完谷不化，块未消者。

川芎一钱，益智一钱，当归四钱，黑姜四分，炙草四分，桃仁十粒，茯苓一钱半。

一本当归作三钱，有枣一枚。

参苓生化汤方：

治产后三日内块已消，谷不化，胎前素弱患此症者。

川芎一钱，当归二钱，黑姜四分，炙草五分，人参二钱，茯苓一钱，白芍一钱（炒），益智一钱（炒），白术二钱（土炒），肉果一个（制）

泻水多，加泽泻、木通各八分；腹痛，加砂仁八分；渴，加麦冬、五味子；寒泻，加黑姜一钱，木香四分；食积，加神曲、麦芽消饭面，砂仁、山楂消肉食。

/1 产后泻痢日久，胃气虚弱，完谷不化，宜温助胃气，六君子汤加木香四分，肉果一个（制）。

注家曰：一本有莲子八枚，去心，枣三枚。）

第六节 痢

【原文】：产后七日内外，患赤白痢，里急后重频并，最为难治。欲调气行血，而推荡痢邪，犹患产后元气虚弱；欲滋荣益气，而大补虚弱，又助痢之邪，惟生化汤减干姜，而代以木香、茯苓，则善消恶露，而兼治痢疾，并行而不相悖也。再服香连丸，以俟一、二日后，病势如减，可保无虞。若产七日外，有患褐花色后重，频并虚痢，即当加补无疑。若产妇禀厚，产期已经二十馀日，宜服生化汤加连、芩、厚朴、芍药行积之剂。

一本作十数日。）

加减生化汤方：

治产后七日内患痢。

川芎二钱，当归五钱，炙草五分，桃仁十二粒，茯苓一钱，陈皮四分，木香三分（磨）

红痢腹痛，加砂仁八分。

青血丸：

治噤口痢。

香连为末，加莲肉粉，各一两半，和匀为丸，酒送下四钱。

凡产三，四日后，块散，痢疾少减，共十症，开后依治：

一产后久泻：元气下陷，大便不禁，肛门如脱，宜服六君子汤，加木香四分，肉果一个（制），姜汁五分；

二产后泻痢：色黄，乃脾土真气虚损，宜服补中益气汤，加木香、肉果；

三产后伤面食：泻痢，宜服生化汤，加神曲、麦芽；

（一本神曲，麦芽下有各一钱。）

四产后伤肉食：泻痢，宜服生化汤，加山楂、砂仁；

五产后胃气虚弱：泻痢，完谷不化，当温助胃气，宜服六君子汤，加木香四分，肉果一个（制）；

六产后脾胃虚弱：四肢浮肿，宜服六君子汤，加五皮散（见后水肿）；

七产后泻痢：无后重，但久不止，宜服六君子汤，加木香、肉果；

八产后赤白痢：脐下痛，当归、厚朴、黄连、肉果、甘草，桃仁、川芎；

九产后久痢：色赤，属血虚，宜四物汤，加荆芥、人参；

十产后久痢：色白，属气虚，宜六君子汤，加木香、肉果。

第七节 霍乱

【原文】：由劳伤气血，脏腑空虚，不能运化食物，及感冷风所致，阴阳升降不顺，清浊乱于脾胃，冷热不调，邪正相搏，上下为霍乱。

生化六和汤方：

治产后血块痛未除，患霍乱。

川芎二钱，当归四钱，黑姜、炙草、陈皮，藿香各四分，砂仁六分，茯苓一钱，姜三片，

水煎。

附子散：

治产后霍乱吐泻，手足逆冷，须无块痛方可服。

白术一钱，当归二钱陈皮，黑姜丁香，甘草（各四分）

共为末，粥饮送下二钱。（一本有附子五分。）

温中汤方：

治产后霍乱吐泻不止，无块痛者可服。

人参一钱，白术一钱半 当归二钱，厚朴八分，黑姜四分，茯苓一钱，草豆蔻六分，姜三片。

水煎服。

第八节 呕逆不食

【原文】：产后劳伤脏腑，寒邪易乘于肠胃，则气逆呕吐而不下食也。又有瘀血未净而呕者，亦有痰气入胃，胃口不清而呕者，当随症调之。

加减生化汤方：

治产妇呕逆不食。

川芎一钱，当归三钱，黑姜、砂仁、藿香各五分，淡竹叶七片

水煎，和姜汁二匙服。

温胃丁香散：

治产后七日外呕逆不食。

当归三钱，白术二钱，黑姜四分，丁香四分，人参一钱，陈皮五分，炙草五分，前胡五分，藿香五分，姜三片。

水煎服。

石莲散：

治广妇呕土心冲目弦。

石莲子（去壳，去心，一两半）白茯苓一两，丁香五分

共为细末，米饮送下。一本有白术，无白茯苓，丁香作五钱，用者酌之。

生津益胃汤方：

治产妇虚弱，口渴气少，由产后血少多汗内烦不生津液。

人参，麦冬（去心）茯苓（各一两），大枣竹叶，浮小麦炙草，栝蒌根大渴不止，加芦根。

一本人参一钱，麦冬茯、苓三钱，存参。

第九节 咳嗽

【原文】：治产后七日内，外感风寒，咳嗽鼻塞，声重恶寒，勿用麻黄以动汗；嗽而胁痛，勿用柴胡汤；嗽而有声，痰少面赤，勿用凉药。凡产有火嗽，有痰嗽，必须调理半月后，方可用凉药，半月前不当用。

加味生化汤方：

治产后外感风寒咳嗽及鼻塞声重。

川芎一钱，当归二钱，杏仁十粒，桔梗四分，知母八分。

有痰加半夏曲；虚弱有汗咳嗽，加人参。总之产后不可发汗。（知母一本作四分）。

加参安肺生化汤方：

治产后虚弱，旬日内外感风寒，咳嗽声重有痰，或身热头痛及汗多者。

川芎一钱，人参一钱，知母一钱，桑白皮一钱，当归二钱，杏仁十粒（去皮尖），甘草四分，桔梗四分，半夏七分，橘红三分。

虚人多痰，加竹沥一杯，姜汁半匙。

按：咳嗽论中，明示纵有火嗽，在半月前，犹不得轻用凉药，垂戒綦严。而第一与第二方中，均有知母，小注均有“外感风寒”云云。此必于既感之后，将蕴而为燥热，不得已而用之，小注未及申明。如谓不然，苟初感即用此凉品，岂不与前论显为枘凿。读者须会前人微意，庶不致用古方而自少权衡耳。

加味四物汤方：

治半月后干嗽有声，痰少者。

川芎、白芍、知母、瓜蒌仁各一钱，生地、当归各二钱，诃子二钱，冬花六分，桔梗四分，甘草四分，兜铃四分，生姜一大片

第十节 水肿

傅山曰：产后水气，手足浮肿，皮肤见光荣色，乃脾虚不能制水，肾虚不能行水也。

必以大补气血为先，佐以苍术、白术、茯苓补脾；壅满，用陈皮、半夏、香附消之；虚火，加人参、木通；有热，加黄芩、麦冬以清肺金。健脾利水，补中益气汤；七日外，用人参、白术各二钱，茯苓、白芍各一钱，陈皮五分，木瓜八分，紫苏、木通、大腹皮、苍术、厚朴各四分；大便不通，加郁李仁、麻仁各一钱。如因寒邪湿气伤脾，无汗而肿，宜姜皮、半夏，苏叶加于补气方，以表汗。

五皮散：

治产后风湿客伤脾经，气血凝滞，以致面目浮虚，四肢肿胀气喘。

五加皮，地骨皮 大腹皮，茯苓皮各一钱，姜皮一钱，枣一枚，水煎服。

又云，产后恶露不净，停留胞络，致令浮肿，若以水气治之，投以甘遂等药，误矣！但服调经散，则血行而肿消矣。

调经散：

没药（另研），琥珀（另研，各一钱肉桂，赤芍 当归（各一钱

上为细末，每服五分，姜汁、酒各少许，调服。

（此方能调经治腹痛。）

第十一节 流注

【原文】：产后恶露流于腰臂足关节之处，或漫肿、或结块，久则肿起作痛，肢体倦怠，急宜用葱熨法以治外肿；内服参归生化汤以消血滞，无缓也。未成者消，已成者溃。

葱熨法：

用葱一握，炙热，捣烂作饼，敷痛处，用厚布二、三层，以熨斗，火熨之。

参归生化汤方：

川芎一钱半，当归二钱，炙草五分，人参二钱，黄耆一钱半，肉桂五分，马蹄香二钱。

傅山曰：此症若不补气血，节饮食，慎起居，未有得生者。如肿起作痛，起居饮食如常，是病气未深，形气未损，易治；若漫肿微痛，起居倦怠，饮食不足，最难治。或未成脓，未溃，气血虚也，宜服八珍汤；憎寒恶寒，阳气虚也，宜服十全大补汤；补后大热，阴血虚也，宜服四物汤，加参、术、丹皮；呕逆，胃气虚也，宜服六君子汤，加炮姜、干姜；食少体倦，脾气虚也，宜服补中益气汤；四肢冷逆，小便频数，肾气虚也，补中益气汤加益智仁一钱。神仙回洞散治产后流注恶露，日久成肿，用此宜导其脓，若未补气血旺，不可服此方。

第十二节 膨胀

【原文】：其人素弱，临产又劳，中气不足，胸膈不利，而转运稽迟，若产后即服生化汤以消块止痛，又服加参生化汤以健脾胃，自无中满之症。其膨胀，因伤食而误消，因气郁而误散，多食冷物而停留恶露；又因血虚大便燥结，误下而愈胀；殊不知气血两虚，血块消后，当大补气血，以补中虚。治者若但知伤食宜消，气郁宜散，恶露当攻，便结可下，则胃气反损，满闷益增，气不升降，湿热积久，遂成膨胀。岂知消导坐于补中，则脾胃强，而所伤食气消散；助血兼行，大便自通，恶露自行。

如产后中风，气不足，微满，误服耗气药而胀者，服补中益气汤。

补中益气汤方：

人参五分，当归五分，白术五分，白茯苓一钱，川芎四分，白芍四分，萝卜子四分，木香三分。

一本人参、白术俱作一钱，当归作二钱，有姜一片。

如伤食，误服消导药成胀；或胁下积块，宜服健脾汤

健脾汤

人参、白术、当归各三钱，白茯苓、白芍、神曲、吴萸各一钱，大腹皮、陈皮各四分，砂仁、麦芽各五分。

一本人参、白术作二钱。

如大便不通，误服下药成胀，及腹中作痛，宜服养荣生化汤。

养荣生化汤方：

当归四钱，白芍一钱，白茯苓一钱，人参一钱，白术二钱，陈皮五分大腹皮五分，香附五分，从蓉一钱，桃仁十粒（制）

块痛，将药送四消丸。屡误下，须用参、归半斤，大便方通，膨胀方退。凡误用消食耗气药，以致绝谷，长生活命丹屡效。方见伤食条。

一本无桃仁。

第十三节 怔忡惊悸

【原文】：由产忧惊劳倦，去血过多，则心中跳动不安，谓之怔仲；若惕然震惊，心中怯怯，如人将捕之状，谓之惊悸。治此二症，惟调和脾胃，志定神清而病愈矣。如分娩后血块未消，宜服生化汤，且补血行块，血旺则怔定惊平，不必加安神定志剂。如块消痛止后患此，宜服加减养荣汤。

加减养荣汤方：

当归二钱，川芎二钱茯神一钱，人参一钱，枣仁一钱（炒），麦冬一钱，远志一钱，白术一钱，黄耆一钱（炙），元肉（八枚）陈皮四分，炙草四分

姜煎。虚烦加竹沥、姜汁，去川芎、麦冬，再加竹茹一团；加木香，即归脾汤

养心汤方：

治产后心血不定，心神不安。

炙黄耆一钱，茯神八分川芎八分，当归二钱麦冬一钱八分），远志八分柏子仁一钱，人参一钱半炙草四分，五味（十粒）姜。

水煎服。一本有元肉六枚。

第一节 骨蒸

【原文】：宜服保真汤。先服清骨散。

柴胡梅连汤方：

即清骨散作汤，速效。

柴胡，前胡，黄连，乌梅（去核）

各二两，共为末听用；再将猪脊骨一条，猪苦胆一个，韭菜白十根，各一寸，同捣成泥，入童便一酒盏，搅如稀糊，入药末，再捣，为丸如绿豆大，每服三四十丸，清汤送下。如上膈热多，食后服。此方凡男女骨蒸皆可用之，不专治产妇。

保真汤方：

黄耆六分，人参二钱白术二钱（炒），炙草四分川芎六分，当归二钱天冬一钱，麦冬二钱白芍二钱，枸杞二钱黄连六分（炒），黄柏六分（炒）知母二钱，生地二钱

五味（十粒），地骨皮六分枣三枚，去核，水煎服。

一本无麦冬、黄连。）

加味大造汤方：

治骨蒸劳热。若服清骨散、梅连丸不效服此方。

人参一两，当归一两，麦冬八分，石斛八分（酒蒸）柴胡六钱，生地二两，胡连五钱，山药一两，枸杞一两，黄柏七分（炒）

先将麦冬、地黄捣烂，后入诸药同捣为丸，加蒸紫河车另捣，焙干为末，炼蜜丸。

一本麦冬、石斛仅作八钱，柴胡五钱，黄柏四分（酒炒）。

第二节 心痛第

【原文】：此即胃脘痛。因胃脘在心之下，劳伤风寒，及食冷物而作痛，俗呼为心痛。心可痛乎！血不足，则怔仲惊悸不安耳。若真心痛，手足青黑色，旦夕死矣。治当散胃中之寒气，消胃中之冷物，必用生化汤，佐消寒食之药；无有不安。若绵绵而痛，可按止之，问无血块，则当论虚而加补也。产后心痛、腹痛，二症相似，因寒食与气上攻于心，则心痛；下攻于腹，则腹痛，均用生化汤加肉桂、吴萸等温散之药也。

加味生化汤方：

川芎一钱，当归三钱，黑姜五分，肉桂八分，吴萸八分，砂仁八分，炙草五分

伤寒食，加肉桂、吴萸；伤面食，加神曲、麦芽；伤肉食，加山楂、砂仁；大便不通，加肉从蓉。

第三节 腹痛

【原文】：先向有块无块。块痛，只服生化汤，调失笑散二钱，加元胡一钱；无块，则是遇风冷作痛，宜服加减生化汤。

加减生化汤方：

川芎一钱，当归四钱，黑姜四分，炙草四分，防风七分，吴萸六分，白蔻五分，桂枝七分

痛止去之。随伤食物，所加如前。

第四节 小腹痛

【原文】：产后虚中，感寒饮冷，其寒下攻小腹作痛；又有血块作痛者；又产后血虚脐下痛者，并治之以加减生化汤。

加减生化汤方：

川芎一钱，当归三钱，黑姜四分，炙草四分，桃仁十粒

有块痛者，本方中送前胡散，亦治寒痛；若无块，但小腹痛，亦可按而少止者，属血虚，加熟地三钱，前胡、肉桂各一钱为末，名前胡散。

第五节 虚劳

当归黄耆人参韭白猪肾汤方：

指节冷痛，头汗不止。

人参三钱，当归三钱，黄耆二钱，淡豆豉十粒，生姜三片，韭白十寸，猪肾二个。

先将猪肾煮熟，取汁煎药八分，温服。（一本有或用猪胃一个。先将胃略煮后再煎汤煮药。）

罗注：韭白十寸，恐怕为十只。当归黄芪汤，又叫当归补血汤。

第六节 遍身疼痛

【原文】：产后百节开张，血脉流散，气弱则经络间血多阻滞，累日不散，则筋牵脉引，骨节不利，故腰背不能转侧，手足不能动履，或身热头痛，若误作伤寒，发表出汗，则筋脉动荡，手足发冷，变症出焉，宜服趁痛散。

趁痛散方：

当归一钱，甘草、黄耆、白术、独活各八分，肉桂八分，桑寄生一钱，牛膝八分，薤白五根，姜三片。

水煎服。一本无桑寄生。

第七节 腰痛

【原文】：由女人肾位系胞，腰为肾腑，产后劳伤肾气，损动胞络，或虚未复而风乘之也。

养荣壮肾汤方：

治产后感风寒，腰痛不可转。

当归二钱，防风四分，独活、桂心、杜仲、续断、桑寄生各八分，生姜三片

水煎服。两帖后痛未止，属肾虚，加熟地三钱。一本川芎八分。

加味大造丸：

治产后日久，气血两虚，腰痛肾弱，方见骨蒸条。

青娥丸：

胡桃十二个，破故纸八两（酒浸，炒），杜仲一斤（姜汁炒，去丝）

为细末，炼蜜丸，淡醋汤送六十丸。

第八节 胁痛

【原文】：乃肝经血虚气滞之故。气滞，用四君子汤加青皮、柴胡；血虚，用四物汤加柴胡、人参、白术。若概用香燥之药，则反伤清和之气，无所生矣。

补肺散：

治胁痛。

山萸、当归、五味、山药、黄耆、川芎、熟地、木瓜、白术、独活、枣仁（各等分）

水煎服。

一本山萸二钱，当归二钱，五味十粒，黄耆八分，川芎六分，熟地钱半，木瓜、白术各一钱，独活八分，枣仁一钱，姜一片，无山药，存参。

第九节 阴痛

【原文】：产后起居太早，产门感风作痛，衣被难近身体，宜用祛风定痛汤。

祛风定痛汤方：

川芎一钱，当归三钱，独活、防风、肉桂、荆芥（炒黑）各五分，茯苓一钱，地黄二钱，枣二枚，

煎服。

又附阴疳阴蚀。阴中疮曰匿疮，或痛或痒，如虫行状，浓汁淋漓。阴蚀几尽者，由心肾烦郁，胃气虚弱，致气血流滞。经云："诸疮痛痒皆属于心。"治当补心养肾，外以药熏洗，

宜用十全阴疳散。

十全阴疳散：

川芎，当归 白芍，地榆 甘草（各等分）

水五碗，煎二碗，去渣薰，日三夜四，先薰后洗。

一方，用蒲黄一升，水银二两，二味调匀搽。

一方，用虾蟆、兔粪等分为末，敷疮。

一方，治疳虫食下部及五脏。取东南桃枝，轻打头散，以绵缠之。

一方，用石硫黄末，将缚桃枝蘸而燃烟薰之（按此条宜与上条合看）。

一方，截一短竹筒，先纳阴中，以桃枝烧烟薰之。

第十节 恶露

【原文】：即系裹儿污血，产时恶露随下，则腹不痛而产自安。若腹欠温暖，或伤冷物，以致恶露凝块，日久不散，则虚症百出；或身热骨蒸，食少羸瘦；或五心烦热，月水不行，其块在两胁，动则雷鸣，嗜杂晕眩，发热似疟，时作时止，如此数症，治者欲泄其邪，先补其虚，必用补中益气汤送三消丸，则元气不损，恶露可消。

加味补中益气汤方：

人参一钱，白术二钱，当归三钱，黄耆一钱（炙）白芍一钱，广皮四分，甘草四分，姜，枣，煎服

三消丸：

治妇人死血食积痰三等症。

黄连一两（一半用吴萸煎汁去渣浸炒，一半用益智仁炒，去益智仁不用），川芎五钱，莱菔子一两五钱（炒），桃仁（十粒），山栀、青皮、三棱莪术（各五钱，俱用醋炒），山楂一两，香附一两（童便浸炒）

上为末，蒸饼为丸，食远服，用补中益气汤送下五、六十丸；或用白术三钱，陈皮五钱，水一盅，煎五分送下亦可。

此方治产后伤食，恶露不尽。若初产恶露不下，宜服生化汤加楂炭三钱。每日一帖，连服四剂，妙。

第十一节 乳痈

【原文】：乳头属足厥阴肝经，乳房属足阳明胃经。若乳房臃肿，结核色红，数日外肿痛溃稠脓，脓尽而愈，此属胆胃热毒，气血壅滞，名日乳痈，易治。若初起内结小核，不红不肿不痛，积之岁月，渐大如巉岩石，破如熟榴，难治。

治法：痛肿寒热，宜发表散邪；痛甚，宜疏肝清胃；脓成不溃，用托里；肌肉不生，脓水清稀，宜补脾胃；脓出及溃，恶寒发热，宜补血气；饮食不进，或作呕吐，宜补胃气。乳岩初起，用益气养荣汤加归脾汤，间可内消；若用行气破血之剂，速亡甚矣。

瓜蒌散方：

治一切痈疽，并治乳痈。痈者，六腑不和之气，阳滞于阴则生之。

瓜蒌一个（连皮捣烂），生甘草五分，当归三钱，乳香五分（灯心炒），金银花三钱，白芷一钱，没药五分（灯心炒），青皮五分。

水煎，温服。

回脉散：

乳痈未溃时服此，毒从大便出，虚人不用。

大黄三钱半，白芷八分，乳香五分，木香五分，没药五分，穿山甲五分，蛤粉拌炒。

共为末，人参二钱煎汤，调药末服。一本大黄作三钱，有人参三钱。

十全大补汤方：

人参、白术、黄耆、熟地各三钱，茯苓八分，甘草五分，川芎八分，金银花三钱。

泻，加黄连、肉果；渴，加麦冬、五味；

寒热往来，用马蹄香捣散。凡乳痈服薏苡仁粥好。

又方：

用乌药软白香辣者五钱（研），水一碗，牛皮胶一片，同煎七分，温服。

如孕妇腹内痛，此二方可通用。一本人参四味各二钱。

又有乳吹，乃小儿饮乳，口气所吹，乳汁不通，壅结作痛，不急治则成痈，宜速服瓜蒌散，更以手揉散之。

第十二节 风甚

【原文】：用山羊血取色新者，于新瓦上焙干，研末，老酒冲下五，六分为度；重者用至八分，其效如神。

又用抱不出壳鸡子，瓦上焙干，酒调服。

如治虚寒危症，用蓝须子根刮皮，新瓦上焙干，研末，温服一钱为度，虽危可保万全。

第一节 不语

【原文】：乃恶血停蓄于心，故心气闭塞，舌强不语，用七珍散。

七珍散：

人参、石菖蒲、川芎、生地（各一两），辰砂五分（研），防风五钱，细辛一钱。

共为细末，用薄荷汤下一钱。

因痰气郁结，闭口不语者，用好明矾一钱，水飞过，沸汤送下。一方治产后不语。

治产后不语方：

人参，石莲子（去心），石菖蒲（各等分）

水煎服。

《妇人良方》云：产后暗，心肾虚不能发声，七珍散；脾气郁结，归脾汤；脾伤食少，四君子汤；气血俱虚，八珍汤，不应，独参汤，更不宜急加附子，盖补其血以生血，若单用佛手散等破血药，误矣。

第二十章 补集

第一节 产后大便不通

【原文】：用生化汤内减黑姜加麻仁；胀满，加陈皮；血块痛，加肉桂，元胡。如燥结十日以上，肛门必有燥粪，用蜜枣导之。

炼蜜枣法：

用好蜜二、三两，火炼滚，至茶褐色，先用湿桌，倾蜜在桌上，用手作如枣样，插肛门，待欲大便，去蜜枣，方便。

又方，用麻油，口含竹管入肛门内，吹油四、五口，腹内粪和即通；或猪胆亦可。

治产后鸡爪风：

组成：桑柴灰三钱（存性），鱼胶三钱（炒）手指甲（十二个，炒）

共为末，黄酒送下，取汗即愈。

保产无忧散：

组成：当归钱半（酒洗），炒黑芥穗八分，川芎钱半，艾叶七分（炒）面炒枳壳六分，炙黄耆八分，菟丝子（钱四分（酒炒）），厚朴，七分，姜炒）羌活五分，川贝母一钱（去心）白芍（钱二分（酒炒）），甘草五分，姜三片，温服。

上方保胎，每月三、五服，临产热服，催生如神。保产无忧散

治遍体浮肿

治遍体浮肿方：

是脾虚水溢之过。凡浮肿者可通用，俱神效。

真缩砂仁四两，莱菔子二两四钱

研末，水浸浓取汁，浸砂仁，候汁尽，晒干，研极细末，每服一钱，渐加至二钱为度，淡姜汤送下

【缩砂仁】：味辛，气温，无毒。入足太阴、阳明、少阴、厥阴。也入手太阴阳明厥阴可升可降，降多于升，阳也。辛能散能润，温能和畅通达，故治一切虚寒凝结气滞。

缩砂仁，辛温香窜，补肺益肾，和胃醒脾，快气调中，通行结滞。除霍乱恶心，却腹痛安胎，温脾胃下气消食；治冷泻赤白，及休息痢，上气奔豚，鬼疰邪疰，转筋吐泻，胃气壅滞，丹田虚寒，能温脾胃，困乏能醒。然未免香燥走窜，孕妇气虚者，多服反致难产，不可不知。若肺热咳嗽，气虚肿满，火热腹痛，血热胎动，皆宜禁用。

主治（痘疹合参） 去壳炒研用。若治孕妇安胎者，宜带壳炒研。凡痘腹中虚寒作痛，并脾胃气结滞不散作闷，不思饮食，虚冷泻痢呕吐，消食健胃安胎，皆所必用，但气味香燥，不利于灌脓之时，及咳嗽喉痛音哑之症，均宜切忌。倘不得已投于阴虚有火之人，宜盐汤浸炒用之。

保产神效方：

未产能安，临产能催，偶伤胎气，腰疼腹痛，甚至见红不止，势欲小产，危急之际，一服即愈，再服全安。临产时交骨不开，横生逆下，或子死腹中，命在垂危，服之奇效。

全当归一钱五分（酒洗），紫厚朴七分（姜汁炒），真川芎一钱五分，菟丝子一钱五分（酒泡），川贝母二钱（去心，净煎好方和入），枳壳六分（面炒），川羌活六分，荆芥穗八分，黄耆八分（蜜炙），蕲艾五分（醋炒），炙草五分，白芍一钱二分，冬用二钱（酒炒）生姜三片。

水二盅，煎八分，渣水一盅煎六分，产前空心预服二剂，临产随时热服。此方仙传奇方，慎勿以庸医轻加减其分两。

按：保产无忧散、保产神效方，与编首治产秘验良方，俱相同，特引论略别，并存参看可也。

第二十一章 附录：妇人病案集

第一节 妇人精神病

【麦甘大枣汤治无故悲泣不止】本事方：

乡里打一妇人，数欠伸，无故悲泣不止。或谓之有祟，祈壤请祷备至，终不应。用麦甘大枣汤，尽剂而愈。

【妊娠四五个月遇昼则惨戚悲伤泪下】妇人良方：

程虎卿内人妊娠四五个月，遇昼则惨戚悲伤泪下，数欠如有所凭。医巫兼治，皆无益。与大枣汤一投而愈。（即本方）

【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云：

患女，12 岁。癫痫大发作六年，用苯妥英纳治疗无效，改用甘麦大枣汤，每日加明矾米粒大 1 枚冲服，连服半年而愈。随访 6 年未发作。(浙江中医杂志)

按语：本案标本兼治，值得借鉴。

【抵当汤治月经不来下焦蓄血引起的精神病】胡希恕曰：

“妇人经水不利下”，不是月经不调，是经闭，经闭不利下，就是用其它的药也不下。这个临床上也常有，我临床遇着一个精神病，她这个例假吃抵当汤才下，上次我给她用了抵当汤，她月经下了挺大一块的、很多很多的，现在她这个精神大致是好了，她以前拿斧子砍人，在精神病院治疗很长时间，现在这个人挺好。我用其它的祛瘀药都不行，她这个例假就是不见，用抵当汤这个是真有力量，我就用这个方子，不过我还加芒硝了，因为她这个大便也特别干，人也是癫狂。

罗按：这个其实应当归类下焦蓄血病，精神病不是主证，是兼证，下焦蓄血病才是主证，外证除精神病外，应当有脉沉结、少腹硬满而痛、大便黑，小便通利等证。

【血在下则忘精神病医案】刘渡舟：

女，30 岁，姓魏，河南人，1969 年患精神分裂症。住院用电疗、用胰岛素治疗，没完全好。出院以后遗留下一个问题，头皮发紧，就像打了一块铁箍。另外就是言听视众，随过随忘，一点儿记性都没有，就是喜忘。两目呆滞，神情淡漠；月经来的时候，小肚子疼痛。脉沉滑，舌苔有点儿发腻。我给她辨证为有瘀血，一个，因为脉见沉滑，沉主里，滑脉有的时候主瘀血。《濒湖脉学》：“滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎”。另外根据《内经》所说蓄血在下其人发狂，蓄血在上其人喜忘，善忘。同时，她月经来的时候小肚子疼痛，有瘀血的痛经。

根据这个，我第一个方子就是抵当汤加柴胡、半夏。抵当汤活血化瘀，加柴胡、半夏，一方面疏肝，一方面给祛痰，因为舌苔有点儿腻。吃了两付，效果不理想。第二次看，还是有瘀血，所以就按照桂枝茯苓丸的意思开，桂枝两钱，桃仁四钱，牡丹皮三钱，茯苓八钱，赤芍三钱，大黄三钱。这是桂枝茯苓丸的底子，还有大黄，又加上一个失笑散，蒲黄二钱、五灵脂二钱，也是活血化瘀的。吃下以后她就大便作泄，泄了好几次，泄完以后头上这个铁箍就去掉了，也就是说这个症状就解除了。问她记性怎么样？她感觉着有好转，还是忘但是轻了一点儿。感觉这个方子用对了，第三次就是大黄三钱、桃仁五钱、炙甘草二钱、芒硝二钱、牡丹皮三钱、赤芍三钱、郁金三钱、菖蒲三钱，在活血化瘀里加上一点儿芳香开窍、开心窍的药。这个药吃了两三付，大便还泄，这回泄的就不是一般的东西，像脓血之物甚多，

似脓非脓，似血非血，黏黏糊糊。拉完以后，说是好了百分之八十。又开了个方子，她带回河南老家吃，约定如果还不好就来信，回去了以后根本就没来信，这病可能也就好了。

【喜笑不休医案】张氏医通：

昔治人笑不休口流涎，用黄连解毒汤加半夏、姜汁、竹沥，而笑止。

经云："神有余则笑不休，精气并于心则喜"，心主手厥阴之脉，是动则病目黄，喜笑不休。河间云：喜笑者，皆心火之盛也。五行之中，惟火有笑。

黄连解毒汤方：外台秘要）
黄连三两，黄芩、黄柏各二两，栀子十四枚（擘）
上四味切，以水六升，煮取二升，分二服。

【喜笑不休医案】张氏医通：

戴人治一妇，病喜笑不休，已半年矣。以盐块二两，烧令通赤，放冷研细，河水煎服，探吐出热痰五升，次服降火之剂，不数日而笑定。

《内经》曰：神有余则笑不休，此所谓神者，火是也。火得风而成焰，笑之象也。

【笑哭不常医案】张氏医通：

倪惟德治一妇，病气厥，笑哭不常，人以为鬼祟所凭，诊之，六脉俱沉，胃脘必有积，遂以二陈汤导之，吐痰升许而愈。此积痰类祟也。

【辰砂甘遂散治妇人神经病终日歌唱达旦不寐医案】曹颖甫：

此公系同乡高长佑先生之友。予因治其妻神经病，始识之。盖其妻饮食如故，但终日歌唱，或达旦不寐。诊其脉滑疾，因用丁甘仁先生法，用猪心一枚剖开，内藏辰砂二钱，甘遂二钱，扎住，向炭炉煨枯，将甘遂朱砂研成细末。一服而大下，下后安眠，不复歌唱矣。后以十全大补汤收膏调之，精神胜于未病时。附录之，以资谈助。

【桂枝汤加龙骨牡蛎治入夜每与人交医案】徐伯伦：

高某某，女，34 岁，农民。入夜每与人交，天明始去，已 4、5 年，误为"狐仙"，羞愧难言。初则不以为然，久则心悸胆怯，延期失治，病情日重。避卧于邻家，仍纠缠不散。形体消瘦，困倦乏力，少气懒言，头晕眼花，腰膝痠软，带多清稀，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。系阴阳两亏，心肾不交，属梦交症。拟用桂枝加龙骨牡蛎汤方：桂枝 18 克，白芍、龙骨各 20 克，甘草、生姜各 9 克，生牡蛎 30 克，红枣 7 枚。5 剂后，诸证消除，予归脾丸巩固疗效。随访 1 年未复发。(浙江中医杂志 1984；<1)：46)

【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：

孟某，女，53 岁，农民，1993 年 12 月 2 日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13 服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3 天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各 15g，生龙骨、生牡蛎各 20g，甘草 10g，生姜 10g，大枣 10 枚。

复诊：服 6 剂后，患者言语平稳，头胀痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石 15g，龟板 10g，以加强重镇之功，7 剂后症状消失，追访 1 年未再复发。(河南中医 1995；(6>：343)

【桂枝汤加龙骨牡蛎治表情抑郁少语寡言时时惊恐医案】付美育：

吴某某，女，36 岁，营业员，1986 年 6 月 24 日就诊。5 年前因与人口角而突然晕倒，不省人事，四肢僵硬，约数分钟后苏醒，但仍觉头晕乏力，后反复发作，每月 2～3 次，每逢情志不畅则发作频繁，多种检查未发现器质性病变。西医诊断为癔病。5 年来，服多种中西药罔效，遂求诊于余。刻诊：发作后 2 天，表情抑郁，少语寡言，时时惊恐，伴头晕，时自汗出，舌淡、苔薄白，脉弦略浮。予桂枝加龙骨牡蛎汤治疗。处方；桂枝 10 克，白芍、炙甘草各 20 克，生龙骨、生牡蛎各 30 克，生姜 5 克，大枣 30 枚。每日 1 剂，水煎分 2 次服。服

药5剂，自觉诸症消失，效不更方，守原方续进30余剂，5年沉疴遂愈，随访至今，未再复发。(新中医1992；<6)：44)

【脏躁奔豚汤治精神恍惚医案】王峰：

马某，女，16岁，学生，1988年10月14日初诊。患者自9月6日以来，每见欠伸之后即哭泣无常或叫嚷吵闹，或精神恍惚，不闻不见。询其因，乃上学恋爱，被家人打骂恐吓而发病。曾服谷维素、安定、氨络酸等西药治疗，疗效不佳，故于今日来诊。诊：患者无故自悲，善惊易恐，心烦不寐或多梦纷纭，大便干硬，小便短赤，头重昏蒙，面带愁容。舌红苔少，脉弦细。诊为脏躁，乃血虚气火逆乱所致。治宜养血平肝，泻火安神。投奔豚汤加味：葛根15g，白芍、当归、柴胡、黄芩各12g，半夏、李根白皮各10g，甘草、川芎、生姜各6g，潞参、生牡蛎、生龙骨各18g。日1剂，水煎服。服4剂后，证有转机，续服10余剂，诸症消失，安如常人。1990年10月随访，病无反复。(国医论坛)

注家按语：本例系血虚肝旺之体，故投奔豚汤养血、平肝、泻火，合小柴胡汤疏理气机，伍生龙牡凉血、镇潜、安神。诸药合用，血虚得养，邪热得泻，故是自安。

【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：

孟某，女，53岁，农民，1993年12月2日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头胀痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，追访1年未再复发。(河南中医1995；(6>：343)

【桂枝汤加龙骨牡蛎治入夜每与人交医案】徐伯伦：

高某某，女，34岁，农民。入夜每与人交，天明始去，已4、5年，误为“狐仙”，羞愧难言。初则不以为然，久则心悸胆怯，延期失治，病情日重。避卧于邻家，仍纠缠不散。形体消瘦，困倦乏力，少气懒言，头晕眼花，腰膝痠软，带多清稀，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。系阴阳两亏，心肾不交，属梦交症。拟用桂枝加龙骨牡蛎汤：桂枝18克，白芍、龙骨各20克，甘草、生姜各9克，生牡蛎30克，红枣7枚。5剂后，诸证消除，予归脾丸巩固疗效。随访1年未复发。(浙江中医杂志1984；<1)：46)

第二节 妇人乳房病医案

【桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤主之治乳腺增生】网文：

张女，38岁，乳房疼痛月余，乳腺增生，纳可，平素怕冷，见凉气则流涕，二便可，舌淡红，苔白，脉细紧。查其所服中药大多为疏肝理气，活血止痛之品。岂知寒气郁闭，气机不畅，亦可出现乳腺疼痛。《金匮要略》有言：“大气一转，寒气乃散”，故而疏方桂枝去芍药加麻附辛，患者服药一周，疼痛已不明显，见凉气则流涕亦消失！

【半夏厚朴汤乳腺纤维腺瘤(乳癖)】李志亮：

患者，女，29岁，无意间发现右侧乳房外上方肿块3月余，不红，不肿，不痛，曾就诊于县人民医院、地区人民医院，均诊为乳房纤维腺瘤，建议手术治疗。因该患者惧怕手术，于1998年2月18日来诊，查见患者表情忧郁，时叹息，自觉胁胀不欲食，右侧乳房外上象限有一大小3cmx2.5cm肿块，质硬，表面光滑，与周围组织无粘连，随乳房移动而自由移动，无触压痛，诊为乳房纤维腺瘤，证属气滞痰凝成结成核所致，治以理气行滞，化痰散结，半

夏厚朴汤加减：半夏 12g、厚朴 9g、茯苓 20g、苏梗 9g、生姜 9g、柴胡 12g、夏枯草 12g、生牡蛎 15g、瓜蒌 15g、穿山甲 12g、香附 9g、郁金 12g、佛手 12g、赤芍 12g，上方加减共服 35 剂，肿块消失。（现代中西医结合杂志）

【半夏厚朴汤急性乳腺炎(乳痈)】承忠委：

王某，女，30 岁，1983 年 8 月 2 日初诊。新产甫 3 月，左侧乳房肿痛，色微红，伴寒热呕恶，胸闷太息，咽如物堵，纳谷不馨，漫少便溏，苔白厚，脉弦滑。证属气郁痰阻，痰热互结于足厥阴、阳明之络，而发为乳痈是也。治以行气解郁，化痰通络，参以清解。方予姜半夏、制厚朴各 6g，苏叶、炮穿山甲、通草各 10g，银花、蒲公英各 15g，土苓、茯苓各 20g，生姜 3 片，2 剂。药后肿痛顿减，他症亦轻，守原方继服 6 剂，乳痈消散。（陕西中医）

【少腹逐瘀汤治乳腺增生乳房胀痛医案】

陈某，女，38 岁，乳腺增生，乳房胀痛，经来时更甚，仍属气虚血瘀寒凝病机，服此合方，2 月而愈。

【软坚散结化乳癖】

王某，女，41 岁，干部。3 年前沐浴时不经意间发现两侧乳房之右下方均有一肿物，似有触痛。曾就医于市内某医院妇科,以乳腺小叶增生名之，中西药物交替使用而无显效，渐次于劳累、情志不舒或经前即感胀痛，触之尤甚。1998 年 5 月 7 日延余诊视：舌质暗，边尖有瘀点，苔薄稍黄，脉沉弦。左右乳房分别有一 1.9×1.7cm，2.3×2.1cm 之硬结物推之可移，皮色无异常。脉症合参，显系乳癖。治宜疏肝解郁，化痰散结之剂。柴胡 13g，当归、川芎、三棱、莪术、醋香附、皂刺各 15g，醋白芍 30g，大贝母、生地各 12g,昆布、海藻各 25g，桃仁、红花、桔梗、青皮各 10g,煅牡蛎 20g。嘱其每日 1 剂，水煎，日 3 服。药后,以白酒 10ml，呷之。连尽 45 剂。

按：肝之经脉布胸胁，抵少腹，绕阴器，故以柴胡疏肝解郁为君;桃红四物汤活血通经，祛瘀柔肝为臣;昆布、海藻消痰软坚，散结行水;三棱、莪术破瘀通经，行气消积;煅牡蛎收涩软坚而消硬肿,协昆布、海藻以扬军威，助三棱、文术以壮行色;大贝母清热化痰而软坚，滋阴行水而散结;皂刺辛温，活血消肿，青皮辛温，破气散结，二味相伍均具辛者可散，温者可行之功，如此则一活一破，即可无坚不摧，无关不克;醋香附乃气病之总司，妇科之主帅，郁证之良友，调经之妙剂，在此可周旋于诸药之间，使气通血活，经畅脉顺也;桔梗为药中之舟楫，载诸药以上行;白酒者温经活血，其所用之法非饮非服，而言呷者，乃小口慢下，以求药力之持续不断而见“滴水穿石”之功也。同年 8 月 21 日再触其乳房，左右之肿块均未查及,B 超所示亦无异常可见。

【白通汤加味治乳痈(乳腺炎)】

谢××，女，二十四岁，江苏人。产后六、七日，因夜间起坐哺乳而受寒，次日即感不适，恶寒、发热、头身疼痛，左乳房局部硬结，肿胀疼痛。患者当即赴省级某医院诊治，服银翘散、荆防败毒散等方加减数剂，发热已退，仍有恶寒，左乳房硬结红肿不散，反见增大，疼痛加剧。一周后，创口溃破，流出少许黄色脓液及清淡血水，经西医外科引流消炎治疗，半月后破口逐渐闭合。

但乳房肿块未消散，仍红肿疼痛，乳汁不通，眠食不佳。每日午后低热，僳懔恶寒，历时一月未愈。1963 年某日延余诊视，病如前述，但见患者面色觥白，精神疲惫，脉沉细而弱，舌质含青色，苔白厚腻。此乃寒邪失于宣散，郁闭阻滞经脉血络，迁延未愈，血气耗伤，正气内虚，无力抗邪外出。

局辞虽成破口而脓根未除尽，创口虽敛而痈穗未能全部消除，此即所谓养痈而遗患也。法当温通里阳，排脓消肿，散结通乳。方用白通汤加味。

附片 150 克，干姜 15 克，川芎 10 克，当归 15 克，桔梗 10 克，皂刺 9 克，赤芍 10 克，通草 6 克，细辛 5 克，白术 12 克，葱白 3 茎

服二剂后，恶寒、低热已解，体温退至正常，左乳房红肿硬结渐消。惟乳头右下方复觉灼热、刺痛，局部发红，稍见突起。此系得阳药温运，气血渐复，血脉疏通，正气抗邪，已有托脓外除之势。脉沉细而较前和缓有力，舌质青色已退，舌心尚有腻苔。继以上方加香附9克，连服二剂。腐败之血肉，已化脓成熟，局部皮肤透亮发红。服三剂后，脓包自行溃破，流出黄色脓液半盅多，疼痛顿减，红肿消退。再以温经扶阳调补气血之四逆当归补血汤加白术、杭芍、桂枝、川芎等连进四剂，脓尽肿消，创口愈合，病告痊瘳。

【麻黄附子细辛汤加味乳痈(乳腺炎)】

尹××，女，二十五岁，昆明人。1969年春季，产后六日，因右侧乳房患“急性乳腺炎”赴某医院就诊，经用青霉素等针药治疗，病情不减，又改延中医外科诊治，认为系热毒所致，当即投以清热解毒之剂，外敷清热消肿软膏。连用五剂，诊治十余日，寒热不退，右侧乳房红肿疼痛反而日渐增剧，遂延余诊视。证见患者发热而恶寒，清晨体温37．4℃，午后则升高至39℃左右。头疼，全身酸痛，右侧乳房红肿灼热而硬，乳汁不通，痛彻腋下，呻吟不止。日不思饮食，夜不能入眠，精神疲惫，欲寐无神。脉沉细而紧，舌质淡而含青，苔白厚腻。此系产后气血俱虚，感受风寒外邪，致使经脉受阻，气血凝滞。后又误服清热苦寒之剂，伤正而益邪，遂致乳痈加剧。法当扶正驱邪，温经散寒，活络通乳。方用麻黄附子细辛汤加味。

附片30克，麻黄9克，细辛5克，桂枝15克，川芎9克，通草6克，王不留行9克，炙香附9克，生姜15克，甘草6克

次日复诊。昨日连服上方二次，温覆而卧，数刻后则遍身絷絷汗出，入夜能安静熟寐，今晨已热退身凉，顿觉全身舒缓，头身疼痛已愈，右侧乳房红肿热痛减去其半，稍进稀粥与牛奶，痛苦呻吟之状已减，脉已不紧，沉细和缓。舌质青色已退而转淡红，苔薄白，根部尚腻。此乃证虽见效，然余邪未尽，气血未充，继以扶阳温化之法治之，方用茯苓桂枝汤加味。

茯苓15克，桂枝15克，川芎9克，通草6克，细辛3克，炙香附9克，苡仁15克，附片45克，生姜15克

连服二剂，右侧乳房红肿硬结全部消散，乳汁已通，眠食转佳。唯气血尚虚，以黄芪建中汤调理善后，连服四剂，诸证获愈。半月后，乳汁渐多，又能照常哺乳。

【结乳肿疼兼治乳痈奇方】张锡纯：

表侄刘生，从愚学医，曾得一治结乳肿疼兼治乳痈方。用生白矾、明雄黄、松萝茶各一钱半，共研细，分作三剂，日服一剂，黄酒送下，再多饮酒数杯更佳。此方用之屡次见效，真奇方也。若无松萝茶，可代以好茶叶。

治乳痈奇方：

生白矾、明雄黄、松萝茶各一钱半

共研细，分作三剂，日服一剂，黄酒送下，再多饮酒数杯更佳。

【消乳汤治乳痈医案】张锡纯：

在德州时，有张姓妇，患乳痈，肿疼甚剧。投以此汤，两剂而愈。然犹微有疼时，怂恿其再服一两剂，以消其芥蒂。以为已愈，不以为意。隔旬日，又复肿疼，复求为治疗。愚曰：此次服药不能尽消，必须出脓少许，因其旧有芥蒂未除，至今已溃脓也。后果服药不甚见效。遂入西医院中治疗，旬日后，其疮外破一口，医者用刀阔之，以期便于敷药。又旬日，内溃益甚，满乳又破七八个口，医者又欲尽阔之使通。病患惧，不敢治。强出院还家，复求治于愚。见其各口中皆脓、乳并流，外边实不能敷药。然内服汤药，助其肌肉速生，自能排脓外出，许以十日可为治愈。遂将内托生肌散，作汤药服之，每日用药一剂，煎服二次，果十日全愈。

消乳汤方：

治结乳肿疼或成乳痈新起者，一服即消。若已作脓，服之亦可消肿止疼，俾其速溃。并治一切红肿疮疡。

知母八钱，连翘四钱，金银花三钱，穿山甲二钱（炒捣），栝蒌五钱（切丝），丹参四钱，生明乳香四钱，生明没药四钱。

内托生肌散方：

治瘰疬疮疡破后，气血亏损不能化脓生肌。或其疮数年不愈，外边疮口甚小，里边溃烂甚大，且有串至他处不能敷药者。

生黄芪四两，甘草二两，生明乳香一两半，生明没药一两半，生杭芍二两，天花粉三两，丹参一两半

上七味共为细末，开水送服三钱，日三次。若将散剂变作汤剂，须先将花粉改用四两八钱，一剂分作八次煎服，较散剂生肌尤速。

【少腹逐瘀汤治乳腺增生乳房胀痛医案】

陈某，女，38 岁，乳腺增生，乳房胀痛，经来时更甚，仍属气虚血瘀寒凝病机，服此合方，2 月而愈。

【百合知母汤合甘麦大枣汤治疗乳腺病双乳胀痛】高秀飞：

乳癖严某，女，53 岁，2005 年 4 月 4 日就诊。双乳胀痛 3 周，时有刺痛，心烦，急躁，浑身不适，夜寐欠安，腰酸，曾口服乳癖消、逍遥丸等中成药，效果不佳。体检发现双乳无明显肿块，触痛明显。苔少，舌尖红，脉细数。证属肝郁化火，阴虚内热。治拟养阴舒肝。药用：百合 30g，知母 12g，甘草 6g，淮小麦 30g，红枣 20g，郁金 12g，香附 9g，元胡 12g，莪术 30g，三棱 12g，巴戟肉 15g，肉苁蓉 12g，八月札 30g，川楝子 9g，杜仲 15g。并鼓励患者在生活、工作中放松自己，保持怡悦心情。服 14 剂后，双乳胀痛明显改善，情绪较前稳定，夜寐转安。以后随证加减，服药 3 个月后，诸症渐消。(辽宁中医杂志)

【百合知母汤治疗乳腺病乳腺癌术后难以入睡】高秀飞：

郑某，女，39 岁，2005 年 8 月 29 日就诊。左乳癌术后 2 年 2 个月，近来情绪波动较大，心烦躁热，坐立不安，夜寐难以入睡，睡后易醒，醒后彻夜不眠，不能自已，神疲乏力，小便频数。苔薄，边尖红，脉弦细。诊断：乳癌术后。证属气阴两虚，冲任失调，心神不养。治拟养阴安神，益气补肾。药用：百合 30g，知母 12g，生黄芪 30g，党参、茯苓各 12g，白术 9g，枸杞子、南沙参、淫羊藿各 15g，肉苁蓉、巴戟肉各 12g，莪术、石见穿各 30g，蜂房、石菖蒲各 12g、磁石(先煎)、丹参各 30g，杜仲 15g，覆盆子、益智仁各 12g，怀牛膝 30g，制黄精 12g，龙葵 30g。同时对患者进行耐心解释和开导，帮助病人解除顾虑，树立信心，劳逸结合，稳定情绪。服 14 剂后，夜寐明显好转，心烦躁热有所改善，小便次数减少。再服该方 2 个月，夜寐转安，情志舒畅，小便正常。(辽宁中医杂志)

【乳腺癌术后局部创面感染不愈案】

W/MZ，女，79 岁，患者形体中等偏瘦，脸色暗而缺乏光泽，贫血貌，身高 162，体重 49kg。1981 年曾有乳腺癌手术，1991 年手术局部破皮，渐渐如米粒大，现局部溃疡面积 2*3cm2，深 1cm，近来常有感染，每 3 周感染一次，需要服用抗生素，且放疗后局部皮包骨头，色暗，疼痛甚，影响睡眠，有脓液，每天需要引流 2 次，且一直有低烧 37.5 左右，希望中医参与治疗。患者食欲尚可，大便成形，舌暗淡，脉 84 次/分。

自强不息:我想知道为什么去掉麻黄？ 学阳和汤的时候老师曾说这张方子熟地得麻黄不会滋腻太过，麻黄得熟地就没有了发汗动血之虞。

Gugu：这个病人可看成小柴胡汤的虚证，补中益气汤应该可用的

黄师处方：炙甘草 6 克，党参 12 克，肉桂 6 克（后下），桂枝 6 克，麦冬 20 克，生地 15 克，阿胶 12 克（另烊），龙骨 12 克（先煎），牡蛎 12 克（先煎），赤芍 10 克，干姜 6 克，鹿角胶 10 克，白芥子 6 克，红枣 30 克

药后一周复诊，患者低烧退，继续服药半月后患者精神状态尚佳，局部感染已经不明显，

脓液明显减少，疼痛感明显减轻。

黄波：体瘦，脸色暗而缺乏光泽，贫血，舌暗，局部营养状况差等。---此患者乃炙甘草汤体质。

【右乳腺小叶增生医案】王秀玉：

陈某某，女，34 岁，农民，诊于 1986 年 3 月 18 日。右侧乳房内有一肿物，近似橄榄大小，随月经周期而时大时小约二年。乳房肿物增大时，胸闷胀痛，触之移动，肤色正常，拟诊为右乳腺小叶增生。患者素有情志不畅史，易怒，难眠。舌质淡白，苔薄，脉弦细。证为肝郁伴痰浊阻滞所致乳癖，治宜疏肝理气，化痰散结。处方：栝蒌 20 克，薤白、夏枯草各 15 克，柴胡、郁金各 10 克，半夏 8 克，王不留行 12 克，牡蛎 30 克(先煎)，甘草 4 克，煎服。

连服 7 剂，局部肿物缩小，胸闷痛亦明显减轻。按上方加路路通 10 克，连服 10 剂。至 4 月 17 日诊察，月经正常来潮，乳腺肿物消失，照上方去柴胡，加当归 10 克，每日 1 剂，前后共服 40 剂，乳癖未再发作。(福建中医药 1988)

【栝蒌薤白白酒汤加味治初产后左乳肿痛医案】李长青：

刘某某，女，28 岁。初产后左乳肿痛，经用青霉素注射及外敷金黄散一周未效，诊见：左乳红肿，按之剧痛，发热恶寒，体温 39℃，西医诊为急性乳腺炎，中医诊为乳痈。初服仙方活命饮加减效果不显，后改用栝蒌薤白白酒汤加味：栝蒌 75 克，薤白 40 克，麻黄 10 克，双花 50 克，连翘 30 克，赤芍 20 克，生甘草 25 克，白酒 10 毫升(后入)。服 6 剂症状明显好转，效不更方，继服 6 剂痊愈。(黑龙江中医药 1989)

【初产后两月患急性乳腺炎医案】权依经：

杨某，女，32 岁，1978 年 5 月 8 日初诊。初产后两月患急性乳腺炎，经多方治疗无效，遂来求诊。诊见右侧乳腺明显肿大，局部红肿发硬，疼痛难忍，脉数。处方：全栝蒌 9 克，半夏 6 克，黄连 3 克，水煎分：次服，3 剂。

服药后，红肿开始消散，疼痛减轻，但脉仍数。上方再服踪 3 剂，请症消失。（《古方新用》1981）

【大黄甘遂汤产后腹满小便难】

陈妻，难产，二日始生。产时血下甚少，腹大如鼓，小便其难，大渴。医以生化汤不效，腹满甚，且四肢头面肿。延余诊，不呕不利，饮食如常，舌红而（苔）黄，脉滑有力。断为水与血结在血室。投以大黄甘遂汤，先下黄水，次下血块而愈。初，病家疑此方过峻。予曰：小便难，知其停水；产后血少，知其蓄瘀；不呕不利，饮食如常，脉滑有力，知其正气未虚，故可攻之。若泥胎产前责实，产后责虚之说，因循观望，正气既伤，虽欲攻之不能矣。《广州近代老中医医案医话选编》

【葛根汤治产后乳痈医案】

宋某，女，26 岁。1976 年 5 月 12 日诊。自述产后半月，突觉右乳红肿作痛剧烈，且恶寒发热，无汗，头疼身痛，口淡无味，饮食不佳，二便尚调。余查其右乳内有一硬结，红肿，脉象浮紧，舌苔白滑。辨为外感风寒之邪，阻滞经络而发为乳痈，拟葛根汤加味治之。处方：葛根 25g，麻黄 10g，白芍 10g，桂枝 10g，细辛 5g，甘草 6g，大枣 12g，生姜 12g，吴茱萸 5g。2 剂。水煎服。服 1 剂寒热解除，红肿稍退，服 2 剂诸症悉愈。《龚志贤临床经验集》

说明：因外感风寒所致的乳痈较风热所致者疼痛更为剧烈。因寒为阴邪，其性收引，凝滞气血，致脉络不通，故痛剧烈也。见有寒邪外证者用葛根汤加细辛、吴茱萸；若无外证，而有内寒，疼痛剧烈，脉沉者，可用仲景白通汤加吴茱萸、细辛，奏效更速，一般可二三剂而获痊愈。

注：乳痈之患以风热毒邪所致者为多，用仙方活命饮治疗，效如桴鼓。未溃者数剂即消，已溃者十余剂亦可告愈，均不必外用敷药。但事物总是一分为二的。有热必有寒，乳痈属热

性的为多见，属寒者亦有。上述用葛根汤治愈病例，则说明临床上确有因寒致发乳痈者，值得引起医者注意。

【枳实薤白桂枝汤治乳房上方簇状疱疹】

女，65 岁，左乳房上方簇状疱疹，疼痛灼热，胃部隐痛不适，泛酸、嗳气，有上顶之感，大便不成形，难下不爽利。舌诊：舌淡胖无苔，表面细颗粒状。脉诊：66 一 68 次/分，浮、右脉大、长有紧之象，左脉短、虚。方剂：枳实薤白桂枝汤枳实 12 厚朴 12 薤白 18 桂枝 6 瓜蒌 30 二剂水煎服。二诊：一剂，略见效果，二剂，感效果明显。疱疹疼痛减轻，疱疹较前回缩。未外出现新的疱疹。仍有泛酸、嗳气，腹部胀满上顶减轻，大便改善。

舌诊：舌淡胖，舌根些少白苔，表面细颗粒状。脉诊：66 一 68 次/分，浮、右脉大、长有紧之象，左脉短、虚。方剂：效不更方。枳实薤白桂枝汤枳实 12 厚朴 12 薤白 18 桂枝 6 瓜蒌 30 二剂水煎服。

枳实薤白桂枝汤中，枳实厚朴破坚除湿满，桂枝温散，薤白味辛，苦，性温。助桂枝之温，兼苦收，使邪不散漫，瓜蒌性寒，味甘，微苦，归肺、胃、大肠经，清热散结、润肺化痰，滑肠通便，导邪从大便而出。

三诊：带状疱疹痊愈，腹胀，大便先硬后溏，难下不爽，打喷嚏、嗳气，无反酸，眠差，有梅核气的感觉，有头晕的情况。

方剂：半夏厚朴汤和橘枳姜汤：半夏 9，生姜 15，茯苓 9，厚朴 12，枳实 12，陈皮 24，苏叶 12。二剂水煎服

【桂枝茯苓丸双乳胀痛医案】王辅民：

张某，女，27 岁，已婚。1989 年 9 月 5 日初诊。患者素体健康，婚后生一男孩，健康，已 3 岁。近 1 年来，每于月经来潮前 10 日左右，双乳胀痛，稍为挤压或行走震动，疼痛加重。其胀满如哺乳时壅实，月经过后可稍微减轻，乳房亦略见松软，曾服中药数十剂，收效甚微。带下不多，二便正常，经期无腰酸痛，经期尚准，经量较多，色淡。检查：双乳房丰满充实，无肿块，按压痛，皮色正常，双侧对称，脉沉弦滑有力，舌淡红苔白而润。证属冲任壅实，气滞血瘀，水湿瘀阻，发为乳胀。治宜疏泄冲任，行气渗湿散结。处方：桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、白芍各 20g，每日 1 剂，煎 3 遍，分 2 次服。

9 月 15 日复诊：服完 1 剂，乳胀即减轻。服 4 剂尽，乳胀基本消除，月经来潮，量多于以往。又予上方 6 剂，于经净后 3 天始服，追访 3 个月未再复发。(山东中医杂志 1990；(5>：21)

第三节 妇人月经不调诸病

【回阳饮治寒闭经(误服蚕砂酒引发危证)】

1924 年 2 月，曾治一奇证，颇险。有姚姓之女，年十八岁，因上年患白喉证服寒凉药过多．以致信期不调，三、五月一至，时时“发痧”。此系阳虚血寒已极无疑。该女因天癸数月不至，用蚕砂二两泡酒服之，冀使通达，殊料服两小盏后，经亦未通，骤发危象。始延某医诊视，断言无救，未拟方而去。随即延余诊视之，六脉俱绝，唇爪俱黑，面目全身皆发青，牙关紧闭，用物拨开，见口舌亦青黑，四肢厥逆，不省人事，气喘欲脱。缘由体素虚寒，且服过量蚕砂酒，亦系寒凉之物，致成纯阴无阳之候，病情险恶。余始疑无救，然口中气息尚存，不忍坐视而归。若用他药，恐为时不及，急以上肉桂泡水灌之，偶咽下一、二口，觉气稍平。又速频频灌喂，喘息渐定，稍识人事，目珠偶动，呼之乃应。

继而复诊，脉仍不见应指。余思寻之，暴病无脉系闭，久病无脉乃绝。此乃暴病所致，肉桂强心温暖血分之寒，服之气机稍回，必有生机。约两小时方过，病者始能言语，言其周

身麻木，腹中扭痛，忽而大泻酱黑稀便。再诊，脉隐隐欲现，色象稍转，气微喘，扶之以卧，试其舌，青黑冰指，乃以大剂回阳饮治之。

黄附片 60 克，干姜 20 克，上肉桂 20 克(研_束，泡水兑入)，甘草 10 克。

次日诊视，六脉俱回，轻取弦紧重按无力而空。唇舌青黑悉退，唯面部仍稍带青绿色，党头晕，体痛，腹中冷痛，喜滚饮。此阳气尚虚，里寒未净，宜击鼓直追，方能定夺。

继以上方加味治之，连服数剂，厥疾遂瘳。

天雄片 60 克，干姜 12 克，黑姜 12 克，上肉桂心 1 0 克(研末，泡水兑入)，桂尖 12 克，炒吴茱萸 6 克，半夏 12 克，茯苓 15 克，甘草 6 克。

【抵当汤治少女闭经医案】曹颖甫：

余尝诊一周姓少女，年约十八九，经事三月未行，面色萎黄，少腹微胀，证似干血劳初起。因嘱其吞服大黄庶虫丸，每服三钱，日三次，尽月可愈。自是之后，遂不复来，意其差矣。

越三月，忽一中年妇人扶一女子来请医。顾视此女，面颊以下几瘦不成人，背驼腹胀，两手自按，呻吟不绝。余怪而问之，病已至此，何不早治？妇泣而告曰：此吾女也，三月之前，曾就诊于先生，先生令服丸药，今腹胀加，四肢日削，背骨突出，经仍不行，故再求诊！余闻而骇然，深悔前药之误。然病已奄奄，尤不能不一尽心力。第察其情状，皮骨仅存，少腹胀硬，重按痛益甚。此瘀积内结，不攻其瘀，病焉能除？又虑其元气已伤，恐不胜攻，思先补之。然补能恋邪，尤为不可。于是决以抵当汤予之。

虻虫一钱，水蛭一钱，大黄五钱，桃仁五十粒

明日母女复偕来，知女下黑瘀甚多，胀减痛平。惟脉虚甚，不宜再下，乃以生地、黄耆、当归、潞党、川芎、白芍、陈皮、茺蔚子活血行气，导其瘀积。一剂之后，遂不复来。后六年，值于途，已生子，年四五岁矣。

【按】丸药之效否，与其原料之是否地道，修合之是否如法，储藏之是否妥善，在在有关，故服大黄庶麻虫丸而未效者，不能即谓此丸竟无用也。

【理冲汤腹痛闭经医案】张锡纯：

王生妻，来院求为治癥瘕。自言瘀积十九年矣，满腹皆系硬块。亦治以理冲汤，为其平素气虚，将方中参、 加重，三棱、莪术减半。服数剂，饮食增加，将三棱、莪术渐增至原定分量。又服数剂，气力较壮，又加水蛭二钱、樗鸡（俗名红娘）十枚。又服二十余剂，届行经之期，随经下紫黑血块若干，病愈其半。又继服三十剂，届经期，瘀血遂大下，满腹积块皆消。又俾服生新化瘀之药，以善其后。

理冲汤方：

生黄芪三钱，党参二钱，于术二钱，生山药五钱，天花粉四钱，知母四钱，三棱三钱，莪术三钱，生鸡内金三钱（黄者）

用水三盅，煎至将成，加好醋少许，滚数沸服。

服之觉闷者，减去于术。觉气弱者，减三棱、莪术各一钱。泻者，以白芍代知母，于术改用四钱。热者，加生地、天冬各数钱。凉者，知母、花粉各减半，或皆不用。凉甚者，加肉桂（捣细冲服）、乌附子各二钱。

瘀血坚甚者，加生水蛭（不用炙）二钱。若其人坚壮无他病，惟用以消癥瘕积聚者，宜去山药。室女与妇人未产育者，若用此方，三棱、莪术宜斟酌少用，减知母之半，加生地黄数钱，以濡血分之枯。若其人血分虽瘀，而未见癥瘕或月信犹未闭者，虽在已产育之妇人，亦少用三棱、莪术。若病患身体羸弱，脉象虚数者，去三棱、莪术，将鸡内金改用四钱，因此药能化瘀血，又不伤气分也。迨气血渐壮，瘀血未尽消者，再用三棱、莪术未晚。若男子劳瘵，三棱、莪术亦宜少用或用鸡内金代之亦可。

【理冲汤腹痛闭经医案】张锡纯：

奉天孙姓妇，年四十许。自幼时有癥瘕结于下脘，历二十余年。癥瘕之积，竟至满腹，常常作疼，心中怔忡，不能饮食，求为延医。因思此证，久而且剧，非轻剂所能疗。幸脉有根柢，犹可调治。遂投以理冲汤，加水蛭三钱。恐开破之力太过，参、 又各加一钱，又加天冬三钱，以解参、 之热。数剂后，遂能进食。服至四十余剂，下瘀积若干，癥瘕消有强半。因有事还籍，药遂停止。阅一载，腹中之积，又将复旧，复来院求为延医。仍照前方加减，俾其补破凉热之间，与病体适宜。仍服四十余剂，积下数块。又继服三十余剂，瘀积大下。其中或片或块且有膜甚浓，若胞形。此时身体觉弱，而腹中甚松畅。恐瘀犹未净，又调以补正活血之药，以善其后。

【腹痛闭经医案】（医学训中参西录）广西柳州宾生来函：

一妇人，十七岁，自二七出嫁，未见行经。先因腹、胁作疼求为延医，投以活络效灵丹立愈。继欲调其月事，投以理冲汤三剂，月经亦通，三日未止。犹恐瘀血未化，改用王清任少腹逐瘀汤，亦三剂，其人从此月事调顺，身体强壮矣。

【安冲汤原方治经水行时多而且久淋漓八九日始断后复如故医案】张锡纯：

友人刘生其长子妇，经水行时，多而且久，淋漓八九日始断。数日又复如故。医治月余，初稍见轻，继又不愈。延愚诊视，观所服方，即此安冲汤，去茜草、螵蛸。遂仍将二药加入，一剂即愈。又服一剂，永不反复。

刘生疑而问曰：茜草、螵蛸，治此证如此效验，前医何为去之？答曰：彼但知茜草、螵蛸能通经血，而未见《内经》用此二药雀卵为丸，鲍鱼汤送下，治伤肝之病，时时前后血也。故于经血过多之证，即不敢用。不知二药大能固涩下焦，为治崩之主药也。

【安冲汤去黄芪加白术治经水行不止医案】张锡纯：

一妇人，年三十余。夫妻反目，恼怒之余，经行不止，且又甚多。医者用十灰散加减，连服四剂不效。后愚诊视，其右脉弱而且濡。询其饮食多寡，言分毫不敢多食，多即泄泻。遂投以此汤，去黄芪，将白术改用一两。一剂血止，而泻亦愈。又服一剂，以善其后。

【安冲汤去术加麦冬霍石斛香附米治经水行时多而且久】直隶青县张生来函：

王氏妇，年十九岁，因殇子过痛，肝气不畅，经水行时多而且久，或不时漏下。前服逍遥、归脾等药，皆无效。诊其脉，左关尺及右尺皆浮弦，一息五至强。口干不思食，腰疼无力，乃血亏而有热也。遵将女科方安冲汤去 、术，加麦冬、霍石斛、香附米，俾服之。二剂血止，六剂后食量增加，口干腰疼皆愈。继将汤剂制作丸药，徐徐服之，月事亦从此调矣。直隶盐山孙生来函：

一九二四年七月，友人张生之母，因筹办娶儿媳事劳心过度，小便下血不止，其血之来沥沥有声，请为诊视，举止不定，气息微弱，右脉弦细，左脉弦硬。为开安冲汤，服后稍愈。翌日晨起，忽然昏迷，其家人甚恐，又请诊视。其脉尚和平，知其昏迷系黄芪升补之力稍过，遂仍用原方，加赭石八钱，一剂而愈。

【当归生姜羊肉汤闭经医案】刘爱国：

李某某，女，19 岁，未婚，务农。1984 年 12 月由其母陪伴前来就诊。主诉：冬季经水不潮 3 年。患者 15 岁时月事初潮，50 天左右一行，色淡、量少，一日即净。至 16 岁，每逢入冬寒冷之时则信水不至，待来年春暖花开之际月经方来。停经期间，白带淋漓，质清稀，周身困倦，乏力。诊时：经水 50 余天未行，面色萎黄，畏寒身冷，四肢不温，诉其脐下时时有凉气，若置冰霜，大便溏薄，舌淡、苔薄白，脉沉细。此乃血虚寒凝之症，治宜补血温中。方用当归生姜羊肉汤方：当归 50 克，生姜 100 克，羊肉半斤。用法：上三味，加水 2500 毫升，煎取 1000 毫升，每次温服 250 毫升，日服两次。

服药 12 天，面色华润，自觉有力，畏寒身冷小腹寒凉消失•，手足转温，白带减少。复服 8 天，月经来潮。随嘱月经净后 20 天，继服上药 6 天，以资巩固。后经随访，病告痊愈。

（国医论坛 1989）

注家按语：平素经行后期、色淡量少、面萎黄、身倦乏力、舌淡苔薄则血虚可定；畏寒身冷、四肢不温、小腹寒凉、带多质稀、脉沉细则阳虚无疑。冬季天寒地圻，阳虚之体，极易为寒邪侵袭，遂成血虚经寒之症。血虚则经无物可行，寒凝则经涩滞不通，故月经闭止而不潮。方取当归生姜羊肉汤，可使血充滞通，月经自潮。药证合拍，故获良效。

【抵当汤治妇人经水不利】曹颖甫：

经水不利，有虚实寒热之分。虚者宜温经汤，兼有湿热则宜土瓜根散，产后水与血俱结胞中，则宜大黄甘遂汤。

妇人经水不利下，而主治乃为抵当汤。太阳篇云，热在下焦，下腹当硬满，小便利者，下血乃愈，抵当汤主之。又云脉沉结，少腹硬，小便自利，其人如狂者，血证谛也。抵当汤主之。其明证也。按此证少腹必结痛，大便必黑，要以小便利为不易之标准，使但用寻常通经之药，岂有济乎？

予昔在同仁辅元堂治周姓十七岁少女时经停五月矣，以善堂忌用猛药，每日令服大黄庶虫丸，不应送诊期后，病者至江阴街寓所求诊，月事不行，已抵七月，予用虻虫水蛭各一钱，大黄五钱，桃仁五十粒下之，下后以四物中参芪善后，凡二剂。十年后来于江阴街遇之，始知其嫁于小古门朱姓，已生有二子矣。

【资生汤治痨瘵闭经】张锡纯：

一九一三年，客居大名。治一室女，劳瘵年余，月信不见，羸弱不起。询方于愚，为拟此汤。连服数剂，饮食增多。身犹发热，加生地黄五钱，五六剂后热退，渐能起床，而腿疼不能行动。又加丹参、当归各三钱，服至十剂腿愈，月信亦见。又言有白带甚剧，向忘言及。遂去丹参加生牡蛎六钱，**又将于术加倍**，连服十剂带证亦愈。遂将此方邮寄家中，月余，门人喘促异常，饮食减少，脉甚虚数，投以资生汤十剂全愈。”审斯则知此方治劳瘵，无论男女，服之皆有捷效也。

女子月信，若日久不见，其血海必有坚结之血。治此等证者，但知用破血通血之药，往往病犹未去，而人已先受其伤。鸡内金性甚和平，而善消有形郁积，服之既久，瘀血之坚结者，自然融化。矧此方与健脾滋阴之药同用，新血活泼滋长，生新自能化瘀也。

罗注：此案中白带，是白术之功，非牡蛎也，盖下焦禀中焦气，是以白术补脾胃之气故也。牡蛎涩肠，补水，软坚。咸以软坚，化痰，消瘰疬结核，老血瘕疝；涩以收脱，治遗精崩带，止嗽敛汗（或同麻黄根、糯米为粉扑身，或加入煎剂）固大、小肠；微寒以清热补水，治虚劳烦热，温疟赤痢，利湿止渴，为肝、肾血分之药（王好古曰：以柴胡引之，去胁下硬；茶引之，消颈核；大黄引之，消股间肿；以地黄为使，益精收涩，止大小便利；以贝母为使，消积结）。盐水煮一伏时，粉用。亦有生用者，贝母为使。恶麻黄、辛夷、吴茱萸。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良（海气化成，纯雄无雌，故名牡）。

【资生汤治痨瘵闭经医案】四川泾南周生来函：

杨姓女，年十九岁。出嫁二载，月事犹未见，身体羸瘦，饮食减少，干咳无痰，五心烦热，诊其脉细数有力。仿用资生汤方，用生山药一两，于术二钱，牛蒡子三钱，玄参五钱，生地黄四钱，生鸡内金一钱。连服五剂，热退咳减，食欲增加。遂于原方中去生地，倍于术。又服三剂，潮忽至。共服二十剂全愈。

【一味薯蓣饮治闭经】张锡纯：

一室女，月信年余未见，已成劳瘵，卧床不起。治以拙拟资生汤，复俾日用生山药四两，煮汁当茶饮之，一月之后，体渐复初，月信亦通。

资生通脉汤方：
治室女月闭血枯，饮食减少，灼热咳嗽。
白术三钱（炒），生怀山药一两，生鸡内金二钱（黄色的），龙眼肉六钱，

山萸肉四钱（去净核），枸杞果四钱，玄参三钱，生杭芍三钱，桃仁二钱，红花钱半，甘草二钱。

灼热不退者，加生地黄六钱或至一两。咳嗽者，加川贝母三钱，米壳二钱（嗽止去之）。泄泻者，去玄参，加熟地黄一两，云苓片二钱，或更酌将白术加重。服后泻仍不止者，可于服药之外，用生怀山药细末煮粥，搀入捻碎熟鸡子黄数枚，用作点心，日服两次，泻止后停服。大便干燥者，加当归、阿胶各数钱。小便不利者，加生车前子三钱（装袋），地肤子二钱或将芍药（善治阴虚小便不利）加重。肝气郁者，加生麦芽三钱，川芎、莪术各一钱。汗多者，将萸肉改用六钱，再加生龙骨、生牡蛎各六钱。

张锡纯曰：《内经》谓“二阳之病发心脾，有不得隐曲，在女子为不月。”夫二阳者，阳明胃腑也。胃腑有病，不能消化饮食，推其病之所发，在于心脾。又推其心脾病之所发，在于有不得隐曲（凡不能自如者皆为不得隐曲）。

盖心主神脾主思，人有不得隐曲，其神思郁结，胃腑必减少酸汁（化食赖酸汁，欢喜则酸汁生者多，忧思则酸汁生者少），不能消化饮食，以生血液，所以在女子为不月也。夫女子不月，既由于胃腑有病，不能消化饮食。

治之者，自当调其脾胃，使之多进饮食，以为生血之根本。故方中用白术以健胃之阳，使之 动有力（饮食之消亦仗胃有 动）。山药、龙眼肉，以滋胃之阴，俾其酸汁多生。鸡内金原含有酸汁，且能运化诸补药之力，使之补而不滞。血虚者必多灼热，故用玄参、芍药以退热。又血虚者，其肝肾必虚，故用萸肉、枸杞以补其肝肾。甘草为补脾胃之正药，与方中萸肉并用，更有酸甘化阴之妙。桃仁、红花为破血之要品，方中少用之，非取其破血，欲借之以活血脉通经络也。至方后附载，因证加减诸药，不过粗陈梗概，至于证之更改多端，尤贵临证者，因时制宜耳。

【资生通脉汤治月经不来】张锡纯：

沧州曹姓女，年十六岁，天癸犹未至。饮食减少，身体羸瘦，渐觉灼热。其脉五至，细而无力。治以资生通脉汤，服至五剂，灼热已退，饮食加多。遂将方中玄参、芍药各减一钱，又加当归、怀牛膝各三钱。服至十剂，身体较前胖壮，脉象亦大有起色。又于方中加樗鸡（俗名红娘虫）十枚，服至七八剂，天癸遂至。遂减去樗鸡，再服数剂，以善其后。

【资生通脉汤治闭经】张锡纯：

奉天马氏女，自十四岁，月事已通，至十五岁秋际，因食瓜果过多，泄泻月余方愈，从此月事遂闭。延医延医，至十六岁季夏，病浸增剧，因求为延医。其身形瘦弱异常，气息微喘，干嗽无痰，过午潮热，夜间尤甚，饮食减少，大便泄泻。其脉数近六至，微细无力。俾先用生怀山药细末八钱，水调煮作粥，又将熟鸡子黄四枚，捻碎搀粥中，再煮一两沸，空心时服。服后须臾，又服西药百布圣二瓦，以助其消化。每日如此两次，用作点心，服至四日，其泻已止。又服数日，诸病亦稍见轻。遂投以资生通脉汤，去玄参加生地黄五钱、川贝三钱，连服十余剂，灼热减十分之八，饮食加多，喘嗽亦渐愈。遂将生地黄换作熟地黄，又加怀牛膝五钱，服至十剂，自觉身体爽健，诸病皆无，惟月事犹未见。又于方中加 虫（即土鳖虫，背多横纹者真，背光滑者非是）五枚、樗鸡十枚，服至四剂，月事已通。遂去 虫、樗鸡，俾再服数剂，以善其后。

【资生通脉汤治闭经】张锡纯：

马姓女十七岁。自十六岁秋际，因患右目生内障，服药不愈，忧思过度，以致月闭。自腊月服药，直至次年孟秋月底不愈，求为延医。其人体质瘦弱，五心烦热，过午两颧色红，灼热益甚，心中满闷，饮食少许，即停滞不下，夜不能寐。脉搏五至，弦细无力。为其饮食停滞，夜不能寐，投以资生通脉汤，加生赭石（研细）四钱，熟枣仁三钱，服至四剂，饮食加多，夜已能寐，灼热稍退，遂去枣仁，减赭石一钱，又加地黄五钱，丹皮三钱，服约十剂，

灼热大减。

又去丹皮，将龙眼肉改用八钱，再加怀牛膝五钱。连服十余剂，身体浸壮健。因其月事犹未通下，又加 虫五枚、樗鸡十枚。服至五剂，月事已通。然下者不多，遂去樗鸡、地黄，加当归五钱，俾服数剂，以善其后。

【当归生姜羊肉汤闭经医案】刘爱国医案：

李某某，女，19 岁，未婚，务农。1984 年 12·月由其母陪伴前来就诊。主诉：冬季经水不潮 3 年。患者 15 岁时月事初潮，50 天左右一行，色淡、量少，一日即净。至 16 岁，每逢入冬寒冷之时则信水不至，待来年春暖花开之际月经方来。停经期间，白带淋漓，质清稀，周身困倦，乏力。诊时：经水 50 余天未行，面色萎黄，畏寒身冷，四肢不温，诉其脐下时时有凉气，若置冰霜，大便溏薄，舌淡、苔薄白，脉沉细。此乃血虚寒凝之症，治宜补血温中。方用当归生姜羊肉汤方：当归 50 克，生姜 100 克，羊肉半斤。用法：上三味，加水 2500 毫升，煎取 1000 毫升，每次温服 250 毫升，日服两次。

服药 12 天，面色华润，自觉有力，畏寒身冷小腹寒凉消失·，手足转温，白带减少。复服 8 天，月经来潮。随嘱月经净后 20 天，继服上药 6 天，以资巩固。后经随访，病告痊愈。(国医论坛)

注家按语：平素经行后期、色淡量少、面萎黄、身倦乏力、舌淡苔薄则血虚可定；畏寒身冷、四肢不温、小腹寒凉、带多质稀、脉沉细则阳虚无疑。冬季天寒地圻，阳虚之体，极易为寒邪侵袭，遂成血虚经寒之症。血虚则经无物可行，寒凝则经涩滞不通，故月经闭止而不潮。方取当归生姜羊肉汤，可使血充滞通，月经自潮。药证合拍，故获良效。

【醴泉饮治水经数月不行医案】张锡纯：

初制此方时，原无赭石，有丹参三钱，以运化人参之补力。后治一年少妇人，信水数月不行，时作寒热，干嗽连连，且兼喘逆，胸隔满闷，不思饮食，脉数几至七至。治以有丹参原方不效，遂以赭石易丹参，一剂咳与喘皆愈强半，胸次开通，即能饮食，又服数剂脉亦和缓，共服二十剂，诸病皆愈。

以后凡治妇女月闭血枯，浸至虚劳，或兼咳嗽满闷者，皆先投以此汤，俾其饮食加多，身体强壮，经水自通。间有瘀血暗阻经道，或显有瘕可据者，继服拙拟理冲汤，或理冲丸以消融之，则妇女无难治之病矣。若其人胸中素觉短气，或大便易滑泻者，又当预防其大气下陷（大气下陷详升陷汤）。用醴泉饮时，宜减赭石、牛蒡子，并一切苏子、蒌仁、紫菀、杏仁，治咳。

醴泉饮方：

生山药一两，大生地五钱，人参四钱，玄参四钱，生赭石四钱（轧细），牛蒡子三钱（炒，捣），天冬四钱，甘草二钱。

【鸡内金治月信不通】张锡纯：

《内经》谓“女子二七天癸至”，所谓二七者，十四岁也。然必足年足月十四岁，是则室女月信之通，当在年十五矣。若是年至十五月信不通，即当预为之防。宜用整条生怀山药，轧细过罗，每用一两或八钱，煮作茶汤，调以蔗糖令适口，以之送服生鸡内金细末五分许，当点心用之。日两次，久则月信自然通下。此因山药善养血，鸡内金善通血也。若至因月信不通，饮食减少，渐觉灼热者，亦可治以此方，鸡内金末宜多用至一钱，服茶汤后再嚼服天冬二三钱。

至于病又加重，身体虚弱劳嗽，宜用拙拟资生通脉汤。此方之后，载有数案，且用此方各有加减，若服资生通脉汤，病虽见愈月信仍不至者，可参观所附案中加减诸方。

上所论诸方之外，愚有新拟之方，凡服资生通脉汤病见愈而月信不见者，可用生怀山药四两，煮浓汁，送眼生鸡内金细末三钱。所余山药之渣，仍可水煮数次，当茶饮之。久之月信必至，盖鸡内金生用，为通月信最要之药，而多用又恐稍损气分，故又多用山药至四两，

以培气分也。

【腹痛闭经医案】张锡纯：

奉天孙姓妇，年四十许。自幼时有癥瘕结于下脘，历二十余年。癥瘕之积，竟至满腹，常常作疼，心中怔忡，不能饮食，求为延医。因思此证，久而且剧，非轻剂所能疗。幸脉有根柢，犹可调治。遂投以理冲汤，加水蛭三钱。恐开破之力太过，参、 又各加一钱，又加天冬三钱，以解参、 之热。数剂后，遂能进食。服至四十余剂，下瘀积若干，癥瘕消有强半。因有事还籍，药遂停止。阅一载，腹中之积，又将复旧，复来院求为延医。仍照前方加减，俾其补破凉热之间，与病体适宜。仍服四十余剂，积下数块。又继服三十余剂，瘀积大下。其中或片或块且有膜甚浓，若胞形。此时身体觉弱，而腹中甚松畅。恐瘀犹未净，又调以补正活血之药，以善其后。

【腹痛闭经医案】张锡纯：

王生妻，来院求为治癥瘕。自言瘀积十九年矣，满腹皆系硬块。亦治以理冲汤，为其平素气虚，将方中参、 加重，三棱、莪术减半。服数剂，饮食增加，将三棱、莪术渐增至原定分量。又服数剂，气力较壮，又加水蛭二钱、樗鸡（俗名红娘）十枚。又服二十余剂，届行经之期，随经下紫黑血块若干，病愈其半。又继服三十剂，届经期，瘀血遂大下，满腹积块皆消。又俾服生新化瘀之药，以善其后。

【山楂红糖汤治月信不来】张锡纯：

女子至期，月信不来，用山楂两许煎汤，冲化红蔗糖七八钱服之即通，此方屡试屡效。若月信数月不通者，多服几次亦通下。

【生料八味倍桂、附少腹不时酸痛经不行者半载余】张氏医通：

飞畴治一妇，平昔虚火易于上升，因有怒气不得越，致中满食减，作酸嗳气，头面手足，时冷时热，少腹不时酸痛，经不行者半载余，其脉模糊，快而无力，服诸破气降气行血药不效，不知此蕴怒伤肝，肝火乘虚而克脾土，脾受克则胸中之大气不布，随肝火散漫肢体，当知气从湿腾，湿由火燥，惟太阳当空，则阴霾之气自散，真火令行，则郁蒸之气自伏，又釜底得火则能腐熟水谷，水谷运则脾胃有权，大气得归而诸证可愈矣。因用生料八味倍桂、附，十日而头面手足之冷热除，间用异功而中宽食进，如是出入调理，两月经行而愈。

【抵当丸治月经不通患癞病三年赤斑如云】《古方便览》：

一妇人，年三十，患癞病三年，眉毛脱落，鼻梁肿大，一身尽肿，赤斑如云，手足麻痹，月事不通。余乃作抵当丸使饮之，日服三钱，三十余日，血下数升，百日痊愈。”按紫斑证，属瘀血确候，我曾以大柴胡合桂枝茯苓丸或桃仁承气汤治愈数人，大抵言兼腹痛剧烈，并未曾遇有抵当丸证者。西医前曾对此证讲求输血疗法，但不去瘀则病根不拔，终不得治。

【资生汤加减治处女经闭医案】张锡纯：

天津陈氏女，年十七岁，经通忽又半载不至。**病因**：项侧生有瘰疬，服药疗治，过于咸寒，致伤脾胃，饮食减少，遂至经闭。

证候：午前微觉寒凉，日加申时，又复潮热，然不甚剧。黎明时或微出汗，咳嗽有痰，夜间略甚，然仍无妨于安眠。饮食消化不良，较寻常减半。心中恒觉发热思食凉物，大便干燥，三四日一行。其脉左部弦而微硬，右部脉亦近弦，而重诊无力，一息搏逾五至。

诊断：此因饮食减少，生血不足以至经闭也。其午前觉凉者，其气分亦有不足，不能乘阳气上升之时而宣布也。至其晚间之觉热，则显为血虚之象。至于心中发热，是因阴虚生内热也。其热上升伤肺易生咳嗽，胃中消化不良易生痰涎，此咳嗽又多痰也。其大便燥结者，因脾胃伤损失传送之力，而血虚阴亏又不能润其肠也。左脉弦而兼硬者，心血虚损不能润肝滋肾也。右脉弦而无力者，肺之津液胃之酸汁皆亏，又兼肺胃之气分皆不足也。拟治以资生通脉汤，复即原方略为加减，俾与证相宜。

处方：资生汤加减，去牛蒡子。

白术（三钱炒） 生怀山药（八钱） 大甘枸杞（六钱） 龙眼肉（五钱）生怀地黄（五钱） 玄参（四钱） 生杭芍（四钱） 生赭石（四钱轧细）当归（四钱） 桃仁（二钱） 红花（钱半） 甘草（二钱）

共煎汤一大盅，温服。

复诊：将药连服二十余剂（随时略有加减），饮食增多，身形健壮，诸病皆愈。惟月信犹未通，宜再注意通其月信。

处方：生水蛭（一两轧为细末） 生怀山药（半斤轧为细末）

每用山药末七钱，凉水调和煮作茶汤，加红蔗糖融化，令其适口，以之送服水蛭末六分，一日再服，当点心用之，久则月信必通。

效果：按方服过旬日，月信果通下，从此经血调和无病。

方解：按水蛭《神农本草经》原无炙用之文，而后世本草谓若不炙即用之，得水即活，殊为荒唐之言。尝试用此药，先用炙者无效，后改用生者，见效甚速。其性并不猛烈，惟稍有刺激性。屡服恐于胃不宜，用山药煮粥送服，此即《金匮》硝石矾石散送以大麦粥之义也。且山药饶有补益之力，又为寻常服食之品，以其粥送水蛭，既可防其开破伤正，且又善于调和胃腑也。

罗按：《伤寒论》抵当丸，水蛭用炙。脉数而虚，虚劳病也，二阳之病发心脾，故治从心脾，此资生汤之义也。此处用资生汤加生血活血之药，很有深意，张氏谓虚劳之人多血痹，故应加治血痹之药，此或是在资生汤中加桃仁、红花、当归之意。谓旧血不去，新血不生。

【肾气汤治长期低热月经延迟医案】俞长荣：

林某某，女，30 岁，工人。1973 年 4 月 30 日初诊。长期低热(体温在 37．3～37．5C 间)，持续半年以上(有肺结核病史)。口干而不喜饮，食欲不振，月经每月延迟 10～20 天。舌苔白厚较干，脉弱两尺尤涩。处方：熟地、茯苓各 15 克，枸杞、丹皮、泽泻、肉苁蓉各 9 克，附子 6 克，肉桂心 3 克。服 5 剂，体温恢复正常，诸症好转。3 月后随访，低热未再复发。(辽宁中医杂志 1980；(10)：22)

【三黄泻心汤治闭经】刘渡舟：

这是个古老之方，也不是张仲景的。太仓公淳于意的诊籍里有一个“火齐汤”，据说就是三黄泻心汤。古人用它治妇女心火不能下降，所以“胞脉闭也”，月经不来。因为心主血脉，通于胞，通于子宫。如果心火总往上来，不往下降，月经就不来了。月经不来了，这个人烦躁，很难受的，就是月经病了，所，以用泻心之法。一泻心火，心火一下降，心的血脉下达了，月经就来了。唐容川《血证论》治热性的吐血，头一个方子就是泻心汤。泻心汤治血证，效果是非常好了。这里是治热痞，用大黄黄连泻心汤，要用泡药之法。

【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：

一妇人，患疫，身热如灼，口舌糜烂，渴好热饮，一日妄语如狂，自胸至少腹，硬疼不可近手，十余日不大便，先生投以桃仁承气汤，黑便通快，诸证悉去。

《方舆鞔》曰：此方证(即桃仁承气汤证)本论曰下血，曰少腹急结，若比抵当汤证，其血犹未沉痼也，兹举余所治屡验之一于下：经血欲来，腹疼不可忍，甚至到心妄者，以桃仁承气攻之，二三帖，疼失如神。此证经年不瘥，久患成宿疾者，皆由轻剂微汤无效故也。每月经期时，用桃仁承气二三帖或四五帖，得以定疼即停服，至下月经期之问，经服逐瘀丸散之类，至期时，复服桃仁承气汤，过期后，复服缓攻之剂，如前，如是回环四五月，则数稔之滞患，亦得痊愈。

【资生汤治痨瘵闭经】张锡纯：

一九一三年，客居大名。治一室女，劳瘵年余，月信不见，羸弱不起。询方于愚，为拟此汤。连服数剂，饮食增多。身犹发热，加生地黄五钱，五六剂后热退，渐能起床，而腿疼不能行动。又加丹参、当归各三钱，服至十剂腿愈，月信亦见。又言有白带甚剧，向忘言及。

遂去丹参加生牡蛎六钱，**又将于术加倍**，连服十剂带证亦愈。遂将此方邮寄家中，月余，门人喘促异常，饮食减少，脉甚虚数，投以资生汤十剂全愈。”审斯则知此方治劳瘵，无论男女，服之皆有捷效也。

女子月信，若日久不见，其血海必有坚结之血。治此等证者，但知用破血通血之药，往往病犹未去，而人已先受其伤。鸡内金性甚和平，而善消有形郁积，服之既久，瘀血之坚结者，自然融化。矧此方与健脾滋阴之药同用，新血活泼滋长，生新自能化瘀也。

罗注：此案中白带，是白术之功，非牡蛎也，盖下焦禀中焦气，是以白术补脾胃之气故也。牡蛎涩肠，补水，软坚。咸以软坚，化痰，消瘰疬结核，老血瘕疝；涩以收脱，治遗精崩带，止嗽敛汗（或同麻黄根、糯米为粉扑身，或加入煎剂）固大、小肠；微寒以清热补水，治虚劳烦热，温疟赤痢，利湿止渴，为肝、肾血分之药（王好古曰：以柴胡引之，去胁下硬；茶引之，消颈核；大黄引之，消股间肿；以地黄为使，益精收涩，止大小便利；以贝母为使，消积结）。盐水煮一伏时，粉用。亦有生用者，贝母为使。恶麻黄、辛夷、吴茱萸。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良（海气化成，纯雄无雌，故名牡）。

【资生汤治痨瘵闭经医案】四川泾南周生来函：

杨姓女，年十九岁。出嫁二载，月事犹未见，身体羸瘦，饮食减少，干咳无痰，五心烦热，诊其脉细数有力。仿用资生汤方，用生山药一两，于术二钱，牛蒡子三钱，玄参五钱，生地黄四钱，生鸡内金一钱。连服五剂，热退咳减，食欲增加。遂于原方中去生地，倍于术。又服三剂，潮忽至。共服二十剂全愈。

【一味薯蓣饮治闭经】张锡纯：

一室女，月信年余未见，已成劳瘵，卧床不起。治以拙拟资生汤，复俾日用生山药四两，煮汁当茶饮之，一月之后，体渐复初，月信亦通。

罗按：此闭经，是虚则补其母之要妙也，肾虚则补其母土，土生水是也。

【大黄牡丹皮汤治腹中有干血着脐下不大便月经不调医案】

《续建殊录》云：“摄州船场某贾人之女，年十八，便秘而难通者有年。近日经闭及三月，其父母疑其有私，乃使医察之。医曰：『怀孕也。』女不认，复使他医察之，不能断。乃就诊于先生，按其腹，于脐下有一小块，以手近之则痛。先生曰：“是蓄血也，非重身也。”乃与大黄牡丹皮汤，服汤三剂而下利十数行，杂有黑血。尔后块减半，又兼用当归芍药散，不久经水来，大便如平日。”

汤本求真曰：月经闭止三月，于脐下部生小块，自服大黄牡丹皮汤后，下黑血而减小块之半。由此观之，则其小块之为血塞无疑矣。

【验方益元暖官汤少腹坠胀冷痛经闭】

宋××，女，二十七岁，河南人，住昆明郊区呈贡飞机场。患者禀赋素弱，婚后多年未孕。初始月经参差不调，每月均需用中西药物调治，方能应期而潮。但每次行经，量少而黑，少腹坠胀冷痛。如是两三年后，经血渐少以至闭结。

76后又继用中、西药物治疗，并行人工周期法以诱导之，前后内服中药百余剂，均未获效，迄今已经闭六年之久。患者予1959年7月到云南中医学院附设门诊部就诊。证见患者面色萎黄不泽，神情倦怠，少气懒言，毛发稀疏而焦黄。自月经闭止以来，常感头昏耳鸣，心中烦闷。日间困倦思睡，入夜又不能安眠。口淡无味，不思饮食。腰脊酸痛，腿膝酸软无力，手足厥逆，少腹亦感冰冷不适。脉象沉濇，舌质淡嫩，色黯夹瘀，苔薄白而润。此系元阳不足，冲任俱虚，血寒气滞，胞宫寒冷所致。阳虚生寒，气虚易滞，血寒则凝。血寒气虚，瘀滞难行，百脉不荣，经血无源，故而闭止，亦不孕育。故当温扶下元，温经活血，散寒暖宫。自拟验方益元暖官汤治之。

附片100克，当归15克，丹参15克，桂枝12克，吴萸9克，炙香附12克，细辛6克.赤芍9克，炒艾叶12克，干姜15克，甘草9克

服上方三剂后复诊，腹部疼痛减去七、八，少腹冰冷感觉减轻，尚有坠胀感。食思增进，手足四肢回温，心中已不烦闷，夜已能熟寐。脉仍沉濇，舌质淡，瘀黯稍减，苔薄白。

继上方温化之剂加红花5克以助温经活血之功，并嘱服药时滴酒少许为引，以促其温行血脉之效。告知患者，如服药后诸证均见好转，惟腰及少腹又复酸胀痛者，为月经欲潮之兆，幸勿疑误。

上方连服八剂，果如余言。于原方中去赤芍加川芎9克，阿胶15克(烊化兑服)药炉不辍连服五剂，经水即潮，先行者为黑色血块，继则渐红。次日，腰腹疼痛随之缓解，行经五日而净。继以八珍汤加香附、益母、炒艾等调补气血。

连服十余剂后，面色毛发润泽，精神眠食转佳。其后经信通调，应时而潮，一年后顺产一子。

【当归建中汤月事将行必先腹痛证医案】

宗嫂十一月十七日，月事将行，必先腹痛，脉左三部虚，此血亏也，宜当归建中汤。

全当归四钱，川桂枝三钱，赤白芍各三钱，生甘草钱半，生姜三片，红枣七枚，饴糖二两（冲服）

【按】当归建中汤，即桂枝汤加味也。姑以本方为例，甘草之不足，故加饴糖。白芍之不足，故加赤芍。桂枝之不足，故加当归。本经表桂枝治上气咳逆，表当归治咳逆上气，然则其差也仅矣。我今用简笔法，略发其义于此，而贻其详畀读者。

【甘麦大枣汤闭经医案】王国瑭：

王某某，女，35岁，1979年3月10日初诊。患者于18岁结婚，生育二胎，因在24岁分娩第二胎时出血过多，自此月经一直未潮十一年，伴有头晕目眩，胃中嘈杂，神疲肢倦，腰膝酸软，两颧发赤，心悸，夜卧多梦，善太息，舌质淡红，苔薄黄，脉弦细。病由产后失血过多，血虚无以灌注冲任，心火亢盛，脾阴不足，拟甘润滋补以益心脾之法。处方：甘草10克，小麦30克，红枣15枚，每日1剂，嘱服半月。3月17日二诊：服上方10剂后，月经来潮，腰腹略有胀痛，经色正常，四天月经干净，诸证渐向愈。按前方续服一月，随访两年月经按期来潮，于1982年5月生一男孩。(新中医1984)

注家按语：《景岳全书·妇人规》谓："凡妇人病损，至旬月半载之后，未有不经闭者。正因阴竭，所以血枯，枯之为义，无血而然。"本案产后失血过多，肝血虚少，脾阴暗耗。津血两亏，经源枯涸，月水自然难于来潮。此证虽为虚证，不宜大补，虽有虚火，又不宜苦降，唯用甘麦大枣取其甘平之味，养胃生津化血以达胞室，使肝血得养，脾阴得滋，水火得济，则经自通矣。若妄投通行利滞之品，急切图功，即或能竭蹶一行，而血海益涸。

【下瘀血汤月经过多医案】陈果然：

姚某，女，45岁，患者从1982年开始出现月经过多，虽经中西医多种药物治疗效果均不明显，每次月经要用卫生纸5包以上。1986年9月底月经突然如崩，持续不断，B超探查示子宫略增大，月经一直持续到10月24日方尽。自诉经期小腹部有坠痛感觉，血块多，疲乏无力，大便干结而5—6日一解，诊见舌质淡苔薄，脉沉细而数。患者经血过多，气阴两虚，但刻下经血多，有血块，伴小腹部疼痛，血瘀现象显见，虚实兼有，当以治实为主，投下瘀血汤加减：地鳖虫、桃仁(打)、白术、女贞子、全当归、木香各10g，莪术15g，太子参30g，大黄3g，甘草5g。服上方15剂，月经再临时小腹坠痛已除，精神转佳，月经量较前减少。上方隔日服1剂，服至1987年1月9日，月经量明显减少，但经期仍较长。续服至1987年2月底，所有症状全部消失。巩固治疗2个月，上述症状未再复发。(国医论坛1993；<5>：14)

【大黄䗪虫丸治闭经】：

予昔在同仁辅元堂，治周姓十七岁少女，时经停五月矣。以善堂忌用猛药，每日令服大黄䗪虫丸，不应送诊期后，病者至江阴街寓所求诊，月事不行，已抵七月，予用䗪虫水蛭各

一钱，大黄五钱，桃仁五十粒下之，下后以四物中参芪善后，凡二剂。十年后来于江阴街遇之，始知其嫁于小古门朱姓，已生有二子矣。

【大黄甘遂汤治月事不复小便难少腹满日渐膨隆医案】戴鉴周：

徐翁三儿媳，因半产而体质渐羸，月事不复，且纳差，小便难，少腹满，日渐膨隆，家人误认为妊娠。待半载后，虽腹大而无儿动之象，加之体瘦，面容无华，随卧床不起矣。翁乃惧，急遣人延戴老往诊。见病妇面容憔悴，腹如复釜，扪之软如水囊，两手尺脉弦涩而有力，辨为水与血互结于血室，致成肿满症。综其机制，肝失调达，肺失肃降，中土失运，肝、脾、肺三脏失调，损及冲任，致三焦不能运化水湿，决渎无权，酿成水血弥漫之疾。

遂处以大黄 12 克，甘遂(用面包烧后，研面，馍皮包吞服)4．5 克，阿胶 16 克，烊化冲服，枳实 12 克，白术 12 克。

一帖分三服后，连下水粪数次，而腹部肿消。后用人参养荣汤增减配以艾附吴萸之属，以培补中土，暖宫行血消除余邪。继而天癸至，月事复，一年后产一男婴。(河南中医 1985；〈2)：14)

【薏苡附子败酱散治少腹痛甚闭经】QQ 群流传：

女，20 岁。经闭八月，忽而右少腹痛甚，而彻及臀。延请诸医，均施攻破血分、通经止痛药而无效。余诊其肌肤甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，身无热但畏寒，脉沉弦数。

此乃肠内痈脓是也。治以辛热散结，排脓破瘀法。方用薏苡附子败酱散加减：薏苡仁 30 克，附子 10 克，公英 30 克，桃仁 10 克，大黄 10 克。水煎分温，日二服。四日月经下，随出一皮囊，如鸡卵，内包黄水合许。腹痛亦止，而告病痊。余以此治水结下元，亦见神功。经方之妙者，如此。

【肾气汤治痛经医案】柳英华：

王某，女，22 岁，1989 年 6 月 15 日初诊。痛经 6 年，月经于 16 岁初潮，每于行经时，少腹坠痛，伴腰骶痛，恶心欲吐，手足冰冷，头面汗出，服止痛药物，效微；月经延后，量少色淡，无凝血块，带下清稀。形体瘦弱，面色㿠白，肢体乏力。舌质淡红，苔薄白，脉沉细。肾气未充，精血虚少，冲任不调。治宜温肾助阳，填补阴精，调理冲任。

药用：附子 9g，肉桂 3g，熟地 30g，山茱萸 15g，丹皮 6g，茯苓 10g，泽泻 9g，当归 10g，白芍 15g，益母草 30g，l 甘草 3g，小茴香 6g。连服 3 个月经周期，月事正常。随访 4 年，痛经消失。(山东中医杂志 1994；〈7〉：305)

【桂枝汤证治月事后期而少时时微恶寒医案】曹颖甫：

王右，无表证，脉缓，月事后期而少，时时微恶寒，背部为甚，纳谷减，此为血运迟滞，胃肠虚弱故也，宜桂枝汤以和之。

川桂枝三钱，大白芍三钱酒炒，炙甘草三钱，生姜三片，大枣十二枚。

【按】吾国旧式妇女平日缺少运动，每致食而难化。冬日限于设备，又未能勤行沐浴。而家庭组织庞杂，妯娌姑嫂每难和睦，因而私衷抑郁，影响气血。始则气逆脘痛，纳谷不畅，自称曰肝胃气，书则谓木侮土。名虽有雅俚显晦之分，实则无二致也。驯至头晕，心悸，经事不调，成俗所谓贫血症。按其脉，常缓而无力。若贫血甚者，反成细小而数。不待风寒之侵袭，而常萧瑟恶寒，尤其在冬日为甚。余逢此等证状，常投桂枝汤原方。病者服后，陡觉周身温暖，经脉舒畅，如曝冬日之下，如就沐浴之后。此无他，桂芍活血之功也。而向之大便难者，今乃得润滑而下，因甘草安肠，本有缓下之力。若大便仍坚据不动，不妨加大黄每剂一钱以微利之，生者固佳，制者亦可。二三剂后，便乃畅行，且胃开矣。其用甚妙，亲历者方能言之。若嫌大黄近于霸道，则不妨改用研麻仁每剂四五钱，亦可缓缓奏功。况又有姜枣以刺激其胃机能，令化谷食为精微，渊源既开，血乃渐滋。吾师常以简括之句表本汤之功，曰："桂枝汤功能疏肝补脾者也。"盖肝主藏血，血行既畅，神经胥得涵养，可杜烦躁之渐，故曰疏肝，亦曰平肝。脾本概括消化系统而言，今肠胃既健，故曰补脾，善哉言乎。

于此有一要点须注意及者，即本案王右服桂枝汤后是否汗出是也。曰：不汗出，但觉周身温暖而已。然则桂枝汤果不能发汗乎？曰：发汗与否乃服后之现象。服后之现象等于方药加病证之和，非方药可得而独专也。详言之，桂枝汤必加中风证，乃得“药汗”出，若所加者非中风证，而为如本案之里证姑名此以别于太阳中风之表证），必不得汗出，或纵出而其量必甚微，甚至不觉也。吾人既知此义，可以泛应诸汤。例如服麻黄汤而大汗出者，必其人本有麻黄汤证，服承气汤而大下者，必其人本有承气汤证。反之，加麻黄汤于承气证，加承气汤于麻黄证，则欲下者未必剧汗，欲汗者未必剧下，有可断言者。然而病之形能既乱，于是坏病成矣。

或问曰：“桂枝汤既能治表证，又能治里证，表里不一，方药却同，亦有仲圣之言可资证明乎？”曰：“师曰：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。”夫曰“无寒热”，非即无表证之互辞乎？曰“不能食”而“渴”，非即胃肠虚寒，不能化谷食为精微乎？曰“名妊娠”，非即谓无病而更无表证乎？

【当归生姜羊肉汤治经水50余天未行医案】刘爱国：

李某某，女，19岁，未婚，务农。1984年12·月由其母陪伴前来就诊。主诉：冬季经水不潮3年。患者15岁时月事初潮，50天左右一行，色淡、量少，一日即净。至16岁，每逢入冬寒冷之时则信水不至，待来年春暖花开之际月经方来。停经期间，白带淋漓，质清稀，周身困倦，乏力。诊时：经水50余天未行，面色萎黄，畏寒身冷，四肢不温，诉其脐下时时有凉气，若置冰霜，大便溏薄，舌淡、苔薄白，脉沉细。此乃血虚寒凝之症，治宜补血温中。方用当归生姜羊肉汤方：当归50克，生姜100克，羊肉半斤。甩法：上三味，加水2500毫升，煎取1000毫升，每次温服250毫升，日服两次。

服药12天，面色华润，自觉有力，畏寒身冷小腹寒凉消失·，手足转温，白带减少。复服8天，月经来潮。随嘱月经净后20天，继服上药6天，以资巩固。后经随访，病告痊愈。(国医论坛1989)

【大黄牡丹皮汤治腹中有干血着脐下不大便月经不调医案】

《续建殊录》云：“摄州船场某贾人之女，年十八，便秘而难通者有年。近日经闭及三月，其父母疑其有私，乃使医察之。医曰：『怀孕也。』女不认，复使他医察之，不能断。乃就诊于先生，按其腹，于脐下有一小块，以手近之则痛。先生曰：“是蓄血也，非重身也。”乃与大黄牡丹皮汤，服汤三剂而下利十数行，杂有黑血。尔后块减半，又兼用当归芍药散，不久经水来，大便如平日。”

汤本求真曰：月经闭止三月，于脐下部生小块，自服大黄牡丹皮汤后，下黑血而减小块之半。由此观之，则其小块之为血塞无疑矣。

【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：

一妇人，患疫，身热如灼，口舌糜烂，渴好热饮，一日妄语如狂，自胸至少腹，硬疼不可近手，十余日不大便，先生投以桃仁承气汤，黑便通快，诸证悉去。

《方舆鞔》曰：此方证(即桃仁承气汤证)本论曰下血，曰少腹急结，若比抵当汤证，其血犹未沉痼也，兹举余所治屡验之一于下：经血欲来，腹疼不可忍，甚至到心妄者，以桃仁承气攻之，二三帖，疼失如神。此证经年不瘥，久患成宿疾者，皆由轻剂微汤无效故也。每月经期时，用桃仁承气二三帖或四五帖，得以定疼即停服，至下月经期之问，经服逐瘀丸散之类，至期时，复服桃仁承气汤，过期后，复服缓攻之剂，如前，如是回环四五月，则数稔之滞患，亦得痊愈。

【抵当汤与瓜蒂散治腹脉坚实心下硬塞月经不来奇怪医案】《漫游杂志》：

一妇人，三十余岁，月事即断，年年肥大，腰带数围，每月必发头疼一二次，药食皆吐，不能入咽。余诊之，腹脉坚实，心下硬塞，推之难以彻底，与抵当丸，湿膝丸，数百帖，血亦不来，及与瓜蒂末一钱，大吐一日，翌日，按心下硬塞减半，又作抵当汤与之，数日大便溏

泻，日五六次，十日后，再与瓜蒂散五分，又与抵当汤如前，肚腹剧疼，代用以丸，日三、五分，三十余日，经水来如常，头痛已除。"此案颇奇，大有研究价值。

【少腹逐瘀汤加味治疗痛经医案案例】

张某，女，38 岁。2006 年 8 月 31 日首诊：痛经自初潮开始，经来第一天或第二天开始腹痛，量大，夹有瘀块，大便似干，畏冷。舌淡胖润，脉滑尺沉。此属血瘀寒痛，以夹有瘀块为特点，法当活血祛瘀，温经止痛，王清任少腹逐瘀汤主之：

延胡索 15g，没药 10g，当归 30g，川芎 15g，赤芍 15g，蒲黄 10g，五灵脂 10g，干姜 20g，肉桂 10g，小茴香 10g，桂枝 10g，细辛 5g，炙甘草 10g，附子 10g，茯苓 30g。每于月经开始头一天服用，每日 1 剂，连服 7 剂，水煎服。服 3 个月已愈。

按：少腹逐瘀汤为治血瘀寒痛的名方，临床应用以少腹胀满疼痛，或经期腰酸少腹胀痛，或有瘀块为辨证要点。组成：川芎、炮姜、延胡索、五灵脂、芍药、小茴香、蒲黄、肉桂、当归、没药。本案另加桂枝、细辛、附子增强温通力量。

【少腹逐瘀汤加味治疗痛经医案案例】

肖某，女，36 岁。2008 年 2 月 4 日首诊：子宫内膜异位症 10 年，痛经，小腹发凉，受凉后加重，舌淡胖润有痕，脉沉滑。处方：延胡索 15g，没药 10g，当归 20g，川芎 15g，赤芍 15g，蒲黄 10g，五灵脂 10g，干姜 15g，肉桂 10g，小茴香 10g，细辛 10g，炙甘草 10g，通草 5g，茯苓 30g。上方连服半个月，痛经未发，小腹由凉转暖，嘱服右归丸巩固。

【桂枝茯苓丸治治疗闭经】：

用桂枝茯苓丸加减：加郁金、菖蒲、橘络治疗闭经 20 例，停经最短 2 个月，最长 3 年。服 1~3 剂，来月经者 8 例，4~6 剂来者 7 例，无效 5 例。

【桂枝茯苓丸治痛经】：

等用桂枝茯苓丸加味：桂枝、茯苓各 6g，牡丹皮、桃仁、赤芍、白芍各 10g，生大黄 3~6g，甘草 6g。病重加三棱、莪术、穿山甲各 9g；疼痛剧加乳香、没各 9g，路路痛 12g；便秘重用生大黄 9~12g，桃仁 15g；气虚体弱者加黄芪 9~12g、党参 9~12g；子宫腺肌症加夏枯草 15g，牡蛎 30g；月经不调加当归 9g，香附 9g，益母草 12g。经期停药。38 例痛经者好转 26 例，占 68.4%；25 例子宫内膜异位症 9 例明显缩小，占 32.14%。

【温经汤闭经医案】《经方躬行录》

郭某，38 岁，人工流产后，月经 5 月未行，于 1997 年 7 月 13 曰来诊。患者面白无华，精神萎靡，唇干萎，舌质微暗，苔白薄。询知人流术中出血甚多，流产后过食生冷果品，从此少腹隐隐作痛，带下清冷，腰脊酸痛，至夜掌心烦热。胃纳不佳，口干不欲水，大便日一行。诊其脉沉细缓，触其腹，小腹不温，左少腹微有压痛。

闻雷声而知雨意，人流失血过多，必损伤冲任，血海亏空，水浅则浪不潮也；产后过食生冷，必血为寒凝，瘀滞胞脉，是以月经不汛。治当补益冲任，温经散寒。若海足扬波，经自至矣。拟：

当归 15g，川芎 10g，赤芍 15g，桂枝 10g，吴茱萸 10g，阿胶 10g，党参 30g，甘草 6g，丹皮 10g，半夏 10g，麦冬 10g，杜仲 15g，生姜 5 片 三剂

二诊：小腹转温，疼痛不再，带下减少，饮食略增，精神大好。守方五剂。

三诊：药未尽剂，月经已至，量不多，杂紫块，少腹、腰微痛，掌心热，脉仍沉细。此寒散瘀化，然血海未充，补血益冲，仍宜继续。原方十剂。

【温经汤痛经医案】《经方躬行录》

王某，20 岁，18 岁月经初潮。每届经期，小腹疼痛，近两年益甚，以致不能上课，唯卧床耳。经毕则饮食、起居如常。中西药迭进，痛未少离，于 2005 年 12 月 3 日来诊。

本豆蔻年华，却无玫瑰风姿，但见形体消瘦，面色微青，舌淡红，有瘀斑。询知经行后期，35～45 日一行，量多，紫暗杂块，小腹、四末发冷，腰痛。恶心欲吐，口干不思饮，二

便正常。今已毕 29 日，入夜手心烦热，睡寐殊难。切得脉象沉细。腹诊腹肌挛急，无压痛。

月经迟汛者，先天不足也。从痛经、腹冷、脉细、血紫诸症观之，此血海亏虚，寒凝血滞证也。刻下月经将潮，宜未雨绸缪，拟温经汤温之通之。

当归 15g，川芎 10g，赤芍 15g，党参 15g，桂枝 10g，吴茱萸 10g，丹皮 10g，甘草 6g，半夏 10g，麦冬 15g，阿胶 15g，熟地 15g，生姜 5 片 五剂

二诊：剂尽经汛，腹痛大减，量亦少，小腹微冷，手足温，今已行 3 日，舌脉如前。守方五剂，嘱经净后早服肾气丸、晚服归脾丸各一粒，下届经期，温经汤继续服之。

三诊：此次月经 29 日即汛，腹不痛，亦不冷，行经 6 日，量不多。为绝痛经，嘱下届经期如法服之。

【失笑散经闭三月少腹痛贯彻心医案】张璐：

余治一仆人之妇，经闭三月，少腹痛贯彻心，而见前证不已，与失笑散一服，瘀血大下，遂不复作。

失笑散《太平惠民和剂局方》
五灵脂酒研，淘去沙土　蒲黄炒香，各二钱(各 6g)
先用醋调二钱，熬成膏，入水一盏，煎七分，食前热服。(现代用法：共为细末，每服 6g，用黄酒或醋冲服，亦可每日取 8-12g，用纱布包煎，作汤剂服)。
【功用】：活血祛瘀，散结止痛。
【主治】：瘀血停滞证。心腹刺痛，或产后恶露不行，或月经不调，少腹急痛等。

【半夏厚朴汤治闭经的经验】承忠委：

闭经李某，女，25 岁。1982 年 3 月 8 日初诊。据析与爱人争吵后，月讯半年未潮，症见胸闷胁痛，乳房作胀，恶心纳差，烦躁寝难，且喉中不适，舌黯、苔白滑，脉弦滑。证系气滞血瘀，痰浊凝遏。予制厚朴、苏叶、姜半夏、益母草、川牛膝、王不留行子、赤白芍、生姜各 10g，茯苓神各 15g。3 剂药后诸恙好转，但经仍未通，嘱原方续服 5 剂，经即复潮。（陕西中医）

【少腹逐瘀汤治闭经医案】

徐某，女，32 岁，闭经 2 年，多方医治，虽有效果，但停药即闭，深以为苦，求治于笔者。证属脾肾阳虚，血瘀寒凝，以补中益气汤合阳和汤少腹逐瘀汤治之，患者愿服汤剂，3 日一剂。第一月仍无月事，继服之，第二月经来，量甚少，患者喜之，连服 4 月，后月事以时下，量中等如常人。

【少腹逐瘀汤加味治治疗治疗月经后期 68 例医案案例】

药用少腹逐瘀汤加减。药用：元胡 9g，没药 9g，五灵脂 9g，肉桂 6g，当归 12g，赤芍 10g，川芎 10g，蒲黄（包）9g，益母草 20g，牛膝 10g。每日 1 剂，水煎至 300ml，早晚各服 150ml。临证略有加减，以每次月经的第 14 天开始服药，2 周为 1 个疗程。一般观察 1～3 个疗程，中病即止。完成 3 个疗程无效者，停止用药治疗。在治疗过程中禁止使用具有治疗作用的其他中、西药物及治疗措施。痊愈 28 例(80.00%)，显效 4 例(11.43%)，有效 2 例(5.71%)，无效 1 例（2.86%）。总有效率达 97.14%。

典型病例：患者，32 岁，2004 年 3 月 12 日初诊。月经 14 岁初潮，18 岁后月经规律，周期 28～30 天，经期 5～7 天。3 个月前因行人流术后，出现月经 40 余日一至，量较过去稍减，色紫黑有块，块大而多，小腹疼痛。舌质黯，边有瘀斑。脉弦细而涩。生殖系统 B 超及妇科内诊等检查未见异常。诊为月经后期证属血瘀。以上述方法治疗 1 个疗程即愈，随访 1 年未复发。

月经后期是指月经周期退后 7 天以上，甚至 40～50 天 1 次，称为月经后期，亦称经期错后、经迟等。病因有虚也有实，虚者多因营血亏损，阳气虚衰，以致血液不足，血海失充。实者多因气郁血滞，或寒凝血瘀，冲任受阻。如果月经后期而且量少，色黯有块，小腹冷痛

拒按者，属于血寒；月经后期量少，色黯淡，经质清稀，小腹冷痛，喜温喜按者，属于虚寒；月经后期量少，色淡，质稀薄，属于血虚；月经后期量少或正常，色黯红或有小块，小腹胀满而痛者，则属气滞。月经先后无定期是指月经周期不定，或先或后，超前、退后在 7 天以上者，称为月经先后无定期，又称经乱。发病因素，多为肝郁气滞，亦可能为肾虚。如果月经周期不固定，经量或多或少，色黯红有块，或有胸胁、乳房胀痛症状者，多属肝郁，为情志所伤，肝失疏泄，气血失调，血海蓄血的能力失常。

月经后期是妇科常见病，临床多以经行错后，经色黯或紫黑有块，小腹或少腹固定性疼痛，或小腹胀痛，病情反复发作，严重影响工作和学习。月经后期的原因很多，症情复杂，临床所见病人轻重不同，病情长短各异，因而明确病因，因病而致经迟者，当月经周期调至正常，还应注重治疗其原发病，方可巩固其疗效。并且，女性的特点是“以血为本，以血为用”，所以用药不可长期使用温燥之品，中病即止，以免耗伤阴血。

由于导致本组 35 例的病机由于药流或流产术后体虚，或由于宫内节育器，起居不慎，外感寒邪或过食生冷，血为寒凝，运行涩滞，冲任欠通，血海不能如期满溢，而致月经期延后。故方取少腹逐瘀汤加减以温经散寒，活血行瘀，使瘀去新生，冲任通畅月经如期而至。针对本组月经后期的病因病机，因而取得了较好的疗效。

【血府逐瘀汤是治经来淋漓不尽】齐建民：

赵某，女，34 岁，桥东副食厂工人。主诉：经来淋漓 10 余天才净，二三年经量渐多且伴有全身不适，如乳房发胀，腹痛，经来有块，色黑紫，平日潮热。烦躁，曾用归脾汤、柴胡疏肝饮、逍遥散等交替治疗，均无效。因血海本有蓄热，归脾太早，则滞而不化。

查体：患者脉紧而弦，舌红紫，苔薄。治疗：非王氏妙法不可奏效，故选用血府逐瘀汤，加生地黄、柴胡连服十余剂而愈。

【补中益气汤合少腹逐瘀汤经来腹痛呕吐下腹坠胀疼痛案】

何某，女，16 岁，经来腹痛，呕吐，下腹坠胀疼痛而久坐马桶不起（中医术语称为虚坐努责），笔者初以少腹逐瘀汤治之，不效。因思患者除血瘀寒凝病机外，尚有虚坐努责这一中气下陷之病机特点，遂以补中益气汤合少腹逐瘀汤，补中气，活血散寒止痛：党参 30 克，黄芪 30 克，当归 15 克，炒白术 15 克 陈皮 15 克，升麻 15 克，柴胡 15 克，炙甘草 10 克 小茴 15 克，干姜 15 克，玄胡 15 克，五灵脂 15 克　没药 10 克，川芎 15 克，蒲黄 15 克，官桂 15 克　赤芍 15 克

汤剂内服，服药 2 次顿觉胀痛大减，虚坐努责之感消失，嘱其继服上方一月，痛经之病后未再发。

此例属笔者进修结束回到医院之时，运用陈教授所授之辨证论治方法而取得显著效果，这为后来发现此合方可治痛经、乳腺炎、乳腺增生，以及泌尿生殖系感染，肠道感染等多种作用而广泛应用于临床各科，奠定了基础。

【当归四逆加吴茱萸生姜汤治痛经医案】陈沅生：

万某某，女，22 岁。患者经来腹痛已有 5 年之久，曾服温经汤及调经诸药，收效甚微，乃请余诊治。自述平时身冷恶寒'四肢疲软无力，小腹常觉不温，月经愆期，白带多而清稀；每逢经期小腹剧痛，痛时手足冰冷，口不渴，时吐清涎；小便量多。舌质淡暗、苔薄，脉沉迟细弱。证属虚寒逆经。欲以当归四逆加吴茱萸生姜汤治之。……处方：

处方：当归 15 克，桂枝 12 克，白芍(酒炒)15 克，细辛 6 克，大枣 18 克'木通 9 克，炙甘草 6 克，官桂 9 克，台乌 9 克，艾叶(炒)6 克，吴茱萸 9 克，生姜 9 克，加白酒—杯同煎。

嘱在经前煎服此方 3 剂，下月经期前再服 3 剂。后 6 剂而愈。

【黄芪建中汤加减腹痛常发于月经来时病医案】

曹某，女，腹痛剧烈，病情反复已近 5 载，经西医院确诊为卟啉病。自诉腹痛常发于月

经来时。刻下全腹胀痛，腹壁拘急，轻按适可，重按反舒，形寒喜暖，四肢不温，头晕目眩，面色苍白，唇甲带紫，恶心欲吐，大便秘结。舌淡边多齿痕，苔白，脉细弦。证属气血亏虚，循行失畅，肝失温养则络脉拘急，脾受寒阻则阳失通化。拟以黄芪建中汤加减治之。1 剂后，翌晨腹痛大减，大便亦通，连服 3 日腹痛始平，四肢得温。后连服月余，经来亦未发病。出院后随访年余，情况良好。检查尿、血均无血卟啉可见。《上海历代名医方技集成》

【疮疡三两三治经闭风疹】

邱氏，女，20 余岁，经闭三年余，多方疗法无效，时发风疹来诊，予本方服三剂后，风疹愈而经行。后曾多次用于体弱经闭患者，均得奇功。

“疮疡三两三”全方组成列下：生黄芪 30g，金银花 30g，全当归 30g，生甘草 9g，川蜈蚣 0.1g。

【阳和汤治痛经】李秀丽：

崔某，女，16 岁，2001 年冬初诊。自诉月经初至时淋雨，自此每次月经期则腹痛。诊见患者精神一般，面色苍白，形体稍胖，四肢清冷，纳食尚好，腹痛喜温喜按，月经量少色淡，舌体胖大，舌苔白而腻，脉沉细而迟。诊为痛经，证属寒湿内凝、气滞痰阻，阳虚阴盛，冲任失调。予阳和汤原方重用炮姜、肉桂，另加当归 10g，连服 10 剂，后月经来潮未再腹痛。

按：痛经一证原因很多，有风寒、气滞、血瘀之分，本案系寒湿内凝，阳虚阴盛的经行腹痛，阳和汤既能温阳补，虚，又能通滞止痛，故获捷效。方中白芥子更有驱除寒痰.解郁利肝的作用，用之最妙。

【桃核承气汤治倒经腹中有块】

曹右，住林荫路。初诊十月二十二日。经事六七月不来，鼻衄时作，腹中有块，却不拒按，所以然者，鼻衄宣泄于上故也。阙上痛，周身骨节烘热而咳。此病欲作干血。以其体实，宜桃核承气汤加味，上者下之也。川桂枝二钱，制大黄三钱，枳实二钱，桃仁泥四钱，生甘草钱半，牛膝二钱，全当归二钱，大白芍二钱。按：桃核承气汤亦余所惯用而得效之方也……藜藿之妇女，经停腹痛而乞诊。其甚者更见鼻衄或吐血，所谓倒经是也。余苟察其非孕，悉以本方加减投之，必下黑污之物而愈，本案特其一例耳。

曹右约三十余岁，面目黧黑，一望而知为劳苦之妇人也。妇诉其苦，备如案述。干咳不得痰。其块在少腹之左，久据不移，腹中痛，却喜按。假令腹中有块而拒按，此为本汤的证，绝无可疑者。今却喜按，则本汤之中否，实须细考。余以其鼻衄之宣泄为亡血家，法当导之使下，乃径与本方，盖处方之前，未尝不踌躇审顾也！二诊十月二十三日。骨节烘热已减，咳嗽亦除，癥块已能移动，不如向之占据一方矣。服药半日，见效如此，非经方孰能致之？

川桂枝三钱，枳实三钱，当归三钱，制大黄四钱，牛膝三钱，白芍三钱，桃仁四钱，甘草三钱。按：服药半日云者，盖妇于昨日下午五时服药，迄今日下午五时，方为一日，而今日上午九时妇即来二诊故也。妇谓其块自原处略向上中方向移动，大便畅而未察其色，咳与烘热均减，而夜寐以安。

夫不治其咳而咳差，不治其骨蒸而骨蒸减者，何也？所谓治病必求其本，今主病去，而客病随除也。三日，妇未来。四日，续来，曰：服二诊方后，饭量增，体随舒快。其块更向上中方向移动，渐在腹之中道矣。余曰：若是甚佳，中道犹通衢，其块易下矣。曰：昨以便故，丐他医施诊，顾服药后，今日反觉不舒，块亦不动。

阅其案，曰：经闭，腹中痞块，日晡潮热，宿瘀内阻，胞脉不利，宜祛瘀为治。药为桃仁泥六钱，花槟榔三钱，两头尖二钱，大白芍三钱，青陈皮各钱半，川桂枝一钱，醋炒三棱、莪术各三钱，紫丹参二钱，泽兰叶三钱。余曰：案甚佳，方亦合，量又不轻，安得无效？妇坚请疏方。余曰：服二诊之方可矣，安用多事为？五日，妇竟不复来。阅者将虞其殆乎？余则敢必其向愈。《经方实验录》

【奔豚汤治经行时呕吐医案】魏翠荣：

赵某某，女24岁。1992年8月9日就诊。半年来每次经行时呕吐，腹痛作胀，经服维生素B，颠茄片等药治疗未愈。刻诊：经水27天至30天一行，经色淡红有小血块，腹痛发胀欲呕，胃脘痞满，心中烦闷，口苦咽干，头晕昏沉，小便黄，大便稍干，舌质淡红，苔略黄，脉细数，证属血虚有热，胃气不和，治宜滋养营血，和胃降逆。处方：黄芩18g，川芎、半夏各10g，杭芍、陈皮、甘李根白皮、当归各12g，葛根15g。服5剂后症状消失。随访半年，未复发，已痊愈。(四川中医1995i(10>：40)

【小柴胡汤治神经性厌食闭经医案】日本：

22岁妇女，自1年半之前开始。粒米不进，不论吃了什么食物即感剑突下如食石，痛苦难忍。吃饭时只吃大约1片苹果，1片面包。大便4～5日甚至10日不行。1个月前开始闭经。体重减至30公斤。足冷，肩酸痛，脉沉迟弱，收缩压只有90mmHg。腹部瘦，无弹性，右胁下有抵抗压痛，胸胁苦满明显。正中线稍偏右至脐上有膨隆。不食病昔称“神仙劳”，香川修庵认为是癫痫之一种类型。年轻妇女较多，数年来不吃米饭，仅进少许果仁、小豆、果子等，多不主诉其他痛苦。古人用延年半夏汤、抑肝扶脾散、四君子汤、半夏厚朴汤、分心气饮、驱瘀血剂等。此患者根据其腹证用小柴胡汤。服后立即发生剧烈腹痛下利，辗转反侧，但不久疼痛即消失。第3日起食3碗米饭，并无不适。虽然尚有腹痛下利，但目眩和呼吸较前为好。《临床应用汉方处方解说》

【验方益元暖官汤少腹坠胀冷痛经闭】

宋××，女，二十七岁，河南人，住昆明郊区呈贡飞机场。患者禀赋素弱，婚后多年未孕。初始月经参差不调，每月均需用中西药物调治，方能应期而潮。但每次行经，量少而黑，少腹坠胀冷痛。如是两三年后，经血渐少以至闭结。

76后又继用中、西药物治疗，并行人工周期法以诱导之，前后内服中药百余剂，均未获效，迄今已经闭六年之久。患者予1959年7月到云南中医学院附设门诊部就诊。证见患者面色萎黄不泽，神情倦怠，少气懒言，毛发稀疏而焦黄。自月经闭止以来，常感头昏耳鸣，心中烦闷。日间困倦思睡，入夜又不能安眠。口淡无味，不思饮食。腰膂酸痛，腿膝酸软无力，手足厥逆，少腹亦感冰冷不适。脉象沉濇，舌质淡嫩，色黯夹瘀，苔薄白而润。此系元阳不足，冲任俱虚，血寒气滞，胞宫寒冷所致。阳虚生寒，气虚易滞，血寒则凝。血寒气虚，瘀滞难行，百脉不荣，经血无源，故而闭止，亦不孕育。故当温扶下元，温经活血，散寒暖宫。自拟验方益元暖官汤治之。

附片100克，当归15克，丹参15克，桂枝12克，吴茱萸9克，炙香附12克，细辛6克．赤芍9克，炒艾叶12克，干姜15克，甘草9克

服上方三剂后复诊，腹部疼痛减去七、八，少腹冰冷感觉减轻，尚有坠胀感。食思增进，手足四肢回温，心中已不烦闷，夜已能熟寐。脉仍沉濇，舌质淡，瘀黯稍减，苔薄白。

继上方温化之剂加红花5克以助温经活血之功，并嘱服药时滴酒少许为引，以促其温行血脉之效。告知患者，如服药后诸证均见好转，惟腰及少腹又复酸胀痛者，为月经欲潮之兆，幸勿疑误。

上方连服八剂，果如余言。于原方中去赤芍加川芎9克，阿胶15克(烊化兑服)药炉不辍连服五剂，经水即潮，先行者为黑色血块，继则渐红。次日，腰腹疼痛随之缓解，行经五日而净。继以八珍汤加香附、益母、炒艾等调补气血。

连服十余剂后，面色毛发润泽，精神眠食转佳。其后经信通调，应时而潮，一年后顺产一子。

【四逆汤治反复发作鼻出血淋漓月经淋漓不断医案】李洪善：

张某某，女，45岁。反复发作鼻出血淋漓不止已半年有余，血色淡红、质稀；遇冷出血次数增加。近来血中间有牛奶样分泌物，且伴有懒言少语，倦怠乏力，遂来就诊。初诊：鼻

出血约50毫升，色淡质稀。面色㿠白，气短声低，形寒肢冷，精神萎靡不振，咳嗽吐痰带血丝。近二月来，月经淋漓不断，色淡红质清稀，舌质淡、苔薄白、脉沉微细。观其脉证相合，纯属一派阳虚之象，治宜温阳摄血，予四逆汤治之：

炮附子、炮姜各9克，炙甘草6克，2剂，水煎服。

二诊：服上药后，诸证均减，效不更方，守上方2剂。三诊：诸症已愈，惟觉口苦咽干，舌面偶生小疮。改投导赤散加炮附子12克2剂。后经随访，未见复发。

【小柴胡汤合四物汤治疗来月经时发热】矢数道明：

患者42岁，女，初诊于1973年11月。患者5年前起来月经时有腰痛和肩凝。一年来月经来得早，初来的前两天必有恶寒，并发热38~39°C。月经结束，发热也消退。体格、营养一般，常有口腔炎，尿频。脉平。腹诊：脐左侧有抵抗和压痛。

治疗：针对血热证让服小柴胡汤合四物汤，即从第二次月经起无恶寒无发热，再服一个月后，以后再没有患来月经时发热症状。前后服3个月停药。《汉方的临床》1974年6月。

罗按："脐左侧有抵抗和压痛"，这是诊断小柴胡证的依据，病位在于胸胁间。日本人习惯腹诊。也有往来寒热。四物汤，它是一个血虚型的活血药。用于营血虚滞证。

四物汤方《仙授理伤续断秘方》

当归（去芦，酒浸炒）9g，川芎6g，白芍9g，熟干地黄酒蒸(熟地黄已有成品，干地黄即生地黄晒干12g)各等分

上为粗末。每服三钱(15g)，水一盏半，煎至八分，去渣，空心食前热服(现代用法：作汤剂，水煎服)。

【主治】矢数道明：补血调血。营血虚滞证。头晕目眩，心悸失眠，面色无华，妇人月经不调，量少或经闭不行，脐腹作痛，甚或瘕块硬结，舌淡，口唇、爪甲色淡，脉细弦或细涩。

【方解】矢数道明：本方是补血调经的主方，是从《金匮要略》中的芎归胶艾汤减去阿胶、艾叶、甘草而成。本方治证由营血亏虚，血行不畅，冲任虚损所致。血虚与心、肝两脏关系最为密切。肝藏血，血虚则肝失所养，无以上荣，故头晕目眩；心主血，藏神，血虚则心神失养，故心悸失眠；营血亏虚，则面部、唇舌、爪甲等失于濡养，故色淡无华；冲为血海，任主胞胎，冲任虚损，肝血不足，加之血行不畅，则月经不调，可见月经量少、色淡、或前或后，甚或经闭不行等症；血虚则血脉无以充盈，血行不畅易致血瘀，可见脐腹疼痛，甚或瘕块硬结；脉细涩或细弦为营血亏虚，血行不畅之象。治宜补养营血为主，辅以调畅血脉。方中熟地甘温味厚质润，人肝、肾经，长于滋养阴血，补肾填精，为补血要药，故为君药。当归甘辛温，归肝、心、脾经，为补血良药，兼具活血作用，且为养血调经要药，用为臣药。佐以白芍养血益阴；川芎活血行气。四药配伍，共奏补血调血之功。

本方的配伍特点是以熟地、白芍阴柔补血之品(血中血药)与辛香之当归、川芎(血中气药)相配，动静相宜，补血而不滞血，行血而不伤血，温而不燥，滋而不腻，成为补血调血之良方。

本方在《仙授理伤续断秘方》中治外伤瘀血作痛，宋代《太平惠民和剂局方》用于妇人诸疾。

辨证要点　本方是补血调经的基础方。临床应用以面色无华，唇甲色淡，舌淡，脉细为辨证要点。

【己椒苈黄丸闭经医案】刘露祥：

傅某某，35岁。因患闭经，延医数人，有按瘀血论治者，有从血亏论治者，有从气血双虚而治者，医治年余，经未行而身体日衰。患者素体健壮，曾因怒气而渐食少，形瘦腹大，经闭，腹内漉漉有声，对坐即能听到。自言腹满甚，口干舌燥，舌淡苔薄白，双手脉均沉细而弦。脉症合参，证属痰饮阻经。给予己椒苈黄丸方：防己10克，川椒目15克，炒葶苈子

10 克，大黄 10 克(后入)。水煎服 2 剂。服药后当晚泻下痰液水一瓷脸盆余，泻后除感乏力外，反复有腹中舒适与饥饿感，脉弦象亦减。余日：药已中病，隔日再服 1 剂。二诊：患者两次泻下后(第二次泻之痰水为前次的一半)身感舒适，饮食增加。宗“衰其大半而止”之旨，嘱停药后以饮食调养。月后随访，经血已通，康复如前。(山东中医学院学报 1980；<1>：54)

【桂枝茯苓丸加味月经不调医案】谭俊臣：

谢某，女，27 岁。1980 年 8 月 2 日初诊。患者主诉：经常头晕、心悸、月经不调已五年之久，经多次妇检未见明显器质性病变。使用各类补血剂，血色素仍保持在 6～7 克之间。患者 14 岁月经初潮，量一般，至 20 岁时仍属正常，21 岁结婚后夫妻不和，以致忧郁重重。近一年来，每月行经二次，每次 1～2 天，量极少，色紫暗少腹坠胀、刺痛拒按，夜多恶梦，纳差，神疲，烦躁不宁。诊察：面色不华，两目暗黑，眼睑㿠白，肌肤甲错，舌尖见黍粒状瘀斑点多个，脉沉涩。考虑忧郁伤肝，思虑伤脾，肝脾受损，导致瘀血内停。瘀血不去，则新血不生，正气无由恢复。治宜祛瘀散结，方用桂枝茯苓丸加大黄 15 克煎服。服药 5 剂，经行量多，排出紫暗色血块，自觉少腹格外轻松，经色正常，腹已不痛，五日经净。自觉症状明显好转，食欲增进，精神舒畅。守原方去大黄加当归 10 克、川芎 5 克、党参 10 克、吴茱萸 3 克，10 剂后面色转红润，血色素递增至 11．5 克，症状全部消失，月经正常，一年后生一子，身体健康。(河南中医 1985；(2)：20)

【验方益元暖官汤少腹坠胀冷痛经闭】

宋××，女，二十七岁，河南人，住昆明郊区呈贡飞机场。患者禀赋素弱，婚后多年未孕。初始月经参差不调，每月均需用中西药物调治，方能应期而潮。但每次行经，量少而黑，少腹坠胀冷痛。如是两三年后，经血渐少以至闭结。

76 后又继用中、西药物治疗，并行人工周期法以诱导之，前后内服中药百余剂，均未获效，迄今已经闭六年之久。患者予 1959 年 7 月到云南中医学院附设门诊部就诊。证见患者面色萎黄不泽，神情倦怠，少气懒言，毛发稀疏而焦黄。自月经闭止以来，常感头昏耳鸣，心中烦闷。日间困倦思睡，入夜又不能安眠。口淡无味，不思饮食。腰膂酸痛，腿膝酸软无力，手足厥逆，少腹亦感冰冷不适。脉象沉濇，舌质淡嫩，色黯夹瘀，苔薄白而润。此系元阳不足，冲任俱虚，血寒气滞，胞宫寒冷所致。阳虚生寒，气虚易滞，血寒则凝。血寒气虚，瘀滞难行，百脉不荣，经血无源，故而闭止，亦不孕育。故当温扶下元，温经活血，散寒暖宫。自拟验方益元暖官汤治之。

附片 100 克，当归 15 克，丹参 15 克，桂枝 12 克，吴茱萸 9 克，炙香附 12 克，细辛 6 克．赤芍 9 克，炒艾叶 12 克，干姜 15 克，甘草 9 克

服上方三剂后复诊，腹部疼痛减去七、八，少腹冰冷感觉减轻，尚有坠胀感。食思增进，手足四肢回温，心中已不烦闷，夜已能熟寐。脉仍沉濇，舌质淡，瘀黯稍减，苔薄白。

继上方温化之剂加红花 5 克以助温经活血之功，并嘱服药时滴酒少许为引，以促其温行血脉之效。告知患者，如服药后诸证均见好转，惟腰及少腹又复酸胀痛者，为月经欲潮之兆，幸勿疑误。

上方连服八剂，果如余言。于原方中去赤芍加川芎 9 克，阿胶 15 克(烊化兑服)药炉不辍连服五剂，经水即潮，先行者为黑色血块，继则渐红。次日，腰腹疼痛随之缓解，行经五日而净。继以八珍汤加香附、益母、炒艾等调补气血。

连服十余剂后，面色毛发润泽，精神眠食转佳。其后经信通调，应时而潮，一年后顺产一子。

【当归芍药散月经过多】

一妇人，月经过度，或月再见，肩背强，腹中挛急，或硬满，饮食能进，大便秘结，阴门时痒，患之者数年，未得治效。先生与当归芍药散，兼用下瘀血丸，宿疴遂全治。《成绩录》

【血府逐瘀汤治逆经】：

姚某，女，20 岁，周期性逆经(衄血)3 年余。初诊正值月经来潮，诉每月周期性衄血，色鲜，持续 3～4 天，乳胀，无腹痛、腰酸，时有头胀感，平素急躁，纳差，夜寐欠佳，舌淡暗，边有齿痕，尖有瘀点，苔薄黄根腻，脉弦细。于外院行鼻窦 CT 平扫检查未见异常。中医诊断：逆经，衄血。四诊合参，证属肝气上逆，迫血上溢。治拟凉血活血，平肝降逆。予血府逐瘀汤加味，处方：当归、枳壳、黑芥穗、神曲、天冬、麦冬各 9g，生地黄、川牛膝、白芍、生牡蛎各 30g，桃仁、红花、桔梗、柴胡、甘草各 6g，川芎 3g，赤芍、栀子炭各 15g。每天 1 剂，水煎服。

二诊：服药 3 剂后衄血止，仍有头胀，乳胀，神疲乏力，口干欲饮，纳呆，寐多梦，舌淡有瘀点，苔薄黄腻，根腻，脉弦细。前方去黑芥穗、栀子炭，改川牛膝 9g，加郁金、藿香、紫苏梗各 9g，姜黄 6g，麦芽 15g，继服 7 剂。复诊：头胀、乳胀感消失，胃纳渐增，舌象仍见瘀点，脉弦细。后继予活血平肝法 14 剂，月经如期而行，衄血症消。继以养血活血、疏肝健脾立法调理 2 月。6 月后随访，月经皆应时而行，周期性衄血未有复发。

按：《叶氏女科证治·逆经》云："经不往下行，而从口鼻中出，名曰逆经。"论病因病机，一为火热，一为气机逆乱。如《素问·至真要大论》中言："诸逆冲上，皆属于火。"《类证治裁》云："按月倒经，血出鼻口，此由肝火上迫，不循常道。"本病病机临床以肝气、肝火上逆为常见，上冲于肺则成鼻衄；热蒸于胃，则为吐血或齿衄。从脏腑论，肝藏血，主疏泄，肝喜条达而恶抑郁，若肝气横逆，血随气机而外溢，则为吐衄、血崩等证。如《傅青主女科》云："……人以为火热之极也，谁知是肝气之逆乎。夫肝之性最强……顺则气安，逆则气动，血随气为行止，气安则血安，气动则血动。"患者平素急躁易怒、纳差、头胀、乳胀提示肝郁甚而化火之征；肝气逆乱，肝火旺盛，血随气行，上溢而为吐衄；而舌尖边有瘀斑点、脉弦皆为血瘀之象，故以血府逐瘀汤为基础方，取其清热平肝、活血化瘀之功。方中四逆散调和肝脾，理气和血；桃红四物补血活血，取通因通用之法；加入天冬、麦冬、黑芥穗、栀子炭，合生地黄、赤芍滋阴清热，凉血泻火而止衄；白芍、牡蛎柔肝平肝、固涩止衄；重用生地黄、白芍、川牛膝，意在滋肾柔肝、清热凉血、引热下行，令上逆之肝气得顺，引离经之血得归常道。女科之病多责之于肝，疏肝理气、清肝降火是常法。而通因通用，见于《素问·至真要大论》："寒因寒用，热因热用，塞因塞用，通因通用，心伏其所主，而先其所因。"该法是反治法之一，是以通治通，即用通利药治疗具有实性通泄症状的病症，一般多用于食积腹痛、泻下不畅及膀胱湿热所致尿急、尿频、尿痛病症之类，此处活用于血证治疗（月事之际），不拘于见血止血，亦为一种思路。

第四节 妇人痛经

【血府逐瘀汤加味治瘀滞痛经案】：

林某，35 岁，1998 年 1 月 4 日初诊。缘于 1997 年 11 月初，正值经期第 3d，因惊吓后经血骤停。之后总觉小腹不适，未予治疗。至 1997 年 12 月初月经来潮前 5d 开始小腹痛胀，自服"止痛药"减轻，至月经来潮时腹痛难忍，血量少，色紫黑有块。伴有恶心、腰酸腿痛。去附近诊所注射"止痛针"，又服八珍益母丸好转。

1998 年元旦期间，因腹痛较前次加重来我院诊治。患者痛苦病容，舌隐青、脉沉迟，下腹拒按。此为气乱而致血海气机不利经血运行不畅，冲任瘀阻之痛经症，治以行滞化瘀、安神止痛法，选血府逐瘀汤加味：当归 20g，生地 20g，桃仁 5g，红花 10g，枳壳 15g，赤芍 15g，柴胡 15g，川芎 5g，牛膝 15g，甘草 10g，益母草 20g，远志 5g，茯苓 20g，3 剂。服第 2 剂时来潮，且血量较多，流下黑血块，腹痛明显减轻，3 剂服完后血量、血色正常，腹痛消失。经血持续 6d 停止。

1998 年 1 月 10 日二诊：精神振作，舌隐青，脉沉。效不更方又服 5 剂。于 2 月 3 日月经来潮，期、量、色、质均正常，仅有轻微腰酸，舌淡红，脉滑数。病痊愈。按：此痛经案为经期惊恐所致，惊则气乱，气不能为血帅，冲任气血运行受阻，不通则痛。用血府逐瘀汤活血化瘀、通经止痛，引瘀血不行，则经通而痛自止。

【桂枝茯苓丸经来少腹痛不可忍医案】张季高：

卓某某，女，18 岁，1986 年 2 月 4 日初诊。主诉：14 岁月经初潮后，经量少而时间不准。近三个月，经来少腹痛不可忍，经中西医治疗未效。现适逢经来，腹痛不堪言。症见痛苦面容，少腹阵发性剧痛，痛引腰骶，经色紫黯不畅而伴血块。唇舌紫黯，脉沉而涩，综此脉证，属胞宫血瘀，经行腹痛。拟活血化瘀为主，兼以理气。方用桂枝茯苓丸加味主之。处方：桂枝、丹皮、蒲黄各 5 克，茯苓、赤芍、桃仁、延胡、五灵脂各 10 克。2 剂疼痛减半，再进 2 剂而愈。嘱下次月经前遵上方服用 2 剂，经痛乃止，追访多年，月经正常。(新中医 1991；(6>：5)

【少腹逐瘀汤加味治原发性痛经医案案例】

痛经是指妇女月经期或者经期前后出现周期性下腹疼痛，常呈痉挛性，有时包括其他症状如：乏力、头晕、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腰腿痛等。是年轻女性的常见病症，分为原发性和继发性痛经。原发性痛经是指不伴有明显的盆腔器质性疾病，即功能性痛经，多数发生于月经初潮后 2～3 年，多见于青春期少女和未婚年轻妇女。往往多数病人都是在疼痛发作时，口服止痛药帮助缓解症状。笔者观察，按照中医辨证分型，痛经以实证居多，虚症较少；寒症居多，热症较少。应用传统名方少腹逐瘀汤加减治疗 88 例寒凝血瘀型原发性痛经，收到较好疗效，现报道如下。

选用王清任《医林改错》之少腹逐瘀汤(小茴香、干姜、延胡索、当归、川芎、官桂、赤芍、蒲黄、五灵脂)进行加减，在药物上加减以单味为主，不超过 3 个单味药。水煎汤剂，由我院煎药室代煎。每剂 2 袋，每袋 100ml。每次 l 袋，每日 2 次口服。经行前 l 周开始至

经行结束为 1 疗程，连服 3 个疗程。服药期间禁服其它止痛药，忌食生冷及刺激性物，避免情绪起伏过大，经期避免游泳、泡浴或当风着凉。分别于疗程结束后第 1 个月经周期和停药后 3 个月共 2 次对症状评分，以此判定疗效。结果 88 例患者，痊愈 15 例(17.05%)，显效 34 例(38.64%)，有效 18 例(20.45%)，无效 21 例(23.86%)，总有效率为 76.14%。

现代医学认为,痛经的发生主要与月经时子宫内膜合成和释放膜前列腺素(PG)含量增高，引起子宫过强收缩甚至痉挛性收缩有关，同时与精神过度紧张、遗传因素亦有关。另外，许多研究还证实血管加压素和催产素也是导致痛经的重要因素。中医学认为，痛经病位在子宫、冲任，以“不通则痛”或者“不荣而通”为主要病机。实者可由气滞血瘀、寒凝血瘀、湿热瘀阻导致子宫的气血运行不畅，“不通则痛”；虚者主要由于气血虚弱、肾气亏损导致子宫失于濡养，“不荣而通”。经过临床观察，痛经以实证居多，虚症较少；寒症居多，热症较少。如果经期经前感受寒邪，或过食寒凉生冷，寒客冲任，与血相搏，导致冲任气血失畅。经前、经期气血下注冲任，子宫气血壅滞，“不通则痛”。若经前、经期冒雨、涉水、游泳或久居湿地，则寒邪与湿邪共同致病。本研究选取临床常见的寒凝血瘀型原发性痛经患者进行治疗观察，探讨经典成方的疗效。本组观察患者 88 例均为年轻女性，青春期者居多，正处于生长发育阶段，先天禀赋不足，肾气欠盛，嗜食生冷，涉水着凉，致寒邪为病，或兼湿邪，客于冲任、胞中，表现为痛症。治宜温经散寒，活血化瘀，调经止痛。少腹逐瘀汤正投此意，方中肉桂、小茴香、干姜温经散寒，当归、川芎、赤药养血活血，蒲黄、五灵脂、没药、延胡索化瘀止痛，全方有温经散寒、化瘀通经止痛之功效。寒散血行，冲任子宫血气调和流畅，疼痛自止。如《血证论》说：“若无瘀血，则经自流通，安无恙。”兼湿邪者，加苍术燥湿化浊，茯苓健脾渗湿；痛胀明显者加香附、乌药疏肝理气；冷痛甚者，加艾叶、吴茱萸增加温经散寒之力。

现代药理学认为，肉桂、当归均能扩张血管，增加血流量，加快血液循环，当归还具有兴奋和抑制子宫收缩的双重作用；赤芍、延胡索、五灵脂有解痉、镇痛的作用；当归、川芎有降低血粘度，抑制血小板聚集，促进子宫内膜退行性变、裂解、萎缩、脱落的功能。有研究认为：活血化瘀类中药具有改善患者盆腔血流波形、波幅、血灌注量等血流动力学指标作用；甲皱毛细血管的形态、流态、袢周状态呈现的微循环障碍也随着临床症状的缓解而改善。还有研究报道：活血化瘀中药有降低经血和子宫内膜 PGF2a 含量的作用。本研究运用王清任的少腹逐瘀汤加减进行临床治疗观察，收到良好疗效，但其作用机理的动物实验研究有待进一步探讨。

【血府逐瘀汤加味治瘀滞痛经案】：

林某，35 岁，1998 年 1 月 4 日初诊。缘于 1997 年 11 月初，正值经期第 3d，因惊吓后经血骤停。之后总觉小腹不适，未予治疗。至 1997 年 12 月初月经来潮前 5d 开始小腹痛胀，自服“止痛药”减轻，至月经来潮时腹痛难忍，血量少，色紫黑有块。伴有恶心、腰酸腿痛。去附近诊所注射“止痛针”，又服八珍益母丸好转。

1998 年元旦期间，因腹痛较前次加重来我院诊治。患者痛苦病容，舌隐青、脉沉迟，下腹拒按。此为气乱而致血海气机不利经血运行不畅，冲任瘀阻之痛经症，治以行滞化瘀、安神止痛法，选血府逐瘀汤加味：当归 20g，生地 20g，桃仁 5g，红花 10g，枳壳 15g，赤芍 15g，柴胡 15g，川芎 5g，牛膝 15g，甘草 10g，益母草 20g，远志 5g，茯苓 20g，3 剂。服第 2 剂时来潮，且血量较多，流下黑血块，腹痛明显减轻，3 剂服完后血量、血色正常，腹痛消失。经血持续 6d 停止。

1998 年 1 月 10 日二诊：精神振作，舌隐青，脉沉。效不更方又服 5 剂。于 2 月 3 日月经来潮，期、量、色、质均正常，仅有轻微腰酸，舌淡红，脉滑数。病痊愈。按：此痛经案为经期惊恐所致，惊则气乱，气不能为血帅，冲任气血运行受阻，不通则痛。用血府逐瘀汤活血化瘀、通经止痛，引瘀血不行，则经通而痛自止。

【乌梅汤加味治痛经】蒲辅周医案：

董某某，女，41 岁。痛经 10 年，月经干净后 10 天左右，即开始阴道、少腹牵拉样疼痛难忍，直到行经方渐缓解消失。然行经不利，有血块，少腹疼痛较甚，伴有嗳气，矢气，大便溏，心烦，失眠，恶热喜凉，精神困倦。近年来渐加重，曾服活血化瘀、疏肝解郁之剂亦未见效应。脉右沉细无力，左弦细，舌质稍暗，苔薄白，证属厥阴为病，寒热错杂，肝脾失调，气血不和。治宜调肝和脾，兼理气血，拟乌梅汤加味。处方：

乌梅 10 克，花椒 6 克，干姜 6 克，马尾连 9 克，细辛 3 克，黄柏 6 克，制附片 4 克，当归 9 克，党参 9 克，吴茱萸 5 克，红糖为引，水煎服。

服 2 剂，阴道少腹牵拉疼痛减轻，服 5 剂而消失，续服 7 剂，月经来潮时疼痛已微，嗳气便溏有好转，继服乌梅丸调治而愈。

按语：痛经，凡阴道少腹牵引疼痛者，其病与厥阴关系最为密切。因足厥阴之脉，循股阴，入毛中，过阴器，抵小腹。据蒲老经验：若肝郁血虚者，选用逍遥散；血虚寒闭者，选用当归四逆汤，用之可效；而对寒热错杂，气血失和者，选用乌梅丸则有较好疗效。

罗按：乌梅汤是乌梅丸的汤剂。

【乌头汤治痛经医案】陈寿永医案：

程某某，女，18 岁。1994 年 11 月 8 日初诊。上月经前冒寒在外，身寒嗇嗇，次日，少腹绞痛，经用薪艾煎水热敷良久，方行紫黑小血块和污液，后打针吃药好转。前天又不慎受凉，经水昨行。现少腹冷痛，热熨则减，按则痛剧，经色紫暗，有块，经行不畅，行毕则舒，唇舌瘀紫，苔白较厚，面色㿠白，体倦乏力，腰酸膝软，四末清冷，大便常溏，脉沉紧而细。

证属寒邪客于胞宫，气受寒则滞，血受寒则凝，气滞血瘀，痛经乃作。辗转思维，乌头汤合拍，众知麻黄解毒，II 岳床上将其加入温补药中，宣通络隧，威而不猛，实为搜剔寒邪

之骁将。 制川乌、麻黄、艾茎各6g，黄芪、白芍各15g，炙草100g，蜂蜜90g。冷水浸透，烈火煎开，文火续煎15分钟，取头汁；加开水，文火再煎15分钟，取二汁与头汁混合，分成三份，早、中、晚饭前分饮之。3剂药后经水畅行，色红，无血块，小腹痛愈。(四川中医)

注家按语：经行受寒，寒凝胞脉，气血不通，而致痛经，故用乌头汤温经散寒止痛，从本而治也。

第五节 妇人崩漏下血诸病

【经行血崩及口鼻出血不止】

过××之妻，年三十五岁，湖南籍，住昆明市东庄九十九号，素患经痛不调，经某医诊治，拟方以破气行瘀之法，方中配伍桃仁、红花、三棱、文术、川芎、当归等，并嘱可作常服，冀使经信通调。如是方药已服十年有余，攻破太过，致气血大伤。1961年6月下旬，因打骂小孩动气生怒，忽然经行血崩不止，急往某医院就诊，经治数日，子宫仍出血未止，又复鼻衄频仍及牙龈出血，身发紫斑，病势日重。

7月1日，家属主动抬出医院改请某中医诊治。医者立案为“血不归经之侯”，拟方二帖：内服以酒炒生地50克，酥炒侧柏叶30克，艾叶30克，炒杭芍30克，浙寸冬30克，姜炭30克，藕节二个，生草20克，点童便少许并加发灰为引，嘱服二剂。

外治用附子面100克，酒炒，包足心涌泉穴。殊料服药一次，上、下出血更甚，呻吟不已，气短欲脱，举家惶恐万状。7月2日清晨来舍促余急诊，见患者面色淡黄晦黯无华，唇舌亦淡白，苔白滑，唇、舌、口腔内两颊粘膜均有大小不匀之紫黑血泡，舌心血泡一枚，约拇指头大，鼻及牙龈仍见出血，色黯红不鲜，用物填塞鼻孔，则血块阻于咽喉，渐从口中咳吐而出，亦为紫黑血块及血水。四肢及胸背皮肤起青紫血斑，神情淡漠、声低息短，呻吟不已，但觉心中慌跳，气虚难接。日不思食，夜不能寐，唯少喜热饮一、二日。六脉芤虚，重按若无。缘由攻破太过，气血两亏，气虚无力摄血，阳不守阴，血虚则气无所依，阴不恋阳，以致血不归经，游溢妄行，气随血耗，散漫无羁。如继续流血不止，恐血尽气亡，阴阳俱脱。盖气血两亏失血之证，当以治气为先，气足则血自能止，血止之后，方能言补益之法。当此证候，余主以扶阳收纳，固气止血，方用：

黑天雄150克，炮黑姜30克，黑荆芥6克，上肉桂15克(研末，泡水兑入)，茯神20克，桂尖30克，甘草6克，大枣2被(烧黑存性)

7月3日复诊。服上方后已见效，出血减少。然气血太亏，一时难以尽复，口鼻及下部仍流出淡黑血水，心泛呕逆，仍不思饮食，神志尚弱。由于气血所亏，原患寒湿痹痛旧疾又复发，左手肩臂疼痛。照上方佐以温经散寒之剂治之。

附片200克，炮黑姜10克干姜10克上肉桂15克(研末，泡水兑入)西砂仁10克桂尖20克北细辛6克吴茱萸5克甘草10克

7月4日三诊。脉象较有神根，各部出血减少十之八、九，唇舌转红润，口舌血泡已瘪，昨夜得熟寐。小便转长，喜热饮，稍能进食。惟头部昏重作痛，左肩臂筋肉仍痛，然病势已见大减，渐可转危为安。处方：

附片200克，炮黑姜10克，干姜15克，上肉桂15克(研末，泡水兑入) 桂尖30克，北细辛7克，法夏15克，公丁5克，甘草10克，麻黄根10克

7月6日四诊。上方连进二付，口鼻出血已止，口舌紫黑血泡全退。舌质红润，苔尚薄白，下部仍稍流黑血，极腥臭。此系已离经败坏之血，得阳药温化而下行，非新出之血液也。腑气已通，数日以来始有大便，色黑而干。精神、食量均较佳，脉已和缓较有神，惟左臂仍稍掣痛，延及左侧头项，再以扶阳温化通经散寒治之。

附片200克干姜50克，北细辛10克，桂尖50兑 羌活5克独活6克，苡仁15克，麻黄

5 克，上肉桂 15 克(研末，泡水兑入)甘草 15 克

7 月 8 日五诊。病状大减，头疼止，肩臂痛已大为减轻，遂照原方去麻黄，服二剂后，诸证已愈。再以四逆汤加口芪、当归、白术、苡仁数剂调理而善后。

【胶艾治经行血崩】

杨××，女，四十一岁，住昆明市正义南路教子巷。1953 年秋，适值月经来潮，因抬重物用力过猛，骤然下血如崩。先后经二医诊治，皆云血热妄行，服用清热，凉血、止血之剂，血未能止，迁延十余日，以致卧床不起，延余诊治。

患者面色蜡黄、精神疲倦，气短而懒言，不思饮食，手足不温。经血仍淋漓不断，时而如潮涌出，皆清淡血水兼夹紫黑血块，腰及小腹酸胀坠痛。舌质淡，苔薄白少津，脉沉濇。此乃阳气内虚，冲任不守，气不纳血，血海不固，致成崩漏之证。方用回阳饮加人参扶阳固气。

附片 120 克，吉林红参 9 克，炮黑姜 9 克，上肉桂 9 克(研末，泡水兑入)， 甘草 9 克。

服二剂后，流血减少其半，血色淡红，瘀块减少，呼吸已转平和，四肢回温。饮食稍增，能进藕粉少许。照原方加炒艾 15 克，阿胶 24 克(烊化分次兑服)，炒白术 9 克，侧柏炭 9 克。连服三剂后，流血大减，仅为少量淡红血水，精神饮食增加，面色已转润泽，舌质显红润，苔薄白，脉缓弱，已能起床。阳气回复，气血渐充，欲求巩固，仍须与甘温之剂调补之。以四逆当归补血汤加味气血两补。

附片 90 克，黄芪 60 克，当归 30 克，干姜 15 克，上肉桂 12 克(研末，泡水兑入），炒艾 15 克，阿胶 12 克(烊化，分次兑服），甘草 9 克

连服五剂，流血全止，精神、饮食基本恢复，颜面唇舌已转红润，脉象和缓，已能下床活动。惟气血未足，阳神尚虚，走动稍感头昏、腿软，继服四逆当归补血汤加上肉桂、砂仁，服二十余剂，气血恢复，诸证获愈，恢复健康。

【崩漏的案例】尤阳春：

聂女士 53 岁，因膝关节退行性病，膝关节积液等变收住我科，拟计划行自血分离，注射 PRP 手术。入科时，说自己月经量大，已经有 20 余日，久久不绝。幸亏该患者体格强健，吃喝不受影响，也没有头晕，心慌等失血症状。但入科后，月经出血越来越大，很是担心，久露必崩，况且也不利于计划的手术开展。急急以止血为要务，为后续的治疗，创造条件。

治疗崩漏的方子很多，如何从中筛选那？患者没有少腹的疼痛，脉象也不沉弱，一切看起来很正常，吃喝拉撒就还可以，就是出血量大，而且红。

猛然想起郭永来老先生所著作《杏林集叶》崩漏验方可以使用。之前我有使用的经验，故对之印象颇深。

原文所述：经过临床反复验证，行之有效的方剂，方可称为验方。本文作者通过数十年的临床经验总结出治疗崩漏的基础方，临证可依据患者具体情况加减变化，由简入繁，尤其对于初入临床的青年医师具有一定启发，以免多多益善，终而不知治法之要领。处方：当归、地黄、白芍、乌梅、生地榆、藕节。这是我自己在临床上试验出来的一个方剂，由四物汤去川芎，加藕节、乌梅、地榆组成，治经频，月经过多，崩漏或漏下淋漓不止，产后恶露久久不断。腹痛有瘀可合用失笑散（蒲黄、五灵脂），脉弱体虚可加党参或人参，有条件的地区，药中更可加鲜藕 1~3 两（30~100g），平稳有效，屡用于临床，堪称良方。方中各药可用常量或稍加重，但白芍须重用至 60g 左右，才有理想的效果。地黄用生地还是熟地，则视病情需要而定。

本方看似平常，但我用此方已有 30 多年，有时竟能一剂即愈。治好的患者有多少，我没有统计过，后来也都不记。好，既然原书说的那么肯定，那我就拿来使用，处方如下

当归 30，地黄 30，白芍 60，乌梅 20、，生地榆 20、，党参 20，仙鹤草 30。医院没有藕节，我加了党参和仙鹤草，一方面益气生津，一方面益气收涩止血。

结果：服用过过程中，有很多大血块出现，两幅经量明显减少，四付流血彻底消失。神效！

【老年下血傅青主方医案】张锡纯：

家族婶有下血证，医治十余年，时愈时发，终未除根。一九二六年六月，病又作，请为诊视。治以《傅青主女科》治老妇血崩方，遵师训加生地黄一两，一服即愈。七月，病又反复。治以安冲汤方，以其心中觉凉，加干姜二钱，一剂病又愈。

【安冲汤治少女下血不止医案】张锡纯：

斯年初秋，李姓之女，年十七岁，下血不止，面唇皆白，六脉细数。治以安冲汤，重用山萸肉，三剂而愈。

【资生汤、一味薯蓣饮治闭经】张锡纯：

一室女，月信年余未见，已成劳瘵，卧床不起。治以拙拟资生汤，复俾日用生山药四两，煮汁当茶饮之，一月之后，体渐复初，月信亦通。

【参西录原文】：资生汤方：治劳瘵羸弱已甚，饮食减少，喘促咳嗽，身热脉虚数者。亦治女子血枯不月。

资生汤方：
生山药一两，玄参五钱，于术三钱，生鸡内金二钱（捣碎），牛蒡子三钱（炒，捣），热甚者，加生地黄五六钱。

罗注：玄参，又叫元参；于术，就是产于浙江于潜的白术，地道药材，现在没有选择，只能用白术。鸡内金，现代养鸡天天打针施药，故以农村不打针药鸡所出的鸡内金为上品。牛蒡子，一名鼠粘子，一名恶实。 泻热，解毒。辛平。润肺解热，散结除风，利咽膈，理痰嗽，消斑疹，利二便，行十二经。散诸肿疮疡之毒，利腰膝凝滞之气（性冷而滑利，痘症虚寒泄泻者忌服）。实如葡萄而褐色，酒拌蒸，待有霜，拭去用。根苦寒，竹刀刮净，绞汁，蜜和服，治中风，汗出乃愈。捣和猪脂，贴疮肿及翻花疮（肉翻出如花状）。

劳瘵之证，非止一端。其始也，未有不因气体虚弱，劳伤心肾而得之，又有外感风寒热湿之气，先为疟疾，以致咳嗽，寒邪入里，失于调治，不能保养，过于房劳，伤于饮食，久而成劳瘵之候。其为证也，令人肌肉羸瘦，毛皮干枯，寒热盗汗，遗泄白浊，或腹中有块，或脑后两边有小结核，或聚或散，或咳嗽痰涎，或咳唾脓血。如劳瘵多是血气亏损，多因轻病时，发汗通利，差误所致。妇人多病此。盖于产后闭经而传之耳。

【资生汤加减治处女经闭】张锡纯：

天津陈氏女，年十七岁，经通忽又半载不至。**病因**：项侧生有瘰疬，服药疗治，过于咸寒，致伤脾胃，饮食减少，遂至经闭。

证候：午前微觉寒凉，日加申时，又复潮热，然不甚剧。黎明时或微出汗，咳嗽有痰，夜间略甚，然仍无妨于安眠。饮食消化不良，较寻常减半。心中恒觉发热思食凉物，大便干燥，三四日一行。其脉左部弦而微硬，右部脉亦近弦，而重诊无力，一息搏逾五至。

诊断：此因饮食减少，生血不足以至经闭也。其午前觉凉者，其气分亦有不足，不能乘阳气上升之时而宣布也。至其晚间之觉热，则显为血虚之象。至于心中发热，是因阴虚生内热也。其热上升伤肺易生咳嗽，胃中消化不良易生痰涎，此咳嗽又多痰也。其大便燥结者，因脾胃伤损失传送之力，而血虚阴亏又不能润其肠也。左脉弦而兼硬者，心血虚损不能润肝滋肾也。右脉弦而无力者，肺之津液胃之酸汁皆亏，又兼肺胃之气分皆不足也。拟治以资生通脉汤，复即原方略为加减，俾与证相宜。

处方：资生汤加减，去牛蒡子。

资生汤加减
白术三钱（炒），生怀山药八钱，大甘枸杞六钱，龙眼肉五钱，生怀地黄五钱，玄参四钱，生杭芍四钱，生赭石四钱（轧细）当归四钱，桃仁二钱，红花钱半 甘

草二钱

共煎汤一大盅，温服。

罗按：脉数而虚，虚劳病也，二阳之病发心脾，故治从心脾，此资生汤之义也。此处用资生汤加生血活血之药，很有深意，张氏谓：虚劳之人多血痹，故应加治血痹之药，此或是在资生汤中加桃仁、红花、当归之意吧。谓旧血不去，新血不生。

复诊：将药连服二十余剂（随时略有加减），饮食增多，身形健壮，诸病皆愈。惟月信犹未通，宜再注意通其月信。

处方：生水蛭一两轧（为细末），生怀山药（半斤轧为细末）

每用山药末七钱，凉水调和煮作茶汤，加红蔗糖融化，令其适口，以之送服水蛭末六分，一日再服，当点心用之，久则月信必通。

效果：按方服过旬日，月信果通下，从此经血调和无病。

方解：按水蛭《神农本草经》原无炙用之文，而后世本草谓若不炙即用之，得水即活，殊为荒唐之言。尝试用此药，先用炙者无效，后改用生者，见效甚速。其性并不猛烈，惟稍有刺激性。屡服恐于胃不宜，用山药煮粥送服，此即《金匮》硝石矾石散送以大麦粥之义也。且山药饶有补益之力，又为寻常服食之品，以其粥送水蛭，既可防其开破伤正，且又善于调和胃腑也。

罗按：《伤寒论》抵当丸，水蛭用炙，不知何故。

《医学衷中参西录》固冲汤，治妇女血崩。

固冲汤方：

白术一两（炒），生黄芪六钱，龙骨八钱（捣细），牡蛎八钱（捣细），萸肉八钱（去净核）生杭芍四钱，海螵蛸四钱（捣细），茜草三钱，棕边炭二钱，五倍子五分（轧细药汁送服）

脉象热者加大生地一两；凉者加乌附子二钱；大怒之后，因肝气冲激血崩者，加柴胡二钱。若服两剂不愈，去棕边炭，加真阿胶五钱，另炖同服。服药觉热者宜酌加生地。

张锡纯曰：从前之方，龙骨、牡蛎皆生用，其理已详于理冲丸下。此方独用煅者，因煅之，则收涩之力较大，欲借之以收一时之功也。

【固冲汤治下血两日不止医案】张锡纯：

一妇人，年三十余。陡然下血，两日不止。及愚诊视，已昏愦不语，周身皆凉，其脉微弱而迟。知其气血将脱，而元阳亦脱也。遂急用此汤，去白芍，加野台参八钱、乌附子三钱。一剂血止，周身皆热，精神亦复。仍将白芍加入，再服一剂，以善其后。

【固冲汤治骤得下血证医案】张锡纯：

子生曾治一妇人，年四十许。骤得下血证甚剧，半日之间，即气息奄奄，不省人事。其脉右寸关微见，如水上浮麻，不分至数，左部脉皆不见。急用生黄芪一两，大火煎数沸灌之，六部脉皆出。然微细异常，血仍不止。观其形状，呼气不能外出，又时有欲大便之意，知其为大气下陷也。遂为开固冲汤方，将方中黄芪改用一两。早十一点钟，将药服下，至晚三点钟，即愈如平时（后子生在京，又治一血崩证，先用固冲汤不效，加柴胡二钱，一剂即愈，足见柴胡升提之力，可为治崩要药）。

或问：血崩之证，多有因其人暴怒，肝气郁结，不能上达，而转下冲肾关，致经血随之下注者，故其病俗亦名之曰气冲。兹方中多用涩补之品，独不虑于肝气郁者，有妨碍乎？答曰：此证虽有因暴怒气冲而得者，然当其血大下之后，血脱而气亦随之下脱，则肝气之郁者，转可因之而开。且病急则治其标，此证诚至危急之病也。若其证初得，且不甚剧，又实系肝气下冲者，亦可用升肝理气之药为主，而以收补下元之药辅之也。

【附方】《傅青主女科》，有治老妇血崩方，试之甚效。其方用生黄芪一两，当归一

两（酒洗），桑叶十四片，三七末三钱（药汁送下）水煎服，二剂血止，四剂不再发。若觉热者，用此方宜加生地两许。

又：诸城友人王生，传一治血崩秘方。用青莱菔生捣取汁，加白糖数匙，微火炖温，陆续饮至三大盅，必愈。

又：西药中有麦角，原霉麦上所生之小角，其性最善收摄血管，能治一切失血之证，而对于下血者用之尤效。角之最大者，长近寸许，以一枚和乳糖（无乳糖可代以白蔗糖）研细，可作两次服。愚常用之与止血之药并服，恒有捷效。

附：治女子血崩有两种草药臭科子、龙葵

一种为宿根之草，一根恒生数茎，高不盈尺，叶似地肤，微宽，浓则加倍，其色绿而微带苍色，孟夏开小白花，结实如杜梨，色如其叶，老而微黄，多生于宅畔路旁板硬之地，俗呼为牡牛蛋，又名臭科子，然实未有臭味。初不知其可入药也。戊辰孟夏，愚有事回籍。有南关王氏妇，患血崩，服药不效。有人教用此草连根实锉碎，煮汤饮之，其病顿愈。后愚回津言及此方，门生李生谓："此方余素知之，若加黑豆一小握，用水、酒各半煎汤，则更效矣。"一种为当年种生之草，棵高尺余，叶圆而有尖，色深绿，季夏开小白花，五出，黄蕊，结实大如五味，状若小茄，嫩则绿，熟则红，老则紫黑，中含甜浆可食，俗名野茄子，有山之处呼为山茄子。奉省医者多采此草阴干备用，若遇血崩时，将其梗叶实共切碎煎汤服之立愈。在津曾与友人张生言及此草，张生谓，此即《本草纲目》之龙葵，一名天茄子，一名老鸦睛草者是也。而愚查《本草纲目》龙葵，言治吐血不止，未尝言治血崩。然治吐血之药，恒兼能治下血，若三七、茜草诸药是明征也。以遍地皆有之草，而能治如此重病，洵堪珍哉。

附录：

【固冲汤妊流产下血甚多治案】直隶青县张生来函：

族姊适徐姓，年三十余。有妊流产，已旬日矣。忽然下血甚多，头晕腹胀，脉小无力。知为冲脉滑脱之征证，予以固冲汤，加柴胡钱半，归身二钱。服药三剂即止。俾继服坤顺至宝丹以善其后。

【固冲汤行经过期不止治案】直隶盐山李生来函：

天津赵生妻，年四十余岁，行经过期不止，诸治不效，延弟诊视。见两部之脉皆微细无力，为开固冲汤原方予之，服数剂即全收功。因思如此年岁，血分又如此受伤，谅从此断生育矣。不意年余又产一子，安然无恙。盖因固冲汤止血兼有补血之功也。

【固冲汤小产后血不止者治案】

又：天津张生妻，年二十四岁，因小产后血不止者绵延月余，屡经医治无效。诊其脉象，微细而数，为开固冲汤方，因其脉数，加生地一两。服药后，病虽见轻，而不见大功。反复思索，莫得其故。细询其药价过贱，忽忆人言此地药局所鬻黄芪，有真有假，今此方无显著之功效，或其黄芪过劣也。改用口黄芪，连服两剂全愈。

由斯知药物必须地道真正方效也。

【小柴胡汤合当归芍药散加生地艾叶治崩漏不止】胡希恕：

赵某，女，22 岁，学生。 初诊日期 1966 年 4 月 5 日：2 年来月经淋漓不断。16 岁即来月经，前三个月不规律，但半年后大致正常。缘于年前撤暖气时，过于劳累而感冒，适月经正行，没想到感冒愈后，月经淋漓至今未止。曾到妇科多次检查，未查清病因，服用止血药毫无收效。又找中医治疗，服汤剂、丸剂等，症有增无减。托亲友介绍找胡老诊治。近来症状：月经淋漓不断，色淡红，有时见小血块，时有腹隐隐作痛，常乏力、头晕、或头痛，口干，纳差，或心烦，手足心热，舌苔薄白，舌质淡红，脉沉细。胡老与小柴胡汤合当归芍药散加生地艾叶：

柴胡四钱，党参三钱，黄芩三钱，半夏四钱，生姜三钱，大枣四枚，当归三钱，川芎二钱，炙甘草二钱，茯苓三钱，苍术三钱，泽泻三钱，生地五钱，艾叶三钱。

结果：上药服 10 剂血止，嘱继服原方巩固疗效。三月后其同学告之月经正常。

按：本例辨证用方实耐人寻味。一般而论，长期月经淋漓不断，当首先考虑血虚、血瘀，脾不统血、肝不藏血、肾不摄血、气衰血脱等，本例何以用小柴胡汤？复习一下胡老对小柴胡汤的论述可冀拨云见日。《伤寒论》第 101 条曰："伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。"胡老在注解此条时写道："外感初传少阳，柴胡证往往四证不备，医者不知用小柴胡汤，因使风寒小病久久不愈，此例甚多，宜注意。"又《金匮要略·妇人产后病》"附方（一、《千金》三物黄芩汤治妇人草褥自发露得风，四肢苦烦热，头痛者，与小柴胡汤；头不痛但烦者，此汤主之。"对此胡老注解谓：产后中风，由于失治便病久不解，因致烦热，若兼见头痛者，与小柴胡汤即解。可见胡老对小柴胡汤的方证深深理解，一看本例症状就能判定为小柴胡汤合当归芍药散方证，故服之很快起沉疴。由此也可体会到，胡老所提出的'辨方证是六经八纲辨证的继续,亦即辨证的尖端'的观点是一生医学实践总结,是科学的论断。

【黄芪桂枝五物汤治春产后两个月阴道出血淋漓不断月经不调医案】：王金洲

李某，24，农民，1983 年 10 月 5 日就诊。患者平素体质较弱，1981 年早春产后两个月阴道出血淋漓不断，后经中药治疗而愈。半年前小儿断乳后月经来潮，但一直后错。或四五十天而至，或两个月方来。量少，质清，伴少腹凉而隐痛，腰酸痛，畏寒，舌淡，有齿痕，苔薄白，脉沉迟无力。自服当归片、七制香附丸不见好转，本次月经已过四十天仍未来潮。方拟黄芪桂枝五物汤方：黄芪 30 克，桂枝 15 克，白芍 12 克，生姜 4 片，大枣 6 枚。3 剂。

药服完后，怯寒大减，少腹发温发胀，此乃阳已温通，月经将至之象。遵上方加当归 15 克，熟地 15 克，3 剂。服至 2 剂后，月经来潮，但仍量少，色淡。照上方续服 5 剂，怕冷、腰痛、腹痛等症消失，停药观察。月经于 11 月 13 日来潮，经色，经量基本正常。此后月经周期一直为 28～32 天，未再出现后期现象。(河南中医 1987；(5>：43)

【用大剂真武汤治漏下医案】易庆棠：

内兄梁瑞阶，世医儿科巨擎也，妻马氏患漏下，日投芎归，俱未获效。痰喘咳逆，手足面目微肿，畏寒作呕，无胃，四肢沉重，不能自支，脉细滑。予曰："此阳虚水寒用事，阳虚阴必走，故漏下"。用大剂真武汤，照古法加羌辛味，以温寒镇水止咳，再加吴萸以治呕，石脂祈艾以固血，一日二服，再用白术二两生姜一两浓煎代茶，十余日全愈。

或曰："病在漏下，有形之血当用有形之药以补之，地黄芎归胶芍在所必需，何以先生舍而不用?"予曰："人身一小天地，天统地，阳包阴，此症气不统血，即阳不包阴之义也，且又见恶寒咳喘呕肿，诣阴症，再用滋阴之药，阴云四布，水势滔天而死。惟温其阳气塞其漏，俾阳气充足，得以磨化水谷，中焦取汁奉心化赤成血，此即补火致水之义，道理最精，今人不讲久矣。"

真武汤方：

茯苓三两，芍药三两，白术二两，生姜三两（切），附子一枚（炮去皮破八片）

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。若咳者，加五味子半升，细辛干姜各一两；若小便不利者，加茯苓一两；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，去附子，加生姜足前成半斤。

【张锡纯升陷汤证宗气下陷治子宫出血半年医案】娄绍昆

娄问其父，学西医还是中医好？其父亲说，学中医学西医都好,问题是中医可以自学，西医无法自学;中医可以在没有条件没有医疗设备的环境里诊治疾病，然而西医不能。我的一个高中同学，是一位西医大夫，在上海一个大医院工作，老家在永强下洋街。春节回家探亲时，乡亲们一看上海的大医师来了，都来找他看病。这可把他难坏了，因为西医大夫离开了医院，离开了检测仪器，就没法给病人诊断、开药。看到乡亲们满怀希望而来，失望而去，这位大夫的心里很不是滋味，沮丧之情毫不掩饰地溢于言表。

其中一个二十多岁的妇女，是我们同班同学的女儿，她子宫出血半年，各个大医院都

认为要子宫切除才能治愈。她从老远老远的地方慕名而来，最后还得失望而归。后来还是我把她介绍到二都的王云五医师那里诊治，云五医师给她开了三帖中药，病了半年的子宫出血就止住了。我的高中同学，那位上海的西医大夫亲眼目睹了整个治疗过程，因而对中医很是羡慕，甚至决心要学中医。他说，应该承认，中医可以越过西医学中的病因、病理、病位的这些层面，直接进入更深的层次。一个中医走到哪儿，哪儿就是一个医院。他的意思是说，中医可以整体性地把握疾病，所以中医走到哪儿都能给人看病，而西医只有在医院里才能给人看病。

向云五医师他说这个病症是张锡纯的升陷汤证，也就是宗气下陷，给她的三帖中药都是重用生黄芪一两。他说这样的病症经常遇见，中医中药疗效很好，许多妇女免除了手术之苦。

【桂枝汤加龙骨牡蛎治产后暴崩医案】连建伟：

冯某某，女，28 岁，1971 年 10 月 20 日诊。患者系初产妇，产后恶露已净，少腹不痛。突然于产后第 26 天晚上暴崩不止，急送某医院。经西医用止血剂治疗并输血 400 毫升，病情有所好转，但漏下仍未止。又服当归炭、炒白芍、生地炭、丹参炭等养血止血之剂，反增心悸怔忡，饮食减少等证。改邀笔者诊治。患者脉来细弱，舌质淡白少华。辨证论治：产后暴崩，无腹痛，为气虚不能摄血之证。气为血之帅，气虚则血不循经而妄行。此证本应益气摄血，反投养血止血，滋腻之性，损伤阳气，心阳受损则心悸怔忡，脾阳不振则纳食少进。脉来细弱，舌质淡白少华，均为气血大虚之象。治拟益气养营，引血归脾。处方：桂枝 4．5 克，炒白芍 9 克，炙甘草 4．5 克，生姜 3 片，大枣 5 枚，龙骨 15 克，牡蛎 24 克，党参 12 克，炙黄芪 12 克，炒白术 9 克，广皮 6 克，黑归脾丸 12 克(吞)。3 剂。

10 月 23 日复诊：漏下渐止，纳食渐增，怔忡亦有好转，再服原方 3 剂，诸症悉愈。(《金匮方百家医案评述》1991：75)

【当归芍药散合柏叶汤加阿胶汤治月经淋漓不尽】冯世纶

高某，女性，41 岁，就诊时间是 2018 年 7 月 31 日，主诉是月经淋漓不尽 2 个月。

起因是 2017 年 9 月份，因一次头部外伤后出现月经两个月未来，12 月份来了至 2018 年 1 月份不走，曾服中药和西药不效，遂去当地人民医院就诊，医以刮宫诊查治疗，刮诊未见异常。刮宫后四个月未来月经，至 5 月份来了一次月经，量少色正常，月经干净后，到 6 月份来月经时经量稍增多点，至就诊时一直淋漓不净。半月前我曾给与芎归胶艾汤 5 付中药治疗，我的处方是:生地炭 15 白芍 20 川芎 10 当归 15 艾叶 10 阿胶 10 生地 15，五剂，日一剂煎二次分服。服用后月经不减反增，我让其停药观察几天一直未见好转，遂过来让冯老师诊治。

刻下症状：无头疼头晕，无恶寒恶风，出汗正常，口中和，无胸闷气短，无心悸，纳可，睡眠可，大便日二次偏稀，小便正常，无起夜，无四逆，精神无明显乏力。苔白脉沉细。

冯老辨证为“太阴里虚寒，血虚血瘀”。处方是当归 10 白芍 10 川芎 6 茯苓 12 泽泻 10 苍术 10 炮姜 6 艾叶 10 侧柏炭 10 阿胶 10 黄酒 20ml，7 剂水煎日一次分二次服用。

张学国 （冯氏之徒）按：冯老师的处方“当归芍药散合柏叶汤加阿胶”。描述柏叶汤的条文整部书里就这一条，一共十个字。让我们跟据字意去理解就是用于吐血的止血方剂，因药味看着平淡，解释的条文字句又少，所以临床我们很少应用。老师给我们讲解我们为什么选用这个方呢？冯老讲:其患者阳性证不明显，月经淋漓日久，大便日二次便稀，体型偏胖，所以辨六经是太阴兼血虚血瘀，为里虚寒。选方呢因没有热像就用“当归芍药散合柏叶汤”。假如病人稍有点热像时我们就可以用胶艾四物汤了，因胶艾四物汤里有生地，清热力量大所以偏寒，是治疗有阳明热的。此患者不太适合，临床上要特别注意，特别是虚寒性的病人。

冯老师讲当年他跟胡老学习时曾遇到一病人是一 16 岁的小女孩，在一口腔医院住院，我们去会诊，得的兔唇，需做手术，因有“先天性肝糖原累积症”，做手术后伤口一直渗血不止，那里的中医都用时方十灰散什么的，都止不住，每天输血，刚开始输血顶一天，后来输

血不起做用了，胡老看后开了胶艾四物汤，当时胡老不敢用生地怕凉，就用了点生地炭，第二天就不出血了，胡老用生地时很谨慎。临床如遇到急性出血病人有时因有热，用胶艾四物汤的机会多，如慢性一般就没热了，就要把生地去掉，也必须跟据临床症状而行六经八纲的判断。如临床遇到里虚寒重的有胃不好了，就需加点党参、苍术，理中健胃保护胃气。

此方和温经汤比较呢温经汤属于其证上热下寒，治亦清上温下，属厥阴病了。柏叶汤里有干姜适用于里虚寒的，临床根据情况虚寒重的用炮姜，柏叶呢用柏叶炭，这样整个方都偏温了，可以加点黄酒效果很好。马通汁有时很难找，也很难喝，临床上可以用黄土代替，也可用阿胶代替。

病人的用药反应和过程，其诉：回去后因天晚第二天开始服的药。8 月 1 日服药当天无什么变化，8 月 2 日、3 日上午月经量和以前一样多，下午和晚上量明显减少，4 日上午 10 点前量和以前一样，10 点后月经没有了，至 5 日和 6 日一直没有，服了五天的药，8 月 7 日晚上零晨 1 点时因坐火车来北京复诊，少见一点粉色的，后一直没有。停药后大便正常日一行，不稀也不干。精神也好。效果非常好！冯老说:“可以停药了，不用再服了，无症状服药也不好”。

【血府逐瘀汤治经来淋漓不尽】

赵某，女，34 岁，桥东副食厂工人。主诉：经来淋漓 10 余天才净，二三年经量渐多且伴有全身不适，如乳房发胀，腹痛，经来有块，色黑紫，平日潮热。烦躁，曾用归脾汤、柴胡疏肝饮、逍遥散等交替治疗，均无效。因血海本有蓄热，归脾太早，则滞而不化。

查体：患者脉紧而弦，舌红紫，苔薄。治疗：非王氏妙法不可奏效，故选用血府逐瘀汤，加生地黄、柴胡连服十余剂而愈。

【血府逐瘀汤治经来淋漓不尽】齐建民：

赵某，女，34 岁，桥东副食厂工人。主诉：经来淋漓 10 余天才净，二三年经量渐多且伴有全身不适，如乳房发胀，腹痛，经来有块，色黑紫，平日潮热。烦躁，曾用归脾汤、柴胡疏肝饮、逍遥散等交替治疗，均无效。因血海本有蓄热，归脾太早，则滞而不化。

查体：患者脉紧而弦，舌红紫，苔薄。治疗：非王氏妙法不可奏效，故选用血府逐瘀汤，加生地黄、柴胡连服十余剂而愈。

【血府逐瘀汤治疗崩漏症案】：

刘某，43 岁，1996 年 5 月 10 日来诊。自 1996 年 3 月 20 日月经来潮，初时经色、质、量正常。持续 1 周不净。第 8d 突然血量增多，并夹有血块。在当地医院被诊断为“月经不调”，投以人参归脾丸、安络血片等口服十余日不见效。又服乌鸡白凤丸等数十日，仍淋漓不断。并伴有小腹刺痛、乏力、心烦口渴、手足心热。来诊时已经流血 1 个多月。患者一般状态较差，面色、唇色白光白无华，形体消瘦，语音低微，舌质紫暗有瘀点，脉细涩无力。追问发病史，患者于月经来潮前 1 周曾与家人争执，心中郁闷不舒。证属肝气郁结，气滞而至血瘀，瘀阻胞络血不得归经，选用行气化瘀调经法，投血府逐瘀汤加减。

处方：当归 15g，生地 20g，桃仁 5g，红花 7.5g，枳壳 15g，赤芍 10g，柴胡 15g，川芎 5g，牛膝 10g，牡丹皮 10g，蒲黄炭 15g，知母 15g。4 剂。服第 1 剂时血量增多，并流下黑色血块。家人惶恐来院询问。嘱其继续服药。第 4 剂服完后经血已停。

5 月 6 日二诊：停血 3d，精神状态较前明显好转，面现红润，语音洪亮。舌仍有瘀点，脉涩。依前方去蒲黄炭加白术 15g，焦三仙各 15g 以调理脾胃，扶正驱邪。再服 5 剂。半年后随访患者月经已恢复正常。

按：本案系情志不畅，肝气郁结为病。因“气行则血行，气滞则血凝”，气滞则血运不畅，瘀血停滞，新血不得归经而导致崩中漏下。因失血日久伤阴，而出现口渴心烦、手足心热。用血府逐瘀汤理气化瘀调经，此乃“通因通用”之法，故取药到病除之效。

【真武汤治阴道出血两月余医案】韩桂茹：

于某，43 岁，初诊 1981 年 12 月 29 日。阴道出血两月余，量多，曾于外院经用多种止血剂均无效。行诊刮宂，病理报告："增生期宫内膜，有轻度增殖。"诊为"功能性子宫出血''。现症：阴道出血量多，呈黑褐色，未见血块，颜面四肢肿胀，小腹冷痛，小便不利，大便溏薄，面色咣白，唇淡无华，舌淡胖有齿痕，苔白'脉沉细无力。治以温肾助阳，益火制阴法，真武汤治之。方药：

炮附子、白朮各 10 克，生姜 6 克，白芍、云苓各 10 克。

服 6 剂，血止，阳气渐复，阴霾逐散，尿量遂增，颜面肢肿消，四肢转温，腹部冷痛好转，后以右归丸加减调治，于 1982 年 1 月 22 日、2 月 26 日月经应期而至，其量适中，追访半年，月经正常。

【少腹逐瘀汤加味治经行点滴迁延时医案案例】

经行点滴迁延时日，三年至今（八年前作过子宫浆膜瘤切除）。以祛瘀法为治。当归 9 克、五灵脂 6 克、白芍 12 克、肉桂 2.4 克、女贞子 6 克、小茴香 1.2 克、炒黑蒲黄 6 克五剂。复诊：5 月 3 日。药后经行量较多，色泽略转正。续以祛瘀为治。五灵脂 6 克、当归 9 克、白芍 12 克、炒蒲黄 6 克、炮姜 1.5 克、肉桂 3 克、女贞子 9 克、小茴香 1.2 克、延胡索 6 克、旱莲草 9 克、川芎 4.5 克、没药 3 克五剂。

三诊：5 月 11 日。进少腹逐瘀法后，以益奇经法为续。

小茴香 1.2 克、当归 6 克、沙苑蒺藜 9 克、党参 12 克、鹿角霜 4.5 克、肉苁蓉 6 克、枸杞子 12 克、紫石英 12 克、补骨脂 15 克、川断 6 克、山萸肉 9 克、炒阿胶珠 12 克五剂。

四诊：6 月 26 日。本月经行量极少，已净，初有腹痛。以定经益血为法。菟丝子 9 克、炒荆芥 4.5 克、白芍 9 克、鸡血藤 6 克、茯苓 9 克、白术 9 克、附子 9 克、党参 12 克、山药 15 克、甘草 4.5 克五剂。

【少腹逐瘀汤加味治经行点滴迁延时医案案例】

正定县城关公社东关大队人。结婚三年多不孕。近一年来，月事不调，前后无定期，经色紫暗，有块，少腹经常隐痛，经前尤甚。白带较多。经县医院检查，诊断为宫体小，后位。给予乙稀雌酚、黄体酮等药治疗未效。于 1977 年 7 月 3 日由大队保健站介绍就诊。

患者面色无华，两胁胀痛，经前乳房憋胀，少腹畏寒喜暖，两侧有肿块，压之有疼痛及憋胀感。经前白带较多。口唇微紫，舌质稍淡，有瘀斑，苔薄白，脉沉弦。据脉症合参，属气滞血瘀，冲任不调。拟以舒肝理气，活血化瘀之剂，以调冲、任。宗王清任少腹逐瘀汤加减治之。

方药：小茴香 4.5 克、元胡 9 克、没药 9 克、当归 12 克、木香 6 克、官桂 6 克、赤芍 9 克、蒲黄 12 克、五灵脂 9 克、附子 9 克、丹参 9 克、炮姜 3 克水煎服。于经前连服三剂。

二诊（7 月 9 日）：自云上药连服三剂后，乳房憋胀大减，行经。腹痛明显好转，初时仍有血块，后三日经色转正常。少腹肿块压痛感减小，白带量减少。自觉胸腹舒适。脉象和缓。以原方去没药，加紫石英 18 克，川芎 6 克，淫羊藿 12 克。嘱下次经期前再进三剂，以观后效。患者遵嘱，连服三剂后，不久即怀孕，足月生一男婴（后因病而死）后又痛经复作，时过年余不孕。嘱仍按前方再服二剂，痛经愈，现已怀孕 3 月余。体质较健。

此治邪客少腹、足厥阴肝经脉络瘀滞法也。方以四物、失效两方出入，养血活血，破瘀通滞，去地黄之甘寒柔润，尤恐壅滞气机；官桂、茴香之用，一补名门而暖丹田，一暖肝脏而祛阴寒；干姜辛热，温气血而散沉寒。寒邪得辛热而驱散，脉络因散瘀而濬和，气血得以畅行，何病之有哉。

【血崩证医案】张锡纯：

天津徐姓妇，年十八岁，得血崩证。病因：家庭不和，激动肝火，因致下血不止。

证候：初时下血甚多，屡经医治，月余血虽见少，而终不能止。脉象濡弱，而搏近五至。

呼吸短气，自觉当呼气外出之时，稍须努力，不能顺呼吸之自然。过午潮热，然不甚剧。

诊断：此胸中大气下陷，其阴分兼亏损也。为其大气下陷，所以呼气努力，下血不止，为其阴分亏损，所以过午潮热。宜补其大气，滋其真阴，而兼用升举固涩之品方能治愈。

处方：生箭芪（一两） 白术（五钱炒） 大生地（一两） 龙骨（一两 捣）牡蛎（一两 捣）天花粉（六钱） 苦参（四钱） 黄柏（四钱）柴胡（三钱） 海螵蛸（三钱去甲） 茜草（二钱）西药麦角中者一个，搀乳糖五分，共研细，将中药煎汤两大盅，分两次服，麦角末亦分两次送服。

效果：煎服一剂，其血顿止，分毫皆无，短气与潮热皆愈。再为开调补气血之剂，俾服数剂以善其后。

【四逆汤治反复发作鼻出血淋漓月经淋漓不断医案】李洪善：

张某某，女，45 岁。反复发作鼻出血淋漓不止已半年有余，血色淡红、质稀；遇冷出血次数增加。近来血中间有牛奶样分泌物，且伴有懒言少语，倦怠乏力，遂来就诊。初诊：鼻出血约 50 毫升，色淡质稀。面色㿠白，气短声低，形寒肢冷，精神萎靡不振，咳嗽吐痰带血丝。近二月来，月经淋漓不断，色淡红质清稀，舌质淡、苔薄白、脉沉微细。观其脉证相合，纯属一派阳虚之象，治宜温阳摄血，予四逆汤治之：

炮附子、炮姜各 9 克，炙甘草 6 克，2 剂，水煎服。

二诊：服上药后，诸证均减，效不更方，守上方 2 剂。三诊：诸症已愈，惟觉口苦咽干，舌面偶生小疮。改投导赤散加炮附子 12 克 2 剂。后经随访，未见复发。

【黄连阿胶汤治月经淋漓不止医案】刘渡舟：

唐某某，女，30 岁。月经淋漓不止已半年许，妇科检查未见异常，Hb7．2g％。伴心烦不得卧，惊惕不安，自汗沾衣。索其前方，多是参、芪温补与涩血固经之药，患者言服药效果不佳，切其脉萦萦如丝，数而薄疾(一息六至有余)，视其舌光红无苔，舌尖红艳如杨梅。细绎其证，脉细为阴虚，数为火旺，此乃水火不济，心肾不交，阴阳悖逆之过。治应泻南补北，清火育阴，安谧冲任为法。

黄连 10 克，阿胶 12 克，黄芩 5 克，白芍 12 克，鸡子黄两枚(自加)。

此方服至 5 剂，夜间心不烦乱，能安然入睡，惊惕不发。再进 5 剂，则漏血已止。Hb 上升至 12g％。

【黄连阿胶汤治阴道流血医案】权依经：

贺某，女，34 岁，1968 年 4 月 6 日初诊。于 1965 年因高烧住院，治疗半月后体温降至正常，但双目失明，经眼科会诊，眼底正常。继而发生阴道流血不止，呼吸摇肩，手足冰凉，神志不清，心中痛热，脉若有若无，危在旦夕。后经各方治疗，诸症有所好转，惟双目失明一证尚在，特来求治。经询问与检查，其症如上，脉细无力。先辨为肝血不濡，但用补肝血之药效果不佳。患者表现为双目失明而烦躁，改投黄连阿胶汤方：

黄连 12 克，黄芩 3 克，白芍 6 克，阿胶 9 克，鸡子黄 1 枚。水煎前三味，去滓后烊化阿胶，稍凉后入鸡子黄，搅匀服，1 剂。

二诊：服上药后，患者当晚疼痛难忍，直到夜半才入睡，于次晨即能看见大的物体，不再烦躁。改用六味地黄汤加生牡蛎(生地 24 克，山药、山萸肉各 12 克，丹皮、泽泻、茯苓各 9 克、生牡蛎 12 克)，3 剂而愈。

【当归四逆加吴茱萸生姜汤治经来量多色黑成块腹痛坠胀难支】朱可贞：

李女，月事后期，经来量多，色黑成块，腹痛坠胀难支，久治不愈，面黄唇白，手足厥冷，腰膝无力，食少懒言，舌苔白腻而质色淡红，脉沉而迟。用当归四逆加吴茱萸生姜汤，连服五剂，经来紫黑无块，腹痛二日自止，食增神旺，守原方加茴香，再进五剂，而病痊愈。（《函讯》）

【小柴胡汤合当归芍药散加生地艾叶汤治月经淋漓至今未止医案】胡希恕：

赵某，女，22 岁，学生。初诊 1966 年 4 月 5 日：2 年来月经淋漓不断。16 岁即来月经，前三个月不规律，但半年后大致正常。缘于年前撤暖气时，过于劳累而感冒，适月经正行，没想到感冒愈后，月经淋漓至今未止。曾到妇科多次检查，未查清病因，服用止血药毫无收效。又找中医治疗，服汤剂、丸剂等，症有增无减。托亲友介绍找胡老诊治。

近来症状：月经淋漓不断，色淡红，有时见小血块，时有腹隐隐作痛，常乏力、头晕、或头痛，口干，纳差，或心烦，手足心热，舌苔薄白，舌质淡红，脉沉细。胡老与小柴胡汤合当归芍药散加生地艾叶：

柴胡四钱，党参三钱，黄芩三钱，半夏四钱，生姜三钱，大枣四枚，当归三钱，川芎二钱，炙甘草二钱，茯苓三钱，苍术三钱，泽泻三钱，生地五钱，艾叶三钱。

上药服 10 剂血止，嘱继服原方巩固疗效。三月后其同学告之月经正常。

【吴茱萸汤治月经前轻度头痛头痛频发】

30 岁妇女，身材矮小，不胖不瘦。主诉数年前起，最初每隔 1 月 1 次剧烈头痛，近来 1 月剧烈发作 3 次。头痛虽多在睡眠不足、眼睛困乏时发生，但有时无故发作。发作则肩至颈酸痛。头痛在左右太阳穴中心，也有耳鸣。头痛剧烈时呕吐。诊得胸胁苦满，右侧显著。虽见小柴胡汤证，但给予吴茱萸汤。服药之后，两个月内只发作 1 次。主诉月经前轻度头痛，虽已停药，未再头痛。《临床应用汉方处方解说》

【黄土汤早期流产出血不止医案】赵锡武：

赵某某，女，婚后初孕，患早期流产出血不止，索方求治。书加味黄土汤予以数剂而愈，后生一女。二孕又显流产先兆，又服前方数剂得保无恙，两女均甚健。处方：熟地黄 60 克，元肉 30 克，当归 12 克，黄芪 18 克，白术 9 克，附子 9 克，甘草 9 克，黄芩 9 克，鹿角胶 30 克，伏龙肝 12 克。以上十味，以水十二杯，先煮伏龙肝取八杯去渣，再煎前八味二杯去渣入鹿角胶，再上火候胶化尽，分二次服。（《赵锡武医疗经验》）

【黄土汤月经量多医案】丁小燕：

赵某某，44 岁，1983 年 11 月 7 日初诊。患者一年来月经量多，经潮 10～12 / 15～20，末次月经 10 月 14 日。此次月经 10 月 30 日来潮，量甚多，昨夜下血 200 余毫升，色淡红，质稀，有小血块，面苍白，头眩心悸，手足冷，少腹坠痛，自觉寒凉，喜暖喜按，舌质淡苔薄白，脉沉细无力。查血色素 7 克。证属脾肾阳虚，气不摄血。治以温补脾肾，养血止血。处方：伏龙肝 30 克，黄芩 6 克，生地 15 克，白术 25 克，附子 10 克，阿胶珠 15 克，炙草 10 克。

服药 2 剂后经量大减，继服原方 3 剂，经水已净，手足温，小腹下坠冷痛大减。查血色素 9．5 克。后每于经前服此方，追访四个月，未见复发。（北京中医杂志 1985；（1>：56）

【黄土汤加味治疗崩漏 36 例】孔文清：

孙氏以本方（灶心黄土用赤石脂代）加味治疗崩漏 36 例。水煎，每日 1 剂。一般在行经期 4~6 剂，3 个月经周期为 1 个疗程。非行经期可根据病情配合服用中成药以巩固疗效。效果：显效 21 例，有效 13 例，总有效率为 94.4%。[江苏中医]

【桂枝茯苓丸合下瘀血汤下血晦暗滴沥不断医案】张法运：

周某某，女，35 岁，农民，1978 年 7 月 5 日就诊。经停三月余，食少纳差，体倦泛呕，自以为受孕。半月前忽见阴道下血，腹中坠痛，前医按胎动下血论治，迭进益气安胎，养血止血之剂十余付，罔效，前来就诊。证见：少腹胀满，拒按刺痛，下坠，夜间脐周时有跳动，下血晦暗，滴沥不断，腰酸乏力，精神不振，舌淡紫暗，脉沉而涩。据脉参证，此乃瘕积为患，非胎也。病家不以为然。余曰：是胎何能三月始动，下血半月何胎能存，数进止血安胎之剂因何不效?病家默然，即以桂枝茯苓丸合下瘀血汤之复方祛瘀消瘕，推陈致新。

处方：桂枝、茯苓、丹皮、赤芍、桃仁各 15 克，大黄、䗪虫、甘草各 12 克，2 剂，水

煎服。

药进 1 剂，阴道下血量多，进 2 剂腹中坠痛，难以忍受，下扁圆形紫暗血块，形似烂肉，外附弹子大白色水泡，连接一起，尤如一串串葡萄覆盖其上，腹痛顿减。病家请余视之，乃西医所谓葡萄胎也，斯属祖国医学瘕积范畴。药既中的，逐邪务净，嘱守原方追服 1 剂。药后又下此物一块，前后约重 1．5 公斤，兼杂墨紫色血水甚多，腹痛消失，下血逐渐停止。病人现面色觥白，汗出乏力，如同产后，乃失血过多，气血亏虚之故。继以当归补血汤加人参益气养血，调理一旬而愈，一年后怀孕，生一男婴，母子健康，随访至今，身体健壮。(河南中医 1989<5>20~21)

【回阳饮加人参经行血崩】

杨××，女，四十一岁，住昆明市正义南路教子巷。1953 年秋，适值月经来潮，因抬重物用力过猛，骤然下血如崩。先后经二医诊治，皆云血热妄行，服用清热，凉血、止血之剂，血未能止，迁延十余日，以致卧床不起，延余诊治。

患者面色蜡黄、精神疲倦，气短而懒言，不思饮食，手足不温。经血仍淋漓不断，时而如潮涌出，皆清淡血水兼夹紫黑血块，腰及小腹酸胀坠痛。舌质淡，苔薄白少津，脉沉濇。

此乃阳气内虚，冲任不守，气不纳血，血海不固，致成崩漏之证。方用回阳饮加人参扶阳固气。

附片 120 克吉林红参 9 克炮黑姜 9 克上肉桂 9 克(研末，泡水兑入) 甘草 9 克

服二剂后，流血减少其半，血色淡红，瘀块减少，呼吸已转平和，四肢回温。饮食稍增，能进藕粉少许。照原方加炒艾 15 克，阿胶 24 克(烊化分次兑服)，炒白术 9 克，侧柏炭 9 克。连服三剂后，流血大减，仅为少量淡红血水，精神饮食增加，面色已转润泽，舌质显红润，苔薄白，脉缓弱，已能起床。阳气回复，气血渐充，欲求巩固，仍须与甘温之剂调补之。以四逆当归补血汤加味气血两补。

附片 90 克口芪 60 克当归 30 克干姜 15 克上肉桂 12 克(研末，泡水兑入) 炒艾 15 克，阿胶 12 克(烊化，分次兑服) 甘草 9 克

连服五剂，流血全止，精神、饮食基本恢复，颜面唇舌已转红润，脉象和缓，已能下床活动。惟气血未足，阳神尚虚，走动稍感头昏、腿软，继服四逆当归补血汤加上肉桂、砂仁，服二十余剂，气血恢复，诸证获愈，恢复健康。

【张锡纯的升陷汤证宗气下陷治子宫出血半年医案】娄绍昆：

娄问其父，学西医还是中医好？

其父亲说，学中医学西医都好，问题是中医可以自学，西医无法自学；中医可以在没有条件没有医疗设备的环境里诊治疾病，然而西医不能。我的一个高中同学，是一位西医大夫，在上海一个大医院工作，老家在永强下洋街。春节回家探亲时，乡亲们一看上海的大医师来了，都来找他看病。这可把他难坏了，因为西医大夫离开了医院，离开了检测仪器，就没法给病人诊断、开药。看到乡亲们满怀希望而来，失望而去，这位大夫的心里很不是滋味，沮丧之情毫不掩饰地溢于言表。

其中一个二十多岁的妇女，是我们同班同学的女儿，她子宫出血半年，各个大医院都认为要子宫切除才能治愈。她从老远老远的地方慕名而来，最后还得失望而归。后来还是我把她介绍到二都的王云五医师那里诊治，云五医师给她开了三帖中药，病了半年的子宫出血就止住了。我的高中同学，那位上海的西医大夫亲眼目睹了整个治疗过程，因而对中医很是羡慕，甚至决心要学中医。他说，应该承认，中医可以越过西医学中的病因、病理、病位的这些层面，直接进人更深的层次。一个中医走到哪儿，哪儿就是一个医院。他的意思是说，中医可以整体性地把握疾病，所以中医走到哪儿都能给人看病，而西医只有在医院里才能给人看病。

向云五医师他说这个病症是张锡纯的升陷汤证，也就是宗气下陷，给她的三帖中药都是

重用生黄芪一两。他说这样的病症经常遇见，中医中药疗效很好，许多妇女免除了手术之苦。

升陷汤方：（张锡纯）

生箭芪（六钱）知母（三钱）柴胡（一钱五分）桔梗（一钱五分）升麻（一钱）

气分虚极下陷者，酌加人参数钱，或再加山萸肉（去净核）数钱，以收敛气分之耗散，使升者不至复陷更佳。若大气下陷过甚，至少腹下坠，或更作疼者，宜将升麻改用钱半，或倍作二钱。

张锡纯曰：升陷汤，以黄芪为主者，因黄芪既善补气，又善升气。惟其性稍热，故以知母之凉润者济之。柴胡为少阳之药，能引大气之陷者自左上升。升麻为阳明之药，能引大气之陷者自右上升。桔梗为药中之舟楫，能载诸药之力上达胸中，故用之为向导也。至其气分虚极者，酌加人参，所以培气之本也。或更加萸肉，所以防气之涣也。至若少腹下坠或更作疼，其人之大气直陷至九渊，必需升麻之大力者，以升提之，故又加升麻五分或倍作二钱也。方中之用意如此，至随时活泼加减，尤在临证者之善变通耳。

【黄连阿胶汤治月经来潮时下腹部疼痛剧烈】

周晓晓，女，30 岁。初诊日期:1973 年 1 月 23 日(一青年妇女步入诊室，观其身体较消瘦，体态自如，精神尚可，面色苍白，颧红唇红。)

医师:哪里不舒服?病人:月经来潮时下腹部疼痛剧烈。医师:几年了?现在情况怎么样?

病人:三年了，生第一胎之后就开始疼痛。近年月经量逐年增多，痛经也加重，每月来潮都痛，疼痛程度也加剧。严重时甚至要卧床一天。这次月经将汛，下腹部已有不适。西医诊断为贫血、子宫内膜异位症、盘腔积液。

思路:月经期下腹部激烈疼痛的病人，常见的有桃仁承气汤证、当归建中汤证、当归四逆汤证、温经汤证等；月经量过多造成贫血，常见的有黄连阿胶汤证、归脾汤证、芎归胶艾汤证。

临床辨证要围绕以上方证进行，这样的辨证就有了明确的目标。但也不排除以上方证都不十分符合，需要重新确立新的方药来契合临床脉症的情况。所以经方医师临证时需要胸有成竹，但要时时防患胸有成见。

医师:(按脉、察舌、触手:脉细数，舌淡苔少而干燥，手温不凉。)

平时对气温变化有什么反应?手心对寒热有什么感觉，有否干燥感?头部、四肢对寒热有什么感觉?

病人:平时对气温变化没有什么异常。手掌对寒热没有什么感觉，也不感到干燥。头部时有发冷发热的感觉，四肢寒热感觉正常。

医师:月经期对气温变化有什么反应?

病人:有烦热的感觉。特别是在痛经发作的时候，有烦热汗出。

医师:头部有什么感觉?

病人:平时尚可，月经之后因为出血量多而头痛、头晕。

医师:口中有什么感觉?

病人:口干而不想喝水。

医师:食欲如何?饥饿的时候胃里感觉如何?食物吃进去以后胃里感觉如何?

有没有嗳气、吞酸?

病人:食欲可以，饥饿的时候胃里感觉嘈杂，全身无力，食物吃进去以后胃里

就舒服。没有嗳气、吞酸。

医师:大便、小便情况如何?

病人:大便干结，小便黄。

医师:胸部情况如何?

病人:还好。

医师:睡眠情况如何?

病人:睡眠不安，眠浅易醒。

思路:以上的问诊已经排除了当归四逆汤证、温经汤证、归脾汤证、芎归胶艾汤证。因为当归四逆汤证是以手足冷为主症，但是病人四肢寒热感觉正常而不冷，所以排除了当归四逆汤证；归脾汤证以心悸、失眠、纳呆、便溏为主症，病人仅有睡眠不安，眠浅易醒一症符合，比较之后也被排除。芎归胶艾汤证是以虚寒型出血症兼贫血为主症，病人虽然是出血症兼贫血，但并不虚寒，也给排除了。温经汤证是芎归胶艾汤证的类证，以手掌烦热，或干燥为对象，宜气血虚及寒冷证为主要目标，但病人没有手掌烦热或干燥，也没有寒冷证，相反地却具有热证，所以被排除。

桃仁承气汤证是出现在体质壮实，营养良好的病人身上。这个病人身体较消瘦、面色苍白、脉细数、舌淡，均不符合。然而只要病人腹部有瘀血证存在，桃仁承气汤在痛经发作期也可以斟酌用之，因为它是治疗腹部急追性剧烈疼痛的一个难得的效方，所以有时候要通过腹诊来决定取舍。

医师:请你躺下仰卧，把两腿伸直，两臂顺沿两胁伸展，腹部不得用力，使之弛缓，心情不要紧张。

(腹诊时发现，该患者“腹直肌拘挛”，这是桂枝加芍药汤证、小建中汤与当归建中汤证常见的腹证。少腹部感觉到肌肉菲薄无力，没有发现少腹急结、压痛等瘀血证的存在，所以最后排除了桃仁承气汤证。)

医师:请你俯卧，把两腿伸直。

(用手指按压腰背部脊椎、经络、穴位时，发现该患者腰俞压痛强烈，此穴是诊治痛经的经验穴。)

思路:病人具有当归建中汤证与黄连阿胶汤证，考虑到月经来汛，先在月经期给予黄连阿胶汤清热止血调经。待到月经期过后，使用当归建中汤与黄连阿胶汤合方以清热育阴、补血调经。

综合望、闻、问、切四诊所搜集的临床资料，得出四诊病情记录和证名诊断结论如下:

[病案记录]

主诉:经期小腹疼痛三年，加重一年；月经量逐年增多。

[四诊综述]

患者三年前因第一胎产后开始，月经来潮时小腹疼痛。近年来痛经加重，月经量逐年增多。这次月经将汛，下腹部已有不适。月经之后，因为出血量多而头痛、头晕。患者身体较消瘦，面色苍白，颧红唇红，烦热汗出，渴不欲饮，饥时胃里嘈杂，以及全身无力，大便干结，小便黄，脉细数，舌淡苔少而干燥，腹直肌拘挛，少腹部感觉到肌肉菲薄无力。

[证名]少阴病黄连阿胶汤证。

[治法]育阴清热。

[解析]患者因产后开始，月经来潮时小腹疼痛，月经量逐年增多，类似少阴病热化证，实为大黄黄连泻心汤之虚证。唐容川在《血证论》中认为泻心汤是治血证的第一方，所以黄连阿胶汤对于虚性的泻心汤证也应该是方证相对应的。患者身体较消较消瘦，面色苍白，头痛、头晕，舌淡苔少而干燥，脉细数，腹直肌拘挛，少腹部感觉到肌肉菲薄无力，俱为阴血不足之象，所以方中的白芍、阿胶、鸡子黄均能养血育阴止痛。睡眠不安，眠浅易醒，颧红唇红，大便干结，小便黄，为少阴热化指征，方中黄连、黄芩清热泻火止血。

[方药]黄连阿胶汤方。

黄连二钱，黄芩三钱，白芍一两，阿胶三钱(烊入)，鸡子黄一枚六帖

[治疗效果]三棱针刺血拔罐后，大概不到10分钟，小腹不适感明显减轻。服药六天后，小腹疼痛比前几个月稍有减轻，月经量也稍有减少，其他各种症状都明显减弱。继续服用当

归建中汤与黄连阿胶汤合方 15 剂，随后患者自行停药。第二个月痛经基本没有出现，月经量趋于正常量。为了巩固疗效，依据第一个月的治疗方案继续重复一次，此病症痊愈。两年来，常因其他疾病前来就诊，都没有出现此病的复发。

【血府逐瘀汤治疗崩漏症案】：

刘某，43 岁，1996 年 5 月 10 日来诊。自 1996 年 3 月 20 日月经来潮，初时经色、质、量正常。持续 1 周不净。第 8d 突然血量增多，并夹有血块。在当地医院被诊断为“月经不调”，投以人参归脾丸、安络血片等口服十余日不见效。又服乌鸡白凤丸等数十日，仍淋漓不断。并伴有小腹刺痛、乏力、心烦口渴、手足心热。来诊时已经流血 1 个多月。患者一般状态较差，面色、唇色白光白无华，形体消瘦，语音低微，舌质紫暗有瘀点，脉细涩无力。追问发病史，患者于月经来潮前 1 周曾与家人争执，心中郁闷不舒。证属肝气郁结，气滞而至血瘀，瘀阻胞络血不得归经，选用行气化瘀调经法，投血府逐瘀汤加减。

处方：当归 15g，生地 20g，桃仁 5g，红花 7.5g，枳壳 15g，赤芍 10g，柴胡 15g，川芎 5g，牛膝 10g，牡丹皮 10g，蒲黄炭 15g，知母 15g。4 剂。服第 1 剂时血量增多，并流下黑色血块。家人惶恐来院询问。嘱其继续服药。第 4 剂服完后经血已停。

5 月 6 日二诊：停血 3d，精神状态较前明显好转，面现红润，语音洪亮。舌仍有瘀点，脉涩。依前方去蒲黄炭加白术 15g，焦三仙各 15g 以调理脾胃，扶正驱邪。再服 5 剂。半年后随访患者月经已恢复正常。

按：本案系情志不畅，肝气郁结为病。因“气行则血行，气滞则血凝”，气滞则血运不畅，瘀血停滞，新血不得归经而导致崩中漏下。因失血日久伤阴，而出现口渴心烦、手足心热。用血府逐瘀汤理气化瘀调经，此乃“通因通用”之法，故取药到病除之效。

第六节 妇人外阴诸疾病

【甘麦大枣汤外阴瘙痒医案】邵金阶：

邹某某，女，40 岁，护士。初诊：1985 年 8 月 6 日。外阴瘙痒 11 个月，多方医治，均少效验。患者面色萎黄，头昏肢倦，梦多寐差，心烦易怒，口干纳呆，月经量中等，白带不多，外阴干燥瘙痒。证属肝血不足，生风化燥之阴痒证，治当补血以安神，滋肝以润燥，拟用甘麦大枣汤加味：炙甘草 15 克，大枣 10 枚，小麦 30 克，黄芪、当归、苦参各 10 克，茯苓 15 克，3 剂，每日 1 剂。二诊：8 月 10 日，精神转佳，痒减过半，宗前方继服 6 剂告愈，至今未发。(湖北中医杂志 1989)。

注家按语：肝经之脉自足上行，沿腹内侧，入阴毛中，环绕阴器，血虚不能濡润肝经，生风化燥，故生阴痒。治用甘麦大枣汤加味有效。

甘草小麦大枣汤方：汉《伤寒论》）

甘草三两 小麦一升 大枣十枚（擘）

上三味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

【当归四逆汤治子宫肌瘤并不孕症】

邹 xx，女，31 岁。体胖，结婚后 7 年未孕，经前胸乳胀痛，腰痛，小腹坠胀疼痛，经来最多，经色暗黑有血块，淋漓难尽，经后腰痛，白带多，清稀，手足不温，舌质淡，舌体胖大，苔白，脉沉细无力。方用当归四逆汤化裁：当归 9 克，桂枝 9 克，白芍 30 克，细辛 9 克，甘草 6 克，通草 9 克，三棱 12 克，莪术 12 克，红藤 30 克，败酱草 30 克，法夏 9 克，炮甲 6 克，路路通 9 克，石见穿 15 克，皂角刺 9 克，一日一剂，一日 3 次，饭后温服。药渣布包热敷小腹部。经期更方为：熟地 15 克，赤芍 9 克，当归 15 克，川芎 9 克，蒲黄生炒各 6 克，太子参 15 克，覆盆子 15 克，菟丝子 15 克，牛膝 9 克，前仁 9 克，苍白术各 15 克，

仙灵脾15克，仙茅9克，一日一剂，一日3次，饭后温服。连续治疗二月，B超检查提示：子宫形态、结构无异常，诸症悉除。越一年，家人来告生一子。

痛经一症，病因很多，临床多见命门火衰，脾肾两虚。痰瘀阻滞胞宫等，导致痛经不孕。本例乃子宫肌瘤，肌瘤为有形之邪，寒凝气滞，痰瘀阻滞，故致痛经不孕，用当归四逆汤化裁，温阳散寒，化瘀止痛，使寒散痛消，气血畅达，阴阳调和，经来不痛，故能受孕生子。

综上所述，当归四逆汤用来治疗厥阴病，无论现代医学诊断为什么病，但见阳虚阴甚皆可应用。其辨证要点为："手足厥寒，脉细欲绝者，"其使用指征不必二者悉俱，但见一证便可使用，只要用法得当，随证加减，都可收到不可估量的疗效。

【蛇床子散与苓桂术甘汤合方加味治多年真菌性阴道炎】

许某，女，34岁。有多年真菌性阴道炎病史，近因带下量多前来诊治。刻诊：带下色白量多，阴中瘙痒，阴部潮湿，舌质淡，苔薄白，脉沉。辨为寒湿下注证，治当温阳散寒、除湿止带。给予蛇床子散与苓桂术甘汤合方加味：蛇床子30g，茯苓12g，桂枝10g，白术6g，生甘草6g，花椒10g，鸦胆子(研碎)2g。6剂，每日1剂，水煎分内服外洗，内服每日3次，每次约50ml，余药分早、晚2次外洗。二诊：瘙痒减轻，以前方6剂。三诊：带下减少，以前方6剂。四诊：阴部潮湿减轻，以前方6剂。五诊：带下止，以前方12剂。六诊：诸症基本解除，又以前方治疗20余剂。随访1年，一切尚好。

【用方提示】根据带下色白辨为寒，再根据阴部潮湿辨为湿，因瘙痒辨为湿浸，以此辨为寒湿下注证。方以蛇床子散温阳散寒、燥湿止痒；以苓桂术甘汤健脾利湿，杜绝湿生之源；加花椒温阳散寒止痒，鸦胆子燥湿解毒。方药相互为用，以奏其效。

【蛇床子散治阴道瘙痒】：

妇女外阴及阴道瘙痒，甚则痒痛难忍、坐卧不宁或伴带下增多等称为阴痒，有称"阴门瘙痒"。《济阴纲目》有"妇人阴痒者，是虫蚀所为，微者为痒，重者乃痛"的论述。与西医妇科学的对于外阴瘙痒症的认识相符。自拟蛇床散外洗治疗阴痒症百余例，效果满意。

治疗前需检查白带常规及空腹血糖，明确滴虫及霉菌感染并且排除糖尿病。临床上用药前需细察患者有无眼部溃疡、口腔溃疡、外阴溃疡，目的是将白塞氏病排除。

组方：蛇床子9克，五倍子9克，苦参9克，黄柏9克，紫苏叶3克，炒蜂房9克。如外阴红肿灼热感去五倍子加金银花15克，龙胆草10克；霉菌（+）加土茯苓30克；如滴虫（+）加百部30克。上药加水1500毫升煎至1000毫升，去渣，倒入盆内，至温热适度，坐浴（经期除外），浸洗10~15分钟，每日1次，一般5~7次即有效。

方解：《本经》云："蛇床子主恶疮，则外治之药也，外疡湿热痛痒浸淫诸疮，可作汤洗，可为末敷，收效甚捷，不得以贱品而忽之。"此药温中下气，苦能除湿，辛能润肾，甘能益脾，故功用颇奇，内外俱可施治，而外治尤良；再入苦参、黄柏、五倍子取其清热而去湿，排脓水而制痒，疗疮而杀虫也；蜂房攻毒杀虫，苏叶利气发散，促使诸药渗入，以冀奏效更捷。全方共奏清热化湿，杀虫止痒之功效，在治疗过程中忌食辛辣发物。

【甘麦大枣汤外阴瘙痒医案】邵金阶：

邹某某，女，40岁，护士。初诊：1985年8月6日。外阴瘙痒11个月，多方医治，均少效验。患者面色萎黄，头昏肢倦，梦多寐差，心烦易怒，口干纳呆，月经量中等，白带不多，外阴干燥瘙痒。证属肝血不足，生风化燥之阴痒证，治当补血以安神，滋肝以润燥，拟用甘麦大枣汤加味：炙甘草15克，大枣10枚，小麦30克，黄芪、当归、苦参各10克，茯苓15克，3剂，每日1剂。二诊：8月10日，精神转佳，痒减过半，宗前方继服6剂告愈，至今未发。(湖北中医杂志1989)按语：肝经之脉自足上行，沿腹内侧，入阴毛中，环绕阴器，血虚不能濡润肝经，生风化燥，故生阴痒。治用甘麦大枣汤加味有效。

【甘麦大枣汤尿道涩痛医案】邵金治：

袁某某，淋证，女，48岁，干部。初诊：1982年10月10日，尿道涩痛，时轻时重，甚

则尿频尿急，疼痛难忍，已有年余，久治罔效。患者形体清癯，精神抑郁，心烦易怒，夜寐欠安，口干喜饮，舌红苔薄黄，脉弦细，证属心肝阴亏移热小肠，治宜育阴利水，养心安神，甘麦大枣汤加味：生甘草、生地各 15 克，大枣 10 枚，小麦、白茅根各 30 克，黄芪、淡竹叶、当归各 10 克。二诊：10 月 16 日，服前方 5 剂后诸证明显减轻，效不更方，续服 10 剂告愈，随访至今，未再发作。(湖北中医杂志 1989)

注家按语：本案为心肝阴虚，志火内动，移热小肠。治病求本，以甘麦大枣汤加生地、当归养心肝阴血；以淡竹叶、白茅根利水通淋，治其标也。

【附子汤治阴痒】孙长德：

宋某，女，35 岁，1982 年 5 月 10 日诊。阴痒已半年余，医治无效，今来我院就诊。初拟利湿解毒之药不效，细察其症见阴痒而痛，夜间尤甚，局部可见腐烂，而流清液，少腹冷感，舌苔白滑，脉沉迟。当属阳虚阴寒证。治当温阳祛寒化湿。方选附子汤加味：

附子 12 克、党参、白芍各 10 克，茯苓 20 克，白朮、炒苍朮、黄芪各 15 克。连服 3 剂。外用苦参 30 克，蛇床子 30 克，煎水冲洗，腐烂处以六神丸为散外敷，每日 2 次。

药后痛痒大减，守方减附子为 6 克，又服 2 剂，外用药同前，药尽病愈。

按语：湿为阴邪，易伤阳气，阳虚不运寒湿，湿滞为毒，则腐烂痛痒。用附子汤温阳逐寒，加苍朮燥湿、黄芪以托毒外出，并加外洗，局部用药，以缩短病程。

【桃核承气汤妇阴门肿痛如剂腹硬满少腹急结】《古方便览》：

一妇阴门肿痛如剂，上冲头痛，日夜号哭者数日。腹硬满少腹急结，用桃仁承气汤三剂，其夜痛益甚，及晓忽然出脓血，疾顿愈。

【附子汤治子宫脱垂宫颈糜烂案】：

朱女士，32 岁，患者小腹坠胀，白带多，质稀薄，无臭味，已一年多。活动后病情往往加重，伴有小腹冰凉，腰酸，疲乏无力。西医诊断为子宫脱垂 I 度，宫颈糜烂 I 度。舌体胖舌质淡，舌苔薄白。

综合辨证为脾肾阳虚。开方附子、白术、白芍、茯苓、党参，用药 7 天后，白带减少，下坠感轻，小腹冰凉有所好转。用药 15 天，白带正常，小腹转温，腰酸、乏力亦明显好转。续用上方 15 天，小腹坠胀感完全消失，即便活动亦无影响，已能参加轻微劳动，遂停药。

【当归四逆加吴茱萸生姜汤治阴户遽现紧缩手足厥冷医案】赵守真：

刘妇，年四旬余，邮亭圩北村人。体素虚弱，某日农作过劳，傍晚归途遇雨，衣履尽湿，归仅更衣，不甚介意。晚间又经房事，而风雨之夜，寒气砭骨，夜半时起入厕，未久，睡感寒甚，数被不温，少腹拘急绞痛，次第加剧，待至天将明时，阴户遽现紧缩，自觉向腹中牵引，冷汗阵出，手足厥冷，头晕神困，不能起立，服药鲜效。其夫来迎治，脉象微细，舌润不温，乃一阴寒证也。其夫且曰："内子阴户收缩，成一杯大空洞形，时流清液，令人见而生畏。"吾曰："病虽奇，治尚易，近村魏妇病与相若，曾一方即愈，毋用惊惧。"乃书与当归四逆加吴茱萸生姜汤，嘱一日服完两大剂，并用艾灸气海、关元十余炷，又锡壶盛开水时熨脐下。次日往视，已笑逐颜开，操作厨下，惟身觉略倦而已。

【百合地黄汤治阴道干涩症】高齐民：

我曾治 2 例妇女阴道干涩症，大碍于房事，服百合地黄汤 5 副后，阴道干燥消失。所用处方为：百合 30g，地黄 60g。经方的特点是药少力宏，小方可以治大病。

【当归四逆加吴茱萸生姜汤治少腹大痛医案】赵守真：

袁素珠，青年农妇，体甚健，经期准，已育子女三四人矣。一日，少腹大痛，筋脉拘急而未稍安，虽按亦不住，服行经调气药不止，迁延十余日，病益增剧，迎余治之。其脉沉紧，头身痛，肢厥冷，时有汗出，舌润，口不渴，吐清水，不发热而恶寒，肢以下痛，痛剧则冷汗出，常觉有冷气从阴户冲出，痛处喜热敷。此由阴气积于内，寒气结搏而不散，脏腑虚弱，风冷邪气相击，则腹痛里急．而成纯阴无阳之寒疝。窃思该妇经期如常，不属于血凝气滞，

亦非伤冷食积，从其脉紧肢厥而知为表里俱寒，而有类于《金匮》之寒疝。其谓："腹痛脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒；紧则不欲食，邪正相搏，即为寒疝"。……本病证状虽与上引《金匮》原文略出入，而阴寒积痛则属一致。处以乌头桂枝汤方：制乌头 12 克，桂枝 18 克，芍药 12 克，甘草 6 克，大枣 6 枚，生姜 3 片。水煎，兑蜜服。

上药连进 2 帖，痛减厥回，汗止人安。换方当归四逆加吴茱萸生姜汤，以温通经络，清除余寒，病竟愈。(《治验回忆录》1962：76)

【当归四逆加吴茱萸生姜汤治妇人阴缩】

刘妇，年四旬余，邮亭圩北村人。体素虚弱，某日农作过劳。傍晚归途遇雨，衣履尽湿，归仅更衣，不甚介意。晚间又经房事，而风雨之夜，寒气砭骨，夜半时起如厕，未久，睡感寒甚，数被不温，少腹拘急绞痛，次第加剧，待至天将明时，阴户遽现紧缩，自觉向腹中牵引，冷汗阵出，手足厥冷，头晕神困，不能起立。服药鲜效，其夫来迎治。脉象微细，舌润不渴。乃一阴寒证也。其夫且曰："内子阴户收缩，成一杯大空洞形，时流清液，令人见而生畏。"吾曰："病虽奇，治尚易，近村魏妇病与相若，曾一方即愈，毋用惊惧。"仍书与当归四逆加吴茱萸生姜汤，嘱一日服完二大剂，并用艾灸气海、关元十余炷，又锡壶盛开水，时熨脐下。次日往视，已笑逐颜开，操作厨下，惟身觉略倦而已。《治验回忆录》

【外阴湿疹搔痒溢水双眼干涩全身发小脓疮下肢红斑累累医案】王足明：

李某，女，32 岁。自述 1960 年即患白塞氏综合征，经积极治疗，明显溃疡已愈。诊见：外阴湿疹，搔痒溢水，双眼干涩，全身发小脓疮，双下肢红斑累累，抓破流脂，形体瘦弱，面白无华，纳差口苦，小便灼热短黄，大便干结难下，每次经血量多，经潮时诸症减经，经净后病又如故，舌红，苔黄厚腻，脉细缓。此乃狐惑病，舌红，苔黄腻乃湿热之象。湿热蕴结，蒸腐气血，泛滥周身则为脓疮，流注阴部则生溃烂，湿疹搔痒等，热毒迫血则经多，经行诸症减是湿热随经而泄，病久损伤气血，故脉细缓而形神俱不足也。此虚中夹实，治当凉血解毒，清利湿热，调补气血：赤小豆 25 克，当归 10 克，苦参 12 克，银花 12 克，知母 12 克，苡米 25 克，车前子 10 克(包)，地榆炭 18 克，熟地炭 18 克，淮山药 15 克，党参 12 克，黄芩炭 10 克。每日 1 剂，水煎。

上方服 4 剂后，月经尚未干净，阴部溃疡如故，但湿痒消失；下肢红斑隐退，脓疮亦有愈合之势，食纳稍增，仍溲黄便结，舌苔黄，根部稍腻，为防经后病情加重，守服原方 4 剂，药后月经已净，外阴湿痒未发，脓疮已愈，阴部溃疡亦将愈合，唯黄白带下增多，此乃湿热蕴毒已现外出之机，仍守原方去知母，加草薛 12 克，连服 10 剂后，诸症消失，经妇科检查证实："阴部溃疡已全部愈合"。出院后仍予上方 5 剂，以巩固疗效，随访年余，未见复发。(广西中医药 1982；<4)：5)

【附子汤阴痒而痛夜间尤甚局部可见腐烂医案】孙长德：

宋某，女，35 岁，1982 年 5 月 10 日诊。阴痒已半年余，医治无效，今来我院就诊。初拟利湿解毒之药不效，细察其症见阴痒而痛，夜间尤甚，局部可见腐烂，而流清液，少腹冷感，舌苔白滑，脉沉迟。当属阳虚阴寒证。治当温阳祛寒化湿。方选附子汤加味：

附子 12 克、党参、白芍各 10 克，茯苓 20 克，白朮、炒苍朮、黄芪各 15 克。连服 3 剂。外用苦参 30 克，蛇床子 30 克，煎水冲洗，腐烂处以六神丸为散外敷，每日 2 次。

药后痛痒大减，守方减附子为 6 克，又服 2 剂，外用药同前，药尽病愈。

【大承气并大陷胸汤加味臌胀下阴常流黄水臭味异常】

范某，女，22 岁。成都市龙泉区长风乡，农民。病史：两岁时开始患腹胀，其后发展到全身皆肿，肌肉变硬。下阴常流黄水，臭味异常。十多年来，病魔缠身，其父为之四处求医，未见显效。1969 年 8 月，前来就诊，按阳明腑证论治，服药 2 剂后基本治愈。诊治：腹胀如鼓，胸胁满闷。皮色苍黄，全身肌肤胀硬。大便常秘结，所下如羊粪，已四日未行；下阴不断渗出臭黄水。舌质深红，苔黄燥，脉沉实有力。此为阳明腑证兼水热互结。法宜峻下热结，

兼逐积水，以大承气并大陷胸汤加味主之。处方：生大黄 18g，厚朴 30g，枳实 30g，芒硝 30g，甘遂 15g(冲服)，芫花 15g(冲服)，桑皮 60g。先服 1 剂，泻下燥屎十余枚，并臭秽黄水甚多，腹部硬胀消失大半。续服 1 剂，胸腹肿胀皆消，全身肌肤变软，下阴外渗之黄水亦止。因自觉病势顿减，加以客居成都。经济困难，遂自行停药回家。不久患者邻友来告，已康复如常。1979 年 7 月追访，病愈结婚，并生一子。10 年来身体一直很好。《范中林六经辨证医案选》

【桃核承气汤妇阴门肿痛如剂腹硬满少腹急结】《古方便览》：

一妇阴门肿痛如剂，上冲头痛，日夜号哭者数日。腹硬满少腹急结，用桃仁承气汤三剂，其夜痛益甚，及晓忽然出脓血，疾顿愈。

【蛇床子散与苓桂术甘汤合方加味治多年真菌性阴道炎】

许某，女，34 岁。有多年真菌性阴道炎病史，近因带下量多前来诊治。刻诊：带下色白量多，阴中瘙痒，阴部潮湿，舌质淡，苔薄白，脉沉。辨为寒湿下注证，治当温阳散寒、除湿止带。给予蛇床子散与苓桂术甘汤合方加味：蛇床子 30g，茯苓 12g，桂枝 10g，白术 6g，生甘草 6g，花椒 10g，鸦胆子(研碎)2g。6 剂，每日 1 剂，水煎分内服外洗，内服每日 3 次，每次约 50ml，余药分早、晚 2 次外洗。二诊：瘙痒减轻，以前方 6 剂。三诊：带下减少，以前方 6 剂。四诊：阴部潮湿减轻，以前方 6 剂。五诊：带下止，以前方 12 剂。六诊：诸症基本解除，又以前方治疗 20 余剂。随访 1 年，一切尚好。

【用方提示】根据带下色白辨为寒，再根据阴部潮湿辨为湿，因瘙痒辨为湿浸，以此辨为寒湿下注证。方以蛇床子散温阳散寒、燥湿止痒；以苓桂术甘汤健脾利湿，杜绝湿生之源；加花椒温阳散寒止痒，鸦胆子燥湿解毒。方药相互为用，以奏其效。

【蛇床子散治阴道瘙痒】：

妇女外阴及阴道瘙痒，甚则痒痛难忍、坐卧不宁或伴带下增多等称为阴痒，有称“阴门瘙痒”。《济阴纲目》有“妇人阴痒者，是虫蚀所为，微者为痒，重者乃痛”的论述。与西医妇科学的对于外阴瘙痒症的认识相符。自拟蛇床散外洗治疗阴痒症百余例，效果满意。

治疗前需检查白带常规及空腹血糖，明确滴虫及霉菌感染并且排除糖尿病。临床上用药前需细察患者有无眼部溃疡、口腔溃疡、外阴溃疡，目的是将白塞氏病排除。

组方：蛇床子 9 克，五倍子 9 克，苦参 9 克，黄柏 9 克，紫苏叶 3 克，炒蜂房 9 克。如外阴红肿灼热感去五倍子加金银花 15 克，龙胆草 10 克；霉菌（+）加土茯苓 30 克；如滴虫（+）加百部 30 克。上药加水 1500 毫升煎至 1000 毫升，去渣，倒入盆内，至温热适度，坐浴（经期除外），浸洗 10~15 分钟，每日 1 次，一般 5~7 次即有效。

方解：《本经》云：“蛇床子主恶疮，则外治之药也，外疡湿热痛痒浸淫诸疮，可作汤洗，可为末敷，收效甚捷，不得以贱品而忽之。”此药温中下气，苦能除湿，辛能润肾，甘能益脾，故功用颇奇，内外俱可施治，而外治尤良；再入苦参、黄柏、五倍子取其清热而去湿，排脓水而制痒，疗疮而杀虫也；蜂房攻毒杀虫，苏叶利气发散，促使诸药渗入，以冀奏效更捷。全方共奏清热化湿，杀虫止痒之功效，在治疗过程中忌食辛辣发物。

【反复阴痒二周伴白带增多医案】

患者方某，女，43 岁，2017 年 5 月 13 日初诊。因反复阴痒二周伴白带增多要求中药治疗。面部黄褐斑，自诉经前偶有乳胀口苦，经期尚规则，经色偏黯、量偏少，白带呈乳白色，偶有阴部烧灼感。白带常规：白细胞（++），霉菌（+），舌质略红，苔薄白，脉细弦。治宜疏肝理气，清带止痒。

内服方：柴胡 6 克，当归 6 克，荆芥 5 克，川楝子 10 克，生白术 10，土茯苓 10 克，白鲜皮 10 克，苦参 10 克，炒牛膝 12 克。7 服。

外洗方：蛇床子 9 克，土茯苓 30 克，黄柏 9 克，紫苏叶 3 克，炒蜂房 9 克，金银花 6 克，龙胆草 5 克。3 服。（1 服外洗方可以用 2 天）。患者药后阴部瘙痒显减，白带减少。内服方去改当归为当归炭 6 克，川楝子改生地 15 克，外洗方按原方出入。三诊白带常规：霉菌

（-），白细胞（-），嘱下次月经来潮后复查白带常规以善后。

【蛇床子散交感则觉阴中隐痛】

一宠妾，三十余，凡交感，则觉阴中隐痛，甚则出血，按其脉，两尺沉迟而涩，用补血散寒之剂不愈。因思药与病对，服而不效，恐未适至其所也。偶检《千金方》，用蛇床子散，绵裹纳其中，二次遂愈。（名医类案）

蛇床子散方：
蛇床子一两
上一味，末之，以白粉少许，和合相得，如枣大，棉裹纳阴中，自温。

曹颖甫曰：自然温（当云不痒）妇人寒湿下注阴中，或为白带，或为败血，久久化热，皆足生虫，多而窜动，则痒不可忍，以川椒百部洗之，往往不效，惟蛇床子散足治之，昔年予治一妇人历节风愈后，自言阴痒不可忍，自用明樊泡水洗之，时稍定，少顷痒如故，予以此方授之，二日而瘥（详历节篇）尽以蛇床子之燥，烈合铅粉之杀虫，湿去虫死，其痒乃止，但予实变法用之，使之煎汤坐盆中洗之，然后扑以铅粉，此可知仲师立方之旨，在燥湿杀虫而不在祛寒矣，陈修园乃谓遥承上节令阴制痛，少腹恶寒证，出其方治，岂其然乎，又按阴寒不孕，另是一证，仲师当别有方治，近世所传吴茱萸，蜀椒各八两为末，炼蜜为丸，弹丸大，帛里内阴中，日夜一换，一月后，子宫温和即孕，用法与此方相似或即仲师之遗方欢，否则本条所列病证与方治固了不合也。

注家曰：本方应用中注意有带下清稀、腰酸困重、少腹寒冷、外阴瘙痒等症状。临床可用治宫颈糜烂，滴虫性、霉菌性阴道炎，湿疹，外阴瘙痒症，包皮、龟头念珠菌病等属于下焦寒湿之证。

《神农本草经》：“主男子阴痿湿痒，妇人阴中肿痛，除痹气，利关节，癫痫，恶疮。”

《药性论》：“治男子、女人虚，湿痹，毒风，顽痛，去男子腰疼。浴男子阴，去风冷，大益阳事。主大风身痒，煎汤浴之瘥。疗齿痛及小儿惊痫。”

【蛇床子应用】：

1．阴部湿痒，湿疹，疥癣。本品辛苦温燥，有杀虫止痒，燥湿诸作用。为皮肤及妇科病常用药，常与苦参、黄柏、白矾等配伍，且较多外用。治阴部瘙痒，与白矾煎汤频洗，如《濒湖集简方》；现临床治滴虫性阴道炎较常用。《千金方》则单用本品研粉，猪脂调之外涂，治疗疥癣瘙痒。

2．寒湿带下，湿痹腰痛。本品性温热可助阳散寒，辛苦又具燥湿祛风之功。治带下，腰痛尤宜于寒湿兼肾虚所致者，常与山药、杜仲、牛膝等同用。

3．肾虚阳痿，宫冷不孕。本品温肾壮阳之功亦佳。如《千金方》在30首治肾虚阳痿精冷方中，用蛇床子方达半数以上，且内服、外用均有。亦常配伍当归、枸杞、淫羊藿、肉苁蓉等治疗阳痿无子，如赞育丹（《景岳全书》）。

《金鉴》曰：蛇床子，脾、肾经，温肾壮阳，燥湿杀虫，祛风止痒，治阳痿，阴囊湿痒，宫寒不孕，寒湿带下，阴痒肿痛。白粉应是铅粉。倪氏云：此处白粉，乃水银升华后凝结物。众说不一。

赵以德曰：白粉即米粉，藉之以和合也。此言与胡希恕之说法不同。

《汉药神效方》曰：妇人阴中痒痛，或白带，或子宫下垂，交合时发痛者，用蛇床子末，和熟艾，軒绢袋中，其形如蕃椒，插入阴中，以尖头插入子宫为佳。

《集简方》曰：妇人阴痒，蛇床子一两，白矾二钱，煎汤频洗。

高学山曰：阴寒，亦指阴庭之寒冷而言，俗解作子宫寒。坐，以坐药外治，不能温子宫故也。坐药者，纳之而坐，非一时取效之谓，故方后曰绵裹者，恐其坐久致化之义也。凡妇人一切纳药、坐药、洗药，俱与深远之脏腑无干，而为外症，外症而治以内药，既失之迂，而且虞脏腑之喜恶不齐，先为药病也，故外症皆从外治之例。

蛇床子，《本草》称蛇虺喜卧其下，故有蛇床虺床之名，则其性之温暖可知，又味辛而甘，夫辛甘主散，则其温暖之性，为能横施旁达又可知，用为坐药，而阴寒自温可必也。

客有素读仲景之书，而难予者曰：阴非独寒，必子宫上冷而后下阴户者，本衣冠文物主坐药，而子谓但温阴庭，而非子宫之药，毋乃所见之偏且执耶？余曰：是非客所知也。夫《金匮》一书，分门立论，其就症列方者，大似玉碎珠零，金星宝片，殊无可贵，是在灵机无碍者，会其全神，譬之重漆围屏，钳镶斗缝，则异彩奇光，照耀堂奥，而成玻璃世界，客之所见者，屑末而已矣。乌足以知此哉，诚如客言，彼子宫之寒在先天者，肾气丸不具在乎，在后天者，理中丸不具在乎，何妨以内药先温其本，而后以外药兼治其标耶，且云坐药可上温子宫，则亦将以漱口不下咽者，能愈中焦疾苦乎，客失笑而语塞。

第七节 妇人癥瘕卵巢囊肿子宫肌瘤诸病症

【化癥回生丹治卵巢囊肿医案】路新：

郎姓，女，56 岁，未婚。1962 年冬季，于行经期间，不慎坠入井中。此后，经期不准，经行血少而少腹痛。1963 年 1 月开始发现左小腹部有包块，并逐渐增大；每因劳累即少腹有胀满下坠感。曾针灸治疗数次，少腹痛略减，但包块未见缩小。至 6 月间，逐渐增大，腹部膨隆。服香棱丸数剂，亦未效。至 8 月间，至某医院妇科检查，诊断为卵巢囊肿，拟作手术治疗。因患者不愿手术治疗，于 9 月 30 日来我院住院治疗。

检查：面色苍白，精神抑郁，表情淡漠，舌质色淡，苔滑白，脉沉细而涩，少腹有包块，呈椭圆形(如妊娠 5 个月)，按之不痛而移动，边缘清楚，质软而滑。诊断为肠覃症。《灵枢 •水胀》载："寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内著，恶气乃起，息肉乃生；其始生也，大如鸡卵，稍以益大，至其成，如怀子之状，久者离岁；按之则坚，推之则移，月事以时下。"此患者的病因是经期坠井，致寒湿之邪客于肠外，以致气结血凝，聚而成块。治宜扶正软坚，消瘀散结。用化癥回生丹(《温病条辨》方)原方，如法制成丸药，每丸 6g，每次服 1 丸，每天服 2 次。治疗经过：初服月余，包块渐软而略缩小。又服 1 个月，包块缩小 1 注家曰：。出院后，又继续服药 1 个月。经服上药 3 个月后，来我院检查：包块全部消失，身体恢复健康。停药 3 个月后，至某医院检查，认为卵巢囊肿已愈。在服上药期间，患者除自觉头面、手脚皮肤干燥外。并无其他不适。[上海中医药杂志，1965，(8)：16]。

【化癥回生丹治子宫肌瘤医案】梁颂如：

谭某某，女，42 岁。初诊：患者于 1958 年 9 月来诊。自诉近半年月经周期退后，经量多而有块，每次经前腹痛，经后 1~2 天腹痛即止。平时自带量多。下腹可触及肿块，如鸡蛋大，头晕腰坠，舌苔白腻厚，脉弦细。经妇检诊为子宫上唇肌瘤。先后经中西医治疗不效，故来求诊。此乃气血瘀积、痰湿凝滞，阻于胞宫，结为"石瘕"。宜先用二陈合完带汤加减以去其痰湿，后用化癥回生丹以图活血散瘀。处方：法半夏 12g，茯苓 15g，陈果皮 4.5g，制香附 12g，台乌药 12g，党参 12g，苍术、白术各 9g，黑芥穗 4.5g，桃仁 9g，丹皮 9g。3 剂。复诊：患者自服 6 剂后来诊。谓头晕腰坠减轻，苔转薄白，白带亦明显减少。说明痰湿已除，所留瘀癥一病，非一朝一夕能收效。改用自制化癥回生丹 1 料，嘱其坚持服食，不需再来诊治。半年后，病者登门拜访。谓自服完 1 料后，月经正常，下腹肿块已摸不着，并经妇科检查，原子宫上唇肌瘤已消除。[新中医，1985，(11)：43-44]。

【化癥回生丹治癥瘕医案】：

张某，28 岁，脐左癥瘕，面黄肢倦，食少不能作文，自看书亦不能久，宛如虚损。与化癥回生丹缓通阴络法，每日空心服一丸，亦有早晚各服一丸之时。服至二年有余，计服化癥回生丹六、七百丸之多，癥始化净，气体复原，看书作文，始举进士。(《吴鞠通医案》)

【临证提要】本方有行气活血、消癥散结、补益扶正之功效。本方为治气血瘀滞所致的癥结积聚，日久不散，气血已亏的良剂。主要用治癥结、血痹、疟母，以及妇科瘀血经闭、痛经、产后少腹疼痛等，也可用于外伤疼痛。近多用于肝硬化、肝脾肿大、肝癌、子宫肌瘤、卵巢肿瘤。但方中用虻虫、水蛭等虫药，且大黄重用，破血逐瘀之力甚强，体虚者慎用。

【作用与功效】行气活血，消癥散结。

【主治】癥结不散不痛；癥发痛甚；血痹；妇女干血痨证之属实者；妇女经前作痛；妇女将欲行经而寒热者；妇女将欲行经误食生冷腹痛者；妇女经闭；妇女轻来紫黑甚至成块者；产后瘀血少腹痛拒按者；疟母左胁痛而寒热者；腰痛之因于跌扑死血者；跌扑昏晕欲死者；金疮棒疮之有瘀滞者。

【方解】本证因瘀血久积所致，故用益母草、大黄、乳香、没药、桃仁、藏红花、元胡、蒲黄、五灵脂、苏木、干漆、三棱、阿魏、虻虫、水蛭等活血祛瘀、消癥散结；丁香、川椒、姜黄、良姜、两头尖、香附、降真香行气止痛；肉桂、吴茱萸、艾叶、小茴香温通经脉；苏子、杏仁以宣降气机；麝香芳香通络、散结止痛；鳖甲胶软坚散结，配合白芍、熟地、当归、川芎补血活血，人参补气健脾。诸药合用体现了攻补兼施，攻不伤正之法。本方制成丸剂意在对于癥结日久不消之证宜缓消。

【理冲汤癥瘕起于少腹医案】张锡纯：

一妇人，年三十余。癥瘕起于少腹，渐长而上。其当年长者稍软，隔年即硬如石。七年之间，上至心口，旁塞两肋，饮食减少，时觉昏愦，剧时昏睡一昼夜，不饮不食，屡次服药竟分毫无效。后愚为诊视，脉虽虚弱，至数不数，许为治愈，授以此方。病患自揣其病，断无可治之理，竟置不服。次年病益进，昏睡四日不醒。愚用药救醒之，遂恳切告之曰：去岁若用愚方，病愈已久，何至危困若斯。然此病尚可为，甚勿再迟延也，仍为开前方。病患喜，信愚言，连服三十余剂，磊块皆消。惟最初所结之病根，大如核桃之巨者尚在。又加生水蛭（不宜炙）一钱，服数剂全愈。

理冲汤方：
生黄芪三钱，党参二钱，于术二钱，生山药五钱，天花粉四钱，知母四钱，三棱三钱，莪术三钱，生鸡内金三钱（黄者）
用水三盅，煎至将成，加好醋少许，滚数沸服。

【理冲汤癥瘕结于上脘医案】张锡纯：

一妇人，年二十余。癥瘕结于上脘，其大如橘，按之甚硬，时时上攻作疼，妨碍饮食。医者皆以为不可消。后愚诊视，治以此汤，连服四十余剂，消无芥蒂。

【理冲汤心腹满闷医案】张锡纯：

一媪，年六旬。气弱而且郁，心腹满闷，不能饮食，一日所进谷食，不过两许，如此已月余矣。愚诊视之，其脉甚微细，犹喜至数调匀，知其可治。遂用此汤，将三棱、莪术各减一钱，连服数剂，即能进饮食。又服数剂，病遂全愈。

【理冲汤少年癖结于少腹医案】张锡纯：

一少年，因治吐血，服药失宜，癖结于少腹（在女子为癥瘕在男子为 癖）大如锦瓜。按之甚坚硬，其上相连有如瓜蔓一条，斜冲心口，饮食减少，形体羸弱。其脉微细稍数。治以此汤，服十余剂癖全消。

【当归芍药散合桂枝茯苓丸癥瘕(子宫肌瘤)医案】岳美中：

赵某某，女，47 岁，1961 年 4 月 3 日初诊。患者于四年前发现下腹部有一鸡蛋大肿物未予介意。但以后肿物逐渐增大，四年后肿物增大使腹围增至 97 公分，较前增加 17 公分，如怀胎状。两天前突发下腹剧痛，冷汗淋漓。经某某医院诊为“子宫肌瘤”，并要立即手术治疗，患者未允。乃请岳老诊治。诊见形体瘦弱，面色萎黄，下腹肿物按之坚硬，压痛明显，舌质暗，少苔，脉沉细而涩。经水二至三月一行，量少色黯，夹有血块。证属瘕积瘀血，治

以疏肝健脾，破瘀消瘕。

处方：桂枝 9 克，茯苓 9 克，川芎 9 克，丹皮 9 克，桃仁 9 克，白芍 21 克，当归 9 克，泽泻 21 克，白术 12 克，服药 10 剂后，腹痛明显减轻，乃将原方改为散剂，每服 9 克，日服二次。

服用二个月，下腹肿物日渐变小，症状大见好转。服药半年，下腹肿物消失，经水正常，诸症悉除。七年以后，患者复因处境不顺，情志不舒。下腹肿物又起，逐渐增大，症状同前。经岳老诊治，仍继服原方散剂，三个月后，又获痊愈。

按语：此病系肝郁气滞，血行不畅，气血滞于小腹，久积而成。岳老虑其体虚，不宜攻逐，当治病留人，缓消其瘕。故选用当归芍药散合桂枝茯苓丸以疏肝健脾，活血消癥，病虽重却免于手术，药治半年而愈。

【桂枝茯苓丸加味治卵巢囊肿医案】刘昭坤：

何某，32 岁。患者月经周期 45 天～50 天，经期 6 天～8 天，行经腹痛、夹黑色血块、并逐次加重 1 年余，白带量多质稀，少腹凉而坠痛，腰酸体倦，舌质黯两侧有瘀斑，苔白厚，脉沉弦。屡服少腹逐瘀汤、完带汤等，其效不著。妇科检查：耻骨联合左侧扪及 7cm×6.5cmX8cm 囊性包块；质软，活动度好。B 型超声波检查报告：子宫未见异常，左附件见 6．5cm×8cm 液性暗区，提示：左侧卵巢囊肿。综其脉症，乃痰湿与瘀血互结为症。治宜温化痰湿，活血消瘕。方以桂枝茯苓丸加味：桂枝 20g，茯苓 45g，丹皮 10g，桃仁 10g，赤芍 10g，泽兰 30g，香附 15g，黄芪 30g。日 1 剂，水煎，分早晚 2 次温服。服药 3 个疗程后经妇科检查及 B 超复查报告：子宫及双侧附件未见异常。迭进 5 剂，改 2 天 1 剂，以巩固疗效。经随访 2 年，并做 B 超检查，无复发。

按语：卵巢囊肿古谓之“肠覃”，对其治疗《内经》云“可导而下”，临床实践证明，用桂枝茯苓丸治疗有佳效。如刘氏报道，共治疗 98 例，痊愈 71 例，显效 19 例，有效 6 例，无效 2 例，总有效率达 97．96%。

吴氏曰：曾有人问：为什么子宫肌瘤用桂枝茯苓丸治疗没有效果？我说子宫肌瘤是肿瘤，是痰瘀互结，其背后是脏腑阴阳气血逆乱，一定要去恢复其脏腑阴阳气血。怎么去恢复呢？这个属于后面“阴阳易”章节中讲的“重阴”，雌激素水平高了，就需要对抗她的雌激素。重阴纠正后，子宫肌瘤就小了，这与西医用三苯氧胺治疗子宫肌瘤的原理是一样的。但是我们的办法和西医还不一样，我们通过内源性阻断，治疗的办法很多，不仅仅是桂枝茯苓丸、桃核承气汤。

【麻黄附子细辛汤合桂枝茯苓丸治多囊卵巢综合证一例】

张某，女，20 岁。闭经一年，身体日渐肥胖，体毛增多，于当地妇幼保健院检查诊断为多囊卵巢综合征，性激素六项显示睾酮、垂体催乳素水平高，B 超显示双侧卵巢数十个囊状回声。

一诊：患者自述曾于经期吃过冰淇淋，自此以后便停经，身体开始肥胖，食欲亢盛。仔细问询，无其它异常，无口干口渴口苦，二便正常，手足自温，不凉不热，睡眠可，偶有多梦。查其皮肤干燥甲错，无汗，自述闭经后再无出汗，即使剧烈运动也很少出汗，舌质淡紫舌苔水滑，脉弦滑。方用麻黄细辛附子汤合桂枝茯苓丸，十付。

二诊：用药后无变化，月经未至，嘱继续服药十付。期间患者母亲动摇，寄希望于手术治疗。

三诊：仍未有起色，劝说继续服药，十付。此次，十付药未服完，患者微信告知阴道流出酱油色液体若干，询问是否是月经。嘱不须停药，继续服用。

此后一直守方服用，又过月余，月经如期而至，色量俱可。嘱继续服用，患者以工作为由停药，前后共服药 50 余剂。自此后月经每月都来，偶有拖后，但大致正常。一年以后复查，性激素六项基本正常，B 超亦显示无多囊卵巢。

本例患者追溯病史很重要，经期受凉是导致闭经的直接原因，用药须温阳通经，经闭日久必有瘀血留著，舌紫和肌肤甲错也提示血瘀，故选用桂枝茯苓丸。选用麻黄细辛附子汤，是考虑到本方既能发汗通经又能温里逐寒。多囊卵巢综合征是妇科常见病、疑难病，西医目前仍无可靠有效的治疗方案，常规治疗口服避孕药、促排卵药、激素疗效不理想，手术打孔容易复发、损伤卵巢。而中医通过辨证论治，治疗本病可收到意想不到的效果，副作用少，安全可靠。

【薏苡附子败酱散治卵巢囊肿白带增多医案】于慎中：

马某，女，39 岁，1990 年 12 月 2 日初诊。主诉右下腹肿块，小腹坠痛 2 月余。患者曾有慢性盆腔炎病史，近 2 年来小腹部胀痛，月经前期腰酸，经期延长，白带增多。今年 9 月发现右侧下腹部有拳头大小肿物，伴隐痛，下坠感，按压轻痛，近一个月阴道出血 2 次，量少，有血块，小腹坠痛加重。

在我院妇科检查：下腹部轻压痛，右下腹部可触及 9×7 厘米大小的肿物，活动差，质软，表面光滑，轻压痛。B 超检查示，右侧卵巢区域，可见 10×7 厘米大小的液性回声反射区域，边界清，明显壁包膜。临床诊断为右侧卵巢囊肿，慢性盆腔炎。建议消炎治疗后手术切除囊肿，患者不愿手术，遂转中医治疗。患者面白少泽，身倦乏力，胃纳不佳，小腹坠胀，疼痛，喜暖畏凉，白带多，清稀，小便清，大便正常，腹部濡软，舌质淡，苔白薄腻，脉沉紧。处方：淡附片 12 克，薏苡仁 30 克，败酱草 15 克，

上方服 6 剂后，小腹坠胀明显减轻，白带量减少，胃纳好转。继服上方 12 剂，12 月 24 日妇科复查，右下腹肿块缩小，大小约 6×4 厘米，质软，压痛不明显，原方再服 18 剂。妇科检查：右下腹肿块消失，B 超复查未见异常，随访至今未见复发。(山西中医)

注家按语：本案脉证所现，为寒湿郁遏，气血郁滞之象。由于营血郁滞，渐成包块，治宜温阳散寒，利湿开结，薏苡附子败酱散为的对之方，改散作汤，则其效更速。

罗按：“右下腹肿块，小腹坠”可对应上边条文的“腹皮急”，“如肿状”对应了。那么，对应的地方是：腹皮急，如肿状。所以用薏苡附子败酱汤治。但也有白带增多等诸情况，所以要把握主证，若是当白带治，就白费劲了。

【癥瘕结于上脘医案】张锡纯：

一妇人，年二十余。癥瘕结于上脘，其大如橘，按之甚硬，时时上攻作疼，妨碍饮食。医者皆以为不可消。后愚诊视，治以此汤，连服四十余剂，消无芥蒂。

【六十年代当我用一个方子消掉了患者多年的子宫肌瘤】

我突然明白：手起刀落只是开始并不是结束。中药消肌瘤，不做手术胜似手术！上世纪六十年代，我刚从学校出来就踏入下乡插队的大军，站在毛主席的雕像下庄严宣誓“接受贫下中农再教育，扎根农村干革命”。但是现实和理想之间往往是有天大的差距的，别说大有作为了，下乡插队的条件艰苦，有时候连吃饭都成了问题。当时正逢水稻收割的大忙季节，队长安排我们同刚开始参加农田劳动、仅拿两三分工分一天的少年儿童去收拾遗掉在地上的稻穗。二十来岁的毛后生，竟同一群十三四岁的孩子们一起干些田头的零碎农活，使我感到十分自卑和惭愧。

后来队里没办法了让我们学医的给村民看病挣工分，不会看病的去巡山护林，这已经是对我们很大的照顾了。为此队里让我专门搬到村子里一个已经年纪 70 多岁的老药师家里去住，这样取药看病都方便，老药师家里也没啥，就是一间上面只有几片青瓦的小房子。

老药师不善言辞，不经常说话。隔三差五的还要出山去给采药，一去就是好几天，就留我在家里给人看病。有天也是他出门采药不在家，来了一位妇女体型比较瘦。

年纪轻轻的也就三十岁，因为流产而检查的时候发现有子宫肌瘤，在大夫的建议下做了手术切除。不曾想也就手术后几个月的时间，因为腹部疼痛检查又发现多个子宫肌瘤最大的直径有 8 厘米多，光直径 7 厘米的就有两个。就这情况她自己当时也是吓的不轻，医院给出

的建议是将整个子宫切掉，这样可以以绝后患。这样是解决问题了，但是根本没有考虑患者的感受，她还没有孩子，年纪轻轻的就将子宫全部切除，这对她的打击无疑是晴天霹雳的。

百般纠结之后她决定试试中医。听完她的哭诉。根据她的实际情况给她开了一副方子。

方：醋三棱，丹参，桂枝，陈皮，山药，络石藤，黄芪，炒鸡内金，醋莪术，威灵仙，瞿麦，茯苓，醋延胡索，穿破石。这副方子她用了有半月左右的时间，她的腹痛的情况首先就减轻了，精神也比之前好了很多。继续将方量做调整，服用二十多天的时间正好赶上她的月经来潮，排下不少的瘀状血块。但是整个人明显的感觉轻松了。

经过长达三个多月治疗，将她的肌瘤全部消除。我记得她当时来感谢我时笑的就开心的像个孩子，但是眼睛里却满是泪水。那一刻我突然感觉作为的一个大夫真正的意义所在，即使过去了这么多年我依然历历在目。老大夫也对我是赞赏有加，从此我便踏入了中医之门。

行医这么多年，这副药到底有何神奇之处呢？首先是因为流产后来又因为手术，使得本来就不充盈的气血，越发匮乏，气血虚弱这是必然的；

另外再加上手术所致瘀血滞留阻滞气血运行,子宫乃女性血气变化最为敏锐的器官之一，久而久之局部瘀血积少成多而成肌瘤；说白了肌瘤的形成与手术有着很大的关系。

最后舌头胖大瘀紫有齿痕，中有裂纹，舌苔白厚微腻，脉象虚弱，乃寒湿瘀阻之象。所以在治疗上就要破於消滞，补气活血，祛湿温阳。

1、破於消滞一瞿麦、三棱、莪术、络石藤、穿破石

大剂量的瞿麦宜不仅可以治疗妇科肌瘤,还对泌尿系囊肿和肝囊肿有着良好的治疗效果；三棱、莪术、络石藤、穿破石他们就像利剑直达子宫肌瘤的病所，能化肌瘤破淤积；

2、补气活血一黄芪、延胡索、水蛭、鸡内金、丹参

水蛭、鸡内金、丹参相配有着强大的活血化瘀之效。尤其是虫类药钻剔经络以疏通癥瘕内部气血运行、化瘀消癥。延胡索疏肝理气。

3、祛湿温阳一威仙灵、茯苓、陈皮、山药、桂枝

威灵仙具有强大的祛风湿、通经络、消骨梗之功效，所谓人中吕布，马中赤兔，药中威仙灵。桂枝可以温通经络温阳，将体内的寒气赶出体外。茯苓利水燥湿；陈皮，山药健脾。

其实行医这么多年，所谓的肌瘤息肉等等不过就是体内的瘀血，毒素，精微等流通不畅而发生的积聚，它既不属于变异，也不输于外来物种。一次次的切除手术看似很完美，但是它的根重新长上来只是时间问题。这个方子这样说出来，你听起来很简单，但是这要是没有个几十年的行医功底，也很难开出来，因为中医用药的量很关键。

我这样说，并不是我有多厉害，而是现在的中医很难，偌大一个县城根本找不到几个有真才实学的中医。但是不少的只有二两功夫的人却冒充中医，中医的发展举步维艰，像我们院已经有不少的老大夫逝去了，但是这些空缺的位置根本补不上来。去社会上找，根本找不到，而中医大学毕业的，只会背几条理论，差的很远。那时候的人学中医心中装的是患者是天下，现在的人学中医心中却装的是票子。

不是患者觉得中医不科学，而是中医人变得不科学了。我现在虽然是老头一个，但是在这小县城里我依然要用心看好每个病人，我下过乡，挨过饿受过批斗，我知道无药可医的真实滋味，不是一两句话就可以说清楚的。

【薏苡仁能促使孕妇流产的理由卵巢囊肿子宫肌瘤医案】矢数道明

薏苡仁的作用中包括治筋急拘挛，就是说能治好肌肉痉挛。妊娠子宫的肌肉具有保护胎儿作用此时若使肌肉松弛，可能就会容易引起流产另外，最近的研究表明，薏苡仁有抑制肿瘤作用；可能其成分中有某些特殊物质因而服用上应当慎重。前述的庄氏也认为鸠麦有抑制异常发育的作用，因而当子宫中有异物时，恐怕也要加以逐出的。这种有制癌作用的薏苡仁，很早就周知是除疣的妙药，它可将疣这类坚硬的异物，加以软化后除掉，故而可以想象，可能对胎儿也是不利的。

至少可以肯定，对于虚证体质、松弛性体质，有冷症、有习惯性流产的孕妇，似应在服用薏苡仁上，加以慎重考虑为宜。不过，笔者本人却没有遇到过服用薏苡仁后引起流产，或孕妇服用其它妊娠禁忌药物而导致流产的实例。在日本东洋医学会讲演时，笔者曾补充了如下一些内容：

《金匮》中的桂枝茯苓丸可用于有子宫肌瘤而怀孕并有出血的孕妇，而桂枝茯苓丸处方中却含有妊娠禁忌药桃仁、牡丹皮。这就是说，与有病时，这些禁忌药仍是可以用的另外，笔者曾遇到一次极端特殊的事例，似却是本人的实际经验事情发生在战前笔者刚入门汉方的第 2 年，正处干无所畏惧的青年时代。

他的小学同学之夫人体质较弱，相当于当归芍药散证婚后不久就怀了孕在妊娠 5 个月时右下腹突然发生剧痛，可触及肿块开始曾怀疑阑尾炎而投给大黄牡丹汤，但第 2 天腹部胀大，如同要分娩时大小，疼痛进一步加剧，第 3 天疼痛突然停止，但触诊可触及临盆时胎儿大小的硬块。原来患者是右侧卵巢囊肿，因子宫的不断发育而引起茎部突然捻转，血液只进不出，囊肿乃逐渐胀大造成剧痛第 3 天囊肿茎因捻转绞紧而自然断裂，疼痛虽失，肿胀依旧，因为其中充满出血之故因当时友人家境贫寒，无力住院作手术，要求继续用汉方治疗，乃投给抵当丸每次 30 粒 1 日 3 次。服后连续 3 天由肛门排血数次，腹部肿胀全消，卵巢囊肿也缩小到手掌大小。其后，经多方设法，终于作手术，发现肿中充满毛发、骨牙等物质，看来这些是抵当丸也无法消除的了。手术后，妊娠仍正常进展，足月后生一男婴：以后又生过两胎。抵当丸处方中有所谓孕妇禁忌的水蛭、芒虫、蛰虫、大黄等药味，但服用后只打下了腹中淤血，并未引起随胎对这种人类的生命力、自然之力的如此强韧不折、实在令人惊奇不已。如果半夏可以造成流产的话、那么妊娠恶阻时，就不可能使用小半夏加茯苓汤进行治疗了。

【少腹逐瘀汤加味治子宫肌瘤医案案例】

子宫肌瘤之治，桂枝茯苓丸之外，少腹逐瘀汤也是的对之方，且举一案：张某，女，38 岁。因患子宫肌瘤两年就诊。于两年前体检 B 超发现子宫前壁 2CMX2，25CM 两个肿物，诊为子宫肌瘤。平素月经时，小腹隐痛，经期时间长，持续 10 天左右。头晕，四肢乏力，饮食二便正常。舌体瘦，舌苔薄白，脉细弱。辨为气虚血瘀，少腹逐瘀汤加味。处方：小茴香、干姜、元胡、灵脂、没药、川芎、当归、赤芍、莪术各 10，生蒲黄、肉桂各 8 克，党参黄芪各 15。每日一剂，两月后复查子宫 B 超，子宫肌瘤消失，月经正常。（朱东晨）审之，此案乃系少腹逐瘀汤原方加参芪莪术也，加参芪者，以病者现头晕，四肢乏力脉弱诸气虚见证，因方中有姜桂茴，似更适于气虚而偏寒者，本病之治，有多种类型，临症不可执其一端。尤宜注意者,肌瘤变性坏死感染时，可有湿热见证，当于少腹逐瘀汤中减姜桂量并增清热除湿药为宜。

【少腹逐瘀汤加味治治卵巢囊肿医案案例】

药方组成：小茴香 6g，干姜 6g，延胡索 15g，当归 20g，川芎 10g，官桂 3g，赤芍 10g，蒲黄 10g，炒五灵脂 10g，香附 12g，乌药 10g。制剂用法：上方每日 1 剂，水煎成 400mi，分 2 次温服，月经期不停药。

适应病证：大部分患者感腰骶部疼痛不适，月经先后无定期，部分病人有痛经史，个别患者诉性交时下腹部胀痛，全部病例均经妇科检查及 B 超提示为卵巢巧克力囊肿。应用上方时应注意：原方加入香附、乌药二味意在增强活血化瘀之效果。

【当归四逆汤治腰痛小肚子痛冰凉冰凉医案】刘渡舟：

我在余家庄看过一个妇女，小肚子疼得很严重，怎么得的？就是劳动的时候，出了一身汗，解个小便，正赶上例假的时候，风也大，她就觉得小肚子冰凉冰凉的，肚子疼，腰也疼，吃了小茴香、益母草以后好一点儿，但不解决问题，脉细，还有点儿弦。我就给她开了当归四逆汤。

你可不要轻看，这里面有细辛，细辛通经活络止疼的效果是很好的。她吃了几付就好了。

下部受寒和肝脉有关，女性小腹疼痛，男性小腹疼痛或疝气牵扯睾丸的，用这个方子都有效，因为它既能补血，又能温通经络。当归四逆汤还治头疼，因为厥阴肝经和督脉会于巅顶，血虚有寒也会头疼，尤其连着眼睛目眶都疼，脉弦而细，舌质淡。还能治痹证，血虚有寒的关节疼痛、全身疼痛，当归四逆汤效果是很好的。

【抵当丸卵巢囊肿破裂医案】矢数道明：

26 岁妇女。妊娠 4 个月。主诉某日右下腹突发剧烈疼痛，痛若碾转不安，右回盲部可触及鸡卵大肿块。与大黄牡丹皮汤，但次日自觉渐渐腹满，右下腹部肿块肿大显著，达到似小儿头大，当时在痛苦之后，突然疼痛消失。此者，右下腹部肿块，即卵巢囊肿与妊娠子宫增大同时引起蒂扭转与肿胀。因而发生了剧烈疼痛，一昼夜达到极点，终于发生破裂疼痛方消失。下腹部肿物破裂，出血自然充满。对此，与抵当丸，日下黑便数次，数日后下腹瘀血已消，肿块恢复原形。劝其入院手术果然有囊肿，剖开其中有毛发、齿质而堵塞不通。此者，即使是抵当汤也无济于事。目前，子宫肌瘤和卵巢囊肿多数用抵当丸，但已触及下腹肿瘤者，几乎无什么效果。此妇人是笔者友人之妻，此症发生余学习中医三年时之事，当时还未生育。君妻以后生 3 个孩子。（作者治验）《汉方临床应用解说》

【下瘀血汤抵当治女性小腹积块汤案】翟书庆：

李某，女，23 岁。1976 年秋初诊，该患者素性乖张，闻逆耳之言，遂悲伤闷郁，久不得其解，健壮之体，日渐羸瘦。一日突发寒热，脘腹胀满而痛，诊为腹膜炎。经用抗生素，补液消炎等法治疗，热退痛止，逾月出院调养。孰料不及一周，前症又作。见其面色黄晦，弯腰抱腹，步履艰难，骨瘦如柴，语言低怯，周身乏力。自诉：腹胀，少腹见有拳大包块，质不硬，推之不移动，触按则痛甚，月事半载不潮，二便正常。舌质淡黯，苔黄腻，脉沉涩。系情志久郁，失于调理，气病及血，结于少腹，月信当行不行，腹部安有不胀不痛。故病在胞宫，气血凝结，延成癥积之候。“大实有羸状”。破血通经乃应急之策，使邪去正安。遂用下瘀血汤、抵当汤加味：大黄（后下）12 克，䗪虫 9 克，桃仁 12 克，水蛭、虻虫各 6 克，三棱、文术各 3 克。煎服两贴。药后腹痛，遂泻下数次，胃腹觉舒和，饮食增加，但月事仍未来潮。此非药不中病，乃病重药轻之故。改服大黄䗪虫丸料变汤剂两帖，但服药后，症情如初。窃思之，“癥积”之疾，非成于一旦，偿若正气壮盛，推血畅行，何致如此？况病程既久，正气定不足以协药祛邪，正如《本草经疏》人参条下言之：“……通血脉者，血不自行，气壮则行……”。

因此，原立法一味攻破，无补气之药统领，攻药何以到达病所，抵积不行？乃于首剂方中加大攻破药之用量，增入党参一味，激动阳气。拟方：

大黄（后下）15 克，䗪虫 12 克，桃仁 15 克，水蛭、虻虫、三棱、文术各 9 克，党参 30 克。卑量大攻专，驱邪而不伤正。果一剂药后少腹剧痛，随见月经来潮，再剂下瘀血数块，腹痛之症若失，饮食大增，精神转佳。继用攻补兼施法调理以荡其余邪，还原正气，面色日渐红润。末用十全大补汤加减调补旬日而愈。可见虚不任补，而在补药之中杂以消导，实不耐攻，而在破药之中稍加补益，常可收到意外的疗效。《当代医家论经方》

【抵当汤治少腹疼痛而拒按女性脐下积块医案】：

邝某，女，32 岁。广东台山荻海人。患者于 1936 年 3 月起月经停止两个月，即觉腰部酸痛而紧，少腹疼痛而拒按，动则更甚，脐下周围一硬块如柚大，推之不移、腹部胀满，青筋显露，病起之后胃纳呆减，大便秘结、小便黄赤。诊其脉沉涩而实，两尺尤甚，舌尖红而苔黄厚，此经停蓄血之证也。拟活血攻瘀。用抵当汤加减：当归 30 克，生大黄 24 克，桃仁 30 克，制虻虫 15 克，制水蛭 15 克，嘱其连服二帖。

二诊，服前药后，大便溏泻。泻后腰腹痛皆减，腹胀稍减，小便黄，脉象如前，照前方将大黄增至 30 克，嘱服二帖。

三诊，服药后排出瘀血一痰盂，腹胀大减，腰腹畅通，脐下癥块略为缩小，腹部青筋隐

而不张，已无拒按感。脉沉涩而无实象，邪去大半，防其正气受伤，拟前方加党参 30 克，嘱服二帖。

四诊，服上药后，大便继续排出瘀血。腹胀全消，脐下癥块已不能触及，唯胃口欠佳，精神较差，脉象沉微无力，舌质淡白无苔。以益气健胃善后。处方：

党参、黄芪各 30 克，茯神 15 克，炙甘草 6 克，砂仁 6 克，陈皮 3 克，当归 15 克，丁香 3 克，嘱连服十帖。

五诊脉象沉微有力，诸症霍然，但工作时间过长则显头晕眼花，精神欠佳。再拟十全大补汤加减，嘱其间隔 2~3 天服一帖，经服二十帖后月经恢复正常，面色红润，肌肉饱满，悉如常人。（《广东中医》）

【抵当汤治瘀血少腹肿胀医案】刘景琪：

栾某，48 岁，女，工人，1982 年 7 月 20 日就诊。少腹胀，全身浮肿已一月。尿时尿道有发热疼痛感，但小便通畅，化验无异常发现，全身浮肿，憋胀，夜卧不宁，不能坚持工作，曾服中药八正散等二十余剂无效。心腹部有压痛，烦躁，健忘，易怒。脉滑，舌胖苔白。辨证：膀胱蓄血，气化不利。治则：破血逐瘀。处方：大黄 9 克桃仁 9 克水蛭 9 克蛇虫 8 个去翅足，三剂，水煎服，服药后大便稀，色黑，日 3~4 次，三剂服完后全身浮肿憋胀消失，少腹硬痛消失。《经方验》

论：小腹胀满，但小便通畅，此为瘀血之胀满。烦燥，健忘，易怒，是瘀血之证。为什么会浮肿？

【附子汤治子宫肌瘤案】：

张女士，38 岁，月经两月未至，小腹疼痛，阴道有轻微流血，色淡量少。头晕恶心，纳差食减，检查为子宫肌瘤。患者面色青暗，恶寒倦卧，四肢冰冷，小便清长，大便稀薄。观其舌苔，舌质青，舌苔薄白。触诊发现小腹有一拳头大块物，疼痛拒按，推之不移。

综合辨证为阳虚寒凝、气滞血瘀而闭经，经闭日久，酿成症瘕。开方附子、人参、茯苓、白术、白芍、当归，用药两天，全身逐渐温暖，头晕恶心亦减，腹痛微减。用药 15 天，头晕恶心减轻，饮食正常，舌质转为淡红。用药 30 天，腹痛轻微，月经恢复。用药 2 月后，腹部疼痛和肿物消失，复查彩超发现子宫肌瘤已消失，遂停药。

【少腹逐瘀汤治疗治疗子宫肌瘤医案】

方用少腹逐瘀汤加减，药用：小茴 10g，川芎 12g，当归 15g，没药 12g(醋制) 玄胡 15g(醋制) 干姜 10g 肉桂 5g，赤芍 10g，蒲黄 12g(包煎) 五灵脂 10g。辨证加减，气虚者加党参 15g，白术 12g；少腹灼热者去干姜，肉桂加黄柏 15g，丹皮 12g，败酱草 15g；少腹冷痛甚者加附子 10g(先煎)；积块较大者加牡蛎 30g，鳖甲 15g(醋制)。气滞者加香附 15g，台乌 12g。煎服方法：取上药加水 500ml 浸泡 5-10min，武火煎沸后，文火再煎 30min，每次煎取 150ml，每日三次，适寒温服。每日一剂，一月为一疗程。治愈 30 例，有效 3 例，无效 4 例，有效率 89.2% 。

【血府逐瘀汤加减治疗行气解郁治经闭多囊卵巢综合征】

吴某，女，21 岁，农民。1992 年 1 月就诊。14 岁初见经水，一年后经行无定期，且血量极少，一日即止。1989 年 2 月迄今，月经停潮，形体日胖，郁郁寡欢，烦躁易怒。3 年内体重由 50kg 增至 75kg，且腹部隆起，两乳高突，昔日所穿之衣物尽显瘦小而不能着身。曾以黄体酮治之，不为所动，复求治于省会某大医院，诊为多囊卵巢综合征，遂告其母：待字闺中，适时行手术治疗。家人甚为忧虑，其女亦“自惭形秽”而羞于见人。详察其候：舌质紫暗、苔薄白，脉弦涩，乳晕色素颇深。《内经》云：“心主血脉”，“肝藏血”，“脾统血”。可见血证总以心、肝、脾三脏为主，而于血证之属实者则明言“血实宜决之”。故以行气解郁，活血通经为治也。柴胡、当归、生地、川芎、丹皮、醋香附、瞿麦、川牛膝各 15g，醋白芍、水蛭各 18g，桃仁、红花、桔梗各 10g，茯苓 20g，土白术、穿山甲、郁金各 12g。水煎，日 3 夜 1 服。10 剂后，腹部平平，

乳房不隆,体重降至60kg,连投12剂,乳晕色素正常,侃侃而谈,喜形于色。遵上方,加黄芪30g,以3剂量,末之,日3服,每次4～5g,开水送下。一月后,经水至,色如墨汁,杂见血块,历四日而止。半年后随访,体重52kg,经行正常。按:肝为刚脏,性喜条达而恶抑郁。柴胡、香附疏肝理气而畅气机;郁金行气活血而利通道;四物汤养血滋阴而固冲任;桃仁、红花、穿山甲活血祛瘀而为诸药之前锋;水蛭乃血肉之躯,且嗜血成性,为血药中之剽悍勇猛之将,四力并行,则攻城掠地而战无不胜也;脾为后天之本,生血之源,土白术、茯苓甘缓以补中,淡渗以除湿,意在顾护中州之土也;血不利则为水,瞿麦入心肾,破血而通经,且有清热利尿作用,血瘀而久必有郁热,热邪从膀胱而出,亦《内经》“洁净府”之义也;桂枝辛温,化阳而通经脉,丹皮苦寒,破血而消症结,一辛一苦,一温一寒,相辅而力增,相成而功卓;川牛膝一则壮腰健肾而培先天,一则引药下行而达卵巢,一身而二任焉。《孙子兵法》曰:“胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者,形也。”诚哉斯言。医者自当于孙子之言悟出辨证论治之真谛也。

【多发子宫肌瘤右侧附件囊肿盆腔积液医案】微信网文:

中医的癥瘕包括了西医学所认为的子宫肌瘤、附件囊肿、卵巢囊肿、盆腔的炎性包块、子宫内膜异位症、子宫内膜异位症结节性包块、盆腔结核性包块以及陈旧性宫外孕血肿,宫颈囊肿等等。

王某，女，37岁，5月8日初诊。主诉:小腹胀痛半年余，伴经期延长，加重2月。

现病史:患者自述小腹胀痛半年余，每至经期加重，月经量多，经期延长，有时经期延长9～10天，有时经期延后12天～14天才干净。近2月疼痛加重，医院B超检查，提示子宫有多个低回声光团，其中较大的一个为4.5cm×3.6cm×2.3cm低回声光团，右侧附件区见2.6cm×1.8cm的无回声团，盆腔见液性暗区，范围约2.5cm×1.6cm，西医诊断：多发子宫肌瘤，右侧附件囊肿，盆腔积液。由于患者不愿意做手术，曾经中西药物治疗，效果不显著。听朋友说她自己就是子宫肌瘤手术治疗后1年左右又复发了，后来吃中药好的，更加坚定不做手术的决心，经朋友介绍到我处就诊。症见:小腹胀痛，经期延后，月经量多，色紫暗有块，胸胁乳房胀痛，面色晦暗，大便时干时稀，舌质暗，边有瘀点，苔薄白，脉弦涩。

西医诊断:子宫肌瘤，附件囊肿，盆腔积液。

中医诊断:癥瘕。

辨证：肝郁气滞，痰瘀互结。

治法：疏肝理气，化痰软坚，化瘀消癥。

拟方:柴胡10克、当归10克、香附10克、川芎10克、桃仁10克、茯苓15克、青皮10克、法半夏15克、生牡蛎30克、桂枝10克、陈皮15克、丹参30克、三棱10克、莪术10克、浙贝母15克、醋鳖甲30克、丹皮10克、赤芍10克、胆南星10克、白芥子10克、水蛭6克，延胡索10克、甘草10克。7剂水煎服，日一剂，早中晚服用。

二诊:患者自述服用中药后，月经来潮，量多，有血块排出后腹痛随之减轻，说之前是月经有时经期延长9天左右才干净，有时经期延长12～13天，不知道这次月经会不会要这么长时间才干净。嘱咐患者经期来潮的前4天停药，第5天开始服用中药，处方如下:

黄芪30克，茜草炭10克，桔梗6克，白术15克，山萸肉15克，党参15克，煅龙骨20克，煅牡蛎20克，蒲黄炭10克，白芍10克，丹参15克，棕榈炭10克，仙鹤草15克，益母草15克，三七粉3克（冲），海螵蛸15克。3剂水煎服，日一剂，早中晚服用。

三诊:患者自述服用第2剂中药月经量就少了,喝第3剂中药已经就基本干净了,也就是说这次月经7天就干净了。腹痛、乳腺胀痛减轻，有腰酸，改方如下:

柴胡10克、当归10克、川芎10克、桃仁10克、茯苓15克、青皮10克、法半夏15克、生牡蛎30克、桂枝10克、陈皮15克、丹参30克、三棱10克、莪术10克、浙贝母15克、醋鳖甲30克、丹皮10克、赤芍10克、胆南星10克、白芥子10克、水蛭6克、小茴香6克、山慈菇10克、杜仲15克、黄芪30克。7剂水煎服，日一剂，早中晚服用。

四诊:患者自述服用中药后，乳房胀痛、腰酸等症状改善，有盆腔积液，改方如下:当归10克、川芎10克、桃仁10克、茯苓15克、青皮10克、法半夏15克、生牡蛎30克、桂枝10克、陈皮15克、丹参30克、三棱10克、莪术10克、浙贝母15克、醋鳖甲30克、丹皮10克、赤芍10克、胆南星10克、白芥子10克、水蛭6克、小茴香6克、山慈菇10克、黄芪30克、海藻15克、昆布15克、益母草15克、车前草15克。7剂水煎服，日一剂，早中晚服用。

五诊:患者自述服用中药后，各方面症状都好转，舌边的瘀点也少了很多，处方如下:

当归10克、川芎10克、桃仁10克、茯苓15克、青皮10克、法半夏15克、生牡蛎30克、桂枝10克、陈皮15克、丹参30克、三棱10克、莪术10克、浙贝母15克、醋鳖甲30克、丹皮10克、赤芍10克、胆南星10克、白芥子10克、水蛭6克、小茴香6克、山慈菇10克、黄芪30克、海藻15克、昆布15克、益母草15克、车前草15克。14剂水煎服，日一剂，早中晚服用。

六诊:患者自述服用中药后，月经来潮，各方面症状都好，这次月经量适中，6天就基本干净了，效不更方，原方继续14剂，日一剂，早中晚服用。

七诊:半个月后患者兴高采烈的对我说:张医生吃了你开的中药后感觉各方面症状都好，同事和朋友都说我脸上气色都变好了，去医院复查，子宫肌瘤和附件囊肿都变小了，盆腔积液没有了我现在非常有信心在您这里治疗，相信后面再吃一段时间的中药就会痊愈的。边说边递给我一张检查单，上面提示子宫肌瘤1.9cm×1.3cm×0.6cm,附件囊肿1.2×0.6cm,盆腔积液消失了。患者要求继续服用中药，守前方加减巩固服用近2个月后去复查，子宫肌瘤和附件囊肿消失而愈。

随访1年，一切正常，未复发。

【血府逐瘀汤治疗慢性子宫出血】:

方药:血府逐瘀汤加减:柴胡10g，桔梗10g，桃仁10g，红花10g，赤芍10g，枳壳10g，香附15g，牛膝15g，益母草15g，陈皮10g，党参30g，黄芪30g，当归15g，大枣15枚（捣烂）。每日1剂水煎服。患者每晚用暖水袋热敷小腹部，促进化瘀之效。服用3剂，诸症减轻，继服3剂后，间断出血，全身有力，可服人参归脾丸补养气血以固疗效。《素问?阴阳应象大论》曰“善诊者，察色按脉，先别阴阳，审清浊而知部分，视喘息，听声音而知所苦，观权衡规矩而知病所主，按尺寸，观浮沉滑涩而知病所生，以治无过，以诊则不失矣”，《景岳全书?妇人规》曰“崩淋之病，未有不由忧思郁怒，先损脾胃，次及冲任而然者”，祖国医学称此病为“崩漏”。忽然暴下谓之崩中；非时而下，淋漓不断，谓之漏下，两者可以互相转化，故崩漏并称。治疗原则，本着急则治其标，缓则治其本，采用塞流、澄源、复旧固本三法，根据情况，分别施治。其出血量不多，则重在澄源，瘀者行之，通因通用法治之，达到治愈疾病的目的。中医治病，重在辨证，分清阴阳、表里、寒热、虚实。

【少腹逐瘀汤加味治治疗慢性盆腔炎医案案例】

基本方:小茴香15g，炮姜15g，元胡25g，灵脂20g，没药10g，川芎15g，当归20g，蒲黄15g，肉桂15g，赤芍15g，桃仁15g，红花15g，三棱15g，莪术15g。湿热重，伴随急性炎症者，减炮姜、小茴香，加金银花30g，蒲公英30g，白花蛇舌草30g;脾虚加白术15g，黄芪20g;肾虚痛及腰骶，加川断20g，杜仲20g;闭经加益母草20g，红花20g，牛膝20g;盆腔积液及输卵管积水加白茅根30g，益母草30g;盆腔结缔组织炎加穿山甲20g，水蛭3g（研末吞服）。水煎服，日1剂。10天1个疗程，月经前10天治疗效果更佳。治愈105例，显效18例，好转17例，无效10例，治愈率70%，总有效率93.3%。

少腹逐瘀汤出自清代名医王清任《医林改错》，历经数代医家验用，具有活血祛瘀，温经止痛的作用，被誉为“调经种子第一方”。现代药理研究证明［2］:川芎、桃仁、红花、三棱、莪术等活血化瘀药等具有以下作用:（1）改善血液动力学，尤其穿山甲、水蛭、桃仁、

莪术、益母草具有扩张股动脉的作用。(2) 抑制组织异常增生，活血化瘀药能抑制胶原合成，促进分解，使增生变性的结缔组织转化，吸收。(3) 抑制炎症，活血化瘀药能扩张血管，加速血流，降低毛细血管通透性，改善局部组织的血液循环，减少炎性渗出和促进炎性渗出的吸收。(4) 调节免疫抗感染，桃仁、三棱、莪术等具有加强细胞免疫，促进淋巴母细胞转化，增加网状内皮系统功能及吞噬细胞的活力，具有类似免疫增强剂的作用。因此，对于西药治疗效果不理想的慢性盆腔炎，应用以活血化瘀药为主的少腹逐瘀汤治疗可迅速见效。

慢性盆腔炎是妇科常见病之一，常为急性盆腔炎未能彻底治疗或患者体质较差，病程拖延所致。由于多为混合感染，加之炎性渗出，粘连及结缔组织异常增生，应用抗生素往往效果不佳，且量大，副作用多。祖国医学认为此病因外感湿热邪毒，邪毒客于胞宫或阻于胞脉，影响冲任气血运行，气血瘀滞而致[3]。应用少腹逐瘀汤加减治疗本病既符合现代药理学理论，又符合中医治病求本的原则。治疗中我们体会到病程较短者较易治愈，病程长者治愈速度较慢。对于已形成慢性盆腔结缔组织炎，甚至冰冻骨盆患者，该治疗方法更具疗效。

【癥瘕起于少腹医案】张锡纯：

一妇人，年三十余。癥瘕起于少腹，渐长而上。其当年长者稍软，隔年即硬如石。七年之间，上至心口，旁塞两肋，饮食减少，时觉昏愦，剧时昏睡一昼夜，不饮不食，屡次服药竟分毫无效。后愚为诊视，脉虽虚弱，至数不数，许为治愈，授以此方。病患自揣其病，断无可治之理，竟置不服。次年病益进，昏睡四日不醒。愚用药救醒之，遂恳切告之曰：去岁若用愚方，病愈已久，何至危困若斯。然此病尚可为，甚勿再迟延也，仍为开前方。病患喜，信愚言，连服三十余剂，磊块皆消。惟最初所结之病根，大如核桃之巨者尚在。又加生水蛭（不宜炙）一钱，服数剂全愈。

【温经汤治子宫肌瘤，乳腺增生，甲状腺亢进癖医案】楞青社：

患者是挚友之妻，庚子年，41 岁。患者因常年工作压力大，常熬夜，所以体质比较虚弱，以前也常问我拿药吃。后来我们生活在不同城市，只能远距离指导她用药。

患者在庚子年中单位集体体检，被告知是乳腺癌的临界，病情危急，建议最好到大医院治疗。随后便来电咨询我的意见，我建议她去找当地最有名的中医师治疗。名医开了逍遥散加牡蛎等疏肝散结之品，用药一周后乳腺增生变大且痛，两腹股沟也长两肿块，心情焦急，便来电咨询我的意见。

刻下主诉：乳腺增生肿痛，两腹股沟新长两肿块且有疼痛感、口干渴、嘴唇干、手心热、暮发潮热、心烦、大便软、小便正常、睡眠差。其人瘦，眼微突，脸色白带淡黄夹青色。舌质淡红苔薄白。

听完上述症状后我以唇干，手心热，暮发潮热为主证，建议她试用温经汤一剂，若有效再续后服，若无效再另作打算。不料一剂疼痛减轻，三剂后腹股沟肿块消失。按此思路治疗半年（中间有用建中，真武，理中等），乳腺增生变小并脱离危险状态。

【活血祛瘀消症瘕】

李某，女，31 岁，教师。12 岁信水初潮，每月应期而至，25 岁结婚，两年后生一女婴。嗣后月经紊乱，或错前五、七日，或愆期十余天，进而经水量大，甚则淋漓不断，其色深黑，伴见血块，不时少腹隐痛。曾屡服安络血、维生素 K3 等，唯可取效于一时，继而依然。1990 年 6 月 18 日就诊：面色萎黄不华，气短乏力，舌质暗，苔薄而少，脉沉细而涩。少腹部可触及一核桃大之硬块，压痛明显，系症瘕无疑。复以 B 超印证：子宫内有一 3.8×2.6cm 之肌瘤。病理活检为良性肿物。冰冻三尺，非一日之寒。急攻之则劳而伤财，缓图之则事半而功倍，故以活血祛瘀，消症散结为法。方拟：黄芪 30g，当归、赤芍、川芎、五灵脂、蒲黄、玄参、川牛膝各 15g，生地 12g，柴胡、桃仁、红花各 10g，桂枝 6g，甘草 5g。长流水煎服，每次 250ml，日 3 服，连投 60 剂。同年 10 月 21 日再诊：面色红润，气平音和，舌质略红、苔薄白，

脉缓有力。触按少腹未见肿块。B超复查：宫内未见异常。患者自述，九月迄今，经行二次，应期而至，食欲有增，体态丰盈，诸症悉除。按：桃红四物汤活血瘀而独领风骚;肝藏血而主疏泄，柴胡乃治肝之要药，既可疏肝理气以畅气机，又可开郁通道而为血之运行推波助澜;五灵脂、蒲黄活血以止痛，散结以消症，因其功效卓奇而有“失笑散”之美名;津血同源，血病日久必累及阴津,故以善治恶疮之元参滋液而化坚;桂枝温经通阳而入血分,为大军之轻骑,虽不事声张而有斩关夺隘之能;川牛膝不仅壮腰健肾而补先天，且引药下行直达血海，使诸药并力攻邪以捣敌穴;甘草，味甘可助黄芪以补元气，性平，可调和诸药，使峻历者无伤正之弊，平和者无缓滞之忧;阴血既亏，正气亦虚，于大队活血祛瘀之品中加黄芪以扶正，犹如重兵压境，两军对垒，粮草充足者自无后顾之忧而能一鼓作气，决战决胜也;取长流水者,在于借其历经坎坷，劈山造路，来势峻猛而锐不可挡之意也。

【大黄牡丹汤治小腹疼痛带下量多输卵管囊性肿块医案】刘芳贵：

李某，女，36岁，干部。1991年9月8日初诊。主诉：小腹疼痛半年，左下腹肿块3月余。患者小腹刺痛且胀，月经40～50天一潮，血量中等，小血块较多。3月前发现左侧有核桃大肿块，局部有轻微压痛。伴见：带下量多，色黄白相兼，质粘稠，有臭味。阴部时有瘙痒，腰部刺痛且胀，身热口渴，尿少色黄，大便干结，舌红，苔黄腻，脉滑数。妇检：左侧输卵管处可触及3×3平方厘米的肿块，质稍硬，压痛明显。B超检查：见左侧输卵管处有3×4平方厘米的囊性肿块，中间有液平面，诊为：“左侧包块型附件炎”。证属：湿热蕴结，气血瘀滞之癥瘕。治以清热利湿，破瘀消癥。方用大黄牡丹皮汤加味。处方：炒大黄10克，丹皮20克，桃仁15克，冬瓜仁20克，芒硝12克(冲服)，败酱草30克，苡仁30克，甲珠10克，莪术10克。守方加减1月病瘥。(云南中医杂志1993；(4)：25)

【葛根汤合桂枝茯苓丸治脸上麻鹊斑囊肿和肌瘤】蔡长福：

一个中年妇女，三十几岁，这个人白白的皮肤，很漂亮，雪白的皮肤，偏胖，一身胖肉，肚子大，可是脸上不好看，脸上一脸的麻鹊斑，乌云密布连在一起，来看病。看什么病的呢？患者回答说，我有囊肿和肌瘤。我搭脉：阳明脉浮长，问诊，吃饭也行，就是肚子胀，身上没劲，身体重，我看这个样子，必然身上重。我问这个肌瘤囊肿有多久了，患者说，一年多了吧。没治好。根据她的脉象，细长细软无力。体质很虚，当时我就根据她的脸，根据她的脉象，我就辨她有葛根证。肌瘤与囊肿怎么治疗呢？我加上桂枝茯苓丸，加上麻杏石甘汤，麻杏苡甘汤，半个月以后，这个病人体质突然一变，体重减少了十几斤，脸上麻点先是发黑，然后起白皮，最后暗淡，然后就少了下去。一个半月后，身材大为变好，医院检查，肌瘤囊肿都没有了。体质也瘦掉了。这个人从那么胖变为那么苗条，为什么你用这个几个方子？大家想一想，葛根汤走表，走于面部，麻杏石甘汤，麻杏苡甘汤是不是消皮中之水啊？麻杏石甘汤是不是清肺中之热啊？一个半月，这个人就瘦了，下半个月，我用小建中汤，吃了半个月。小建中汤吃了一个月到一个半月，这个病完全治愈了。面色大变，脸上黑斑全都消失，身材苗条，发肿发胖全都正常。这种病人，怎想起来用这个方子呢？这个病人是皮中有水啊，麻杏苡甘汤消皮中之水，麻杏石甘汤清肺中之热。葛根汤解阳明之表，三方合一，里外同治。桂枝茯苓丸，消水消淤。所以脸色大变，摸摸脉，还有体质虚，所以建中汤用上，肌瘤囊肿全部消失。这是一个医案。

【附子汤治子宫肌瘤案】：

张女士，38岁，月经两月未至，小腹疼痛，阴道有轻微流血，色淡量少。头晕恶心，纳差食减，检查为子宫肌瘤。患者面色青暗，恶寒倦卧，四肢冰冷，小便清长，大便稀薄。观其舌苔，舌质青，舌苔薄白。触诊发现小腹有一拳头大块物，疼痛拒按，推之不移。

综合辩证为阳虚寒凝、气滞血瘀而闭经，经闭日久，酿成症瘕。开方附子、人参、茯苓、白术、白芍、当归，用药两天，全身逐渐温暖，头晕恶心亦减，腹痛微减。用药15天，头晕恶心减轻，饮食正常，舌质转为淡红。用药30天，腹痛轻微，月经恢复。用药2月后，腹部

疼痛和肿物消失，复查彩超发现子宫肌瘤已消失，遂停药。

【附子汤治子宫脱垂宫颈糜烂案】：

朱女士，32 岁，患者小腹坠胀，白带多，质稀薄，无臭味，已一年多。活动后病情往往加重，伴有小腹冰凉，腰酸，疲乏无力。西医诊断为子宫脱垂Ⅰ度，宫颈糜烂Ⅰ度。舌体胖舌质淡，舌苔薄白。

综合辨证为脾肾阳虚。开方附子、白术、白芍、茯苓、党参，用药 7 天后，白带减少，下坠感轻，小腹冰凉有所好转。用药 15 天，白带正常，小腹转温，腰酸、乏力亦明显好转。续用上方 15 天，小腹坠胀感完全消失，即便活动亦无影响，已能参加轻微劳动，遂停药。

【当归芍药散治疗子宫下垂】矢数道明：

患者 55 岁，女，初诊于 1978 年 1 月。 2 个月前过夫妻性生活时子宫疼痛。妇科医生诊断为子官下垂和有小的子宫肌瘤。生过 1 个小孩，人工流产 3 次。

数年前患阴道脱出时接受过手术。

体格、营养、脸色等一般，血压 130/80，还有肩酸痛、头痛、耳鸣、全身倦怠，有体质性过敏倾向，常患荨麻疹。腹部平坦，没有抵抗压痛等瘀血症状。稍偏虚证。

治疗：让服当归芍药散料，3 周后再次来院时患者说全身症状大有好转。子宫下垂感减轻，患者说此方很有效而继续服。再服 1 个月后，子宫下垂感的自觉症状几乎全部消失。过夫妻性生活时也不感觉疼痛。

子宫下垂脱出在汉方中称为阴挺下脱，俗名为“茄子”，完全脱出的形状像茄子。(463)《汉方的临床》1978 年 8 月。

【附子汤治月子病案】：

张女士，41 岁。患者右上肢肩下腕上整个部位有痛感，半夜疼痛尤为明显，患处不能受风、受寒，否则疼痛难耐。该症已有 13 年。患者易出虚汗，手足心热，恶心，舌体淡胖，舌苔白厚。

综合辨证为肾阳虚衰，寒湿内生开方制附子、茯苓、党参、焦白术、赤芍，用药 1 天，疼痛就有所减轻，连服 30 天后，诸症均消，巩固用药 15 天后停药，随访至今未发。

【折冲饮治疗月经痛子宫肌瘤卵巢囊肿】矢数道明：

患者 48 岁，女，初诊于 1978 年 2 月 8 日。从有月经起至今每逢来月经时都有疼痛。已生过 4 个小孩，但月经痛未愈。主诉为去年中旬月经结束后右侧下腹部疼痛剧烈，外科医生认为是阑尾炎，但白血球未升高，因此观察一个时期再考虑是否手术。今年 1 月份左侧下腹疼痛去妇科。某大学医院的妇科开始说患者右侧有子宫肌瘤，左侧有卵巢囊肿，心脏的卵圆孔未闭而需要做手术。患者并没有心脏方面的自觉症状，因此听了这番话后吓得一时不能动弹。

体格、营养、脸色一般，血压 120/80.下腹部右腹股沟上方有抵抗压痛，但没有触及肿块。也触及不到卵巢囊肿。

治疗：针对肌肉瘤、囊肿、下腹部的抵抗压痛等的瘀血症状，让服桂枝苓茯丸料加薏苡仁。服药两周后，连续 3 日患者下腹部疼痛，七颠八倒，家属准备叫救护车，但患者忍心下来没有让叫。3 月 1 日起改服折冲饮。3 月份来了两次月经，但月经痛减轻，没有服镇痛药也能忍耐下来了。4 月份没有感觉月经痛，患者非常高兴。以后继续服折冲饮，月经痛几乎完全消失。心脏有杂音，但没有自觉症状。子宫肌瘤和囊肿及心脏可暂不做手术但需看治疗经过。此患者的子宫肌瘤和卵巢囊肿并不是已治愈，但月经痛先消失。

我在《汉方诊疗医典》月经困难症中对折冲饮的使用写着：“用于炎症性的子宫内膜炎、骨盆腹膜炎、附件炎等，对亚急性至慢性的月经困难症有效。”处方内容：牡丹皮、川芎、芍药、桂枝各 3.0，桃仁、当归各 5.0,延胡索、牛膝各 2.0,红花 1.0。是从桂苓丸中去茯苓而加当归、川芎、延胡索、牛膝、红花者。对桂苓丸证没有完全对证的用折冲饮合适。《汉

方的临床》1978 年 10 月。

罗注：折冲饮来源：《观聚方要补》卷九。药物组成：牛膝 1 两，桂心 3 分，芍药 3 分，桃仁 3 分，延胡索 3 分，当归 3 分，牡丹皮 3 分，川芎 3 分，地黄、红花、蒲黄。

【桂枝茯苓丸行经腹痛黑色血块左侧卵巢囊肿医案】刘昭坤：

何某，32 岁，工人，1991 年 5 月 8 日初诊。患者月经周期 45 天～50 天，经期 6 天～8 天，行经腹痛、夹黑色血块、并逐次加重 1 年余，白带量多质稀，少腹凉而坠痛，腰酸体倦，舌质黯两侧有瘀斑，苔白厚，脉沉弦。屡服少腹逐瘀汤、完带汤等，其效不著。妇科检查：耻骨联合左侧扪及 7cm×6．5cmX8cm 囊性包块；质软，活动度好。B 型超声波检查报告：子宫未见异常，左附件见 6．5cm×8cm 液性暗区，提示：左侧卵巢囊肿。综其脉症，乃痰湿与瘀血互结为症。治宜温化痰湿，活血消瘕。方以桂枝茯苓丸加味：桂枝 20g，茯苓 45g，丹皮 10g，桃仁 10g，赤芍 10g，泽兰 30g，香附 15g，黄芪 30g。日 1 剂，水煎，分早晚 2 次温服。

服药 3 个疗程后经妇科检查及 B 超复查报告：子宫及双侧附件未见异常。迭进 5 剂，改 2 天 1 剂，以巩固疗效。经随访 2 年，并做 B 超检查，无复发。(国医论坛 1995；(5>：14)

【林氏子宫内膜异位症】

以血府逐瘀汤为基本方药并随证加减:月经先期加黄芩;月经后期生地黄改熟地黄，加白术;月经期酌加肉桂、炮姜、小茴香、香附;月经有血块、盆腔有包块加三棱、莪术、丹参;腹痛甚加五灵脂、炒蒲黄、延胡索;乳房胀痛重用柴胡，加川楝子;心烦加栀子、莲子心，20 天为 1 个疗程，治疗 28 例，痊愈 16 例，显效 6 例，有效 4 例，无效 2 例;有效率达 92.8%。

第八节 妇人腹满寒疝诸病

【当归生姜羊肉汤治血虚寒疝(慢性胰腺炎)停经医案】刘俊士医案：

佟某，女，50 岁，1984 年 10 月 8 日初诊，左少腹疼痛伴发吐食已 6～7 年。过去曾因左腹部急性绞痛住某医院，诊断为急性胰腺炎，经住院后，症状有所缓解。出院后左少腹时有隐痛。平时大便次数较多，每日 3～4 次 / 日，平时怕冷，特别是少腹发凉，月经提前后错不定，现已停经一年。口不干，两脉滑带涩，舌正。中医辨证属血虚寒疝，当归生姜羊肉汤主之。当归 12 克，生姜 9 克，羊肉 60 克，3 剂，每日 1 剂。病人服 3 剂后，左少腹隐痛明显好转。随访半年腹痛未复发。(《古妙方验案精选》1992：139)

注家按语：少腹隐痛，见便溏、怕冷、少腹发凉，有寒也；闭经、脉涩，血虚也。盖少腹属肝，肝藏血，肝血不足，阳虚寒生，脉络失养，而致腹痛隐隐不休，用当归生姜羊肉汤养血散寒，正中病机，获效必然。

【大黄甘遂汤治月事不复小便难少腹满日渐膨隆医案】戴鉴周：

徐翁三儿媳，因半产而体质渐羸，月事不复，且纳差，小便难，少腹满，日渐膨隆，家人误认为妊娠。待半载后，虽腹大而无儿动之象，加之体瘦，面容无华，随卧床不起矣。翁乃惧，急遣人延戴老往诊。见病妇面容憔悴，腹如复釜，扪之软如水囊，两手尺脉弦涩而有力，辨为水与血互结于血室，致成肿满症。综其机制，肝失凋达，肺失肃降，中土失运，肝、脾、肺三脏失调，损及冲任，致三焦不能运化水湿，决渎无权，酿成水血弥漫之疾。

遂处以大黄 12 克，甘遂(用面包烧后，研面，馍皮包吞服)4．5 克，阿胶 16 克，烊化冲服，枳实 12 克，白术 12 克。

一帖分三服后，连下水粪数次，而腹部肿消。后用人参养荣汤增减配以艾附吴萸之属，以培补中土，暖宫行血消除余邪。继而天癸至，月事复，一年后产一男婴。(河南中医 1985；<2)：14)

【大黄甘遂汤治闭经三月余腹部膨隆医案】谢胜臣：

钟某某，女，43 岁，农民。闭经三月余，腹部膨隆，状如十月怀胎，曾经数医诊治，且

时减时复，求治于余。诊时见其患者形体尚充实，惟面色萎黄，腹大如臌，呕吐频繁，小便不利，大便稍结，时腹部隐痛，不欲饮食，睡眠不实，舌质偏红，苔白，脉沉缓。审前服之方，皆桃仁、红花、三棱、莪术之类，且服用半月余，病情全无更动。乃详辨之，诊为血水并结于血室之《金匮》大黄甘遂汤证，施血水并攻之法。大黄 15 克，阿胶(烊化)50 克，桃仁、甘遂各 10 克，一剂。

晚间服药，至夜半时，腹中剧痛，约半小时后，前阴排出大量淡红色血水：其痛即解，腹胀亦随消。原方减量复进一剂，又排出血水若干，腹膨隆基本消除。

复诊：服药后月经即来潮，经量较多且挟血块，头晕乏力，自汗畏寒，苔薄质淡，脉沉而细，改拟健脾益气，温中复阳之方调理之，予归脾汤合四逆汤加减数剂获痊愈。(新中医 1984；(4>：25)

【防己椒目葶苈大黄汤治腹胀月经不调医案】孙德华

薛某，女，41 岁。1978 年 6 月初诊。患者于 1968 年盛夏劳动后，一次吃数支冰棍，随后出现胃脘痛。继而腹部胀大，身体消瘦，不能坚持正常工作。先后 2 次以肠功能紊乱收住院治疗，服疏肝健脾方药数百剂，效果不显。延余诊治，症见：腹大如鼓，腹胀，口渴而不欲饮，每日进食 200g 左右，食后肠鸣，沥沥有声。大便每日 2~3 次，呈细条状，难以解出。半年经行一次，量少色淡。舌质淡，苔白滑，两脉弦缓。此乃饮邪内结，中阳被遏，饮留肠间，拟己椒苈黄汤用其苦辛宣降，前后分消。防己、椒目各 10g，葶苈子 9g，大黄 6g。服 3 剂后，矢气频频，大便通畅而量多，腹胀稍减轻。守原方再进 3 剂，腹胀大减，未闻腹鸣，饮食渐增，口渴欲饮，病有向愈之势，停药注意饮食，调理月余，病渐愈。(辽宁中医杂志 4)

罗按："一次吃数支冰棍，随后出现胃脘痛。继而腹部胀大"，这是病因，寒凝气机，令中焦不运，下焦蓄水。证见腹满，肠间沥沥有声。病痰饮者，当以温药和之。

【大黄附子细辛汤治少腹经常冷痛皮疹密布集簇成片医案】张广麒：

陈某某，女，27 岁，1981 年 11 月 8 日来诊。患慢性湿疹 3 年，发作无定时，四季皆有，无明显诱因，多番治疗获效不显，三天前因急性扁桃腺炎后呈急性发作。皮疹密布集簇成片，呈红色斑丘疹状，高出于皮肤，以暴露部位多见，红肿灼热痒甚，颜面及下肢有搔破结痂及少量渗出液，杂有脓疮样损害。大便干难解，口于但不思饮，近年来月事延期，经量少、色黑，少腹经常冷痛，畏寒，四肢厥冷。舌质淡夹青，苔白薄。脉象沉弦。证属寒实内结，营卫(气血)不调。处方：附片 15 克，细辛 6 克，大黄 15 克，桂枝 12 克，白芍 10 克，土茯苓 20 克。

服 2 剂后，大便通畅，肢冷畏寒近愈，皮疹红肿灼痒减半。继方加绿豆 20 克，再服 2 剂，灼痒痛止，湿疹基本干萎转为晦暗。继以桂枝汤加绿豆、赤小豆、苡仁、土茯苓 2 剂，湿疹痊愈，留下色素沉着疤痕。(云南中医杂志 1983；(3)：23～24)

【大黄牡丹汤治盆腔炎医案】魏磊：

患者米某，女，28 岁，小腹坠胀，腰沉腰酸，白带增多并伴有血丝 3 月余。曾口服西药甲硝唑、环丙沙星及静脉点滴菌必治等药物后症状改善不明显。情况：带下量多、色黄、质黏稠伴便干溲赤，小腹坠胀。舌质红，苔薄黄，脉弦滑。处方：大黄 10 克，桃仁 10 克，丹皮 10 克，冬瓜仁 20 克，芒硝 6 克，土茯苓 30 克，红藤 30 克，芡实 30 克。服 5 剂后症状大减。仍小腹胀痛，继上方加炒灵脂 12 克，生蒲黄 15 克（包）。再进 5 剂，诸症消失。6 个月后随访未复发。

【桂枝茯苓丸加味双侧输卵管不通医案】王峰：

余某，女，31 岁，1988 年 4 月 12 日就诊。患者婚后 4 年未孕(爱人男科检查正常)，妇科检查：外阴、阴道正常，宫颈口轻度糜烂，双侧附件(一)，输卵管通液实验示双侧输卵管不通。妇科治疗 2 年未效，用中药补血填精、理气活血之品亦未果。刻诊：面色晦暗，神疲

倦怠，少腹冷痛，腰膝酸软，月经量少，色暗有块，10余日1行，白带较多，舌暗苔白润，脉沉迟涩。此为寒湿阻滞，瘀遏胞脉，治以温经通脉，化湿祛瘀。药用：桂枝、薏苡仁各18g，茯苓15g，赤芍、杜仲各12g，丹皮、桃仁各9g。水煎，每于经前服7剂。用21剂后，证情好转，输卵管通液实验显示双侧输卵管基本通畅。前后服药56剂，1989年12月3日随访，已妊娠2月余。(河南中医1994；(3>：168)

第九节 妇人带下诸病

【薏苡附子败酱散治黄带(慢性盆腔炎)医案】（江准保）

医案：李某，女，30岁。1991年8月10日初诊。近半年来腰骶部及下腹部疲胀痛，服抗生素等症状未减。近1月来，又增肛门坠胀，劳累、受凉及月经期症状加重。月经期延长，经色黯黑，白带量多色黄。舌淡黯、苔白润，脉细弱。妇科检查：附件增粗，压痛(+)。B超示：输卵管增粗，子宫直肠窝积液，液平2．4厘米。

证属久病正虚，湿热蕴结盆腔。薏苡附子败酱散加味：制附片10克，败酱草、薏苡仁、益母草、红藤各30克，黄芪15克，柴胡6克，

10剂后，腹痛、肛门坠胀明显减轻，然口干、大便秘结，上方制附片减至5克，加生首乌30克，继服20余剂，诸症悉除。B超复查：子宫直肠窝少许积液。至今未发。(浙江中医杂志1995)

注家按语：本案患者系阳气耗损，阴阳失调，湿热内蕴，气血壅滞所致，故投薏苡附子败酱散加味，以温阳散结，除湿破瘀，使顽疾得除。

【薏苡附子败酱散治黄带(慢性盆腔炎)医案】江准保：

医案：李某，女，30岁。1991年8月10日初诊。近半年来腰骶部及下腹部疲胀痛，服抗生素等症状未减。近1月来，又增肛门坠胀，劳累、受凉及月经期症状加重。月经期延长，经色黯黑，白带量多色黄。舌淡黯、苔白润，脉细弱。妇科检查：附件增粗，压痛(+)。B超示：输卵管增粗，子宫直肠窝积液，液平2．4厘米。

证属久病正虚，湿热蕴结盆腔。薏苡附子败酱散加味：制附片10克，败酱草、薏苡仁、益母草、红藤各30克，黄芪15克，柴胡6克，

10剂后，腹痛、肛门坠胀明显减轻，然口干、大便秘结，上方制附片减至5克，加生首乌30克，继服20余剂，诸症悉除。B超复查：子宫直肠窝少许积液。至今未发。(浙江中医杂志1995)

注家按语：本案患者系阳气耗损，阴阳失调，湿热内蕴，气血壅滞所致，故投薏苡附子败酱散加味，以温阳散结，除湿破瘀，使顽疾得除。

罗按：薏苡附子败酱汤扩展治疗了，适应证，细想一下，“腰骶部及下腹部疲胀痛”，它符合“腹皮急”，“月经期延长，经色黯黑，白带量多色黄”，这是兼证。“舌淡黯、苔白润，脉细弱”，反映湿浊，正气虚衰。“输卵管增粗，子宫直肠窝积液，液平2．4厘米”。这不是肠痈，但是它也是受血于肠胃，就是说胃肠供应它营养的，胃肠之血有毒，它能毒下子宫，所以要正本清源，要清胃是“逐瘀泄浊”。

【附子粳米汤治少女带下医案】夏先福：

魏某，17岁，1990年8月诊。病者13岁时月经初潮，量多色淡，平素带下如水，腰膝酸楚，溲频清彻，乏力，腰以下沉重，食少便溏，求医3年，而无一效。刻诊：脉细弱且濡，舌淡苔白，面色黧黑，少气懒言，证属脾肾阳虚，带脉虚损。处方：附片30g(先煎)，半夏15g，党参15g，粳米15g，白术15g，茯苓15g，陈皮15g，大枣15g，鹿角霜20g，乌贼骨20g，肉桂6g。服药5剂带止。后以肾气丸巩固，其后月经正常。(以上四案见河南中医)

按语：脾者位居中央，处四脏之中，为中州，乃运化之脏，生于荣卫，通行津液；盖脾

为后天之本，肾为先天之本。若素体脾阳虚或失之调和，久损及肾，肾阳不暖脾土之阳，则导致脾肾之阳两虚。凡罹脾肾虚寒，阳气式微，阴寒内结，皆取附子粳米汤以温肾阳，使脾阳健旺，则阴寒自散，以复其痊。以上数例，病症虽异，但病机类同，故曰："疾异者，疗其要一也"。案五虽为胎疾，附子仍用至 30 克，以其病机相符也，径用之，果取良效，《内经》所谓"有故无殒，亦无殒"之意也。

【原文】：阳明病，腹中寒气，切痛雷鸣，胸胁逆满，呕吐者，此虚寒也，附子粳米汤主之。（金匮）

附子粳米汤方：

附子一枚（炮），半夏半升，甘草一两，大枣十枚，粳米半升

上五味，以水八升，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

注家曰：附子粳米汤主治脾胃虚寒，水湿内停之肠鸣腹痛之证。脾胃阳气虚弱，不能运化水湿，改走肠中，则见肠鸣；寒滞气机，则腹痛。《灵枢．五邪篇》说："邪在脾胃……阳气不足，阴气有余，则寒中肠鸣腹痛"。若寒气上逆犯胃，则呕吐，《素问·举痛论》所云"寒气客于肠胃，厥逆上出，故痛而呕也"，即为此义。总为阳虚寒盛，饮阻气逆之证，故治用附子粳米汤以温阳散寒，降气化饮。方中附子温阳散寒，半夏降逆化饮，甘草、大枣、粳米以补益脾胃。若寒甚者，加蜀椒、干姜效佳。

【黄芪桂枝五物汤治白带量增多状如鸡子清淋漓不断医案】张宽智：

王某某，35 岁，已婚，于 1983 年 10 月 17 日初诊。患者于 1 年前行人流术后，渐觉白带量增多，状如鸡子清，淋漓不断，伴腰痠小腹冷痛，夜尿频数，倦怠乏力。舌苔薄白，脉沉细。证属脾肾阳虚，阴寒内盛。治宜益肾健脾、固涩止带。处方：黄芪 20 克，杭白芍 15 克，桂枝、白术、生姜、芡实、制附子各 12 克，益智仁、补骨脂、杜仲各 10 克：大枣 12 枚。6 剂后，白带量大减，效不更方。续服 6 剂，白带尽除，余症全消。后以金匮肾气丸调理，以巩固疗效。（浙江中医杂志 1990；(2)：68）

【肾气汤治带下量多色白质稀医案】金家隆：

张某，31 岁，石浦二村人。1983 年 9 月 21 日初诊。主诉：第二胎哺乳 4 个月，因有事远出，请人代哺，2 天后返回自哺，婴儿不愿吮乳，其它婴儿亦同样不愿吮乳。自尝汁，味咸而涩。胃纳正常，亦不偏食。平时带下量多，色白质稀，无臭味，伴有腰酸，腰以下有冷感。诊见神倦乏力，面色无华，目睑松弛。舌质淡、苔薄，脉右关细缓，两尺沉细。证属脾肾两虚，督带亏损，治宜温补脾肾，升固督带，投肾气丸加味。方用熟地、怀山药、党参、炙黄芪、炒苡仁、菟丝子各 30 克，炒白术、山萸肉、泽泻、丹皮、升麻各 10 克，鹿角片 15 克，附片 20 克，官桂、柴胡各 5 各。服药 5 剂，乳味转淡，带下、腰酸诸恙亦瘥。续进 10 剂，乳汁恢复淡而微甘，余恙均愈。

【资生汤治痨瘵闭经白带医案】张锡纯

一九一三年，客居大名。治一室女，劳瘵年余，月信不见，羸弱不起。询方于愚，为拟此汤。连服数剂，饮食增多。身犹发热，加生地黄五钱，五六剂后热退，渐能起床，而腿疼不能行动。又加丹参、当归各三钱，服至十剂腿愈，月信亦见。又言有白带甚剧，向忘言及。遂去丹参加生牡蛎六钱，**又将于术加倍**，连服十剂带证亦愈。遂将此方邮寄家中，月余，门人喘促异常，饮食减少，脉甚虚数，投以资生汤十剂全愈。"审斯则知此方治劳瘵，无论男女，服之皆有捷效也。

女子月信，若日久不见，其血海必有坚结之血。治此等证者，但知用破血通血之药，往往病犹未去，而人已先受其伤。鸡内金性甚和平，而善消有形郁积，服之既久，瘀血之坚结者，自然融化。矧此方与健脾滋阴之药同用，新血活泼滋长，生新自能化瘀也。

资生汤方：

生山药一两，玄参五钱，于术三钱，生鸡内金二钱（捣碎），牛蒡子三钱（炒，

捣）。

热甚者，加生地黄五六钱。

罗注：此案中白带，是白术之功，非牡蛎也，盖下焦禀中焦气，是以白术补脾胃之气故也。牡蛎涩肠，补水，软坚。咸以软坚，化痰，消瘰疬结核，老血瘕疝；涩以收脱，治遗精崩带，止嗽敛汗（或同麻黄根、糯米为粉扑身，或加入煎剂）固大、小肠；微寒以清热补水，治虚劳烦热，温疟赤痢，利湿止渴，为肝、肾血分之药（王好古曰：以柴胡引之，去胁下硬；茶引之，消颈核；大黄引之，消股间肿；以地黄为使，益精收涩，止大小便利；以贝母为使，消积结）。盐水煮一伏时，粉用。亦有生用者，贝母为使。恶麻黄、辛夷、吴茱萸。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良（海气化成，纯雄无雌，故名牡）。

【赤小豆当归散赤白带下医案】彭述宪：

谌某某，女，52 岁。工人。1956 年 6 月 12 日就诊。阴道流赤白黏液 2 年，服完带汤、丹栀逍遥散、内补丸等方，带下时多时少。近月病情加重，赤多白少，稠黏气臭，每日换纸 2 次，小腹疼痛，不可重按，小便短黄，舌质红、苔黄滑厚，脉滑数。证属湿热化毒，下蕴胞宫。治宜清热利湿，活血解毒。用赤豆当归散加味：赤小豆、金银花、败酱草各 20g，当归、薏苡仁、贯众、冬瓜仁各 12g。服 10 剂，阴道仅有少量赤白黏液流出，小腹痛止。然头晕，心慌，体倦，纳差，以原方去贯众，加条参、炒山楂各 9g 以补脾健胃，继进 10 剂，带止体健。(湖南中医杂志)。

【临证提要】赤豆当归散主要针对湿热壅滞导致的血败肉腐成脓之证，临床常治疗肠痈、痢疾、带下病、痔疮等，此方既能渗利湿毒又能活血祛瘀。本方在临床中多在辨证基础上与其他药物联合使用。如治疗痔疮出血、便血等多加用侧柏炭、地榆炭等凉血止血之品；而用于风湿痹证多与桑枝、藤类药材等祛湿通络止痛之品合用；而对湿热带下则加用清热利湿之品。

【当归芍药散治带下(慢性附件炎)医案】张天思：

宋某，女，40 岁，农民。1981 年 6 月 10 日初诊。三年来阴道分泌物增多，呈白色，有时呈水样，淋漓不断，伴小腹隐隐而痛，每因分泌物增多时则前阴瘙痒。小腹胀满，双下肢有时浮肿，身沉无力，形瘦，纳少，便溏，日 2～3 次，呈完谷不化。舌质淡、苔薄白。脉沉弦细。西医诊为“慢性附件炎”，属中医之脾虚带下。

投当归芍药散为汤剂：当归、白芍、川芎、泽泻各 10 克，茯苓 15 克，白术 30 克。

水煎服，服 6 剂后带下去其半，浮肿消，纳增，腹痛减，守方继服 20 剂而诸症皆除。(陕西中医)

按语：脾虚带下见脉象沉弦，乃肝气来乘也，故用当归芍药汤取效。

【矾石治带下医案】经方心裁：

初诊：2006 年 5 月 29 日。周某，39 岁，带下量多已经一年，如水样阵下 5 天，外阴潮湿，难以终日,纳可，二便正常，月经周期 30~40 天一潮，经量正常，经色鲜红，7~10 天净，经前乳房胀痛。B 超检查提示:子宫三径之和 16.9cm,未发现输卵管积水现象。曾以脾肾阳虚辨证治疗,投以真武汤合五苓散 5 剂无效。末次月经 4 月 23 日来潮，5 月 20 日净。舌淡红，苔薄白，脉细。妇科检查:外阴无殊,阴道通畅，宫颈轻炎，子宫后位，略大，质地中等,活动，无压痛，两侧附件无压痛。西医诊断:(1)慢性子宫颈炎。(2)子宫肥大症。

治法:温经燥湿止带。方剂:温经汤合矾石汤。

桂枝 5g，吴茱萸 3g，川芎 5g，当归 6g，炒白芍 10g，丹皮 10g，炮姜 5g，半夏 10g，麦门冬 10g，党参 12g，炙甘草 5g，阿胶(烊冲)10g，苍术 12g,5 剂。明矾粉每日 30g，加水适量浸洗外阴。

二诊:2006 年 6 月 2 日。带下已除，外阴潮湿已消，舌脉如上。中药守上方续进 7 剂。明矾外洗如上。

三诊:2006 年 6 月 10 日。带下不多,外阴潮湿未再发生,舌脉如上。中药守上方续进 7 剂。

[按语]矾石汤是治疗“脚气冲心”的外洗方剂。矾石即明矾，味涩、酸,性寒,有小毒,功效之一是燥湿收敛,因此张仲景用它与杏仁相合研而为矾石丸,纳入阴道治疗“妇人经水闭不利，脏坚癖不止，中有干血，下白物”，此“下白物”，即是带下;《本草经疏》称其治疗"妇人白沃多由虚脱”者，此“白沃"也即带下。前为丸药塞阴道,后为内服,殊途同归。

带下《素问:痿论》称之为“白淫”。该案带下清稀如水，阵阵而下而无臭,并非湿热可知,原以为从脾肾阳虚论治能愈,不意无功。改用温经调冲的温经汤加健脾燥湿的苍术水煎口服，配合矾石汤外洗治疗，获得成功。该案使用温经汤者，以《产宝诸方》有“温经汤治女人曾经小产成带”之说。曾经阅读过用明矾与葛根配伍水煎泡脚，可以治疗脚汗症的报导，我用明矾外洗治疗外阴潮湿，即受此启发。明矾为含水硫酸铝钾，如果将明矾火煅,脱去其结晶水之后外用，便称为枯矾，其燥湿的功效可以加强，外用时多采取枯矾。

【真武汤治疗白带】卢医：

某女，43 岁。2009 年 7 月就诊。白带症多年。曾服健脾利湿之剂不愈。经人介绍来诊。自述白带清稀如水，嗅味难闻。每天必须换 2~4 次内裤。平素畏寒怕冷。查舌质淡嫩，苔薄白，脉沉迟。

辨证：阳虚水滞。治则：温阳化水。

方药：真武汤加减。黑附子 60g(与生姜一起先煎 1 小时)白术 30g，茯苓 45g，白芍 45g，生姜 45g，萆薢 30g。7 服。水煎留汁 600 毫升，每次 200 毫升，日 3 次。

药毕，白带明显减少，畏寒怕冷好转。

按：真武汤由茯苓、芍药、白术、生姜、炮去皮，附子五味药组成，具有温阳化水作用，治疗病症颇多。

“太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之”，“少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者此为有水气。其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。”

本例病人，白带症多年，重以健脾之剂，不可谓不对症。然久病及肾，肾阳不足，气化不利，水湿阻滞，故带下不止。真武汤化气利水，加萆薢渗湿祛浊，故收功甚捷。

【乌梅丸治疗妇科疾病真菌性阴道炎症见豆腐渣样带下医案】

真菌性阴道炎症见豆腐渣样带下，宫颈癌症见阴道流秽浊之物，常用乌梅丸合用当归、贝母、苦参等治疗。寒象比较明显者，就用桂枝芍药知母汤。桂枝芍药知母汤还用治胎死腹中、胎已腐烂、手足肢节疼痛，《金匮要略》中用其治类风湿关节炎，有中医外科医师用其治疮痈肿毒、化脓性关节炎，收效良好。我也会用于外阴癌、宫颈癌的治疗。桂枝芍药知母汤用量注意知母与附子的配伍是 2∶1、白芍与桂枝的配伍是 2∶1。

【桂枝汤加龙骨牡蛎治带下清稀绵绵不断医案】叶益丰：

吕某某，女，45 岁，1979 年 3 月 14 日诊。带下清稀，绵绵不断，时达两年，屡经医治，时缓时剧，面色㿠白，头晕乏力，乱梦惊悸，黎明盗汗，小腹冷痛，腰痛如折，舌质淡，苔薄白，脉沉弱。此为久带耗阴，阴损及阳，带脉失约之证。治宜扶阳摄阴，固涩止带。药用桂枝、白芍各 10 克，甘草 5 克，生姜 3 片，大枣 10 枚，鹿角胶、菟丝子、苏艾实各 20 克，煅龙骨、煅牡蛎各 30 克。连服 10 剂而愈。(山东中医杂志 1985；<5>：20～21)

【反复阴痒二周伴白带增多医案】

患者方某，女，43 岁，2017 年 5 月 13 日初诊。因反复阴痒二周伴白带增多要求中药治疗。面部黄褐斑，自诉经前偶有乳胀口苦，经期尚规则，经色偏黯、量偏少，白带呈乳白色，偶有阴部烧灼感。白带常规：白细胞（++），霉菌（+），舌质略红，苔薄白，脉细弦。治宜疏肝理气，清带止痒。

内服方：柴胡 6 克，当归 6 克，荆芥 5 克，川楝子 10 克，生白术 10，土茯苓 10 克，白

鲜皮 10 克，苦参 10 克，炒牛膝 12 克。7 服。

外洗方：蛇床子 9 克，土茯苓 30 克，黄柏 9 克，紫苏叶 3 克，炒蜂房 9 克，金银花 6 克，龙胆草 5 克。3 服。（1 服外洗方可以用 2 天）。患者药后阴部瘙痒显减，白带减少。内服方去改当归为当归炭 6 克，川楝子改生地 15 克，外洗方按原方出入。三诊白带常规：霉菌（-），白细胞（-），嘱下次月经来潮后复查白带常规以善后。

【真武汤治白带多清稀无臭医案】亢海荣：

丘姓，女，42 岁，1981 年 7 月就诊。患者素体阳虚，经常感冒。去冬腰疲腿困，疲乏无力，白带多，清稀无臭，严重时白带顺腿流。妇科检查：慢性盆腔炎。多方治疗无效。面色萎黄，舌质淡嫩、苔滑，脉沉缓无力。辨证，阳虚水泛，寒湿内滞。处以杜仲真武汤方：

炒杜仲 60 克，附片 24 克，白朮 30 克，芍药 10 克，生姜 10 克，茯苓 12 克。

上方连服 3 剂白带即少，又照原方服 6 剂痊愈。此外习惯性感冒也不治而愈。

处方：附子 20 克，白朮 30 克，赤芍 45 克，茯苓 45 克，生姜 45 克。以水 1600 毫升，煎至 600 毫升，分三次服。

服 3 剂后小腹痛去其大半，恶心已止，纳可。麦氏点稍有压痛，无反跳痛。守原方继服 5 剂而告痊愈。

【薏苡附子败酱散治卵巢囊肿流白带医案】于慎中：

马某，女，39 岁，1990 年 12 月 2 日初诊。主诉右下腹肿块，小腹坠痛 2 月余。患者曾有慢性盆腔炎病史，近 2 年来小腹部胀痛，月经前期腰酸，经期延长，白带增多。今年 9 月发现右侧下腹部有拳头大小肿物，伴隐痛，下坠感，按压轻痛，近一个月阴道出血 2 次，量少，有血块，小腹坠痛加重。

在我院妇科检查：下腹部轻压痛，右下腹部可触及 9×7 厘米大小的肿物，活动差，质软，表面光滑，轻压痛。B 超检查示，右侧卵巢区域，可见 10×7 厘米大小的液性回声反射区域，边界清，明显壁包膜。临床诊断为右侧卵巢囊肿，慢性盆腔炎。建议消炎治疗后手术切除囊肿，患者不愿手术，遂转中医治疗。患者面白少泽，身倦乏力，胃纳不佳，小腹坠胀，疼痛，喜暖畏凉，白带多，清稀，小便清，大便正常，腹部濡软，舌质淡，苔白薄腻，脉沉紧。处方：淡附片 12 克，薏苡仁 30 克，败酱草 15 克。

上方服 6 剂后，小腹坠胀明显减轻，白带量减少，胃纳好转。继服上方 12 剂，12 月 24 日妇科复查，右下腹肿块缩小，大小约 6×4 厘米，质软，压痛不明显，原方再服 18 剂。妇科检查：右下腹肿块消失，B 超复查未见异常，随访至今未见复发。(山西中医)

注家按语：本案脉证所现，为寒湿郁遏，气血郁滞之象。由于营血郁滞，渐成包块，治宜温阳散寒，利湿开结，薏苡附子败酱散为的对之方，改散作汤，则其效更速。

罗按：“右下腹肿块，小腹坠”可对应上边条文的“腹皮急”，“如肿状”对应了。那么，对应的地方是：腹皮急，如肿状。所以用薏苡附子败酱汤治。但也有白带增多等诸情况，所以要把握主证，若是当白带治，就白费劲了。

【薏苡附子败酱散治黄带(慢性盆腔炎)医案】江准保：

李某，女，30 岁。1991 年 8 月 10 日初诊。近半年来腰骶部及下腹部疲胀痛，服抗生素等症状未减。近 1 月来，又增肛门坠胀，劳累、受凉及月经期症状加重。月经期延长，经色黯黑，白带量多色黄。舌淡黯、苔白润，脉细弱。妇科检查：附件增粗，压痛(+)。B 超示：输卵管增粗，子宫直肠窝积液，液平 2.4 厘米。

证属久病正虚，湿热蕴结盆腔。薏苡附子败酱散加味：制附片 10 克，败酱草、薏苡仁、益母草、红藤各 30 克，黄芪 15 克，柴胡 6 克。

10 剂后，腹痛、肛门坠胀明显减轻，然口干、大便秘结，上方制附片减至 5 克，加生首乌 30 克，继服 20 余剂，诸症悉除。B 超复查：子宫直肠窝少许积液。至今未发。(浙江中医杂志 1995)

注家按语：本案患者系阳气耗损，阴阳失调，湿热内蕴，气血壅滞所致，故投薏苡附子败酱散加味，以温阳散结，除湿破瘀，使顽疾得除。

罗按：薏苡附子败酱汤扩展治疗了，适应证，细想一下，“腰骶部及下腹部疲胀痛”，它符合“腹皮急”，“月经期延长，经色黯黑，白带量多色黄”，这是兼证。“舌淡黯、苔白润，脉细弱”，反映湿浊，正气虚衰。“输卵管增粗，子宫直肠窝积液，液平2.4厘米”。这不是肠痈，但是它也是受血于肠胃，就是说胃肠供应它营养的，胃肠之血有毒，它能毒下子宫，所以要正本清源，要清胃是“逐瘀泄浊”。

【当归四逆加吴茱萸生姜汤治白带多而清稀经期少腹冷痛医案】陈沅生：

黄某某，女，40岁。身体病弱，患头痛2月余，服中药羌、柴、荆、防等头痛更剧。痛甚之时，只能急服西药止痛，而得暂安，初则有效，渐次失灵。余诊之，其脉沉细无力，左关稍弦，舌质淡而胖嫩，苔薄白。视其面容，惨淡忧郁。身着厚衣，头上仅裹青帕，少气懒言。细询之，知患者一日头剧痛数次，痛时有轻度干呕，痛在巅顶部位；头部怕冷、畏风，四肢不温，常欲蒙被而卧。平时月经错后，量少、色淡，白带多而清稀；经期少腹冷痛，腰亦疲痛。脉证合参，诊断为肝阳不足，阴寒上逆，处以当归四逆汤加槁本、吴茱萸：

当归12克，桂枝9克，白芍15克，细辛6克，木通9克，吴茱萸4．5克，槁本6克，大枣18克，炙草6克。

服上方1剂后，即觉头痛大减，3剂而肢暖痛愈，不裹头巾，亦无怕冷畏风之感。复诊其脉细，但中取即得。经带如前，神疲纳差，法取补中填下，乃易归芪建中汤加鹿角霜、补骨脂、淮山药，调养月余而康复。

【大黄牡丹汤治腹痛拒按带下色黄臭秽杂有血液医案】刘昭坤：

龚某，28岁，农民，于1993年8月15日初诊。主诉：高烧寒战，腹痛心烦，溺赤便干2天。伴恶心不眠，口渴咽干，腹痛拒按，带下色黄臭秽杂有血液，舌质红，苔黄燥，脉数。测T39．8℃。妇科检查：外阴经产式，阴道红肿而热，宫颈充血触痛，子宫体软胀大触痛。血检：}tbgog／l。，RBC30×10他L，wBCl2．2×10。／L。门诊医生以急性子宫内膜炎收入住院。中医辨证为热毒内蕴，气血瘀滞。治宜清热解毒，凉血化瘀，通腑泻浊。方以大黄牡丹皮汤加味：大黄(后下)10g，牡丹皮12g，桃仁10g，冬瓜仁30g，芒硝(溶化)6g，蒲公英30g，土茯苓30g，水煎分3次服，日1剂；同时静滴青霉素800万u／日。

服药2剂体温降至39。C，3剂后大便得下，质稀臭秽，高烧退(T37．5rC)，腹痛轻微，带下黄白间杂、臭秽带血，无口渴、咽干、恶心，欲进稀粥，舌质红，苔薄黄，脉沉细弦。效不更方，继用8剂，体温正常，无腹痛，少量白带、无臭秽，舌质淡，苔薄微黄，脉沉细。为善其后，上方去芒硝，加黄芪、当归，2日1剂。共用青霉素6天，住院25天，痊愈出院。经随访1年无复发。(河南中医1996；(3)：151～152)

【大黄牡丹汤治小腹疼痛带下量多输卵管囊性肿块医案】刘芳贵：

李某，女，36岁，干部。1991年9月8日初诊。主诉：小腹疼痛半年，左下腹肿块3月余。患者小腹刺痛且胀，月经40～50天一潮，血量中等，小血块较多。3月前发现左侧有核桃大肿块，局部有轻微压痛。伴见：带下量多，色黄白相兼，质粘稠，有臭味。阴部时有瘙痒，腰部刺痛且胀，身热口渴，尿少色黄，大便干结，舌红，苔黄腻，脉滑数。妇检：左侧输卵管处可触及3×3平方厘米的肿块，质稍硬，压痛明显。B超检查：见左侧输卵管处有3×4平方厘米的囊性肿块，中间有液平面，诊为：“左侧包块型附件炎”。证属：湿热蕴结，气血瘀滞之癥瘕。治以清热利湿，破瘀消癥。方用大黄牡丹皮汤加味。处方：炒大黄10克，丹皮20克，桃仁15克，冬瓜仁20克，芒硝12克(冲服)，败酱草30克，苡仁30克，甲珠10克，莪术10克。守方加减1月病瘥。(云南中医杂志1993；(4)：25)

【桃花汤以芡实易粳米加肉桂、阿胶治赤白带下经来紫黑淋沥不断】

王某，体素虚弱，经事或前或后，最近赤白带下，经来紫黑，淋沥不断已半月，面白无

华，神疲思睡，腹微胀，胁微痛，腰脊酸楚，舌红苔白，脉象微细。熊英权初投归脾汤略效，再剂血下反多，体益不支，乃改投桃花汤，以芡实易粳米，加肉桂、阿胶，一剂经漏即止，三剂而竣功。（《江西医药》）

桃花汤方：

赤石脂一斤（一半全用一半筛末），干姜一两，粳米一升

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，纳赤石脂末方寸匕，日三服，若一服愈，余勿服。

【桂枝汤加龙骨牡蛎治带下清稀绵绵不断医案】叶益丰：

吕某某，女，45 岁，1979 年 3 月 14 日诊。带下清稀，绵绵不断，时达两年，屡经医治，时缓时剧，面色㿠白，头晕乏力，乱梦惊悸，黎明盗汗，小腹冷痛，腰痛如折，舌质淡，苔薄白，脉沉弱。此为久带耗阴，阴损及阳，带脉失约之证。治宜扶阳摄阴，固涩止带。药用桂枝、白芍各 10 克，甘草 5 克，生姜 3 片，大枣 10 枚，鹿角胶、菟丝子、苏芡实各 20 克，煅龙骨、煅牡蛎各 30 克。连服 10 剂而愈。(山东中医杂志 1985；<5>：20～21)

【附子理中汤加真武汤治患慢性腹泻白带两年医案】娄绍昆：

我村子里有一个中年妇女腹痛腹泻两年，白带如水一年，我就是用附子理中汤合真武汤把她治愈的，疗程也只有一个多月。

【当归芍药散少腹作痛慢性盆腔炎白带多医案】岳美中：

邵某某，眭某某两位女同志，均患少腹作痛。少腹痛，白带多，头晕，诊断为慢性盆腔炎，予以当归芍药散作汤。方用：当归 9 克，白芍 18 克，川芎 6 克，白术 9 克，茯苓 9 克，泽泻 12 克。数剂后，腹痛与头晕基本消失，白带见少。眭长期腹痛，小腹重坠，白带多，头目眩晕，投当归芍药散作汤用，三诊，腹痛白带均减，改用少腹逐瘀汤治其白带症。

第十节 妇人淋之为病

【薏苡附子败酱散治劳淋(慢性肾盂肾炎)医案】（许琼政）

杨某某，女，43 岁，护士。1987 年 7 月 21 日初诊。患者一年多来反复出现尿频、尿急、尿痛。间歇期虽尿痛不著，却淋沥不已，余沥难尽，尿液混浊，腰酸腰痛。每次尿检查均有白细胞或脓细胞(+++)，尿蛋白时为阳性。尿培养有葡萄球菌生长。西医诊为慢性肾盂肾炎，并根据药敏试验多次使用抗生素治疗而罔效。

近 10 多天来上述症状复发，诊见面色灰黯乏华，四肢欠温，腰间叩击痛，舌淡、苔白略腻，脉沉细无力。尿检：淡黄微浊，蛋白(±)，白细胞(5～8)，白细胞管型(0～1)，上皮细胞(10～12)均为低倍镜，尿酸碱度 6.5。一周前再次尿菌培养为葡萄球菌生长。此属中医“劳淋”范畴。乃肾阳虚衰，膀胱湿热，气化失司，水道不利所致。治宜振奋肾阳，清热利湿。方用薏苡附子败酱散：熟附子 12 克，薏苡仁、败酱草各 30 克，9 剂。

药后尿频、尿急、尿痛、腰痛等症状消失，尿检查转阴性，但尿时仍有余沥不尽感。继服原方至 30 剂，诸症皆失，尿菌培养阴性。追踪三个月，症无复发，并每月复查尿常规均阴性而告愈。(新中医)

按语：究“劳淋”一病，隋·巢元方说：“诸淋者，由肾虚而膀胱热故也”。又说：“劳淋者，谓劳伤肾气而生热成淋也。”本病例为肾阳虚衰，膀胱湿热所致，与仲景薏苡附子败酱散所治病证虽异，然病机却同，故用本方能获异病同治之良效。

罗按：为什么不是肠内有痈，而是尿频、尿急、尿痛。间歇期虽尿痛不著，却淋沥也用这个方？是因为肠和血液有营养物质和代谢产物交换的功能，肠子生病，它罢工了，那么交

换的功能就弱或者没有了，代谢产物重入血液中，这就是所谓的热，肾是下焦，受浊于中焦。其实就是说血含有不良物质，它毒害了肾。薏苡附子败酱散的主要功能是排泄化解胃肠系统血液中的积浊，血正常了肾就不再受毒了。

感触：光是看条文，真难理解，有医案就容易多了。

【甘麦大枣汤小便不禁医案】张正海：

潘某，女16岁，学生，1984：年8月初诊。患者每见流动之水则小便不禁。经西医泌尿系统及化验检查均无异常发现，于1984年8月经介绍前来中医治疗。为验其病情，当即令其目睹杯水泄地之状，果然云已遗尿于裤内。查患者发育正常，似无病之人；望其舌质淡红，苔薄白；诊其脉左寸稍弱，余部皆平。虽属小恙，处方尚觉棘手，寻思良久，复究其因，方知两年前打水时被恶犬惊吓，值时毫无不适，日久却见此疾。姑拟甘麦大枣汤加味，以观消息。药用炙甘草15克，淮小麦30克，大枣8枚，桑螵蛸15克，益智仁24克，生牡蛎12克。2剂。越二日，其父来告，药后已不再遗尿。药已中的，勿需易辙，原方迭进3剂，以资巩固。(国医论坛1987)，按语：病发于惊恐，为情志所伤。《素问·举痛论篇》云“余知百病皆生于气也，……恐则气下。”年方二七，肾气初盛，卒逢惊恐，气机下趋，恐能伤肾，开阖失司；肾为牝脏，主运五液，外水之动，亦从其类。又心主神明，职司五神，故恐动于心则肾应之，乃发斯证。治宜养心气以宁心神，固肾气以利开阖，故以甘麦大枣汤加味而收功。

【薏苡附子败酱散治劳淋(慢性肾盂肾炎)医案】许琼政：

杨某某，女，43岁，护士。1987年7月21日初诊。患者一年多来反复出现尿频、尿急、尿痛。间歇期虽尿痛不著，却淋沥不已，余沥难尽，尿液混浊，腰酸腰痛。每次尿检查均有白细胞或脓细胞(+++)，尿蛋白时为阳性。尿培养有葡萄球菌生长。西医诊为慢性肾盂肾炎，并根据药敏试验多次使用抗生素治疗而罔效。

近10多天来上述症状复发，诊见面色灰黯乏华，四肢欠温，腰间叩击痛，舌淡、苔白略腻，脉沉细无力。尿检：淡黄微浊，蛋白(±)，白细胞(5～8)，白细胞管型(0～1)，上皮细胞(10～12)均为低倍镜，尿酸碱度6.5。一周前再次尿菌培养为葡萄球菌生长。此属中医“劳淋”范畴。乃肾阳虚衰，膀胱湿热，气化失司，水道不利所致。治宜振奋肾阳，清热利湿。方用薏苡附子败酱散：熟附子12克，薏苡仁、败酱草各30克，9剂。

药后尿频、尿急、尿痛、腰痛等症状消失，尿检查转阴性，但尿时仍有余沥不尽感。继服原方至30剂，诸症皆失，尿菌培养阴性。追踪三个月，症无复发，并每月复查尿常规均阴性而告愈。(新中医)

按语：究“劳淋”一病，隋·巢元方说：“诸淋者，由肾虚而膀胱热故也”。又说：“劳淋者，谓劳伤肾气而生热成淋也。”本病例为肾阳虚衰，膀胱湿热所致，与仲景薏苡附子败酱散所治病证虽异，然病机却同，故用本方能获异病同治之良效。

罗按：为什么不是肠内有痈，而是尿频、尿急、尿痛。间歇期虽尿痛不著，却淋沥也用这个方？是因为肠和血液有营养物质和代谢产物交换的功能，肠子生病，它罢工了，那么交换的功能就弱或者没有了，代谢产物重入血液中，这就是所谓的热，肾是下焦，受浊于中焦。其实就是说血含有不良物质，它毒害了肾。薏苡附子败酱散的主要功能是排泄化解胃肠系统血液中的积浊，血正常了肾就不再受毒了。感触：光是看条文，真难理解，有医案就容易多了。

第十一节 妇人不孕证诸疾病

【大黄牡丹汤治婚后9年不育医案】李玉有：

吴某，32岁，1989年5月20日初诊。患者婚后9年不育，辗转求医，均不效。应他人之荐，延吾诊视。诉因婚久不孕，又多治无望，遭受家人歧视虐待，曾几寻短见未成。恳求医治。曾诊为双侧输卵管阻塞不通、慢性附件炎。询之，素体壮实，14岁月经初潮，周期略前，经量较多，色紫黯夹有瘀块，双侧少腹疼痛，时烦，便秘，带下色黄。查：少腹两侧可触及条索状物。，压痛明显，舌紫黯、边有瘀点、苔黄，脉沉涩有力。辨为热瘀蕴结，胞脉闭塞。拟清热逐瘀，疏通卵甬之法。方用大黄牡丹汤加败酱草，香附、穿山甲(芒硝每服5剂用1次)。值经期易养血活血之剂。调治2月半，诸恙得平。再作输卵管通气复查，为双侧输卵管畅通。斯时停药，试观如何。是年腊月，患者偕家人前来道谢，欣谓已怀孕3月矣。(新中医1993；(3)：44)

【肾气汤治性欲淡漠幼稚子宫婚后6年不孕医案】赵三立：

胡某某，30岁，1981年10月613初诊。婚后6年不孕。经期紊乱，量少色淡，性欲淡漠，夜尿频数，大便溏薄，腰腿酸软。脉沉细，舌淡体胖，苔腻。上海某医院诊为幼稚子宫，经多种治疗无效。此乃肾气不足。予肾气丸加枸杞子30克，白术20克，当归15克，续断、党参各10克。以上方为大，随证变化加减，经6个月调治，基本告愈，于次年5月怀孕。(浙江中医杂志1990；(4)：181)

【吴茱萸汤患者婚后两年不孕医案】案例分享：

患者婚后两年不孕，不口干不口苦，睡眠差，容易醒，醒后难入寐，梦多有汗，大便烂小便清,怕冷，脾气大，脉沉细无力，左关弦而无力，厥阴寒化证，7付吴茱萸汤，远方原剂量，45克吴茱萸，45克党参，90克生姜，12个红枣。患者夜寐改善，脾气大好，且成功受孕。经方随证治之,魅力大。

【内经四乌贼骨一蔥茹丸方治左侧输卵管狭窄阻塞】岳美中：

岳先生对本方颇有心得，认为此方能开通下血:“治女子血枯,经水不利。此方可以移治输卵管窄狭。其中乌贼骨味咸性温，能通经络，祛寒湿，善破液痕。蔥茹，即今之茜草，可以通经。雀卵甘温，最能旺盛性机能。鲍鱼汁亦为血肉有情之品，除补味之外，能入肝散血，气臭腥秽，可引诸药入于胞中，亦同气相感之意。四药合用能兴阳开结，疏化积滞。

曾在印尼治一妇人，结婚二十年，久不怀孕。西医诊断为左侧输卵管狭窄阻塞，求治于我。思索良久，亦投本方，服二月后，经X光片检查，左侧输卵管闭塞已通。”

【当归四逆汤治子宫肌瘤并不孕症】

邹xx，女，31岁。体胖，结婚后7年未孕，经前胸乳胀痛，腰痛，小腹坠胀疼痛，经来最多，经色暗黑有血块，淋漓难尽，经后腰痛，白带多，清稀，手足不温，舌质淡，舌体胖大，苔白，脉沉细无力。方用当归四逆汤化裁：当归9克，桂枝9克，白芍30克，细辛9克，甘草6克，通草9克，三棱12克，莪术12克，红藤30克，败酱草30克，法夏9克，炮甲6克，路路通9克，石见穿15克，皂角刺9克，一日一剂，一日3次，饭后温服。药渣布包热敷小腹部。经期更方为：熟地15克，赤芍9克，当归15克，川芎9克，蒲黄生炒各6克，太子参15克，覆盆子15克，菟丝子15克，牛膝9克，前仁9克，苍白术各15克，仙灵脾15克，仙茅9克，一日一剂，一日3次，饭后温服。连续治疗二月，B超检查提示：子宫形态、结构无异常，诸症悉除。越一年，家人来告生一子。

痛经一症，病因很多，临床多见命门火衰，脾肾两虚。痰瘀阻滞胞宫等，导致痛经不孕。本例乃子宫肌瘤，肌瘤为有形之邪，寒凝气滞，痰瘀阻滞，故致痛经不孕，用当归四逆汤化裁，温阳散寒，化瘀止痛，使寒散痛消，气血畅达，阴阳调和，经来不痛，故能受孕生子。

【血府逐瘀汤治不孕证】

袁某，女，25岁。结婚5年未孕。自14岁初潮起，经期少腹及腰部疼痛，拒按，尤以经后期为甚，月经量少，时淋漓不尽，色紫黑夹块。常伴胸闷不舒，胁肋及乳房胀痛。舌紫

暗，有瘀斑，脉沉涩。思患者色、脉、证皆为血瘀之象，其不孕当为原发性痛经所致，宜从经论治，以行气化瘀，调经助孕。方选血府逐瘀汤加减：当归、川芎、赤芍、生地各 20 克，桃仁、牛膝、柴胡、桔梗、玄胡索各 15 克，乳香、没药、木香、枳壳、香附各 12 克，红花 10 克，甘草 5 克。水煎，经前 2 周开始服用，一日 1 剂。用后当月，疼痛明显减轻，胸闷及乳胁胀痛消失，经量增多，颜色转红，瘀块减少。效不更方，继用原方。二诊之后，诸症消失，月经正常。次年育 1 女。

【少腹逐瘀汤治不孕医案】王清任：

道光癸未年，直隶布政司素纳公，年六十，因无子甚忧，商之于余。余曰：此易事耳，至六月，令其如君服少腹逐瘀汤，每月五付，至九月怀孕，至次年甲申六月二十二日生少君，今七岁矣。

【少腹逐瘀汤治疗不孕症 40 例医案案例】

不孕症是指女子结婚后夫妇同居 2 年以上配偶生殖功能正常，未避孕而不受孕者。中医认为肾主生殖，故治疗不孕症，大多从补肾着手。晚清王清任创立少腹逐瘀汤，从活血化瘀入手，选用小茴香、干姜、元胡、没药、当归、川芎、官桂、赤芍、蒲黄、五灵脂等来治疗不孕症，并称此方“种子如神”，认为“本方祛疾、种子、安胎、尽善尽美”。所有病例一律采用纯中药治疗，以少腹逐瘀汤为基础，气虚者加生白术、太子参；血虚者加熟地、丹参；虚寒者加淡竹叶、细辛；阴虚者加玄参、阿胶。

【少腹逐瘀汤治疗不孕症医案】

李某，女，26 岁，于 2007 年 11 月 14 日初诊。患者结婚 3 年同居不孕，丈夫精液常规检查正常。患者 15 岁初潮，平素经期错后 5-7 天，经色暗红、量少，有血块，且伴有经前，经期小腹疼痛。妇科检查见外阴、阴道正常；宫颈光滑、宫体前倾、较正常幼小；双侧附件正常。自诉不思饮食，经常胸闷、喜叹息，伴头晕、疲乏、失眠多梦、二便正常、舌淡胖、质地较黯、舌边、尖布满瘀点，脉来细弱无力。

诊断：①不孕症；②痛经。辨证：气滞血瘀兼气血亏虚。治法：理气活血，佐补养气血之品。方药：少腹逐瘀汤加减。小茴香 6g，干姜 6g，元胡 10g，五灵脂 10g，没药 10g，川芎 15g，蒲黄（单包）9g，肉桂 6g，赤芍 10g，当归 10g，白术 15g，熟地 15g，1 日 1 剂，日 2 次水煎服。

2007 年 12 月 19 日复诊，自诉此次月经较上月提前 7 天，但经前、经期均未出现腹痛，月经血块较前明显减少，仍疲乏，睡眠差，食欲不振。在前方基础上去熟地，加泽兰 15g，益母草 20g，酸枣仁 15g，神曲 10g，1 日 1 剂，续服。

2008 年 1 月 15 日三诊，自诉服药后不适症状均较前好转，来月经时已无血块，余无异常。诊其舌淡、边、尖瘀点已所剩无几，脉细弱，处方：小茴香 6g，干姜 6g，元胡 10g,五灵脂 10g，当归 10g，蒲黄（单包）9g,赤芍 10g，太子参 15g，生地 15g，白术 15g，枸杞子 10g，益母草 20g。

此后，按此方每月经净后服 5 剂，月经规律正常，于 2008 年 8 月 14 日查出怀孕，并且无不适感。全家人欣喜异常。

【少腹逐瘀汤治疗不孕症医案】

王某，女，37 岁，2006 年 9 月 17 日初诊。患者婚后 9 年未孕，其夫精液常规检查正常，曾经中、西医治疗，多年未见疗效。自述 16 岁月经初潮，每次经期错后 10-14d 不等，行经时伴少腹冷痛，经色暗黑有血块，舌淡，苔白，脉沉弦迟。

诊断：不孕症。辨证：气滞血瘀兼寒滞肝脉。治法：疏气化瘀兼温经通脉。方药：少腹逐瘀汤加减。

小茴香 6g，干姜 6g，元胡 10g，五灵脂 10g，蒲黄（单包）9g，当归 10g，白术 15g，枸杞子 15g，熟地 15g，肉桂 10g，细辛 3g，淡附片 5g，吴茱萸 10g，1 日 1 剂，日 2 次水煎服。

此后嘱患者服 5 剂后，减淡附片，加阿胶水煎服。连服 3 个月经周期后，月经期少腹冷痛减轻，经色鲜红无血块。治疗半年后经停而受孕，足月顺产一男婴。家人同样欣喜万分。

【少腹逐瘀汤治妇女双侧输卵管因炎症而阻塞不通不育医案】

杨某，女，25 岁，结婚 2 年而仍未怀孕，经医院检查属双侧输卵管因炎症而阻塞不通，笔者以此合方散剂治之，服至第三月，即已正常妊娠，后生一双胞胎。

【少腹逐瘀汤治妇女不育医案】

岳某，女，28 岁，婚后 6 年未孕，服此合方散剂年余，终于怀孕。患者又恐已服中药年余，会对胎儿不利，遂想引之，但又获子不易，左右为难，即来问笔者，笔者告之，观君神色，必有好运，中药安全，不必多疑。遂从之，生一男，聪明过人，过目不忘。

【半夏厚朴汤治不孕】

赵某，女，25 岁。1981 年 12 月 30 日初诊。婚后 5 年未孕，迭治乏效。刻诊：正值经期腹痛颇甚，量少色黯，乳胁胀痛，脘闷纳少，眩晕呕恶，精神不舒，咽如物梗，溲清便溏，苔白腻，脉弦滑。证系肝郁气滞，脾虚痰凝之痛经。治宜疏肝理气，健脾化痰。方予茯苓 20g，姜半夏、制厚朴、苏叶梗、制香附、炒白芍、川郁金各 10g，川芎、生姜各 6g。3 剂后痛势好转，诸症亦减。后每届经临则连服上方 3 剂，4 个月后，痛经告愈，候 2 月受孕。（陕西中医）

【少腹逐瘀汤婚后痛经紊乱色紫血块数年无生育】

患者刘某，女，25 岁，石家庄市大兴纺织厂工人。主诉：21 岁结婚，婚后痛经，月经周期紊乱，经来色紫，有血块，结婚数年无生育。刘某体质素壮，无其他病史，舌苔白腻，肝脉弦沉无力，肾气虚寒。

妇人不孕，其经或前或后，或多或少，行经作痛。经色不正或紫、黑、淡、凝而不调，不调则气血乖争，不能怀孕。脉涩而不畅，舌紫苔薄，脸色苍黑，有瘀斑，手心灼热，口干失眠。

【辨证】气瘀搏结于少腹，冲任无权。

【治疗】血府逐瘀汤 1 剂。平日予少腹逐瘀汤，经来前连服 5 剂。本方由当归、川芎、延胡索、肉桂、没药、炮姜、五灵脂、炒小茴香、生蒲黄、赤芍共十味药组成。

治疗 3 个月，月经正常，腹痛消失，停服血府逐瘀汤。经前续服少腹逐瘀汤 5 剂，半年后怀孕，后生一男孩。

少腹逐瘀汤主治瘀在少腹，致肝肾功能失调，或寒凝气滞，疏泄不畅，症见少腹作痛，或积块，或月经不调等。本患显系气血瘀滞于少腹，故有经行不畅且痛、经色紫、脉涩、舌紫暗等症状。瘀血阻滞，气机不畅，肝肾失调，冲任升降无权，胞宫因而失养，故长期不孕。

上述诸症都是少腹瘀血所致，所以用蒲黄、五灵脂、川芎、没药、延胡索活血行血；因为血得温则行，所以又用肉桂、炮姜温经散寒；小茴香祛寒理气，既引药下行，又能行气以活血。因本方有消瘀止痛作用，瘀血消除，月经自然正常，这就是根据“瘀血不去，出血不止”的临床经验总结的一种治法。

【温经汤治不孕】曹颖甫：

予按此为调经统治之方，凡久不受胎经来**先期后期，或经行腹痛，或见紫黑，或淡如黄浊之水**，施治无不愈者，曾记寓华废坊时，治浦东十余年不孕之妇，服此得子者六七家，江阴街四明范姓妇亦然，此其成效也。

【抵当汤治不孕】曹颖甫：

予昔在同仁辅元堂治周姓十七岁少女时经停五月矣，以善堂忌用猛药，每日令服大黄庶虫丸，不应送诊期后，病者至江阴街寓所求诊，月事不行，已抵七月，予用虻虫水蛭各一钱，大黄五钱，桃仁五十粒下之，下后以四物中参芪善后，凡二剂。十年后来于江阴街遇之，始知其嫁于小古门朱姓，已生有二子矣。

【温经汤不孕医案】《经方躬行录》

李某，25 岁，农民。婚后五年不孕，月经二三月一行，甚无规律。西医做人工周期三月，月经按时而至，停则姗姗不来，遂改求中医。初意在鹤发银鬓之老医，发乌须墨如余者，不屑一顾也。然服药数月未效，一日来诊，适值老医休息，不得已而求余，然不乐之色显于眉

间。询知经前乳房胀痛，经来量多，杂有血块，延期十日左右。经期腹痛、腰痛，喜温喜按，经后头痛，今已毕56日。带多清稀，小腹发冷，夜间手足心热，胃纳可，口干思饮，大便正常。望其面白少红，人中深凹，唇干不荣，舌淡红，苔薄白。诊其脉，沉弦细，触其腹，小腹不温，松软无压痛。

脉证观之，此冲任虚寒，气滞血瘀证也。盖冲为血海，任主胞胎，冲任虚寒若寒冬地冻，种子焉能发芽生根？老医所开之方，乃号称种子安胎第一方——少腹逐瘀汤。是方虽有茴香、干姜、官桂暖宫之品，然不补益气血，填充冲任，凝寒瘀血安能去之？拟：

当归15g，川芎10g，白芍15g，党参30g，桂枝10g，吴茱萸 10g，甘草6g，丹皮10g，麦冬15g，阿胶15g，柴胡12g，生姜5片 五剂 。

二诊：服药四剂，月经汛潮，经前乳未痛，经来腹安和，今已行三日，量仍多，色鲜杂块，脉舌如前。守方七剂，忌食、触寒凉。

三诊：上次月经七日即净，头未痛，口干、掌热均减，精神大好，纳化有增。某面色泛红，屠涡可掬，今又毕41日，切其脉，滑数有珍。彼不之信，云："不恶心、不思酸，何言有孕"？令作尿检，果呈阳性。

附记：李妊娠后，村民闻讯，先后有数人经余调治亦身怀六甲。是年冬，该公社党委书记某，怒气冲冲而来，云彼未成为模范书记者，因余致人口净增率超标，计划生育拉分故也。余对曰："若汝多年不育，求医否？若汝为医生，拒诊否?"如此为名利而背情理，实可笑也。此20世纪80年代事也。

【婚后2年不孕经前腹泻如水数年验案】：

王xx，女，23岁，已婚，寿阳县人。1983年10月6日初诊：婚后2年不孕，经前腹泻如水数年，前来诊治。视其面黄体瘦，倦怠无力，脾气不健也。询其纳差食少，肠鸣漉漉。自言不敢食生冷瓜果，否则便溏如水。察其舌淡苔白，切脉细迟无力。证属脾肾气虚，水湿不化。治宜健脾补气，益肾温阳，兼化水湿。健固汤加味：党参20克，焦白术30克，盐巴戟10克，云苓12克，薏苡仁10克，炮姜3克，补骨脂6克，肉豆蔻6克，甘草3克，生姜3片，红枣6枚。水煎服5剂。

同年10月15日二诊：药后纳食增加，精神转佳，近1周来，大便甚调。经期尚有1周方潮，嘱前方再服5剂，以观经来水泄之情。同年10月30日三诊，药服10剂，而经前泄水获愈。经后嘱服参苓白术散以善后。3个月后闻其妊娠。

经前泄水，经后自愈者，一般多因脾肾虚损所致。盖脾虚则湿不化而渗注于下，带脉是以弛缓。肾气虚则固摄无力，胞宫是以后倾而压迫直肠。故此证平常腰困带下较甚。经血来潮之际，胞宫因经血充盈而膨大，直肠不胜其迫而数泄水湿。经净后宫体空虚，压迫力弱而泄水自止。

此例素体脾肾亏损，遵青主健脾利湿之意，用健固汤合温肾健脾之补骨脂、肉豆蔻、炮姜，以健补带脉胞宫，连服10余剂而经脉健固，脾健则升散；肾壮则固摄，胞宫无后迫之忧，水湿化而泄水愈。故妊娠自然之理也。

【附子汤治不孕案】

张女士，32岁，结婚八年未孕，多方求治无果。患者四肢常冷，小腹痛胀，月经不至，全身困倦，嗜唾懒言。

综合辨证为下焦虚寒，全身阳气运化不足。开方附子汤，服药5天，怕冷腹胀改善。服药月余，反馈周身活畅，诸痛消失，经期准，经色暗红。续服上药一月，肢冷腹痛消失，月经准时，四肢温暖。停药月余，成功怀孕，后诞下一子。

【生水蛭治少腹有癥瘕不育医案】张锡纯：

曾治一妇人，经血调和，竟不产育。细询之，少腹有癥瘕一块。遂单用水蛭一两，香油炙透，为末。每服五分，日两次，服完无效。后改用生者，如前服法。一两犹未服完，癥瘕

尽消，逾年即生男矣。惟气血亏损者，宜用补助气血之药佐之。

或问，同一水蛭也，炙用与生用，其功效何如此悬殊？答曰：此物生于水中，而色黑（水色）味咸（水味）气腐（水气），原得水之精气而生。炙之，则伤水之精气，故用之无效。

水族之性，如龙骨、牡蛎、龟板大抵皆然。故王洪绪《外科证治全生集》谓用龙骨者，宜悬于井中，经宿而后用之，其忌火可知，而在水蛭为尤甚。特是水蛭不炙，为末甚难，若轧之不细，晒干再轧或纸包置炉台上令干亦可。此须亲自检点，若委之药坊，至轧不细时，必须火焙矣。西人治火热肿疼，用活水蛭数条，置患处，复以玻璃杯，使吮人毒血，亦良法也。

【半夏泻心汤治不孕医案】彭海燕：

田某，女，29 岁，1990 年 3 月 7 日初诊。婚后 4 年余，3 年前曾于孕 3 个月时无明显诱因自然流产一胎。此后 3 年同居未孕。曾行多种检查及治疗，盆腔碘油造影提示："宫腔形态正常，双侧输卵管通畅。诊刮病检报告："子宫内膜腺体分泌不良"。测基础体温双相，但高温相上升较慢。其爱人精液检查正常。屡服健脾及补肾填精之品不效。患者平素小腹冷感，**胃脘嘈杂胀满**，大便质稀 1～2 次。月经周期正常，末次月经 1991 年 2 月 27 日。舌红苔薄黄腻。证属寒热互结?胞脉受阻而致不孕。治宜调和寒热，理气温经。投半夏泻心汤化裁：

半夏、党参、香附各 12 克、黄芩、干姜、陈皮各 9 克，黄连、炙甘草各 3 克，大枣 3 枚。服 5 剂，胃脘嘈杂明显减轻，苔薄黄略腻，余症同前。上方去黄芩、香附，加白术、桑寄生。服药月余来诊，告知月经 40 余天未至，经查怀孕，后足月顺产一男婴。（陕西中医 1992）

按语：脾胃虚弱，寒热与痰湿互结于中焦，气机不畅，胞脉阻滞而致不孕。治又当撇开补肾之传统大法，而予半夏泻心汤以辛开苦降，祛除痰湿，调畅气机。虽不刻意种子安胎，而实收种子安胎之效矣。

罗按：中焦气机失调之半夏泻心汤证具：胃逆、胸满、下利。

【防己椒目葶苈大黄汤原发性不孕症医案】侯成钦

赵某，29 岁。1985 年 6 月 13 日初诊。自诉婚后 5 年未孕。月经周期延后，经期腹痛，小腹发凉，行走时腹内似水声吱吱作响，面黄形瘦，纳谷不香，舌胖苔腻滑，脉沉细弦。检阅前医处方，皆以健脾祛痰，养血为治，均未见效。遂投己椒苈黄汤加味逐水治之。

防己 12g，椒目 30g，大黄 15g(单包后下)，木香 12g，枳壳 12g，茵陈 15g，泽泻 15g，芒硝 12g(单包药汁烊化服)，葶苈子 20g。

水煎服，6 剂，每日 1 剂。药后，泻下半痰盂米水样便，行走时腹内响声未作，脉沉减轻，转以参苓白术散加减调理。

党参 12g，白术 12g，扁豆 15g，陈皮 12g，山药 15g，甘草 10g，砂仁 12g，茯苓 12g，桔梗 10g，木香 10g，川芎 15g，干姜 15g，良姜 12g，小茴香 12g。水煎服，6 剂，每日 1 剂。6 剂药毕，饮食大增，月经按期而至，次月怀孕，生有一子现已上学。(湖南中医杂志)。

罗按：《金匮要略·痰饮》篇云："其人素盛今瘦，水走肠间，沥沥有声，谓之痰饮。"，此是肠间有水气，故防己椒目葶苈大黄丸主之。妇人不孕，从人皆以为胞宫之疾，不知胞宫以膜与肠相连，为脾胃所养。故治病不能想当然，要从病家脉证辩论。

《伤寒论》曰：肺饮不弦，但喜喘短气。病患一臂不随，时复转移在一臂，其脉沉细，非风也，必有饮在上焦。其脉虚者为微劳，荣卫气不周故也，久久自瘥。一云：冬自瘥）腹满，口苦干燥，此肠间有水气也，防己椒目葶苈大黄丸主之。

防己椒目葶苈大黄丸方：
防己，椒目，葶苈，大黄各一两
上四味，捣筛，炼蜜为丸，如梧桐子大，先食，饮服一丸，日三服，不知稍增。

罗注：川椒，筛下种子即为椒目，性味辛，温。 入脾、胃、肾经。温中止痛，燥湿杀

虫。主治脘腹冷痛吐泻，虫积腹痛，湿疮瘙痒。配苦参，地肤子、明矾煎汁熏洗，治湿疹瘙痒。

【方解】本方防己、椒目、葶苈辛宣苦泄，导水从小便而出；大黄泄可去闭，逐水从大肠而去。四药合用，使肠间水气从二便分消而去，水去则腹满消；水去津生，则口干舌燥自解。若服药后反加口渴，则为饮阻气结，故加芒硝以软坚破结。

罗按："肺饮不弦，但喜喘短气"。肺中有水饮，脉不弦，外证表现为喘，呼吸短而困难。为什么不弦，因为肺动脉血注于心，心再输血于脉，隔了一重山。"病患一臂不随，时复转移在一臂"，随，转动动作不灵活，它没说有痛。若是这个情况，加其脉沉细，不是风病也，这是因为有饮在上焦，治从饮家。

胡希恕曰：一般的饮是多弦脉，但肺饮却不弦，咱刚才讲的属于肺饮的都有外邪的关系，他都是咳逆吐涎沫等等，它都有外邪的关系，就是浮而不弦了，但苦喘而短气，他怕你不明白，这苦喘短气都是有外邪的关系，所以搁个肺饮不弦。

黄元御曰：肺病痰饮，金能胜木，故脉不弦。但苦痰饮阻碍，喘促短气耳。

注家曰：水既聚于下，则无复润于上，是以肠间有水气而口舌反干燥也。后虽有水饮之入，只足以益下趋之势，口燥不除而腹满益甚矣。防己疗水湿，利大小便，椒目治腹满，去十二种水气，葶苈、大黄，泄以去其闭也。渴者知胃热甚，故加芒硝，经云，热淫于内，治以咸寒也。

程云来曰：痰饮留于中则腹满，水谷入于胃，但为痰饮而不为津液，故口舌干燥也。上证曰："水走肠间沥沥有声，故谓之痰饮"，此肠间有水气，亦与痰饮不殊，故用此汤以分消水饮。

尤在泾曰：水既聚于下则无润于上，是以肠间有水气而口舌反干燥也，后虽有水饮之入，只足以益下趋之势，口燥不除而腹满益甚矣。防己疗水湿，利大小便，椒目治腹满，去十二种水气，草拐、大黄泄以去其闭也。

【半夏泻心汤治不孕医案】彭海燕 ：

田某，女，29 岁，1990 年 3 月 7 日初诊。婚后 4 年余，3 年前曾于孕 3 个月时无明显诱因自然流产一胎。此后 3 年同居未孕。曾行多种检查及治疗，盆腔碘油造影提示："宫腔形态正常，双侧输卵管通畅。诊刮病检报告："子宫内膜腺体分泌不良"。测基础体温双相，但高温相上升较慢。其爱人精液检查正常。屡服健脾及补肾填精之品不效。患者平素小腹冷感，**胃脘嘈杂胀满**，大便质稀 1～2 次。月经周期正常，末次月经 1991 年 2 月 27 日。舌红苔薄黄腻。证属寒热互结?胞脉受阻而致不孕。治宜调和寒热，理气温经。投半夏泻心汤化裁：

半夏、党参、香附各 12 克，、黄芩、干姜、陈皮各 9 克，黄连、炙甘草各 3 克，大枣 3 枚。服 5 剂，胃脘嘈杂明显减轻，苔薄黄略腻，余症同前。上方去黄芩、香附，加白朮、桑寄生。服药月余来诊，告知月经 40 余天未至，经查怀孕，后足月顺产一男婴。（陕西中医 1992；(5)：225）

按语：脾胃虚弱，寒热与痰湿互结于中焦，气机不畅，胞脉阻滞而致不孕。治又当撇开补肾之传统大法，而予半夏泻心汤以辛开苦降，祛除痰湿，调畅气机。虽不刻意种子安胎，而实收种子安胎之效矣。

【葛根汤合并龙胆泻肝汤治怪病面上肿不能孕】蔡长福：

云南人，四十一岁，没有怀孕，不能吃芒果，不能闻芒果，有人在家里吃芒果，两天以后，她来到家里，闻到芒果气味，脸就肿了。这样的案例我见得不多，开始感觉难以辨证，前人没有讲，后人没有论。这叫什么病呢？我问你身上痒不痒呢？回答说，身上痒。我看她很瘦，没有肉，气不接续，我一搭脉，虽然人瘦，脉非常有力，右脉细长，不浮，我问脸上可有症状，额头难受，眼难受，始终觉得不舒服，按左脉，弦紧有力，右脉虚，左脉弦紧有力，大家想一想，根据这个症状，四十一岁没有怀孕，瘦成这个样子，十二岁就吃芒果，脸

肿，治了一个星期，才把脸肿治好。皮肤病半辈子了，皮肤病耗人，耗营卫，耗血，耗肠胃，当时，我就给她开方，葛根汤领头，重用干姜，重用白朮，重用炙甘草，合并龙胆泻肝汤，二方合一。第二次来见我，跟我说，吃了你的药一个星期，就能吃两个芒果了，然后吃了一个半月，就怀孕了。现在孩子都不小了。芒果过敏，我也很少见过。这是一个葛根汤医案，我用葛根汤加上升麻，专治表证，身上痒。加上龙胆泻肝汤，治疗表有热，里有热，肝经湿热不泻。遇到这种皮肤病，要想到这个方子，如果不对症，可能一辈子都治不好。

【附子汤治不孕案】

张女士，32 岁，结婚八年未孕，多方求治无果。患者四肢常冷，小腹痛胀，月经不至，全身困倦，嗜唾懒言。

综合辨证为下焦虚寒，全身阳气运化不足。开方附子汤，服药 5 天，怕冷腹胀改善。服药月余，反馈周身活畅，诸痛消失，经期准，经色暗红。续服上药一月，肢冷腹痛消失，月经准时，四肢温暖。停药月余，成功怀孕，后诞下一子。

【吴茱萸汤患者婚后两年不孕医案】案例分享：

患者婚后两年不孕，不口干不口苦，睡眠差，容易醒，醒后难入寐，梦多有汗，大便烂小便清，怕冷，脾气大，脉沉细无力，左关弦而无力，厥阴寒化证，7 付吴茱萸汤，远方原剂量，45 克吴茱萸，45 克党参，90 克生姜，12 个红枣。患者夜寐改善，脾气大好，且成功受孕。经方随证治之，魅力大。

【吴茱萸汤治患者婚后两年不孕医案】案例分享：

患者婚后两年不孕，不口干不口苦，睡眠差，容易醒，醒后难入寐，梦多有汗，大便烂小便清，怕冷，脾气大，脉沉细无力，左关弦而无力，厥阴寒化证，7 付吴茱萸汤，远方原剂量，45 克吴茱萸，45 克党参，90 克生姜，12 个红枣。患者夜寐改善，脾气大好，且成功受孕。经方随证治之，魅力大。

【大黄附子细辛汤治 4 年未孕医案】刘大平：

周某，女 26 岁，1987 年 12 月 20 日诊。已婚 4 年未孕。16 岁初潮，每次月经延后 7 天～10 天，甚或淋漓不断，经量少，色紫暗，时有瘀块，并伴有经前 2 日小腹疼痛。痛时欲呕，纳差。某医院检查：输卵管通畅，附件及子宫无占位病变。曾多方求治；均无疗效。刻诊：面色无华，身体瘦弱，精神疲乏，小腹冷感，喜温喜按。舌淡边尖有瘀斑，苔白腻。脉沉弦细，辨证为阳虚宫寒、胞脉瘀阻，治宜温经暖宫、化瘀调经。方用大黄附子汤加味：附子(先煎)30g，细辛、制大黄各 6g，肉桂、吴茱萸各 10g，水蛭粉(兑入药汁冲服)4.5g，益母草 60g。

4 帖后诸症均有好转，原方加入当归、红花各 15g，黄芪 30g，沉香粉 6g，研末加蜜制丸，每服 6g，早晚分服，以图缓治。2 月后复诊，月经正常，腹痛消失，嘱注意起居、饮食，保持心情舒畅。后足月顺产一男婴。(湖北中医杂志 1994；〈5〉：51)

【重用黄连大黄黄连泻心汤面部红肿和不孕的病症】汪阿姨：

患者 25 岁，因为婚后五年未能怀孕，服了一位老中医的中药后，脸廓变得暗红而肿，痛痒难熬。月经淋漓不止，大便秘结，小便黄短，失眠多梦，胃纳不香一年多，经四处诊治，病情依然。后来经人介绍，求治于我的父亲。父亲给她投大黄黄连泻心汤，三帖后就有明显效果，接着给她黄连阿胶汤合黄连解毒汤十帖而愈。过了半年患者就怀孕了，后来足月生产，母子平安。我印象之中，这个病人除了满面红肿之外，身上还有一种难闻的气味，后来随着病症的减轻其气味也逐渐减弱，治愈以后这种气味也就没有闻到了。我父亲说，身上闻到这种气味的人，方中就要重用黄连。

【金匮肾气丸痛经婚后三年未怀孕】娄绍昆：

张某，女，24 岁，张妻的小姑。患者素有痛经，婚后三年未怀孕。据谓经前小腹腰围疼痛已有六年之久，延医诊治终不效，深觉烦恼。来诊时，月经期结束刚一周，诊见两尺脉浮

弱，沉按不见，舌根苔白腻，舌质淡，面色偏贫血貌，腰背、二膝、脚跟酸痛，少腹无力，有不仁感。此证系属肾阳不足，予金匮肾气丸料煎服，嘱其一直服到下次月经来潮为止。患者遵嘱服药，连服 15 剂，经来腹疼消失，后即怀孕。

【六经辨证桂枝汤妇女不孕症的诊治】娄绍昆：

譬如，对于妇女不孕症的诊治，一般不会从伤寒六经人手，然而我受古塞先生的启发，临床上对一些久治不效的试从六经辨证，以当时的主诉为主症，方证对应之时毅然投方，却能时时见效。

张某，26 岁，初诊于 1985 年 10 月 7 日。婚后三年未孕，月经初潮 16 岁，一直先期，量多期长，色淡质稀，基础体温双相，卵泡期短，黄体不健。检查:形体消瘦，神疲乏力，肤色苍白。多年来，时觉恶风自汗，微微发热，但体温正常，脉浮濡而略数，舌淡红，苔薄白腻，腹诊无特殊。治疗:按太阳病中风证论治，投以桂枝汤三剂，解肌祛风，调和营卫，温摄经血。桂枝、生白芍、炙甘草各 10g，大枣 5 枚，生姜 5 片；针刺双侧风池、双侧风门。针药后恶风稍减，自汗略敛，发热转微，.脉浮濡不数。上方加当归 10g，川芎 6g，继服七剂。当月经适期来潮，量中，色暗红，偶有恶风自汗。桂枝汤加味，桂、芍量减半，守方半月，诸症悉除，停药观察，后足月产一女婴。

此案患者，用伤寒六经辨证来分析，属持续多年的太阳中风证，她虽有“恶风自汗，微微发热”等自觉症状，但由于体温正常，就没有引起医家应有的重视。此案治疗时，由于严格掌握太阳中风的基本脉症，并综合各方面的情况，选择了佳枝汤。由于方证契合，针药并用，多年月经先期之病在短期之内一举纠正，随后就出现李梴所论述的“妇人月水循环，纤疴不作而有子”的可喜疗效。

【当归芍药散婚后 5 年不孕慢性输卵管炎医案】赵三立：

谢某某，27 岁。1978 年 2 月 5 日初诊。婚后 5 年不孕。月经后期，量少色淡，面色萎黄，饮食不振，胁肋胀满，腹痛绵绵，小便不利，下肢浮肿。脉沉，舌质淡，苔薄白。某医院诊为慢性输卵管炎。此乃肝脾不调，予当归芍药散加丹参 30 克，败酱草 20 克，山楂 15 克，延胡索、香附各 10 克。以上方为基础，调治 4 个月，月经恢复正常，余症基本痊愈，同年 7 月怀孕。(浙江中医杂志 1990；(4>：81)

【六经辨证桂枝汤妇女不孕症的诊治】娄绍昆：

譬如，对于妇女不孕症的诊治，一般不会从伤寒六经人手，然而我受古塞先生的启发，临床上对一些久治不效的试从六经辨证，以当时的主诉为主症，方证对应之时毅然投方，却能时时见效。

张某，26 岁，初诊于 1985 年 10 月 7 日。婚后三年未孕，月经初潮 16 岁，一直先期，量多期长，色淡质稀，基础体温双相，卵泡期短，黄体不健。检查:形体消瘦，神疲乏力，肤色苍白。多年来，时觉恶风自汗，微微发热，但体温正常，脉浮濡而略数，舌淡红，苔薄白腻，腹诊无特殊。治疗:按太阳病中风证论治，投以桂枝汤三剂，解肌祛风，调和营卫，温摄经血。桂枝、生白芍、炙甘草各 10g，大枣 5 枚，生姜 5 片；针刺双侧风池、双侧风门。针药后恶风稍减，自汗略敛，发热转微，.脉浮濡不数。上方加当归 10g，川芎 6g，继服七剂。当月经适期来潮，量中，色暗红，偶有恶风自汗。桂枝汤加味，桂、芍量减半，守方半月，诸症悉除，停药观察，后足月产一女婴。

此案患者，用伤寒六经辨证来分析，属持续多年的太阳中风证，她虽有“恶风自汗，微微发热”等自觉症状，但由于体温正常，就没有引起医家应有的重视。此案治疗时，由于严格掌握太阳中风的基本脉症，并综合各方面的情况，选择了佳枝汤。由于方证契合，针药并用，多年月经先期之病在短期之内一举纠正，随后就出现李梴所论述的“妇人月水循环，纤疴不作而有子”的可喜疗效。

【金匮肾气丸痛经婚后三年未怀孕】娄绍昆：

张某，女，24 岁，张妻的小姑。患者素有痛经，婚后三年未怀孕。据谓经前小腹腰围疼痛已有六年之久，延医诊治终不效，深觉烦恼。来诊时，月经期结束刚一周，诊见两尺脉浮弱，沉按不见，舌根苔白腻，舌质淡，面色偏贫血貌，腰背、二膝、脚跟酸痛，少腹无力，有不仁感。此证系属肾阳不足，予金匮肾气丸料煎服，嘱其一直服到下次月经来潮为止。患者遵嘱服药，连服 15 剂，经来腹疼消失，后即怀孕。

【桂枝茯苓丸肾盂肾炎未怀孕】娄绍昆：

1976 年 8 月 20 日，张妻，24 岁，永强人。婚后患肾盂肾炎已将两年，时有发作，以致迟未怀孕。后请我诊视。见其脉涩，唇舌色黯，面色萎黄腰酸痛，捶之舒服，人疲思卧，纳差，小便不利，左小腹触之有抵抗压痛的肿块，但不急结，大便正常，经期不定，经色暗、有块。诊断为瘀血停滞为害，予以桂枝茯苓丸料煎服，从活血化瘀法着手调治。三剂后，诸症悉消，精神亦复，后数月遂孕，全家欣喜无限。

【当归建中汤后半月小腹疼恶露淋漓】娄绍昆：

阿光媳妇，25 岁，状元四大队社员，1976 年 5 月 6 日来诊。产后半月小腹疼，恶露淋漓，脉沉细，舌淡，面色苍白，晕眩，脚抽筋，自感恶寒，两腹直肌挛急，按之不适。证属产后营气均虚，投以当归建中汤以补血温中、缓急止痛，一剂知，三剂痊。

【大黄黄连泻心汤五年未能怀孕】汪阿姨

“患者 25 岁，”汪阿姨一边回忆一边说，“因为婚后五年未能怀孕，服了一位老中医的中药后，脸廓变得暗红而肿，痛痒难熬。月经淋漓不止，大便秘结，小便黄短，失眠多梦，胃纳不香一年多，经四处诊治，病情依然。后来经人介绍，求治于我的父亲。父亲给她投大黄黄连泻心汤，三帖后就有明显效果，接着给她黄连阿胶汤合黄连解毒汤十帖而愈。过了半年患者就怀孕了，后来足月生产，母子平安。我印象之中，这个病人除了满面红肿之外，身上还有一种难闻的气味，后来随着病症的减轻其气味也逐渐减弱，治愈以后这种气味也就没有闻到了。我父亲说，身上闻到这种气味的人，方中就要重用黄连。”

真是一个鲜活的病案，一个奇病怪疾，病因病机千头万绪，然而诊治的方法却是如此的简单与平常，疗效如此的快捷与明确，这就是我心中追慕的目标。真要感谢汪阿姨的讲述，虽然我听了之后只知道一个病案的情节与结果，而不知道具体的细节与过程，更不知道其中的机制与原因，但对我来说，这个故事的正面作用已经够大了，够我记忆它一辈子。特别是闻病人体味而辨识用哪一味中药的事实，更是让人叹为观止。中国人认为鼻子是最重要的器官，闻香识臭非它莫属，所以在别人面前称呼自己的时候，往往口中说着“我”，大拇指或者食指会不由自主地指向鼻子。古代中医对辨别病人的身体发出的气味非常重视，这种辨别就是“望闻问切”中的闻诊，被列为四诊中的第二位。然而在漫长的历史过程中，闻诊在临床上偏重于“听声音”，在中医学的典籍中仅仅强调对病人的口腔、分泌物与排泄物的区别。

如口臭为消化不良、龋齿、口腔不洁；酸臭气为内有食积:腐臭气多为溃腐疮疡；身发腐臭气，可考虑有疮疡等，仅此而已。因此，医师的嗅觉也不能像史前时代那样地敏感，更罕见它在诊察中与药征相关的微妙作用的记录。

我与汪阿姨交谈以后，就一直倾力于中医病人身体气味闻诊的探秘，长年累月的留意，一人一病的积累，渐渐地似有所得。在我的临床中这一诊察方法已经发挥着择方选药的作用。无独有偶，后来我遇见江阴的薛蓓云医师，交谈之中，她说自己一闻到某些病人的气味就能知道该用什么方药，这样的心得真是不期而遇。

【血府逐瘀汤治不孕证】

袁某，女，25 岁。结婚 5 年未孕。自 14 岁初潮起，经期少腹及腰部疼痛，拒按，尤以经后期为甚，月经量少，时淋漓不尽，色紫黑夹块。常伴胸闷不舒，胁肋及乳房胀痛。舌紫暗，有瘀斑，脉沉涩。思患者色、脉、证皆为血瘀之象，其不孕当为原发性痛经所致，宜从

经论治，以行气化瘀，调经助孕。方选血府逐瘀汤加减：当归、川芎、赤芍、生地各20克，桃仁、牛膝、柴胡、桔梗、玄胡索各15克，乳香、没药、木香、枳壳、香附各12克，红花10克，甘草5克。水煎，经前2周开始服用，一日1剂。用后当月，疼痛明显减轻，胸闷及乳胁胀痛消失，经量增多，颜色转红，瘀块减少。效不更方，继用原方。二诊之后，诸症消失，月经正常。次年育1女。

第十二节 妇人妊娠诸病

【当归四逆汤妊娠冲疝，痛甚昏厥】

吴饮玉兄令眷，未出室时，左肋下素有气积，时时举发而痛。在家皆用逍遥散治之，罔效。嫁后怀孕三月，此积竟冲心而痛，痛甚昏厥，手足逆冷，口出冷气，脉沉弦而紧。此肝经积冷，结为冲疝，非桂、附莫效。又属世医之女，且怀有孕，举世皆禁桂、附，予何敢用焉？其太翁言修先生曰：大人要紧，胎且置之。遂投以当归四逆汤。桂枝、附子、当归、芍药、炮姜、吴茱萸、甘草、茯苓。服卜即应手取效。每食生冷必发，发则必须前剂。怀孕在腹，屡发屡医而胎竟不伤。今所生之郎，已十有余岁矣。后以东垣酒煮当归丸，服三年未断，其冲疝不发，并形俱消，屡屡生育。《素圃医案·女病治效》

【附子粳米汤治妊娠恶阻医案】夏先福：

杨某，女，23岁，1989年3月诊。受孕月余，呕吐频繁，思热饮，得食则吐，前医以香砂六君子汤、小半夏加茯苓汤等数剂罔效。余诊脉滑而细弱，舌淡苔白且胖嫩，证属脾肾阳虚，寒气上逆。处方：附片30g(先煎)，半夏24g，粳米50g，大枣10g，炙草10g，茯苓20g，肉桂6g。服药呕止。

【附子粳米汤治滑胎(习惯性流产)】夏先福医案：

欧某，女，30岁，1989年4月诊。婚前月经正常，其后每孕5～6月无故流产，先后已流产6次，别无异常。刻诊：脉沉迟细而无力，舌淡苔白且腻，证属肾阳素弱，胎元不固，故立温阳固胎之法。处方：附片30g(先煎)，炙草10g，大枣20g，粳米20g，杜仲30g，阿胶20g(烊化分次兑服)。服药20余剂，其后足月生一男婴。

【黄芪桂枝五物汤治妊娠尿不尽之感医案】：

王金洲医案：刘某，40岁，农民，1979年11月14日就诊。患者妊娠七个月。自述20多天前似有尿不尽之感，症状逐日加重，近几日来频频入厕，但所溺甚少，伴少腹胀痛，疲乏无力，头晕眼花。舌质淡红，苔薄白，脉虚滑。处方：黄芪60克，桂枝10克，白芍12克，升麻6克，通草10克，生姜4片，大枣6枚。2剂后小便增多，少腹胀痛减。继服3剂，小便得通，伴随症状也随之消失。(河南中医1987；<5)：43)

【半夏泻心汤加乌梅妊娠恶阻】

嵘城朱茂盛店主妇瑞英，年三十有奇，妊娠六七月，一闻谷气即呕恶，连声不断，不得饮食者二十余日。其间有谓胎气上逆，以安胎为主，用苏梗、枳壳、砂仁、白术、黄芩等味者；有谓脾胃虚弱不能容受而然，以安胃为主，用参术苓甘四君加广皮者；有谓阴中火虚，气不归元，用景岳理阴煎者。杂投无效，求治于余。诊脉两手弦数，谓曰：此乃体质虚弱，触动肝气，所以木郁生火，心阳因之上亢。治宜半夏泻心汤加乌梅，取其辛以开之，苦以降之，补以运之，酸以收之，始中病情。有同道某不读圣经，谓妊娠可用半夏乎？余固争之曰：此证当重用半夏。以痰气阻塞中脘，阴阳拂逆，非半夏不除。经曰：有故无殒，亦无殒也。先生岂未之知耶？彼无从辨，但云：且看服后何如。余谓一剂而呕立止，二剂而进米饮，三剂而能食粥，效可预必。服之果如所言，心以为喜而已。出处：《医案梦记》。

【四逆当归补血汤加味妊娠胎漏(先兆流产)】

范××之妻，年二十八岁，四州省会理县人。身孕六月，某日因家务不慎，忽而跌仆，遂漏下渐如崩状，腰及少腹坠痛难忍，卧床不起。因其夫公务未归，无资以疗，延至六、七日，仍漏欲堕。余往诊之，气血大伤，胎恐难保，惟幸孕脉尚在，以大补气血，扶阳益气引血归经为治，纵虽胎堕，可保产母无损矣。拟方四逆当归补血汤加味治之。

附片 100 克，北口芪 60 克，当归身 24 克，阿胶 12 克(烊化兑入) 炙艾叶 6 克，炙甘草 10 克，大枣 5 枚(烧黑存性)

服一剂，漏止其半，再剂则全止，三剂霍然，胎亦保住，至足月而举一子，母子均安。

按：附子补坎中一阳，助少火而生气，阳气上升，胎气始固。芪术补中土之气，脾气健运，则能统摄血液以归其经，入当归、阿胶以资既伤之血。艾、附相伍，能温暖下元以止腰腹之疼痛。姜、枣烧黑、取其温经止血，且烧黑变苦，得甘草之甘以济之，苦甘化阴，阴血得生。阳气温升，阴血能朴，则胎不堕矣。

《内经》云："治病必求其本。"本固而标自立矣，若只以止血为主，而不急固其气，则气散不能速回，其血何由而止？

【四逆当归补血汤加枣艾半产血崩(流产失血)】

方××夫人，年三十五岁，罗平县人，住云南省昆明市红栅子十号，素患半产。1923 年 5 月 12 日，孕五月又堕。初起腰腹坠痛，继则见红胎堕，血崩盈盆成块，小腹扭痛，心慌目眩，气喘欲脱，脉芤虚无力，两寸且短。唇淡红，舌苔 白滑，舌质夹青乌。据其夫云，是晚曾昏绝二次。由于素患半产，肾气大亏，气虚下陷，无力摄血，阳气有随血下脱之势。以气生予肾，统于肺，今肺肾之气不相接，故气喘欲一脱。拟四逆当归补血汤加枣艾治之。方中四逆汤扶阳收纳，启坎阳上升，佐以口芪、当归，补中益气而生过伤之血，干姜、艾、枣制黑，能温血分之寒，引血归经。

黑附片 160 克，炮黑姜 50 克，炙甘草 24 克，北口芪 60 克，当归 26 克，蕲艾 6 克(炒黑存性) 大枣 5 枚(烧黑存性)

13 日服一剂后，血崩止，气喘平，病状已去六、七，精神稍增。仍守原方，14 日次剂服完，证遂全瘳。

【当归芍药散加大黄治疗妊娠的高血压】矢数道明：

患者 34 岁，女，初诊于 1972 年 9 月，1970 年起血压高，190/ 110 不容易降下，以醛甾酮增多症嫌疑接受检查，但不能确诊患肾上腺皮质肿瘤。已生过两个小孩，自觉症状有颈、肩凝和头重，食欲一般，大便正常。初诊时血压 180 / 105.

治疗：服柴胡加龙骨牡蛎汤，后来改服八物降下汤，但血压有时 150/ 100 有时 180/ 110 很不稳定。

1973 年 5 月没有月经，6 月去曾经检查的医院检查结果有了妊娠，尿蛋白(十)医生告诉患者如果血压升高，尿蛋白严重，应中止妊娠。但患者不想中止妊娠，说服汉方药可以坚持下去。我劝她去某大学医院检查，在某大学医院内科和妇产科检查结果血压 200 傅山曰：10，我劝患者去引产，而患者不想引产而坚持要服汉方药。

针对有点便秘而让服当归芍药散料和大黄 0.3，结果血压降为 150/90，我鼓舞患者保重身体，11 月尿酸逐渐增加，有引起妊娠肾的危险，12 月中旬住医院时血压 200/ 120，我担心会发生危险。1974 年 1 月 15 日却无事，安全地生了女孩子，母子健全，非常高兴。只是一事遗憾，在妊娠中，胎位偏左侧，我以为会生男孩而等待着，但却生了女孩。患者说生女儿也很好而高兴地笑了起来。以后母亲日益康复，婴儿长得很快，很健康。《汉方的临床》1974 年 7 月。

罗按：当归芍药散方证的作用部位为少腹部。王付曰：气血两虚夹湿证代表方是当归芍药散。针对有点便秘而加大黄。

当归芍药散方：

当归、川芎（各三两），芍药（一斤），茯苓、白术（各四两），泽泻（半斤）

上六味，杵为散，取方寸匕，温酒和，日三服。

【当归芍药散呕吐全身黄色鲜明周身浮肿医案】金芝芳：

陶某某，女，22 岁，农民。妊娠 8 月，今证见全身黄色鲜明，周身浮肿，以面部及双下肢为甚，按之凹陷，恶心呕吐，纳呆，腹胀食后为甚，口渴不欲饮，大便溏，小便深黄，舌质淡，苔白厚，根部稍黄，脉弦细滑数。肝功能：黄疸指数 40 单位，碘试验++，麝浊 20 单位，谷丙转氨酶 175 单位(赖氏法)。辨证为肝郁脾虚，湿热内蕴。治以养血调肝，健脾利湿，清热退黄。药用：当归 12 克，白芍、白术各 15 克，川芎 6 克，茯苓、泽泻各 20 克，茵陈 40 克，藿香 10 克。

3 剂后呕吐止，但腹胀甚。上方去藿香加枳壳 15 克，连进 20 剂，顺产一男，黄疸、浮肿均消退，食欲增加。复查肝功能：黄疸指数 7 单位，谷丙转氨酶 30 单位。改用逍遥散 10 剂以调理肝脾善后。(浙江中医杂志 1986；<10>：467)

第十三节 妇人产后病

【猪苓汤产后患慢性肾炎医案】聂惠民：

于某，女 28 岁，1963 年 10 月初诊。患急性肾盂肾炎。1963 年秋，产后合并尿潴留，行留置导尿术三天，并配合针灸治疗而愈。一月之后，突然发热恶寒(体温 38～39℃)周身酸楚，腰酸且痛，恶心不欲食，小便稍频，脉浮数，苔白。就诊于某院名医，因产后月余，形体消瘦，医者遵“产后宜温”之理，拟疏解外邪之剂，并重用黄芪、党参等品。服药两剂，自觉周身热甚，犹如有热气从肌腠中向外蒸发，烦热难忍，衣被难着，不得安卧，尿频尿急，尿量不多，便后尿道灼痛，脉浮数且细，苔淡黄。尿常规：蛋白+，红、白细胞满视野。医者见温之不得，又现热淋之证，故改投清热利湿之剂，重用木通、车子、扁蓄等通利之品，服药三剂，诸症增剧，出现肉眼血尿，小便频数不减，以致入厕不欲起身。余诊之，见病不解，反致血淋，此乃通利过度，事得其反，导致疾病剧变，故更前法，改用：

猪苓汤加金银花、大蓟、小蓟、藕节、白茅根。

服药数剂，病热始衰，继服前方取效．治疗月余而痊愈，未见复发。《伤寒论与临证》

【回阳饮加味产后失血】

苏××，女，三十五岁，住昆明某医院妇产科。分娩第三胎，产后子宫收缩无力，遂致流血不止。经医院施以针药及输血治疗，出血仍不见终止。病已三日，病势日趋危重，于 1952 年某日邀余前往会诊。患者卧床，已人事不省，面色苍白，目眶凹陷，形容憔悴，呼吸微弱，唇干色淡。掰开口唇，见齿枯舌淡而少津，脉细弱沉伏欲绝，手足冰冷。阴道流血仍未止，色淡而清，浸透垫褥。此系阳弱气虚，气不摄血，血不归经所致。患者失血过多，气血两亏，病势沉重，危在旦夕。若继续出廊，恐有气随血脱之虑。补血及输血之法，固属必要，然已虚之阳无力摄血，无力生血，血亦不能归经循行。此证急当扶阳益气，方能止血固脱。拟大剂回阳饮加味主之。

附片 120 克，炮黑姜 15 克，上肉桂 15 克(研末，泡水兑入) 口芪 30 克，当归 15 克，炒艾 9 克，炙甘草 9 克

因病情较重，嘱早晚各煎服一剂，多次徐徐喂之。

次日复诊。昨日方药浓煎频频喂服，服后，今日流血已减其半，神识恢复，能饮葡萄糖水二、三口，呼吸稍觉平稳，手足开始回温。唇、舌仍淡，脉沉细弱，已不似昨日欲绝之状。此阳气已回，有望生机。继上方加阿胶珠 9 克，炒白术 9 克连服五剂，流血已止，神识清明、面色渐润，并能背靠床头坐卧，进牛奶及半流汁饮食。惟气血尚虚，阳神尚弱，久坐则感头

昏无力，夜寐多梦，气短心慌，声低懒言。舌质已稍现红润色，脉沉细而缓，两尺较弱。拟四逆汤加味治之。

附片 90 克，干姜 12 克，砂仁 9 克，口芪 24 克，白术 15 克，茯苓 15 克补骨脂 12 克甘草 3 克

上方连服八剂，患者食思倍增，面色润泽，精神恢复。继后以四逆当归补血汤及黄芪桂枝五物汤数剂调理善后，住院一月痊愈出院。其后于 1964 年相遇，询及十余年来，身体健康。

【附子粳米汤治产后腹痛医案】夏先福：

张某，女，26 岁，1988 年 10 月诊。5 天前因横位难产入院，立即施剖腹产术。术后两天，忽然脐腹作响，绞痛，上腹部凸起一个包块，便秘不通，呕吐频繁，X 光透视诊断为术后高位肠梗阻，嘱其再次手术，病者不愿手术，故求中医治疗。刻诊：脉细无力，舌淡苔白，证属肠胃虚寒，阳气式微，阴寒内结。处方：附片 30g(先煎)，炙草 10g，红参 10g，半夏 20g，粳米 50g，大枣 15g，大黄 6g(后下酒炒)，日服 5 次。5 小时后，诸症顿减，后以附子理中丸巩固。

【当归生姜羊肉汤治产后腹痛医案】李翠萍医案：

刘某，女，27 岁。产后第五天，感腹部冷疼，得温稍舒，恶露量少色暗，舌淡苔白，脉细弱无力。系产后血虚肝寒之腹痛证。用当归生姜羊肉汤加味治之：当归 10 克，羊肉 1 斤，生姜、大茴、桂皮、葱白适量，盐少许。共煮取汤，以汤煮挂面和鸡蛋，与羊肉共食之。1 剂而愈。（国医论坛 1987；(4>：38)

注家按语：肝主藏血而养筋，产后血虚，寒动于中，少腹失其温煦，故筋脉挛急而痛。《素问·藏气法时论》云：“肝苦急，急食甘以缓之。”《素问·至真要大论》亦云：“寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛。”当归生姜羊肉汤温肝散寒，缓急止痛。对于妇人产后及平人虚劳不足之腹痛，即血虚内寒所致者，均有良效。

【当归生姜羊肉汤治产后寒痹气厥医案】辛军：

祝某，女，41 岁，藏族，1992 年 12 月 4 日诊。产后患全身麻木痹痛 8 年。，近 2 年又增生气后晕厥。自述生头胎时，产后不忌冷水而感受风寒，致全身痹痛，至生二三胎时渐加重，但自恃体壮不就医。近 2 年又出现生气后晕厥，伴口吐白沫，四肢抽搐，但患者初晕倒时心中甚明白，约 1min 左右就失去知觉，历时 20min，晕厥频繁，痹痛与麻木愈来愈重。只能在心情愉快时，痹痛才有所缓解，近日又做“人流”1 次，痹痛弥加，不能忍耐，且畏寒恶风，嗜睡健忘，舌淡，苔白，脉弱迟几天。

辨属产后受风寒，气血亏损，阳气大虚，厥阴寒逆，故见痹痛、气厥证。治宜养血活营，温阳降逆。仿仲景当归生姜羊肉汤加味：当归、生姜各 30g，羊肉 500g，桂枝、山萸肉、肉桂各’10g，代赭石 15g。日 1 剂，水煎，早晚各 1 服。

连服 8 剂，痹痛麻木明显好转，但觉口干苦，是厥阴寒除，相火壮旺。原方略事加减，继进 4 剂，自述生气后不再晕厥，精神好转，痹痛亦愈。1993 年 2 月虽又因生气而致血崩，但未出现晕厥。(国医论坛)

注家按语：痹与气厥本为两病证，但在病机上属血虚寒凝，厥气上逆则一。以当归生姜羊肉汤温散寒逆，借代赭石重坠引药直达下焦，兼治气逆，桂枝、山萸肉和肝平冲降逆，故一药而两病证皆除。

【当归生姜羊肉汤治产后发热医案】张介眉：

胡某某，女，38 岁。因滞产早破水而行剖腹产，第 3 日出现高热，体温波动于 39～39.5IC 之间，疑术后感染，治疗 10 余日罔效。刻下诊见：发热，微恶寒，口干喜热饮，二便调，食减，面色苍白，腹软无压痛，恶露少许，色淡红，无异味，舌淡苔薄白，脉弦数，重取无力。白细胞总数 11.6×10。/L，中性 82%，淋巴 18%，此为产后失养、气弱血虚、阳浮外越证。治以温里散寒、补益气血法。拟当归生姜羊肉汤方：当归 50 克，生姜 10 克，羊肉 100 克，

炖服，每日一剂。服 3 剂后热退，体温正常，无恶寒感，但喜热饮，脉弦细，舌淡，续进 1 剂，将息调养而愈。(湖北中医杂志)

注家按语：本例发热，微恶寒，口干喜热饮，舌淡苔白，显非实热。《素问·生气通天论》曰："阴者，藏精而起亟也，阳者卫外而为固也"。今剖腹而产，失血过多，气随血失，势必阴不能藏精而起亟；阳不能卫外而为固，虽受微寒，易致表里失和，而为发热恶寒等证。本案无腹痛，似乎方证不符，然则血虚而寒伤里，则多为腹痛。若血虚而卫外不固，寒伤于外，则多见发热恶寒等，是病证不一，而原因略同。治以当归生姜羊肉汤，内证得之，则能温补气血，以散内寒；外证得之，则补内调外，以退寒热。

【黄芪桂枝五物汤治流产后每逢经行及经后小腹疼痛医案】金志春：

李某，女，35 岁，孕 4 产 2，人流 2 次。患者自去年流产后，每逢经行及经后小腹疼痛，经量少、色暗，有时有小血块，伴有小腹轻度发凉，面色苍白无华，唇淡，舌质淡、舌边轻度紫暗，脉细无力。证为气血亏虚，冲任不足，胞宫失养兼瘀血阻滞胞络之痛经。治以调补气血，滋养冲任，兼以活血祛瘀，通畅胞络。方用黄芪桂枝五物汤加味：黄芪 15 克，桂枝、赤芍、生姜、大枣、当归各 10 克。上方每次经净后连服 5 剂。平时注意调节饮食，加强营养，连续治疗 3 个周期，痛经消失。(陕西中医 1991；(12)：552)

【一味独参汤产后大出血的案例】刘渡舟：

我治过一个产后大出血的妇女，脸色像黄纸，眼睛睁不开，看不见东西，脉似有似无，很急，就用一味独参汤，将一两人参浓煎，喝下以后鼻子上就见汗，眼睛随后就睁开了，下边血也止了。

【桃仁承气汤合大陷胸汤、抵当汤死胎不下医案】黎庇留：

简某之妻，分娩后腹大如鼓，次日更大，医生以普通的生化汤加减与之，日大一日，腹痛异常。有以予为荐者，病家鉴于其邻近之产后腹痛肿胀，用温补而愈者多人。以为予好用热药，未敢来请。迨延五日，其大如瓮，几有欲破之势。且下部气不至而坚硬矣，始延予诊。

审问其产时，胎已先死而血与水点滴未流。予断此为水血相混，腐败成脓如大疮然；热极，气滞而肿也。病毒如此剧烈，非大猛烈之剂不能攻取。深思良久，乃与桃仁承气汤合大陷胸汤与之。服后下脓血大半桶，其臭不可响迩。腹肿消九成，所余茶蒌大者，居脐右，仍痛不可耐。予继投寻常攻痛之药，不少动。因谓病家曰；此燕师之下齐七十余城，独即墨负固为牢不可破。故不得不为抵当汤，直捣中坚，一鼓而下。奈五月盛暑亢旱，村落水蛭颇不易得。寻觅数日，始获四五条，合虻虫如煎法服。计前后三剂中，水蛭用至二十余条，肿势日渐消尽，身体如常矣。

再三年后，此妇又连产三子，由其体质强健故尔。此症使当时稍有因循规避之见，不敢放心放胆，则命不可保矣。《经方医案集》

论：瘀血积聚，牢不可破，是为抵当，所以名为抵当汤也。桃仁，大黄，水蛭，虻虫，尽为攻破之能事，水陆空三军，直捣中坚，破其抵当，一鼓而下，故名抵当汤。这个抵当，是以病证命汤名。以抵当之名，而诠释难治之意。

【小柴胡汤治产后数日大便难呕不能食微眩晕医案】易庆棠：

丙戌岁，同邑吕少薇之妻，生产后数日，大便难，呕不能食，微眩晕。医者用补药未效。延予诊视。主以小柴胡汤，柴胡用至八两。举座哗然，以为服此方必死。吕叔骏明经，少薇之叔也。知医道，力主服予方。谓古人治产妇郁冒原有是法。一服即愈。

小柴胡汤方：
柴胡八两，黄芩三两，人参三两，甘草三两（炙），半夏半升，生姜三两（切），大枣十二枚（擘）
上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，更煎取三升，温服一升，日三服。

罗注：仲景曰："产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出。所以然者，

血虚而厥，厥则必冒，冒家欲解，必大汗出；以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出也。所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复；大便坚，呕不能食者，小柴胡汤主之。”

用柴胡汤透少阳之热，解少阳之气郁。据《神农本草经》载，“柴胡治肠胃中结气，饮食积聚”。说明柴胡可促进六腑的新陈代谢，有消食化积的作用。小柴胡汤应以解热剂为主。临床应用时，据病情变化而加减变化。若胸中烦而不呕，去人参之甘补，半夏之辛温，加瓜蒌实清热除烦；若渴，去半夏之燥，加瓜蒌根，人参，甘苦凉润，清热益气，生津止渴；若腹中痛，去黄芩之苦寒伤中，加芍药制肝益脾，缓急止痛；若胁下痞硬，去大枣之壅补，加牡蛎软坚散结；若心下悸，小便不利，去黄芩之苦寒，加茯苓淡渗以利水；若不渴，身有微热，去人参之壅补，加桂枝以解外；若咳者，去人参，大枣之甘温壅滞，生姜之辛散，加五味子，干姜温肺止咳。

临床应用于以下几个方面：治产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出等症；治阳毒伤寒，四肢壮热，心膈烦躁，呕吐不定，以本方加减；治疗肝胆疾病，急慢性肝炎，急慢性胆囊炎以及胁痛，吐酸不食；治疗普通感冒及流感，支气管炎肺炎等；治肾小球肾炎，肾盂炎，月经适来适断，以小柴胡汤加入丹皮、桃仁、生地、赤芍、红花、延胡等活血化瘀之品。综上所述，小柴胡汤广泛应用于临床不仅是治疗外感的常用方，也是治疗内伤杂病的重要方。现代临床上小柴胡汤的应用已逐渐扩大，不再局限于少阳病，广泛用于内、外、妇、儿科疾病的诊治，凡证但见气郁、痰阻之病机，即可用此方加减灵活应用，不必拘于某症，上焦得通，津液得下，全身气机运行通畅，则疾病可愈。

高学山曰：产妇郁冒，与平人不同，且郁冒之脉，或大且强，今不大而微，不强而弱，适合产妇平脉，尚未至正败无权，邪入为主也。冒则胃逆，故不能食，郁则脾陷，其便易溏，以血虚津伤而胃燥，故大便反坚，血虚于下，气盛于上，为阴不平阳不闭，故但头汗出，所以然者，血本阴而涵阳，血虚而阳反内陷故厥，厥者，手足逆冷也。气本阳而育阴，汗出，而阴随外越故冒，冒者，心神蒙昧也。幸脉见微弱，邪未夺正，当攻补两难之际，勿妄治之。俟其气过血还，阴阳复通，因气过不升动其血，则血还而送泄其气，故得汗而冒解，此郁冒之始于厥，而终于汗之道也。症中但头汗出，大似可下之候，而实非者，以新产血虚，则下寒而下厥，孤阳失附，则上热而上蒸，故头汗耳，若误认而早下之则危矣。至郁冒之不解于头汗，而必解于通身之汗者，因产妇亡血，而血乍虚，则阳气自长而孤盛，故冒于外，阴虚，故不能送之外泄，而尚自郁滞也。夫汗自出者，是阴生而阳泄，故阴阳复得其平矣。若郁冒既解，所有便坚、呕不能食二症，当先主小柴，以解其热上冲之气，令呕止能食，至七八日更发热者，是确于七八日之中，积其所食者，而为胃实外蒸之所致，然后可直任大承下之。而无所顾虑矣。

【安冲汤小产后数日忽又下血医案】张锡纯：

一妇人，年二十余。小产后数日，恶露已尽，至七八日，忽又下血。延医服药，二十余日不止。诊其脉，洪滑有力，心中热而且渴。疑其夹杂外感，询之身不觉热，又疑其血热妄行，遂将方中生地改用一两，又加知母一两，服后血不止，而热渴亦如故。因思此证，实兼外感无疑。遂改用白虎加人参汤以山药代粳米。方中石膏重用生者三两。煎汤两盅，分两次温饮下。外感之火遂消，血亦见止。仍与安冲汤，一剂遂全愈。又服数剂，以善其后。

安冲汤方：医学训中参西录）
治妇女经水行时多而且久，过期不止或不时漏下。
白术六钱（炒），生黄芪六钱，生龙骨六钱（捣细），生牡蛎六钱（捣细），大生地六钱，生杭芍三钱，海螵蛸四钱（捣细），茜草三钱，川续断四钱。

【抵当汤治半产后脉紧而脐下结硬血不得下医案】日本《生生堂治验》：

一妻，半产后，面色黧黑，上气头晕，先生诊之，脉紧而脐下结硬，曰:此有蓄血也，即

与抵当汤，三日而觉腰以下宽舒，更与桃仁承气汤，俄顷，果大寒战，发热汗出，谵语，四肢搐搦，从前阴下血块，形如鸡卵者，六日，约下二十余枚，均用前方，所患若失。

【产后营卫气血不足新加汤医案】郝万山：

有一家矿工的年青的媳妇坐月子，生完小孩二十天，发烧十天，身上疼痛十天，我们到家里给她看病，当然我们就想到是气血两虚，肌肤失养，所以开始我给她用八珍汤，吃了三付，没效果，还是疼，后来又用人参养荣汤，还是没效果。

我和刘渡舟老师住一个房间，我说，刘老，我遇到一个产后身痛的病人，我用补气养血的方法，怎么没有效啊，她又没有感冒的症状。他说，你用的什么方子，我说，八珍汤我用过了，人参养荣汤我也用过了。

他说，你应当用《伤寒论》中的方子桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤，这张方子是在桂枝汤里加重芍药的用量来养血柔筋止痛，加重生姜的用量来引药达表，另外加人参来益气。那么我在开这个方子的时候，产妇在产后出汗很多，一动就冒汗，我心想生姜不能多用，更何况生姜很辣，因为我吃饭的时候特别讨厌生姜，我就想到别人也讨厌，所以生姜我用了三小片，其它的药还是正常的，吃了三付，还没效果。

我说，老师，您告诉我的那个新加汤，我给病人用了，我给人家看了九天了，人家身疼已经十天，现在又是九天，都二十天了，身痛不能缓解，吃了您的那个方还没效。

你把方子拿来我看看，我就把方子给他看。老师说，生姜三片，多大三片，我说，三小片。他说，为什么这么少。我说，她产后出汗这么多，我不敢给她用辛散的，更何况生姜太辣。老师说，你知道新加汤中用生姜的意义吗？我说，它还是引药达表吗？你用这么点药怎么能够引药达表。我说，她还出汗呢。

他说，你现在不是在用补气养血的药吗？（生姜）引药达表（但量小），她就不会发汗，它是补益肌表的气血来营养肌肤，治疗身痛的。

我说，那生姜用多少，他说，用 15 克，你直接写清楚 15 克，称完了让她切片。我说，老师，会不会太辣？他说你是给她做饭呢，还是给她配药？

用完 15 克，生姜以后，病人吃完了，汗并没有多，吃了二付身痛减轻，吃了三付身痛好了。回来我说，刘老，那个病人好了。他说，是啊，你看这个方子，你就是把生姜按照原来的剂量比例用它就有疗效。

我说，老师，我用人参养荣汤，八珍汤并没有错啊。他说，你养内脏的气血是没有错的，她现在是气血不足，肌肤失养，它不能引药达表，所以治不了身痛。所以“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。从那之后我再用新加汤治疗，营血不足，肌肤失养的身疼痛的时候，就知道这个生姜的量是不能够少的。

【当归生姜羊肉汤治产后身痛加味】杨洪安：

王某，女性，27 岁，1999 年 3 月 10 日初诊。患者 2 个月前生产时失血过多，致身体虚弱，动则汗出。产后 2 周又不慎受风寒，开始感觉四肢关节酸痛怕冷，继之遍身关节酸痛，肢体麻木，以下肢为重，多方治疗效果不佳而来诊。诊见患者精神不振、面色萎黄，舌质淡红少苔，脉细而无力。检查未发现异常体征。

诊见患者精神不振、面色萎黄，舌质淡红少苔，脉细而无力。检查未发现异常体征。辨证为产后气血双亏，风寒乘虚而入，痹阻脉络，筋脉关节失养。治以补血益气、温经散寒、通络止痛。方用当归生姜羊肉汤加味，服 10 剂后诸症消失而愈。随访半年未复发。(中国民间疗法)。

罗按：我为什么要把这个医案放在这呢？是让读者作一个对比，特别是郝老说的那句话：“治疗，营血不足，肌肤失养的身疼痛的时候，就知道这个生姜的量是不能够少的”。我们广东的乡下有个流传不知多久的习惯，就是产妇生产后天天也吃鸡蛋加生姜加酒汤，天天吃，甚至引起年轻人的反感，她们问为什么总吃这个，大家也说不出所以然，但是家家户户必然

这么做。说明生姜这个东西的血气亏虚身痛的实际作用。

【血府逐瘀汤郑氏等产后缺乳】

用桃仁、红花、赤芍、当归各10g，川芎、桔梗、柴胡、枳壳、香附、炮山甲、王不留行各8g，甘草3g，治疗1例，疗效极佳。47、鲍氏等视网膜静脉阻塞。用血府逐瘀汤为主方（桃仁、川芎、牛膝、枳壳、柴胡、桔梗各10g，红花12g，当归尾、生地黄、赤芍各15g，甘草6g，另三七粉5g冲服）加减:年老体虚伴头痛头晕、腰膝酸软、耳鸣、五心烦热者去枳壳、柴胡、桔梗，加熟地黄、山药、山茱萸、知母等滋阴补肾;伴心烦易怒，口红舌干者去枳壳、桔梗，加石决明，夏枯草、草决明等清肝泻火;伴眼胀、心烦闷、胁胀痛者去桔梗，加郁金、泽兰、白芍等疏肝平肝;有视网膜水肿者加泽泻、车前子等利水消肿。治疗32例，显效17例，有效11例，无效4例;有效率为87.5%。48、李氏等慢性喉喑。予柴胡、红花、牛膝各12g，枳壳、生地、赤芍、木蝴蝶、桃仁各15g，浙贝、海浮石、南沙参各20g，桔梗10g，甘草6g，一般20剂后，诸症消失。李氏等还用血府逐瘀汤加减治耳胀耳闭，鼻窒，疗效亦颇佳。

【血府逐瘀汤治疗产后气虚】：

一产妇，27岁。4天前在人民医院妇产科剖腹产得一女婴，产后一直全身无力，四肢不温，经常感到肢体麻木，给予益气生血之剂效果不显，故转中医科调治，就诊时半卧于床上，声低气微，面色泛青，少腹部有局部青紫，全身血管脉络青紫可见，舌暗红，脉涩。自诉自少女时便开始痛经，经色黑暗有血块。处方：桃仁12g　红花12g　当归15g　生地12g　丹参12g　牛膝12g　郁金12g　甘草6g　川芎9g　香附9g　赤芍9g　干姜9g　益母草12g　大枣5枚。从症状上看患者一派气虚血虚之象，妇产科已经注意到“产后多虚”的特点，却没有注意到“产后多瘀”的特点。从舌脉上看此产妇有瘀无疑，而从其剖腹产后少腹局部青紫，全身血管脉络也青紫可见，说明“瘀”的程度还不轻。中医有“血为气之母”的说法，此病案中的患者自少女时起就痛经并经出瘀血，说明其本身有瘀，“产后多瘀”又加重了瘀血的程度，瘀血阻滞脉络、脏腑、肢节等部位，就容易缺乏血的供养从而出现气虚血少。这就是失去了所谓的“血能养气”的功能，剖腹产必然会导致大量出血，一者离经之血未能及时消除，再者“气随血脱”往往导致气机涣散不收之象。“瘀”为此病之本，病根不除，气虚血虚之象很难缓解。所以用血府逐瘀汤祛瘀血，加香附、益母草以活血调经，丹参、郁金以活血化瘀，消瘀化滞，干姜温阳，大枣补益气血。若“瘀”得去，再加以后期补养，则气血虚衰之象必当得愈。

【小产后寒热腹痛医案】张璐：

又治一贵显之媳,小产后寒热腹痛,亦有前证,与炮黑楂肉、熬焦黑糖为丸,用伏龙肝煮水澄清,煎独参汤送三钱,一服结粪大下,再进瘀血续行,而前证顿止,始悟猪膏发煎,皆为逐瘀而设,虽皆未用其方,而实不离金匮之法也。

【当归生姜羊肉汤治产后发热医案】张介眉：

胡某某，女，38岁。因滞产早破水而行剖腹产，第3日出现高热，体温波动于39～39.5IC之间，疑术后感染，治疗10余日罔效。刻下诊见：发热，微恶寒，口干喜热饮，二便调，食减，面色苍白，腹软无压痛，恶露少许，色淡红，无异味，舌淡苔薄白，脉弦数，重取无力。白细胞总数11.6×10。/L，中性82%，淋巴18%，此为产后失养、气弱血虚、阳浮外越证。治以温里散寒、补益气血法。拟当归生姜羊肉汤方：当归50克，生姜10克，羊肉100克，炖服，每日一剂。服3剂后热退，体温正常，无恶寒感，但喜热饮，脉弦细，舌淡，续进1剂，将息调养而愈。(湖北中医杂志)

注家按语：本例发热，微恶寒，口干喜热饮，舌淡苔白，显非实热。《素问·生气通天论》曰：“阴者，藏精而起亟也，阳者卫外而为固也”。今剖腹而产，失血过多，气随血失，势必阴不能藏精而起亟；阳不能卫外而为固，虽受微寒，易致表里失和，而为发热恶寒等证。本案无腹痛，似乎方证不符，然则血虚而寒伤里，则多为腹痛。若血虚而卫外不固，寒伤于

外，则多见发热恶寒等，是病证不一，而原因略同。治以当归生姜羊肉汤，内证得之，则能温补气血，以散内寒；外证得之，则补内调外，以退寒热。

【当归生姜羊肉汤治产后腹痛医案】李翠萍：

刘某，女，27 岁。产后第五天，感腹部冷疼，得温稍舒，恶露量少色暗，舌淡苔白，脉细弱无力。系产后血虚肝寒之腹痛证。用当归生姜羊肉汤加味治之：当归 10 克，羊肉 1 斤，生姜、大茴、桂皮、葱白适量，盐少许。共煮取汤，以汤煮挂面和鸡蛋，与羊肉共食之。1 剂而愈。(国医论坛)

注家按语：肝主藏血而养筋，产后血虚，寒动于中，少腹失其温煦，故筋脉挛急而痛。《素问·藏气法时论》云："肝苦急，急食甘以缓之。"《素问·至真要大论》亦云："寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛。"当归生姜羊肉汤温肝散寒，缓急止痛。对于妇人产后及平人虚劳不足之腹痛，即血虚内寒所致者，均有良效。

【异功散治产妇咳而胸满不食涕唾面肿气逆医案】：

咳嗽一产妇咳而胸满不食，涕唾，面肿气逆，此病在胃而关于肺，用异功散而愈。(《校注妇人良方》)。

【资生汤治产后虚劳医案】奉天法库县万生来函：

族弟妇产后虚羸少食，迁延月余，渐至发灼、自汗、消瘦、乏气、干呕、头晕等证，此方书所谓蓐劳也。经医四人治不效，并添颧红作泻。适生自安东归，为之诊视，六脉虚数。检阅所服之方，有遵《医宗金鉴》三合饮者，有守用养荣汤者，要皆平淡无奇。然病势至此，诚难入手，幸脉虽虚数，未至无神，颧虽红，犹不持聚（若持聚则阴阳离矣，不持聚是其阴阳犹未离），似尚可治。此盖素即阴虚，又经产后亡血，气亦随之，阴不中守，阳不外固，故汗出气乏；其阴阳不相维系，阴愈亏而阳愈浮，故发烧咳嗽头晕；其颧红者，因其部位应肾，肾中真阳上浮，故发现于此，而红且热也；其消瘦作泻者，以二阳不纳，无以充肌肉，更不特肾阴虚，而脾阴胃液均虚，中权失司，下陷不固，所必然者。此是病之原委欤？再四思维，遂处方，用生怀山药二两，于术三钱，玄参四钱，鸡内金、牛蒡子各二钱（此系资生汤原方稍加重），外加净萸肉、龙骨、牡蛎各五钱，止汗并以止泻。五剂后，汗与泻均止，饮食稍进，惟干咳与发热仅去十之二三。又照原方加粉甘草、天冬、生地等味，连服七剂。再照方减萸肉，加党参二钱，服四剂后，饮食大进，并能起坐矣，惟经尚未行。更按资生汤原方，加当归四钱。服数剂后，又复少有加减，一月经脉亦通。

【红蓝花酒产后恶露不尽医案】王明宇：

汤某某，女，26 岁。1982 年 1 月 10 日诊。初产恶露未尽之时，过食生冷而发生腹痛，已三月。某医处以加味四物汤后，恶露止，腹痛亦减。尔后腹痛时作，缠绵不休。昨晚突然腹中刺痛，时而增剧而昏厥，随后经至排出少量瘀血块，腹痛减轻，手足欠温。刻诊：腹痛连及腰胯部，月经时来忽止，患者形体肥胖，面部色青，舌质紫黯，脉弦涩有力。此为恶血瘀阻。治以活血通经。处方：红花 50 克，入酒 60 克煎，分 3 次服。1 剂后，排出大量暗黑色血块之月经，腹痛减轻。改用红花 15 克，益母草 30 克，入酒 60 克煎。连服 3 剂而愈。随访一年，未见异常。(四川中医 1986；(11>：35)91

【大黄牡丹汤治产后半月乳汁泌少医案】李玉有：

朱某，24 岁，1990 年 6 月 28 日初诊。患者产后半月，乳汁泌少，曾服下乳涌泉散、通乳丹等皆无效。其婆母误为营养不足，特购排骨、鲫鱼、猪蹄配西茴炖煮，令其姿意食之，然乳汁却日益递减，继而点滴不下，后求治于余。症见：焦躁失眠，心中懊侬，两乳饱满，触之硬而发热，胸脘痞满，口粘而苦，纳谷不馨，尤厌油食，便干尿黄，舌紫红、苔黄厚腻，脉滑数。此为湿热瘀三邪互结阻滞乳络。治宜清热利湿，祛瘀通络。方用大黄牡丹汤加通草、穿山甲。2 剂，水煎服。方中取芒硝外用，与蒲公英捣敷两乳。

复诊：药后焦躁除，食欲增，乳硬消，汁泌出，诸症向安。既获效机，且恐损伤胃气，

大黄用熟，继进1剂，以臻全功。嗣后婴食之而有余。(新中医1993；(3)：44)

【大黄牡丹汤治新产发热不退医案】李玉有：

徐某，26岁，1988年8月12日初诊。患者新产1周，发热不退，医者疑为产后失血正虚所致，以参芪类补之，不意服后竟热势更高，头痛如劈，烦躁不安，两目胀痛，邀余急诊。症见面红气粗，高热汗出，体温39．8℃，时而神昏谵语，且大便3日未解，尿少色黄，扪之小腹胀满疼痛拒按，恶露量少，气味臭秽，色紫黯有块，舌黯红、苔黄燥，脉数而有力。诊为热毒与瘀血互结胞中，治拟清热解毒，泻下逐瘀。方用大黄牡丹汤加金银花、连翘、败酱草。嘱服1剂，以观动静。翌日晨，其夫来告，谓头煎服后，大便得通，胀痛随缓，热势渐降，神志清醒，谵语未作，头痛有歇。随服2煎大效，热退痛减，恶露下多，唯小腹稍有不舒，恶露气味仍臭，虑其产后之殊，中病即止，以五味消毒饮加败酱草、益母草，制其小剂，调之而愈。(新中医1993；(3>：44)

【葛根汤加高丽参产后发热下利】

甲午岁作客长沙，有劳德扬之媳，产后患病，发热，下利不止。延医诊治月余未愈，几濒于危，请余诊之。脉浮而大，不数，知为太阳与阳明合病。《伤寒》云：太阳与阳明合病，必自下利，葛根汤主之。遂用葛根汤加高丽参治之。因久病元气亏故加参。服一剂而下利止，服二剂发热亦除。复诊：脉转弦涩。弦为余邪移于少阳，涩因产后营气虚。用小柴胡汤加当归治之。服数剂告痊。《医理探源》卷八。

【小补肝汤治产后综合征抑郁症医案】：

张某某，女，27岁，2001年2月13日就诊。一年前顺产一男婴，产后情志不遂，郁郁不乐，久而成病，厌世，几次欲了却生命，都被家人发觉，某院诊断为产后抑郁症。

症见：身体消瘦，乏力，心中恐疑，噩梦，半夜常被惊醒，气上冲心，胸中满，气噫，越汗出，头目眩晕，月经至今未下，白带，腹痛，腰痛，头痛，面色苍白，舌质淡，无苔，双脉沉细。肝气不足。投小补肝汤方：桂枝20g 干姜20g 五味子20g 大枣去核，12枚 白术20g。上五味，以水1000ml，煮至400ml，温分二次服。

2月19日复诊：服上药后头晕好转，神情较前安定，其症状缓解。小补肝汤服用二十剂，症状消失，改服桃红四物十二副，月经下，按月至，病愈。

按：此案系产后伤损，心肝虚弱，内分泌紊乱，神经衰弱。桂枝、干姜皆气温之药，而升散温阳；桂枝、五味一敛一散，降冲逆；小补肝升降气机，交互金木，斡旋中土，肝之体用得以承平而其虚自愈。

【桂枝茯苓丸死男婴小便不通医案】谭俊臣：

杨某某，女，30岁。1979年7月27日临产时即感小便困难，29日下午5时半娩出1死男婴后，小便不通。经当地卫生院导尿2次，后小便仍不通。于31日上午11时半送入本院。经尿道置导尿管保留4天，小便仍不能自排，虽用利尿剂肌注、热敷、针刺等法治疗，诸症如故。8月2日邀中医会诊，见患者面色苍白，头眼微肿，声音低弱，舌嫩苔薄白，脉迟。处方：桂枝25克，茯苓15克，桃仁10克，赤芍10克，丹皮10克，益母草30克。2剂。每剂浓煎2次，于1天内分4次服完。

患者于8月2日上午11时服药至当天下午2时，服完2次，在下午7时开始自行排尿100毫升左右，下午8时起继服2次，约半小时后又排尿600毫升左右，第2剂服完，排尿正常，痊愈出院。(上海中医药杂志1981；<12>：28)

【桂枝茯苓丸人工流产手术下腹部坠胀疼痛医案】刘绪英：

袁某，女，41岁。1993年3月2日初诊。患者于1991年12月做人工流产手术，术后因受凉始觉下腹部坠胀疼痛，腰骶部冷痛，白带量增多、质稀、呈褐色，左下腹似有包块，按之疼甚，每逢受凉则上述症状加重。曾在某院妇科检查，子宫大小正常，活动受限，双侧附件增厚并明显压痛。左下腹可触及3cm×4cm大小之条索状包块，压痛，B超提示：左侧附件

区可见囊性包块，化验血常规：白细胞7．2×10。／L，中性0．70，淋巴0.30。诊断为慢性盆腔炎。给予氟哌酸等西药治疗，效果不佳，遂来我科就诊。症状同上述，诊见：面色苍黄，舌色淡红，舌边缘有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。中医诊为带下病。辨屑寒凝血瘀，湿浊不化，治以活血化瘀，祛寒化湿法，方用桂枝茯苓丸加味。

处方：桂枝10g，桃仁15g，丹皮15g，茯苓12g，赤芍15g，川芎12g，延胡索12g，苍术12g，香附12g，甘草3g。水煎服，日1剂。

服上方8剂后，下腹坠胀疼痛及腰骶部冷痛明显减轻，白带明显减少，左下腹包块缩小，继用上方加蒲黄9g，又连服10剂，自觉症状消失，妇科检查：子宫大小正常，双侧附件区压痛消失，左下腹条索状包块消除，复查B超提示左附件区囊性包块消失。病告痊愈，随访1年未复发。(河南中医1995，(6>：342)

【桂枝茯苓丸人流后阴道出血淋漓不止医案】王明惠：

张某，女，28岁，已婚，1985年10月20日就诊。自诉人流后阴道出血，淋漓不止半年余，经用中西药(归脾汤、固冲汤之辈及西药止血之剂)未能根除。西医妇检：胎膜残留。现症：出血黑紫，质稀，时有血块，小腹胀痛，拒按，腰酸困，头晕乏力，面色晦黯，形体消瘦，舌质黯，边有瘀斑，脉沉细涩。证属瘀血阻络，久致气血亏虚。治宜活血化瘀，佐以益气养血。方用桂枝茯苓丸加水蛭粉5g(冲)，黄芪20g，当归15g，三七粉4g(冲)。3剂后出血量增，伴大量血块，腹痛缓解。守方加阿胶15g，黑地榆20g，去水蛭，又进．5剂而血全止，继以益气养血、滋补肝肾之剂以调冲任、益精血j服药3周，精神渐振。随访半年，未复发。(国医论坛1995；(3>：9)

瘀血内阻致血不归经的崩漏，则必当活血化瘀治之。本案由胎膜残留于内，所现脉证多为瘀血之象，故当化瘀通经，以桂枝茯苓丸加味治之。舍此而用归脾、固冲汤类，“实实”之误也、必不效。

【桂枝茯苓丸死胎医案】张季高：

廖某某，女，32岁，1984年6月14日初诊。主诉：妊娠已七个月，二十余天前不慎跌仆，三天后阴道微量流血，即到某医院妇科就诊，予安胎止血针药，并进安胎中药数剂，血仍未止。十余天后转流黑豆汁样液体，具臭秽味，经多方检查，断为死胎，欲予入院清除死胎，因患者及家人慑于手术，执意先作中药治疗，遂转诊张老。症见阴道有黑豆汁样秽臭味液体流出，少腹时有隐痛，伴重坠感，胎动、胎心音皆消失，面色青黯，舌质瘀紫，脉弦数而涩。脉证互参，诊为死胎不下。再三劝导入院治疗不从，唯试用和胃行气下胎法，拟平胃散加芒硝、枳实。处方：厚朴、枳实、玄明粉(冲)、苍术各10克，陈皮、甘草各3克，1剂。

6月15日二诊：昨日药后，只排稀便一次，余无动静，遂转活血行气，祛瘀下胎法。方用脱花煎加芒硝，处方：当归15克，川芎、车前子、牛膝各10克，肉桂(炀)2克，红花5克，玄明粉(冲)8克，1剂，以观动静。

6月16日三诊：药后再排稀便一次，死胎依然不下。转以桂枝茯苓丸加味，处方：桂枝、茯苓、丹皮、赤芍各10克，桃仁、怀牛膝各15克，1剂。上午10时服药，下午3时许始腹痛，有宫缩现象，5时半，产程开始，经接生者检查，排出完整男性死胎一具。(新中医1991；(16)：4～5)

【桂枝茯苓丸初产后恶露不尽医案】蒲辅周：

陈某某，女，已婚，1963年5月7日初诊。自本年3月底足月初产后，至今4旬恶露不尽，量不多色淡红，有时有紫色小血块。并从产后起腰酸痛，周身按之痛，下半身尤甚，有时左小腹痛，左腰至大腿上三分之一处有静脉曲张，食欲欠佳，大便溏，小便黄，睡眠尚可，面色不泽，脉上盛下不足，右关弦迟，左关弦大，寸尺俱沉涩，舌淡红无苔。由产后调理失宜，以致营卫不和，气血紊乱，恶露不化。治宜调和营卫，和血消瘀。处方：桂枝4.5克，白芍6克，茯苓9克，炒丹皮3克，桃仁3克(去皮)，炮姜2．4克，大枣4枚。服5剂。

16 日复诊：服药后恶露已净，小腹及腰腿痛均消失，食欲好转，二便正常，脉沉弦微数，舌淡无苔。瘀滞已消，宜气血双补，十全大补丸 40 丸，每日早晚各服 1 丸，服后已恢复正常。（《蒲辅周医案》）

【四逆当归补血汤加味妊娠胎漏(先兆流产)】

范××之妻，年二十八岁，四州省会理县人。身孕六月，某日因家务不慎，忽而跌仆，遂漏下渐如崩状，腰及少腹坠痛难忍，卧床不起。因其夫公务未归，无资以疗，延至六、七日，仍漏欲堕。余往诊之，气血大伤，胎恐难保，惟幸孕脉尚在，以大补气血，扶阳益气引血归经为治，纵虽胎堕，可保产母无损矣。拟方四逆当归补血汤加味治之。

附片 100 克，北口芪 60 克，当归身 24 克，阿胶 12 克(烊化兑入），炙艾叶 6 克，炙甘草 10 克，大枣 5 枚(烧黑存性)。

服一剂，漏止其半，再剂则全止，三剂霍然，胎亦保住，至足月而举一子，母子均安。

按：附子补坎中一阳，助少火而生气，阳气上升，胎气始固。芪术补中土之气，脾气健运，则能统摄血液以归其经，入当归、阿胶以资既伤之血。艾、附相伍，能温暖下元以止腰腹之疼痛。姜、枣烧黑、取其温经止血，且烧黑变苦，得甘草之甘以济之，苦甘化阴，阴血得生。阳气温升，阴血能朴，则胎不堕矣。

《内经》云：“治病必求其本。”本固而标自立矣，若只以止血为主，而不急固其气，则气散不能速回，其血何由而止？

【当归建中汤后半月小腹疼恶露淋漓】娄绍昆：

阿光媳妇，25 岁，状元四大队社员，1976 年 5 月 6 日来诊。产后半月小腹疼，恶露淋漓，脉沉细，舌淡，面色苍白，晕眩，脚抽筋，自感恶寒，两腹直肌挛急，按之不适。证属产后营气均虚，投以当归建中汤以补血温中、缓急止痛，一剂知，三剂痊。

【血府逐瘀汤郑氏等产后缺乳】

用桃仁、红花、赤芍、当归各 10g，川芎、桔梗、柴胡、枳壳、香附、炮山甲、王不留行各 8g，甘草 3g，治疗 1 例，疗效极佳。47、鲍氏等视网膜静脉阻塞。用血府逐瘀汤为主方（桃仁、川芎、牛膝、枳壳、柴胡、桔梗各 10g，红花 12g，当归尾、生地黄、赤芍各 15g，甘草 6g，另三七粉 5g 冲服）加减:年老体虚伴头痛头晕、腰膝酸软、耳鸣、五心烦热者去枳壳、柴胡、桔梗，加熟地黄、山药、山茱萸、知母等滋阴补肾;伴心烦易怒，口红舌干者去枳壳、桔梗，加石决明，夏枯草、草决明等清肝泻火;伴眼胀、心烦闷、胁胀痛者去桔梗，加郁金、泽兰、白芍等疏肝平肝;有视网膜水肿者加泽泻、车前子等利水消肿。治疗 32 例，显效 17 例，有效 11 例，无效 4 例;有效率为 87.5%。48、李氏等慢性喉喑。予柴胡、红花、牛膝各 12g，枳壳、生地、赤芍、木蝴蝶、桃仁各 15g，浙贝、海浮石、南沙参各 20g，桔梗 10g，甘草 6g，一般 20 剂后，诸症消失。李氏等还用血府逐瘀汤加减治耳胀耳闭，鼻窒，疗效亦颇佳。

【血府逐瘀汤治疗产后气虚】：

一产妇，27 岁。4 天前在人民医院妇产科剖腹产得一女婴，产后一直全身无力，四肢不温，经常感到肢体麻木，给予益气生血之剂效果不显，故转中医科调治，就诊时半卧于床上，声低气微，面色泛青，少腹部有局部青紫，全身血管脉络青紫可见，舌暗红，脉涩。自诉自少女时便开始痛经，经色黑暗有血块。处方：桃仁 12g，红花 12g，当归 15g，生地 12g，丹参 12g，牛膝 12g，郁金 12g，甘草 6g，川芎 9g，香附 9g，赤芍 9g，干姜 9g，益母草 12g，大枣 5 枚。从症状上看患者一派气虚血虚之象，妇产科已经注意到“产后多虚”的特点，却没有注意到“产后多瘀”的特点。从舌脉上看此产妇有瘀无疑，而从其剖腹产后少腹局部青紫，全身血管脉络也青紫可见，说明“瘀”的程度还不轻。中医有“血为气之母”的说法，此病案中的患者自少女时起就痛经并经出瘀血，说明其本身有瘀，“产后多瘀”又加重了瘀血的程度，瘀血阻滞脉络、脏腑、肢节等部位，就容易缺乏血的供养从而出现气虚血少。这

就是失去了所谓的“血能养气”的功能，剖腹产必然会导致大量出血，一者离经之血未能及时消除，再者“气随血脱”往往导致气机涣散不收之象。“瘀”为此病之本，病根不除，气虚血虚之象很难缓解。所以用血府逐瘀汤祛瘀血，加香附、益母草以活血调经，丹参、郁金以活血化瘀，消瘀化滞，干姜温阳，大枣补益气血。若“瘀”得去，再加以后期补养，则气血虚衰之象必当得愈。

第十四节 妇人其它疾病

【参附汤加味衄血】

秦××，男，六旬有四，广西人，住上海新闸路。秦素多痰湿，患痰饮咳嗽多年。昨日因咳嗽气急上气，忽而鼻衄不止，用物堵塞鼻孔则血由口中吐出。经注射止血针药，血未能止住。曾昏厥一次，喂服白兰地酒少许始回苏。1933 年 7 月 11 日延余诊视，患者面色惨淡，鼻衄不止，口角亦见血迹，冷汗淋漓，沉迷无神，气息低弱而呈奄奄一息之状。脉来芤虚欲散，重按无根，二、三至则一止，已现代象。掰开口视其舌，质淡夹青而少血色。此证良由气虚不摄血，阳虚不守阴，以致阴血散漫归于经。复因咳嗽气动，挣破血络而成衄。察其脉证，病势颇危，有阳气欲随阴血外脱之势，急宜扶阳收纳，如得血汗均止，始有生机。以参附汤加味急救。

高丽参 10 克附片 30 克炮黑姜 6 克，甘草 3 克，大枣 2 枚(烧黑存性)

服一剂则效，衄血减，神气转佳。再剂则血汗均已得止。次日又照服一剂，13 日复诊，神识已清醒，不再衄血。

唇舌已转红，脉缓弱较有神，但五、六至，间仍有止歇，依原方增量加口芪扶阳固气。

高丽参 10 克，附片 60 克，炮黑姜 15 克，口芪 24 克，甘草 10 克大枣 2 枚(烧黑存性)

连服二付，饮食、精神均有恢复，面唇舌色已红润、脉缓和有神，惟尚有咳嗽，痰中夹少许黑血，此乃离经之瘀血随痰咯出之故。原方去参、芪加入法夏 10 克、茯苓 15 克、砂仁 3 克，三剂而痊。此后多年，未见再衄。

【四逆当归补血汤加枣艾治衄血】

李××，十四岁，素患鼻衄，无他痛苦，故未用药石调理之。某日，感客邪，身热恶寒，头疼体痛，喜冷饮，脉浮而细数，主以麻杏石甘汤一剂霍然。异日外出，适值阴雨天寒，又复感冒而病，发热恶寒，头昏疼，肢体酸痛，不渴饮，脉反沉细而弱，主以麻黄细辛附子汤加桂尖、生姜一剂。服后汗出热退。次晨忽又鼻衄不止，用物塞鼻孔则血由口中溢出，似有不可止之状。头晕，腹痛，面色淡而无华，形弱神疲，复诊其脉迟缓而弱。此乃气血素亏，阴阳不相为守也。血虚散漫妄行，气虚则无力统摄血液，易致离经外溢。

表邪虽解、气血尚虚，主以四逆当归补血汤。

附片 50 克，炮黑姜 15 克，砂仁 6 克，大枣 3 枚(烧黑存性)

一剂衄血立止，再剂霍然。是夜因大便用力，起身时忽而气喘咬牙，昏厥欲绝，唇青，面色灰白，脉细迟无力，扶之使卧，稍定，乃以四逆汤加上肉桂治之，连进四剂而痊。

【胡希恕桂枝茯苓丸治脉管炎】

这个我用这方治过脉管炎。尤其这个下肢。邻居他姓尹，他得这个脉管炎病，他到这个同仁医院，说你这个将来得截肢，他害怕了，他愁得很。我说用不着截肢吧。我用的就是这个桂枝茯苓丸，这个方子得加驱血淤的药，他这个有桂枝就不用加桂枝了，就再加桃仁、丹皮、茯苓就行了。这个挺好使这个。他们外科用的这个氧化糖，与这个方子差不多。

【当归生姜羊肉汤治眩晕(低血压眩晕)医案】徐有全：

徐某，男，80 岁，农民。。患低血压性眩晕多年，头晕县眩，裹首闭目，立则晕倒，卧

床不起。血压常在 90／55 毫米汞柱左右。前医投参、芪诸药及人参蜂王浆等罔效，复予西药眩晕停、培他定、胞二磷胆碱等，效亦不显。投当归生姜羊肉汤方：

先将羊肉 250 克，合生姜 15 克，切片，文火熬成羊汤 3 碗，加入调料待用，另煎当归、大枣各 50 克，成 200 毫升药液。每日分 2 次将药液、羊肉汤分别依次饮尽(混合难服)，连服 1 周。2 周后复诊，血压升至 105／70 毫米汞柱，未用它药，诸症悉除。(浙江中医杂志 1992；<1)：33)

注家按语：(原按)低血压性眩晕之症，临床所见多属气血不足，营卫失和，脑失所养而致。方中当归补血和血，羊肉益气补虚，温中暖下。李杲谓："羊肉甘热，能补血之虚，有形之物也，能补有形肌肉之气，凡味与羊肉同者皆可以补之"。生姜具有升压作用，有人报告正，常人口嚼生姜 1 克，(不咽下)，可使收缩压平均升高 11.2 毫米汞柱，舒张压上升 14 毫米汞柱。大枣补中益气，善补阴阳气血。成无己称："姜枣味辛甘，专行脾之津液而和营卫，药中用之，不独专于发散也"。上药配伍，药食并用，气类相感，形精同补，相得益彰。俾血气充，营卫调和，脑髓得养，眩晕自平。

【当归生姜羊肉汤治肌衄(血小板减少性紫癜)医案】田国栋：

岳某某，女，52 岁。常因头痛，身疼而服大量阿斯匹林，已近 20 年。每因饮冷或遇寒即觉腹痛。1976 年 12 月 13 日，突然头痛加剧，鼻齿衄血百余毫升，腹中绞痛。全身满布米粒大小之紫癜，尤以躯干为多。于次日住院治疗。诊见面色萎黄，形寒肢冷，紫斑大小不等，不隆起，压之不褪色。舌淡，苔白，脉沉细无力。化验：血小板 34，ooo／立方毫米。遂诊为"血小板减少性紫癜"，虚寒肌衄。宜补血温阳，方拟当归生姜羊肉汤方：当归 50 克，生姜 50 克，羊肉 100 克，水煎服，每日一剂。

服药 9 剂，诸证悉除，紫斑逐渐消退。化验：血小板 140，ooo／立方毫米。1976 年 12 月 24 日病愈出院。随访三年未见复发。1979 年 12 月化验血小板为 170，000／立方毫米。(吉林中医药)

注家按语：衄血属热者固多，然属寒者亦复不少。本案肌衄见面色萎黄、形寒肢冷、舌淡苔白、脉沉细无力，显系虚寒性肌衄，以当归生姜羊肉汤温补无疑，否则，若误用苦寒折火之法，势必戕伐阳气，祸不旋踵。

【黄芪桂枝五物汤治左下肢慢性溃疡医案】程莉：

殷某，女，49 岁。1986 年 11 月初诊。左下肢慢性溃疡反复发作 2～3 年，每遇阴雨天则瘙痒疼痛，并流稀脓水，常缠裹以纱布，曾多处求治，大都给予抗生素类药治疗，收效甚微。视其左小腿内踝上方溃疡面积约 5cm×4cm，表面有稀脓水样，白色分泌物，周围皮肤呈晦暗色。舌质淡红，苔薄白微腻，脉细缓。证属阳气失于宣通，气血失常，湿邪痹阻于下，方以黄芪桂枝五物汤加味：生黄芪 30g，桂枝 15g，白芍 9g，生姜 3 片，大枣 4 枚(劈)，土茯苓 30g，当归 20g，牛膝 15g，公英 18g，薏苡仁 30g。水煎服，每日 1 剂，并配以三黄粉(黄连、黄芩、黄柏等份研细粉)撒敷溃疡面。服 5 剂后即显效，疼痛消失，渗出物减少，仍感瘙痒。上方又进 10 剂，疮面结痂而愈，至今未再复发。(山东中医杂志 1991；(1)：31)

【黄芪桂枝五物汤治皮肤紫殿医案】赵克安：

李某，男，8 岁，1990 年 9 月 21 日初诊。生后母逝，喂养失宜，3 年前出现皮肤紫殿，牙龈出血，经某医院诊为：血小板减少性紫癜，营养不良性贫血。3 年来病情时轻时重，紫癜时隐时现，间有便血。血小板数：70×10。／升，血红蛋白：78～100 克／升。曾用激素及中药归脾汤、十全大补汤等治疗。近 2 个月来症状加重，症见面色浮黄，唇白无华，头发稀黄无泽，精神疲倦，心悸气短，动则出汗，畏寒怕冷，纳差，时有黑便，因用氟美松和强的松而致"满圆脸"、"水牛背"、背部多毛。肝右肋下 1 厘米，脾未触及，全身皮肤散在出血点，色淡红，舌淡少苔，脉浮无力。血小板 72×10。／升，血红蛋白 98 克／升，白细胞数 5．5×10。／升，红细胞数 21×10，z／升，大便潜血阳性。证属脾失健运，化源不足，

气虚血亏，脾不统血。拟黄芪桂枝五物汤加味：黄芪20克，桂枝45克，白芍9克，姜炭13克，大枣6枚，人参6克，熟附片5克，当归6克，阿胶6克(烊化)，生地榆12克。3剂。

10月25日二诊：精神渐振，皮肤出血点减少，畏寒轻，自汗减少。前方再进3剂。

10月28日三诊：皮肤出血点消失，唇色红润，舌质淡红并出现小量薄白苔，脉缓有力，血小板数87×10。/升，血红蛋白112克/升，大便隐血阴性。阳复阴和，脾运振兴，守法再调。处方：黄芪12克，桂枝3克，白芍6克，炮姜3克，生熟地(各)6克，大枣3枚，当归4．5克，阿胶6克，紫河车粉1．5克(冲服)。隔日1剂，调理40余剂。

1991年1月3日复查：血小板数160×10V升，血红蛋白142克/升。白细胞数7．8×10。/升，追访2年健康如常。(山西中医1994。；<6)：29)

以助温阳。配人参、当归、阿胶以益气养阴补血，并加生地榆、干姜炭以止血。3剂而阳复症减，6剂血止。三诊更加血肉有情之品大补精血，且守方久服，病终获愈。

【黄芪桂枝五物汤治荨麻疹医案】陈国权：

夏某，女，42岁，营业员，1993年4月7日初诊。诉荨麻疹反复发作年余。1992年10月旅游归来途中全身突起“风疹块”，痒甚，经西医用息斯敏等药抗过敏治疗，3日后即愈。但自此以后，遇天冷则发，或服上药而愈，或不药而愈。此发作已5天，双上肢及胸腹、背部满布风疹块，高出皮肤，呈粉红色或苍白色。周围皮色淡红，无明显灼热感，舌红，苔少而根薄黄，脉缓。此乃卫气不畅，寒邪袭表，兼湿热内生所致。黄芪桂枝五物汤合三妙丸加味：黄芪、桂枝、白芍、苍术、黄柏、川牛膝、防风、赤芍各10g，大枣12枚，生姜5片。日1剂，水煎服。第2剂服毕，诸症若失。为防复发，予黄芪桂枝五物汤合四物汤加味以善其后，半年后追访，未再复发。

【黄芪桂枝五物汤治产后爱出汗医案】王金洲：

鲁某，32岁，职工，1979年4月10日就诊。患者于去年十二月份产一子，因是臀位，产程较长，出血较多。此后便觉比以前爱出汗，平时不动即觉汗出溱溱，稍有活动便汗出湿衣，多次服用西药及煎服浮小麦不效，近来头晕目眩，疲乏无力，望诊：面色㿠白，舌淡，诊其脉虚数无力。处方：黄芪20克，桂枝10克，白芍12克，生姜3片，大枣6枚，当归12克，煅龙牡各20克。服3剂后汗出大减。但仍于活动时出汗，头晕，身懒。照上方黄芪加至30克，当归加至18克，继服3剂后，自汗等症状均愈。（河南中医1987；(5>：43)

【黄芪桂枝五物汤治产后四肢抽搐医案】金志春：

刘某，女，22岁，农民。素有月经过多史，自然流产1次，患者于2月13日住院分娩，产程顺利，出血稍多。产后第2日突然出现四肢抽搐，西医给予镇静、解痉及液体疗法，但均只暂时缓解，药力过后，病情如故。治疗两日毫无改善，遂求中医诊治。患者诉产后第2d起自觉恶寒，汗出，头晕，次日出现低烧(38．5℃以下)，口渴，小腹轻度疼痛，恶露量少、色淡。诊见：面色苍白，唇淡无华，语声低微，舌质淡苔薄白，脉虚细无力而见浮象。诊为产后痉证，证属气血亏虚，外感风邪，营卫失调，筋脉失养。治以补养气血、濡润筋脉，调和营卫、解肌祛风。方用黄芪桂枝五物汤方：黄芪15克，桂枝、芍药、生姜、大枣各10克。水煎服。1剂之后，诸证明显减轻，次日再进1剂而抽搐止。余仅长年气血亏虚之证。再拟他方治之。(陕西中医1991；<12)：552)

【黄芪桂枝五物汤治腹产后腰腿疼痛医案】闵捷：

圣某，女，29岁，工人，1982年5月11日初诊。剖腹产后4月余，腰腿疼痛，头昏神疲，自汗肢麻，奶水不多，饮食尚可，二便正常。尿检：(一)，舌淡苔白脉微而紧，证属产后气血虚衰，风寒痹阻脉络。治以益气温经，和营通痹，方选黄芪桂枝五物汤加味，重用黄芪。药物：黄芪30克，桂枝6克，白芍6克，怀牛膝10克，全当归10克，生姜3片，大枣15克。服上药5剂后腰腿痛减，自汗已止，服药10剂后腰腿痛除，继以八珍汤加减调治而愈。(云南中医杂志1985；(4>：36～37)

【黄芪桂枝五物汤治顺产后小便欲解而不下医案】张雯：

秦某，女，24 岁，1992 年 6 月 14 日诊。足月顺产后已 12 小时，小便欲解而不下，伴小腹部胀痛，面色少华，腰酸乏力，纳谷不香，大便未解。舌质淡红，苔薄白，脉细无力。以手扪之下腹部，膀胱充盈较甚。证属脾虚气弱，中气不足，膀胱气化失司。方药：生黄芪 30 克，川桂枝 10 克，炒白芍 10 克，白茯苓 20 克，木通 5 克，生姜 3 片，大枣 10 枚。取上方 1 剂，煎汤约 150 毫升内服。服药后 3 小时小便自解，小腹胀痛亦除，继服 2 剂以巩固疗效。(山西中医 1994；(3>：33)

【黄芪桂枝五物汤治动则汗出恶阻医案】王金洲：

韦某，21 岁，农民，1982 年 3 月 5 日就诊。患者十多天前自觉恶心，不思饮食，未予注意。渐至食入即吐，不能进食。近两日气短，神疲，四肢无力，动则汗出；末次月经 1 月 10 日来潮，舌淡，苔薄白，脉缓滑无力，乳胶试验结果亦为阳性。证属恶阻无疑。方用：黄芪 15 克，桂枝 10 克，白芍 15 克，生姜 6 片，大枣 5 枚，白术 10 克，砂仁 10 克。两剂后汗出已止，气短等症亦减，恶心呕吐稍见好转，于上方中再加半夏 10 克，服 3 剂后，恶心呕吐止，饮食增加，精神转佳，后用香砂养胃丸调理而愈。(河南中医 1987；(5>：43)

【红蓝花治产后恶露不尽汤医案】王明宇：

某某，女，26 岁。1982 年 1 月 10 诊。初产恶露未尽之时过食生冷而发生腹痛已 3 月。某医处以加味四物汤后，恶露止，腹痛亦减。尔后腹痛时作，缠绵不休。昨晚突然腹中刺痛，时而增剧而昏厥，随后经至排出少量瘀血块，腹痛减轻，手足欠温。刻诊：腹痛连及腰胯部，月经时来忽止，患者形体肥胖，面部色青，舌质紫黯，脉弦涩有力。此为恶血瘀阻。治以活血通经。处方：红花 50g，入酒 60g 煎，分 3 次服。1 剂后，排出大量暗黑色血块之月经，腹痛减轻。改用红花 15g，益母草 30g，入酒 60g 煎。连服 3 剂而愈。随访 1 年，未见异常。(四川中医)。

【资生汤治产后虚劳医案】奉天法库县万生来函：

族弟妇产后虚羸少食，迁延月余，渐至发灼、自汗、消瘦、乏气、干呕、头晕等证，此方书所谓蓐劳也。经医四人治不效，并添颧红作泻。适生自安东归，为之诊视，六脉虚数。检阅所服之方，有遵《医宗金鉴》三合饮者，有守用养荣汤者，要皆平淡无奇。然病势至此，诚难入手，幸脉虽虚数，未至无神，颧虽红，犹不持聚（若持聚则阴阳离矣，不持聚是其阴阳犹未离），似尚可治。此盖素即阴虚，又经产后亡血，气亦随之，阴不中守，阳不外固，故汗出气乏；其阴阳不相维系，阴愈亏而阳愈浮，故发烧咳嗽头晕；其颧红者，因其部位应肾，肾中真阳上浮，故发现于此，而红且热也；其消瘦作泻者，以二阳不纳，无以充肌肉，更不特肾阴虚，而脾阴胃液均虚，中权失司，下陷不固，所必然者。此是病之原委欤？再四思维，遂处方，用生怀山药二两，于术三钱，玄参四钱，鸡内金、牛蒡子各二钱（此系资生汤原方稍加重），外加净萸肉、龙骨、牡蛎各五钱，止汗并以止泻。五剂后，汗与泻均止，饮食稍进，惟干咳与发热仅去十之二三。又照原方加粉甘草、天冬、生地等味，连服七剂。再照方减萸肉，加党参二钱，服四剂后，饮食大进，并能起坐矣，惟经尚未行。更按资生汤原方，加当归四钱。服数剂后，又复少有加减，一月经脉亦通。

【甘麦大枣汤产后自汗医案】吴德熙：

泮某，产后自汗，38 岁，产后一周，恶露量小，小腹疼痛，日间汗出津津，入夜盗汗如洗，醒后心神恍惚，极度疲乏，口渴引饮，饮食无味，舌淡、边黯紫、苔白，脉细涩，辩证为产后气血虚，营卫失调兼胞宫留有瘀血，方用甘麦大汤补益心脾，调和营卫以敛汗，佐生化汤祛瘀生新以止恶露。1 剂后小腹不疼，汗少；3 剂汗止，口不渴，饮食有味。(浙江中医杂志 1982)

按语：吴氏认为，妇人产后自汗不止，或盗汗如洗，或口渴引饮，或渴不欲饮，系产后耗气伤血，心脾不足，营卫不和；阴阳失调居多。宜用甘麦大枣汤主之，阴虚偏重，酌加首

乌、熟地、当归、沙参、麦冬、五味子；气虚偏重，加黄芪、白术、党参；兼血瘀者，和生化汤合用。

【白头翁汤治产后下利赤白里急后重医案】：

商女，产后下利赤白，里急后重，日夜四十余次，腹痛甚则发厥，口极苦而喜饮，按其胸腹灼手，脉细数。黄仲权用白头翁汤加金银花、白芍、阿胶、黄芩、益元散、荷叶，一剂痛、厥即除，痢亦稀减，调理而愈。（《全国名医验案类编》）

【下瘀血汤产后三天恶露未行随即高热不退神昏谵语医案】胡杰峰：

刘某某，女，26 岁，务农，81 年 11 月 16 日入观察室治疗。患者素体壮实，产后三天恶露未行，随即高热不退，神昏谵语而住院。西医诊断为“感染性精神病”，经多方治疗，虽体温有所下降，但仍有神志不清，胡言乱语。诊时，患者面红自赤，口唇干燥，似睡非睡，呼之不应，时而胡言乱语或语言不清，答非所问，大便一周未行，按其少腹，则蹙眉皱额，苔薄黄，舌质紫，脉涩有力。诊为败血停蓄，瘀浊攻心。治当活血逐瘀，佐以醒神开窍，用下瘀血汤加味：生厚朴 15 克(后下)，桃仁 12 克，䗪虫 10 克，川连 5 克，石菖蒲 10 克，枣仁 15 克，生甘草 6 克。l 剂，鼻饲。

药后下黑便两次，神志转清，自行拔去鼻饲管。知药已中病，原方生厚朴改酒制厚朴 15 克，加生地黄 30 克，水酒为引，连服 3 剂，恶露复行，神志已清。后改桃红四物汤数剂，并以天王补心丹善后，调治半月而愈。(江西中医药 1982；(3)：44)

【桂枝汤加龙骨牡蛎治上半身烘热汗出医案】张秀云：

魏某，女，48 岁，干部，1994 年 2 月初诊。患者近半年来出现阵发性上半身烘热、汗出，下半身如常，每次汗出前，周身烦躁，闷胀不舒，继则数分钟内上半身大汗出，汗后如常，发无定时，精神紧张时加重。近 2 个月发作频繁，日发 1～2 次，伴失眠、多梦、月经不调。经西医诊为“更年期综合症”，曾服谷维素片，维生素片等疗效不显。舌尖红，苔薄白，脉细缓。患者年近五十岁，处更年期，肝气失调致阴阳逆乱，治以调理阴阳，调疏肝气。方用桂枝 10g，白芍 9g，甘草 10g，生龙骨 20g，生牡蛎 20g，炒枣仁 15g，生姜 3 片，大枣 3 枚，合欢皮 15g。复诊：前方服 5 剂后睡眠佳，出汗次数明显减少，舌脉同前，原方再服 6 剂而愈。(河南中医 1995；(6)：343)

【当归贝母苦参丸治小便不利有涩痛感医案】赵宁真：

樊氏，青年农妇，体素不健,疾病时罹,迭来就治，皆数药而安，信甚笃。1944 年夏伤子湿热，饮食如常，而小便不利，有涩痛感。时余客零未归，求治于李医，认为湿热所致，先服五苓散去桂加滑石不应，易服八正散亦不应，迁延半月，精神饮食减退，肢倦无力，不能再事劳作。闻吾归，邀为之治。切脉细滑，面色惨淡,气促不续，口干微咳，少腹胀痛，大便黄燥，小便不利而疼。此下焦湿热郁滞与上焦肺气坏宣，上下失调故尿闭不通。如仅着重下焦湿热，徒利何益。因师古人上通下利之旨，用宣肺开窍诸品，佐渗利清热药为引导，当可收桴鼓之效。拟用当归贝母苦参丸(改汤)加桔梗、白蔻、鸡苏散等。是以桔、贝、蔻仁开提肺窍，苦参、鸡苏散入膀胱清热利水，当归滋血，以补不足。此与头痛医头者，大相径庭。果 2 剂而小便通利，不咳，尿黄而多，此湿热下降之联兆。更以猪苓汤加海金砂、瞿麦滋阴利水，除积清热，数剂小便清，饮食进，略为清补即安。(治验回忆录)

按语:本案治疗颇具特色，在使用当归贝母苦参丸导下的同时，配伍开提肺窍之品。盖肺“通调水道，下输膀胱”。，肺窍合，则下窍闭;肺窍开,则下窍利、古人所谓“提壶揭盖”之法也。

【抵当汤、桃核承气汤治半产后面色黧黑下焦蓄血医案】

《生生堂治验》曰：“一妇人半产后，面色黧黑，上气头晕。先生诊之，脉紧而脐下结硬。曰：『此有蓄血也。』即与抵当汤，三日而觉腰以下宽舒，更与桃核承气汤。俄顷，果大寒战，发热汗出，谵语，四肢搐搦，从前阴下血块，其形如鸡卵者。六日约下二十余枚，

仍用前方，约二旬，所患若失。”

汤本氏注：黧黑者，无光泽而黄黑色也。头晕者，眩晕也。脐下结硬者，下腹部坚硬有凝块也，是即血塞。谵语，自言自语也。搐搦，间代性痉挛也。前阴，阴户也。此证因流产时恶露排泄未净，于下腹部发生血塞，其余波及于头脑使至眩晕，而自服抵当汤及桃核承气汤后则瘀血完全排出，故获效也。

【下瘀血汤治附件炎】

陈某，女，36 岁。诉右下腹刺痛 3 年，妇科检查诊断为附件炎，但经抗炎西药久治无效，伴月经周期延长，经前右下腹疼痛加剧，胸胁窜痛，乳房及腰部胀痛，经色暗有血块。无异常白带。平素性情抑郁，心情稍有不舒则引发腹痛加重。纳食欠佳，大便不畅。切其右下腹，疼痛拒按。舌质暗，有瘀点，苔薄白，脉沉弦。脉症合参，证属瘀血内结少腹，肝经气血阻滞;治宜活血破瘀,疏肝理气;方用下瘀血汤合柴胡疏肝散加减:制大黄 10g,桃仁 10g,虫 10g,柴胡 10g，白芍 15g，枳实 15g，甘草 6g，香附 15g，郁金 15g，川芎 10g，蒲黄，五灵脂 15g，莪术 10g。水煎服，每日 1 剂。服药 7 剂，腹痛减轻，大便通畅。继服 14 剂，前阴排出大量暗黑色血块，随后诸症悉除，月经亦转正常，腹痛未再复发。本案附件炎，无湿热邪毒之症，反见-派血瘀气滞之证。瘀血不去，气血不通，则腹痛难除，炎症难消，故不以清热解毒之法消其炎，而以逐瘀破结，活血理气之法调其气血。方用下瘀血汤破血逐瘀，引瘀血下行;柴胡疏肝散去陈皮，理气和血，缓急止痛;加失笑散配郁金、莪术活血止痛。诸药合用，行气活血破瘀，使瘀血下排，气血调畅，故腹痛自愈。妇人附件炎、盆腔炎或闭经等病症，属瘀血内结所致者，以下瘀血汤为主方治疗，均可取得满意疗效。

【心腹满闷医案】张锡纯：

一媪，年六旬。气弱而且郁，心腹满闷，不能饮食，一日所进谷食，不过两许，如此已月余矣。愚诊视之，其脉甚微细，犹喜至数调匀，知其可治。遂用此汤，将三棱、莪术各减一钱，连服数剂，即能进饮食。又服数剂，病遂全愈。

【带下绵注色白已 2 年】：

薛某某，女，35 岁，1984 年 12 月 4 日诊。患者禀素体弱，带下绵注色白已 2 年，月经周期尚属正常，B 超子宫无异常，右侧附件轻度增粗，白带常规未见霉菌、滴虫，患者冬季畏寒甚于常人，两足不温，近 1 年来经常出现梦交，夜寐不宁，心烦口干，两颧潮红，腰膝酸软，头晕耳鸣，苔薄舌淡，脉虚细数责之元阳不足，带脉失约，上热下寒，拟予温元阳，潜浮火，束带脉。

煅龙牡各 30g 先煎，巴戟肉 20g，肉桂心 5g，北五味 10g，制附子 6g，怀牛膝 12g，菟丝子 15g，莲子心 5g，鹿角霜 15g。

上方连服 10 剂，带下明显减少，半月来心烦口干、梦交之证均平，惟仍感畏寒，嘱其再服上方 5 剂后继服八味地黄丸缓调 2 月，B 超复查子宫附件均无异常，1 年后随访，带下梦交之症未复发。

【少腹逐瘀汤在妇科临床中的应用】

药方组成：当归 9 克，五灵脂 6 克，赤药 6 克 蒲黄(生)9 克，川芎 6 克，茴香 7 粒，元胡 3 克，干姜(炒)三片，没药 6 克，官桂 3 克。

本方以当归、赤芍、川芎为主药，活血祛瘀，养血调经，辅以五灵脂、生蒲黄、元胡、没药，其中五灵脂、蒲黄通利血脉，祛瘀止痛，进而可推陈致新，没药散气、通血滞、消肿定痛、祛腐生肌，元胡为气中血药，善行气活血，气行则血行，为止痛良药，四药相配，共奏散结定痛，祛於生新之功也，以小茴香、炮姜、官桂为佐药，温经散寒，理气止痛，并能引诸药直达少腹。

适应证：本方专治瘀血为患的妇科多种疾病。少腹积块疼痛或有积块不疼痛，或疼痛而

积块，或少腹胀满，或经血见时，先腰酸少腹胀，或经血一月见三、五次，接连不断，断而又来，其色或紫、或黑、或块、或崩漏，兼少腹疼痛，或粉红白滞，皆能治之。 上述诸证，相当于我们在妇科临床中常见的月经不调、痛经、闭经、崩漏、症瘕、不孕、坠胎、小产等疾患。

辨证要点：

1、所见经血其色或黑、或紫，其质有块。

2、腹痛、少腹尤甚，疼痛性质，多见绞痛、冷痛、胀痛、或刺痛、痛不移处，且痛柜按。

3、瘀结不散、瘀久成块，故腹腔可触到积块。

4、“有诸内必形诸外”，察舌尖边，或体，有瘀点或瘀斑，或舌质紫暗，诊断见弦或沉涩。

临床加减：

胸胁乳房胀痛者，加郁金、川楝子等疏矸理气之药，少腹胀痛甚、或冷痛，可加香附、乌药、葫芦巴、等理气开郁止痛。腰酸、膝软乏力，加川断、寄生、牛七、杜仲、巴戟之药，以调补肝肾，身倦乏力短气者，去五灵脂、川芎，加党参、黄芪、白术等益气健脾之药，滞下量多、色白、质稀，或四肢不温，使溏、面目虚浮者，去五灵脂，当归少用，或不用，重用炮姜、官桂，加苍术、白术、茯苓、黄芪、炒苡仁等健脾利湿之药，积聚、或少腹胀满硬痛，按之有块者，可酌加三梭、莪术等行气活血、开郁结之药，并可适当选用昆布、海藻、穿山甲、鳖甲等活血软坚消积之药，甚者，则可酌加上鳖虫、水蛭、虻虫、全蝎、蜈蚣，以剔络逐恶。若见崩漏量多、有块或淋漓不畅、腹痛甚者，可加三七，以化瘀止血定痛，兼及血气虚者，可加重北芪、党参、山鹤草等，益气化瘀止血。

【少腹逐瘀汤治疗下腹部持续性疼痛医案】

张某，女，42 岁，农民，1997 年 5 月 10 日初诊。因下腹部持续性疼痛 5 个月余，曾在当地多家医院诊治未效，。到我院妇产科诊治，经 B 超检查发现子宫底部有一个约 7cm×l1cm ×5cm 大小的低回声占位区，提示子宫肌瘤，最后确诊为子宫肌瘤，建议住院手术治疗。患者因家庭经济困难不愿手术治疗，要求中医保守治疗，遂入我科治疗，诊见：形体壮实，面色晦黯，下腹积块坚硬，疼痛拒按，善言易激动，自述常因腹痛而难以入睡，月经先后不定，经色黯，时夹血块，经前及经中小腹疼痛尤甚，痛如针刺，经期较长，常缠绵半月左右，观其舌边尖瘀点密集，舌下络脉瘀紫，苔黄微腻，适其脉紧而涩。证属癥瘕之瘀血积滞，吾试投少腹逐瘀汤 3 剂：小茴 10g，川芎 12g，当归 15g，没药 12g(醋制) 玄胡 15g(醋制) 干姜 10g 肉桂 5g，赤芍 10g，生蒲黄 12g(包煎) 五灵脂 10g 牡蛎 30g，鳖甲 15g(醋制)。服第 1 剂药后，当夜后半夜腹痛缓解，患者入睡 l～2h；第 2 剂药后，腹痛又减，能入睡 3～4h，纳增，精神好转；第 3 剂药后，患者顿觉得腹痛全消，能鼾睡至天亮。效不更方，余以前方出入，共进 30 剂后，不仅诸症若失，而且 B 超复查未发现子宫肌瘤。随访至今 5 年有余，患者健康，月经如常。

子宫肌瘤在育龄妇女中发病率高达 20%-30%，好发于 30－50 岁的妇女，临床上多表现月经过多、淋漓不尽、小腹胀痛、隐痛，腰酸、困痛、多梦、乏力等。轻者长期压迫膀胱、直肠等器官，重者则可发生长期大量出血，甚至发生癌变，危及生命。其临床表现与少腹逐瘀汤证机理相同，其病位在少腹，其病因在于 “瘀”。“瘀血阻滞，经脉不通，不通则痛。”故其以痛为主，治以逐瘀止痛，软坚散结，使瘀血去，积滞消，方法得当，自然能获痊愈。

【血府逐瘀汤治更年期综合症】

王某，女，51 岁，2002 年 5 月 21 日就诊。患者自诉 1 年前绝经后，心烦易怒，失眠多梦，每日仅睡 3 小时，头晕头痛，心悸胸闷，曾在市级医院检查无明显器质性病变，一直服用谷维素、安定等药，效果不明显。近半月来因生气而起病，症见：郁郁寡欢，烦躁易怒，失眠多梦，胸闷，委屈哭泣，舌质暗淡，边有瘀斑，苔薄白，脉弦细。综观脉症辨为气滞血

瘀，治宜疏肝活血，除烦安神，予以桃仁 10g 红花 10g 赤芍 15g 当归 10g 生地 12g 川芎 10g 柴胡 10g 枳壳 12g 郁金 15g 桔梗 9g 牛膝 15g 茯神 12g 甘草 6g，药进 12 剂后，情绪明显好转，睡眠改善，烦躁易怒等症减轻，效不更方，又服 9 剂，诸症悉除。按：朱丹溪曰："血气冲和，万病不生；一有怫郁，诸病生焉。"此例为情志不舒，肝失疏泄，气滞血瘀。治以解郁理气为主，兼活血化瘀。方中柴胡、郁金、枳壳、桔梗疏肝理气解郁；桃仁、红花、当归、川芎、赤芍、牛膝活血养血通脉，茯神养心安神为佐药。全方配伍合理，共奏疏肝理气解郁、活血化瘀安神之功。

【少腹逐瘀汤治右侧股骨头坏死医案】

任某，女，54 岁，右侧股骨头坏死，需花二万元住院治疗。患者求治于笔者，证属脾肾阳虚，血瘀寒凝，治以补中益气汤合阳和汤少腹逐瘀汤，以其家贫，故作散剂以服之。服药一月，其右侧肢体疼痛大减，嘱继服，共服 4 月，诸症消失，已能劳作负重，合家感谢笔者，并诚心念佛，三年来未发。

【黄芪建中汤急性盆腔炎医案】何少山章勤：

沈某，女，33 岁。1997 年 5 月 7 日初诊:2 年前有急性盆腔炎史，当时予抗炎药物治疗后腹痛缓解。常因劳累或经后感小腹掣痛。本次亦因劳累后复发，少腹左侧掣痛，腰痛，头晕乏力，纳差，舌质淡，苔薄腻。脉细弦。西医诊断:慢性盆腔炎。

中医辨证:脾胃虚弱，湿瘀内阻。诊断:盆腔少腹痛。治拟健脾和中，散瘀解痛。

药用:炙黄芪 15g,桂枝 5g,炒白芍 10g,生甘草 5g，茯苓 10g，炒白术 10g，红藤 30g，马齿苋 15g，蒲公英 15g，徐长卿 9g，制没药 6g，川断 10g。7 剂后精神稍振，腹痛亦轻，守方再调理近 2 月，腹痛基本消除，随访半年内未复发。摘自江苏中医

覃医生按：何少山，他是国家级名老中医，江南“何氏妇科”第三代传人，中医妇科临床大家。黄芪建中汤为基础方因为加味比较多（此方去除了怡糖）。

要分析黄芪建中汤，就要先说小建中汤“虚劳里急，悸，衄，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，小建中汤主之。”

黄芪建中汤即是在小建中汤的基础上增加了黄芪一两半，原条文“虚劳里急，诸不足，黄芪建中汤主之”。

小建中汤和黄芪建中汤都有“虚劳里急”，“虚劳”说明了疾病的根源，“里急”说的是腹部有挛急感，按之不硬，是症状。

小建中汤的作用是温中补虚，缓急止痛，调和肝脾，黄芪建中汤就是在小建中汤的基础上增加了补“诸不足”的黄芪，

本医案”因劳累后复发”说明患者是的病因跟虚劳的关，“少腹左侧掣痛”和条文的“里急”“腹中痛”对应，“头晕乏力，纳差，舌质淡，脉细弦”符合黄芪建中汤的“诸不足”，故抛开西医的诊断病名“慢性盆腔炎”可以说这个患者是按条文生病的，所以选用黄芪建中汤为基础方是体现了方证对应，但是只用黄芪建中汤的原文估计是治不好的，此患者“苔薄腻”说明患者是脾虚湿阻，故增加了“茯苓 10g，炒白术 10g”炒白术健脾去湿，茯苓将水湿化尿排出去。

红藤，在本科教材里正名是大血藤，它的功效：清热解毒，活血，祛风止痛，长于清热解毒，消痈止痛；

马齿苋的功效：清热解毒,凉血止血

蒲公英的功效：清热解毒，消肿散结，利湿通淋；

红藤在这个医案里重用至 30 克，马齿苋和蒲公英各 15 克，这三味药都具有清热解毒的作用，马齿苋和蒲公英的质地比较轻，但各 15 克从体积看也是一大堆了。从这三味药的功效看，这个患者的盆腔炎属于湿热型。

徐长卿的功效：祛风除湿,止痛；本品具有较强的止痛作用，故常用于各种痛证；

没药的功效：散瘀定痛，消肿生肌；具有散血化瘀的作用；

川断的功效：补肝肾，强筋骨，续折伤

徐长卿的药性是辛，温，因为辛具有走窜的特点，故而它和没药搭配加强了散血化瘀的作用，徐长卿，没药和川断这三味药一起搭配看起来跟盆腔炎不沾边，原医案记录并没有用药的分析，我认为这几味药有两个作用：第一，是用来治腰痛的，第二，医者诊断这个患者盆腔炎是“湿瘀内阻”，这三味药一起搭配也正是起到化瘀的作用。

【升肝舒郁汤治阴挺医案】张锡纯：

一妇人，年三十余。患此证，用陈氏《女科要旨》，治阴挺方，治之不效。因忆《傅青主女科》有治阴挺之方，其证得之产后。因平时过怒伤肝，产时又努力太过，自产门下坠一片，似筋非筋，似肉非肉，用升补肝气之药，其证可愈。遂师其意，为制此汤服之。数剂即见消，十剂全愈。

张锡纯曰：肝主筋，肝脉络阴器，肝又为肾行气。阴挺自阴中挺出，形状类筋之所结。病之原因，为肝气郁而下陷无疑也。故方中黄芪与柴胡、芎蒡并用，补肝即以舒肝，而肝气之陷者可升。当归与乳香、没药并用，养肝即以调肝，而肝气之郁者可化。又恐黄芪性热，与肝中所寄之相火不宜，故又加知母之凉润者，以解其热也。

升肝舒郁汤方：

治妇女阴挺，亦治肝气虚弱，郁结不舒。

生黄芪六钱，当归三钱，知母三钱，柴胡一钱五分，生明乳香三钱，生明没药三钱，川芎一钱五分

【理郁升陷汤阴挺医案】张锡纯：

一室女，年十五。因胸中大气下陷，二便常觉下坠，而小便尤甚。乃误认为小便不通，努力强便，阴中忽坠下一物，其形如桃，微露其尖，牵引腰际下坠作疼，夜间尤甚，剧时号呼不止。投以理郁升陷汤，将升麻加倍，二剂疼止，十剂后，其物全消。盖理郁升陷汤，原与升肝舒郁汤相似也。

【附子汤治月子病案】：

张女士，41 岁。患者右上肢肩下腕上整个部位有痛感，半夜疼痛尤为明显，患处不能受风、受寒，否则疼痛难耐。该症已有 13 年。患者易出虚汗，手足心热，恶心，舌体淡胖，舌苔白厚。

综合辨证为肾阳虚衰，寒湿内生开方制附子、茯苓、党参、焦白术、赤芍，用药 1 天，疼痛就有所减轻，连服 30 天后，诸症均消，巩固用药 15 天后停药，随访至今未发。

【下瘀血汤腹痛拒按医案】姜春华：

何某某，女，26 岁。月经常衍期，经来量少，腹痛拒按，色紫黑成块，有血块排出后，痛即缓解。舌边瘀紫苔薄白，脉沉涩。证属瘕瘕积聚，瘀血阻滞。用下瘀血汤加减。桃仁 6 克，大黄 6 克，䗪虫 3 克，桂枝 9 克，芍药 24 克，甘草 6 克，香附 9 克。7 剂。（辽宁中医杂志 1986；（7）：2）

【下瘀血汤四逆汤活血化瘀产后两日胞衣不下腹中冷痛】张谷才：

石姓，女，37 岁。产后两日，胞衣不下，腹中冷痛，形寒怕冷。脉象弦迟，舌淡苔白。一医认为瘀血内阻，用抵当汤破血泻衣，胞衣不下；一医认为气血亏虚，用八珍汤扶正下衣，少腹胀痛更重。殊不知病因乃客寒外侵，血凝瘀阻，单用破瘀或纯用扶正，都不能下其胞衣。因为寒凝瘀阻，非温阳寒不解，非下瘀胞不下。所以用四逆汤温阳祛寒，下瘀血汤活血化瘀。处方：大黄 10 克，桃仁 10 克，䗪虫 8 克，附子 6 克，干姜 3 克，甘草 4 克，艾叶 5 克。1 日服两剂，胞衣即下，诸证消失。后用生化汤调治。（辽宁中医杂志 1980；（8>：13）

【下瘀血汤全身广泛出血医案】林上卿：

朱某，女，25 岁，福鼎县前岐人，1984 年 3 月 1 日诊。产后五天，全身广泛出血。住某医院治疗，经用抗生素、止血剂、输血等措施，兼服中药而罔效。乃求诊于余。询其病史，家属告知因临产时恐其体虚，曾进服西洋参 15 克，翌日又进食鸡酒半碗，继而身热，延医治疗诊为“外感发热”，投以退热剂(药名不详)，遂作自汗出，继则吐、衄血。证见：面色苍白，吐血、鼻衄，全身皮肤见块状紫瘢，眼眶、指甲均呈紫色，精神萎靡，气短声低，唇口干燥而不喜饮，心烦不安，纳呆，小腹胀满，按之刺痛，大便数日不行，小便短少，恶露稀少，舌红少苔，脉微涩。查血常规：血红蛋白 2 克%，红细胞 216 万 / 立方毫米，白细胞 3，800 / 立方毫米，中性 56%，淋巴 38%，嗜酸性 6%，血小板 4 万 / 立方毫米。证系瘀血内阻，误用补塞，瘀阻化热，前医用退热之品，汗出伤阴，热炽化火，迫血妄行而成吐、衄。其证危笃！当投下瘀血汤以釜底抽薪。处方：䗪虫 6 克，桃仁 10 克，大黄 15 克。三味共研末，加白蜜 25 克，煎分四次服。

药后大便二次，吐、衄减轻，恶露未通，此时孰进孰退颇难抉择。悟“失之毫厘，差之千里”，知方对证，惟大黄用量过于䗪虫、桃仁，故守方行药量增减，处方：䗪虫、大黄各 10 克，桃仁 15 克，白蜜 30 克，煎分四次服。药后恶露渐通，排出紫色血块甚多，吐衄、身热等症消失，继以调养心脾月余而康，复查血常规示正常。(新中医 1986；(6)：47)

【下瘀血汤间歇性左下腹部剧痛医案】胡杰峰：

黄某某，女，35 岁，教师，于 1981 年元月 2 日住院。患者停经 40 余天，间歇性左下腹部剧痛一天入院。检查：血压 122 / 80mmHg，心率 76、次 / 分，体温 37hC，发育中等，营养尚可，神清合作，心肺听诊未见异常，肝脾未扪及，左下腹有明显压痛，可扪及一鸭蛋大包块，质软，阴道后穹窿穿刺有不凝血液，超声波探及前后径 3～5 厘米大小包块，妊娠免疫试验两次阳性，诊断为“宫外孕”，不稳定型。诊其脉弦涩，舌偏紫，苔黄。辨证为少腹血瘀，治拟活血化瘀，理气止痛。用下瘀血汤加味：酒炒厚朴 12 克，桃仁 9 克，䗪虫 6 克，香附 12 克，蜈蚣 4 条(去头足)，川牛膝 15 克，甘草 3 克。

连服 7 剂，腹痛消失，妊娠免疫试验阴性，超声波未探及包块，原方除蜈蚣、川牛膝，加炮甲珠 10 克，全当归 15 克。4 剂后，诸症消失，继以八珍汤善后。(江西中医药 1982；<3)：44)

【大黄甘遂汤治四肢头面肿水与血结在血室】易庆棠：

河南永发店，予先人旧日所做生理也。癸未六月，有店伴陈姓者，其妻患产难，二日始生，血下甚少，腹大如故，小便甚难，大渴。医以生化汤投之，腹满甚，且四肢头面肿。延予诊视。不呕不利，饮食如常，舌红黄，脉滑有力，断为水与血结在血室。投以大黄甘遂汤。先下黄水，次下血块而愈。主家初亦疑此方过峻。予曰：“小便难知其停水，生产血少知其蓄瘀，不呕不利，饮食如常，脉有力知其正气未虚，故可攻之。若泥胎前责实，产后责虚之说，延迟观望，正气即伤，虽欲攻之不能矣。”主家坚信之，故获效。

【大黄甘遂汤治腹大如鼓小便甚难医案】易巨荪：

癸未 6 月，有店伴陈姓者，其妻患难产，两日始生，血下甚少，腹大如鼓，小便甚难，大渴，医以生化汤投之，腹满甚，且四肢头面肿，延予诊治。不呕不利，饮食如常，舌红苔黄，脉滑有力，断为水与血结在血室，投以大黄甘遂汤，先下黄水，次下血块而愈。病家初疑此方过峻，予曰：小便难，知其停水，生产血少，知其蓄瘀，不呕不利，饮食如常，脉滑有力，知其正气未虚，故可攻之。若泥胎前责实，产后责虚之说，迟延观望，俟正气既伤，虽欲攻之不能矣。病家坚信之，故获效。(广东中医 1962；(8>：34)

【大黄甘遂汤变方治产后小腹微胀医案】宋同勋：

李某某，女，26 岁。1970 年 11 月就诊。第一胎足月横位难产，产后三日，除小腹微胀微肿外，别无不适。后腹胀日重，疼肿加剧。诊脉沉涩，舌质红暗苔滑，腹部压迫难受，少

腹与脐周隆起，如孕六七月状。从脐的右上部至脐的左下部有一隆起斜条，按之硬。小便不利，滴漓可下，尚不甚急迫。拟方：厚朴 10 克，甘遂 4．5 克，阿胶 10 克。一剂煎服，服后小便有所增加，仍无大进展。药既稍效，增量而再进。厚朴 30 克，甘遂 6 克，阿胶 12 克，木通 15 克。1 剂。药服后，一日夜尿量大增，腹消而愈。(河南中医 1983；(4)：30)

【肾气汤治口中泛咸妇女更年期综合症医案】艾发源：

丁某某，女，52 岁，农民。1981 年 5 月 3 日就诊。口中泛咸已有年余，饮水后稍减，须臾同前。伴头晕，耳鸣，腰酸膝软，畏寒肢凉等。曾在某医院检查，考虑为“妇女更年期综合症”。患者形体消瘦，面色苍黄，舌质淡胖，舌苔薄白，两脉沉细。分析：咸味归肾，其性属阴，肾阳虚不能制阴，阴液上乘，故口中作成。嘱其常服金匮肾气丸，日服 2 次，各服 1 丸。服用 1 月后，口咸即除，余症亦好转，随访 1 年未复发。(四川中医 1986；<5>：17)

【桂枝汤加龙骨牡蛎治产后暴崩医案】连建伟：

冯某某，女，28 岁，1971 年 10 月 20 日诊。患者系初产妇，产后恶露已净，少腹不痛。突然于产后第 26 天晚上暴崩不止，急送某医院。经西医用止血剂治疗并输血 400 毫升，病情有所好转，但漏下仍未止。又服当归炭、炒白芍、生地炭、丹参炭等养血止血之剂，反增心悸怔忡，饮食减少等证。改邀笔者诊治。患者脉来细弱，舌质淡白少华。辨证论治：产后暴崩，无腹痛，为气虚不能摄血之证。气为血之帅，气虚则血不循经而妄行。此证本应益气摄血，反投养血止血，滋腻之性，损伤阳气，心阳受损则心悸怔忡，脾阳不振则纳食少进。脉来细弱，舌质淡白少华，均为气血大虚之象。治拟益气养营，引血归脾。处方：桂枝 4.5 克，炒白芍 9 克，炙甘草 4.5 克，生姜 3 片，大枣 5 枚，龙骨 15 克，牡蛎 24 克，党参 12 克，炙黄芪 12 克，炒白术 9 克，广皮 6 克，黑归脾丸 12 克(吞)。3 剂。

10 月 23 日复诊：漏下渐止，纳食渐增，怔忡亦有好转，再服原方 3 剂，诸症悉愈。(《金匮方百家医案评述》1991：75)

【加味逍遥散治疗老年性郁病】矢数道明：

患者 72 岁，女。患者 56 岁时患子宫出血而接受了全子宫摘除手术。从那以后患忧郁症，说话不清，易疲倦、头痛、眩晕、耳鸣、动悸，呼吸困难，常有灼热感和恶寒交错，体温约 37°C。无食欲，大便 1 日 1 次，数年来血压 180 傅山曰：00，每月有一半时间卧床不起，精神郁闷，营养稍差，脸色无精神，忧郁。脉弦。脐上有动悸，起夜小便 2 次。

治疗：服加味逍遥散二周后有了精神，脸色出现气色，出现食欲。血压成为 160/85，精神愉快，好像变成另外一个人。患者自己和家属都很惊奇。以前每年到冬天就卧床不起，今年 8 尽管很冷，也能起床，患者非常高兴。

服药以来病情好转，在我的治验例中这种好转的病例也是不多的。《 汉方的临床》1974 年 6 月。

罗按：加味加味逍遥散，在《傅青主女科》中治带下病，就是该方证能作用于妇人子宫的病位，也能作用于肝经。当然日本人治病他不看经络，看证的多，脉也不怎么看。

【当归芍药散妇人交媾疼痛】曹习诠：

杨某，37 岁。1979 年 2 月 1 日诊。近半年来每次性交时及以后均出现阴道及子宫胀痛，

并向小腹放射，疼痛可持续3～5天不等，难以忍受。患者形体消瘦，精神不振，平素饮食少思，身软无力，睡眠多梦，带下量多色白，外阴瘙痒，舌质淡苔白，脉弦细。当归、茯苓、柴胡、枳实各12克，白芍、白术各15克，泽泻18克，．川芎10克，甘草3克。服1剂，疼痛轻，饮食增加，白带明显减少。连服4剂，一切如常。随访至今，再无性交疼痛发生。(四川中医1990；〈12)：34)

【四逆三生饮方证治形寒肢冷性欲下降】阿骅表兄：

一个三十五岁的妇女，青年时代患过肺结核病，两年前停经以后，渐渐地陷入了疾病的漩涡之中而难以自拔，屡经中西医治疗没有明显疗效。现在的病况是：面色青白，形寒肢冷，生趣全无，容易疲乏，动作迟滞，话语减少，注意力分散，浅睡易醒，性欲下降，时有痰涎呕出，反复出现轻生的想法与行为。病人脉象沉滑，舌体淡红，舌苔白厚水滑，腹诊没有什么特殊征象。病症是少阴病四逆汤证，再考虑到”寒痰蒙蔽心窍为癫”的古训，就毅然投以四逆汤与《局方》三生饮合剂三帖。处方如下；制附片三钱，干姜二钱，甘草一钱，制南星二钱，木香二钱，制川乌一钱，生姜三片。药后诸症明显减轻，守方一周，病人神清气爽，恢复正常，停药观察没有复发，至今已经三个月了。阿骅表兄把这个病的以上脉症命名为“四逆三生饮方证”，要我在临床上注意观察与应用。

第十五节 桂枝茯苓丸方证

【桂枝茯苓丸医案癥瘕(子宫肌瘤)】岳美中：

赵某某，女，47岁，1961年4月3日初诊。患者于四年前发现下腹部有一鸡蛋大肿物未予介意。但以后肿物逐渐增大，四年后肿物增大使腹围增至97公分，较前增加17公分，如怀胎状。两天前突发下腹剧痛，冷汗淋漓。经某某医院诊为“子宫肌瘤”，并要立即手术治疗，患者未允。乃请岳老诊治。诊见形体瘦弱，面色萎黄，下腹肿物按之坚硬，压痛明显，舌质暗，少苔，脉沉细而涩。经水二至三月一行，量少色黯，夹有血块。证属瘢积瘀血，治以疏肝健脾，破瘀消瘕。

处方：**桂枝9克，茯苓9克，川芎9克，丹皮9克，桃仁9克**，白芍21克，当归9克，泽泻21克，白术12克。服药10剂后，腹痛明显减轻，乃将原方改为散剂，每服9克，日服二次。

服用二个月，下腹肿物日渐变小，症状大见好转。服药半年，下腹肿物消失，经水正常，诸症悉除。七年以后，患者复因处境不顺，情志不舒。下腹肿物又起，逐渐增大，症状同前。经岳老诊治，仍继服原方散剂，三个月后，又获痊愈。

按语：此病系肝郁气滞，血行不畅，气血滞于小腹，久积而成。岳老虑其体虚，不宜攻逐，当治病留人，缓消其瘕。故选用当归芍药散合桂枝茯苓丸以疏肝健脾，活血消瘢，病虽重却免于手术，药治半年而愈。

癥瘕(桂枝茯苓丸加味治卵巢囊肿)刘昭坤：

何某，32岁。患者月经周期45天～50天，经期6天～8天，行经腹痛、夹黑色血块、并逐次加重1年余，白带量多质稀，少腹凉而坠痛，腰酸体倦，舌质黯两侧有瘀斑，苔白厚，脉沉弦。屡服少腹逐瘀汤、完带汤等，其效不著。妇科检查：耻骨联合左侧扪及7cm×6.5cmX8cm囊性包块；质软，活动度好。B型超声波检查报告：子宫未见异常，左附件见6．5cm×8cm液性暗区，提示：左侧卵巢囊肿。综其脉症，乃痰湿与瘀血互结为症。治宜温化痰湿，活血消瘕。方以桂枝茯苓丸加味：桂枝20g，茯苓45g，丹皮10g，桃仁10g，赤芍10g，泽兰30g，香附15g，黄芪30g。日1剂，水煎，分早晚2次温服。服药3个疗程后经妇科检查及B超复查报告：子宫及双侧附件未见异常。迭进5剂，改2天1剂，以巩固疗效。经随访2年，并做B超检查，无复发。

按语：卵巢囊肿古谓之“肠覃”，对其治疗《内经》云“可导而下”，临床实践证明，用桂枝茯苓丸治疗有佳效。如刘氏报道，共治疗98例，痊愈71例，显效19例，有效6例，无效2例，总有效率达97.96%。

吴氏曰：曾有人问：为什么子宫肌瘤用桂枝茯苓丸治疗没有效果？我说子宫肌瘤是肿瘤，是痰瘀互结，其背后是脏腑阴阳气血逆乱，一定要去恢复其脏腑阴阳气血。怎么去恢复呢？这个属于后面“阴阳易”章节中讲的“重阴”，雌激素水平高了，就需要对抗她的雌激素。重阴纠正后，子宫肌瘤就小了，这与西医用三苯氧胺治疗子宫肌瘤的原理是一样的。但是我们的办法和西医还不一样，我们通过内源性阻断，治疗的办法很多，不仅仅是桂枝茯苓丸、桃核承气汤。

【胡希恕桂枝茯苓丸治脉管炎】

这个我用这方治过脉管炎。尤其这个下肢。邻居他姓尹，他得这个脉管炎病，他到这个同仁医院，说你这个将来得截肢，他害怕了，他愁得很。我说用不着截肢吧。我用的就是这个桂枝茯苓丸，这个方子得加驱血淤的药，他这个有桂枝就不用加桂枝了，就再加桃仁、丹皮、茯苓就行了。这个挺好使这个。他们外科用的这个氧化糖，与这个方子差不多。

【麻黄附子细辛汤合桂枝茯苓丸治多囊卵巢综合证一例】

张某，女，20岁。闭经一年，身体日渐肥胖，体毛增多，于当地妇幼保健院检查诊断为多囊卵巢综合征，性激素六项显示睾酮、垂体催乳素水平高，B超显示双侧卵巢数十个囊状回声。

一诊：患者自述曾于经期吃过冰淇淋，自此以后便停经，身体开始肥胖，食欲亢盛。仔细问询，无其它异常，无口干口渴口苦，二便正常，手足自温，不凉不热，睡眠可，偶有多梦。查其皮肤干燥甲错，无汗，自述闭经后再无出汗，即使剧烈运动也很少出汗，舌质淡紫舌苔水滑，脉弦滑。方用麻黄细辛附子汤合桂枝茯苓丸，十付。

二诊：用药后无变化，月经未至，嘱继续服药十付。期间患者母亲动摇，寄希望于手术治疗。

三诊：仍未有起色，劝说继续服药，十付。此次，十付药未服完，患者微信告知阴道流出酱油色液体若干，询问是否是月经。嘱不须停药，继续服用。

此后一直守方服用，又过月余，月经如期而至，色量俱可。嘱继续服用，患者以工作为由停药，前后共服药50余剂。自此后月经每月都来，偶有拖后，但大致正常。一年以后复查，性激素六项基本正常，B超亦显示无多囊卵巢。

本例患者追溯病史很重要，经期受凉是导致闭经的直接原因，用药须温阳通经，经闭日久必有瘀血留著，舌紫和肌肤甲错也提示血瘀，故选用桂枝茯苓丸。选用麻黄细辛附子汤，是考虑到本方既能发汗通经又能温里逐寒。多囊卵巢综合征是妇科常见病、疑难病，西医目前仍无可靠有效的治疗方案，常规治疗口服避孕药、促排卵药、激素疗效不理想，手术打孔容易复发、损伤卵巢。而中医通过辩证论治，治疗本病可收到意想不到的效果，副作用少，安全可靠。

【核承气汤去芒硝合桂枝茯苓丸治脉混合痔】熊兴江：

熊某，男，58岁。2008年1月25日初诊。主诉：肛门疼痛坠胀不适两天。患者有混合痔病史20余年，18年前已行手术治疗，后来仍时有反复。两天前过度劳累后出现肛门疼痛坠胀不适，便后有少量暗红色血液；时有头晕头痛，夜间咳喘，胃纳好，睡眠尚可，小便黄，大便一直干结。患者有高血压病史5年，每年冬天血压升高，目前在服卡托普利片控制，平素血压未监测。有嗜烟史，查：患者体格壮实，面色暗红，肌肉坚紧有力，声音洪亮；唇色暗红，舌质偏红，苔薄白，脉弦有力；大腹便便，腹诊下腹坚满有力；测量血压134／96mmHg；肛周外观可见赘生物突出，未指检。中医诊断：内外痔；西医诊断：混合痔。证属瘀热互结下焦，拟桃核承气汤去芒硝合桂枝茯苓丸治疗，处方：桃仁10g，大黄（生）10g，桂枝10g，

茯苓 15g，赤芍 10g，丹皮 10g，生甘草 6g。3 服，水煎服。

患者服上方至第二服大便即软，痔疮疼痛大减，外观赘生物缩小一半，三服后肛门基本不疼，头晕头痛基本好转，夜间咳喘减半，一周后赘生物消失。随访至今再未复发。

注家按：本案患者肛周疼痛坠胀，有赘生物，唇暗红是为瘀血证；大腹便便，腹诊坚满有力，平素容易头晕头痛，血压升高，大便偏干，舌红脉弦有力，全为阳证实证，类似于上述“瘀热”类型的体质，考虑桂枝茯苓丸与桃核承气汤合方治疗。

桃核承气汤原文主治伤寒下焦蓄血证，“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。”方证中尤以少腹急结为辨证要点。该方可以泻热逐瘀，最适用于大便干结，下腹疼痛的瘀热互结证。叶橘泉认为该方证主证为阳明里实证，小腹急结、瘀血、充血、冲逆、蓄血如狂等症候群，妇人诸病、癫狂病、充血性头痛、眼结膜炎、齿龈炎、急性高血压、鼻衄、跌打伤肿痛、痔疮肿痛、肛痈肿痛等，只要具备上述阳明病的“色”、“脉”及腹部症状（小腹急结）都可使用本方。该患者肛周疼痛坠胀，大便时痛苦异常，可以看作是少腹急结的一种表现。去芒硝是考虑减轻泻下之力。方中再合桂枝茯苓丸改善腰以下部位（尤以盆腔为主）的血液循环，加强化瘀，促使瘀血消散吸收。药后病症大减，效如桴鼓，说明方证对应。

【桂枝茯苓丸治下肢水肿】熊兴江：

李某某，男，61 岁。2008 年 12 月 17 日初诊。主诉：下肢水肿一年。一年前发现下肢水肿，按之凹陷明显，下午明显，曾服五苓散 10 余服无效。时有头晕头痛，胃纳可，睡眠尚好，大便容易干结，小便无力，有分叉，夜间小便 3 次。查：血压 150 **胡希恕曰：**00mmHg，患者体格壮实，腹部实大，腹肌紧张有力；面红，午后尤甚，唇暗红，舌苔薄白，脉弦有力。既往有高血压病史 8 年，在服卡托普利片，血压控制情况不详，有下肢静脉曲张病史多年，具体不详。中医诊断：水肿、眩晕；西医诊断：高血压病、下肢静脉曲张。证属水瘀热内阻，拟桂枝茯苓丸原方，处方：桂枝 15g，茯苓 30g，桃仁 15g，赤芍 20g，丹皮 15g。3 服，水煎服。

患者药后大便通畅，头晕头痛减少，水肿变化不大，无咽痛、小便黄。拟原方茯苓加至 60g，继续服用。患者坚持服药 30 服，电话告知下肢水肿基本消失，颜面不红，头痛头晕未作，血压维持在 136/86mmHg 左右，随访至今，患者病情一直平稳。

注家按：该患者下肢水肿与静脉曲张和高血压病均有关联。从药物运用指征角度来看，患者也是一例典型的“瘀热”体质，故用桂枝茯苓丸方治疗。值得注意的是，患者共服用桂枝近 500g，并未出现“桂枝下咽，阳盛则闭”之弊，提示我们只要遵循“有是证用是药”的原则，临证放大药物剂量很可能会加速疾病痊愈。

【桂枝茯苓丸治疗肺病】黄煌：

人但知桂枝茯苓丸是妇科方，却不晓其也是内科良方，用于肺病颇佳。前不久在江阴诊治一老人，患慢性阻塞性肺气肿，一月数发，必住院输液吸氧，稍能稳定。其人身板硬朗，但面红如酒后，谈话中气喘吁吁。断为肺循环不佳，用桂枝茯苓丸加川芎、丹参。一月后复诊，告诉咳喘大平，未再住院，老人满心欢喜。

【桂枝茯苓丸治疗咳嗽痰血暗红】黄煌：

桂枝茯苓丸治疗肺病的案例不少。一安徽老者，有糖尿病，咳嗽痰血暗红已数月，排除肺占位，面暗红，舌底静脉迂曲。用桂枝茯苓丸加怀牛膝大黄，其血不久便止。

【桂枝茯苓丸治疗上肺陈旧性肺结核】黄煌：

一中年男子，右胸刺痛数月，检查发现右肺上有阴影，诊断为右上肺陈旧性肺结核，右下肺局限性纤维化伴有肺部感染。其人面部灰暗，眼圈发黑，唇舌暗红，舌下静脉瘀紫。有心脏搭桥手术史。给服桂枝茯苓丸加川芎、丹参、当归，半月后胸痛大减，续用半月，胸闷痛消失，脸色红润。

【桂枝茯苓丸治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压】黄煌：

还有一位慢性血栓栓塞性肺动脉高压的患者，两目暗黑如熊猫，嘴唇紫暗，心悸，动辄气喘，甚则晕厥。方用桂枝茯苓丸加甘草、川芎，其中桂枝 20 克、肉桂 10 克。另再口服大黄䗪虫丸。一月后复诊，其脸色由青色转红润，精神明显好转，心慌消失，腹中痞胀减轻。凝血酶原时间由原来 8 月 22 日查的 41 秒减少为 18.2 秒(正常为 11 一 14 秒)。至于用桂枝茯苓丸合大柴胡汤治疗支气管哮喘，我已经多次提及，在此不再赘述。

根据我的经验，桂枝茯苓丸是治疗肺病的又一良方，一是平喘。这种喘，不是中医人常说的风寒束表的肺气郁闭，也不是肾不纳气的虚喘，而是一种瘀血喘。二是治胸痛。这种痛，非痰热结胸，也非寒实结胸，也是瘀血在胸膈。所谓瘀血，用现代的话来说，就是肺循环障碍。这种状态的识别，主要看面色和舌象，其特征是面红如酒后，紫红或潮红，唇舌紫暗，舌底静脉迂曲充盈显见。有的患者可以出现眼圈发黑、面部皮肤毛孔粗大，以及下肢皮肤干燥脱屑，或浮肿，或足冷如冰。这种状态，前人常称之为“戴阳”，大多需要用肉桂以引火归元。其实，这就是一种桂枝证，特别是桂枝茯苓丸证。桂枝茯苓丸服用后可以平喘，同时可以改善睡眠、通便、利腰膝等。其原理，就是活血化瘀，改善肺循环，从而改善心肺功能。

【桂枝茯苓丸治疗下肢静脉血栓】黄煌：

毛某，男，51 岁。2004 年 11 月底因左腿肿痛确诊为左下肢静脉血栓，血栓长度 20cm，曾在当地住院治疗。医生欲手术去栓，患者畏惧手术，但用静脉抗栓治疗无效。希望服用中药试试。2005 年 5 月 21 日开始服用如下汤方：桂枝 10 克、肉桂 5 克、茯苓 15 克、桃仁 12 克、丹皮 10 克、赤芍 15 克、白芍 15 克、怀牛膝 30 克、丹参 12 克、石斛 20 克、红花 10 克。服用两月，复查 B 超下肢静脉血栓已消失。

静脉血栓绝大多部分发生在下肢，而且多为左下肢，患肢肿胀、增粗、疼痛，发病迅速。其并发症肺梗塞的发病率和死亡率高，据说，美国每年约有 50000 至 200000 人死于肺梗塞。静脉壁损伤、静脉血流滞缓和血液高凝状态是下肢静脉血栓形成的三大要素。长期卧床、外科手术后、肾病、静脉插管、心肌梗死、恶性肿瘤、吸烟、口服避孕药、粗暴按摩、肥胖、高龄等均可成为诱发因素。本病的治疗，现代医学主要采取抬高患肢，自患肢静脉滴注低分子右旋糖酐、复方丹参及小剂量溶栓剂，上述治疗持续 3 天后症状仍不缓解并加重者，可考虑行介入治疗。中药治疗一般也使用活血化瘀药。

从中医的角度看，患者的瘀血不仅是指下肢血管的血栓，而有其特有的诊断着眼点。首先，患者是一位体格壮实的中年男子，面色暗红，腹部肌肉比较紧张；第二，左下肢肿胀疼痛，活动时疼痛加剧；第三，既往有痔疮，近日频发。痔疮也是瘀血在下的指征。以上三条，符合瘀血在下的判断。

本案使用的配方由经方桂枝茯苓丸和经验方四味健步汤组成。桂枝茯苓丸是经典的活血化瘀方，有关论述可参见前案。我重点说说本人的经验方四味健步汤。该方由芍药、怀牛膝、丹参、石斛组成。主要用来治疗下肢疼痛为特征的瘀血性疾病，其作用部位以血管为主。许多糖尿病的并发症，如糖尿病足、糖尿病肾病、静脉血栓形成等经常有应用的机会。

本方中的这些药物，大多是古代用于治疗腰腿痛或步履乏力的药物。芍药是经方芍药甘草汤的主要药物，《伤寒论》用芍药甘草汤来治疗“脚挛急”，说药后“其脚即伸”。有趣的是，《朱氏集验方》将此方治疗不能走路，改方名“去杖汤”。《神农本草经》也说芍药“除血痹”，血痹，都是有疼痛。怀牛膝，《神农本草经》说得更清楚，说“主寒湿痿痹，四肢拘挛，膝痛不可屈伸”，唐宋方中多用来治疗腰膝酸软。还有石斛，古代多用来治疗脚弱腰痛的病症。比如《外台秘要》记载的生石斛酒，用生石斛三斤，牛膝一斤，杜仲八两，丹参八两，生地黄三升，泡酒，用于治疗风痹脚弱，腰胯疼冷。《辩证录》有一方，名石斛玄参汤，用石斛一两，玄参二钱，水煎服，治疗胃火上冲，心中烦闷，怔忡惊悸，久则成痿，两足无力，不能步履。

现在看来，这些脚弱腰痛的病症，大多是糖尿病引起的，也有的是静脉血栓之类的疾病。经过一段时间临床验证，发现此方效果很好，主要表现为下肢疼痛、麻木、抽筋、浮肿等症状的缓解，有些患者居高不下的血压也能有所下降，有些患者多年困扰的便秘也能解决。方中的芍药，有赤白芍药两种，习惯认为，白芍以养血柔肝为主，用于肌肉痉挛性疾病为主。赤芍以活血化瘀为主，用于舌质暗紫，或血液粘稠者较多。我临床往往赤芍白芍一起用，用量根据病情调整。如果疼痛剧烈者，大便干结者，芍药的总量可以达到 120g。牛膝，有川牛膝、怀牛膝两种饮片，怀牛膝具有补益肝肾的功效，所以，对于腰痛脚弱者，用怀牛膝比较好，量可以用至 100 克。

效果还是比较好的，后来随访，在服用中药三月后，血栓已消，局部遗留血栓囊壳，有肿胀感，痔疮未发。余无不适。目前已经停药。

【柴胡加龙骨牡蛎汤合桂枝茯苓丸与栀子厚朴汤治疗痴呆老人】黄煌：

一位女士是我的老病人了，她患有严重的便秘，检查发现结肠冗长，结肠袋消失，外科医生建议手术。我给她服用的是柴胡加龙骨牡蛎汤合栀子厚朴汤，后来居然有了便意，开塞露也可以停用。所以，她介绍了不少消化系统的病人来，而且效果都不错。

这次她来的目的，除了自己看以外，还为她的奶奶转方。老人已经 87 岁，消瘦，去年冬天房颤发作，后又出现脑梗，至今年春天大都卧床不起，经常胡言乱语。我当时用的方是柴胡加龙骨牡蛎汤合桂枝茯苓丸与栀子厚朴汤。这位女士告诉我这张方很灵，服用以后，头脑就会清醒，失眠、夜尿频繁、烦躁，说话颠三倒四的现象就减少。但停药个把月后，症状又会加重，再服此方，又会好转。所以，这张配方也就间断服用的。我没有更方，慢性病还是要守方。这位女士小心收下处方签，笑容满面地走了。

这个反馈信息对我很重要。老年性痴呆是难病，柴胡加龙骨牡蛎汤与桂枝茯苓丸栀子厚朴汤合方对老年性痴呆有效，虽然是近期疗效，而且也只是改善部分症状，但已经是不简单了。这个信息提示我以后可以进一步观察。我的许多经验就是从个案开始摸索的。

柴胡加龙骨牡蛎汤是《伤寒论》方，方证的经典表述为："胸满，烦、惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者"。这都是精神神经系统疾病的部分常见症状，所以，我将此方经常用于抑郁症、恐惧症、神经症以及脑萎缩、痴呆等。桂枝茯苓丸是活血化瘀的名方，老年人瘀血多，尤其是脑血管梗塞患者，多用此方。栀子厚朴汤只有三味药，栀子、厚朴、枳实，经典方证是"心烦腹满，卧起不安"，这正是焦虑症、抑郁症患者常见的表现，栀子厚朴汤除胀满，抗焦虑，效果好。三方相合，作用面更宽，改善睡眠的效果尤其明显。对于许多老年性痴呆等老年脑病患者来说，睡眠的改善就是其生活质量的提高，不可小视啊。

【桂枝茯苓丸治性肺栓塞】黄煌：

2010 年 2 月 15 日，25 岁的八一女篮队员王凡因肺梗塞去世。肺梗塞是肺栓塞后因血流阻断导致的肺组织坏死。引起肺栓塞的常见栓子是深静脉血栓，还可有脂肪、肿瘤栓子和气体等。此病起病急，有呼吸困难、胸痛和咯血等，死亡率极高。王凡就在 301 医院昏迷 23 天未能幸免。此病的急症是轮不到我们治疗的，我曾经治疗过一例慢性肺栓塞病人。此人为老年男性，一年数次急诊抢救入院，后用桂枝茯苓丸加川芎、丹参，并服大黄䗪虫丸等，较好地控制了病情，患者数年稳定。这个患者形体消瘦、面色青黄、眼圈发黑如熊猫眼，口唇

紫暗，肌肤甲错，一看就是中医所说的瘀血体质。我上网看了一下王凡生前的照片，发现她的脸色也偏黄，而且眼圈也发暗，口唇也不鲜红，可见她早有瘀血隐患。我想，如果王凡早点服用中药调理，自己也注意休息，可能就会逃过一劫。但为时已晚，一代女篮骁将，说走就走了！

桂枝茯苓丸是古代的下死胎方，后世的应用范围非常广，特别是日本汉方，将桂枝茯苓丸作为活血化瘀的基本方用于各科临床。我在临床发现桂枝茯苓丸对血栓性疾病有效，不仅是肺栓塞，对心肌梗塞、脑梗塞以及下肢的静脉血栓也有效果。只是有时需要合方，或合血府逐瘀汤、或合黄芪桂枝五物汤，或合大柴胡汤，或合柴胡加龙骨牡蛎汤，或合大黄䗪虫丸，或合桃核承气汤，或合本人验方四味健步汤，“病”“人”同调，效果要更好些。

迟到的建议，桂枝茯苓丸。除了对王凡去世的哀悼之外，更希望这点小小的经验，能引起各位网友对体质调理的关注，更希望引起中医界对桂枝茯苓丸这种经方应用范围扩展的关注。桂枝茯苓丸不是仅仅是治疗子宫肌瘤的成药，其中蕴含的巨大能量需要好好地去利用和开发。

【桂枝茯苓丸治身上的紫斑】黄煌：

今天苏北沭阳的老仲来第三次复诊，病情与去年 11 月的初诊相比已经有明显的好转。当时，他患脑梗，左半身不遂。过量的喝酒、长期缺乏运动，不科学的生活方式，使他 50 岁刚到就有了糖尿病、高血压、高脂血症、脂肪肝，血脂高达 6。硕大的腹，暗红的舌，还有涨红的脸。记得在按压其腹部，疼痛、胀满，他惊恐害怕：是否还有更重的病?他也忧郁，经常失眠，第一次感受到失去行动自由的他，在医生面前流下了悔恨的泪水。我给他服用的是大柴胡汤合桂枝茯苓丸。

3 月份他来复诊，就感觉身体轻快了许多。效不更方，我嘱其原方继续服用。今天，他的步态已经接近正常，血脂降为 4。空腹血糖也接近正常。舌质转红活，面色也白了不少。他笑着告诉我，很多老朋友都不知道他竟然患过那等重病。他还告诉我，他服药很认真，每天三次，每次都是一大碗！

这次，发现了一个特别的现象：满身的皮下暗斑。他撩起衣服，让我看他的皮肤上许多淡紫色的暗斑，不是丘疹，不是出血点，也不是皮下紫癜，压之不褪色，大片的，几乎在躯干上，不痛不痒。犹如刺青，但颜色更淡些。据他说，去年冬天就有了，开始是红色的，后来服用中药以后就变淡了，变紫了。他问：是否是体内的瘀血发出来的缘故?我无法肯定地回答。人体有无数的秘密，病人有许多的疑问，做医生真是不容易！

【桂枝茯苓丸加大黄牛膝下瘀血如神】黄煌：

桂枝 20 克、茯苓 20 克、丹皮 15 克、赤芍 30 克、桃仁 20 克、怀牛膝 60 克、制大黄 10 克。这是我给 X 女士的老父亲所开的处方-桂枝茯苓丸加大黄牛膝。

2 个月前，X 女士告诉我，他父亲胸闷异常，无法行走，恐为时不久，情绪低落，邀我出诊。前往 X 老居室，见其虽然已经是 90 岁的高龄，但形体依然魁梧，只是脸色黝黑发红，端坐在椅子上，无法行走。诉说胸闷腹胀，观其腹部，硕大如鼓，犹如弥勒佛，按之不痛但也不柔软。而察其两下肢，浮肿，按之如泥。大便十分困难，必须依赖开塞露，否则干燥难解。我看是腰腿少腹有瘀血沉积，所以，苦腹胀。当用大剂桂枝茯苓丸加大黄牛膝。嘱七剂后联系。一周后反馈，药后感到舒适，嘱效不更方，再服一月。昨天，X 女士女士在电话中高兴地告诉我：他老父亲的肚子小了一圈，下肢浮肿也退了，大便顺畅。老人能够每天出来走走，心态好了许多。

桂枝茯苓丸善于消解少腹腰腿瘀血。女人痛经、漏下、闭经、不孕者，男人便秘、腰痛、前列腺增生、下肢浮肿、脚痛等，都可用此方。加大黄、怀牛膝更佳。大黄、桂枝、桃仁，为活血化瘀的经典组合，犹如桃园三结义，能通调血脉，清除淤积。牛膝利腰膝，能通经活血，并治少腹痛。前人说牛膝能引药下行，是否能如此不好说，但牛膝的作用部位在下肢，

倒是明显的。而且，牛膝能治大肚子。先前治疗一中年男子，腹大如怀八月胎儿，外号大肚子。用大量牛膝后明显松快缩小。桂枝茯苓丸加大黄、牛膝，我常用于各种血栓性疾病。X老就是下肢静脉血栓可能，如不加治疗，瘀血冲胸，也会酿成大祸。

后续：近治一产妇，顺产三周后恶露仍为红色血性物，B超显示子宫底有7.8以及8.1毫米的强回声光条，医院建议马上清宫。病家畏惧，改服经方桂枝茯苓丸加大黄牛膝，9月1日服药，3剂血止，5日复查宫内已经很干净了。

【桂枝茯苓丸方证的一角肺团块状软组织影】黄煌：

从小火瓦巷的家到科巷菜场，金金金82岁的1老居然能够徒步来回，让全家高兴。他10年前肺泡破裂大出血后，反复肺部感染，经常右胸痛，动则气促，便秘，腰痛腿软，行走困难。当时的肺部摄片提示右下肺团块状软组织影，占位可能，右侧胸腔积液。我给他用的方如下：桂枝20克、茯苓20克、赤芍20克、丹皮20克、桃仁20克、怀牛膝20克、制大黄10克、丹参20克。仅仅服用一周，效果如此明显，我也感到高兴。

近几年来，我用桂枝茯苓丸加味方治疗瘀血肺病屡屡得效。这些肺病，大多是陈年久病，或是咳喘为主的慢性阻塞性肺气肿，或是不明原因的肺动脉高压，或是糖尿病导致的肺部出血，或者是支气管哮喘，或者是间质性肺病等，或是先天性心脏病等。病虽不同，瘀血则一。其表现有在上的面色暗红、唇舌紫暗、动则气喘、胸痛等，在下的便秘、腰痛、下肢浮肿、抽筋、发冷以及两腿皮肤甲错发暗等。

这些案例常常让学生大惑不解。因为从《金匮要略》原文来看，确实是很难将桂枝茯苓丸与肺病联系起来的。桂枝茯苓丸的经典方证比较简略："妇人素有症病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者"。遵循古法，后世也大多用桂枝茯苓丸下死胎、消症瘕、止漏下，范围大多局限在妇产科临床。

但是，纵观当今中外临床，桂枝茯苓丸的应用范围确实大大拓展了，呼吸科、心血管科、神经内科、皮肤科、男科、皮肤病、外科均有应用的机会。其实，不仅仅是桂枝茯苓丸，许多经方均是如此。无数经方现代应用的成功事实向我们提示了一个十分重要的规律：经方的应用要读经典原文，但不能拘泥于经典原文。清代医家吕震名说的好："凡读仲景书，既从有字句处知其定法，又当从无字句处参其活法"。定法，是既有的经验和规矩；活法，是尚待发现的规律和处理问题的原则。在经方家看来，读经典，就是要善于通过经典原文对经方方证进行整体的复原，犹如古生物学家能从一个恐龙的骨骼化石进行全身复原的一样。经典表述的方证是真实的，但是不完全的。如果说方证是冰山，那经典方证就是那浮出水面的一角。

【桂枝茯苓丸方证的一角尿毒症的经方透析法】黄煌：

今天，常州那位尿毒症患者的丈夫来电话，说服药一周以后效果很好，肌酐已经从700多降到600多。而且，服药后又来了月经，患者感到全身非常舒服。那是一位少妇，眼圈发黑，神情忧郁，因为不愿透析，来南京用中药一试。我用的桂枝茯苓丸加大黄牛膝丹参川芎。我当时劝慰她，我们来想想办法，先用用"经方透析法"治疗！

桂枝茯苓丸本是古代下死胎方，也是活血化瘀的祖方，尤其是瘀血在下，此方最佳。不少肾病患者，多有瘀血证。其人或烦躁失眠，或头痛头晕，或腰痛腹痛。其客观指证，一是面部暗红，或两目暗黑，舌质多暗紫；二是少腹压痛，或左或右；三是小腿皮肤干燥，或如鱼鳞，或暗黑，也有浮肿以及步履疼痛者。当然，其舌质多暗紫。

桂枝茯苓丸用于肾病，多配大黄、牛膝，如果有头痛头晕者，加丹参、川芎，而如果是糖尿病肾病，则还要配上石斛、黄芪。

【桂枝茯苓丸治临床应用医案】网文：

桂枝茯苓丸将丸剂改汤剂，使其临床应用及适应范围不断扩大，现可用于治疗内、外、妇、皮肤等各科疾病。故我将近十几年来桂枝茯苓丸在各科疾病中的应用作一一综述。

因其病机为瘀血阻滞胞宫，故方中用：桂枝温通血脉、行气活血化瘀；茯苓健脾利水下行、与桂枝同用能入阴通阳；丹皮消瘀血；桃仁破血结；赤芍行血中之滞；全方具有活血化癖消肿散结之功。运用桂枝茯苓丸加减或合方治疗痛经、崩漏、慢性盆腔炎、癌症、各种疼痛等多种疾病，病因虽各不相同，但其发病机制均有瘀血内阻，故根据其寒多于热，虚多于实的实践经验，偏重用桂枝茯苓丸加减治疗，均取得较好疗效，体现了中医“异病同治”的论治特色，现将其综述如下。

【桂枝茯苓丸合安宫牛黄丸治疗晚期肝癌医案】：

处方用桂枝茯苓丸原方加柴胡、川楝子，每日 1 剂，水煎分两次服；安宫牛黄丸，每日服 2 次。

【桂枝茯苓丸治列腺增生前列腺炎癃闭医案】：

男人因为前列腺增生、前列腺炎等等疾病引起的排尿困难。用桂枝茯苓丸加味治疗：桂枝 10g，茯苓 10g，赤芍 15g，丹皮 15g，桃仁 10g，白芥子 10g，浙贝 20g，薏苡仁 30g，怀牛膝 20g，海藻 15g。用药日 1 剂，进药 2 小时，小便微通，服药 2 剂，自觉排尿困难好转，少腹坠胀已除，继服 10 剂诸症皆消，后用桂枝茯苓丸以巩固疗效，治疗 3 个月后病情稳定，迄今未发。

【桂枝茯苓丸治眩晕医案】：

用桂枝茯苓丸加味：桂枝、茯苓、赤芍、石菖蒲各 15g，丹皮、桃仁、柴胡各 10g，细辛 5g，吴茱萸 6g，磁石 30g。每日 1 剂，水煎 2 次，早晚分服。3 剂小效。原方加倍桂枝 30g，加丹参 20g，再进 5 剂，诸症悉除，嘱服桂枝茯苓丸 1 个月以善其后。随访 2 年，未再复发。

【桂枝茯苓丸治癃闭哮证(哮喘)】：

选桂枝茯苓丸加味：桂枝、茯苓、丹皮、赤芍、桃仁、杏仁、葶苈子、红花各 10g，薤白 15g，麻黄 7g。每日进 1 剂。水煎 2 次，早晚分服。服药 3 剂后，哮喘大减。又加五味子 10g，去掉葶苈子继服 10 剂而愈。

【桂枝茯苓丸治腰痛】：

治疗病人自述 3 天前抬重物扭伤腰部，疼痛难耐，痛有定处，腰部活动受限，动则痛剧。舌紫暗，脉弦紧。此淤伤腰府。桂枝，续断，茯苓各 15g，赤芍、丹皮、五灵脂各 12g，没药、乳香、延胡各 20g，牛膝 24g，桃仁 15g 水煎服，每日 1 剂。服药 3 剂后腰痛减轻，续服 12 剂，疼痛明显好转，腰部活动自如，仅有轻微不适感，嘱其理疗，以巩固疗效。

【桂枝茯苓丸治不孕症】：

用桂枝茯苓丸加减治疗胞络瘀阻型不孕症：处方：桂枝、桃仁、丹皮各 12g，赤芍、茯苓、败酱草、桑寄生、杜仲、丹参各 15g，牛膝、莪术各 20g。水煎服，每日 1 剂。以此方为主加减连服半年后怀孕，生育一子。

【桂枝茯苓丸肾盂肾炎未怀孕】娄绍昆：

1976 年 8 月 20 日，张妻，24 岁，永强人。婚后患肾盂肾炎已将两年，时有发作，以致迟未怀孕。后请我诊视。见其脉涩，唇舌色黯，面色萎黄腰酸痛，捶之舒服，人疲思卧，纳差，小便不利，左小腹触之有抵抗压痛的肿块，但不急结，大便正常，经期不定，经色暗、有块。诊断为瘀血停滞为害，予以桂枝茯苓丸料煎服，从活血化瘀法着手调治。三剂后，诸症悉消，精神亦复，后数月遂孕，全家欣喜无限。

【桂枝茯苓丸治卵巢囊肿】：

已婚女，不孕：桂枝、赤芍、茯苓、桃仁、败酱草、郁金、泽兰、香附各 15g，丹皮、昆布各 12g，三棱、生牡蛎各 24g，牛膝 20g，莪术 30g。水煎服，每日 1 剂。用此方加减，连服 3 个月，左侧包块已消，右侧包块明显缩小，嘱其继续服药。后生一女孩。

处方：桂枝 12g，茯苓 30g，赤芍 10g，丹皮 6g，车前子 20g，汉防己 10g。本方连续服用 1 个月后，B 超示：右侧卵巢囊肿 38mm×34mm。月经来潮时血块减少，疼痛消失，由于患

者工作繁忙，不愿服汤剂，续服桂枝茯苓丸6丸，每日2次，服用2月，痛经瘥，B超复查囊肿消失，随访未见复发，婚后育，男孩。

【桂枝茯苓丸治治疗附件囊性包块（卵巢囊肿）】：

以桂枝茯苓丸加减组方：桂枝、牡丹皮、桃仁各15g，茯苓、赤芍各12g，红花、三棱、莪术各10g，若痛甚者，加延胡索12g；热重者，去桂枝加白花蛇舌草、鱼腥草、败酱草各20g，蒲公英15g，郁重者，加香附12g；两胁胀痛者，加柴胡15g；气虚者，加黄芪15g；脾虚者加生薏苡仁18g；输卵管积水严重者，加泽泻、车前子各15g。水煎，每日1剂，3煎，饭后温服，10天为1个疗程。治疗附件囊性包块96例。结果：痊愈55例，显效12例，无效7例，有效率为92.71%。

【桂枝茯苓丸治慢性盆腔炎】：

用桂枝茯苓丸加味，处方：桂枝9g、茯苓15g、桃仁9g、牡丹皮9g、赤芍9g、连翘12g、鱼腥草20g、败酱草20g、薏苡仁30g、延胡索12g。服用6剂，每日1剂。经后复诊诉经行腹痛明显减轻，效不更方，守上方继服3个月，诸症消失，妇科检查及B超示子宫及双侧附件均无异常。停药观察，随访3个月未再复发。

【桂枝茯苓丸治痛经（月经期小腹疼痛）】：

用桂枝茯苓丸治疗痛经76例，结果43例痊愈(症状消失3个月以上)；29例好转(症状消失不满3个月或仍有轻微疼痛)；4例无效(症状无改善)。总有效率94.7%。

应用桂枝茯苓汤加减治疗痛经46例药物组成：桂枝9g，茯苓、桃仁各12g，丹参、白芍各20g，延胡索、香附、五灵脂各12g，川牛膝6g，甘草9g。恶心呕吐加代赭石12g；头晕加钩藤9g；面色苍白、出冷汗、血压下降、晕厥加黄芪30g。水煎服，每日1剂。经前3~5日服用，共服6剂。3个月经周期为1个疗程。结果：痊愈33例，占77.74%；好转10例，占21.74%；未愈3例，占6.52%总有效率93.48%。

【桂枝茯苓丸治子宫肌瘤】：

用桂枝茯苓加味基本方组成：丹参30g，牡丹皮、桃仁、赤芍、川芎各9g，茯苓、海藻、昆布、当归、路路通各12g，桂枝6g，女贞子、旱莲草各20g。

治疗子宫肌瘤65例。以桂枝茯苓丸加减：桂枝10g，茯苓12g，牡丹皮、赤芍各10g，番红花3g，鸡血藤10g，益母草10g，三棱5g，莪术9g，水蛭3g，夏枯草15g，牡蛎3g，鳖甲30g，海藻10g，昆布10g，月经量多加蒲黄10g，茜草10g，炙大黄3g；腹痛加川楝子10g、延胡索10g。上药共研细末制蜜丸，每丸9g，每日2次，每次2丸，月经期停服，连服3个月为1疗程。

【桂枝茯苓丸治子宫内膜异位症】：

用加味桂枝茯苓丸:桂枝、茯苓、桃仁、牡丹皮、白芍、三棱、莪术、川楝子各10g，延胡索、丹参各12g，夏枯草15g，山慈菇6g，月经量多者经期减三棱、莪术、山慈菇、桃仁，加五灵脂、蒲黄炭、茜草各10g，三七粉6g，乌贼骨20g。

共治疗95例，显效率37.9%，有效45.3%，总有效率为83.2%。

【桂枝茯苓丸治异位妊娠】：

用桂枝茯苓丸加减：桂枝、茯苓、牡丹皮、赤芍、桃仁、制香附、制没药各12g，丹参40g，昆布、海藻各15g，生蒲黄10g。治疗异位妊娠40例，治愈39例，无效1例。

【桂枝茯苓丸下死胎】：

谭氏，用桂枝茯苓丸加减：桂枝18g，赤芍、桃仁、牛膝各15g，牡丹皮、红花各12g。下死胎，1剂后当晚开始宫缩，次日继服1剂，死婴娩出，共治疗6例均获效。

【桂枝茯苓丸治治疗子宫肥大症】：

李氏，以桂枝茯苓胶囊：治疗子宫肥大症患者12例，1个月为1疗程，经期停服，一般

服 3 个疗程，最多服 6 个疗程。结果 12 例患者均获得满意效果。月经量基本恢复正常，子宫恢复正常大小者 7 例。

由上可知，桂枝茯苓丸在妇产科应用广泛。妇女以血为主，瘀血为妇产科疾病常见之病机。瘀阻胞脉、冲任，使经脉不通；或血不归经，或壅聚成症，导致痛经、崩漏、异位妊娠、恶露不绝、症瘕等。桂枝茯苓丸活血化瘀方简功著，故临床上泛用于治疗血瘀引起的妇科疾病。

【桂枝茯苓丸治黄褐斑】：

黄褐斑是一种常见的面部皮肤病，俗称蝴蝶斑，表现为脸面部的色素沉着斑，对称分布，形状不规则，大小不定，颜色深浅不一，主要分布在眼睛周围、面颊部、颧部口周等处，影响患者的容貌美，一般无自觉症状，但治疗十分棘手。黄褐斑无论病之久暂皆与血分有关。桂枝入心经，通利血脉，温化水湿，通行头面经脉；茯苓入脾经，补脾益气养血，化浊行饮；赤芍入肝经，柔养肝脏，可行血中之滞；肝藏血，脾统血，心主血脉，丹皮、桃仁活血化瘀，消癥散结，兼清瘀热。

【桂枝茯苓丸治痤疮】：

痤疮是毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤疾患，主要发生于青少年男女面部及胸背部，形成粉刺、丘疹、脓疱、结节、囊肿及瘢痕。中医认为本病多系肺经风热毒邪熏蒸，胃肠积热，热毒蕴聚肌肤，血运不畅，瘀血阻滞而成，故也可以用桂枝茯苓丸加减治疗。

【桂枝茯苓丸加减治乳腺增生】：

以本方加当归、丹参、乳香、没药等治疗乳腺增生 110 例：痛引胸痛与肩臂者加炒柴胡、香附；经行腹痛者加艾叶、延胡索。结果：治愈 31 例，显效 43 例，有效 29 例，无效 7 例，总有效率为 93.?64%。用本方加白花蛇舌草治疗慢性前列腺炎患者 45 例。结果：痊愈 24 例，显效 15 例，有效 3 例，无效 3 例，总有效率为 93.?33%。以本方加琥珀、金钱草、石韦、滑石、甘草治疗输尿管下段结石患者 1 例 12 剂后，每晨尿中可见结石，共排出大小结石 40 枚，患者诸症除。

【桂枝茯苓丸体会】：

桂枝茯苓丸从最初专治妇人妊娠漏下及胎动不安，到现代在妇产科以及临床各科的广泛应用并取得了令人满意的疗效，可以看出以下两个特点第一，虽然此药在治疗中涉及了临床各科，但其病机中都有“症块”，即都有瘀血的致病因素，体现了中医药“异病同治”的优势；第二，用桂枝茯苓丸原方的甚少，几乎都对症进行了加减，或加强了活血消癥，或加强了软坚散结的中药，体现了中医学辩证论治、因人施治的特点。

【桂枝茯苓丸加大黄牛膝下瘀血如神】：

桂枝 20 克、茯苓 20 克、丹皮 15 克、赤芍 30 克、桃仁 20 克、怀牛膝 60 克、制大黄 10 克。

2 个月前，x 女士告诉我，他父亲胸闷异常，无法行走，恐为时不久，情绪低落，邀我出诊。前往 x 老居室，见其他虽然已经是 90 岁的高龄，但形体依然魁梧，只是脸色黝黑发红，端坐在椅子上，无法行走。诉说胸闷腹胀，观其腹部，硕大如鼓，犹如弥勒佛，按之不痛但也不柔软。而察其两下肢，浮肿，按之如泥。大便十分困难，必须依赖开塞露，否则干燥难解。我看是腰腿少腹有瘀血沉积，所以，苦腹胀。当用大剂桂枝茯苓丸加大黄牛膝。嘱七剂后联系。

一周后反馈，药后感到舒适，嘱效不更方，再服一月。昨天，X 女士女士在电话中高兴地告诉我：他老父亲的肚子小了一圈，下肢浮肿也退了，大便顺畅。老人能够每天出来走走，心态好了许多。

【桂枝茯苓丸善于消解少腹腰腿瘀血】：

女人痛经、漏下、闭经、不孕者，男人便秘、腰痛、前列腺增生、下肢浮肿、脚痛等，

都可用此方。加大黄、怀牛膝更佳。大黄、桂枝、桃仁，为活血化瘀的经典组合，犹如桃园三结义，能通调血脉，清除淤积。牛膝利腰膝，能通经活血，并治少腹痛。前人所牛膝能引药下行，是否能如此不好说，但牛膝的作用部位在下肢，倒是明显的。而且，牛膝能治大肚子。先前治疗一中年男子，腹大如怀八月胎儿，外号大肚子。用大量牛膝后明显松快缩小。

桂枝茯苓丸加大黄、牛膝，我常用于各种血栓性疾病。X 老就是下肢静脉血栓可能，如不加治疗，瘀血冲胸，也会酿成大祸。这个“老配方”就是《桂枝茯苓丸》，如果善于辩证加减，可治百病。原方：桂枝 10g 茯苓 10g 牡丹皮 10g 赤芍 10g 桃仁 10g。

【桂枝茯苓丸肾盂肾炎未怀孕】娄绍昆

1976 年 8 月 20 日，张妻，24 岁，永强人。婚后患肾盂肾炎已将两年，时有发作，以致迟未怀孕。后请我诊视。见其脉涩，唇舌色黯，面色萎黄腰酸痛，捶之舒服，人疲思卧，纳差，小便不利，左小腹触之有抵抗压痛的肿块，但不急结，大便正常，经期不定，经色暗、有块。诊断为瘀血停滞为害，予以桂枝茯苓丸料煎服，从活血化瘀法着手调治。三剂后，诸症悉消，精神亦复，后数月遂孕，全家欣喜无限。

第十六节 药物流产避孕方

【药物流产避孕方】宋孝志：

流产“红曲麦芽汤”：红曲 30g，生麦芽 60g，黄酒一杯，水二杯，煎服三副，即达到流产的目的。我一个朋友的夫人怀孕，如法服三副达到流产的目的；他随女儿出国，为华侨流产，用的就是宋老方。

【避孕“神曲麦芽汤”】宋孝志：

六神曲 9g，生麦芽 9g，3 副即可，月经净后第 3 天开始服药，进 3 副就不会再怀孕。

第二十二章 温经汤方证

温经汤方：金匮）

吴茱萸三两，当归、芎劳、芍药、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草各二两，半夏半升，麦冬一升（去心）

上十二味，以水一斗，煮取三升，分温三服，温饮之。**亦主妇人少腹寒，久不受胎，兼治崩中去血，或月水来过多，及至期不来。**

（亦主妇人少腹寒，久不受胎；兼取崩中去血，或月水来过多，及至期不来。）

【原文】：问曰：妇人年五十，所病下血[1]，数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下，何以知之？曾经半产，瘀血在少腹不去，故唇口干燥也，温经汤主之。（金匮）

涪古本对照：问曰：妇人年五十所，病下血，数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此属病带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其症唇口干燥，故知之。当以温经汤主之。

病因和病机：上热下寒，寒瘀，少腹寒

辩证要点：月经漏下数日不止、暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥。或月经不来，少腹寒。

[1]“下血”《金匮》为“下利”。

罗按：女人年 50 岁，其实就是七七四十九岁就闭经了。她下血，所以说“下血”，就是说，这不是月经，是下血，连绵数十天不断。外证：“少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥”，这是为什么呢？老师说：这是带脉为病的下血，故曰带下，为什么呢？“唇口干燥”，所以知道是瘀血在少腹不去，这是因为她生产过，半产，一说是小产。为什么唇口对应少腹？这是一个经络的问题，郝老说的上下对应的问题。

“带下”，和平常意义上的白带黄带没有什么关系，它是说是带脉为病的下血。

尤在泾曰：妇人年五十所，天癸已断而病下利，似非因经所致矣。不知少腹旧有积血，欲行而未得遽行，欲止而不能竟止，于是下利窘急，至数十日不止，暮即发热者，血结在阴，阳气至暮，不得入于阴，而反浮于外也。少腹里急腹满者，血积不行，亦阴寒在下也。手掌烦热，病在阴，掌亦阴也。唇口干燥，血内瘀者，不外荣也。此为瘀血作利，不必治利，但去其瘀而利自止，吴茱萸、桂枝、丹皮，入血散寒而行其瘀，芎、归、芍药、麦冬、阿胶，以生新血，人参、甘草、姜、夏，以正脾气，盖瘀久者营必衰，下多者脾必伤也。

【温经汤医案】王雪华：

一位六十多岁的老干部，他从他掌权的岗位上下来，很不适应，出现了一种象女子的，更年期综合征一样，烦得够呛，非常的自悲。我看他既有寒证，也有热证，我就把温经汤，给他用上了，方中有加减。我怎么考虑的呢？它那方里有桂枝汤的和法，有归、芎、芍齐调肝血的作用，还有当归四逆汤，那个当归四逆汤里头应该有通草，此外这个方里有阿胶，我用阿胶，没用通草，为什么我这么考虑呢？因为他上、下都有病，我上次讲乌梅丸证，叫做“寒热错杂”，只要寒热错杂，咱们就用乌梅丸，对不对？

温经汤，我自从治这位男同志后有很深的体会了，温经汤本来是治女子月经病的，但用到这位男同志身上，我当时就为难了，你说乌梅丸方里有蜀椒，有干姜，太热，他热证还挺明显，我一想，这温经汤方组合得好，里面有丹皮，还有阿胶，还有吴茱萸，不象蜀椒、干姜那么热，我就把这方，是在被迫无奈的情况下，一灵活，就给用到温经汤上去了，结果他吃了以后，很高兴的复诊，他说你这方，我觉得对我挺好，就好像心爽了不少，至少不那么出汗，不那么烦热了，这是一。第二，他觉得，就是好长时间以来，那种自悲感、失落感缓和了，你这方药真好使。所以，我也觉得，温经汤的临床应用扩展，咱们琢磨琢磨，我为什么在那位男患身上，使点劲敢用这个药呢？我一想，这经文里面，温经汤证，先说就是妇女多少岁？五十，“年五十”，年五十是女子绝经的时候到了，“七七天癸竭”的时候，这位男同志的更年期，到底是从哪年开始？我没有作过系统的调查和观察，但这位男干部他那种失落感、自悲感，实在是临床辨证，我觉得有点寒热错杂，你说要用小建中汤吧，纯粹温补，我还觉得不合适，提笔就是温经汤，再进行加减，我觉得，他突然的复诊，来的时候挺好，我就开始琢磨，大概是桂枝汤调和的结果，还是因为上下寒热的症状错杂，给大家一个启发吧。

【温经汤治男科病】蒋毅：

温经汤男科应用:补气血扶正祛瘀，精室虚寒、精少弱精、丸冷痛、无菌性前列腺炎、前列腺痛、精索静脉曲张并不育、前列腺痛并勃起问题。方中吴茱萸味苦、辛大热，入肝、脾胃，暖脾胃肝肾，能止痛、散寒、温阳，是厥阴肝经主药，从温阳壮阳止痛两方面来说无疑对男科各种疼痛、阴萎、不育是非常重要的。本方凡是冲任虚寒、瘀血阻滞即肾虚血瘀虚寒证的都可以加减应用，如精索静脉曲张并不育、部分堵塞性少精症(附睾梗阻)，加鹿角胶、鹿茸、附片补督脉，龟板、巴戟天、枸杞子补冲任，当归、芍药续断补带脉。慢性前列腺炎见虚寒症状，疼痛、排尿异常，原方去阿胶、人参加黄芪、白芷、细辛、威灵仙、白芥子、红花、乌药、益智仁、肉桂。无明原因睾丸冷痛原方重用吴茱萸去阿胶加小茴香、橘核、荔枝核、元胡索、香附、乳没、乌药、槟榔、皮细辛、白芷、白芥子;少精症原方加五子衍宗丸加减:吴茱萸、人参、当归、川芎、芍药、牡丹皮、阿胶、麦冬、桂枝、半夏、甘草、五味子、生姜、覆盆子、枸杞子、淫羊藿、车前子、鹿角胶、鹿茸、菟丝子、沙苑子。肝郁肾阳虚:吴茱萸、人参、法半夏、麦门冬牡丹皮、川芎、桂枝、玄驹、露蜂房、九香虫、白蒺藜、远志、路路通、穿山甲、淫羊藿、紫稍花、大蜈蚣、水蛭、桃仁、贯叶金丝桃、巴戟天、锁阳、蛇床子、韭菜子等。

【温经汤治疗精索静脉曲张】赵淑艳：

温经汤方：吴茱萸 25g，当归 20g，芍药 15g，川芎 15g，人参 20g，桂枝 15g，牡丹皮 15g，生姜 10g，甘草 10g，半夏 10g，麦冬 15g，每日 1 剂，水煎，分 2 次服。服 3 个月为 1 个疗程。

功效主治：温通，养血，祛瘀。临床治疗 30 例，痊愈 11 例，有效 9 例，无效 10 例，总有效率为 66.7%。

经验心得：本病的病因病机主要是肝肾亏虚，血运无力，淤滞肝脉，治宜温补肝肾，通血脉，祛瘀养血。温经汤原本为妇科调经方剂，根据足厥阴肝经循少腹络阴器理论，中医异病同治原则，将本方用于男性不育患者。方中吴茱萸入肝、胃、肾经，温经散寒止痛，桂枝温通血脉，血得温则行。两药合用起温经通脉之功。当归、芍药、川芎俱入肝经，能活血祛瘀、养血调经;牡丹皮入心肝、肾经，活血祛瘀;阿胶能养肝血、滋肾阴;麦冬、半夏、生姜、甘草合人参以补中气，且可制吴茱萸之燥性。诸药共奏温通养血祛瘀之功。（黑龙江中医药）

【温经汤治肌若鱼鳞】

男，60 多，早年开公司多年，压力甚巨，后出现以前臂外侧与小腿外侧为主，全身都有一种皮肤病，皮肤上起干硬皮，很厚，色黑而稍透明，就象鱼皮的颜色，上面的干皮有脱落，只是没有鱼鳞那么规整而已。某医院诊为“对称性神经性皮炎淀粉样变”。他老伴先在我这里治病，效果较好，因为老伴总说吃了中药有多好多好的感觉，他也想试一下，吃点中药调理一下。当时除了这个皮肤病症状外，还有明显的手足凉。没有其他的不适感。望之稍有唇干舌红，就开了温经汤原方三付。服后手足凉明显改善，感觉全身似乎有些舒服，但并没有明确变化，皮肤感觉似乎有点好转，但细看也看不出来，他自己也分不清是不是心理作用。但感觉有点好，问要不要继续吃药。考虑无明显的不适，不需长服汤剂，遂开温经汤原方打成的散剂，嘱服一个月再看。但四天后的门诊他又来了，强烈要求再吃汤药，因为吃散剂的这几天，他的皮肤明显地退了一层，小臂外最重的地方也已经可以看到下面的好皮了。候诊时颇为兴奋，自谓为治此皮肤病全国跑遍治疗多年无效，不意此方几副即如此之好。

补充：此人大约是两周前又来了一趟，上臂的皮肤已经基本正常了，现在只小腿上还有一点点。开他开了麦冬比例增大的原方散剂“温经散 2 号”继续服用。

【能美手的温经汤治手掌皲裂】黄煌：

最近有位熟人告诉我，她女儿烦人的手掌皲裂今年大好。原来她女儿每年手掌裂口、皮肤粗糙，皮肤科看过，外涂药膏，没有效果。但服用了我开的膏滋方过后，效果十分明显。

我记得那是三个月前，她带女儿来诊。闭经多年，服用雌激素替代。姑娘发育不良，个头也比较矮小。我当即告诉她，必须长期服用中药。

我开的是温经汤。温经汤可以治疗女性手掌皲裂，是日本大塚敬节先生和矢数道明先生的经验。他们用温经汤治疗不孕症、月经不调时，发现患者的手掌皮肤干燥开裂随着月经状况的好转，手掌也变得滋润。这个发现很有趣，原来月经不调与手掌皮肤相关。

后来我在治疗女性月经不调时，也注意其手掌皮肤。一般来说，手掌皮肤滋润、嫩白者，大多月经正常，而手掌皮肤干燥，尤其是指端皮肤粗糙干裂，甚至擦手时沙沙作响者，大多有月经不调或闭经。有些虽然没开裂，但甲沟多毛刺，指甲脆裂，也常常伴有月经异常。值得惊叹的是，张仲景在《金匮要略》中已经提及温经汤证有“手掌烦热”。所以，我常说温经汤是美容方，也是美手方。

温经汤可用汤剂，用水 2000 毫升，煮取 600 毫升分三次温服。也可以制成膏剂。煎药时加放上红枣 24 枚撕开、桂圆 15 个、煎好后过滤，放入阿胶和鹿角胶再加入冰糖 1 把或麦芽糖 3 勺，可以使药味可口，便于常服。如加芝麻研粉、核桃仁捣碎更香，熬成膏状备用。鹿角胶（30 克）是传统补肾填精的药物，对月经不调、不排卵等有调理作用，所以，我也常加入。我称之为温经膏。许多女性每天早晚各冲一汤匙，十分方便。服用以后，肤嫩唇红，女

人味更足。

【用温经汤治疗三年无月经】矢数道明：

患者22岁，女，未婚，初诊于1971年6月。病历：1970年12月以前每月有月经，但经血量小，从那以后至初诊为止停经。患者体格稍矮小，脸色像白腊一样，贫血状。回答问题无力气。阴虚证感觉。

自觉症状有下腹部胀，经常疼痛，手足冷，腰痛，发冷时小便次数增加。脉沉、弱、血压110/70，有便秘倾向，腹部脐周围有抵抗稍有压痛，稍有瘀血证。综合起来看身体衰弱，贫血，即气血两虚寒证，发冷时小便频数，为虚寒。属于妇科病的有子宫发育不全和卵巢机能障碍。与妇科检查诊断大致相同。

治疗:使用的汉方有针对血虚的四物汤;补气的四君子汤;针对肝脾血虚的有加味逍遥散，气血两虚用十全大补汤、对贫血、寒证、频尿用当归芍药散，针对脐旁的抵抗压痛和瘀血用桂苓丸料使瘀血循环改善，针对寒冷感强用当归四逆加吴茱萸、生姜汤以温暖身体，针对下腹部经常痛的疝气表现，长期无月经的气滞用半夏厚朴汤以顺气。

按上述考虑，每个方用2~3个月，这样经过一年、二年仍无月经，患者及其母亲坚定地用汉方药，我对这种精神所感动，感到有非治好患者病不可的责任感。我让她去熟人的医院检查血相，因为脸色不好，可能属于萎黄病。但意料之外，血液检查没有多大问题，贫血不严重，可能向来无月经而失血少的原因。除了服汉方药而外，也求助于专看妇科的汉方针灸并用的友人。经过半年针灸也无效果。可能激素缺乏，考虑用激素疗法，但患者及其母亲都不同意用激素。患者有她坚定的想法，用汉方药可以治愈。

我认真思考，回顾了以前治疗的失败，针对气血两虚，寒证的方终于决定尚未使用过的温经汤。

《金匮要略》对温经汤证的使用证有十条:①月经不调，②子宫等出血，③寒证，④下腹膨满感，⑤下腹部痉挛，⑥手掌烦热感，⑦口唇干燥，⑧50岁左右的更年期，⑨曾经流产，◎少腹有瘀血。

此患者①月经闭止，③寒证，④下腹部膨满感，⑤下腹部痉挛，四少腹有瘀血即10条中有6条，其他②、⑦、⑧、⑨没有。

我在《处方解说》中讲述温经汤证时，指出“用于气血虚，带寒冷的妇科诸病”，“属少阴病，阴虚证，以气血虚和寒冷为目标而用于月经不调、月经过多，月经到期不来的无月经”其处方构成:①当归、芍药、川芎治血虚、贫血，②阿胶、麦门冬润枯燥的血，③人参、甘草补气虚。④吴茱萸、生姜、桂枝温暖寒冷。⑤半夏治带下。⑥牡丹皮治下腹部瘀血。

1974年11月让服温经汤。服药后患者逐渐感觉身体温暖，食欲增加。服1个月药后来我院时脸色转好，脸颊出现红润，腹部有力，增加体重1.5公斤。患者从来没有肥胖过。服3个月。即到1975年2月来院时体重增加3公斤，寒冷倾向减少，身体舒服，有体力。但仍无月经。

服4个月即3月26日，患者的母亲打来电话，说4年来第1次有月经并持续8天，很高兴。继续服该方，即4月、5月、6月虽然来迟一周，但每月有月经，4年来尽管服汉方药没有那么理想，但患者从不间断，也不灰心。如果早点让服温经汤，那该有多好。只是气血虚和，虚寒不能决定处方，但温经汤证中的十条，符合6条，因此服用温经汤后症状好转，并来了月经，当然此患者是属于温经汤证的。《汉方的临床》

【温经汤治疗闭经】

刘某，女，20岁，学生。2006年5月初诊。患者16岁初潮，至今月经未按月来潮，或三月一行，或间隔更长。此次来诊月经已半年未至。在当地做B超显示左侧卵巢未发育。患者身高163cm，体重54kg。形体适中，一般状况良好。面色略淡白，唇红，偏干。睡眠尚佳，纳食可。行经无腹痛，量可色鲜红。脉弦细。予温经汤原方12剂，经行，嘱其继续服药。连

续三月，每月月经按时至。嘱其每月行经前服药十剂。如不能按时行经再诊。

2007 年 9 月随访，患者坚持服药一年，每月均按时行经，量色质正常，无腹痛。7 月在当地复查 B 超示：子宫卵巢发育良好。

【温经汤治牛皮癣医案】楞青社：

患者是笔者内人，女，43 岁。己亥年初，右脚跟长一拇指大褐色顽鲜，时而会掉皮，痒难忍，问我拿药吃。当时我没太在意，以为就一般湿疹。因其体胖血虚湿盛，长湿疹湿是常态，便开了小建中加当归芍药散等补虚祛湿之品。另嘱其用黄连磨粉涂抹患处。药后患处无好无坏，仍痒但还能忍受。因常两地分居，没有面诊，也没再用药。

庚子年年初，新冠疫情大爆发的那一天，她的湿疹也全身大爆发。先是肚皮后胸口然后脖子这样一路向上长，一天一个样有全身扩散之势，奇痒难忍，夜不能眠，烦躁不安。

刻诊：脉弦稍弱，两关软。舌淡红苔薄，两侧带淡瘀点。口干不渴，二便正常，居恒手心烦热。我投三剂柴胡姜桂加当归芍药散，无任何收效，继续扩散，情况危急，一时六神无主，于是求救于网上一位素未蒙面的高手。他说他用温经汤疗愈多例牛皮鲜患者，并建议我用温经汤一试。温经汤主证，手心烦热，嘴唇干，暮发潮热等。因只有手心烦热一证，我仍犹豫不决。当天傍晚，患者突发潮热，烦躁，此时我便确信温经汤证无疑。遂开温经汤加蛇床子一剂。煮药时患者闻其味即全身痒止，于是便搬来凳子一直坐在药锅边闻药味。六剂药后顽癣基本褪去但仍有痕迹。后再进药半个月，加日服桂附地黄丸一颗，顽癣得以痊愈，但局部患处仍留有色斑。嘱其坚持吃桂附地黄丸，半年后色斑全褪，皮肤完好，看不出任何痕迹。

患者一直是温经汤证，只怪我平常读书不精，临证无方才迁延至如此危急的状况。这是应该做深刻反思跟自我检讨的案例。此后对素未蒙面的老师一直心存感激。

【温经汤治子宫肌瘤，乳腺增生，甲状腺亢进癣医案】楞青社：

患者是挚友之妻，庚子年，41 岁。患者因常年工作压力大，常熬夜，所以体质比较虚弱，以前也常问我拿药吃。后来我们生活在不同城市，只能远距离指导她用药。

患者在庚子年中单位集体体检，被告知是乳腺癌的临界，病情危急，建议最好到大医院治疗。随后便来电咨询我的意见，我建议她去找当地最有名的中医师治疗。名医开了逍遥散加牡蛎等疏肝散结之品，用药一周后乳腺增生变大且痛，两腹股沟也长两肿块，心情焦急，便来电咨询我的意见。

刻下主诉：乳腺增生肿痛，两腹股沟新长两肿块且有疼痛感、口干渴、嘴唇干、手心热、暮发潮热、心烦、大便软、小便正常、睡眠差。其人瘦，眼微突，脸色白带淡黄夹青色。舌质淡红苔薄白。

听完上述症状后我以唇干，手心热，暮发潮热为主证，建议她试用温经汤一剂，若有效再续后服，若无效再另作打算。不料一剂疼痛减轻，三剂后腹股沟肿块消失。按此思路治疗半年（中间有用建中，真武，理中等），乳腺增生变小并脱离危险状态。

【温经汤不孕医案】《经方躬行录》

李某，25 岁，农民。婚后五年不孕，月经二三月一行，甚无规律。西医做人工周期三月，月经按时而至，停则姗姗不来，遂改求中医。初意在鹤发银鬓之老医，发乌须墨如余者，不屑一顾也。然服药数月未效，一日来诊，适值老医休息，不得已而求余，然不乐之色显于眉间。询知经前乳房胀痛，经来量多，杂有血块，延期十日左右。经期腹痛、腰痛，喜温喜按，经后头痛，今已毕 56 日。带多清稀，小腹发冷，夜间手足心热，胃纳可，口干思饮，大便正常。望其面白少红，人中深凹，唇干不荣，舌淡红，苔薄白。诊其脉，沉弦细，触其腹，小腹不温，松软无压痛。

脉证观之，此冲任虚寒，气滞血瘀证也。盖冲为血海，任主胞胎，冲任虚寒若寒冬地冻，种子焉能发芽生根？老医所开之方，乃号称种子安胎第一方——少腹逐瘀汤。是方虽有茴香、

干姜、官桂暖宫之品，然不补益气血，填充冲任，凝寒瘀血安能去之？拟：

当归 15g，川芎 10g，白芍 15g，党参 30g，桂枝 10g，吴茱萸 10g，甘草 6g，丹皮 10g，麦冬 15g，阿胶 15g，柴胡 12g，生姜 5 片，五剂。

二诊：服药四剂，月经汛潮，经前乳未痛，经来腹安和，今已行三日，量仍多，色鲜杂块，脉舌如前。守方七剂，忌食、触寒凉。

三诊：上次月经七日即净，头未痛，口干、掌热均减，精神大好，纳化有增。某面色泛红，脣涡可掬，今又毕 41 日，切其脉，滑数有珍。彼不之信，云："不恶心、不思酸，何言有孕"？令作尿检，果呈阳性。

附记：李妊娠后，村民闻讯，先后有数人经余调治亦身怀六甲。是年冬，该公社党委书记某，怒气冲冲而来，云彼未成为模范书记者，因余致人口净增率超标，计划生育拉分故也。余对曰："若汝多年不育，求医否？若汝为医生，拒诊否?"如此为名利而背情理，实可笑也。此 20 世纪 80 年代事也。

【温经汤闭经医案】《经方躬行录》

郭某，38 岁，人工流产后，月经 5 月未行，于 1997 年 7 月 13 曰来诊。患者面白无华，精神萎靡，唇干萎，舌质微暗，苔白薄。询知人流术中出血甚多，流产后过食生冷果品，从此少腹隐隐作痛，带下清冷，腰脊酸痛，至夜掌心烦热。胃纳不佳，口干不欲水，大便日一行。诊其脉沉细缓，触其腹，小腹不温，左少腹微有压痛。

闻雷声而知雨意，人流失血过多，必损伤冲任，血海亏空，水浅则浪不潮也；产后过食生冷，必血为寒凝，瘀滞胞脉，是以月经不汛。治当补益冲任，温经散寒。若海足扬波，经自至矣。拟：

当归 15g，川芎 10g，赤芍 15g，桂枝 10g，吴茱萸 10g，阿胶 10g，党参 30g，甘草 6g，丹皮 10g，半夏 10g，麦冬 10g，杜仲 15g，生姜 5 片，三剂

二诊：小腹转温，疼痛不再，带下减少，饮食略增，精神大好。守方五剂。

三诊：药未尽剂，月经已至，量不多，杂紫块，少腹、腰微痛，掌心热，脉仍沉细。此寒散瘀化，然血海未充，补血益冲，仍宜继续。原方十剂。

【温经汤痛经医案】《经方躬行录》

王某，20 岁，18 岁月经初潮。每届经期，小腹疼痛，近两年益甚，以致不能上课，唯卧床耳。经毕则饮食、起居如常。中西药迭进，痛未少离，于 2005 年 12 月 3 日来诊。

本豆蔻年华，却无玫瑰风姿，但见形体消瘦，面色微青，舌淡红，有瘀斑。询知经行后期，35～45 日一行，量多，紫暗杂块，小腹、四末发冷，腰痛。恶心欲吐，口干不思饮，二便正常。今已毕 29 日，入夜手心烦热，睡寐殊难。切得脉象沉细。腹诊腹肌挛急，无压痛。

月经迟汛者，先天不足也。从痛经、腹冷、脉细、血紫诸症观之，此血海亏虚，寒凝血滞证也。刻下月经将潮，宜未雨绸缪，拟温经汤温之通之。

当归 15g，川芎 10g，赤芍 15g，党参 15g，桂枝 10g，吴茱萸 10g，丹皮 10g，甘草 6g，半夏 10g，麦冬 15g，阿胶 15g，熟地 15g，生姜 5 片，五剂

二诊：剂尽经汛，腹痛大减，量亦少，小腹微冷，手足温，今已行 3 日，舌脉如前。守方五剂，嘱经净后早服肾气丸、晚服归脾丸各一粒，下届经期，温经汤继续服之。

三诊：此次月经 29 日即汛，腹不痛，亦不冷，行经 6 日，量不多。为绝痛经，嘱下届经期如法服之。

【温经汤治不孕】曹颖甫：

予按此为调经统治之方，凡久不受胎经来**先期后期，或经行腹痛，或见紫黑，或淡如黄浊之水**，施治无不愈者，曾记寓华废坊时，治浦东十余年不孕之妇，服此得子者六七家，江阴街四明范姓妇亦然，此其成效也。

【抵当汤治不孕】曹颖甫：

予昔在同仁辅元堂治周姓十七岁少女时经停五月矣，以善堂忌用猛药，每日令服大黄庶虫丸，不应送诊期后，病者至江阴街寓所求诊，月事不行，已抵七月，予用虻虫水蛭各一钱，大黄五钱，桃仁五十粒下之，下后以四物中参芪善后，凡二剂。十年后来于江阴街遇之，始知其嫁于小古门朱姓，已生有二子矣。

【温经汤合吴茱萸汤治高血压发作时头晕欲呕医案】：

宫某某，女，年龄46岁，已婚，主诉：头晕。食欲一般，例假提前七八日或四五日，睡眠差，易醒，易惊，大便一日一次，食冷则易腹泻，喜忘，小便夜尿三四次，无浮肿，无汗出，怕冷，头晕或不清爽，无口干，无喜呕，口苦胃不适时有，手足冷长期有。脉象：脉偏弦。舌质淡红略偏暗，苔薄白。体温，血压83\140mmHg心率每分钟74次，两腿无力，时有脸浮肿，曾有痛经史，因丈夫患病脑溢血后操劳而致高血压，现仍在服药，发作时头晕欲呕，高压曾到180mmHg。处方吴茱萸与温经汤70克，日二服，次2.5克左右。5.1日来诊，血压86\141，心率80，睡眠可，诸证已均不明显，现有贫血症状，脉细弱，下眼睑内侧色偏淡。吴茱萸与温经汤加石膏吴茱萸100克，日二服，次2.5克左右。5.30其夫来电话，咨询治疗其脑溢血后遗症的问题，言其服药后血压再没有发生偏高和头晕的情况。

【温经汤治怕冷口腔溃疡案】

Z/YP，女，43岁。形体中等略瘦。贫血貌而肌肉较松弛，B超检查发现左侧卵巢囊肿。白细胞略低于正常值，怕冷，手足皮肤干燥，自觉手如树干样感觉，每日需要搽油2-3次方感舒适。唇干，口腔溃疡不断，易掉头发。查小腿皮肤干燥。舌暗淡，苔薄。

黄师处以温经汤方：吴茱萸10克，党参10克，麦冬20克，炙甘草6克，姜半夏6克，肉桂6克（后下），当归10克，白芍10克，丹皮10克，赤芍10克，川芎6克，阿胶12克（另烊），干姜6克，红枣30克。药后一周患者因口腔溃疡未作而甚为高兴，同时患者自觉怕冷好转，大便亦甚为通畅。原方熬膏冬令服用。

【温经汤治经水淋漓不断医案】：

岳美中医案：周某某，女，51岁，河北省滦县人，1960年5月7日初诊。患者已停经三年，于半年前偶见漏下，未予治疗，一个月后，病情加重，经水淋漓不断，经色浅，夹有血块，时见少腹疼痛。经唐山市某某医院诊为“功能性子宫出血”，经注射止血针，服用止血药，虽止血数日，但少腹胀满时痛，且停药后复漏下不止。又服中药数十剂，亦罔效，身体日渐消瘦，遂来京诊治。诊见面色㿠白，五心烦热，午后潮热，口干咽燥，大便秘结。七年前曾小产一次，舌质淡红，苔薄白，脉细涩。证属冲任虚损，瘀血内停。治以温补冲任，养血祛瘀，投以温经汤方：吴茱萸9克，当归9克，川芎6克，白芍12克，党参9克，桂枝6克，阿胶9克(烊化)，丹皮6克，半夏6克，生姜6克，炙甘草6克，麦冬9克。

服药7剂，漏下及午后潮热减轻，继服上方，随证稍有加减。服药2 0．剂后，漏下忽见加重，挟有黑紫血块，血色深浅不一，腹满时轻时重。病家甚感忧虑。岳老诊其脉象转为沉缓，五心烦热、口干咽燥等症大为减轻，即告病家，脉症均有好转，下血忽见增多，乃为佳兆，系服药之后，体质增强，正气渐充而带血行之故。此瘀血不去，则新血不生，病亦难愈并嘱继服原方6剂，隔日1剂。药后连续下血块五日，之后下血渐少，血块已无。腹胀痛基本消失。又服原方5剂，隔日服。药后下血停止，唯尚有便秘，但亦较前好转，以麻仁润肠丸调理两周而愈。追访十年，未见复发。(北京中医杂志1985；(1>：7)刘渡舟医案：李某某，女，45岁，1993年5月5日初诊。10年前因做人工流产而患痛经。每值经汛，小腹剧痛，发凉，虽服止痛药片而不效。经期后延，量少色黯，挟有瘀块。本次月经昨日来潮，伴见口干唇燥，头晕，腰疼腿软，抬举无力。舌质暗，脉沉。证属、冲化虚寒，瘀血停滞。治宜温经散寒，祛瘀养血。疏温经汤方：吴茱萸8克，桂枝10克，生姜10克，当归12克，白芍12克，川芎12克，党参10克，炙甘草10克，丹皮10克，阿胶10克，半夏15克，麦冬

30 克。服 5 剂，小腹冷痛大减。原方续服 5 剂，至下次月经，未发小腹疼痛，从此月经按期而至，俱无不适。(《刘渡舟临证验案精选》1996：162)

【温经汤治小腹冷痛医案】李贯国：

医案：李姓，女，38 岁。产后 10 余天，进食大量瓜果生冷食物，次日即感小腹冷痛，此后病情加重，月经 3 年未行，曾服中药数十剂，未获效，西医诊为“继发性闭经”，注射黄体酮二周，效果亦不显。现症：面色白而浮肿，四肢不温，少腹冷痛，倦怠乏力，目眩，动则喘促，胸闷恶心，饮食欠佳，大便不实，白带量多，唇舌淡红，脉沉而紧。乃产后过食生冷，血为寒凝，滞于冲任，壅于胞脉，以致经闭不行，属虚寒闭经证。治以温经散寒，养血调经。用温经汤方：当归身 15 克，川芎 9 克，炒白芍 9 克，阿胶 12 克，党参 9 克，姜半夏 6 克，制香附 9 克，丹皮 9 克，桂心 3 克，炒吴茱萸 9 克，炮姜 6 克，甘草 3 克。

二诊：腹 4 剂，食欲增加，少腹冷痛，四肢不温已消，其它症状均有减轻。原方续服 4 剂，症状消失。(上海中医药杂志 1966；<5>：193)张庆云医案：李某某，农家妇女，26 岁。婚后三年未孕，妇幼保健院诊为幼稚子宫。病家十九岁月经初潮，一直后错，久者半年行经一次，量少，色淡红。身材矮小，精神尚好•，脉沉细尺弱，舌苔薄白。《内经》云：“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子”。该女十九岁月事方兴，且量少色淡，显属肾气不足，不能化生精血。血少，则胞宫失养，故胞宫小。精血虚，故月事迟迟不来。治以补先天，暖冲任，润养胞宫。随以温经汤加减治之。处方：当归 30 克，川芎 6 克，炒白芍 5 克，阿胶 15 克，肉桂 6 克，巴戟天 12 克，党参 30 克，丹皮 5 克，干姜 6 克，甘草 12 克，紫河车二克(冲服)。调治半年，生一女婴。(河南中医 1985；(6)：22)

【温经汤治月经先后不定期医案】秦德平：

李某，女，48 岁。月经先后不定期已 3 个月，头昏目眩，失眠多梦，午后低热，心烦口苦，烦躁易怒，耳鸣耳闭，唇舌干燥，手足心热，面部时感烘热，经量或多或少，舌质淡，还有紫斑，脉沉涩。冲任虚寒，瘀血内结，且夹有阴虚内热之象。温经养血，祛瘀滋阴，温经汤加味。吴茱萸 9 克，桂枝 9 克，当归 9 克，赤白芍 9 克，丹皮 9 克，麦冬 9 克，生地 9 克，川芎 4．5 克，月季花 4．5 克，甘草 4．5 克，阿胶 12 克，生鳖甲 20 克。连服 10 剂后自觉头昏略减，睡眠稍安，烦热及面部烘热间或发作，药已获效，继进 7 剂，痊愈。(江西中医药 1980；(4>：67)

【温经汤治阴吹医案】杨百茆：

周某，女，38 岁，1991 年 11 月 19 日初诊。诉 6 年前即有前阴出气如后阴矢气之症，常于劳累或受寒之时发生。初不在意，不以为病。未料愈发愈频，几乎每天发生，有时前阴接连出气作响数声，尤以卧起动作时为显，苦恼不堪。尝欲求医而难于启齿，陷忍不言。病情至今有增无减。询及他症，前阴寒冷，白带绝无，小腹如扇，隐痛喜按，胃脘冷痛，得温则减；手足心热，13 干欲热饮，小便清长，大便稀溏。4 年前曾做人工流产，继而月经失调，量少色淡。今年 1 月以来，经闭不行。诊见；形体瘦小，面色灰暗，精神萎靡，四肢不温，舌质淡红，苔薄白，脉沉细弱。病为阴吹，乃冲任虚寒，阴寒之气下出前阴所致。治以温经散寒，调补冲任之法。方用温经汤化裁：吴茱萸、炙甘草各 6 克，桂枝、川芎、桃仁、党参、法夏各 10 克，当归、鹿角霜、白芍、丹参各 15 克。水煎服，日 1 剂。

服药 7 剂，阴吹次数明显减少，继进 14 剂，阴吹告愈，且月经来潮，余症亦相继消除或减轻。原方随症调整，续服数剂以善其后。随访 1 年，阴吹未发。(国医论坛 1993；(1)：17)

【温经汤治痛经医案】颜德馨：

董某，女，30 岁。宿有痛经史，结婚三年，未有大小生育，痛经逐年加剧，经前乳房胀痛，经量较少，色暗紫而不畅，伴腹痛恶心，痛剧面色苍白，四肢逆冷，大便溏薄，眼眶发黑，苔薄腻，舌紫，脉沉迟。证属寒凝血瘀，用温经汤化裁：赤白芍各 9 克，生姜 3 片，川芎 6 克，阿胶 7 克(烊冲)，吴茱萸 9 克，当归 9 克，紫石英 30 克，桂枝 6 克，小茴香 3 克，

延胡索 9 克，党参 9 克，失笑散 9 克(包)，7 剂。药后诸证减轻。以前方调治四月，乃孕育一子，痛经宿患亦随消失。(国医论坛 1992；(3)：23)

【温经汤治不育精子活动率不足医案】张庆云：

张某某，27 岁。婚后年余不育，经某医院检查，精子 3 千万，活动率 30%。平日腰部酸困疼痛，阴囊常出冷汗，饮食、二便正常，脉沉缓苔薄白。此乃下元虚寒，冲任不足，精少不育。治以温暖下元，补益肝肾，以增生殖之精。处方：当归 12 克，川芎 6 克，白芍 15 克，吴茱萸 10 克，菟丝子 30 克，仙灵脾 30 克，巴戟天 12 克，党参 30 克，肉桂 9 克，阿胶 20 克，丹皮 3 克，干姜 8 克，半夏 12 克，麦冬 12 克，甘草 6 克，紫河车 2 克(冲服)。

紫河车乃血肉有情之品，益气养血，促进生殖之精的生长、分泌；菟丝子、仙灵脾、巴戟天壮肾兴阳，以增强精虫之活力。以上方为基础略事加减，调治二月。据称其爱人已怀孕。(河南中医 1989；(2>：21~22)

【温经汤治阳萎不举医案】李白宪：

张某，男，34 岁。1994 年 5 月 24 日初诊。患者阳萎不举，难以交合 5 年余，致使夫妻不和，曾用激素类药治疗收效不显，后改服中药调治，屡次更医更药，服药百余剂，不仅阳萎未愈。反增头痛眩晕，心烦失眠。证见面色不泽，神疲倦怠，伴头痛眩晕，手掌心烦热，时出冷汗，口唇干燥，午夜心烦失眠，小腹下坠且痛、阴部冷胀，舌淡苔白，脉沉细。证属阳气虚衰，营气不通、宗筋弛缓之候。治宜温阳散寒，调和气血，方用温经汤方：当归 15 克，川芎 10 克，白芍 12 克，党参 15 克，丹皮 10 克，牛膝 15 克，肉桂 10 克，吴茱萸 10 克，麦冬 12 克，炙甘草 10 克，仙灵脾 15 克，仙茅 12 克，生姜 5 片。水煎服，日 1 剂。

服药 10 剂后，精神渐佳，头痛头晕减轻，饮食增加，睡眠好、阳事时兴，余证也相继好转。原方继服 10 剂，病情又明显进步，可以过两性生活。又服 10 剂，房事正常，3 个月后，其妻身有孕。(河南中医 1996；(4>：215)

【温经汤治睾丸硬痛发胀医案】张庆云：

一壮年男子，睾丸硬痛发胀，但不红，阴囊发凉，少腹清冷，劳累则加重。平日自服止痛片，以除一时之苦。诊其脉沉弦，舌苔薄白。肾阳不足，寒凝肝脉所致。方以温经汤加减：当归 12 克，川芎 8 克，赤白芍各 18 克，党参 12 克，桂枝 12 克，丹皮 10 克，吴芋子 12 克，半夏 12 克，大小茴香各 12 克，桔核 12 克，荔枝核 12 克，干姜 10 克，甘草 9 克。调治一旬，病苦痊愈。(河南中医 1985；(6>：21)

【温经汤治双手不温指端反复出现苍白青紫麻木医案】高正今：

医案：张某，女，31 岁。1988 年¨月 9 日诊。双手不温，指端反复出现苍白、青紫、麻木三年，西医诊断为雷诺氏病。虽用麦角硷、烟酸等扩血管药物，效果仍不明显，每因天气转凉或接触冷水加重。刻诊：双手指均显苍白，小指和无名指前端青紫，舌质淡，舌伴有瘀点，脉沉细。证属气虚血瘀。治拟益气活血化瘀。方选温经汤加减：黄芪、党参各 30 克，当归、青芍、川芎、白术各 15 克，吴茱萸、桂枝、生姜、丹皮各 12 克。服 7 付后，双手指麻木、青紫均减退，但接触冷水后手指仍显苍白。上方去吴茱萸、生姜，加肉桂、牛膝各 12 克，继服 20 剂，未再复发。(四川中医 1990；(10>：22)

【温经汤治四肢麻木医案】高正今：

医案：袁某，男，19 岁。1989 年 2 月 8 日诊。因受凉后头痛，周身不适，怕冷半月，四肢麻木无力一周而入院。当时四肢呈驰缓性瘫痪，上下肢肌力均仅Ⅰ级，双腕和踝以下感觉障碍，西医神经内科经各种检查后诊为格林一巴利综合征(急性感染性多发性神经根炎)。应用地塞米松等，病情无好转。诊四肢无力，不温，舌质淡紫，苔薄白稍腻，脉沉而涩。证属寒湿入络，气虚血瘀。治宜温经散寒，益气活血。方用温经汤加减：黄芪、党参各 30 克，当归、川芎、白芍各 15 克。吴茱萸、桂枝、生姜、丹皮各 10 克，红花、甘草各 6 克。

服 12 剂后，四肢转温，麻木感消失，下肢肌力恢复至Ⅳ级，上肢恢复到Ⅲ级，可下床缓

步行走。原方去吴茱萸、生姜、加丹参30克，赤芍15克，继服20剂，继服20剂。痊愈。一年后随访，健康如常人。(四川中医1990；<10>：22)

【温经汤治心前区闷痛心肌梗塞医案】魏小萌：

医案：郭某，男，60岁，1984年12月8日初诊。患者述心前区闷痛，稍活动加重，遇寒尤甚。曾于1983年10月28日在北京某医院诊为“心肌梗塞”，住院34天，出院时心电图示：V。～V。呈宽大而深的Q波，ST段V。抬高。常服消心痛、肠溶阿斯匹林、瓜蒌薤白半夏汤和八珍汤等中西药物无明显改善。刻诊：症如前述，舌淡有瘀斑、苔白稍腻，脉沉缓。检查：血压170／90毫米汞柱，心率78次／分，律齐，心界向左稍扩大，心尖可闻及SMⅡ杂音，电图仍同出院时报告，空腹血糖80毫克，尿糖(阴性)。中医辨证为胸痹。证属气血两虚、寒凝络滞，治宜温补气血，祛瘀通络。方用温经汤去丹皮加丹参。处方：吴茱萸、党参、桂枝各15克，当归、白芍、川芎、阿胶、炮姜、麦冬、半夏各10克，丹参30克，炙甘草5克。六剂后，心前区闷痛明显改善，效不更方，继服六剂，心痛减轻，劳累后时有心悸，晨起咽干口燥，去炮姜易玄参10克，再服35剂，可参加轻微体力劳动，嘱其改为．口服复方丹参片，冬季仍加服温经汤，1987年8月28日心电图报告单为窦性心率，各波段均正常，无T波倒置和异常Q波。病人自觉良好。(新中医1990；(9)：45)

【温经汤治血吸虫性肝硬化少量腹水医案】陈新宝：

医案：方某某，男，64岁。1989年10月16日初诊。患者居住地为血吸虫流行区。1986年在上海华山医院乙状结肠镜活检报告：“回盲部增生性病变，有钙化血吸虫卵沉积”。确诊为血吸虫性肝硬化，少量腹水。诉反复腹胀6年，复发1年余，下肢浮肿3个月，伴头晕乏力，胃纳减退。查体：慢性贫血貌，面色黝黑，颈静脉充盈，腹壁静脉暴露，肝脾末触及，移动性浊音+。B超检查报告，血吸虫性肝硬化、腹水，门脉高压。肝功能报告：黄疸指数30弘，SGP'I、正常，总蛋白7．3，白蛋白3．3，球蛋白4．0；纸上电泳：A49．4％，a13．5％，az4．1％，p7．1％，Y35．9％。舌苔微黄腻、舌质淡嫩，脉沉弦细。证属气血亏虚，气滞血瘀，治拟温肝养血，化瘀行滞。

处方：吴茱萸、炙桂枝、生姜、炙甘草各5克，当归、白芍、川芎、党参、黄芪、阿胶、姜半夏、丹皮、麦冬各10克。连续服用3个月，在治疗期间根据患者情况适当配合护肝、补充白蛋白、液体支持疗法等。治疗后患者自觉症状及体征消退，肝功能检查正常，已上班工作至今。(浙江中医杂志1993；<6>：257)

【温经汤治口干多梦手掌心热月事不调入睡则尿床医案】萧铁珊：

翁某某，女，20岁，自1984年2月始患夜间遗尿病。曾求医于武汉，作血糖尿糖等检查，均属阴性。1985年3月8日求治于余。口干多梦，手掌心热，月事不调，入睡则尿床，面色淡白，少腹不适，精神疲倦，脉细弦，舌暗红苔黄，巩膜有瘀斑数点，药用温肾固摄之品不应。余思足厥阴经脉绕阴器，瘀血搏于膀胱，州都失司，血为阴，以阴从阴，故寐即遗尿。法宜温经散寒，养血祛瘀。仿温经汤处方：当归15克，川芎10克，白芍15克，西党参15克，粉甘草3克，桂枝6克，丹皮10克，生姜3克，阿胶15克，吴茱萸10克，法夏10克，麦冬10克，3剂。次诊：服上方八天来未见遗尿，巩膜瘀斑减少，精神尚佳，食饮渐增，仍以上方5剂，诸证悉除。(河南中医1988)

第二十三章 妇人病偏方

【大黄木香治月经痛经、经少不调秘方】（来源抖音：李振华口述）

他有个亲戚，他不是医生。但是很妇女人找他治病，因为他会治这病，很出名。他跟我

说，年纪大了，给你说说吧，其中就是木香跟大黄。大黄可以清中之邪，也可以活血化瘀，所以我治疗妇女病，在逍遥丸中加木香大黄，很有效。

【山楂治妇人诸病】张锡纯：

山楂：味至酸微甘，性平。皮赤肉红黄，故善入血分为化瘀血之要药。能除 癖癥瘕、女子月闭、产后瘀血作疼（俗名儿枕疼）。为其味酸而微甘，能补助胃中酸汁，故能消化饮食积聚，以治肉积尤效。其化瘀之力，更能蠲除肠中瘀滞，下痢脓血，且兼入气分以开气郁痰结，疗心腹疼痛。若以甘药佐之（甘草蔗糖之类，酸甘相合，有甲己化土之义），化瘀血而不伤新血，开郁气而不伤正气，其性尤和平也。

女子至期，月信不来，用山楂两许煎汤，冲化红蔗糖七八钱服之即通，此方屡试屡效。若月信数月不通者，多服几次亦通下。

痢疾初得者，用山楂一两，红白蔗糖各五钱，好毛尖茶叶钱半，将山楂煎汤，冲糖与茶叶在盖碗中，浸片时，饮之即愈。

附：《本草纲目》山楂后载有两方：一方治肠风下血，若用凉药、热药、补脾药俱不效者，独用干山楂为末，艾叶煎汤调下，应手即愈；一方治痘疹干黑危困者，用山楂为末，紫草煎酒调服一钱。按：此二方皆有效验，故附载之。

第二十四章 【不育灸法】（出自《备急千金要方》）

【原文】：妇人绝子，灸然谷五十壮。在内踝前直下一寸。

【原文】：妇人绝嗣不生，胞门闭塞，灸关元三十壮，报之。

【原文】：妇人妊子不成，若堕落，腹痛，漏见赤，灸胞门五十壮，在关元左边二寸是也。右边二寸。

【原文】：妇人绝嗣不生，灸气门穴，在关元旁三寸，各百壮。

【原文】：妇人子脏闭塞，不受精，疼，灸胞门五十壮。

【原文】：妇人绝嗣不生，漏赤白，灸泉门十壮，三报之，穴在横骨当阴上际。

【原文】：论曰：阴阳调和，二气相感，阳施阴化，是以有娠，而三阴所会则多生女。但妊娠二月名曰始膏，精气成于胞里。至于三月，名曰始胎，血脉不流，象形而变，未有定仪，见物而化，是时男女未分，故未满三月者，可服药方术转之，令生男也。

第二十五章　妇方常用药

第一节 【鸡内金解】张锡纯：

鸡内金：鸡之脾胃也，其中原含有稀盐酸，故其味酸而性微温，中有瓷、石、铜、铁皆能消化，其善化瘀积可知。《内经》谓“诸湿肿满，皆属于脾”，盖脾中多回血管，原为通彻玲珑之体，是以居于中焦以升降气化，若有瘀积，气化不能升降，是以易致胀满。用鸡内金为脏器疗法，若再与白术等分并用，为消化瘀积之要药，更为健补脾胃之妙品，脾胃健壮，益能运化药力以消积也。

且为鸡内金含有稀盐酸，不但能消脾胃之积，无论脏腑何处有积，鸡内金皆能消之，是

以男子 癖、女之癥瘕，久久服之皆能治愈。

又凡虚劳之证，其经络多瘀滞，加鸡内金于滋补药中，以化其经络之瘀滞而病始可愈。至以治室女月信一次未见者，尤为要药，盖以其能助归、芍以通经，又能助健补脾胃之药，多进饮食以生血也。

女子干血劳之证，最为难治之证也，是以愈者恒少。惟善用鸡内金者，则治之多能奏效。愚向为妇女治病，其廉于饮食者，恒白术与鸡内金并用。乃有两次遇有此药者，一月间月信来三次，恍悟此过用鸡内金之弊也。

盖鸡内金善化瘀血，即能催月信速于下行也。然月信通者服之，或至过通，而月信之不通者服之，即不难下通。况《内经》谓“中焦受气取汁，变化而赤，是为血。”血之来源，原在脾胃能多消饮食。鸡内金与白术并用，原能健脾胃以消饮食也。况脾为后天资生之本，居中央以灌溉四旁。此证之多发劳嗽者，脾虚肺亦虚也，多兼灼热者，脾虚而肾亦虚也。再加山药、地黄、枸杞诸药以补肺滋肾，有鸡内金以运化之，自能变其浓浓之汁浆为精液，以灌注于肺肾也。迨至服药日久，脏腑诸病皆愈，身体已渐撤消，而月信仍不至者，不妨再加蜚虫、水蛭诸药。如嫌诸药之猛悍，若桃仁、红花亦可以替代。然又须多用补正之药品以驾驭之，始能有益而无害也。

愚向曾本此意拟一方，名资生通脉汤，后列用其方治愈之案数则，可参观也。

【鸡内金治月信不通】张锡纯：

《内经》谓“女子二七天癸至”，所谓二七者，十四岁也。然必足年足月十四岁，是则室女月信之通，当在年十五矣。若是年至十五月信不通，即当预为之防。宜用整条生怀山药，轧细过罗，每用一两或八钱，煮作茶汤，调以蔗糖令适口，以之送服生鸡内金细末五分许，当点心用之。日两次，久则月信自然通下。此因山药善养血，鸡内金善通血也。若至因月信不通，饮食减少，渐觉灼热者，亦可治以此方，鸡内金末宜多用至一钱，服茶汤后再嚼服天冬二三钱。

至于病又加重，身体虚弱劳嗽，宜用拙拟资生通脉汤。此方之后，载有数案，且用此方各有加减，若服资生通脉汤，病虽见愈月信仍不至者，可参观所附案中加减诸方。

上所论诸方之外，愚有新拟之方，凡服资生通脉汤病见愈而月信不见者，可用生怀山药四两，煮浓汁，送眼生鸡内金细末三钱。所余山药之渣，仍可水煮数次，当茶饮之。久之月信必至，盖鸡内金生用，为通月信最要之药，而多用又恐稍损气分，故又多用山药至四两，以培气分也。

【鸡内金治胃脘有硬物杜塞】张锡纯：

沈阳龚生，年三十岁，胃脘有硬物杜塞，已数年矣。饮食减少，不能下行，来院求为延医，其脉象沉而微弦，右部尤甚，为疏方，用鸡内金一两，生酒曲五钱，服数剂硬物全消。

【鸡内金治腹有积聚】张锡纯：

奉天史生，年近四旬，为腹有积聚，久治不愈，来院求为延医。其积在左胁下大径三寸，按之甚硬，时或作疼，呃逆气短，饮食减少，脉象沉弦。此乃肝积肥气之类。俾用生鸡内金三两，柴胡一两，共为末，每服一钱半，日服三次，旬余全愈。

【鸡内金治贲门有物窒碍】张锡纯：

奉天秦生，年三十余，胃中满闷，不能饮食，自觉贲门有物窒碍，屡经医治，分毫无效。脉象沉牢，为疏方：鸡内金六钱，白术、赭石各五钱，乳香、没药、丹参各四钱，生桃仁二钱，连服八剂全愈。

【鸡内金治胃痛】张锡纯：

奉天宋氏女，年十九岁，自十七岁时，胃有瘀滞作疼，调治无效，浸至不能饮食。脉象沉而无力，右部尤甚，为疏方：鸡内金一两，生酒曲、党参各五钱，三棱、莪术、知母各三钱，樗鸡（俗名红娘子）十五个，服至八剂，大小二便皆下血，胃中豁然，其疼遂愈。

【鸡内金治胃脘旧有停积】张锡纯：

盐山李氏妇，年三旬，胃脘旧有停积数年不愈，渐大如拳甚硬，不能饮食。左脉弦细，右脉沉濡，为疏方：鸡内金八钱，生箭耆六钱，三棱、莪术、乳香、没药各三钱，当归、知母各四钱，连服二十余剂积全消。

【鸡内金治腹有积聚】张锡纯：

友人毛生治一孺子，自两三岁时腹即胀大，至五六岁益加剧，面目黄瘦，饮食减少，俗所谓大肚痞也。毛生见拙拟期颐饼方后载，若减去芡实，可治小儿疳积痞胀、大人癥瘕积聚，遂用其方（方系生鸡内金细末三两，白面半斤，白沙糖不拘多少，和作极薄小饼，烙至焦熟，俾作点心服之），月余全愈。

第二节 【穿山甲解】张锡纯：

穿山甲：味淡，性平。气腥而窜，其走窜之性无微不至，故能宣通脏腑、贯彻经络、透达关窍，凡血凝、血聚为病皆能开之。以治疔痈，放胆用之，立见功效。并能治瘕积聚、周身麻痹、二便闭塞、心腹疼痛。若但知其长于治疮，而忘其他长，犹浅之乎视山甲也。

疔痈初起未成脓者，愚恒用山甲、皂刺各四钱，花粉、知母各六钱，乳香、没药各三钱，全蜈蚣三条，服之立消。以治横 （鱼口便毒之类）亦极效验。其已有脓而红肿者，服之红肿即消，脓亦易出。至癥瘕积聚、疼痛麻痹、二便闭塞诸证，用药治不效者，皆可加山甲作向导。

【穿山甲治血箭证】

友人黄生谓，身上若有血箭证，或金伤出血不止者，敷以山甲末立止，屡次用之皆效，蛤粉炒透用，惟以之熬膏药用生者。

第三节 【乳香、没药解】张锡纯：

乳香：气香窜，味淡，故善透窍以理气。没药：气则淡薄，味则辛而微酸，故善化瘀以理血。其性皆微温，二药并用为宣通脏腑流通经络之要药。故凡心胃胁腹肢体关节诸疼痛皆能治之。又善治女子行经腹疼，产后瘀血作疼，月事不以时下。其通气活血之力，又善治风寒湿痹，周身麻木，四肢不遂及一切疮疡肿疼，或其疮硬不疼。外用为粉以敷疮疡，能解毒、消肿、生肌、止疼，虽为开通之品，不至耗伤气血，诚良药也。

乳香、没药不但流通经络之气血，诸凡脏腑中，有气血凝滞，二药皆能流通之。医者但知其善入经络，用之以消疮疡，或外敷疮疡，而不知用之以调脏腑之气血，斯岂知乳香、没药者哉。

乳香、没药，最宜生用，若炒用之则其流通之力顿减，至用于丸散中者，生轧作粗渣入锅内，隔纸烘至半熔，候冷轧之即成细末，此乳香、没药去油之法。

第四节 【三棱、莪术解】张锡纯：

三棱：气味俱淡，微有辛意。莪术：味微苦，气微香，亦微有辛意。性皆微温，为化瘀血之要药。以治男子痃癖，女子癥瘕，月闭不通，性非猛烈而建功甚速。其行气之力，又能治心腹疼痛，胁下胀疼，一切血凝气滞之证。若与参、术、 诸药并用，大能开胃进食，调血和血。若细核二药之区别，化血之力三棱优于莪术，理气之力莪术优于三棱。

药物恒有独具良能，不能从气味中窥测者，如三棱、莪术性近和平，而以治女子瘀血，虽坚如铁石亦能徐徐消除，而猛烈开破之品转不能建此奇功，此三棱、莪术独具之良能也。而耳食者流，恒以其能消坚开瘀，转疑为猛烈之品而不敢轻用，几何不埋没良药哉。

三棱、莪术，若治陡然腹胁疼痛，由于气血凝滞者，可但用三棱、莪术，不必以补药佐之；若治瘀血积久过坚硬者，原非数剂所能愈，必以补药佐之，方能久服无弊。或用黄芪六

钱，三棱、莪术各三钱，或减黄芪三钱，加野台参三钱，其补破之力皆可相敌，不但气血不受伤损，瘀血之化亦较速，盖人之气血壮旺，愈能驾驭药力以胜病也。

第五节 【水蛭解】张锡纯：

张锡纯曰：仲景抵当汤、大黄䗪虫丸、百劳丸，皆用水蛭，而后世畏其性猛，鲜有用者，是未知水蛭之性也。《神农本草经》曰：水蛭气味咸平无毒，主逐恶血、瘀血、月闭，破癥瘕、积聚、无子、利水道。徐灵胎注云：凡人身瘀血方阻，尚有生气者易治，阻之久则生气全消而难治。盖血既离经，与正气全不相属，投之轻药，则拒而不纳，药过峻，又转能伤未败之血，故治之极难。水蛭最善食人之血，而性又迟缓善入。迟缓则生血不伤，善入则坚积易破，借其力以消既久之滞，自有利而无害也。观《神农本草经》之文与徐氏之注，则水蛭功用之妙，为何如哉！特是徐氏所谓迟缓善入者，人多不解其理。盖水蛭行于水中，原甚迟缓。其在生血之中，犹水中也，故生血不伤也。着人肌肉，即紧贴善入。其遇坚积之处，犹肌肉也，故坚积易消也。

第二十六章 内经四乌鲗骨一藘茹丸方证

【原文】：帝曰：有病胸胁支满者，妨于食，病至则先闻腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，时时前后血，病名为何？何以得之？

张志聪曰：上节论腹中气虚，其病在脾，此论腹中血脱，所伤在肝也。夫血乃中焦水谷之汁，专精者行于经隧，为经脉之血，其流溢于中者，注于肾脏而为精，复奉心化赤而为血，从胞中而注于冲脉，循腹上行，至胸中而散，充肤热肉，淡渗于皮肤，而生毫毛，卧则归藏于肝，寤则随卫气而复行于皮肤之气分，男子络唇口而生髭须，女子以时下为月事，此流溢于中，布散于外之血也。是以此血虚脱，则肝气大伤，有病胸胁支满者，肝虚而胀满也。食气入胃，散精于肝，肝气伤，故妨于食也。肝臭臊，肺臭腥，不能淡渗皮毛则肺虚，无所归藏于肝则肝虚，肝肺两虚，是以病至则先闻腥臊臭也。肺气虚，出清液，肝脏虚，先唾血也。不能充肤热肉则四肢冷，肝开窍于目，故目眩也。肝主疏泄，时时前后血者，肝无所藏而虚泄矣。

【原文】：岐伯曰：病名曰血枯，此得之年少时，有所大脱血，若醉入房中，气竭肝伤，故月事衰少不来也。

张志聪曰：有所大脱血则伤肝，肝伤，在女子则月事衰少不来矣，醉以入房，在男子则伤精，精伤则无从而化赤矣，气生于精血，精血虚脱则气竭矣，杨元如曰：伤寒论热入血室，刺肝经之期门，本经曰肝伤，故月事衰少，是女子之月事，发原于胞中，上行于冲任，布散于皮毛，归藏于肝脏，而后下为月事者也。

【原文】：帝曰：治之奈何？复以何术？

张志聪曰：问治以何药？复以何法救之？）

【原文】：岐伯曰：以四乌鲗骨一藘茹，二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸为后饭，饮以鲍鱼汁利肠中及伤肝也。

张志聪曰：贼同鲗，藘当作茹，乌鲗骨、乌贼鱼之骨也。鲗鱼状若胞囊，腹中有墨，脊上只生一骨，轻脆如通草，盖乌者肾之色，骨乃肾所生，主补益肾藏之精血者也。藘茹一名茜草，又名地血，汁可染绛，其色紫赤，延蔓空通，乃生血通经之草也。夫鱼乃水中动物，属阴中之阳，血中之气，故用乌鲗骨四者，以布散于四肢也。血乃中焦所生，用茹 一者，主生聚于中焦也。夫飞者主气，潜者主血，卵白主气，卵黄主血，雀乃羽虫，丸以雀卵者，因气竭肝虚，补血而补气也。豆乃肾之谷，五者土之数，气血皆中焦所生，故宜饭后而服五豆许也。鲍鱼味咸气臭，主利下行，故饮鲍鱼汁以利肠中，而后补及于肝之伤也。又按，《甲乙经》藘茹作 茹。

四乌鲗骨一藘茹丸方：乌鲗骨、茜草、雀卵、鲍鱼汁

【方义解析】 四乌鲗骨一芦茹丸中的乌鲗骨即乌贼骨，又名海螵蛸，咸温下行，入肝肾二经，主女子赤白漏下及血枯经闭；芦茹，即今之茜草，酸咸入肝走血，既能行血活血，又能止血治崩。麻雀卵，气味甘温，能补肾阳、益精血、调冲任。鲍鱼汁亦为血肉有情之品，除补益之外，能入肝散血，可引药入于胞中。诸药相合，通中有补，补中有通，通补兼施。

【功效主治】 功效：行血通经，益精养血。

主治：胸胁支满，纳食不振，闻腥臊味，鼻出清液，或病闭经，带下，可伴唾血，四肢清冷，头目眩晕，前后二阴出血，舌质淡或淡黯，苔薄白，脉涩或沉。

【临证加减应用】 1. 本方用药上，鉴于鲍鱼罕见、雀卵难取，有学者代之以龟甲、鳖甲、苁蓉、鹿茸等益阴温阳之品，可供临床参考。2. 本方的剂量配比，不必受《素问》乌贼骨、茜草根四一之比所囿，而当根据本虚标实之，灵活运用。据姚颂岳老中医经验：虚实相当者，乌贼骨、茜草根（生用）各为 9 克；虚多实少者，前者为 12～ 15 克，后者（生用）6～ 9 克不等；若崩漏及老年经断复来，症见出血量多，无瘀块者，茜草根则微炒或制炭入药，以增强止血之能；实多虚少者，前者 9 克，后者（生用）9～ 12 克，或不伍乌贼骨而径用茜草根者亦为常例[8]。3. 近代名医张锡纯善用四乌贼骨一芦茹丸，在本方基础上化裁，用于崩漏、带下诸疾。如：①安冲汤：海螵蛸四钱（捣细），茜草三钱，白术六钱（炒），生黄芪六钱，生龙骨六钱（捣细），生牡蛎六钱（捣细），大生地六钱，生杭芍三钱，川续断四钱。功效：补气升提，固涩安冲。主治：妇女经水行时多而且久，过期不止或不时漏下。②固冲汤：海螵蛸四钱（捣细），茜草三钱，白术一两（炒），生黄芪六钱，煅龙骨八钱（捣细），煅牡蛎八钱（捣细），萸肉八钱（去净核），生杭芍四钱，棕边炭二钱，五倍子五分（轧细，药汁送服）。功效：益气健脾，固冲摄血。主治：气虚冲脉不固之血崩证。③清带汤：海螵蛸四钱（去净甲，捣），茜草三钱，生山药一两，生龙骨六钱（捣细），生牡蛎六钱（捣细）。单赤带，加白芍、苦参各二钱；单白带，加鹿角霜、白术各钱。功效：健脾固涩止带。主治：妇女赤白带下。

四乌贼骨一芦茹丸为益精行血的代表方剂，又被后世誉为通补奇经第一方，功能补肝肾、益精血、通经脉、下瘀血、理冲任，临床应用较为广泛，尤擅治妇科疾病，凡因血枯精亏所致的崩漏、闭经、癥瘕、不孕、带下、阴肿、恶露不绝及妇人杂病等，均可用之。盖冲为血海、任主胞胎，冲任二脉功能正常，则经水如期、月事正常。如肝肾损伤，影响冲任充盈，可致经、带、胎、产等诸疾。古往今来，临床应用此方之医家颇多，尤其是近代名医张锡纯在本方“补通并用”这一制方原则的影响下，创制了不少新方。比如理冲汤、理冲丸以治癥瘕，虽该方未用乌贼骨、茜草二药，但他在《医学衷中参西录·治女科方》中指出：“《内经》有四乌贼骨一芦茹丸，原是男女并治，为调补气血之良方，此方（指理冲汤、丸）窃师《内经》之意。”其他新方，如安冲汤、固冲汤、清带汤均选此二味。他说：“乌贼骨即海螵蛸，茹即茜草，是二药为开通之品，而实具收涩之力也。”方中“四药汇集成方，其能开通者，兼以收涩；能收涩者，兼能开通。相助为理，相得益彰”，道出了此方通补之奥秘。可以说，张这些新方拓宽了此方的适用范围，对临证施治、处方用药提供了灵活、便捷的方法和思路。

【临床报道】 1、崩漏：用四乌贼骨一芦茹丸加味方（乌贼骨、茜草、阿胶、仙鹤草、山药、山茱萸、生蒲黄）治疗崩漏患者均获良效。2、药物流产后子宫出血：四乌贼骨一芦茹丸对缩短药物流产后子宫出血时间及减少子宫出血量的作用 3、月经不调。4、妇科肿瘤应用。5、产后恶露不绝。6、带下。7、经期延长。8、闭经。9、倒经。10、肠风下血。

【四乌鲗骨一藘茹丸治血崩医案】

血崩 一妇人，久患血崩，肢体消瘦，饮食到口则闻腥臊，口出清液，每食少许，腹中作胀，此血枯之症，肝肺脾胃亏虚之患，用八珍汤、乌贼骨丸，兼服用两月而经行，百余剂而安。（《校注妇人良方》）

【四乌鲗骨一藘茹丸治漏下医案】

朱，崩漏两年，先有带下，始而半月发病，今夏季每交申酉，其漏必至。思下午为阳中之阴，阴虚阳动，冲脉任脉皆动，下无堤防约束。夫奇经肝肾主司为多，而冲脉隶于阳明，阳明久虚，脉不固摄，有开无阖矣。医但以涩剂图旦夕苟安，未及按经论病，宜毫无一效。海螵蛸、鲍鱼、茜草、生菟丝子、石壳、广莲肉。接服乌贼鱼骨丸。（《临证指南医案》）

【四乌鲗骨一藘茹丸治月经过多医案】名老中医李祥云：

治张某，女，成人，已婚，工人。经水过多已数年，每次行经10余日方止，此次行经已5天，量多如冲，色红夹小血块，头昏目花、神疲乏力，苔薄，脉细，急者治其标，缓者治其本，治拟健脾益气，固摄止血。乌贼骨、龙骨、大蓟、小蓟各五钱，茜草二钱，党参、黄芪、白术、白芍、炒陈棕、炒香附各三钱，牡蛎（先煎）一两。服药3剂经水净，因经水过多而致血虚，故出现头昏目花、腰酸等症状，以后用健脾益气补血之品调理之。

【四乌鲗骨一藘茹丸治产后恶露不绝医案】

刘某，女，成人，已婚，工人。产后2月余恶露一直不净，淋漓不绝，色黯红，无血块，腹痛不明显，腰尻不酸，乳汁不多，苔薄，脉细，患者曾服活血祛瘀之生化汤及益母草膏，还服过益气补血之剂均无效，行妇科检查，宫体正常，无压痛，治拟益气补血，固涩止血。乌贼骨、炒白术、大蓟、小蓟各五钱，党参、生地各四钱，茜草、黄芪、石榴皮各三钱，牡蛎（先煎）一两。服药3剂恶露即止。

【四乌鲗骨一藘茹丸治带下医案】

张某，女，成人，已婚，工人。带下素来较多，色白如涕，神疲乏力，头昏，有时腰酸，每当疲劳后带下剧增，苔薄，脉细，治拟健脾除湿，固涩止带。乌贼骨、炒白术、桑寄生各五钱，茜草二钱，党参、龙骨各四钱，怀山药、牡蛎（先煎）各一两，车前子三钱。服上药5剂后带下大减，为巩固疗效再续服5剂，带下止。

【四乌鲗骨一藘茹丸治经期延长医案】

于某，女，20岁，未婚，学生。2005年11月8日初诊。月经淋漓10天未净。13岁月经初潮，28～ 30天一行，近一年来行经时间明显延长，月经淋漓10～ 12日方净，月经周期基本正常。经量略少，色紫黯有血块。此次10月30日行经，至今未净，伴小腹隐痛，腰酸痛，胃纳尚馨，二便正常。舌紫黯，脉弦涩。B超示子宫及双侧附件未探及异常。诊断：经期延长。证属肾虚血瘀，治以补肾活血，固冲调经。方用四乌贼骨一芦茹丸加味，药用：海螵蛸30克，茜草15克，蒲黄炭12克。经前1周开始，服至经期第5日，日1剂，水煎服，续服3个月经周期后，经行7日止，诸症消失。随访1年未复发。

【四乌鲗骨一藘茹丸治闭经医案】

名老中医朱南孙治某女，27岁。2009年6月16日初诊。12岁初潮，2000年高考后经不自行，诊断为卵巢早衰，一直中西药断续治疗。B超检查：左卵巢大小正常，右卵巢未显示。月经现能自然来潮，但周期不准，6月15日超前半月转，量少，脉细弦，舌黯，苔薄腻，有瘀紫，略有齿印，肾气不足，冲任失调，治拟补肾益气调冲。乌贼骨、茜草、熟地、丹皮各15克，当归、黄芪、党参、丹参各20克，菟丝子、覆盆子、金樱子各12克。12剂。半月后复诊，经讯未超前，再宗前意，月经于7月19日转，量较前增[5]。

【四乌鲗骨一藘茹丸治不孕医案】岳美中：

曾在印尼治一妇人，结婚20年，久不怀孕。西医诊断为“左侧输卵管狭窄阻塞”，前来求治，思索良久，径投四乌贼骨一茹丸方，服2个月后，经X线片检查，提示“左侧输卵管闭塞已通”。

【四乌鲗骨一藘茹丸治宫颈癌医案】王三虎：

对于宫颈癌常常遇到难于确定证型的时候，就以《内经》十三方之一的四乌贼骨一芦茹丸（乌贼骨、茜草）为主方，取乌贼骨软坚散结，通中有涩，茜草活血止血，涩中有通之意。事实证明这个古方可以作为宫颈癌辨病用药的方剂。临证加减如：以疼痛为主要症状者，加用延胡索、九节茶、徐长卿、夏天无、露蜂房；肿块较大，体质尚可者，加三棱、莪术、穿山甲、猫爪草；带下量大者，加茯苓、猪苓、黄芪、益母草；血性白带者，重用仙鹤草，酌加血余炭、藕节炭、荆芥炭、地榆；小便涩疼者，加地龙、栀子、蒲公英、琥珀；大便秘结者，加何首乌、肉苁蓉、大黄、芒硝。

第二十七章 温经汤方证

【原文】：问曰：妇人年五十，所病下血[1]，数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下，何以知之？曾经半产，瘀血在少腹不去，故唇口干燥也，温经汤主之。（金匮）

涪古本对照：问曰：妇人年五十所，病下血，数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此属病带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其症唇口干燥，故知之。当以温经汤主之。

病因和病机：上热下寒，寒瘀，少腹寒

辩证要点：月经漏下数日不止、暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥。或月经不来，少腹寒。

[1]“下血”《金匮》为“下利”。

罗按：女人年 50 岁，其实就是七七四十九岁就闭经了。她下血，所以说“下血”，就是说，这不是月经，是下血，连绵数十天不断。外证：“少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥”，这是为什么呢？老师说：这是带脉为病的下血，故曰带下，为什么呢？“唇口干燥”，所以知道是瘀血在少腹不去，这是因为她生产过，半产，一说是小产。为什么唇口对应少腹？这是一个经络的问题，郝老说的上下对应的问题。

“带下”，和平常意义上的白带黄带没有什么关系，它是说是带脉为病的下血。

尤在泾曰：妇人年五十所，天癸已断而病下利，似非因经所致矣。不知少腹旧有积血，欲行而未得遽行，欲止而不能竟止，于是下利窘急，至数十日不止，暮即发热者，血结在阴，阳气至暮，不得入于阴，而反浮于外也。少腹里急腹满者，血积不行，亦阴寒在下也。手掌烦热，病在阴，掌亦阴也。唇口干燥，血内瘀者，不外荣也。此为瘀血作利，不必治利，但去其瘀而利自止，吴茱萸、桂枝、丹皮，入血散寒而行其瘀，芎、归、芍药、麦冬、阿胶，以生新血，人参、甘草、姜、夏，以正脾气，盖瘀久者营必衰，下多者脾必伤也。

程云来曰：妇人年逾七七则任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通。今病下血数十日不止，下多则亡阴，阴虚则暮发热也。任冲之脉皆起于少腹，任冲虚则少腹急，有淤血则少腹满也。阴虚不能济火，故手掌烦热。血虚不足以荣肝门，故唇口干燥也。妇人五十而有此病，则属带下。以其人曾经半产，而有淤血于少腹不去。故《内经》曰：“任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚”。既已经半产则任冲伤，年逾七七则任冲竭，任冲之脉不能以荣唇口，则唇口干燥，知有淤血也。故以温经汤治之。

陈修园曰：此承上节历年血寒积结胞门之重证，而出其方治也。

《金鉴按》一说为“病下血”，崩漏也，数十日不止，亡阴血，故阴虚生内热也。瘀血不去新血不生，津液失于上润，证属冲任虚寒，用温经汤，温养血脉。

妇人年已五十，冲任皆虚，天癸当竭，地道不通矣。今下血数十日不止，宿瘀下也。五心烦热，阴血虚也；唇口干燥，任冲血伤，不上荣也；少腹急满，胞中有寒，瘀不行也。此

皆曾经半产崩中，新血难生，瘀血未尽，风寒客于胞中，为带下，为崩中，为经水愆期，为胞寒不孕。均用温经汤主之者，以此方生新去瘀，暖子宫补冲任也。

李杲曰：妇人年五十，则已过七七之期，“任脉虚，太冲脉衰，天癸竭，地道不通”时也。所病下利，据本文带下观之，当是崩淋下血之病。盖血属阴，阴虚故发热，暮亦属阴也。任主胞胎，冲为血海，二脉皆起于胞宫，而出于会阴，正当少腹部分，冲脉侠脐上行，故冲任脉虚，则少腹里急，有干血亦令腹满。《内经》云：任脉为病，女子带下瘕聚是也。手背为阳，掌心为阴，乃手三阴过脉之处，阴虚，故掌中烦热也。阳明脉，侠口环唇，与冲脉会于气街，皆属于带脉。《难经》云：血主濡之。以冲脉血阻不行，则阳明津液衰少，不能濡润，故唇口干燥。断以病属带下，以曾经半产，少腹瘀血不去，则津液不布，新血不生，此则唇口干燥之所由生也。

高学山曰：一难，答则丢开问中下利，劈空断为带下，又忽略问中诸症，独取唇口干燥一语，为确诊，而皆不言其所以然之故，如半产血瘀，何以便带下，带下又何以便下利之类，又唇口干燥，亦下利伤阴之兼症，何以便断为带下者。二难，至于断病，则曰少腹瘀血，病属带下，是在下焦矣。而诊病何以却在上焦之唇口干燥，汤名则曰温经，谓温经以去瘀血则可，谓温经而并除带下，是何理也。又本以唇口干燥为的据，投以本汤中之吴茱萸姜桂，而不虞其更干更燥，又何义耶，且问症如彼，主治如此，仲景当日，将置下利不止等候于不问乎，抑治此而愈彼之道，将何奥旨乎，此三难也。

以妇人年五十所一句，谓天癸已竭，地道不通之时，撇开经血胎产，毫不着想，单重下利一病，而问其是寒是热耳，故曰下利一症，寒热异因，各有确症，今数十日不止，大似中焦气寒，而失分理之司，下焦气虚，而无关锁之候，然久利以发热为欲止，因阳气有起伏之机故也。乃暮即发热而利不止，则又非虚寒可断矣。且少腹里急而下坠，腹中胀满而痞塞，又似内有阴寒之据，然手掌烦热，唇口干燥，又却似内有阳热之符，此种下利，其或寒或热，将何推断耶，带下，以妊娠门二条按之。当就漏血之赤带而言，非指白带也。瘀血不去，即致带下，虽详妊娠漏血注，然与妊娠、之漏血有分别者，以妊娠之血，为不得入胞胎而下从血室，此处之带下，又肝血之络，为瘀血所阻，而不得入血室，故自下也。

答意虽就诸症，层层细推，却又专从妇人着眼，专从妇人之年五十所着眼，而断出者也。盖利至数十日，里急腹满，俱似寒因，暮即发热，手掌烦热，俱似阴虚之热因，寒热既不应互见，且唇属脾，口属肺，唇口干燥，热利为合，又与数十日不止，及里急腹满者，尤不应兼见，故知其平日素有赤带之病，以致脾肺不滋，故唇口干燥，血液内竭，故手掌烦热，暮即发热，血虚者，气自寒，故利数十日不止，及里急腹满也。以其在妇人，故知其瘀血在少腹不去，以其年五十所，故知其非目前之瘀，而为曾经半产所得之旧病也。然则不当从利为治，但行其瘀，而使血液归经，则带下可除，止其带而使血液内润，则暮热掌热，及唇口干燥者亦解，究之血裕气温，将并数十日不止之利，及里急腹满者，可不治而自愈矣。名之曰温经汤者，血气得寒则凝，得温则畅也。以辛温之姜桂为主，而以善降之半夏，善敛之芍药佐之。则温下而适所以去下焦之瘀也。因瘀而肝血阻于血室之络，以致血不得由血室而外达上供，故下陷而带下，渐成烦热干燥之候，故以芎麦之上滋者，补上焦之血，胶归之下滋者，补下焦之血，而以善行阴阳之丹皮，分走而各注之。

所以治暮热掌热，唇口干燥等候也。又血虚气寒而至于下利，究当责之阳明之腑，故用苦温之茱萸，甘温之人参，而托以守中之甘草，则胃腑之阴阳起复，譬之大地春融冰消雪化，田畴气暖，冰脱湿干之象，将瘀去而利亦自止矣。妇人少腹寒而不受胎，虽无血瘀，而此汤能温中以温下，故亦主之。崩中去血，是非期而暴下，月水过多，指至期而大下，皆中寒失提，下寒失守之候，故兼取诸此也。至期不来，又中虚而精悍不生，下虚而气血自短所致，故亦取之耳，妇人之月水，名之曰经血者，以其由十二经脉盈满之气，从月光之亏损，而泻下之义也。但其源委，则有两路，从胃腑发精之根，历脾肺肝肾，以及于心，凡经过之脏腑，

各私取以自润其经脉者，一也。又肝为血脏，脏中之余血，由肝络而内从血室，以外达经络，与各脏腑所荣经脉之血会成一片者，又一也。此如潮起之象，其少火生气，潜滋暗长，至三十日，则经脉外满，而不受两血之注，遂使外气平而内气不长，且外盛者具反注之势，故气伏潮落，而十二经脉之血，阖归血室，而下为月水矣。此系血瘀少腹之肝络，肝脏内血，欲由血室而外达以养经，因络阻而不得通过血室，故无期而带下。故曰：与妊娠漏血有别，又曰：使血液归经者此也。

胡希恕曰：“下利”，《金鉴》改得对，应该是“下血”，如果是下利那不是带下了。妇人在五十岁，地道就应该不通了，就是经应该断，反而病下血数十日不止，这个临床上在更年期有这种情形，尤其她这个是真有病。“暮即发热”，瘀血证都是夜间重，那个热入血室，“昼日明了，夜则谵语”啊。“暮即发热”，她这个一到夜间就发热，肯定这个热是个瘀热，瘀血之热。

“少腹里急”，腹满，这个瘀血证啊，陷于少腹这个部位的多，所以少腹急结，咱们讲桃仁承气汤啊、抵当汤啊，全都是少腹满、少腹里急，这都是瘀血证，在腑证里头有这情形，尤其在少腹。手掌烦热，唇口干燥，这是血虚，血虚生内热就是指的这个，血虚津液它也虚，所以五心烦热嘛，唇口干燥，这是瘀血证的一个反应。

“此病属带下”，带下是下血不止。她这个准是以前曾经半产，瘀血在少腹不去，这么一个原因造成的，那么怎么知道呢？你看那个症候就知道了，其证唇口干燥，故知之，唇口干燥，一方面是津虚血少，一方面也是瘀血证的反应，由于这个所以知道是瘀血不去，当以温经汤主之。

对于妇人调理月经，一般说用大攻下的都很少，温经汤，有吴茱萸汤（吴茱萸、人参、生姜、大枣），他去大枣，搁桂枝，也就是温中降逆。这个生姜是降逆的；桂枝治气上冲，也降逆。他既用吴茱萸汤，温中降逆；同时他又用麦门冬汤，麦门冬汤（人参、半夏、甘草、生姜、麦门冬），这不是麦门冬汤嘛，它是滋补润燥而健胃补虚的。麦门是一个甘寒补胃阴，现在的人都爱用石斛这类的药，其实麦门冬这个药挺好挺好的，所以咱们在炙甘草汤中也用它，竹叶石膏汤啊、麦门冬汤都用它，都是有津液枯燥。

津液从胃来的，你得健胃，所以用吴茱萸汤合用麦门冬汤温胃补虚，从胃上下手，这个道理在哪儿呀？胃是生化之本，气血之源啊，这个胃不恢复不能生津，那么这个光祛瘀不行啊，本来这个下血数十日不止了，所以他这个虚啊就用强壮药（当归、川芎、芍药、阿胶、牡丹皮），仅仅用这么几个中药，这几种药是强壮祛瘀，而且有止血的作用，它有阿胶嘛，但是也的确祛瘀，生新祛瘀，无一不备，瘀血不去，新血不生，你光祛瘀不生血，她这个人就虚的不得了啊，所以我们调理这个妇人月经常用温经汤。

温经，胃喜温不喜寒，所以以温经为主。这个久久的瘀血，你不能够大祛，微温能使之行，寒之这血反到凝了，所以我们调理月经的方剂，这个温经汤加减合适是最好使的。在临床上，也有的时候现柴胡证，比方胸胁满哪、恶心啊、不愿吃东西呀，这个小柴胡汤证，我们就不要用这个大祛瘀药，就配合当归芍药散，非常好使。

像这个补中益气汤啊都有用的机会，所以后世用这个四物汤，究竟这个生地还是有碍处的，生地止血比较寒呀，它对胃有影响，所以一般不用它还是对的，后世用这个四物加四君就是八珍汤了，根据这个变化来用药也可以的，但是这个生地不能用呀，更不能用熟地了，用来用去胃弄坏了，倒不能吃东西了，光一个四君子汤啊，那力量很薄。

吴茱萸汤合麦门冬汤，既温中又养液，补阴，所以这个方子叫小温经汤，在调理妇人经脉的时候常有用的机会，但是胃必然现这个症候，这个症候主要是这个人不愿意吃东西，又恶心，他用这个吴茱萸汤去大枣、加桂枝。那么在这个情形之下，这个芍药用的量不大，如果呢肚子痛得厉害，你配合当归芍药散，比这个应该还强。有的时候现柴胡证，我们就配合当归芍药散，与这个方子都差不多。如果有头痛呕吐，或者头晕，加吴茱萸也是可以的，与

这个方也差不多了，一般在调理月经在妇科用这个机会最多。从这个方子治疗他底下写得很清楚，亦主妇人少腹寒，久不受胎，兼取崩中去血，崩中它能治，有瘀血它也能去，或月水来过多，及至期不来，这就是调理的办法。

温经汤方：古本）

吴茱萸三两，当归二两，芎䓖二两，芍药二两，人参二两，桂枝二两，阿胶二两，牡丹皮二两，甘草二两，生姜二两

上十味，以水一斗，煮取三升，去滓，日三服，每服一升，温饮之。

温经汤方：金匮）

吴茱萸三两，当归、芎䓖、芍药、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草各二两，半夏半升，麦冬一升（去心）

上十二味，以水一斗，煮取三升，分温三服，温饮之。**亦主妇人少腹寒，久不受胎，兼治崩中去血，或月水来过多，及至期不来。**

汉方中医云：半夏一升为 120 克，方中半夏，为生半夏，姜半夏，法半夏则无此功，试过用生生半夏一剂见效，而法半夏 21 剂才见效。此半夏为旱半夏，非水半夏。

【温经汤治烦心医案】王雪华：

一位六十多岁的老干部，他从他掌权的岗位上下来，很不适应，出现了一种象女子的，更年期综合征一样，烦得够呛，非常的自悲。我看他既有寒证，也有热证，我就把温经汤，给他用上了，方中有加减。我怎么考虑的呢？它那方里有桂枝汤的和法，有归、芎、芍齐调肝血的作用，还有当归四逆汤，那个当归四逆汤里头应该有通草，此外这个方里有阿胶，我用阿胶，没用通草，为什么我这么考虑呢？因为他上、下都有病，我上次讲乌梅丸证，叫做“寒热错杂”，只要寒热错杂，咱们就用乌梅丸，对不对？

温经汤，我自从治这位男同志后有很深的体会了，温经汤本来是治女子月经病的，但用到这位男同志身上，我当时就为难了，你说乌梅丸方里有蜀椒，有干姜，太热，他热证还挺明显，我一想，这温经汤方组合得好，里面有丹皮，还有阿胶，还有吴茱萸，不象蜀椒、干姜那么热，我就把这方，是在被迫无奈的情况下，一灵活，就给用到温经汤上去了，结果他吃了以后，很高兴的复诊，他说你这方，我觉得对我挺好，就好像心爽了不少，至少不那么出汗，不那么烦热了，这是一。第二，他觉得，就是好长时间以来，那种自悲感、失落感缓和了，你这方药真好使。所以，我也觉得，温经汤的临床应用扩展，咱们琢磨琢磨，我为什么在那位男患身上，使点劲敢用这个药呢？我一想，这经文里面，温经汤证，先说就是妇女多少岁？五十，“年五十”，年五十是女子绝经的时候到了，“七七天癸竭”的时候，这位男同志的更年期，到底是从哪年开始？我没有作过系统的调查和观察，但这位男干部他那种失落感、自悲感，实在是临床辨证，我觉得有点寒热错杂，你说要用小建中汤吧，纯粹温补，我还觉得不合适，提笔就是温经汤，再进行加减，我觉得，他突然的复诊，来的时候挺好，我就开始琢磨，大概是桂枝汤调和的结果，还是因为上下寒热的症状错杂，给大家一个启发吧。

【温经汤治男科病】蒋毅：

温经汤男科应用:补气血扶正祛瘀，精室虚寒、精少弱精、丸冷痛、无菌性前列腺炎、前列腺痛、精索静脉曲张并不育、前列腺痛并勃起问题。方中吴茱萸味苦、辛大热，入肝、脾胃，暖脾胃肝肾，能止痛、散寒、温阳，是厥阴肝经主药，从温阳壮阳止痛两方面来说无疑对男科各种疼痛、阴萎、不育是非常重要的。本方凡是冲任虚寒、瘀血阻滞即肾虚血瘀虚寒证的都可以加减应用，如精索静脉曲张并不育、部分堵塞性少精症(附睾梗阻)，加鹿角胶、鹿茸、附片补督脉，龟板、巴戟天、枸杞子补冲任，当归、芍药续断补带脉。慢性前列腺炎见虚寒症状，疼痛、排尿异常，原方去阿胶、人参加黄芪、白芷、细辛、威灵仙、白芥子、

红花、乌药、益智仁、肉桂。无明原因睾丸冷痛原方重用吴茱萸去阿胶加小茴香、橘核、荔枝核、元胡索、香附、乳没、乌药、槟榔、皮细辛、白芷、白芥子;少精症原方加五子衍宗丸加减:吴茱萸、人参、当归、川芎、芍药、牡丹皮、阿胶、麦冬、桂枝、半夏、甘草、五味子、生姜、覆盆子、枸杞子、淫羊藿、车前子、鹿角胶、鹿茸、菟丝子、沙苑子。肝郁肾阳虚:吴茱萸、人参、法半夏、麦门冬牡丹皮、川芎、桂枝、玄驹、露蜂房、九香虫、白蒺藜、远志、路路通、穿山甲、淫羊藿、紫稍花、大蜈蚣、水蛭、桃仁、贯叶金丝桃、巴戟天、锁阳、蛇床子、韭菜子等。

【温经汤治疗精索静脉曲张】赵淑艳:

温经汤方:吴茱萸 25g,当归 20g,芍药 15g,川芎 15g,人参 20g,桂枝 15g,牡丹皮 15g,生姜 10g,甘草 10g,半夏 10g,麦冬 15g,每日 1 剂,水煎,分 2 次服。服 3 个月为 1 个疗程。

功效主治:温通,养血,祛瘀。临床治疗 30 例,痊愈 11 例,有效 9 例,无效 10 例,总有效率为 66.7%。

经验心得:本病的病因病机主要是肝肾亏虚,血运无力,淤滞肝脉,治宜温补肝肾,通血脉,祛瘀养血。温经汤原本为妇科调经方剂,根据足厥阴肝经循少腹络阴器理论,中医异病同治原则,将本方用于男性不育患者。方中吴茱萸入肝、胃、肾经,温经散寒止痛,桂枝温通血脉,血得温则行。两药合用起温经通脉之功。当归、芍药、川芎俱入肝经,能活血祛瘀、养血调经;牡丹皮入心肝、肾经,活血祛瘀;阿胶能养肝血、滋肾阴;麦冬、半夏、生姜、甘草合人参以补中气,且可制吴茱萸之燥性。诸药共奏温通养血祛瘀之功。(黑龙江中医药)

【温经汤治肌若鱼鳞】

男,60 多,早年开公司多年,压力甚巨,后出现以前臂外侧与小腿外侧为主,全身都有一种皮肤病,皮肤上起干硬皮,很厚,色黑而稍透明,就象鱼皮的颜色,上面的干皮有脱落,只是没有鱼鳞那么规整而已。某医院诊为“对称性神经性皮炎淀粉样变”。他老伴先在我这里治病,效果较好,因为老伴总说吃了中药有多好多好的感觉,他也想试一下,吃点中药调理一下。当时除了这个皮肤病症状外,还有明显的手足凉。没有其他的不适感。望之稍有唇干舌红,就开了温经汤原方三付。服后手足凉明显改善,感觉全身似乎有些舒服,但并没有明确变化,皮肤感觉似乎有点好转,但细看也看不出来,他自己也分不清是不是心理作用。但感觉有点好,问要不要继续吃药。考虑无明显的不适,不需长服汤剂,遂开温经汤原方打成的散剂,嘱服一个月再看。但四天后的门诊他又来了,强烈要求再吃汤药,因为吃散剂的这几天,他的皮肤明显地退了一层,小臂外最重的地方也已经可以看到下面的好皮了。候诊时颇为兴奋,自谓为治此皮肤病全国跑遍治疗多年无效,不意此方几副即如此之好。

补充:此人大约是两周前又来了一趟,上臂的皮肤已经基本正常了,现在只小腿上还有一点点。开他开了麦冬比例增大的原方散剂“温经散 2 号”继续服用。

【能美手的温经汤治手掌皲裂】南京中医药大学黄煌:

最近有位熟人告诉我,她女儿烦人的手掌皲裂今年大好。原来她女儿每年手掌裂口、皮肤粗糙,皮肤科看过,外涂药膏,没有效果。但服用了我开的膏滋方过后,效果十分明显。

我记得那是三个月前,她带女儿来诊。闭经多年,服用雌激素替代。姑娘发育不良,个头也比较矮小。我当即告诉她,必须长期服用中药。

我开的是温经汤。温经汤可以治疗女性手掌皲裂,是日本大塚敬节先生和矢数道明先生的经验。他们用温经汤治疗不孕症、月经不调时,发现患者的手掌皮肤干燥开裂随着月经状况的好转,手掌也变得滋润。这个发现很有趣,原来月经不调与手掌皮肤相关。

后来我在治疗女性月经不调时,也注意其手掌皮肤。一般来说,手掌皮肤滋润、嫩白者,大多月经正常,而手掌皮肤干燥,尤其是指端皮肤粗糙干裂,甚至擦手时沙沙作响者,大多有月经不调或闭经。有些虽然没开裂,但甲沟多毛刺,指甲脆裂,也常常伴有月经异常。值

得惊叹的是，张仲景在《金匮要略》中已经提及温经汤证有“手掌烦热”。所以，我常说温经汤是美容方，也是美手方。

温经汤可用汤剂，用水 2000 毫升，煮取 600 毫升分三次温服。也可以制成膏剂。煎药时加放上红枣 24 枚撕开、桂圆 15 个、煎好后过滤，放入阿胶和鹿角胶再加入冰糖 1 把或麦芽糖 3 勺，可以使药味可口，便于常服。如加芝麻研粉、核桃仁捣碎更香，熬成膏状备用。鹿角胶（30 克）是传统补肾填精的药物，对月经不调、不排卵等有调理作用，所以，我也常加入。我称之为温经膏。许多女性每天早晚各冲一汤匙，十分方便。服用以后，肤嫩唇红，女人味更足。

【用温经汤治疗三年无月经】矢数道明：

患者 22 岁，女，未婚，初诊于 1971 年 6 月。病历：1970 年 12 月以前每月有月经，但经血量小，从那以后至初诊为止停经。患者体格稍矮小，脸色像白腊一样，贫血状。回答问题无力气。阴虚证感觉。

自觉症状有下腹部胀，经常疼痛，手足冷，腰痛，发冷时小便次数增加。脉沉、弱、血压 110/70，有便秘倾向，腹部脐周围有抵抗稍有压痛，稍有瘀血证。综合起来看身体衰弱，贫血，即气血两虚寒证，发冷时小便频数，为虚寒。属于妇科病的有子宫发育不全和卵巢机能障碍。与妇科检查诊断大致相同。

治疗:使用的汉方有针对血虚的四物汤;补气的四君子汤;针对肝脾血虚的有加味逍遥散，气血两虚用十全大补汤、对贫血、寒证、频尿用当归芍药散，针对脐旁的抵抗压痛和瘀血用桂苓丸料使瘀血循环改善，针对寒冷感强用当归四逆加吴茱萸、生姜汤以温暖身体，针对下腹部经常痛的疝气表现，长期无月经的气滞用半夏厚朴汤以顺气。

按上述考虑，每个方用 2~3 个月，这样经过一年、二年仍无月经，患者及其母亲坚定地用汉方药，我对这种精神所感动，感到有非治好患者病不可的责任感。我让她去熟人的医院检查血相，因为脸色不好，可能属于萎黄病。但意料之外，血液检查没有多大问题，贫血不严重，可能向来无月经而失血少的原因。除了服汉方药而外，也求助于专看妇科的汉方针灸并用的友人。经过半年针灸也无效果。可能激素缺乏，考虑用激素疗法，但患者及其母亲都不同意用激素。患者有她坚定的想法，用汉方药可以治愈。

我认真思考，回顾了以前治疗的失败，针对气血两虚，寒证的方终于决定尚未使用过的温经汤。

《金匮要略》对温经汤证的使用证有十条:①月经不调，②子宫等出血，③寒证，④下腹膨满感，⑤下腹部痉挛，⑥手掌烦热感，⑦口唇干燥，⑧50 岁左右的更年期，⑨曾经流产，◎少腹有瘀血。

此患者①月经闭止，③寒证，④下腹部膨满感，⑤下腹部痉挛，四少腹有瘀血即 10 条中有 6 条，其他②、⑦、⑧、⑨没有。

我在《处方解说》中讲述温经汤证时，指出“用于气血虚，带寒冷的妇科诸病”，“属少阴病，阴虚证，以气血虚和寒冷为目标而用于月经不调、月经过多，月经到期不来的无月经”其处方构成:①当归、芍药、川芎治血虚、贫血，②阿胶、麦门冬润枯燥的血，③人参、甘草补气虚。④吴茱萸、生姜、桂枝温暖寒冷。⑤半夏治带下。⑥牡丹皮治下腹部瘀血。

1974 年 11 月让服温经汤。服药后患者逐渐感觉身体温暖，食欲增加。服 1 个月药后来我院时脸色转好，脸颊出现红润，腹部有力，增加体重 1.5 公斤。患者从来没有肥胖过。服 3 个月。即到 1975 年 2 月来院时体重增加 3 公斤，寒冷倾向减少，身体舒服，有体力。但仍无月经。

服 4 个月即 3 月 26 日，患者的母亲打来电话，说 4 年来第 1 次有月经并持续 8 天，很高兴。继续服该方，即 4 月、5 月、6 月虽然来迟一周，但每月有月经，4 年来尽管服汉方药没有那么理想，但患者从不间断，也不灰心。如果早点让服温经汤，那该有多好。只是气血虚

和，虚寒不能决定处方，但温经汤证中的十条，符合 6 条，因此服用温经汤后症状好转，并来了月经，当然此患者是属于温经汤证的。《汉方的临床》

【温经汤治疗闭经】

刘某，女，20 岁，学生。2006 年 5 月初诊。患者 16 岁初潮，至今月经未按月来潮，或三月一行，或间隔更长。此次来诊月经已半年未至。在当地做 B 超显示左侧卵巢未发育。患者身高 163cm，体重 54kg。形体适中，一般状况良好。面色略淡白，唇红，偏干。睡眠尚佳，纳食可。行经无腹痛，量可色鲜红。脉弦细。予温经汤原方 12 剂，经行，嘱其继续服药。连续三月，每月月经按时至。嘱其每月行经前服药十剂。如不能按时行经再诊。

2007 年 9 月随访，患者坚持服药一年，每月均按时行经，量色质正常，无腹痛。7 月在当地复查 B 超示：子宫卵巢发育良好。

【温经汤治牛皮癣医案】楞青社：

患者是笔者内人，女，43 岁。己亥年初，右脚跟长一拇指大褐色顽鲜，时而会掉皮，痒难忍，问我拿药吃。当时我没太在意，以为就一般湿疹。因其体胖血虚湿盛，长湿疹湿是常态，便开了小建中加当归芍药散等补虚祛湿之品。另嘱其用黄连磨粉涂抹患处。药后患处无好无坏，仍痒但还能忍受。因常两地分居，没有面诊，也没再用药。

庚子年年初，新冠疫情大爆发的那一天，她的湿疹也全身大爆发。先是肚皮后胸口然后脖子这样一路向上长，一天一个样有全身扩散之势，奇痒难忍，夜不能眠，烦躁不安。

刻诊：脉弦稍弱，两关软。舌淡红苔薄，两侧带淡瘀点。口干不渴，二便正常，居恒手心烦热。我投三剂柴胡姜桂加当归芍药散，无任何收效，继续扩散，情况危急，一时六神无主，于是求救于网上一位素未蒙面的高手。他说他用温经汤疗愈多例牛皮鲜患者，并建议我用温经汤一试。温经汤主证，手心烦热，嘴唇干，暮发潮热等。因只有手心烦热一证，我仍犹豫不决。当天傍晚，患者突发潮热，烦躁，此时我便确信温经汤证无疑。遂开温经汤加蛇床子一剂。煮药时患者闻其味即全身痒止，于是便搬来凳子一直坐在药锅边闻药味。六剂药后顽癣基本褪去但仍有痕迹。后再进药半个月，加日服桂附地黄丸一颗，顽癣得以痊愈，但局部患处仍留有色斑。嘱其坚持吃桂附地黄丸，半年后色斑全褪，皮肤完好，看不出任何痕迹。

患者一直是温经汤证，只怪我平常读书不精，临证无方才迁延至如此危急的状况。这是应该做深刻反思跟自我检讨的案例。此后对素未蒙面的老师一直心存感激。

【温经汤治子宫肌瘤，乳腺增生，甲状腺亢进癣医案】楞青社：

患者是挚友之妻，庚子年，41 岁。患者因常年工作压力大，常熬夜，所以体质比较虚弱，以前也常问我拿药吃。后来我们生活在不同城市，只能远距离指导她用药。

患者在庚子年中单位集体体检，被告知是乳腺癌的临界，病情危急，建议最好到大医院治疗。随后便来电咨询我的意见，我建议她去找当地最有名的中医师治疗。名医开了逍遥散加牡蛎等疏肝散结之品，用药一周后乳腺增生变大且痛，两腹股沟也长两肿块，心情焦急，便来电咨询我的意见。

刻下主诉：乳腺增生肿痛，两腹股沟新长两肿块且有疼痛感、口干渴、嘴唇干、手心热、暮发潮热、心烦、大便软、小便正常、睡眠差。其人瘦，眼微突，脸色白带淡黄夹青色。舌质淡红苔薄白。

听完上述症状后我以唇干，手心热，暮发潮热为主证，建议她试用温经汤一剂，若有效再续后服，若无效再另作打算。不料一剂疼痛减轻，三剂后腹股沟肿块消失。按此思路治疗半年（中间有用建中，真武，理中等），乳腺增生变小并脱离危险状态。

【温经汤不孕医案】《经方躬行录》

李某，25 岁，农民。婚后五年不孕，月经二三月一行，甚无规律。西医做人工周期三月，月经按时而至，停则姗姗不来，遂改求中医。初意在鹤发银鬓之老医，发乌须墨如余者，不

屑一顾也。然服药数月未效，一日来诊，适值老医休息，不得已而求余，然不乐之色显于眉间。询知经前乳房胀痛，经来量多，杂有血块，延期十日左右。经期腹痛、腰痛，喜温喜按，经后头痛，今已毕56日。带多清稀，小腹发冷，夜间手足心热，胃纳可，口干思饮，大便正常。望其面白少红，人中深凹，唇干不荣，舌淡红，苔薄白。诊其脉，沉弦细，触其腹，小腹不温，松软无压痛。

脉证观之，此冲任虚寒，气滞血瘀证也。盖冲为血海，任主胞胎，冲任虚寒若寒冬地冻，种子焉能发芽生根？老医所开之方，乃号称种子安胎第一方——少腹逐瘀汤。是方虽有茴香、干姜、官桂暖宫之品，然不补益气血，填充冲任，凝寒瘀血安能去之？拟：

当归15g，川芎10g，白芍15g，党参30g，桂枝10g，吴茱萸10g，甘草6g，丹皮10g，麦冬15g，阿胶15g，柴胡12g，生姜5片，五剂。

二诊：服药四剂，月经汛潮，经前乳未痛，经来腹安和，今已行三日，量仍多，色鲜杂块，脉舌如前。守方七剂，忌食、触寒凉。

三诊：上次月经七日即净，头未痛，口干、掌热均减，精神大好，纳化有增。某面色泛红，屠涡可掬，今又毕41日，切其脉，滑数有珍。彼不之信，云："不恶心、不思酸，何言有孕"？令作尿检，果呈阳性。

附记：李妊娠后，村民闻讯，先后有数人经余调治亦身怀六甲。是年冬，该公社党委书记某，怒气冲冲而来，云彼未成为模范书记者，因余致人口净增率超标，计划生育拉分故也。余对曰："若汝多年不育，求医否？若汝为医生，拒诊否?"如此为名利而背情理，实可笑也。此20世纪80年代事也。

【温经汤闭经医案】《经方躬行录》

郭某，38岁，人工流产后，月经5月未行，于1997年7月13日来诊。患者面白无华，精神萎靡，唇干萎，舌质微暗，苔白薄。询知人流术中出血甚多，流产后过食生冷果品，从此少腹隐隐作痛，带下清冷，腰脊酸痛，至夜掌心烦热。胃纳不佳，口干不欲水，大便日一行。诊其脉沉细缓，触其腹，小腹不温，左少腹微有压痛。

闻雷声而知雨意，人流失血过多，必损伤冲任，血海亏空，水浅则浪不潮也；产后过食生冷，必血为寒凝，瘀滞胞脉，是以月经不汛。治当补益冲任，温经散寒。若海足扬波，经自至矣。拟：

当归15g，川芎10g，赤芍15g，桂枝10g，吴茱萸10g，阿胶10g，党参30g，甘草6g，丹皮10g，半夏10g，麦冬10g，杜仲15g，生姜5片，三剂

二诊：小腹转温，疼痛不再，带下减少，饮食略增，精神大好。守方五剂。

三诊：药未尽剂，月经已至，量不多，杂紫块，少腹、腰微痛，掌心热，脉仍沉细。此寒散瘀化，然血海未充，补血益冲，仍宜继续。原方十剂。

【温经汤痛经医案】《经方躬行录》

王某，20岁，18岁月经初潮。每届经期，小腹疼痛，近两年益甚，以致不能上课，唯卧床耳。经毕则饮食、起居如常。中西药迭进，痛未少离，于2005年12月3日来诊。

本豆蔻年华，却无玫瑰风姿，但见形体消瘦，面色微青，舌淡红，有瘀斑。询知经行后期，35～45日一行，量多，紫暗杂块，小腹、四末发冷，腰痛。恶心欲吐，口干不思饮，二便正常。今已毕29日，入夜手心烦热，睡寐殊难。切得脉象沉细。腹诊腹肌挛急，无压痛。

月经迟汛者，先天不足也。从痛经、腹冷、脉细、血紫诸症观之，此血海亏虚，寒凝血滞证也。刻下月经将潮，宜未雨绸缪，拟温经汤温之通之。

当归15g，川芎10g，赤芍15g，党参15g，桂枝10g，吴茱萸10g，丹皮10g，甘草6g，半夏10g，麦冬15g，阿胶15g，熟地15g，生姜5片，五剂

二诊：剂尽经汛，腹痛大减，量亦少，小腹微冷，手足温，今已行3日，舌脉如前。守方五剂，嘱经净后早服肾气丸、晚服归脾丸各一粒，下届经期，温经汤继续服之。

三诊：此次月经29日即汛，腹不痛，亦不冷，行经6日，量不多。为绝痛经，嘱下届经期如法服之。

【温经汤治不孕】曹颖甫：

予按此为调经统治之方，凡久不受胎经来**先期后期，或经行腹痛，或见紫黑，或淡如黄浊之水**，施治无不愈者，曾记寓华废坊时，治浦东十余年不孕之妇，服此得子者六七家，江阴街四明范姓妇亦然，此其成效也。

【温经汤合吴茱萸汤治高血压发作时头晕欲呕医案】：

宫某某，女，年龄46岁，已婚，主诉：头晕。食欲一般，例假提前七八日或四五日，睡眠差，易醒，易惊，大便一日一次，食冷则易腹泻，喜忘，小便夜尿三四次，无浮肿，无汗出，怕冷，头晕或不清爽，无口干，无喜呕，口苦胃不适时有，手足冷长期有。脉象：脉偏弦。舌质淡红略偏暗，苔薄白。体温，血压83\140mmHg心率每分钟74次，两腿无力，时有脸浮肿，曾有痛经史，因丈夫患病脑溢血后操劳而致高血压，现仍在服药，发作时头晕欲呕，高压曾到180mmHg。处方吴茱萸与温经汤70克，日二服，次2.5克左右。5.1日来诊，血压86\141，心率80，睡眠可，诸证已均不明显，现有贫血症状，脉细弱，下眼睑内侧色偏淡。吴茱萸与温经汤加石膏吴茱萸100克，日二服，次2.5克左右。5.30其夫来电话，咨询治疗其脑溢血后遗症的问题，言其服药后血压再没有发生偏高和头晕的情况。

【温经汤治怕冷口腔溃疡案】

Z/YP，女，43岁。形体中等略瘦。贫血貌而肌肉较松弛，B超检查发现左侧卵巢囊肿。白细胞略低于正常值，怕冷，手足皮肤干燥，自觉手如树干样感觉，每日需要搽油2-3次方感舒适。唇干，口腔溃疡不断，易掉头发。查小腿皮肤干燥。舌暗淡，苔薄。

黄师处以温经汤方：吴茱萸10克，党参10克，麦冬20克，炙甘草6克，姜半夏6克，肉桂6克（后下），当归10克，白芍10克，丹皮10克，赤芍10克，川芎6克，阿胶12克（另烊），干姜6克，红枣30克。药后一周患者因口腔溃疡未作而甚为高兴，同时患者自觉怕冷好转，大便亦甚为通畅。原方熬膏冬令服用。

【温经汤治经水淋漓不断医案】：

岳美中医案：周某某，女，51岁，河北省滦县人，1960年5月7日初诊。患者已停经三年，于半年前偶见漏下，未予治疗，一个月后，病情加重，经水淋漓不断，经色浅，夹有血块，时见少腹疼痛。经唐山市某某医院诊为“功能性子宫出血”，经注射止血针，服用止血药，虽止血数日，但少腹胀满时痛，且停药后复漏下不止。又服中药数十剂，亦罔效，身体日渐消瘦，遂来京诊治。诊见面色咣白，五心烦热，午后潮热，口干咽燥，大便秘结。七年前曾小产一次，舌质淡红，苔薄白，脉细涩。证属冲任虚损，瘀血内停。治以温补冲任，养血祛瘀，投以温经汤方：吴茱萸9克，当归9克，川芎6克，白芍12克，党参9克，桂枝6克，阿胶9克(烊化)，丹皮6克，半夏6克，生姜6克，炙甘草6克，麦冬9克。

服药7剂，漏下及午后潮热减轻，继服上方，随证稍有加减。服药2 0．剂后，漏下忽见加重，挟有黑紫血块，血色深浅不一，腹满时轻时重。病家甚感忧虑。岳老诊其脉象转为沉缓，五心烦热、口干咽燥等症大为减轻，即告病家，脉症均有好转，下血忽见增多，乃为佳兆，系服药之后，体质增强，正气渐充而带血行之故。此瘀血不去，则新血不生，病亦难愈并嘱继服原方6剂，隔日1剂。药后连续下血块五日，之后下血渐少，血块已无。腹胀痛基本消失。又服原方5剂，隔日服。药后下血停止，唯尚有便秘，但亦较前好转，以麻仁润肠丸调理两周而愈。追访十年，未见复发。(北京中医杂志1985；(1>：7)刘渡舟医案：李某某，女，45岁，1993年5月5日初诊。10年前因做人工流产而患痛经。每值经汛，小腹剧痛，发凉，虽服止痛药片而不效。经期后延，量少色黯，挟有瘀块。本次月经昨日来潮，伴见口干唇燥，头晕，腰疼腿软，抬举无力。舌质暗，脉沉。证属、冲化虚寒，瘀血停滞。治宜温经散寒，祛瘀养血。疏温经汤方：吴茱萸8克，桂枝10克，生姜10克，当归12克，白

芍 12 克，川芎 12 克，党参 10 克，炙甘草 10 克，丹皮 10 克，阿胶 10 克，半夏 15 克，麦冬 30 克。服 5 剂，小腹冷痛大减。原方续服 5 剂，至下次月经，未发小腹疼痛，从此月经按期而至，俱无不适。(《刘渡舟临证验案精选》1996：162)

【温经汤治小腹冷痛医案】李贯国：

医案：李姓，女，38 岁。产后 10 余天，进食大量瓜果生冷食物，次日即感小腹冷痛，此后病情加重，月经 3 年未行，曾服中药数十剂，未获效，西医诊为“继发性闭经”，注射黄体酮二周，效果亦不显。现症：面色白而浮肿，四肢不温，少腹冷痛，倦怠乏力，目眩，动则喘促，胸闷恶心，饮食欠佳，大便不实，白带量多，唇舌淡红，脉沉而紧。乃产后过食生冷，血为寒凝，滞于冲任，壅于胞脉，以致经闭不行，属虚寒闭经证。治以温经散寒，养血调经。用温经汤方：当归身 15 克，川芎 9 克，炒白芍 9 克，阿胶 12 克，党参 9 克，姜半夏 6 克，制香附 9 克，丹皮 9 克，桂心 3 克，炒吴茱萸 9 克，炮姜 6 克，甘草 3 克。

二诊：腹 4 剂，食欲增加，少腹冷痛，四肢不温已消，其它症状均有减轻。原方续服 4 剂，症状消失。(上海中医药杂志 1966；<5>：193)张庆云医案：李某某，农家妇女，26 岁。婚后三年未孕，妇幼保健院诊为幼稚子宫。病家十九岁月经初潮，一直后错，久者半年行经一次，量少，色淡红。身材矮小，精神尚好•，脉沉细尺弱，舌苔薄白。《内经》云：“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子”。该女十九岁月事方兴，且量少色淡，显属肾气不足，不能化生精血。血少，则胞宫失养，故胞宫小。精血虚，故月事迟迟不来。治以补先天，暖冲任，润养胞宫。随以温经汤加减治之。处方：当归 30 克，川芎 6 克，炒白芍 5 克，阿胶 15 克，肉桂 6 克，巴戟天 12 克，党参 30 克，丹皮 5 克，干姜 6 克，甘草 12 克，紫河车二克(冲服)。调治半年，生一女婴。(河南中医 1985；(6)：22)

【温经汤治月经先后不定期医案】秦德平：

李某，女，48 岁。月经先后不定期已 3 个月，头昏目眩，失眠多梦，午后低热，心烦口苦，烦躁易怒，耳鸣耳闭，唇舌干燥，手足心热，面部时感烘热，经量或多或少，舌质淡，还有紫斑，脉沉涩。冲任虚寒，瘀血内结，且夹有阴虚内热之象。温经养血，祛瘀滋阴，温经汤加味。吴茱萸 9 克，桂枝 9 克，当归 9 克，赤白芍 9 克，丹皮 9 克，麦冬 9 克，生地 9 克，川芎 4.5 克，月季花 4.5 克，甘草 4.5 克，阿胶 12 克，生鳖甲 20 克。连服 10 剂后自觉头昏略减，睡眠稍安，烦热及面部烘热间或发作，药已获效，继进 7 剂，痊愈。(江西中医药 1980；(4>：67)

【温经汤治阴吹医案】杨百茆：

周某，女，38 岁，1991 年 11 月 19 日初诊。诉 6 年前即有前阴出气如后阴矢气之症，常于劳累或受寒之时发生。初不在意，不以为病。未料愈发愈频，几乎每天发生，有时前阴接连出气作响数声，尤以卧起动作时为显，苦恼不堪。尝欲求医而难于启齿，陷忍不言。病情至今有增无减。询及他症，前阴寒冷，白带绝无，小腹如扇，隐痛喜按，胃脘冷痛，得温则减；手足心热，13 干欲热饮，小便清长，大便稀溏。4 年前曾做人工流产，继而月经失调，量少色淡。今年 1 月以来，经闭不行。诊见；形体瘦小，面色灰暗，精神萎靡，四肢不温，舌质淡红，苔薄白，脉沉细弱。病为阴吹，乃冲任虚寒，阴寒之气下出前阴所致。治以温经散寒，调补冲任之法。方用温经汤化裁：吴茱萸、炙甘草各 6 克，桂枝、川芎、桃仁、党参、法夏各 10 克，当归、鹿角霜、白芍、丹参各 15 克。水煎服，日 1 剂。

服药 7 剂，阴吹次数明显减少，继进 14 剂，阴吹告愈，且月经来潮，余症亦相继消除或减轻。原方随症调整，续服数剂以善其后。随访 1 年，阴吹未发。(国医论坛 1993；(1)：17)

【温经汤治痛经医案】颜德馨：

董某，女，30 岁。宿有痛经史，结婚三年，未有大小生育，痛经逐年加剧，经前乳房胀痛，经量较少，色暗紫而不畅，伴腹痛恶心，痛剧面色苍白，四肢逆冷，大便溏薄，眼眶发黑，苔薄腻，舌紫，脉沉迟。证属寒凝血瘀，用温经汤化裁：赤白芍各 9 克，生姜 3 片，川

芎 6 克，阿胶 7 克(烊冲)，吴茱萸 9 克，当归 9 克，紫石英 30 克，桂枝 6 克，小茴香 3 克，延胡索 9 克，党参 9 克，失笑散 9 克(包)，7 剂。药后诸证减轻。以前方调治四月，乃孕育一子，痛经宿患亦随消失。(国医论坛 1992；(3)：23)

【温经汤治不育精子活动率不足医案】张庆云：

张某某，27 岁。婚后年余不育，经某医院检查，精子 3 千万，活动率 30%。平日腰部酸困疼痛，阴囊常出冷汗，饮食、二便正常，脉沉缓苔薄白。此乃下元虚寒，冲任不足，精少不育。治以温暖下元，补益肝肾，以增生殖之精。处方：当归 12 克，川芎 6 克，白芍 15 克，吴茱萸 10 克，菟丝子 30 克，仙灵脾 30 克，巴戟天 12 克，党参 30 克，肉桂 9 克，阿胶 20 克，丹皮 3 克，干姜 8 克，半夏 12 克，麦冬 12 克，甘草 6 克，紫河车 2 克(冲服)。

紫河车乃血肉有情之品，益气养血，促进生殖之精的生长、分泌；菟丝子、仙灵脾、巴戟天壮肾兴阳，以增强精虫之活力。以上方为基础略事加减，调治二月。据称其爱人已怀孕。(河南中医 1989；(2>：21~22)

【温经汤治阳萎不举医案】李白宪：

张某，男，34 岁。1994 年 5 月 24 日初诊。患者阳萎不举，难以交合 5 年余，致使夫妻不和，曾用激素类药治疗收效不显，后改服中药调治，屡次更医更药，服药百余剂，不仅阳萎未愈。反增头痛眩晕，心烦失眠。证见面色不泽，神疲倦怠，伴头痛眩晕，手掌心烦热，时出冷汗，口唇干燥，午夜心烦失眠，小腹下坠且痛、阴部冷胀，舌淡苔白，脉沉细。证属阳气虚衰，营气不通、宗筋弛缓之候。治宜温阳散寒，调和气血，方用温经汤方：当归 15 克，川芎 10 克，白芍 12 克，党参 15 克，丹皮 10 克，牛膝 15 克，肉桂 10 克，吴茱萸 10 克，麦冬 12 克，炙甘草 10 克，仙灵脾 15 克，仙茅 12 克，生姜 5 片。水煎服，日 1 剂。

服药 10 剂后，精神渐佳，头痛头晕减轻，饮食增加，睡眠好、阳事时兴，余证也相继好转。原方继服 10 剂，病情又明显进步，可以过两性生活。又服 10 剂，房事正常，3 个月后，其妻身有孕。(河南中医 1996；(4>：215)

【温经汤治睾丸硬痛发胀医案】张庆云：

一壮年男子，睾丸硬痛发胀，但不红，阴囊发凉，少腹清冷，劳累则加重。平日自服止痛片，以除一时之苦。诊其脉沉弦，舌苔薄白。肾阳不足，寒凝肝脉所致。方以温经汤加减：当归 12 克，川芎 8 克，赤白芍各 18 克，党参 12 克，桂枝 12 克，丹皮 10 克，吴芋子 12 克，半夏 12 克，大小茴香各 12 克，桔核 12 克，荔枝核 12 克，干姜 10 克，甘草 9 克。调治一旬，病苦痊愈。(河南中医 1985；(6>：21)

【温经汤治双手不温指端反复出现苍白青紫麻木医案】高正今：

张某，女，31 岁。1988 年¨月 9 日诊。双手不温，指端反复出现苍白、青紫、麻木三年，西医诊断为雷诺氏病。虽用麦角硷、烟酸等扩血管药物，效果仍不明显，每因天气转凉或接触冷水加重。刻诊：双手指均显苍白，小指和无名指前端青紫，舌质淡，舌伴有瘀点，脉沉细。证属气虚血瘀。治拟益气活血化瘀。方选温经汤加减：黄芪、党参各 30 克，当归、青芍、川芎、白术各 15 克，吴茱萸、桂枝、生姜、丹皮各 12 克。服 7 付后，双手指麻木、青紫均减退，但接触冷水后手指仍显苍白。上方去吴茱萸、生姜，加肉桂、牛膝各 12 克，继服 20 剂，未再复发。(四川中医 1990；(10>：22)

【温经汤治四肢麻木医案】高正今：

医案：袁某，男，19 岁。1989 年 2 月 8 日诊。因受凉后头痛，周身不适，怕冷半月，四肢麻木无力一周而入院。当时四肢呈驰缓性瘫痪，上下肢肌力均仅 I 级，双腕和踝以下感觉障碍，西医神经内科经各种检查后诊为格林一巴利综合征(急性感染性多发性神经根炎)。应用地塞米松等，病情无好转。诊四肢无力，不温，舌质淡紫，苔薄白稍腻，脉沉而涩。证属寒湿入络，气虚血瘀。治宜温经散寒，益气活血。方用温经汤加减：黄芪、党参各 30 克，当归、川芎、白芍各 15 克。吴茱萸、桂枝、生姜、丹皮各 10 克，红花、甘草各 6 克。

服12剂后，四肢转温，麻木感消失，下肢肌力恢复至Ⅳ级，上肢恢复到Ⅲ级，可下床缓步行走。原方去吴茱萸、生姜、加丹参30克，赤芍15克，继服20剂，继服20剂。痊愈。一年后随访，健康如常人。(四川中医1990；<10>：22)

【温经汤治心前区闷痛心肌梗塞医案】魏小萌：

医案：郭某，男，60岁，1984年12月8日初诊。患者述心前区闷痛，稍活动加重，遇寒尤甚。曾于1983年10月28日在北京某医院诊为“心肌梗塞”，住院34天，出院时心电图示：V。～V。呈宽大而深的Q波，ST段V。抬高。常服消心痛、肠溶阿斯匹林、瓜蒌薤白半夏汤和八珍汤等中西药物无明显改善。刻诊：症如前述，舌淡有瘀斑、苔白稍腻，脉沉缓。检查：血压170／90毫米汞柱，心率78次／分，律齐，心界向左稍扩大，心尖可闻及SMⅡ杂音，电图仍同出院时报告，空腹血糖80毫克，尿糖(阴性)。中医辨证为胸痹。证属气血两虚、寒凝络滞，治宜温补气血，祛瘀通络。方用温经汤去丹皮加丹参。处方：吴茱萸、党参、桂枝各15克，当归、白芍、川芎、阿胶、炮姜、麦冬、半夏各10克，丹参30克，炙甘草5克。六剂后，心前区闷痛明显改善，效不更方，继服六剂，心痛减轻，劳累后时有心悸，晨起咽干口燥，去炮姜易玄参10克，再服35剂，可参加轻微体力劳动，嘱其改为．口服复方丹参片，冬季仍加服温经汤，1987年8月28日心电图报告单为窦性心率，各波段均正常，无T波倒置和异常Q波。病人自觉良好。(新中医1990；(9)：45)

【温经汤治血吸虫性肝硬化少量腹水医案】陈新宝：

医案：方某某，男，64岁。1989年10月16日初诊。患者居住地为血吸虫流行区。1986年在上海华山医院乙状结肠镜活检报告：“回盲部增生性病变，有钙化血吸虫卵沉积”。确诊为血吸虫性肝硬化，少量腹水。诉反复腹胀6年，复发1年余，下肢浮肿3个月，伴头晕乏力，胃纳减退。查体：慢性贫血貌，面色黝黑，颈静脉充盈，腹壁静脉暴露，肝脾末触及，移动性浊音+。B超检查报告，血吸虫性肝硬化、腹水，门脉高压。肝功能报告：黄疸指数30弘，SGP'I、正常，总蛋白7．3，白蛋白3．3，球蛋白4.0；纸上电泳：A49．4％，a13．5％，az4.1％，p7．1％，Y35．9％。舌苔微黄腻、舌质淡嫩，脉沉弦细。证属气血亏虚，气滞血瘀，治拟温肝养血，化瘀行滞。

处方：吴茱萸、炙桂枝、生姜、炙甘草各5克，当归、白芍、川芎、党参、黄芪、阿胶、姜半夏、丹皮、麦冬各10克。连续服用3个月，在治疗期间根据患者情况适当配合护肝、补充白蛋白、液体支持疗法等。治疗后患者自觉症状及体征消退，肝功能检查正常，已上班工作至今。(浙江中医杂志1993；<6>：257)

【温经汤治口干多梦手掌心热月事不调入睡则尿床医案】萧铁珊：

翁某某，女，20岁，自1984年2月始患夜间遗尿病。曾求医于武汉，作血糖尿糖等检查，均属阴性。1985年3月8日求治于余。口干多梦，手掌心热，月事不调，入睡则尿床，面色淡白，少腹不适，精神疲倦，脉细弦，舌暗红苔黄，巩膜有瘀斑数点，药用温肾固摄之品不应。余思足厥阴经脉绕阴器，瘀血搏于膀胱，州都失司，血为阴，以阴从阴，故寐即遗尿。法宜温经散寒，养血祛瘀。仿温经汤处方：当归15克，川芎10克，白芍15克，西党参15克，粉甘草3克，桂枝6克，丹皮10克，生姜3克，阿胶15克，吴茱萸10克，法夏10克，麦冬10克，3剂。次诊：服上方八天来未见遗尿，巩膜瘀斑减少，精神尚佳，食饮渐增，仍以上方5剂，诸证悉除。(河南中医1988)

第二十八章 桃核承气汤方证

【抵当汤桃核承气汤治半产后面色黧黑下焦蓄血医案】《生生堂治验》

一妇人半产后，面色黧黑，上气头晕。先生诊之，脉紧而脐下结硬。曰：“此有蓄血也。”即与抵当汤，三日而觉腰以下宽舒，更与桃核承气汤。俄顷，果大寒战，发热汗出，谵语，

四肢搐搦，从前阴下血块，其形如鸡卵者。六日约下二十余枚，仍用前方，约二旬，所患若失。

汤本氏注：黧黑者，无光泽而黄黑色也。头晕者，眩晕也。脐下结硬者，下腹部坚硬有凝块也，是即血塞。谵语，自言自语也。搐搦，间代性痉挛也。前阴，阴户也。此证因流产时恶露排泄未净，于下腹部发生血塞，其余波及于头脑使至眩晕，而自服抵当汤及桃核承气汤后则瘀血完全排出，故获效也。

【桃核承气汤合大柴胡汤治腹痛抽搐医案】：

段某，女性，14 岁，1965 年 10 月 4 日初诊。1964 年 3 月月经初潮，后来未再来潮，1965 年 4 月 23 日发四肢抽搐、昏厥，近来发作频繁。每发作前厌食，右上腹痛，胸闷，当有气自腹向上冲时即发抽搐及昏厥，时伴呼吸急迫、大声喧喊。口苦，便干，舌苔白腻，脉弦细。右上腹痛，胸闷，口苦，便干，大柴胡汤证。月经未潮，四肢抽搐、昏厥、大声喧喊，桃核承气汤证。综合分析：证属瘀血阻滞、郁久化热，治以祛瘀清热，与大柴胡汤合桃核承气汤。处方：柴胡 12g，白芍 10g，枳实 10g，生姜 10g，大枣 4 枚，半夏 12g，大黄 6g，桃仁 10g，桂枝 10g，炙甘草 6g，黄芩 10g，芒硝(分冲）10g。结果：上药服 3 剂，右上腹痛、胸闷未作，抽搐也未发。据证改服小柴胡汤合当归芍药散加减。调理 3 个月诸症已，月经来潮。

【桃核承气汤治经前如狂医案】：

妇女经来狂言谵语，据《竹林寺女科》载，多因月经来时多触烦怒，肝气逆乱，血随气逆，上攻于心所致。治宜舒肝宁心。因热与瘀血相搏而引起的经期发狂更为多见，由于感受实热之邪结于下焦，侵入血分，阻滞气血运行，产生瘀血，热与瘀血相搏，上扰心神，神明失聪，使人如狂、发狂。治宜清泻火热之邪，破血下瘀，瘀、热去而心神得安。用桃核承气汤治疗此病有良好的效果，如在经前服用效果更佳。

典型病例：向，教师，二十多岁，未婚。每到月经来潮时即成癫狂状态，妄见妄言，哭笑无常，夜寐不安，月经过后，不治自愈，数月以来皆是如此。经患者的母亲回忆，此人有痛经史，曾于数月前重感冒一次，那时正是月经期，以后即患此病。患者来就诊时，正是发病的时候，也就是正在月经期。虽然胡言乱语，嬉笑不常，但在问诊时还能够控制，准确的回答。经服桃核承气汤加减四剂而愈。随访数月，概未复发。

按：本例患者平素有痛经史，结合当时的证候，显然有瘀血阻滞，正值经期发生了感冒发热，外感热邪侵入下焦血分，以致瘀血不行，而引起发狂。其发病的机理和《伤寒论》中的蓄血证相同。即“瘀热”所致。如瘀血不与火热结合，仅能为癥积而已，不能发狂，只有热与瘀相挟，瘀浊才能上行清道而扰及神明。如徐灵胎《伤寒论类方》说：“热甚则血凝而上干心包，故神昏如狂。”故用桃核承气汤攻瘀兼清热，取得了速效。但是，这和《伤寒论》中所载的热入血室有根本上的区别，此有瘀血，彼无瘀血。所以在治疗方面，蓄血证是以逐瘀为主，而热入血室则是以疏解（小柴胡汤）针刺（期门）泄肝热为主。

《医方考》：桃仁，润物也，能泽肠而滑血；大黄，行药也，能推陈而致新；芒消，咸物也，能软坚而润燥；甘草，平剂也，能调胃而和中；桂枝，辛物也，能利血而行滞。又曰：血寒则止，血热则行。桂枝之辛热，君以桃、消、黄，则入血而助下行之性矣，斯其治方之意乎！

《古方选注》：桃仁承气，治太阳热结解而血复结于少阳枢纽间者，必攻血通阴，乃得阴气上承，大黄、芒消、甘草本皆入血之品，必主之以桃仁，直达血所，攻其急结，仍佐桂枝泄太阳随经之余热，内外分解，庶血结无留恋之处矣。

【小柴胡汤证与桃仁承气汤证俱在的三叉神经痛】娄绍昆：

“临床上运用‘统观全局提前绕’的原则能否举例说明?”

“我诊治过一个三十五岁三叉神经痛的妇女,眼神经区比上颌神经区的疼痛更为严重”，阿骅表说:“病人体弱消瘦，从小就病怏怏的，结婚生产后，体力更加差了。半年前因为感冒

长期不愈，引发泪囊炎、鼻窦炎，后来就出现了三叉神经痛。在给我诊治之前，一般靠服止痛片减少苦痛。我初诊时，病人烦热、时有恶风、头痛、口苦、恶心、面唇暗红、胸胁苦满、大便秘结，以及月经不调、前后不定期、经量少而色暗紫。腹诊发现左右少腹压痛，左侧有少腹急结状。患者小柴胡汤证与桃仁承气汤证俱在，我给予小柴胡汤与桃仁承气汤的合方三帖。”我一边听，一边想，阿骅表兄的诊治药方是合理的。

“服药后，效果如何?”“第四天，病人哭丧着脸来了。”阿骅表兄摇摇头说:“病人虽然没有说什么，但我还是心里很难过，同时也感到迷惑。方证没有辨错，这一点是没有怀疑的，要是有错就错在合方。如果分开了先后用药，那么到底哪个方先服，哪个方后服呢?”

我只想到临床疗效,就急匆匆地责问说:“阿骅,你为什么不给她针刺呢?"“不要打岔,”阿骅表兄白了我一眼，以责怪的语气说:“先不说针灸，现在讨论用方前后的问题。你说先用哪个方?”

我记得上次与张丰先生讨论合并病的时候，《伤寒论》中对少阳阳明并病出现小柴胡汤证与桃仁承气汤证同在时，是先用小柴胡汤的。

“先用小柴胡汤，”我说，“等到少阳病症消除后，再投桃仁承气汤。”

“这里牵涉到六经辨证中的合并病的诊治规律性问题，”阿骅表兄说，“可以参考《伤寒论》第 144 条。”144 条云:妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热人血室，其血必结，故使如疟状发作有时，小柴胡汤主之。

“阿骅，你是不是先用小柴胡汤进行治疗?”“是的，”阿骅表兄说，“病人服了三帖小柴胡汤后兰叉神经疼痛顿挫，寒热、头痛、口苦、恶心等少阳病症基本消失。然而病人面唇暗红、大便秘结、少腹压痛、左少腹急结依然存在，转投桃仁承气汤七帖，三叉神经疼痛渐渐趋于缓和。至今已经三个多月了，一直没有复发。”

阿骅表兄用这个病例说明中医临床上运用“统观全局提前绕”原则的确恰如其分。

阿骅表兄临走的时候说:“经方医学与定向运动一样，其实是一项选择的运动。没错，尽管经方医师能依照仲景的医学思想进行诊疗，但每一个病症，都有至少两个方法可以治疗，取得疗效的关键在于选对了正确的方证或者说适合病人体内抗病能力的方药。这样，才可能用最聪明的方法战胜疾病，赢得疗效。”

【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】:

一妇人，患疫，身热如灼，口舌糜烂，渴好热饮，一日妄语如狂，自胸至少腹，硬疼不可近手，十余日不大便，先生投以桃仁承气汤，黑便通快，诸证悉去。

《方舆鞔》曰：桃仁承气汤证本论曰下血，曰少腹急结，若比抵当汤证，其血犹未沉痼也，兹举余所治屡验之一于下:经血欲来，腹疼不可忍，甚至到心妄者，以桃仁承气攻之，二三帖，疼失如神。此证经年不瘥，久患成宿疾者，皆由轻剂微汤无效故也。每月经期时，用桃仁承气二三帖或四五帖，得以定疼即停服，至下月经期之问，经服逐瘀丸散之类，至期时，复服桃仁承气汤，过期后，复服缓攻之剂，如前，如是回环四五月，则数稔之滞患，亦得痊愈。

第二十九章 血府逐瘀汤方证

【血府逐瘀汤治疗活血祛瘀消症瘕子宫肌瘤】:

李某,女,31 岁,教师。12 岁信水初潮,每月应期而至,25 岁结婚,两年后生一女婴。嗣后月经紊乱,或错前五、七日,或愆期十余天,进而经水量大,甚则淋漓不断,其色深黑,伴见血块,不时少腹隐痛。曾屡服安络血、维生素 K3 等,唯可取效于一时,继而依然。1990 年 6 月 18 日就诊:面色萎黄不华,气短乏力,舌质暗,苔薄而少,脉沉细而涩。少腹部可触及一核桃大之硬块,压痛明显,系症瘕无疑。复以 B 超印证:子宫内有一 3.8×2.6cm 之肌瘤。病理活检为良性肿物。冰冻三尺,非一日之寒。急攻之则劳而伤财,缓图之则事半而功倍,故以活血祛瘀,消症散结为

法。方拟:黄芪30g,当归、赤芍、川芎、五灵脂、蒲黄、玄参、川牛膝各15g,生地12g,柴胡、桃仁、红花各10g,桂枝6g,甘草5g。长流水煎服,每次250ml,日3服,连投60剂。同年10月21日再诊:面色红润,气平音和,舌质略红、苔薄白,脉缓有力。触按少腹未见肿块。B超复查:宫内未见异常。患者自述,九月迄今,经行二次,应期而至,食欲有增,体态丰盈,诸症悉除。按:桃红四物汤活血瘀而独领风骚;肝藏血而主疏泄,柴胡乃治肝之要药,既可疏肝理气以畅气机,又可开郁通道而为血之运行推波助澜;五灵脂、蒲黄活血以止痛,散结以消症,因其功效卓奇而有“失笑散”之美名;津血同源,血病日久必累及阴津,故以善治恶疮之元参滋液而化坚;桂枝温经通阳而入血分,为大军之轻骑,虽不事声张而有斩关夺隘之能;川牛膝不仅壮腰健肾而补先天,且引药下行直达血海,使诸药并力攻邪以捣敌穴;甘草,味甘可助黄芪以补元气,性平,可调和诸药,使峻历者无伤正之弊,平和者无缓滞之忧;阴血既亏,正气亦虚,于大队活血祛瘀之品中加黄芪以扶正,犹如重兵压境,两军对垒,粮草充足者自无后顾之忧而能一鼓作气,决战决胜也;取长流水者,在于借其历经坎坷,劈山造路,来势峻猛而锐不可挡之意也。

【血府逐瘀汤加减治疗软坚散结化乳癖】:

王某,女,41岁,干部。3年前沐浴时不经意间发现两侧乳房之右下方均有一肿物,似有触痛。曾就医于市内某医院妇科,以乳腺小叶增生名之,中西药物交替使用而无显效,渐次于劳累、情志不舒或经前即感胀痛,触之尤甚。1998年5月7日延余诊视:舌质暗,边尖有瘀点,苔薄稍黄,脉沉弦。左右乳房分别有一1.9×1.7cm,2.3×2.1cm之硬结物推之可移,皮色无异常。脉症合参,显系乳癖。治宜疏肝解郁,化痰散结之剂。柴胡13g,当归、川芎、三棱、莪术、醋香附、皂刺各15g,醋白芍30g,大贝母、生地各12g,昆布、海藻各25g,桃仁、红花、桔梗、青皮各10g,煅牡蛎20g。嘱其每日1剂,水煎,日3服。药后,以白酒10ml,呷之。连尽45剂。

按:肝之经脉布胸胁,抵少腹,绕阴器,故以柴胡疏肝解郁为君;桃红四物汤活血通经,祛瘀柔肝为臣;昆布、海藻消痰软坚,散结行水;三棱、莪术破瘀通经,行气消积;煅牡蛎收涩软坚而消硬肿,协昆布、海藻以扬军威,助三棱、文术以壮行色;大贝母清热化痰而软坚,滋阴行水而散结;皂刺辛温,活血消肿,青皮辛温,破气散结,二味相伍均具辛者可散,温者可行之功,如此则一活一破,即可无坚不摧,无关不克;醋香附乃气病之总司,妇科之主帅,郁证之良友,调经之妙剂,在此可周旋于诸药之间,使气通血活,经畅脉顺也;桔梗为药中之舟楫,载诸药以上行;白酒者温经活血,其所用之法非饮非服,而言呷者,乃小口慢下,以求药力之持续不断而见“滴水穿石”之功也。同年8月21日再触其乳房,左右之肿块均未查及,B超所示亦无异常可见。

【血府逐瘀汤加减治疗行气解郁治经闭多囊卵巢综合征】:

吴某,女,21岁,农民。1992年1月就诊。14岁初见经水,一年后经行无定期,且血量极少,一日即止。1989年2月迄今,月经停潮,形体日胖,郁郁寡欢,烦躁易怒。3年内体重由50kg增至75kg,且腹部隆起,两乳高突,昔日所穿之衣物尽显瘦小而不能着身。曾以黄体酮治之,不为所动,复求治于省会某大医院,诊为多囊卵巢综合征,遂告其母:待字闺中,适时行手术治疗。家人甚为忧虑,其女亦“自惭形秽”而羞于见人。详察其候:舌质紫暗、苔薄白,脉弦涩,乳晕色素颇深。《内经》云:“心主血脉”,“肝藏血”,“脾统血”。可见血证总以心、肝、脾三脏为主,而于血证之属实者则明言“血实宜决之”。故以行气解郁,活血通经为治也。柴胡、当归、生地、川芎、丹皮、醋香附、瞿麦、川牛膝各15g,醋白芍、水蛭各18g,桃仁、红花、桔梗各10g,茯苓20g,土白术、穿山甲、郁金各12g。水煎,日3夜1服。10剂后,腹部平平,乳房不隆,体重降至60kg,连投12剂,乳晕色素正常,侃侃而谈,喜形于色。遵上方,加黄芪30g,以3剂量,末之,日3服,每次4～5g,开水送下。一月后,经水至,色如墨汁,杂见血块,历四日而止。半年后随访,体重52kg,经行正常。按:肝为刚脏,性喜条达而恶抑郁。柴胡、香附疏肝理气而畅气机;郁金行气活血而利通道;四物汤养血滋阴而固冲任;桃仁、红花、穿山甲活血祛瘀而为诸药之前锋;水蛭乃血肉之躯,且嗜血成性,为血药中之剽悍勇猛之将,四力并行,则攻城掠地而战无不胜也;脾为后天之本,生血之源,土白术、茯苓甘缓以补中,淡渗以除湿,意在顾

护中州之土也;血不利则为水,瞿麦入心肾,破血而通经,且有清热利尿作用,血瘀而久必有郁热,热邪从膀胱而出,亦《内经》“洁净府”之义也;桂枝辛温,化阳而通经脉,丹皮苦寒,破血而消症结,一辛一苦,一温一寒,相辅而力增,相成而功卓;川牛膝一则壮腰健肾而培先天,一则引药下行而达卵巢,一身而二任焉。《孙子兵法》曰:“胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者,形也。”诚哉斯言。医者自当于孙子之言悟出辨证论治之真谛也。

【血府逐瘀汤治疗慢性子宫出血】:

方药:血府逐瘀汤加减:柴胡 10g,桔梗 10g,桃仁 10g,红花 10g,赤芍 10g,枳壳 10g,香附 15g,牛膝 15g,益母草 15g,陈皮 10g,党参 30g,黄芪 30g,当归 15g,大枣 15 枚(捣烂)。每日 1 剂水煎服。患者每晚用暖水袋热敷小腹部,促进化瘀之效。服用 3 剂,诸症减轻,继服 3 剂后,间断出血,全身有力,可服人参归脾丸补养气血以固疗效。《素问?阴阳应象大论》曰“善诊者,察色按脉,先别阴阳,审清浊而知部分,视喘息,听声音而知所苦,观权衡规矩而知病所主,按尺寸,观浮沉滑涩而知病所生,以治无过,以诊则不失矣”,《景岳全书?妇人规》曰“崩淋之病,未有不由忧思郁怒,先损脾胃,次及冲任而然者”,祖国医学称此病为“崩漏”。忽然暴下谓之崩中;非时而下,淋漓不断,谓之漏下,两者可以互相转化,故崩漏并称。治疗原则,本着急则治其标,缓则治其本,采用塞流、澄源、复旧固本三法,根据情况,分别施治。其出血量不多,则重在澄源,瘀者行之,通因通用法治之,达到治愈疾病的目的。中医治病,重在辨证,分清阴阳、表里、寒热、虚实。